INSTRUÇÕES

Aqui temos o banco de questões do medgrupo. Cada pdf tem 500 questões, são 112 pdfs então 56.000 questões.

As questões são divididas da mesma forma que é no medgrupo, então, por exemplo, a pasta "CIR 1" irá conter as questões do modulo CIR 1 do medcurso. No pdf, primeiro há as questões e por final os comentários e gabaritos. Como é uma questão por pagina, sempre por volta da pagina 500 terá o começo do gabarito.

A numeração de cada questão é pelo seu ID, da mesma forma que é no app do medgrupo. Por exemplo, se no modulo CIR 1, uma questão ter o ID 33345 (o ID aparece em cima do enunciado em negrito), no gabarito irá aparecer o mesmo ID como a enumeração da questão.

Além disso, certas questões tem imagens e videos respostas. Dessa maneira se acaso a questão de ID 33345 ter uma imagem, ela estará na pasta Imagens (Cir 1/Imagens/33345.png) com o nome 33345.png e o vídeo estará em (Cir 1/videos/33345.mp4)

***Recomendo, para se localizar no gabarito, utilizar CTRL+F (pesquisar), procure o ID da questão que quer ver a resposta, como o ID 33345.**

***Se houver algum erro, envie mensagem no twitter @livremedicina**

345435)

Enunciado: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade do coração de atuar adequadamente como bomba, quer seja por déficit de contração e/ou de relaxamento, comprometendo o funcionamento do organismo, e quando não tratada adequadamente, reduzindo a qualidade de vida e a sobrevida. Um paciente com IC classe II, é aquele em que:

A) Ainda tem ausência de sintomas, é considerado assintomático e teve seu diagnóstico ao acaso na investigação diagnóstica de outras doenças cardíacas.

B) Realiza atividades físicas menos intensas que as habituais que já são o suficiente para causar sintomas.

C) Apresenta limitação física importante, porém confortável apenas no repouso com sintomas moderados.

D) As atividades físicas habituais causam sintomas; há limitação leve e sintomas leves.

345449)

Enunciado: Mulher de 73 anos com história de dispneia aos esforços vai à consulta médica. A radiografia do tórax revelou hipertensão venosa pulmonar. Encontra-se em uso de anticoagulante oral, betabloqueador e diurético de alça, porém refere cansaço e dispneia. No exame apresenta ritmo cardíaco irregular e frequência ventricular de 104 bpm, pressão arterial de 160/80 mmHg; há distensão venosa jugular e edema dos membros inferiores, mas não foram encontrados sopros, terceira bulha ou ruídos adventícios pulmonares à ausculta. A radiografia do tórax revelou hipertensão venosa pulmonar e o ecocardiograma apresentou fração de ejeção de 65%, ventrículo esquerdo com diâmetro normal e hipertrofia concêntrica, e aumento do átrio esquerdo. Sobre essa paciente, podemos afirmar que apresenta:

A) Insuficiência cardíaca; independentemente do tipo de disfunção ventricular, deve ser mantida a terapêutica atual.

B) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada; a dose de diuréticos deve ser aumentada, a pressão arterial sistêmica ajustada com medicação e mantida a anticoagulação oral.

C) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; a hipertensão arterial deve ser melhor controlada com medicamentos e as doses de diurético e anticoagulante devem ser mantidas.

D) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; deve ser realizado o controle da pressão arterial com medicamentos, o diurético deve ser aumentado e deve ser acrescentada medicação inotrópica positiva, além de mantida a anticoagulação.

345454)

Enunciado: Paciente de 52 anos, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) há 5 anos, veio à consulta de rotina. Faz uso regular de captopril (25 mg, de 8/8 horas). A pressão arterial verificada no consultório era de 170 x 110 mmHg. Nos controles realizados em casa, foram observados sempre níveis elevados, semelhantes ao da consulta atual. Qual a conduta mais adequada?

A) Associar um antagonista do receptor de angiotensina II ao esquema em uso.

B) Associar um diurético trazídico ao esquema em uso.

C) Realizar investigação de HAS resistente.

D) Indicar realização de Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial (MAPA).

345471)

Enunciado: Um homem de 58 anos de idade, obeso, hipertenso, dislipdêmico e tabagista dá entrada na sala de emergência com queixa de dispneia, iniciada há cerca de uma hora. Após colher sua história, o médico toma ciência de infarto agudo do miocárdio sofrido há cerca de 6 meses, que necessitou angioplastias e foi abordado em internação prolongada, devido à grande área cardíaca atingida. Na verificação de sinais, o paciente apresentava TA 194x124 mmHg, FC 110 bpm, Tax 36,4ºC, Sat.O2 87%. Notável piora do padrão ventilatório, com asculta contendo crepitantes até o alto dos 2/3 inferiores de ambos os pulmões com alguns bolhosos. Colhidos exames para análise, medicado, o paciente foi recuperando o padrão ventilatório, assim como obteve redução da dispneia. Oximetria demonstrou melhora, chegando a 95% em ar ambiente. Após estabilização, o paciente explicitou que diariamente tem algum nível de dispneia, mas naquele dia teria piorado muito. Considerando o caso clínico, assinale a alternativa que contém a conduta e as medidas que o médico deve tomar na avaliação do caso:

A) O provável quadro clínico é de infarto agudo do miocárdio. A melhora clínica foi mediada pela administração de nitrato sublingual e betabloqueadores. A provável causa do novo IAM foi o prévio e dificuldades de tratamento, com contribuição de provável cardiopatia isquêmica.

B) O provável quadro clínico é de Tromboembolismo Pulmonar (TEP). A melhora clínica foi mediada pela administração de Enoxaparina. A provável causa do TEP foi o IAM prévio.

C) O provável quadro clínico é de insuficiência cardíaca descompensada. A melhora clínica foi mediada pela administração de nitrato sublingual e betabloqueadores, além de Enoxaparina.

D) O provável quadro clínico é de insuficiência cardíaca descompensada. A melhora clínica foi mediada pela administração de diuréticos de alça, além de provável medicação vasodilatadora e administração de O2. A provável causa da insuficiência cardíaca foi o IAM prévio, com contribuição de cardiopatia isquêmica crônica.

345496)

Enunciado: Considere que um menino de 9 anos de idade, compareceu a uma Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina anual. Mãe refere que criança vem apresentando roncos noturnos, sono agitado e episódios de pausa respiratória. Ela informa que o filho é agitado, desatento e dorme em sala de aula. Antecedente pessoal: rinite controlada com higiene nasal e profilaxia ambiental. Exame físico: hipertrofia de amígdalas grau III, hipertrofia de cornetos nasais e respiração oral. O diagnóstico e a conduta são, respectivamente:

A) Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade e cloridrato de metilfenidato.

B) Refluxo gastroesofágico e pHmetria.

C) Síndrome da apnéia obstrutiva do sono e polissonografia.

D) Hipertrofia de adenoides e radiograma de cavum.

343842)

Enunciado: Senhora de 62 anos, 60 kg de peso corporal, hipertensa em uso de losartana 50 mg/dia + hidroclorotiazida 25 mg/dia, chega a unidade de Pronto Socorro encaminhada por colega para avaliação de emergência devido exame laboratorial de rotina (Sódio sérico de 122 mEq/L; VR: 135 - 145 mEq/l), sem outras queixas. Qual a sua conduta para o caso?

A) SF 3% - 30 ml/hora EV nas primeiras 3 horas e solicitar novo Sódio sérico.

B) SF 3% - 60 ml/hora EV nas primeiras 3 horas e solicitar novo Sódio sérico.

C) Suspender hidroclorotiazida, orientar restrição de líquidos, furosemida via oral e repetir sódio sérico ambulatorialmente.

D) Hidratar com SF 0,9% e reavaliar sódio sérico ambulatorialmente.

343851)

Enunciado: Qual dos pacientes abaixo apresenta uma emergência hipertensiva?

A) Senhora de 65 anos, obesa, hipertensa e diabética há 20 anos, vai visitar a mãe na UTI e fica muito emocionada, apresenta tontura e é levada ao PS, onde se constata PA=210x120 mmHg; o restante do exame físico com exceção da obesidade é normal.

B) Jovem de 12 anos refere que há 15 dias teve impetigo, ontem acordou com as pálpebras edemaciadas e hoje não conseguiu praticar educação física por dispnéia. Ao exame físico observaram-se PA=160x100 mmHg, pulmões livres, fundo de olho normal.

C) Senhor de 72 anos, revascularizado do miocárdio há dois anos, refere dor retroestemal há 3 horas. Seu exame físico revela PA=210x130 mmHg e o pulso: diminuídos em membros superiores e não palpáveis em membros inferiores.

D) Senhora de 48 anos, portadora de estenose aórtica devido ao cardite reumática, refere tontura rotatória e vômitos desde hoje cedo, PA=180x105 mmHg.

283286)

Enunciado: Mulher de 60 anos de idade, hipertensa, diabética e dislipidêmica em acompanhamento ambulatorial em uso de metformina 850 mg 2x ao dia, sinvastatina 20 mg/dia, AAS 100 mg/dia, losartana 50 mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia e anlodipino 5 mg/dia. Refere que tem apresentado edema em membros inferiores e crise recorrente de gota. Quais medicamentos seriam responsáveis respectivamente pelo edema e pela gota?

A) Sinvastatina e losartana.

B) Losartana e metformina.

C) Anlodipino e hidroclorotiazida.

D) Anlodipino e losartana.

251858)

Enunciado: Assinale o efeito colateral mais comumente encontrado com o uso de inibidores da ECA:

A) Hipotensão arterial.

B) Hiperpotassemia.

C) Tosse.

D) Disfunção renal.

247145)

Enunciado: Qual o elemento fisiopatológico mais importante na síndrome cardio-renal em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada?

A) Síndrome de baixo débito cardíaco e perfusão renal ruim.

B) Hipertensão venosa sistêmica com elevação de pressão venosa central.

C) Insuficiência renal iatrogênica (medicamentos nefrotóxicos).

D) Hipertensão arterial sistêmica não controlada.

E) Piora de doença renal pré-existente (doença renovascular).

247147)

Enunciado: O principal mecanismo que leva à perda de função renal na hipertensão arterial é:

A) Hiperfiltração glomerular.

B) Hipertensão glomerular.

C) Isquemia.

D) Fibrose intersticial.

E) Esclerose glomerular.

247166)

Enunciado: Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. Paciente do sexo masculino, 50 anos, procura a emergência por cefaleia. Refere história de revascularização miocárdica há um ano. Nega dor precordial. Ao exame físico, é detectada uma pressão arterial de 100q120 mm/Hg sem 3ª ou 4ª bulha. O exame neurológico é normal. Qual é o diagnóstico mais provável e qual a melhor conduta terapêutica para este caso?

A) Emergência hipertensiva - Iniciar nitroglicerina endovenosa.

B) Urgência hipertensiva - Iniciar hidralazina endovenosa.

C) Urgência hipertensiva - Iniciar nitroprussiato de sódio endoveneso e administrar um analgésico.

D) Emergência hipertensiva - Iniciar metroprolol endovenoso.

E) Urgência hipertensiva - Iniciar captopril via oral e administrar um analgésico.

247184)

Enunciado: Menino de 12 anos de idade é trazido ao pronto-socorro com história de falta de ar há 48 horas, cefaleia e desmaio. Ao exame, encontra-se ansioso, dispneico, pletórico, com estase venosa central. O paciente se recusa a deitar para o exame abdominal, a ausculta pulmonar é limpa. Qual diagnóstico mais provável?

A) Hipertensão intracraniana.

B) Síndrome do mediastino superior.

C) Ataque de pânico.

D) Síndrome de lise tumoral.

E) Crise de asma.

217656)

Enunciado: Com relação aos hipotensores, assinale a alternativa CORRETA:

A) Há contraindicação relativa ao uso de alfabloqueadores em hipertensos com hipertrofia prostática benigna.

B) Os inibidores diretos da renina causam redução da produção de angiotensina II e há fortes evidências de seus benefícios sobre a morbimortalidade.

C) Os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II proporcionam redução da morbimortalidade cardiovascular, mas não da renal.

D) Os bloqueadores dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos podem deprimir a função sistólica cardíaca, principalmente em pacientes que já apresentam tal disfunção antes do início do seu uso, devendo ser evitados nessa condição.

182602)

Enunciado: Segundo a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial - HAS (2016), a classificação da HAS em medição casual ou no consultório em um paciente acima de 18 anos de idade com níveis tensionais de 140 X 95 mmHg, estaria classificado como:

A) Pré hipertensão.

B) HAS estágio 1.

C) HAS estágio 2.

D) HAS estágio 3.

182624)

Enunciado: Paciente com Insuficiência Cardíaca que resulta em ligeira limitação da atividade física. Ele fica confortável em repouso. A atividade física ordinária resulta em fadiga, palpitações, dispneia ou dor anginosa. Esse paciente deve ser classificado funcionalmente conforme a New York Heart Association (NYHA) em:

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

183198)

Enunciado: Mulher de 76 anos, hipertensa de longa data, referindo piora de dispneia, atualmente, até aos pequenos esforços. Apresenta ausculta com galope de B4. A pressão arterial é de 160/88 mm Hg e a FC= 96/min. Ao ecocardiograma são observados hipertrofia concêntrica do VE, átrio esquerdo pouco aumentado, tamanho e função ventricular esquerda normais e tempo de relaxamento diastólico anormalmente lento. Qual destas drogas seria mais eficaz e com menor perfil de toxicidade?

A) Digoxina,

B) Lisinopril.

C) Verapamil.

D) Amlodipina.

E) Metolazona.

159089)

Enunciado: O manejo do paciente hipertenso é de grande importância na prática clínica diária, por isso os conhecimentos sobre os fármacos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica e seus riscos são pré-requisitos básicos para o seu emprego adequado e responsável pelo médico que irá atuar nas unidades básicas de saúde. Tendo em vista o exposto acima, relacione as colunas, associando os efeitos adversos aos respectivos fármacos. (1) Hidroclorotiazida; (2) Propranolol; (3) Anlodipino; (4) Captopril. ( ) Tosse e hipercalemia; ( ) Broncoespasmo, insuficiência circulatória periférica, bradiarritmias e mascaramento de hipoglicemia em diabéticos; ( ) Hipocalemia e hiperuricemia; ( ) Cefaleia, edema periférico e palpitação. A ordem numérica CORRETA, na coluna inferior, de cima para baixo é:

A) 2 - 3 - 4 - 1.

B) 2 - 4 - 1 - 3.

C) 4 - 2 - 1 - 3.

D) 4 - 1 - 3 - 2.

159119)

Enunciado: Com relação aos diuréticos usados na insuficiência cardiaca, pode-se afirmar que a:

A) Clortalidona reduz o sódio e potássio urinários.

B) Furosemida pode causar alcalose hipoclorêmica.

C) Amilorida reduz a concentração sérica de magnésio.

D) Hidroclorotiazida não interfere no nível sérico de glicose.

159122)

Enunciado: Sobre as urgências hipertensivas e complicações na hipertensão arterial, pode-se afirmar que: I - A causa da morte mais frequente em hipertensos não tratados é o infarto agudo do miocárdio. II - O metoprolol é o agente anti-hipertensivo parenteral mais indicado na maioria das emergências hipertensivas. III - No evento isquêmico agudo cerebral, não se deve administrar anti-hipertensivos, a não ser em condições específicas ou níveis de pressão extremamente elevados (PAS > 220mmHg ou PAD > 120 mmHg).

A) Apenas a I está correta.

B) Apenas a II está correta.

C) Apenas a III está correta.

D) I e III estão corretas.

159125)

Enunciado: Na terapêutica das emergências hipertensivas, pode se afirmar que:

A) O captopril sublingual é a opção terapêutica para o tratamento ambulatorial.

B) O nitroprussiato de sódio deve ser utilizado em pacientes com suspeita de isquemia miocárdica para a rápida redução do consumo de oxigênio.

C) A furosemida está indicada no tratamento da eclâmpsia para controle de volemia.

D) O betabloqueador venoso está indicado na suspeita de dissecção aórtica em conjunto com o nitroprussiato de sódio.

108798)

Enunciado: Paciente portador de Diabetes e Insuficiência cardíaca estágio B, deve fazer uso das seguintes medicações e condutas:

A) IECA ou BRA;

B) IECA ou BRA e Betabloqueadores;

C) IECA ou BRA, Betabloqueadores, Digitálicos e Transplante cardíaco;

D) IECA ou BRA, Betabloqueadores, Digitálicos e Antagonistas da aldosterona.

108801)

Enunciado: Para um médico de família é fundamental ter conhecimento sobre abordagem da hipertensão arterial sistêmica em seus pacientes. Sobre este assunto é CORRETO afirmar que:

A) A medicação de primeira escolha é o atenolol 25 mg/dia.

B) Pacientes com nível pressórico controlado necessitam realizar consultas anuais.

C) O uso de ácido acetilsalicílico associado é recomendado como terapia auxiliar nos pacientes hipertensos.

D) Mudança do estilo de vida como tratamento inicial pode ser recomendado para alguns pacientes.

84507)

Enunciado: Assinale a opção correta, em se tratando de exames de rotina MÍNIMA para pacientes portadores de hipertensão arterial.

A) Hemograma, sódio, potássio, ureia, urocultura;

B) Glicemia, Na, K, ECG de esforço;

C) Hemograma, EPF, urina I, Ureia;

D) Urina parcial, creatinina, Potássio, glicemia, colesterol e frações, ECG de repouso;

E) Glicemia, fosfatase alcalina, K, Na.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84549)

Enunciado: Qual a alternativa não faz parte das indicações para o uso da espironolactona em pacientes com Insuficiência Cardíaca segundo o último consenso (2013) da Academia Americana do Coração?

A) Pacientes com classe funcional II (NYHA) e Fração de ejeção < 30%.

B) Pacientes com classe funcional III/IV (NYHA) e Fração de ejeção < 35%.

C) Pacientes com Infarto Miocárdico com supra de ST e tenham recebido terapia com inibidores da ECA, com fração de ejeção "< ou =" 40% e permaneça sintomático.

D) Para pacientes que preencham os critérios e tenham níveis de potássio < 5 mEq/L e TFG > 30 ml/min por 1,73 m^2.

E) Para os pacientes com Classe funcional III (NYHA) independente da Fração de ejeção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84493)

Enunciado: Indivíduo do sexo masculino, 29 anos, estressado no trabalho e sedentário, com avó hipertensa, apresenta-se com IMC de 26,3 kg/m2 e PA de 138/84 mmHg (média de duas medidas). Qual a melhor orientação do caso?

A) A PA é normal e não necessita nenhuma orientação específica.

B) A PA é normal e está recomendado o acompanhamento nutricional com vistas à redução do sal.

C) A PA é normal alta e a ênfase deve ser perda de peso, iniciar atividade física e redução do sal.

D) A PA é normal alta e deve ser prescrito fármaco anti-hipertensivo devido à história familiar positiva para hipertensão.

E) A PA é alta e deve ser iniciado fármacos logo de início.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84505)

Enunciado: Paciente de 65 anos admitido com história de ser portador de hipertensão arterial fazendo uso de hidroclorotiazida e losartana, é admitido no pronto-socorro apresentando depressão do segmento ST, achatamento das ondas T e ondas U proeminentes. Qual o distúrbio hidroeletrolítico mais provável:

A) Hipocalcemia.

B) Hiponatremia.

C) Hipocalemia.

D) Hipomagnesemia.

E) Hipercalemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66967)

Enunciado: Para pacientes hipertensos em estágio 2 (pressão arterial sistólica "maior ou igual a" 160 mmHg e pressão arterial diastólica "maior ou igual a" 100 mmHg), pode-se considerar o uso de associações de fármacos anti-hipertensivos como terapia inicial. Ao usar diuréticos tiazídicos associados a betabloqueador, os riscos mais importantes são:

A) Hipocalemia e tosse.

B) Hipovolemia e tosse.

C) Hipocalemia e broncoespasmo.

D) Hipercalemia e hiperuricemia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

50109)

Enunciado: Sua paciente é uma mulher assintomática de 26 anos, que você está examinando pela primeira vez. Você observa tortuosidade arteriovenosa no exame oftalmoscópico e a PA é de 220/132 mmHg. Ela é hospitalizada para uma avaliação mais profunda, que inclui arteriografia renal, tendo em vista que você também detectou:

A) História familiar de hipertensão arterial;

B) Quatro a cinco leucócitos por campo de grande aumento no EAS;

C) Que ela não está usando anticoncepcionais orais;

D) Um discreto sopro na região subcostal esquerda, que apresenta componentes sistólicos e diastólicos curtos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

50118)

Enunciado: Senhor de 52 anos, hipertenso em uso de captopril 75 mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia, dislipidemia em uso de atorvastatina 20 mg/dia, esteatose hepática detectada no último ultrassom. Ao exame físico apresenta: IMC - 37 kg/m², PA - 125 x 85 mmHg, FC - 80 bpm, Pele - Acantose nigricans em cotovelos. Exames recentes - Glicemia jejum - 128 mg/dl, Hemoglobina glicada - 7,6, Colesterol Total - 208, HDL c - 38 mg/dl, Triglicerídeos - 200. Responda a questão com base no caso clínico. Quais os diagnósticos do CASO CLÍNICO?

A) HAS, Dislipidemia, Esteatose hepática, Obesidade grau I, Diabetes Mellitus e Síndrome metabólica;

B) HAS, Dislipidemia, Esteatose hepática, Obesidade grau II, Intolerância à Glicose e Síndrome metabólica;

C) HAS, Dislipidemia, Esteatose hepática, Obesidade grau II, Diabetes Mellitus e Síndrome metabólica;

D) HAS, Dislipidemia, Estatose hepática, Obesidade grau I, Intolerância à Glicose e Síndrome metabólica;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

50120)

Enunciado: Senhor de 52 anos, hipertenso em uso de captopril 75 mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia, dislipidemia em uso de atorvastatina 20 mg/dia, esteatose hepática detectada no último ultrassom. Ao exame físico, apresenta: IMC - 37 kg/m², PA - 125 x 85 mmHg, FC - 80 bpm, Pele - Acantose nigricans em cotovelos. Exames recentes - Glicemia jejum - 128 mg/dl, Hemoglobina glicada - 7,6, Colesterol Total - 208, HDL c - 38 mg/dl, Triglicerídeos - 200. Responda a questão com base no caso clínico. Levando em consideração o CASO CLÍNICO e com base na fisiopatologia do Diabetes m=Mellitus, a classe de medicamento (s) que você escolherá deverá agir:

A) Diminuindo a neoglicogênese hepática, aumentando a sensibilidade dos receptores periféricos à insulina (fígado).

B) Aumentando a produção de insulina pelas células beta do pâncreas.

C) Diminuindo a secreção do Glucagon pelo pâncreas.

D) Retardando a absorção de carboidratos pelo trato gastrointestinal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

50123)

Enunciado: Paciente portador de Insuficiência Cardíaca (IC) estágio B pela classificação da American Heart Association (AHA) deverá apresentar:

A) Alto risco para IC sem cardiopatia estrutural ou sintomas de IC;

B) Cardiopatia estrutural, mas sem sinal ou sintomas de IC;

C) Cardiopatia estrutural com sintomas prévios ou atuais de IC;

D) IC refratária exigindo intervenções especializadas;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

50100)

Enunciado: Escolar de oito anos de idade, sexo masculino, com sobrepeso, tem a Pressão Arterial (PA) aferida no percentil 95. Após duas aferições, em consultas separadas, a PA se mantém no percentil 95. A conduta CORRETA é:

A) Iniciar imediatamente tratamento para hipertensão arterial;

B) Considerar que a pressão é limítrofe normal para a idade e manter rotina pediátrica;

C) Realizar avaliação diagnóstica e iniciar tratamento farmacológico;

D) Monitorar PA, se persistir elevada, realizar avaliação diagnóstica e considerar tratamento para hipertensão arterial;

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

50094)

Enunciado: Quais os sinais de insuficiência cardíaca mais frequentes na faixa etária pediátrica?

A) Hepatomegalia, taquipneia, taquicardia, oligúria.

B) Hepatomegalia, taquipneia, taquicardia, hipotensão.

C) Hepatomegalia, taquipneia, taquicardia, cardiomegalia.

D) Anasarca, edema agudo de pulmão, irritabilidade, enchimento capilar lentificado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37073)

Enunciado: Qual dos pacientes abaixo apresenta uma emergência hipertensiva?

A) Senhora de 65 anos, obesa, hipertensa e diabética há 20 anos, vai visitar a mãe na UTI e fica muito emocionada, apresenta tontura e é levada ao OS, onde se constata PA = 210 X 120 mmHg; o restante do exame físico com exceção da obesidade é normal.

B) Jovem de 12 anos refere que há 15 dias teve impetigo; ontem acordou com as pálpebras edemaciadas e hoje não conseguiu praticar educação física por dispneia. Ao exame físico observaram-se PA = 160 X 100 mmHg, pulmões livres, fundo de olho normal.

C) Senhor de 72 anos, revascularizado do miocárdio há dois anos, refere dor retroestemal há 3 horas. Seu exame físico revela PA = 210 X 130 mmHg e os pulsos: diminuídos em membros superiores e não palpáveis em membros inferiores.

D) Moça lúpica de 22 anos, há uma semana fez todos os exames para avaliação de atividade da doença que foram normais; hoje refere cefaleia e PA = 180 X 105 mmHg.

E) Senhora de 48 anos, portadora de estenose aórtica devido a cardite reumática, refere tontura rotatória e vômitos desde hoje cedo, PA = 180 x 105 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37087)

Enunciado: Paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica acelerada apresenta ao exame de fundo de olho:

A) Exudatos e papiledema

B) Hemorragia retiniana e papiledema

C) Dano Vascular sem papiledema

D) Cruzamentos artério-venoso e papiledema

E) Espasmo arteriolar e papiledema

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37105)

Enunciado: Em relação ao sopro cardíaco na criança, é CORRETO afirmar:

A) O sopro inocente é a alteração da ausculta que ocorre na ausência de anormalidade anatômica ou funcional ao sistema cardiovascular.

B) O sopro inocente é um achado frequente, que ocorre em 50 a 70% das crianças, geralmente na idade escolar.

C) A classificação do sopro quanto à intensidade é estadiado em graus de I a VI.

D) A presença de frêmito (palpável) sempre caracterizará um sopro como patológico.

E) Todas as alternativas estão corretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37106)

Enunciado: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é a condição na qual o débito cardíaco (DC) é inadequado para as necessidades. O diagnóstico da ICC depende da história, do exame físico e de exames subsidiários. Seguindo este raciocínio, assinale qual a melhor sequência de sinais clínicos e de exames que possibilitariam o diagnóstico de ICC na faixa etária infantil.

A) Cianose ? sudorese ?taquicardia ? sobrecarga de átrio direito no ECG.

B) Taquicardia ? taquipneia ? hepatomegalia ? cardiomegalia no RX de tórax.

C) Taquicardia ? diminuição do enchimento capilar normal do RX.

D) Taquicardia ? sudorese ? cianose ? edema ? isquemia miocárdica no ECG.

E) Nenhuma das alternativas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37107)

Enunciado: Em relação à insuficiência cardíaca na criança é correto afirmar, exceto:

A) É um evento clínico, bem estudado, sendo caracterizado por um estado de hipoperfusão tissular.

B) Sempre é acompanhada de edema.

C) Caracteriza-se por cardiomegalia, hepatomegalia, taquipneia e taquicardia.

D) Pode ser classificada de alto e de baixo débito.

E) Nenhuma das alternativas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29354)

Enunciado: Assinale a alternativa correta:

A) A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é a condição na qual o débito cardíaco é inadequado para as necessidades metabólicas do organismo.

B) A ICC no lactente é caracterizada por taquicardia, cardiomegalia, taquipneia e hepatomegalia.

C) A descarga simpática (em reposta à hipotensão, à hipoperfusão e a diminuição da oferta de 02) e a estimulação de mecanorreceptores atriais e ventriculares desencadeiam um aumento de catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina as quais, por sua vez, estimulam barorreceptores cardíacos, aumentando a frequência cardíaca e a contratilidade miocárdica.

D) Todas as alternativas estão corretas.

E) Todas as alternativas estão incorretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29340)

Enunciado: Todas as situações clínicas abaixo são indícios de hipertensão arterial secudária, exceto:

A) Sintomas de apneia durante o sono.

B) Exame de urina anormal (proteinúria ou hematúria)

C) Hipopotassemia espontânea

D) Presença de sopro abdominal

E) presença de síndrome metabólica associada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

369529)

Enunciado: Homem, 41 anos de idade, dá entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por sintomas de dispneia aos esforços e fadiga progressiva, há cerca de 4 meses. Inicialmente, as queixas eram aos esforços moderados e agora ocorrem mesmo em repouso. Ele relata ainda palpitações. Nega febre, sudorese noturna, ou perda de peso; ao exame, PA: 130x80mmHg, FC: 100bpm. Ausculta com ritmo cardíaco regular, sopro diastólico em foco aórtico, irradiado para vasos cervicais. Indique a opção terapêutica de primeira escolha para este paciente:

A) Substituição valvar aórtica por prótese biológica.

B) Substituição valvar aórtica por prótese mecânica.

C) Reparo valvar aórtico.

D) Manejo conservador com medicamentos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343162)

Enunciado: Os inibidores da proteína co-transportadora SGLT2 (ISGLT2) inaugurou uma nova era no tratamento da insuficiência cardíaca IC em pessoas com diabetes.

A) Além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular.

B) Além de não controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular.

C) Além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, aumentando de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular.

D) Além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a não a mortalidade cardiovascular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343163)

Enunciado: A oclusão de artéria retiniana:

A) Não é um marcador de lesão de pequenos vasos e tem sido associada a maior risco de evento cerebral.

B) É um marcador de lesão de pequenos vasos e tem sido associada a maior risco de evento cerebral.

C) É um marcador de lesão de pequenos vasos e tem sido associada a menor risco de evento cerebral.

D) É um marcador de lesão de pequenos vasos e não tem sido associada a maior risco de evento cerebral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313427)

Enunciado: Os IECA e outros bloqueadores do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA), estão de acordo com o seguinte item correto:

A) Podem provocar hipopotassemia em pacientes com insuficiência renal, sobretudo nos diabéticos e, o uso é contraindicado na gravidez, pelo risco de complicações fetais. Por isso, seu emprego deve ser cauteloso e frequentemente monitorado em adolescentes e mulheres em idade fértil.

B) Podem provocar hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, sobretudo nos diabéticos e, o uso é indicado na gravidez frequentemente monitorado em mulheres em idade fértil.

C) Podem provocar hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, exceto nos diabéticos e, o uso é contraindicado na gravidez, pelo risco de complicações fetais. Por isso, seu emprego deve ser cauteloso e frequentemente monitorado em adolescentes e mulheres em idade fértil.

D) Podem provocar hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, sobretudo nos diabéticos e, o uso é contraindicado na gravidez, pelo risco de complicações fetais. Por isso, seu emprego deve ser cauteloso e frequentemente monitorado em adolescentes e mulheres em idade fértil.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313429)

Enunciado: Bloqueadores dos Receptores AT1 da Angiotensina II (BRA), estão de acordo com o seguinte item correto:

A) Antagonizam a ação da Angiotensina II pelo bloqueio inespecífico dos Receptores AT1, responsáveis pelas ações próprias da Angiotensina I (vasoconstrição, estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona).

B) Antagonizam a ação da Angiotensina II pelo bloqueio específico dos Receptores AT1, responsáveis pelas ações próprias da Angiotensina II (vasoconstrição, estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona).

C) Aumentam a ação da Angiotensina II pelo bloqueio específico dos Receptores AT1, responsáveis pelas ações próprias da Angiotensina II (vasoconstrição, estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona).

D) Antagonizam a ação da Angiotensina II, mas não pelo bloqueio específico dos Receptores AT1, responsáveis pelas ações próprias da Angiotensina II (vasoconstrição, estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313431)

Enunciado: Assinale a alternativa correta de acordo com os Efeitos Adversos dos Bloqueadores de Canal de Cálcio:

A) O edema maleolar costuma ser o efeito colateral mais registrado e resulta da própria ação vasodilatadora (mais arterial que venosa), promovendo a transudação capilar.

B) O edema maleolar costuma ser o efeito colateral mais raro e resulta da própria ação vasodilatadora (mais arterial que venosa), promovendo a transudação capilar.

C) O edema maleolar costuma ser o efeito colateral mais registrado e resulta da própria ação vasoconstrictora (mais arterial que venosa), promovendo a transudação capilar.

D) O edema maleolar costuma ser o efeito colateral mais registrado e resulta da própria ação vasodilatadora (mais arterial que venosa), inibindo a transudação capilar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

313434)

Enunciado: A cefaleia latejante e as tonturas são comuns Bloqueadores de Canal de Cálcio BCC, sendo correta a alternativa:

A) O rubor facial é mais raro com os BCC di-hidropiridínicos de ação rápida. A hipercromia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a hipertrofia gengival são efeitos adversos ocasionais.

B) O rubor facial é mais comum com os BCC di-hidropiridínicos de ação lenta. A hipercromia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a hipertrofia gengival são efeitos adversos ocasionais.

C) O rubor facial é mais comum com os BCC di-hidropiridínicos de ação rápida. A hipercromia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a hipertrofia gengival são efeitos adversos ocasionais.

D) O rubor facial é mais comum com os BCC não di-hidropiridínicos de ação rápida. A hipercromia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a hipertrofia gengival são efeitos adversos ocasionais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

314209)

Enunciado: Sabemos que a emergência hipertensiva caracteriza-se por descompensação rápida de funções vitais causada por grande elevação da PA em presença de lesão evidente e recente de órgão-alvo. Assinale a alternativa que apresenta a droga de escolha nessa situação.

A) Hidralazina.

B) Nitroprussiato de sódio.

C) Nifedipino.

D) Enalapril.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278073)

Enunciado: Em relação as situações que podem levar ao falso diagnóstico de Hipertensão Arterial Resistente (HAR), acarretando a realização de exames e o uso de medicação de modo desnecessário. Indique a alternativa correta.

A) É possível referir-se à hipertensão do avental branco como uma causa de hipertensão arterial pseudorresistente.

B) É impossível referir-se à hipertensão do avental branco como uma causa de hipertensão arterial pseudorresistente.

C) É possível referir-se à hipertensão do avental branco como uma causa de hipertensão arterial resistente.

D) É possível referir-se à hipertensão do avental branco como uma causa de hipotensão arterial pseudorresistente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

280393)

Enunciado: Uma vez afastada a pseudorresistência, confirma-se a existência da HAR e inicia-se uma investigação diagnóstica com exames específicos, conforme a orientação das Diretrizes de Hipertensão em relação ao comprometimento de lesões em órgãos-alvo e hipertensão secundária. Sendo correto que:

A) A ocorrência de comorbidades associadas não deve ser detectada com exames especializados de acordo com a suspeita clínica.

B) A ocorrência de comorbidades associadas nunca deve ser detectada com exames de acordo com a suspeita clínica.

C) A ocorrência de comorbidades associadas deve ser detectada com exames especializados de acordo com a suspeita clínica.

D) A ocorrência de comorbidades associadas deve ser detectada com exames especializados, mesmo sem qualquer suspeita clínica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

275968)

Enunciado: De acordo com as Diretrizes Brasileira de Hipertensão 2020, pode-se afirmar que:

A) A hipertensão se caracteriza por níveis pressóricos iguais ou maiores que 130/90 mmHg.

B) Uma das principais causas secundárias de hipertensão é a estenose da artéria renal.

C) Indivíduos com níveis pressóricos de 120-129 mmHg e/ou diastólica de 80-89mmHg são considerados pré-hipertensos.

D) No tratamento a prioridade é medicar o paciente ficando a orientação quanto as modificações do estilo de vida como auxiliar secundário ao tratamento medicamentoso.

E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

280394)

Enunciado: No paciente com Estenose Mitral (EM) não importante, reavaliações podem ser realizadas a cada 1 ano. Sendo correto que:

A) O acompanhamento clínico do paciente, enquanto apresentar valvopatia Mitral anatomicamente não importante é realizado com consultas e reavaliações ecocardiográficas periódicas.

B) O acompanhamento clínico do paciente, enquanto apresentar valvopatia Mitral anatomicamente importante é realizado com consultas e reavaliações ecocardiográficas periódicas.

C) O acompanhamento clínico do paciente, enquanto apresentar valvopatia Mitral anatomicamente não importante, não é realizado com consultas e reavaliações ecocardiográficas periódicas.

D) O acompanhamento clínico do paciente, enquanto apresentar valvopatia Mitral anatomicamente não importante é realizado com consultas e não com reavaliações ecocardiográficas periódicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278075)

Enunciado: A Hipertensão Arterial Resistente (HAR) é definida quando a pressão arterial (PA) apresenta as seguintes características:

A) Permanece abaixo das metas recomendadas com o uso de três anti-hipertensivos de diferentes classes.

B) Permanece acima das metas recomendadas com o uso de três anti-hipertensivos de diferentes classes.

C) Permanece acima das metas recomendadas com o uso de dois anti-hipertensivos de diferentes classes.

D) Permanece acima das metas recomendadas com o uso de três anti-hipertensivos de classes iguais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

280396)

Enunciado: O correto momento de indicação e o tipo de tratamento intervencionista para pacientes portadores de valvopatia cardíaca estão atrelados ao preciso diagnóstico anatômico e funcional da valvopatia cardíaca e a uma minuciosa avaliação global do paciente. Sendo adequado o item:

A) A avaliação clínica individual e a nunca decisão da intervenção devem ser sempre compartilhadas com paciente e familiares.

B) A avaliação clínica individual e a decisão da intervenção devem ser sempre compartilhadas com paciente e familiares.

C) A avaliação clínica individual e a decisão da intervenção devem ser sempre compartilhadas com paciente e não com familiares.

D) A avaliação clínica individual e a decisão da intervenção devem ser sempre compartilhadas somente com os familiares.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

280398)

Enunciado: A ecocardiografia é o principal exame complementar para a avaliação anatômica da valva mitral. Sendo assim, assinale a afirmativa correta.

A) Sendo fundamental para a definição da gravidade da valvopatia, das repercussões hemodinâmicas e não dos parâmetros que estão relacionados à chance de sucesso das intervenções.

B) Não sendo fundamental para a definição da gravidade da valvopatia, das repercussões hemodinâmicas e dos parâmetros que estão relacionados à chance de sucesso das intervenções.

C) Sendo fundamental para a definição da gravidade da valvopatia, das repercussões hemodinâmicas e dos parâmetros que não estão relacionados à chance de sucesso das intervenções.

D) Sendo fundamental para a definição da gravidade da valvopatia, das repercussões hemodinâmicas e dos parâmetros que estão relacionados à chance de sucesso das intervenções.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278610)

Enunciado: Durante a abordagem da Emergências Hipertensivas (EH), o profissional deverá realizar a diferenciação entre emergência e urgência, fazendo o diagnóstico correto das diversas situações de EH, a fim de selecionar a terapia mais adequada para cada Lesão de Órgão Alvo LOA.

A) Isso é muito importante, pois o diagnóstico e o tratamento corretos podem evitar agravamento do quadro clínico decorrente da situação crítica.

B) Isso é muito importante, pois o diagnóstico e o tratamento corretos não evitam agravamento do quadro clínico decorrente da situação crítica.

C) Isso não é importante, pois o diagnóstico e o tratamento incorretos podem evitar agravamento do quadro clínico decorrente da situação crítica.

D) Isso é muito importante, pois o diagnóstico e o tratamento incorretos podem evitar agravamento do quadro clínico decorrente da situação crítica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278611)

Enunciado: A proteína C reativa elevada foi preditoras independente de doença coronariana e cerebrovascular, podemos indicar como correto que:

A) Sendo um marcador menos importante para hipertensos resistentes mais jovens, obesos, com MAPA não controlado e padrão não dipper (descenso noturno ausente ou atenuado).

B) Sendo um marcador mais importante para hipertensos resistentes mais idosos, obesos, com MAPA não controlado e padrão não dipper (descenso noturno ausente ou atenuado).

C) Sendo um marcador mais importante para hipertensos resistentes mais jovens, obesos, com MAPA controlado e padrão dipper (descenso noturno ausente ou atenuado).

D) Sendo um marcador mais importante para hipertensos resistentes mais jovens, obesos, com MAPA não controlado e padrão não dipper (descenso noturno ausente ou atenuado).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278613)

Enunciado: Atualmente, várias opções terapêuticas medicamentosas estão disponíveis para o tratamento das Emergências Hipertensivas (EH). O fármaco anti-hipertensivo ideal para uso parenteral deve apresentar as seguintes características listadas abaixo, indique a errada.

A) capacidade de reverter alterações fisiopatológicas envolvidas.

B) rápido início de ação.

C) curva dose-resposta imprevisível.

D) mínimo ajuste de dosagem.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

280403)

Enunciado: Por outro lado, pacientes com Insuficiência Mitral (IM) importante devem prosseguir no fluxograma de avaliação específica, buscando-se sintomas secundários à valvopatia e/ou presença de complicadores. Sendo adequado o item:

A) Os pacientes com IM anatomicamente discreta ou moderada não deverão ser mantidos em acompanhamento clínico e ecocardiográfico periódicos, sem indicação de intervenção (medicamentosa ou cirúrgica) para interrupção da história natural da doença valvar.

B) Os pacientes com IM anatomicamente discreta ou moderada deverão ser mantidos em acompanhamento clínico e ecocardiográfico periódicos, com indicação de intervenção (medicamentosa ou cirúrgica) para interrupção da história natural da doença valvar.

C) Os pacientes com IM anatomicamente grave deverão ser mantidos em acompanhamento clínico e ecocardiográfico periódicos, sem indicação de intervenção (medicamentosa ou cirúrgica) para interrupção da história natural da doença valvar.

D) Os pacientes com IM anatomicamente discreta ou moderada deverão ser mantidos em acompanhamento clínico e ecocardiográfico periódicos, sem indicação de intervenção (medicamentosa ou cirúrgica) para interrupção da história natural da doença valvar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278086)

Enunciado: Assim, hipertensão arterial resistente não controlada (HAR-NC) é definida como uma PA que permanece acima do nível desejado (140/90 mmHg), sendo correto o item:

A) Apesar do uso não concomitante de quatro ou mais agentes anti-hipertensivos de diferentes classes e um quarto fármaco, que geralmente é um antagonista do receptor mineralocorticoide ou um bloqueador simpático central.

B) Apesar do uso concomitante de quatro ou mais agentes anti-hipertensivos de iguais classes e um quarto fármaco, que geralmente é um antagonista do receptor mineralocorticoide ou um bloqueador simpático central.

C) Apesar do uso concomitante de quatro ou mais agentes anti-hipertensivos de diferentes classes e um quarto fármaco, que geralmente é um antagonista do receptor mineralocorticoide ou um bloqueador simpático central.

D) Apesar do uso concomitante de quatro ou mais agentes anti-hipertensivos de diferentes classes e um quarto fármaco, que não pode ser um antagonista do receptor mineralocorticoide ou um bloqueador simpático central.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

279037)

Enunciado: Para pessoas com Cardiopatia Chagásica em fase inicial, podemos indicar como correto:

A) Apresentam somente alterações no eletrocardiograma (ECG), com fração de ejeção (FE) anormal, ausência de insuficiência cardíaca (IC) e presença de arritmias graves, tanto o tratamento quanto não tratar com benznidazol são alternativas válidas.

B) Apresentam somente alterações no eletrocardiograma (ECG), com fração de ejeção (FE) normal, ausência de insuficiência cardíaca (IC) e ausência de arritmias graves, somente o tratamento com benznidazol é alternativa válida.

C) Apresentam somente alterações no eletrocardiograma (ECG), com fração de ejeção (FE) normal, ausência de insuficiência cardíaca (IC) e ausência de arritmias graves, tanto o tratamento quanto não tratar com benznidazol são alternativas válidas.

D) Não apresentam alterações no eletrocardiograma (ECG), com fração de ejeção (FE) normal, ausência de insuficiência cardíaca (IC) e ausência de arritmias graves, tanto o tratamento quanto não tratar com benznidazol são alternativas válidas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

278634)

Enunciado: Quais os fatores mais importantes na fisiopatologia da obstrução da faringe durante o sono em crianças com síndrome da apneia obstrutiva do sono e doenças neuromusculares ou neurológicas?

A) Aumento do tecido mole ou diminuição da estrutura óssea circunjacente.

B) Hipertrofia de tonsilas faríngea e palatinas.

C) Hipertrofia de tonsilas palatinas e adenoide.

D) Hipotonia muscular ou redução do controle ventilatório central.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

280464)

Enunciado: Médico-Líder no Programa de Reabilitação Cardiovascular coordena as ações médicas, sendo correto que possui a seguinte função:

A) Executar a avaliação pré-participação, com inclusão de testes de exercício, de modo a subsidiar a programação inicial das sessões de treinamento da Reabilitação Cardiovascular - RCV.

B) Executar a avaliação pré-participação, com inclusão de testes de exercício, de modo a subsidiar a programação final das sessões de treinamento da Reabilitação Cardiovascular - RCV.

C) Executar a avaliação pós-participação, com inclusão de testes de exercício, de modo a subsidiar a programação inicial das sessões de treinamento da Reabilitação Cardiovascular - RCV.

D) Jamais executar a avaliação pré-participação, com inclusão de testes de exercício, de modo a subsidiar a programação inicial das sessões de treinamento da Reabilitação Cardiovascular - RCV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249381)

Enunciado: Considerando as aplicações da monitorização residencial da pressão arterial, não podemos apenas indicar como inadequado que:

A) As variações dia a dia da PA podem ser avaliadas.

B) Variações permitem estabelecer separadamente as medidas do período matinal e do entardecer/anoitecer.

C) A PA matinal não pode estar associada a dano em órgão-alvo como AVE.

D) A associação de dano em órgão-alvo com a PA durante o entardecer/anoitecer da MRPA pode ser equivalente à PA durante o sono da MAPA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249285)

Enunciado: No diabetes, a hipotensão ortostática (HO) ocorre, frequentemente, consiste em redução da PA sistólica, de pelo menos 20 mmHg, ou da PA diastólica, de pelo menos 10 mmHg, em 1 a 3 minutos após se assumir posição ortostática. Sendo correto que:

A) Consequência de denervação parassimpática vasomotora eferente, reduzindo a vasoconstrição do leito vascular esplâncnico e periférico.

B) Consequência de denervação simpática vasomotora aferente, reduzindo a vasoconstrição do leito vascular esplâncnico e periférico.

C) Consequência de denervação simpática vasomotora eferente, reduzindo a vasoconstrição do leito vascular esplâncnico e periférico.

D) Consequência de denervação simpática vasomotora eferente, aumentando a vasoconstrição do leito vascular esplâncnico e periférico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249290)

Enunciado: Assinale a alternativa que apresenta alterações cognitivas presentes na criança com síndrome da apneia obstrutiva do sono.

A) São achados de exame.

B) Podem estar presentes desde o ronco primário.

C) São sempre encaminhadas para psicoterapia.

D) Devem ser muito valorizadas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249210)

Enunciado: Marque a alternativa correta sobre a cirurgia de adenotonsilectomia.

A) Deve ser sempre indicada na síndrome da apneia obstrutiva do sono independente do grau de obstrução e da queixa dos pais.

B) Tem seus riscos e está contraindicada em obesos e menores de 02 anos.

C) Pode ser indicada como tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono na criança, mas pode não melhorar a apneia.

D) Deve ser sempre indicada, independentemente da faixa etária ou dos riscos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215470)

Enunciado: Elevação matinal precoce da PA ? calculada pela diferença entre a PAS matinal (média das pressões nas primeiras duas horas após o despertar) e a menor PAS durante o sono (média da pressão mais baixa e das pressões imediatamente antes e após a mais baixa) ? tem sido associada a desfechos cardiovasculares. É CORRETO, apenas, que:

A) A dificuldade da padronização do cálculo desse parâmetro e a sua baixa reprodutibilidade indicam que deve ser usado na prática clínica.

B) A dificuldade da padronização do cálculo desse parâmetro e a sua baixa reprodutibilidade indicam que ele não deve ser usado na prática clínica.

C) A facilidade da padronização do cálculo desse parâmetro e a sua baixa reprodutibilidade indicam que ele não deve ser usado na prática clínica.

D) A dificuldade da padronização do cálculo desse parâmetro e a sua alta reprodutibilidade indicam que ele não deve ser usado na prática clínica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215485)

Enunciado: A variabilidade extraída a partir das diferenças de cada medida é denominada variabilidade de curto período (short term variability). Aponte, apenas. a CORRETA.

A) Está identificada uma associação positiva entre mortalidade e variabilidade sistólica diurna de curto período. Diante de tais resultados, a redução da variabilidade da PA não têm implicações terapêuticas independentemente da redução das médias de PA.

B) Está identificada uma associação positiva entre mortalidade e variabilidade sistólica diurna de curto período. Diante de tais resultados, a redução da variabilidade da PA poderia ter implicações terapêuticas independentemente da redução das médias de PA.

C) Está identificada uma associação positiva entre mortalidade e variabilidade sistólica diurna de curto período. Diante de tais resultados, a redução da variabilidade da PA poderia ter implicações terapêuticas dependentemente da redução das médias de PA.

D) Está identificada uma associação negativa entre mortalidade e variabilidade sistólica diurna de curto período. Diante de tais resultados, a redução da variabilidade da PA poderia ter implicações terapêuticas independentemente da redução das médias de PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215494)

Enunciado: Suporte ventilatório não invasivo com pressão positiva está indicado em todos os pacientes com Insuficiência Cardíaca e com SatO2 < 90% com esforço respiratório, ou desconforto respiratório, que não apresentaram melhora com oxigenoterapia. Apenas um dos itens abaixo se mostra com dados INCORRETOS, aponte-o.

A) Nos pacientes com edema agudo de pulmão associados com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), há benefício comprovado para redução da mortalidade com o suporte invasivo.

B) Também está indicado nos pacientes com edema agudo de pulmão, com benefícios comprovados na redução de evolução para suporte ventilatório invasivo.

C) O suporte respiratório tem como alvos estabelecer Saturação de Oxigênio (SatO2) > 90% e redução do trabalho respiratório, tendo como opções a oxigenoterapia com cateter nasal ou máscara, o suporte ventilatório não invasivo com pressão positiva e o suporte ventilatório invasivo com pressão positiva.

D) Oxigenoterapia está indicada em todos os pacientes com SatO2 < 90%, com cateter nasal ou máscara, com oxigênio a 100% 3 a 5 L/minuto, sendo que, em pacientes com DPOC, o recomendado é 1 a 2 L/minuto, para evitar a indução de hipercapnia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215230)

Enunciado: No cenário da Insuficiência Cardíaca (IC) avançada, a classificação clínica dos pacientes, baseada nas classes funcionais propostas pela New York Heart Association (NYHA), que é funcional e usada para descrever e classificar a gravidade dos sintomas apresenta indicações e limitações. Qual dos itens abaixo está INADEQUADO?

A) Não mais possibilita adequada seleção dos pacientes que se beneficiarão de cardio-desfibriladores implantáveis.

B) Não mais possibilita adequada seleção dos pacientes que se beneficiarão de ressincronizadores ventriculares e transplante cardíaco.

C) Não mais possibilita adequada seleção dos pacientes que se beneficiarão de Dispositivos de Assistência Circulatória Mecânica (DACM).

D) Possibilita adequada seleção dos pacientes que se beneficiarão de terapias medicamentosas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215503)

Enunciado: Os opioides aliviam ansiedade e dispneia dos pacientes com edema agudo de pulmão, mas o uso rotineiro não é recomendado, devido a riscos de efeitos adversos, como os listados abaixo, indique o INADEQUADO.

A) Náusea.

B) Bradicardia e depressão respiratória.

C) Hipertensão.

D) Controvérsias a respeito de maior risco de mortalidade com seu uso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215510)

Enunciado: As cargas de pressões da MAPA expressam a percentagem de medidas acima dos valores de normalidade para as 24 horas, vigília e sono.

A) Avaliação prospectiva em estudo populacional indica que esse parâmetro possa modificar a estratificação de risco fornecida pelas médias de PA.

B) Avaliação prospectiva em estudo populacional não indica que esse parâmetro não possa modificar a estratificação de risco não fornecida pelas médias de PA.

C) Avaliação prospectiva em estudo populacional não indica que esse parâmetro possa modificar a estratificação de risco fornecida pelas baixas e não médias de PA.

D) Avaliação prospectiva em estudo populacional não indica que esse parâmetro possa modificar a estratificação de risco fornecida pelas médias de PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215517)

Enunciado: O edema agudo de pulmão pode ser a apresentação clínica inicial de cerca de pacientes hospitalizados por Insuficiência Cardíaca (IC), somente NÃO sendo correta uma alternativa. Marque-a.

A) A crise hipertensiva, a insuficiência mitral aguda (disfunção do músculo papilar secundária à doença isquêmica ou ruptura espontânea) são os fatores causais mais comuns de edema agudo de pulmão cardiogênico.

B) Síndrome coronariana aguda são os fatores causais mais comuns de edema agudo de pulmão cardiogênico.

C) A apresentação clínica, com hipotensão arterial e sinais de baixo débito cardíaco, é menos frequente e, em geral não observada em pacientes com IC crônica agudizada.

D) Os pacientes com edema agudo de pulmão apresentam modelos distintos de distribuição volêmica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

216305)

Enunciado: Novas tecnologias ecocardiográficas, como speckle tracking com strain longitudinal ventricular são mais sensíveis em detectar disfunção miocárdica subclínica do que as medidas da função sistólica global. Podemos concordar apenas com o item CORRETO:

A) A avaliação ecocardiográfica por parâmetros convencionais, como a FEVE, é raramente afetada por mudanças contínuas nas condições de pré-carga e pós-carga.

B) A avaliação ecocardiográfica por parâmetros convencionais, como a FEVE, é frequentemente afetada por mudanças contínuas nas condições de pré-carga e mas não de pós-carga.

C) A avaliação ecocardiográfica por parâmetros convencionais, como a FEVE, é frequentemente afetada por mudanças contínuas nas condições de pré-carga e pós-carga.

D) A avaliação ecocardiográfica por parâmetros convencionais, como a FEVE, é frequentemente afetada por mudanças contínuas nas condições somente de pós-carga.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215242)

Enunciado: Na abordagem inicial dos pacientes com sinais e sintomas sugestivos de Insuficiência Cardíaca (IC) crônica ambulatorial, recomenda-se a realização de diversos exames laboratoriais complementares, estando INADEQUADO que:

A) Para avaliar a presença e a gravidade de lesões somente no coração.

B) Para detectar comorbidades.

C) Para verificar fatores agravantes do quadro clínico.

D) A realização de exames seriados pode ser necessária para a monitoração de variáveis de segurança, durante o tratamento da IC, incluindo função renal e eletrólitos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215525)

Enunciado: Os pacientes com edema agudo de pulmão apresentam modelos distintos de distribuição volêmica sendo Insuficiência Cardíaca (IC) aguda nova com congestão pulmonar sem hipervolemia periférica (IC de novo). Somente sendo INADEQUADO que:

A) Neste modelo hemodinâmico, o tratamento tem como objetivo redistribuir o volume da circulação pulmonar para a circulação periférica.

B) A melhoria da distribuição de volume é feita por ação de vasodilatadores com uso judicioso de diuréticos e suporte ventilatório com pressão positiva não invasiva de baixa pressão, para reduzir o trabalho respiratório e a hipoxemia, que podem reduzir as taxas de intubação e de mortalidade.

C) O uso de ventilação não invasiva é recomendado em pacientes com congestão pulmonar associada a desconforto respiratório e/ou hipoxemia.

D) É recomendável ter-se cautela com pacientes hipotensos (pressão positiva pode aumentar a pressão arterial) e em pacientes após IAM, os quais podem ter pior evolução.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215532)

Enunciado: Insuficiência Cardíaca (IC) crônica agudizada apresenta o outro modelo de edema agudo de pulmão, somente sendo INCORRETO que:

A) Apresenta congestão pulmonar, mas não a sistêmica.

B) O tratamento tem como prioridade a redução da volemia.

C) Indicação de uso, em larga escala, de diuréticos associados a vasodilatadores e, por vezes, inotrópicos.

D) Em pacientes com sinais de baixo débito com hipotensão arterial, o suporte inotrópico é o tratamento de escolha.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215249)

Enunciado: A realização de Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações é recomendada na avaliação inicial de todos os pacientes com insuficiência cardíaca, para avaliar sinais de cardiopatia que podem demandar cuidados e tratamentos específicos. Marque a opção INCORRETA.

A) Vários destes aspectos são marcadores prognósticos em muitas cardiopatias, como na chagásica crônica.

B) Para avaliar sinais de cardiopatia estrutural como hipertrofia ventricular esquerda, isquemia miocárdica e áreas de fibrose.

C) A detecção de Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE), com alargamento pronunciado da duração do complexo QRS, não altera a indicação da Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC).

D) Para avaliar distúrbios da condução atrioventricular, bradicardia ou taquiarritmias, que podem demandar cuidados e tratamentos específicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215255)

Enunciado: A radiografia simples do tórax, por sua simplicidade, rapidez de obtenção e ampla disponibilidade, é recomendada na avaliação inicial dos pacientes com sinais e sintomas de Insuficiência Cardíaca. Portanto, é INCORRETO:

A) Para a avaliação de cardiomegalia e congestão pulmonar.

B) Sensibilidade do método é bastante limitada e, ainda, que a disfunção sistólica cardíaca significativa pode ocorrer somente com cardiomegalia na radiografia de tórax.

C) O método tem maior valor no contexto da IC aguda, em que as alterações de congestão pulmonar são mais intensas.

D) A radiografia de tórax também é útil por sua capacidade de identificar causas pulmonares de dispneia, como doença pulmonar intersticial, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), neoplasia pulmonar e pneumonia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215263)

Enunciado: O Ecocardiograma Transtorácico Bidimensional com análise dos fluxos pelo método doppler (Eco-2D-Doppler) é o teste diagnóstico por imagem preferencial para avaliação inicial dos pacientes com suspeita de Insuficiência Cardíaca (IC), por sua ampla disponibilidade e por prescindir do uso de radiação ionizante. Estando ADEQUADO que:

A) Método amplamente abrangente, o ecocardiograma não pode identificar acuradamente a presença de alterações estruturais cardíacas.

B) Pode identificar acuradamente incluindo anormalidade do miocárdio, das válvulas cardíacas e do pericárdio, sem avaliar aspectos hemodinâmicos.

C) O ecocardiograma permite a avaliação simultânea de múltiplas variáveis relevantes, do ponto de vista clínico, útil para a compreensão das manifestações clínicas.

D) Auxilia no planejamento terapêutico, mas não na estratificação prognóstica dos pacientes com IC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215284)

Enunciado: Indicações de uso do Ecocardiograma Transtorácico como teste diagnóstico por imagem preferencial para avaliação inicial dos pacientes com suspeita de Insuficiência Cardíaca IC, por sua ampla disponibilidade e por utilizar radiação ionizante, estando INADEQUADO que:

A) Existem inúmeros estudos mostrando que a avaliação da deformação miocárdica pela técnica de speckle tracking adiciona informações ao cenário clínico, constituindo um marcador precoce de disfunção ventricular, antes mesmo da alteração da fração de ejeção.

B) A estimativa do Global Longitudinal Strain vem sendo testada para a detecção subclínica da toxicidade cardíaca secundária à quimioterapia.

C) Tendo em vista um grande número de softwares e modalidades diferentes de execução, além da tecnologia necessária, a avaliação de deformação miocárdica está indicada na avaliação de rotina nos pacientes com IC.

D) A utilização do ecocardiograma transtorácico ou ultrassom torácico em conjunto com a avaliação clínica ajuda de forma significativa a estabelecer com maior certeza o modelo clínico?hemodinâmico do paciente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215290)

Enunciado: Dentro das recomendações para diagnóstico e tratamento da miocardite por doença de Chagas aguda ou reativação, devemos entender que a miocardite por doença de Chagas deve ser suspeitada nos seguintes cenários. Indique o item que se apresenta ERRADO.

A) Insuficiência Cardíaca (IC) de início recente.

B) Sinais de reativação da infecção pelo Trypanosoma cruzi no contexto de transplante de órgãos e/ou uso de imunossupressores, somente com sinais de IC.

C) Sinais de reativação da infecção por T. cruzi no contexto de síndrome da imunodeficiência adquirida com ou sem sinais de IC.

D) Alterações recentes em exames de ECG ou de imagem com ou sem sinais/sintomas de IC em paciente com epidemiologia positiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215294)

Enunciado: Os peptídeos natriuréticos, quando disponíveis, devem ser utilizados de rotina na avaliação diagnóstica admissional na sala de emergência de pacientes com dispneia ou suspeita de Insuficiência Cardíaca (IC) aguda, sendo INADEQUADO, apenas, que

A) Apresentam alto valor preditivo de IC quando analisados de forma isolada, ou quando associados ao exame clínico e radiológico do tórax.

B) Em decorrência dos vários fatores clínicos que podem estar associados à elevação dos peptídeos natriuréticos, reduzindo sua capacidade preditiva diagnóstica positiva.

C) Níveis séricos intermediários de BNP entre 100 e 500 pg/mL, ou NT-proBNP entre 300 e 900 pg/mL necessitam da correlação clínica para confirmação do diagnóstico da IC aguda. Por outro lado, a presença de níveis elevados de BNP > 500 pg/mL e NT-proBNP > 900 pg/mL indicam fortemente diagnóstico de IC aguda.

D) Os peptídeos natriuréticos apresentam baixa capacidade de afastar o diagnóstico (baixa sensibilidade), na presença de níveis séricos de BNP < 100 pg/mL e NT-proBNT < 300 pg/mL.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215300)

Enunciado: Em situações clínicas de rápida instalação, como edema agudo de pulmão em flush, na insuficiência mitral aguda, ou no cor pulmonale agudo, podemos observar níveis não elevados dos peptídeos natriuréticos. Sendo CORRETO que, em pacientes:

A) Sem uso do medicamento sacubitril-valsartana, a inibição da neprilisina pelo sacubitril promove elevação nos níveis séricos do BNP, mas não do NT-proBNP, interferindo na acurácia diagnóstica do BNP. Nestes pacientes, devemos utilizar o NT-proBNP.

B) Em uso do medicamento sacubitril-valsartana, a inibição da neprilisina pelo sacubitril, não promove elevação nos níveis séricos do BNP, mas não do NT proBNP, interferindo na acurácia diagnóstica do BNP. Nestes pacientes, devemos utilizar o NT-proBNP.

C) Em uso do medicamento sacubitril-valsartana, a inibição da neprilisina pelo sacubitril promove elevação nos níveis séricos do BNP, mas não do NT proBNP, interferindo na acurácia diagnóstica do BNP. Nestes pacientes, devemos utilizar o NT-proBNP.

D) Em uso do medicamento sacubitril-valsartana, a inibição da neprilisina pelo sacubitril promove redução nos níveis séricos do BNP, mas não do NT proBNP, interferindo na acurácia diagnóstica do BNP. Nestes pacientes, devemos utilizar o NT-proBNP.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215555)

Enunciado: Os pacientes com Hipertensão Arterial Pulmonar - HAP devem ser submetidos à avaliação clínica periódica com equipe de serviço especializado ou de centro de referência (pneumologistas, cardiologistas e reumatologistas, em caso de HAP associada a doenças do tecido conjuntivo), para consideração dos sinais de insuficiência ventricular direita e síncope, da classe funcional, do teste de caminhada de 6 minutos e de ecocardiografia. Está INCORRETA a alternativa:

A) A primeira avaliação deve ser realizada 3 meses após o início do tratamento, tendo em vista que a maioria dos estudos utilizou esse prazo para confirmar a resposta ao tratamento medicamentoso.

B) Para os pacientes que se mantêm em nível estável e satisfatório após início do tratamento, preconiza-se manter acompanhamento semestral ou anual em serviço especializado.

C) Pacientes em nível estável, mas não satisfatório, devem manter acompanhamento trimestral em serviço especializado ou centro de referência para otimização terapêutica.

D) Pacientes em nível instável e deteriorando, apesar do tratamento, não são candidatos a transplante pulmonar, independentemente do início do tratamento; devem ser reavaliados pelo menos trimestralmente em serviço especializado ou em
centro de referência e mantidos sob acompanhamento simultâneo com as equipes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215283)

Enunciado: Outros exames laboratoriais que devem ser solicitados na admissão são: troponina (na suspeita de doença arterial coronária, miocardite ou Takotsubo), entre outros, somente estando INADEQUADO nesse conceito, o item que se apresenta errado. Indique-o.

A) O ECG permite suspeitar da etiologia da IC e da causa da descompensação. A presença de um ECG normal é comum, e praticamente não exclui doença miocárdica crônica.

B) Na admissão do paciente, é necessária a avaliação por meio do monitor, com confirmação posterior pelo ECG de taquiarritmias ou bradiarritmias, que demandem intervenção terapêutica imediata.

C) O ecocardiograma deve ser realizado em todos os pacientes dentro das primeiras 48 horas da admissão.

D) A realização precoce do ecocardiograma apresenta particular importância nos pacientes com choque cardiogênico e IC aguda nova.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212220)

Enunciado: Insuficiência cardíaca é uma síndrome em que o coração não é capaz de ofertar oxigênio aos tecidos em taxa adequada às demandas ou o faz à custa de elevação de sua pressão de enchimento (pré-carga). Geralmente, resulta de disfunção estrutural ou funcional. Assinale a alternativa que contempla uma causa de insuficiência cardíaca diastólica.

A) Sepse.

B) Doença de Chagas.

C) Estenose valvar aórtica.

D) Síndrome de Takotsubo.

E) Miocardiopatia periparto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215478)

Enunciado: Assinale a alternativa INCORRETA sobre o efeito analgésico da medicação alfa-2 agonista.

A) Por via sistêmica, potencializa o efeito analgésico do opioide pela regulação do aumento da substância P (neuromodulador) no SNC.

B) Estimula receptores alfa-2 agonistas com redução do estímulo simpático.

C) Melhor efeito analgésico via epidural, pois atinge maiores concentrações.

D) Por via oral, potencializa o efeito analgésico do opioide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182726)

Enunciado: Não podemos determinar como correto o seguinte item referenciando a ecocardiografia transtorácica como método diagnóstico, assim indique o item ERRADO dos listados abaixo.

A) A ecocardiografia transtorácica é o principal método diagnóstico em pacientes com IC suspeita ou conhecida.

B) A ecocardiografia transtorácica por este método, incluindo formas refinadas de análise, como a do strainmiocárdico e a ecocardiografia tridimensional, podemos avaliar com pequena precisão os volumes ventriculares, a fração de ejeção, o débito cardíaco.

C) A ecocardiografia de rotina não é indicada em todo paciente cardiopata em pré-operatório, pois ainda não há evidências de que seu uso esteja associado ao aumento da sobrevida ou à menor permanência hospitalar.

D) A ecocardiografia transtorácica em uso pré-operatório, pelo contrário, aumenta o tempo de hospitalização, sem benefício clínico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183563)

Enunciado: Não pode ser determinado como adequado a pacientes com Insuficiência Cardíaca Descompensada ICD na fase avançada, o seguinte item:

A) Outro fator importante, presente em pacientes com Insuficiência Cardíaca Descompensada ICD na fase avançada, é a elevação de citocinas, com o achado de maiores níveis do fator de necrose tumoral, de interleucina-6 e de endotelinas. Estas alterações são responsáveis pela caquexia nos pacientes graves com ICD.

B) Em uma fase mais avançada, a maior estimulação neuro-humoral se faz com predomínio dos neuro-hormônios com efeito vasoconstritor, estes induzem aumento da resistência periférica e piora da função cardíaca, levando o coração para um círculo vicioso de agravamento progressivo.

C) Nesta fase, drogas que modulem a estimulação neuro-humoral aumentada são aquelas que influenciam positivamente a evolução da doença.

D) A fisiopatologia dos pacientes com função sistólica preservada não é diferente da de pacientes com baixa fração de ejeção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183597)

Enunciado: A terapêutica antiviral tem como objetivo promover a eliminação viral como também impedir a sua replicação. Quanto a isso, podemos considerar INCORRETO que:

A) Dentre as possibilidades terapêuticas, temos a infusão subcutânea de interferon-ß (IFN- ß) e a imunoglobulina intravenosa (IG- IV).

B) A infusão subcutânea de IFN-ß em pacientes com cardiomiopatia dilatada e persistência viral (adenovírus e enterovírus) não demonstrou eliminação viral, mas melhora clínica da capacidade funcional e função ventricular.

C) Em pacientes com miocardite viral por parvovírus-B19, o IFN-ß esteve associado à redução da carga viral, melhora da função endotelial e da função ventricular.

D) A terapêutica com IFN-ß em pacientes com miocardite viral está se consolidando como opção terapêutica antiviral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183608)

Enunciado: IC - Insuficiência Cardíaca pode ser classificada de diferentes formas, sendo que ainda não existe uma classificação consensual, havendo vantagens e desvantagens entre as existentes. A classificação Clínico/Hemodinâmico, além de nos permitir melhor avaliação diagnóstica e de tratamento para todos os tipos de pacientes com ICD, permite também traçar o prognóstico destes pacientes. Sendo concebido como INADEQUADO que:

A) Diferentes formas de apresentação não são facilmente caracterizadas através da abordagem clínica direta.

B) As classificações têm como objetivo estabelecer o tratamento mais correto de acordo com o quadro clínico específico de cada paciente no momento do diagnóstico.

C) Para orientação prática do tratamento da ICD no SAVIC adotamos a Classificação Clínico/Hemodinâmico, que é a mais atual e é a classificação que procura melhor descrever os aspectos clínicos da gravidade do paciente desde o momento de chegada na sala de emergência.

D) Por meio da observação da perfusão periférica do paciente e de seu grau de congestão pulmonar através da ausculta pulmonar e estase jugular, ela permite fácil aplicação em todos os setores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183055)

Enunciado: A Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH) é a doença cardíaca genética maior causadora de morte súbita em jovens, com uma prevalência

de 1 para cada 500 adultos. Não sendo possível concordar com seguinte item abaixo

A) Trata-se de uma doença genética de herança autossômica dominante e atualmente reconhecida como do sarcômero cardíaco.

B) Entre os mecanismos fisiopatológicos, estão implicadas mutações nos genes que codificam as principais proteínas estruturais da

arquitetura miocárdica.

C) A heterogeneidade genética é uma característica dessa doença, observando-se diversos padrões de localização e extensão da

hipertrofia.

D) A expressão clínica da doença é pouco variável, sendo a maioria dos portadores assintomática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183616)

Enunciado: Resultados sugerem que o benefício terapêutico da imunoglobulina-IV IG-IV deve ser reservado ao cenário de miocardites com processo inflamatório ativo, avaliado por imunohistoquímica, e identificação viral positiva. Estando INCORRETO que:

A) Ela promove a redução da ativação e ação das citocinas pró-inflamatórias, possui propriedade anti-idiotípica com consequente redução da produção e neutralização dos autoanticorpos.

B) A IG-IV apresenta ainda ação antiviral por reduzir a replicação e favorecer a eliminação viral.

C) A utilização da IG-IV em cardiomiopatia dilatada de início recente não demonstrou benefício na melhora da função ventricular frente ao placebo.

D) Na miocardite por PV-B19 temos uma persistência de carga viral em cerca de 40% dos pacientes após a utilização da IG-IV, sendo que os pacientes que tiveram eliminação do PV-B19 evoluíram com piora da função ventricular, apesar de redução dos diâmetros cavitários.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183065)

Enunciado: Apesar de importantes para a estratificação de risco e orientação da terapêutica nos portadores de Cardiomiopatia Hipertrófica CMH,

a sensibilidade e a especificidade desses critérios são limitadas. Os critérios clínicos estabelecidos de pior prognóstico na CMH são:

A) Septo interventricular com espessura > 30 mm, morte súbita prematura na família, história de síncope sem etiologia definida,

Taquicardia Ventricular Não Sustentada (TVNS) ao Holtere resposta normal da pressão arterial ao teste de esforço em indivíduos com menos de 40 anos.

B) Septo interventricular com espessura > 30 mm, morte súbita prematura na família, história de síncope sem etiologia definida,

Taquicardia Ventricular Não Sustentada (TVNS) ao Holter e resposta anormal da pressão arterial ao teste de esforço em indivíduos com menos de 60 anos.

C) Septo interventricular com espessura > 40 mm, morte súbita prematura na família, história de síncope sem etiologia definida,

Taquicardia Ventricular Não Sustentada (TVNS) ao Holter e resposta anormal da pressão arterial ao teste de esforço em indivíduos com menos de 40 anos.

D) Septo interventricular com espessura > 30 mm, morte súbita prematura na família, história de síncope sem etiologia definida,

Taquicardia Ventricular Não Sustentada (TVNS) ao Holter e resposta anormal da pressão arterial ao teste de esforço em indivíduos com menos de 40 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183073)

Enunciado: Ocorre pior prognóstico (morte súbita e evolução para Insuficiência Cardíaca Congestiva ? ICC) em pacientes com Cardiomiopatia

Hipertrófica CMH, com maior porcentagem de colágeno no miocárdio identificado pela biópsia.

Podemos, apenas, CONCORDAR que

A) analogamente à miocardiopatia isquêmica, vários indícios apontam que o mecanismo arritmogênico que levaria à morte súbita, nos portadores de CMH, esteja diretamente ligado à fibrose miocárdica, como sugerido por estudos demonstrando direta

correlação entre a presença de fibrose miocárdica visibilizada na Ressonância Magnética Cardiovascular - RMC e Taquicardia

Ventricular Não Sustentada TVNS registrada no Holter.

B) Analogamente à miocardiopatia isquêmica, vários indícios apontam que o mecanismo arritmogênico que levaria à morte súbita, nos portadores de CMH, esteja indiretamente ligado à fibrose miocárdica, como sugerido por estudos demonstrando direta

correlação entre a presença de fibrose miocárdica visibilizada na Ressonância Magnética Cardiovascular - RMC e Taquicardia

Ventricular Não Sustentada TVNS registrada no Holter.

C) ao contrário da miocardiopatia isquêmica, vários indícios apontam que o mecanismo arritmogênico que levaria à morte súbita, nos portadores de CMH, esteja diretamente ligado à fibrose miocárdica, como sugerido por estudos demonstrando direta correlação entre a ausência de fibrose miocárdica visibilizada na Ressonância Magnética Cardiovascular - RMC e Taquicardia Ventricular

Não Sustentada TVNS registrada no Holter.

D) analogamente à miocardiopatia isquêmica, vários indícios apontam que o mecanismo arritmogênico que levaria à morte súbita, nos portadores de CMH, não esteja diretamente ligado à fibrose miocárdica, como sugerido por estudos demonstrando direta

correlação entre a presença de fibrose miocárdica visibilizada na Ressonância Magnética

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Cardiovascular - RMC e Taquicardia

Ventricular Não Sustentada TVNS registrada no Holter.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183630)

Enunciado: Os diuréticos de alça (furosemida) são os medicamentos de primeira escolha, em decorrência do seu efeito venodilatador, que já tem início nos primeiros minutos da administração endovenosa. NÃO sendo adequado, porém, que:

A) Já tem uso consagrado, sem trabalhos que demonstrem redução na mortalidade, com grandes efeitos na hipervolemia e congestão.

B) Em decorrência dessa ação inicial, diminuem a pré-carga; além disso, são drogas que promovem grande eliminação de água livre, efeito este, mais precoce.

C) É o diurético de escolha nas descompensações agudas dos pacientes congestos.

D) A dose recomendada é de 1mg/Kg como dose de ataque.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183079)

Enunciado: A RM é um método bastante útil na avaliação da Cardiomiopatia Hipertrófica CMH, fornecendo informações que auxiliam no
diagnóstico e no prognóstico da doença. Estudos comparativos entre a Ressonância Magnética Cardiovascular RMC e a
ecocardiografia demonstraram melhor sensibilidade na detecção de segmentos com hipertrofia. Podemos, apenas, CONCORDAR
que,

A) nos casos de dúvida diagnóstica, especialmente nos casos de diferenciação de hipertrofia miocárdica em atletas, os achados de áreas de fibrose miocárdica, com padrão multifocal, apenas definem o diagnóstico da doença, uma vez que, hipertrofia fisiológica do exercício não resulta em áreas de fibrose miocárdica.

B) nos casos de dúvida diagnóstica, especialmente nos casos de diferenciação de hipertrofia miocárdica em atletas, os achados de
áreas de fibrose miocárdica, com padrão multifocal ou confluente, definem o diagnóstico da doença, uma vez que, hipertrofia fisiológica do exercício não resulta em áreas de fibrose miocárdica.

C) nos casos de dúvida diagnóstica, especialmente nos casos de diferenciação de hipertrofia miocárdica em atletas, os achados de áreas de fibrose miocárdica, com padrão multifocal ou confluente, não definem o diagnóstico da doença, uma vez que, hipertrofia fisiológica do exercício resulta em áreas de fibrose miocárdica.

D) nos casos de dúvida diagnóstica, especialmente nos casos de diferenciação de hipertrofia miocárdica em atletas, os achados de áreas de fibrose miocárdica confluente, definem o diagnóstico da doença, uma vez que, hipertrofia fisiológica do exercício resulta em áreas de fibrose miocárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183635)

Enunciado: O processo de imunomodulação tem como objetivo reduzir a agressão inflamatória e autoimune através da remoção e modulação de possíveis agentes agressores envolvidos na patogênese da miocardite. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) A terapia de imunoadsorção através de plasmaférese seletiva visa a retirada de autoanticorpos específicos associada à terapia

com IG-IV para imunomodulação inflamatória das citocinas e da produção dos autoanticorpos

B) A pentoxifilina apresenta como propriedades anti-inflamatórias o bloqueio da transcriptase do TNF-a e a redução dos níveis de interleucinas 2 e 6, com consequente redução dos efeitos de cardioagressão dessas citocinas.

C) A utilização da imunoadsorção em pacientes com cardiomiopatia inflamatória crônica com níveis séricos elevados de autoanticorpos contra ß1 neuroreceptor miocárdico associado à reposição de IG-IV, demonstrou redução da atividade inflamatória miocárdica e melhora clínica da classe funcional e da função ventricular, mas não maior sobrevida ao fim de cinco anos.

D) Na cardiomiopatia dilatada com IC crônica e na cardiomiopatia periparto, a utilização de pentoxifilina na posologia de 1200mg a 2400mg/dia, pelo período de seis meses, ocasionou melhora clínica da classe funcional e da função ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183032)

Enunciado: O coração de um atleta de alta performance é reconhecidamente diferente de um coração de um indivíduo não atleta, e essasmudanças tê m sido denominadas de síndrome do coração do atleta. NÃO sendo adequado que

A) A síndrome do coração do atleta, que é caracterizada pelo aumento da massa cardíaca, aumento do volume diastólico e do
diâmetro diastólico final nos casos de exercícios predominantemente de resistência (como, por exemplo, os praticantes de
maratona) e aumento da massa e hipertrofia predominantemente concêntrica nos casos dos exercícios predominantemente
isométricos (como, por exemplo, o halterofilismo).

B) É de fundamental importância a diferenciação do coração do atleta de condições patológicas, que podem produzir uma morfologia
cardíaca similar, porém potencialmente letal, de modo que, nesses casos, a continuação da prática esportiva colocaria o atleta em
risco.

C) A presença de fibrose costuma ocorrer no coração de atleta, com descrição de que alguns maratonistas e triatletas podem
apresentar algumas áreas de realce tardio.

D) Dadas as limitações previamente mencionadas do ecocardiograma e mesmo de testes fisiológicos, como o ergoespirométrico, a
Ressonância Magnética Cardiovascular - RMC pode auxiliar na diferenciação do coração de atleta de outras situações
patológicas por meio da avaliação detalhada da morfologia ventricular, assim como pela presença ou ausência de realce tardio
(fibrose) no miocárdio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183062)

Enunciado: Insuficiência Cardíaca Descompensada por Edema Agudo de Pulmão pode ser identificada no paciente que apresenta diversas características, EXCETO pelo item:

A) Quando apresenta aumento progressivo da pressão capilar pulmonar.

B) No qual ocorre aumento do líquido nos espaços intersticial e alveolar pulmonar.

C) Quando causa dispneia súbita e intensa ao repouso com saturação O2 < que 90% à respiração ambiente.

D) Quando esse quadro está comprovado pela radiografia de tórax.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183070)

Enunciado: O conhecimento da fisiopatologia da IC Insuficiência Cardíaca e da Insuficiência Cardíaca Descompensada ? ICD permite uma melhor compreensão na abordagem do paciente. Sendo INADEQUADO que,

A) Apesar da gravidade da doença, conhecendo-se princípios básicos de sua fisiopatologia, pode-se modificar sua evolução e mudar
o prognóstico da doença.

B) A causa mais comum de ICD é a redução da contratilidade miocárdica, geralmente associada à miocardiopatia isquêmica,
dilatada idiopática, chagásica ou hipertensiva.

C) Outras condições que levam à ICD são aquelas em que o coração é submetido à sobrecarga hemodinâmica apenas de volume,
distúrbios de FC (bradiarritmias ou taquiarritmias) ou condições que interfiram com o enchimento atrial.

D) Na fase inicial da IC, antes mesmo do estabelecimento da ICD, há diminuição da função miocárdica, e mecanismos adaptativos
são estimulados para corrigir a disfunção ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183646)

Enunciado: Nos estudos em que foi avaliada a relação entre o uso de insulina e insuficiência cardíaca - IC, verificou-se um impacto nulo ou de aumento de mortalidade. Estando CORRETO que:

A) É provável que a insulina represente apenas um confundidor, tendo em vista que muitas vezes a sua indicação de tratamento representa um DM inicial ou a presença de indicação para o uso de medicação oral (como insuficiência renal avançada), o que por si já demonstra status clínico mais grave.

B) É provável que a insulina represente apenas um confundidor, tendo em vista que muitas vezes a sua indicação de tratamento representa um DM avançado ou a presença de contraindicação para o uso de medicação oral (como insuficiência renal avançada), o que por si já demonstra status clínico mais grave. Nenhum estudo foi realizado, entretanto, com o objetivo de comparar objetivamente o impacto do tratamento com e sem insulina.

C) É improvável que a insulina represente apenas um confundidor, tendo em vista que muitas vezes a sua indicação de tratamento representa um DM avançado ou a presença de indicação para o uso de medicação oral (como insuficiência renal avançada).

D) É provável que a insulina represente apenas um confundidor, tendo em vista que muitas vezes a sua indicação de tratamento representa um DM avançado ou a ausência de contraindicação para o uso de medicação oral (como insuficiência renal inicial), o que por si já demonstra status clínico mais leve. Nenhum estudo foi realizado, entretanto, com o objetivo de comparar objetivamente o impacto do tratamento com e sem insulina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183122)

Enunciado: A situação clínica identificada no paciente que apresenta aumento abrupto da pressão capilar pulmonar, ocorrendo aumento do líquido nos espaços intersticial e alveolar pulmonar, causada de maneira súbita e intensa ao repouso deve ser entendida como

A) Insuficiência Cardíaca Descompensada por Edema Agudo de Pulmão.

B) Insuficiência Cardíaca Descompensada Aguda.

C) Insuficiência Cardíaca Descompensada por Alto Débito.

D) Insuficiência Cardíaca Descompensada Direita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183645)

Enunciado: A maioria dos pacientes vai necessitar do uso de mais de um medicamento para que sejam atingidas as metas de controle de Hipertensão. Sendo INADEQUADO que:

A) Pacientes com HA estágio 1 e com risco CV alto ou muito alto ou com DCV associada e aqueles com estágio 2 ou 3 com ou sem outros FRCV associados, devem ser considerados para o uso de combinação de fármacos.

B) A utilização de associações de dois medicamentos em baixas dosagens em hipertensos estágio 1, mesmo com baixo ou moderado risco CV, embora não preferencial, também poderá ser considerada em casos individuais.

C) Associação de DIU tiazídicos com poupadores de potássio. O uso de DIU de alça deve ser reservado para aqueles com RFG abaixo de 10 ml/min ou com edema grave.

D) Para a escolha dos medicamentos em associação, deve ser evitado o uso de anti-hipertensivos com mesmo mecanismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183038)

Enunciado: Insuficiência Cardíaca Descompensada por Edema Agudo de Pulmão pode ser entendida como a seguinte situação:

A) paciente que apresenta aumento abrupto da pressão capilar pulmonar, ocorrendo aumento do líquido nos espaços intersticial e alveolar pulmonar, causando dispneia súbita e intensa ao repouso com saturação O2 < que 90% à respiração ambiente, quadro este comprovado pela radiografia de tórax. Diagnóstico mais frequente em pacientes idosos, hipertensos, coronariopatas e diabéticos.

B) paciente que apresenta aumento abrupto da pressão capilar pulmonar, ocorrendo aumento do líquido nos espaços intersticial e alveolar pulmonar, causando dispneia súbita e intensa ao repouso com saturação O2 < que 95% à respiração ambiente, quadro este comprovado pela radiografia de tórax. Diagnóstico mais frequente em pacientes idosos, hipertensos, coronariopatas e diabéticos.

C) paciente que apresenta aumento progressivo da pressão capilar pulmonar, ocorrendo aumento do líquido nos espaços intersticial e alveolar pulmonar, causando dispneia súbita e intensa ao repouso com saturação O2 < que 80% à respiração ambiente, quadro este comprovado pela radiografia de tórax. Diagnóstico mais frequente em pacientes idosos, hipertensos, coronariopatas e diabéticos.

D) paciente que apresenta aumento abrupto da pressão capilar pulmonar, ocorrendo aumento do líquido nos espaços intersticial e alveolar pulmonar, causando dispneia progressiva e grave além de intensa ao repouso com saturação O2 < que 90% à respiração ambiente, quadro este comprovado pela radiografia de tórax. Diagnóstico mais frequente em pacientes idosos, hipertensos, coronariopatas e diabéticos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183592)

Enunciado: Dentro das classes de anti-hipertensivos, atualmente consideradas preferenciais para o controle da PA em monoterapia inicial, são verdadeiras as indicações, EXCETO:

A) Deve ser observado que os DIU são os fármacos que apresentam menos evidências de efetividade com relação aos desfechos CV, com claros benefícios para todos os tipos de eventos.

B) Há situações em que a indicação de um ou outro grupo ganha destaque, de acordo com a comorbidade presente.

C) O BB poderá ser considerado como fármaco inicial em situações específicas, como a associação de enxaqueca.

D) O BB poderá ser considerado como fármaco inicial em situações específicas, como a IC e a coronariopatia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183089)

Enunciado: Há várias evidências indicando que a suspensão dos betabloqueadores pode promover aumento da mortalidade, assim, deve-se evitar a suspensão sistemática dos betabloqueadores. Quando se suspeitar que eles são responsáveis pela instabilidade hemodinâmica dos pacientes, apenas podemos ACEITAR que

A) garantir a suspensão de drogas é aspecto importante a ser considerado é a suspensão dos betabloqueadores nos pacientes que fazem uso deles.

B) garantir a não suspensão de drogas é aspecto importante a ser considerado é a não suspensão dos betabloqueadores nos pacientes que fazem uso deles, devendo a dose ser ajustada e a suspensão somente ser realizada em casos de instabilidade hemodinâmica grave, bloqueios atrioventriculares avançados ou efeito colateral comprovadamente relacionado ao medicamento.

C) garantir a não suspensão de drogas é aspecto importante a ser considerado é a não suspensão dos betabloqueadores nos pacientes que fazem uso deles, devendo a dose ser ajustada e a suspensão somente ser realizada em casos de instabilidade hemodinâmica grave, bloqueios atrioventriculares de primeiro grau.

D) garantir a não suspensão de drogas é aspecto importante a ser considerado é a não suspensão dos betabloqueadores nos pacientes que fazem uso deles, não devendo a dose ser ajustada e a suspensão somente ser realizada em casos de instabilidade hemodinâmica grave, bloqueios atrioventriculares avançados ou efeito colateral comprovadamente relacionado ao medicamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181325)

Enunciado: Assinale a alternativa que representa o débito cardíaco.

A) Força exercida no miocárdio no final da diástole.

B) Produto do volume sistólico pela frequência cardíaca.

C) Mede a pós carga ou a resistência do ventrículo esquerdo.

D) Pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias.

E) Resistência, impedância ou pressão que os ventrículos têm que exercer para ejetar seu volume sanguíneo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181338)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 50 anos, obeso, diabético tipo 2, com HDL baixo e função renal normal, vem mantendo pressão arterial de 145 x 95 mmHg. Diante do quadro, qual a conduta terapêutica e meta pressórica a ser atingida?

A) Mudança do estilo de vida associada ao tratamento medicamentoso, com meta pressórica < 140 x 90 mmHg.

B) Mudança do estilo de vida associada ao tratamento medicamentoso, com meta pressórica < 140 x 80 mmHg.

C) Mudança do estilo de vida associada ao tratamento medicamentoso, com meta pressórica < 130 x 80 mmHg.

D) Mudança do estilo de vida por 3 meses; na falta de controle pressórico nesse período, iniciar tratamento farmacológico. Meta pressórica < 130 x 80 mmHg.

E) Mudança do estilo de vida por 6 meses; na falta de controle pressórico nesse período, iniciar tratamento farmacológico. Meta pressórica < 130 x 80 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183564)

Enunciado: No que se refere ao manejo de suporte de crianças com Hipertensão Arterial Pulmo (HAP), assinale a alternativa INCORRETA.

A) A anticoagulação com varfarina é contraindicada em crianças com doença tromboembólica, podendo ser benéfica em outros pacientes com HAP de outras etiologias.

B) Como a hipóxia é um vasoconstritor pulmonar potente, deve-se utilizar a suplementação com oxigênio para a sua correção em pacientes com HAP.

C) Deve-se tratar a insuficiência cardíaca e as arritmias com digoxina (melhora a contratilidade) e antiarrítmicos.

D) Os diuréticos são utilizados para tratar a sobrecarga de volume causada pela HAP associada com falência de ventrículo direito e

são utilizados habitualmente na doença mais avançada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183575)

Enunciado: O sildenafil tem sido utilizado com o objetivo de prevenir os episódios de Hipertensão Arterial Pulmonar, observando-se melhora na Pressão Arterial Pulmonar, no tempo para extubação e no tempo de permanência na UTI de crianças após a realização de cirurgia cardíaca. São efeitos adversos relacionados ao uso do sildenafil, EXCETO

A) dispepsia.

B) hipertensão arterial sistêmica.

C) epistaxe.

D) cefaleia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182741)

Enunciado: Aspectos importantes na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, com grande interação nos achados e na interpretação clínica da situação, sendo assim, assinale a alternativa CORRETA:

A) A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial. Maior ocorrência de EAB, hipotensão ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, podem dificultar a medição da PA.

B) A pseudo-hipertensão, não está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial. Maior ocorrência de EAB, hipotensão ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, podem dificultar a medição da PA.

C) A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece impalpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial. Maior ocorrência de EAB, hipotensão ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, podem dificultar a medição da PA.

D) A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 50 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial. Maior ocorrência de EAB, hipotensão ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, podem dificultar a medição da PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182760)

Enunciado: Ocorre uma grande variação da PA nos idosos ao longo das 24 horas, o que torna a MAPA uma ferramenta muitas vezes útil, também a pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de Osler. Dessa forma, indique a alternativa CORRETA:

A) Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a menor frequência do hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD.

B) Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no aparecimento precoce dos sons durante a deflação do manguito, não resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD.

C) Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD.

D) Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no aparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente baixos para a PAD.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182792)

Enunciado: A decisão terapêutica para tratamento da Pressão Arterial deve basear-se não apenas no nível da PA, mas considerar também a presença de Fatores de Risco, Lesões de Órgãos Alvos e Doença Cardiovascular concomitante. Em relação a isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Por outro lado, resultados de estudos clínicos controlados e randomizados com uso de fármacos anti-hipertensivos placebo-controlados em hipertensos demonstraram claramente redução significativa de mortalidade CV, AVE, infarto do miocárdio e IC. Cabe destacar que a maioria desses estudos avaliou indivíduos com idade "maior ou igual que" 55 anos, de alto risco CV e tempo de seguimento de 3 a 6 anos, limitando, portanto, a extrapolação desses benefícios para o tratamento de longo prazo e em pacientes com outras características.

B) Indivíduos com PA "maior ou igual que" 160/100 mmHg e/ou portadores de risco CV estimado alto, mesmo no estágio 1, devem iniciar de imediato o tratamento medicamentoso associado à terapia não medicamentosa.

C) A abordagem terapêutica da PA elevada inclui medidas não medicamentosas e o uso de fármacos anti-hipertensivos, a fim de reduzir a PA, proteger órgãos-alvo, prevenir desfechos CV e renais. Medidas não medicamentosas têm se mostrado ruins na redução da PA, pela perda de adesão a curto prazo.

D) Estudos com fármacos anti-hipertensivos, a maioria realizada com esse perfil de pacientes hipertensos estágios 2 e 3 e/ou de alto risco, demonstraram eficácia na redução da PA e proteção CV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

182802)

Enunciado: A abordagem de hipertensos estágio 1 de risco baixo e moderado, apresenta uma lacuna no rol de evidências em favor do impacto da terapia anti-hipertensiva sobre a redução de desfechos em hipertensos estágio 1 de risco baixo e moderado. Em relação a isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Nos hipertensos estágio 1 e moderado ou baixo risco CV, a terapia não farmacológica deve ser tentada por um ano.

B) Findo esse período no qual a falta de controle da PA condicionará o início de terapia farmacológica. Faz-se imperativo, contudo, acompanhar esses indivíduos com avaliação periódica da adesão às medidas não farmacológicas.

C) Constatada a falta de adesão às medidas não farmacológicas ou a piora dos valores pressóricos, dever-se-á iniciar precocemente a terapia farmacológica.

D) Vale destacar que a intervenção em hipertensos de baixo risco no estágio 1 pode prevenir a progressão para um risco CV mais elevado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158800)

Enunciado: Frequentemente há necessidade de associação de fármacos para o controle da pressão arterial. Qual a associação de fármacos que deve ser usada com cautela em pacientes diabéticos, em razão da dificuldade do controle glicêmico?

A) Betabloqueadores e diuréticos.

B) Diuréticos e bloqueadores dos receptores de angiotensina.

C) Inibidores da enzima conversora angiotensina e diuréticos.

D) Bloqueadores dos canais de cálcio e bloqueadores dos receptores de angiotensina.

E) Bloqueadores dos canais de cálcio e inibidores da enzima conversora de angiotensina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158795)

Enunciado: Paciente, 45 anos, obesa, comparece ao ambulatório e relata ser hipertensa e dislipidêmica. Traz resultados de exames laboratoriais: glicemia 120 mg/dl; triglicerídeos 180 mg/dl e LDL 160 mg/dl, e na consulta PA = 170 x 100 mmHg. Foi orientada a iniciar de imediato terapia não medicamentosa. Conforme a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, qual o estágio da hipertensão quando deve ser iniciada a terapia medicamentosa, qual a meta e a melhor conduta terapêutica a ser implementada?

A) Estágio 2, terapia medicamentosa deve ser iniciada após 3 meses da mudança no estilo de vida; < 130 x 80 mmHg; terapia combinada (duas classes diferentes).

B) Estágio 2, terapia medicamentosa deve ser iniciada de imediato; < 140 x 90 mmHg; terapia combinada (duas classes diferentes).

C) Estágio 2, terapia medicamentosa deve ser iniciada de imediato; < 130 x 80 mmHg; terapia combinada (duas classes diferentes).

D) Estágio 2, terapia medicamentosa deve ser iniciada de imediato; < 130 x 80 mmHg; monoterapia.

E) Estágio 3, terapia medicamentosa deve ser iniciada de imediato; < 130 x 80 mmHg; terapia combinada (duas classes diferentes).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161356)

Enunciado: Paciente feminina de 56 anos de idade, hipertensa mal controlada, evoluiu com agitação seguida de insuficiência respiratória nesta manhã. Sua pressão sistólica foi de 230 mmHg. Quando assumiu o seu turno no plantão, foi passado o caso como Encefalopatia Hipertensiva, após diagnóstico por Tomografia de Crânio. Dos achados a seguir, qual deles, na Tomografia, NÃO é compatível com o diagnóstico?

A) Edema Cerebral.

B) Apagamento de Sulcos.

C) Lâmina hiperdensa.

D) Dificuldade de separação de substância cinza e branca.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158754)

Enunciado: Paciente de 15 anos, sexo feminino, foi atendida na emergência com quadro de faringoamigdalite. O médico avaliou a paciente e a liberou para casa com prescrição de anti-inflamatório. Evoluiu com poliartrite, nódulos subcutâneos e cardite. Qual a lesão valvar mais frequente na febre reumática crônica?

A) Estenose mitral.

B) Estenose aórtica.

C) Estenose tricúspide.

D) Insuficiência aórtica.

E) Insuficiência mitral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161302)

Enunciado: Quando da escolha do tratamento anti-hipertensivo, ocorre a necessidade de grande raciocínio clínico a fim de determinar a escolha ideal, considerando paciente, mecanismo de ação das medicações, bem como seus efeitos colaterais. Acerca desse assunto, indique a opção considerada INCORRETA.

A) A metildopa pode provocar reações autoimunes, como febre, anemia hemolítica, galactorreia e disfunção hepática, que na maioria dos casos desaparecem com a cessação do uso.

B) Os Betabloqueadores promovem diminuição inicial do débito cardíaco, e aumento da secreção de renina, havendo readaptação dos barorreceptores e aumento das catecolaminas nas sinapses nervosas.

C) Os bloqueadores dos canais de cálcio agem primordialmente proporcionando redução da RVP como consequência da diminuição da quantidade de cálcio no interior das células musculares lisas das arteríolas, decorrente do bloqueio dos canais de cálcio na membrana dessas células.

D) Bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II, os BRA antagonizam a ação da angiotensina II por meio do bloqueio específico dos receptores AT1, responsáveis pelas ações vasoconstritoras, proliferativas e estimuladoras da liberação de androsterona, próprias da angiotensina II.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161392)

Enunciado: Paciente com Insuficiência Renal Crônica não dialítica apresenta hoje intensa dispneia demonstrando em sua ausculta pulmonar estertores e roncos difusos, sendo sua saturação de 80%. Foi indicado entubação e iniciada ventilação mecânica com altas FiO2. Sua pressão é de 230 x 120 mmHg. Iniciado Nitroprussiato de Sódio e solicitado avaliação da Nefrologia para possível Hemodiálise, assinale a alternativa considerada ADEQUADA.

A) Provavelmente não ocorrerá necessidade de hemodiálise após controle da hipertensão.

B) Foi inadequada a indicação de ventilação mecânica.

C) A opção por nitroprussiato foi inadequada.

D) Maior risco de toxicidade por disfunção orgânica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161226)

Enunciado: ?Medicação que promove a inibição direta da ação da renina com consequente diminuição da formação de angiotensina II. Outras ações podem contribuir para a redução da PA e a proteção tissular, tais como redução da atividade plasmática de renina, bloqueio de um receptor celular próprio de renina/pró-renina e diminuição da síntese intracelular de angiotensina II. Foi demonstrado sua eficácia anti-hipertensiva, bem como sua capacidade, em sonoterapia, de redução da PA de intensidade semelhante aos demais anti-hipertensivos.? Marque a alternativa a que corresponde essa afirmação.

A) BRA.

B) IECA.

C) Alisquireno.

D) Betabloqueador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161197)

Enunciado: Acerca da pesquisa diagnóstica de complicações em órgãos-alvo, relacionadas com a Hipertensão Arterial, as informações obtidas e otimizadas pelo Ecocardiograma estão corretas, com EXCEÇÃO de uma. Aponte-a.

A) Menos sensível do que o ECG no diagnóstico de HVE.

B) Agrega valor na avaliação das formas geométricas de hipertrofia e tamanho do átrio esquerdo.

C) Análise da função sistólica e diastólica.

D) Indicado na presença de indícios de HVE ao ECG ou pacientes com suspeita clínica de IC.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161203)

Enunciado: Em relação à decisão de tratamento da abordagem de hipertensos estágios 2 e 3 e/ou de alto risco, assinale a alternativa considerada CORRETA.

A) Indivíduos com PA (maior ou igual) 180/100 mmHg e/ou portadores de risco CV estimado alto, mesmo no estágio 1, devem iniciar de imediato o tratamento medicamentoso associado à terapia não medicamentosa.

B) Estudos com fármacos anti-hipertensivos, a maioria realizada com esse perfil de pacientes, demonstraram eficácia na redução

da PA e proteção CV.

C) Admite-se que a terapia não farmacológica isoladamente possa promover reduções da PA suficientes para o alcance da meta pressórica recomendada, sendo efetivo controle da PA e de outros FRCV frequentemente presentes.

D) Embora o benefício absoluto da terapia seja menor nos estágios 2 e 3, também aumenta o risco residual devido à frequente presença e influência de outros FR e LOA já instalada, neutralizando parte desse benefício. Essa observação reforça a importância de se abordar o risco CV de forma global.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161270)

Enunciado: Dentre as possíveis causas de hipertensão arterial secundária, ou seja, com etiologia definida e, acima de tudo, potencialmente curável, o Feocromocitoma (FEO) são tumores de células cromafins do eixo simpático-adreno-medular produtores de catecolaminas. A respeito disso, aponte a alternativa INCORRETA.

A) De 10% a 15% são extradrenais (paragangliomas), 10% são bilaterais e 90% são malignos.

B) Formas familiares apresentam traço autossômico dominante ou são parte de síndromes com mutações genéticas reconhecidas.

C) Presença de HA persistente ou paroxística (50%), paroxismos de cefaleia, sudorese profusa e palpitações (tríade clássica) são indicativos da doença.

D) O diagnóstico laboratorial é baseado em dosagens de catecolaminas e seus metabólitos no sangue e na urina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161414)

Enunciado: Dentre os objetivos de uma reabilitação cardiovascular e da prevenção secundária, podemos considerar como seus pilares da reabilitação cardiovascular os listados a seguir, com EXCEÇÃO de um. Indique-o.

A) Mudanças no estilo de vida com ênfase na atividade física programada, adoção de hábitos alimentares saudáveis, remoção do tabagismo e do uso de drogas em geral.

B) Uso de estratégias para modular o estresse.

C) O programa de RCV deve ter como objetivo, não só melhorar o estado fisiológico, mas sem poder interferir também o psicológico do paciente cardíaco.

D) O programa deve se basear em uma intervenção multidisciplinar (programa de exercício, educação, avaliação médica, avaliação nutricional etc.).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161359)

Enunciado: Dentro dos conceitos epidemiológicos básicos de Hipertensão Arterial, indique a alternativa que NÃO se encaixa perfeitamente nesse assunto.

A) Hipertensão Arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos = 140 e/ou 90 mmHg.

B) Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo.

C) Agravada pela presença de outros Fatores de Risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e Diabetes Melito (DM).

D) Mantém associação dependente com eventos, como morte súbita, Acidente Vascular Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Insuficiência Cardíaca (IC), Doença Arterial Periférica (DAP) e Doença Renal Crônica (DRC), fatal e não fatal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161366)

Enunciado: Dentre os diversos fatores de risco para Hipertensão Arterial, na realidade brasileira, estudos que avaliaram o impacto de polimorfismos na população não conseguiram identificar um padrão mais prevalente. Indique este fator.

A) Na ingestão de álcool.

B) na idade.

C) Na genética.

D) No sexo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161380)

Enunciado: Você participa do grupo de conselho de saúde de sua cidade, e como médico foi solicitado a opinar a respeito de estratégias para a implementação de medidas de prevenção e desenvolvimento da Hipertensão Arterial. Em relação à sua opinião sobre essas estratégias, assinale a alternativa considerada INCORRETA.

A) Englobam políticas públicas de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação.

B) O objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, e somente o tratamento medicamentoso contínuo.

C) O controle da PA e de FR associados por meio da modificação do estilo de vida (MEV).

D) Estimular uso regular de medicamentos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161383)

Enunciado: Sobre o sedentarismo no contexto brasileiro de hipertensos, estudos de nossa população revelaram prevalência geral de sedentarismo de 75,8%. Observou-se associação significativa entre HA e idade, sexo masculino, e diversos outros fatores, EXCETO por:

A) sobrepeso.

B) adiposidade central.

C) sedentarismo nos momentos de folga e durante o trabalho.

D) escolaridade inferior a 8 anos e renda per capita superior a 5 salários mínimos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161389)

Enunciado: Em referência aos procedimentos para se aferir à Pressão Arterial, marque a opção que NÃO se enquadra nesses procedimentos.

A) Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo.

B) Certificar-se de que o paciente não esteja com a bexiga cheia.

C) Certificar-se de que o paciente não tenha praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos.

D) Certificar-se de que o paciente não tenha fumado nos 10 minutos anteriores

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161393)

Enunciado: Para a adequada técnica de aferição da Pressão Arterial, assinale a alternativa CORRETA.

A) Posicionamento, o paciente deve estar sentado, com pernas cruzadas.

B) Posicionamento, o paciente deve estar com os pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado.

C) O braço deve estar na altura acima do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotear o membro.

D) Medir a PA na posição de pé, após 5 minutos, nos diabéticos, idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161282)

Enunciado: Nos casos de miocardite, a Ressonância Nuclear Magnética NÃO está indicada:

A) Na avaliação da função, geometria e morfologia ventricular na suspeita de miocardite aguda, subaguda ou crônica.

B) Na investigação diagnóstica de miocardite aguda, crônica ou suspeita de miocardite prévia.

C) No acompanhamento de 4 a 12 semanas do episódio agudo.

D) Na miocardite fulminante com instabilidade hemodinâmica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161289)

Enunciado: Considerando as medidas de suporte no tratamento das miocardites, marque a opção INCORRETA.

A) O transplante cardíaco está indicado em situação de prioridade para pacientes que não apresentam melhora clínica ou hemodinâmica.

B) O suporte inotrópico deve ser utilizado pelo menor tempo possível e na mínima dose necessária.

C) A ventilação não invasiva não é uma boa opção terapêutica em pacientes pediátricos com insuficiência cardíaca.

D) Anticoagulante oral está indicado nos casos de miocardite em associação com fibrilação atrial, trombos intracavitários ou fenômenos tromboembólicos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134824)

Enunciado: Paciente com história de Infarto Agudo do Miocárdio, ocorrido há 4 anos, evolui com progressiva deterioração do quadro, com edema, dispneia e agora sinais de baixa perfusão tecidual. Foi, então, indicado uso de Inotrópico, mas estava apenas disponível a Dobutamina. Diante de tal caso, assinale a alternativa que MELHOR define esse quadro clínico.

A) Melhora o consumo de oxigênio pelo miocárdio (diminui).

B) Aumenta o fluxo sanguíneo aos órgãos.

C) Protege o coração de arritmias.

D) Sua dose inicia-se a 15 mcg/kg/min.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134112)

Enunciado: Jovem de 26 anos de idade deu entrada no hospital com queixa de muita fadiga, referindo dor torácica no dia anterior que o obrigava a ficar de cócoras, ou até apertando o tórax contra a cama. Seu exame físico mostra pulso fino e rápido, alguma dispneia e jugulares cheias. Apesar de não ser obeso, sua ausculta cardíaca mostra-se abafada, mas sem atrito audível. Nesse quadro clínico, qual padrão de eletrocardiograma você, como médico, espera encontrar?

A) Supra de ST de V1 a V6.

B) Sobrecarga ventricular.

C) Variação de amplitude de QRS na mesma derivação unipolar.

D) Normal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134314)

Enunciado: Jovem masculino, 32 anos de idade, deu entrada no hospital após grande mal-estar, por uso de cocaína. Seu quadro de intoxicação mostra taquicardia, sudorese fria e agitação. Sua pressão está em 210 x 120 mmHg e sua frequência cardíaca em 185 bpm, referindo, nesse momento, dor torácica. Para esse caso clínico, indique a alternativa que não é adequada:

A) Benzodiazepínicos.

B) Betabloqueadores.

C) Antagonistas de canal de cálcio.

D) Oxigênio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134114)

Enunciado: Quando ocorre lesão cerebral do tipo Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, diversas situações clínicas interagem para se decidir a abordagem da hipertensão. São todas elas muito importantes, com EXCEÇÃO da seguinte. Assinale-a.

A) Presença de outras complicações relacionadas à hipertensão.

B) Valor atingido pela hipertensão.

C) Tomografia de crânio normal.

D) Tempo do qual ocorreu a lesão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134277)

Enunciado: Quando lidamos com quadros de emergência hipertensiva, frequentemente devemos utilizar o Nitroprussiato de Sódio. Por se tratar de medicação potente, sua farmacologia deve ser bem entendida, sendo que

A) Atua somente em artérias.

B) Pode ser usado em todos os pacientes.

C) Seu metabólico tóxico prejudica a respiração.

D) Somente funciona em altas doses.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134311)

Enunciado: O quadro clínico de emergência hipertensiva relacionada à encefalopatia hipertensiva ocorre

A) Sangramento cerebral pela hipertensão.

B) Cefaleia devido à hipertensão.

C) Edema cerebral por toxicidade.

D) Edema cerebral por vasodilatação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134858)

Enunciado: Paciente feminina de 60 anos de idade, hipertensa crônica inicia quadro de intensa dispneia após negligenciar medicações ambulatoriais de tratamento da hipertensão. Em sua avaliação inicial apresenta ausculta com estertores e uma queda da saturação, estando com 88%. Sua PA está bastante elevada, com 210 X 120 mmHg, fora edema em membros inferiores bilateralmente 2+/4+. Diante de tal caso, podemos AFIRMAR que

A) Se trata de edema agudo de pulmão hipertensivo, melhor abordagem com Nitroprussiato de Sódio por melhora pré e pós-carga.

B) Como paciente está edemaciada, a melhor medicação seria diuréticos tiazídicos.

C) Caso se utilize diuréticos, esses somente terão efeito na pós-carga a longo prazo.

D) Se trata de edema agudo de pulmão hipertensivo, sendo melhor utilizar nifedipina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134320)

Enunciado: São considerados órgãos-alvo de emergência hipertensiva todos os elencados abaixo, com a EXCEÇÃO de

A) Coração.

B) Placenta.

C) Aorta.

D) Córnea.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134848)

Enunciado: Paciente refere intensa cefaleia durante avaliação inicial, refere que o quadro se iniciou após estresse emocional por discussão familiar. Não apresenta perdas segmentares ou irritação meníngea, seu Glasgow está em 15. Porém, ao aferir sua pressão, encontramos o valor de 190 X 110 mmHg. Assim, consideramos ADEQUADO

A) Realizar TC de crânio de urgência, provavelmente se trata de HSA.

B) Iniciar Nitroprussiato de Sódio por se tratar de Encefalopatia Hipertensiva.

C) Medicar com analgésicos e ansiolíticos e, posteriormente, avaliar novamente PA.

D) Abordagem como Urgência Hipertensiva com Nifedipina 10 mg de ação rápida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134329)

Enunciado: Paciente idoso, 67 anos, dá entrada no hospital com mal-estar, agitação e cefaleia.

Refere ser hipertenso, com uso irregular de medicação. Sua PA se encontra em 210 x 120 mm Hg.

Não se medica há um dia. Qual das medicações abaixo PODE levar a esse provável rebote?

A) Nifedipina.

B) Captopril.

C) Metildopa.

D) Hidroclorotiazida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134334)

Enunciado: Para que ocorra o diagnóstico de emergência hipertensiva, é necessária a lesão em algum dos órgãos-alvo documentado. Podemos considerar isso em

A) Tomografia com hidrocefalia.

B) Hemograma com anemia.

C) Achado de células elmo.

D) Proteinúria.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134274)

Enunciado: Paciente apresentando choque cardiogênico não-compressivo, com pressão coloido-oncótica plasmática normal, não desenvolverá edema pulmonar se, na manipulação da pré-carga, conseguir manter uma pressão capilar pulmonar entre:

A) 6 a 9 mmHg.

B) 10 a 12 mmHg.

C) 15 a 18 mmHg.

D) 20 a 25 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131372)

Enunciado: Um paciente de 62 anos de idade é atendido na unidade de emergência com história de dor lancinante, extremamente súbita em região precordial, irradiada ao dorso. Ao chegar, estava pálido, taquicárdico, pressão arterial de 180 x 110 mmHg; com sopro de regurgitação no foco aórtico e estertores subcrepitantes em bases pulmonares. Pulsos periféricos diminuídos em MMIIS. Em relação ao caso, NÃO devemos introduzir imediatamente:

A) Nitroprussiato de sódio.

B) Derivados da morfina.

C) Betabloqueadores.

D) Nitratos.

E) Bloqueadores da enzima conversora.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134036)

Enunciado: Paciente masculino, diabético, com 45 anos, apresenta em consulta de rotina níveis de PA = 150/97 mmHg. O restante do exame físico é normal. O paciente refere que há anos mede a pressão frequentemente, e que sempre apresenta esses valores de PA. Ao ECG, observa-se sobrecarga de câmaras esquerdas, e o PCR é igual a "maior ou igual a" 3 mg/l. De acordo com a estratificação de risco individual do paciente para hipertensão (considerar estágio), qual é o risco cardiovascular do paciente, sabendo que ele é diabético e já possui lesão em órgão-alvo?

A) Risco muito alto.

B) Risco médio.

C) Risco alto.

D) Risco baixo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109718)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 60 anos, apresenta medidas seriadas de pressão arterial em torno de 150 x 90 mmHg. Você orientará o paciente sobre medidas não farmacológicas de controle da pressão arterial. Assinale abaixo a medida que NÃO faz parte das orientações para esse paciente:

A) Realizar atividade física regular.

B) Estimular consumo de dieta rica em frutas, vegetais e potássio.

C) Limitar ingestão de café.

D) Limitar ingestão de bebidas alcoólicas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109986)

Enunciado: Qual paciente que pode ser classificado como portador de insuficiência cardíaca crônica em estágio C?

A) Paciente hipertenso, assintomático e com ecocardiograma normal.

B) Paciente hipertenso, assintomático e com hipertrofia ventricular esquerda no ecocardiograma.

C) Paciente hipertenso, assintomático e com redução da fração de ejeção no ecocardiograma.

D) Paciente hipertenso, com sintomas de insuficiência cardíaca e redução da fração de ejeção no ecocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110007)

Enunciado: São causas de insuficiência cardíaca de alto débito, EXCETO

A) a Deficiência de tiamina.

B) a Tireotoxicose.

C) o Tamponamento pericárdico.

D) a Anemia grave.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110063)

Enunciado: A contraindicação ao uso de inibidores da enzima conversora de Angiotensina na Insuficiência Cardíaca Crônica é

A) a fração de ejeção abaixo de 35%.

B) o diagnóstico de estenose de artéria renal bilateral.

C) a creatinina plasmática acima de 1,5 mg/dl.

D) a pressão arterial sistólica abaixo de 100 mmhg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109766)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 76 anos, com Hipertensão Arterial Sistólica Isolada, sem outras comorbidades. Assinale a MELHOR opção terapêutica para esse paciente.

A) Diurético tiazídico.

B) Beta-bloqueador.

C) Bloqueador do receptor da angiotensina.

D) Nitrato.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109971)

Enunciado: São alterações hemodinâmicas resultantes da administração de dobutamina, EXCETO

A) o aumento da frequência cardíaca.

B) o aumento do débito cardíaco.

C) a redução do fluxo esplâncnico.

D) a diminuição da resistência vascular sistêmica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

109741)

Enunciado: A oferta de oxigênio (DO2) para os tecidos depende das seguintes variáveis, EXCETO:

A) volume sistólico.

B) pressão venosa central.

C) contratilidade miocárdica.

D) hemoglobina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110010)

Enunciado: Menino de 12 anos de idade apresenta-se com uma história de dor torácica aguda, pleurítica, que é pior na posição supina. A temperatura da criança é de 38,5ºC e ausculta-se atrito pericárdico. O diagnóstico MAIS provável é:

A) dor torácica musculoesquelética.

B) pericardite.

C) endocardite bacteriana.

D) êmbolo pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

110608)

Enunciado: A Síndrome metabólica é descrita como:

A) Obesidade abdominal (acima de 102 cm no homem e 88 cm na mulher), hipertrigliceridemia (acima de 150 mg/dl), baixos níveis de HDL-colesterol (menor que 40 mg/dl nos homens e 50 mg/dl nas mulheres) e hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg).

B) IMC acima de 35 nas mulheres e 38 nos homens. Associado a: hiperglicemia de jejum (acima de 126 mg/dl), hipertrigliceridemia (acima de 150 mg/dl) e hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg).

C) Obesidade abdominal (acima de 102 cm no homem e 88 cm na mulher), hipertrigliceridemia (acima de 180 mg/dl), baixos níveis de HDL-colesterol (menor que 40 mg/dl nos homens e 50 mg/dl nas mulheres), hiperglicemia de jejum (acima de 118 mg/dl) e hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg).

D) Hipertensão arterial (PA maior que 130 x 85 mmHg), hipertrigliceridemia (acima de 180 mg/dl), baixos níveis de HDL-colesterol (menor que 40 mg/dl nos homens e 50 mg/dl nas mulheres), hiperglicemia de jejum (acima de 118 mg/dl) e obesidade.

E) Hiperglicemia de jejum (acima de 126 mg/dl), hipertrigliceridemia (acima de 150 mg/dl), hipertensão arterial (PA maior ou igual a 130 x 85 mmHg) e obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86639)

Enunciado: Paciente 52 anos, masculino, com relato de taquidispneia há três horas acompanhada de cefaleia importante holocraniana. Refere ainda que observou dificuldade respiratória progressiva a partir do início do quadro. É hipertenso há 10 anos e faz uso irregular de captopril 25 mg três vezes ao dia e hidroclorotiazida 25 mg/dia. Tabagista crônico há 30 anos e deixou há 5 anos. Nega etilismo, dislipidemia e diabetes mellitus. O diagnóstico sindrômico para este paciente é:

A) Emergência hipertensiva sem lesão órgão-alvo.

B) Urgência hipertensiva sem lesão órgão-alvo.

C) Emergência hipertensiva com provável lesão órgão-alvo.

D) Urgência hipertensiva com provável lesão órgão-alvo.

E) Apenas urgência hipertensiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86864)

Enunciado: Qual a maior anormalidade na insuficiência ventricular esquerda?

A) Edema de MMII;

B) Cefaleia;

C) Hepatomegalia;

D) Congestão vascular pulmonar;

E) Hipertensão arterial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86803)

Enunciado: Os Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA), atualmente são drogas eficazes em monoterapia nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Assinale a alternativa correta sobre os efeitos adversos dessas drogas: I. Hipersensibilidade cutânea; II. Rubor facial; III. Bloqueio atrioventricular; IV. Alteração do paladar.

A) Somente I é verdadeira.

B) Somente I e II são verdadeiras.

C) Somente III e IV são verdadeiras.

D) Somente I e IV são verdadeiras.

E) Somente II e III.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

86637)

Enunciado: Rita de Cássia tem 56 anos, parda, recém chegada na Comunidade Vila das Casas. Casada com Antônio, 53 anos e mãe de dois filhos adolescentes. Trabalha como caixa de supermercado na área nobre da cidade, levando cerca de 1 hora no transporte em cada uma das viagens. Faz consultas regulares para planejamento familiar, rastreamento de câncer de colo de útero e controle da HAS. Na última consulta seu nível pressórico foi de 150 x 100 mmHg. O qual ela atribuiu a uma semana estressante no trabalho. Atualmente está fazendo uso de Anlodipino 5 mg/dia e Hidroclorotiazida 25 mg/dia. Foi pedido que ela realizasse uma Monitorização Residencial da Pressão Arterial e evidenciou uma média pressórica de 148 x 98 mmHg. Afirma que não sente nenhum sintoma, não tem tempo para fazer atividade física e nem fazer sua comida à parte da família e prefere resolver seus problemas de saúde com remédios. Tabagista há 36 anos. Na escala de Framinghan obteve resultado de 22% de chances de desenvolver um evento cardiovascular em 10 anos. Frente ao caso e considerando o sinergismo entre as medicações, qual seria conduta mais adequada:

A) Reforçar as medidas não medicamentosas.

B) Reforçar as medidas não medicamentosas e aumentar a dose do Antagonista dos Canais Cálcio.

C) Reforçar as medidas não medicamentosas e aumentar a dose da diurético.

D) Reforçar as medidas não medicamentosas e substituir o Antagonista dos Canais Cálcio por IECA.

E) Reforçar as medidas não medicamentosas e trocar as medicações por IECA e Betabloqueador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158414)

Enunciado: Paciente masculino, 63 anos, obeso, portador de hipertensão arterial sistêmica descontrolada e em uso de hidroclorotiazida, anlodipino e losartana em doses máximas. Relatando sonolência diurna. Ao exame: pletórico. Qual a principal hipótese diagnóstica?

A) Hiperaldosteronismo.

B) Feocromocitoma.

C) Síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono.

D) Hipertensão renovascular.

E) Hipotireoidismo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158398)

Enunciado: Masculino de 68 anos, com antecedente pessoal de diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e infarto do miocárdio prévio, em uso de AAS, enalapril 10 mg ao dia, hidroclorotiazida 25 mg ao dia e metformina 850 mg duas vezes ao dia. Esse quadro evoluiu com dispneia e ortopneia há três dias, piorando progressivamente. Ao exame físico, o paciente apresentou: pressão arterial: 230 x 170 mmHg; frequência cardíaca: 120 bpm; frequência respiratória: 36 irpm; saturação arterial de oxigênio: 94%. RX de tórax evidenciou infiltrado pulmonar difuso, com predomínio na região peri-hilar, sugerindo quadro de congestão pulmonar. Qual a conduta mais adequada para o caso?

A) Noradrenalina EV + hidratação EV + culturas + antibioticoterapia.

B) Morfina EV + midazolam EV + intubação orotraqueal.

C) Nitroprussiato EV + furosemida EV + morfina EV + ventilação não invasiva (CPAP).

D) Hidrocortisona EV + terbutalina SC + inalação com fenoterol e ipratrópio.

E) Dobutamina EV + metoprolol EV + morfina EV + sildenafila VO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108575)

Enunciado: Paciente de 74 anos, hipertenso de longa data, em uso irregular de anti-hipertensivos. No último ano, apresentou dispneia progressiva aos médios esforços palpitações. Ao exame físico, níveis pressoricos elevados, ictus desviado e edema de extremidades. O eletrocardiograma demostra hipertrofia ventricular esquerda. Qual dentre os diuréticos abaixo, é capaz de melhorar sintomas e modificar a história natural da doença relacionado ao caso descrito:

A) Hidroclorotiazida.

B) Espironolactona.

C) Furosemida.

D) Indapamida.

E) Nenhuma das anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108576)

Enunciado: Em relação aos achados na avaliação de Insuficiência Cardíaca (IC), assinale a CORRETA:

A) A cardiomegalia é um achado específico de paciente com IC.

B) A regurgitação funcional da valva mitral ou tricúspide, secundária à dilatação ventricular e anelar, comumente leva a sopros diastólicos no paciente com IC.

C) Na IC grave, podem ocorrer temperatura de até 39°C, secundária à vasoconstrição cutânea.

D) A IC grave, de longa duração, pode levar à anorexia como resultado da congestão intestinal e hipoperfusão mesentérica.

E) Todas estão incorretas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

327229)

Enunciado: O termo "Insuficiência Cardíaca Crônica" reflete a natureza progressiva e persistente da doença. Embora a maioria das doenças que levam à Insuficiência Cardíaca (IC) caracterizem-se pela presença de baixo débito cardíaco (muitas vezes compensado) no repouso ou no esforço (IC de baixo débito), algumas situações clínicas de alto débito também podem levar a Insuficiência Cardíaca entre elas:

A) Insuficiência Coronariana

B) D. de Chagas

C) Anemia

D) Miocardite Viral

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

327230)

Enunciado: No diagnóstico de Hipertensão Arterial podemos encontrar Hipertensão mascarada que é caracterizada por:

A) Valores elevados no consultório, porém com PA normal pela MAPA ou medidas residenciais.

B) Valores normais da PA no consultório, porém com PA elevada pela MAPA ou medidas residenciais.

C) Valores elevados da PA no consultório e pela MAPA.

D) Valores normais da PA no consultório e pela MAPA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298202)

Enunciado: A Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Em relação a IC assinale a alternativa CORRETA.

A) São causas de IC de baixo débito: cardiopatia isquêmica, miocardiopatia dilatada, anemia e gravidez.

B) IC crônica: pacientes com diagnóstico estabelecido de IC ou ocorrência dos sintomas de forma súbita.

C) IC com fração de ejeção reduzida (ICFER): FE ? 40%.

D) A insuficiência cardíaca diastólica é definida como IC em pacientes com fração de ejeção acima de 25%.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298204)

Enunciado: Em relação à Hipertensão Arterial em doentes renais. Assina a alternativa CORRETA:

A) A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2020 recomenda em adultos com Hipertensão Arterial e Doença Renal Crônica, diabéticos ou não, meta de PA < 130/80 mmHg para os que estejam em tratamento conservador.

B) A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2020 recomenda em adultos com Hipertensão Arterial e Doença Renal Crônica, diabéticos ou não, meta de PA < 120/75 mmHg.

C) A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2020 recomenda em adultos com Hipertensão Arterial e Doença Renal Crônica, diabéticos ou não, meta de PA < 140/90 mmHg.

D) A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2020 recomenda em adultos com Hipertensão Arterial e Doença Renal Crônica, diabéticos ou não, meta de PA < 120/80 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

286703)

Enunciado: Quais são os sinais e sintomas mais específicos na insuficiência cardíaca:

A) Ictus desviado para esquerda e cansaço

B) Refluxo hepatojugular e dispnéia

C) B3 e ortopnéia

D) Pressão venosa jugular elevada e dispneia paroxística noturna

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

252212)

Enunciado: Em relação a insuficiência mitral é CORRETO afirmar.

A) A regurgitação mitral é definida pelo refluxo do sangue do Ventrículo Esquerdo ao átrio esquerdo durante a sístole com achado auscultatório de sopro diastólico em foco mitral com irradiação para axila.

B) A regurgitação mitral é definida pelo refluxo do sangue do Ventrículo Esquerdo ao átrio esquerdo durante a diástole com achado auscultatório de sopro holossistólico ou mesossistólico.

C) A regurgitação mitral é definida pelo refluxo do sangue do Ventrículo Esquerdo ao átrio esquerdo durante a sístole com achado auscultatório de sopro holossistólico ou mesotelesistólico.

D) A regurgitação mitral é definida pelo refluxo do sangue do Ventrículo Esquerdo ao átrio esquerdo durante todo o ciclo cardíaco com achado auscultatório de sopro diastólico em foco mitral com irradiação para axila.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

256579)

Enunciado: Paciente de 72 anos, sexo masculino e diabético apresenta há 3 meses dispneia progressiva para pequenos esforços e edema de membros inferiores. No exame físico: Lucido orientado, boa perfusão capilar periférica, creptantes nas bases pulmonares, B3, P2>A2, PA 90 x 50mmHg e FC 100bpm sendo diagnosticado como insuficiência cardíaca descompensada. Qual o perfil clínico hemodinâmico neste caso?

A) Perfil C

B) Perfil A

C) Perfil L

D) Perfil B

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

208359)

Enunciado: A insuficiência cardíaca é uma doença comum e a sua prevalência e incidência continuam a aumentar. Sobre essa patologia é CORRETO afirmar que:

A) Na insuficiência cardíaca crônica agudizada, o padrão hemodinâmico se caracteriza por elevação progressiva das pressões de enchimento ventricular esquerdo por disfunção sistólica predominante associada a importante componente de disfunção diastólica.

B) Na insuficiência cardíaca crônica agudizada, os principais fatores causais são infarto do miocárdio, regurgitação mitral aguda por ruptura de cordoalha ou disfunção de músculo papilar por isquemia, disfunção miocárdica por miocardite.

C) Uma das complicações da insuficiência cardíaca congestiva é o edema agudo de pulmão que se caracteriza por intensa elevação das pressões de enchimento das cavidades direitas, ocasionando importante transudação intersticial pulmonar para o interior dos alvéolos e bronquíolos terminais, podendo chegar à árvore brônquica principal.

D) A insuficiência cardíaca direita caracteriza-se por disfunção ventricular direita com pressões de enchimento atrial direito elevadas associadas com baixo débito cardíaco e consequente hipotensão arterial com congestão pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176014)

Enunciado: O sopro de Carey Coombs está presente em qual patologia?

A) Insuficiência pulmonar.

B) Doença reumática em atividade.

C) Endocardite infecciosa.

D) Insuficiência aórtica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176035)

Enunciado: Paciente de 72 anos, sexo masculino e diabético apresenta há 3 meses dispneia progressiva para pequenos esforços e edema de membros inferiores. No exame físico: lúcido, orientado, boa perfusão capilar periférica, crepitantes nas bases pulmonares, B3, P2 > A2, PA = 90 x 50 mmHg e FC =

100 bpm sendo diagnosticado como insuficiência cardíaca descompensada. Qual o perfil clínico hemodinâmico neste caso?

A) Perfil A.

B) Perfil B.

C) Perfil C.

D) Perfil L.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176074)

Enunciado: Davi tem 35 anos, é branco, solteiro, vive com os pais hipertensos e veio à consulta para fazer ?exames de rotina?. Nega doenças prévias e não apresenta queixas no momento. A pressão arterial está em 154 x 96 mmHg. Podemos orientá-lo:

A) A monitorar sua pressão arterial ao menos 2 vezes com um intervalo de 10 dias.

B) Que está com hipertensão arterial estágio 3, sendo indicado modificações do seu estilo de vida.

C) Que está com hipertensão arterial estágio 1 e necessita de tratamento medicamentoso no diagnóstico.

D) A monitorar sua pressão arterial ao menos 3 vezes pela manhã e 3 vezes à noite durante 7 dias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151883)

Enunciado: Paciente de 32 anos, procurou atendimento ambulatorial por apresentar dispneia aos esforços moderados. O exame físico do aparelho cardiovascular apresentava P2 > A2, primeira bulha mitral hiperfonética, sopro diastólico no quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular +++/6+; PA = 110 x 70 mmHg e FC 90 bpm. Neste caso, qual o principal diagnóstico, tratamento inicial e o exame considerado padrão-ouro no diagnóstico das valvopatias, respectivamente?

A) Estenose tricúspide, betabloqueador e cintilografia do miocárdio.

B) Estenose mitral, betabloqueador e ecocardiograma.

C) Estenose pulmonar, diurético e ecocardiograma.

D) Insuficiência mitral, diurético e ecocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

151899)

Enunciado: A classificação da insuficiência cardíaca pelo perfil clínico hemodinâmico de Stevenson é utilizado para guiar a terapêutica nos casos de insuficiência cardíaca, levando em consideração os seguintes critérios:

A) Galope por B3 e B4.

B) Sinais de congestão e B3.

C) Presença de B3 na ausculta cardíaca.

D) Sinais e sintomas de hipoperfusão e congestão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139123)

Enunciado: Em qual das situações abaixo, os betabloqueadores NÃO estão contraindicados?

A) Crises de broncoespasmo.

B) Doença vascular periférica sintomática.

C) Bloqueio atrioventricular de segundo grau.

D) Insuficiência cardíaca decorrente de miocardiopatia dilatada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103791)

Enunciado: Cada uma das condições abaixo está associada ao desenvolvimento de edema pulmonar, EXCETO:

A) Aumento da pressão venosa pulmonar.

B) Aumento da pressão oncótica do plasma.

C) Altitude elevada.

D) Eclâmpsia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

103798)

Enunciado: Cada uma das afirmações a seguir relacionadas com o feocromocitoma é verdadeira, EXCETO:

A) Aproximadamente 15% dos feocromocitomas são extra-adrenais.

B) Dez por cento dos feocromocitomas são malignos.

C) A hipertensão relacionada com o feocromocitoma raramente causa hipertensão persistente.

D) Dez por cento dos feocromocitomas adrenais são bilaterais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81986)

Enunciado: Pulsos desiguais na extremidade superior podem ser encontrados em cada um dos seguintes distúrbios, EXCETO:

A) Dissecção aórtica.

B) Doença de Takayasu.

C) Estenose aórtica subvalvar.

D) Estenose aórtica supravalvar.

E) Aterosclerose da artéria subclávia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80961)

Enunciado: Escolha a melhor droga ou combinação de drogas indicada no controle da hipertensão em vigência da dissecção de aorta:

A) Furosemida + betabloqueador.

B) Nitropussiato de sódio + betabloqueador.

C) Nitropussiato de sódio isoladamente.

D) Betabloqueador isoladamente.

E) Nitropussiato de sódio + nifedipina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81956)

Enunciado: Qual das seguintes condições está associada ao aumento da pré-carga ventricular esquerda?

A) Sepse.

B) Regurgitação mitral.

C) Infarto do ventrículo direito.

D) Desidratação.

E) Embolia pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81968)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 58 anos, obeso, com glicemia de jejum de 145 mg/dl (repetida e confirmada) e PA 160/90 mmHg. Vem à consulta pela primeira vez e não está medicado. Em relação à conduta, assinale a INCORRETA.

A) Solicitar o teste oral de tolerância à glicose (TOTG).

B) Orientar dieta e atividade física.

C) Iniciar Metformina e tratamento para hipertensão.

D) Solicitar microalbuminúria e creatinina em amostra urinária de jejum.

E) Solicitar exame de fundo de olho para avaliar alterações vasculares na retina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80930)

Enunciado: São fatores de risco para a ocorrência tanto de doença cardiovascular quanto de Diabetes Mellitus:

A) Herança genética e consumo excessivo de sal.

B) Ocupações estressantes e baixa escolaridade.

C) Ocupações menos qualificadas e obesidade.

D) Hipercolesterolemia e obesidade.

E) Sedentarismo e obesidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60829)

Enunciado: Compreende sinal muito sugestivo de insuficiência aórtica grave:

A) Xantelasmas.

B) Aracnodactilia.

C) Sinal de Musset.

D) Pulso parvus et tardus.

E) Lesões de Janeway.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60838)

Enunciado: Paciente de 21 anos, sexo feminino, com história de aumento de volume abdominal há 2 anos, associado à dispneia de esforço. Ao exame físico, paciente em bom estado geral, corada, anictérica, hidratada, com estase jugular a 45 graus e sinal de Kussmaul, PA = 100 x 60 mmHg, FC = 70, RCR sem sopros, com som protodiastólico rude ("Knock"), abdome ascítico, fígado a 5 cm RCD doloroso, ausência de edema de membros inferiores ou estigmas de insuficiência hepática.

Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica:

A) Hepatopatia crônica.

B) Pericardite constritiva.

C) Insuficiência cardíaca esquerda.

D) Insuficiência cardíaca congestiva.

E) Tromboembolismo pulmonar crônico com insuficiência cardíaca direita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

61535)

Enunciado: De acordo com as VI diretrizes de Hipertensão Arterial da SBC, as metas pressóricas nos pacientes em estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio são:

A) PA < 140 x 90 mmHg.

B) PA = 140 x 90 mmHg.

C) PA = 130 x 80 mmHg.

D) PA < 130 x 80 mmHg.

E) PA = 120 x 80 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

60837)

Enunciado: Em relação ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica, podemos afirmar:

A) Baseia-se no tratamento medicamentoso.

B) O consumo de álcool não deve exceder 30 ml/dia de etanol para homens e o tabagismo deve ser abandonado.

C) No tratamento medicamentoso, os diuréticos são a medicação que menos reduz o risco de eventos cardiovasculares, renais e cerebrovasculares.

D) Os diuréticos estão indicados para pacientes em estágio 2, em monoterapia e que não respondam a medidas não medicamentosas.

E) Nas modificações de estilo de vida podemos citar a redução de peso (principalmente da gordura periférica), alimentação saudável, prática de atividade física.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46731)

Enunciado: Nas afirmativas é CORRETO afirmar em relação à Síndrome de Eisenmenger somente que:

A) No exame clínico não há sinais que caracterizam a síndrome sendo seu achado ecocardiográfico.

B) O termo Síndrome de Eisenmenger deve ser reservado a pacientes nos quais a doença pulmonar obstrutiva e a resistência vascular pulmonar é diminuída e reversível.

C) Um impulso ventricular direto proeminente é sentido na borda paraesternal esquerda ao final da expiração ou na área subcostal no final da inspiração.

D) A pressão de pulso alarga-se conforme o débito cardíaco diminui.

E) A ausência de shunt direito-esquerdo torna o paciente inoperável.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46725)

Enunciado: No tratamento da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção reduzida é incorreto afirmar que:

A) As drogas que afetam a ativação excessiva do sistema renina-angiotensina-aldosterona como os IECAs e BRAs podem aliviar os sintomas da Insuficiência Cardíaca.

B) O uso combinado de hidralazina e dinitrato de isosorbida pode ser considerado uma opção terapêutica para pacientes com intolerância aos IECAs e BRAs.

C) A terapia betabloqueadora representa um dos principais avanços no tratamento de pacientes com IC com FE reduzida.

D) A digoxina é recomendada para pacientes com disfunção sistólica ventricular esquerda com fibrilação atrial.

E) Três betabloqueadores se mostraram efetivos na redução do risco de morte em paciente com IC crônica: o carvedilol, propranolol e metoprolol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

46718)

Enunciado: Paciente de 72 anos dá entrada em pronto-socorro com história de episódios de síncope e dor torácica. Ao exame físico, apresenta sopro sistólico mais audível na área aórtica que desaparece sobre o esterno e reaparece sobre o ápice do VE (fenômeno de Gallavardin). O diagnóstico mais provável é:

A) Insuficiência Aórtica.

B) Insuficiência Mitral.

C) Estenose Mitral.

D) Insuficiência Tricúspide.

E) Estenose Aórtica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34115)

Enunciado: Os medicamentos associados à redução da mortalidade em pacientes portadores de insuficiência cardíaca com disfunção sistólica são:

A) Inibidor de ECA, espironolactona, diuréticos de alça e betabloqueador.

B) Betabloqueador, digital, inibidor de ECA e nitrato.

C) Espironolactona, inibidor de ECA (Enzima de Conversão da Angiotensina), betabloqueador e nitrato associado à hidralazina.

D) Inibidor de ECA, diuréticos de alça, espironolactona e betabloqueador.

E) Digital, betabloqueador, inibidor de ECA e espironolactona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34116)

Enunciado: São causas de insuficiência cardíaca com função sistólica preservada, EXCETO:

A) Sarcoidose.

B) Amiloidose.

C) Cardiomiopatia periparto.

D) Cardiomiopatia hipertrófica.

E) Hipertensão arterial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34119)

Enunciado: São causas de choque cardiogênico, EXCETO:

A) Infarto Agudo do Miocárdio.

B) Arritmias.

C) Miocardite.

D) Hemotórax.

E) Contusão Miocárdica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34176)

Enunciado: Qual a etiologia da insuficiência cardíaca no adolescente?

A) Doença de Kawasaki/Anomalia de Ebstein.

B) Coarctação da aorta/síndrome de coração esquerdo.

C) Febre reumática/Anemia Falciforme.

D) Doença de Kawasaki/Persistência do canal arterial.

E) Persistência do canal arterial/Comunicação interventicular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34300)

Enunciado: José de 42 anos, veio a primeira consulta na Unidade Saúde da Família em que você trabalha. Refere dores na nuca. Tem índice de Massa Corporal de 28, pressão Arterial de 180 X110 mmHg. Refere outras aferições também com valores semelhantes, como consta em receituário preenchido pelo técnico de enfermagem de sua unidade. Os pais de José são acompanhados na unidade por você e a mãe tem hipertensão arterial. José é tabagista, vive com pais e trabalha como motorista de táxi. Em relação ao quadro clínico apresentado por José, podemos afirmar, EXCETO:

A) Que ele apresenta Hipertensão Arterial em estágio II.

B) Você deve orientá-lo sobre medidas não famarcológicas bem como a iniciar terapia medicamentosa para controle da pressão.

C) José deve ser orientado a parar de fumar e iniciar abordagem breve cognitivo-comportamental antitabagismo.

D) Os exames que devem ser solicitados nesta 1ª. consulta são exame de urina tipo I, potássio sérico, glicemia, creatinina sérica, lipidograma, hematócrito e eletroencefalograma.

E) José deve ser encaminhado ao especialista caso sua hipertensão seja refratária ao tratamento ou apresente importante lesão de órgão-alvo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26441)

Enunciado: São drogas utilizadas no tratamento na Insuficiência Cardíaca (IC), que se mostraram capazes de alterar o seu prognóstico, diminuindo a mortalidade, principalmente nos casos mais graves, EXCETO:

A) bloqueadores de receptor de angiotensina.

B) betabloqueadores.

C) digital.

D) inibidores de ECA.

E) espironolactona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26442)

Enunciado: Algumas situações interferem na avaliação da pressão arterial (PA). Assinale a alternativa INCORRETA:

A) em pacientes com pseudo-hipertensão, os níveis pressóricos são falsamente elevados devido ao enrijecimento arterial

B) o hiato auscultatório ocorre entre a fase I e II do Korotkoff e pode subestimar a PA sistólica ou superestimar a diastólica

C) a hipertensão do avental branco ocorre quando temos medidas pressóricas elevadas no consultório, porém normais à monitoração ambulatorial da PA (MAPA) ou à monitoração residencial

D) quando o manguito é muito pequeno para o braço do indivíduo, medidas falsamente elevadas podem ocorrer

E) pseudo-hipertensão e hiato auscultatório são mais comuns em gestantes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26481)

Enunciado: São alterações fisiopatológicas do tamponamento cardíaco, EXCETO:

A) choque cardiogênico por falha na contração cardíaca

B) deslocamento da traqueia para a direita por balanço mediastinal

C) turgência jugular por aumento da pressão venosa central

D) abafamento de bulhas cardíacas

E) hipotensão arterial severa sem sinais de hemorragia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26685)

Enunciado: No diagnóstico de estenose aórtica encontramos como características clínicas e hemodinâmicas, exceto:

A) angina

B) Íctus hiperativo deslocado para baixo e para esquerda

C) síncope

D) Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo

E) pulso carotídeo retardado e fraco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7483)

Enunciado: Das substâncias abaixo listadas secretadas pelo rim qual tem efetiva participação em mecanismos hipertensivos?

A) Cininogênio.

B) Fator de ativação plaquetária.

C) Eritropoetina.

D) Renina.

E) Prostaglandinas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7467)

Enunciado: Em idosos, a lesão valvar mais frequente e a sua etiologia principal são, respectivamente:

A) insuficiência mitral pós-inflamatória.

B) estenose aórtica por degeneração.

C) estenose aórtica pós-inflamatória.

D) insuficiência mitral por degeneração.

E) insuficiência aórtica por degeneração.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10045)

Enunciado: Dona Elsa faz seu tratamento de hipertensão há muitos anos na unidade de saúde da família onde você trabalha. Hoje, você irá consultar o seu filho Marcelo que acaba de chegar à cidade. Marcelo tem 40 anos e descobriu há 3 meses ser hipertenso. Ao exame, está com níveis pressóricos elevados, apesar do uso correto da medicação, e sobrepeso. Ele refere que sempre fica nervoso quando vai ao médico. Você o orienta a, EXCETO:

A) Investigar a síndrome do avental branco e pede o MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial).

B) Investiga Hipertensão secundária visto o início súbito da hipertensão antes dos 55 anos de idade e a história familiar.

C) Solicita alguns exames complementares como creatinina sérica, potássio sérico, lipidograma, sedimentocospia urinária e eletrocardiograma.

D) Recomenda dieta com restrição calórica e de sódio.

E) Orienta a prática regular de exercício físico para controle pressórico e redução de peso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7514)

Enunciado: Alguns medicamentos anti-hipertensivos em mulheres não-grávidas são mais úteis em condições específicas. Qual destas combinações está contraindicada?

A) Inibidores da ECA em diabéticas.

B) ß-bloqueadores com doenças coronariana coexistente.

C) Bloqueadores dos canais de cálcio com insuficiência cardíaca esquerda.

D) ß-bloqueadores com enxaqueca.

E) Não há combinação que esteja contraindicada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10003)

Enunciado: A causa mais comum de um derrame pericárdico crônico é:

A) Hipotireoidismo.

B) Neoplasias.

C) Viral.

D) Tuberculose.

E) Uremia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

10005)

Enunciado: São causas de pulso paradoxal, EXCETO:

A) Asma Brônquica.

B) Choque hipovolêmico.

C) Tamponamento cardíaco.

D) DPOC crônico.

E) Regurgitação aórtica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284568)

Enunciado: Mulher, 60 anos de idade, é acompanhada na Unidade de Saúde da Família (USF) por diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Na primeira visita à USF, há cerca de 6 meses, a PA estava em 182 x 100 mmHg. Atualmente, assintomática. Nega outras comorbidades. Em uso regular de metformina 850 mg duas vezes ao dia, losartana 50 mg de 12/12h e anlodipina 10 mg ao dia, há cerca de 6 meses. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, com FC: 70 bpm, PA: 166 x 96 mmHg em ambos os membros superiores e glicemia capilar de 110 mg/dl. Pulsos palpáveis e simétricos. Exame segmentar sem alterações. Traz monitorização residencial da pressão arterial, com PAS entre 140 e 172 mmHg e PAD entre 90 e 96 mmHg. Indique a classificação para a pressão dessa paciente na primeira visita à Unidade de Saúde da Família.

A) Pressão arterial elevada.

B) Hipertensão arterial sistêmica estágio 1.

C) Hipertensão arterial sistêmica estágio 2.

D) Hipertensão arterial sistêmica estágio 3.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284569)

Enunciado: Mulher, 60 anos de idade, é acompanhada na Unidade de Saúde da Família (USF) por diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Na primeira visita à USF, há cerca de 6 meses, a PA estava em 182 x 100 mmHg. Atualmente, assintomática. Nega outras comorbidades. Em uso regular de metformina 850 mg duas vezes ao dia, losartana 50 mg de 12/12h e anlodipino 10 mg ao dia, há cerca de 6 meses. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, com FC: 70 bpm, PA: 166 x 96 mmHg em ambos os membros superiores e glicemia capilar de 110 mg/dl. Pulsos palpáveis e simétricos. Exame segmentar sem alterações. Traz monitorização residencial da pressão arterial, com PAS entre 140 e 172 mmHg e PAD entre 90 e 96 mmHg. Indique a conduta mais adequada para otimizar o esquema anti-hipertensivo dessa paciente.

A) Introdução de hidroclorotiazida.

B) Introdução de captopril.

C) Troca da losartana por hidralazina.

D) Aumento das doses de losartana e anlodipino.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284570)

Enunciado: Mulher, 60 anos de idade, é acompanhada na Unidade de Saúde da Família (USF) por diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica. Na primeira visita à USF, há cerca de 6 meses, a PA estava em 182 x 100 mmHg. Atualmente, assintomática. Nega outras comorbidades. Em uso regular de metformina 850 mg duas vezes ao dia, losartana 50 mg de 12/12h e anlodipino 10 mg ao dia, há cerca de 6 meses. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, com FC: 70 bpm, PA: 166 x 96 mmHg em ambos os membros superiores e glicemia capilar de 110 mg/dl. Pulsos palpáveis e simétricos. Exame segmentar sem alterações. Traz monitorização residencial da pressão arterial, com PAS entre 140 e 172 mmHg e PAD entre 90 e 96 mmHg. Determine as metas de pressão arterial sistólica e diastólica para essa paciente, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes.

A) PAS < 120 e PAS < 70 mmHg.

B) PAS < 130 e PAD < 80 mmHg.

C) PAS < 135 e PAD < 85 mmHg.

D) PAS < 140 e PAD < 90 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230118)

Enunciado: Mulher, 31 anos de idade, procura atendimento ambulatorial com queixa de dispneia aos subir escadas e ladeiras, além de tosse seca, há 6 meses, progredindo para dispneia aos pequenos esforços, há 2 semanas. Refere vários episódios de amigdalite na infância e adolescência. Ao exame físico, apresenta-se com FC: 102bpm, PA: 100X60mmHg. Ausculta com murmúrios vesiculares reduzidos e estertores crepitantes em bases. Ictus cordis em 6º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior, com frêmito palpável. Ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, em 2 tempos, com sopro holossistólico plurifocal, mais audível em foco mitral, e sopro protodiastólico em foco aórtico. Diante desse caso, indique o diagnóstico sindrômico e a sua etiologia mais provável.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230119)

Enunciado: Mulher, 31 anos de idade, procura atendimento ambulatorial com queixa de dispneia aos subir escadas e ladeiras, além de tosse seca, há 6 meses, progredindo para dispneia aos pequenos esforços, há 2 semanas. Refere vários episódios de amigdalite na infância e adolescência. Ao exame físico, apresenta-se com FC: 102bpm, PA: 100X60mmHg. Ausculta com murmúrios vesiculares reduzidos e estertores crepitantes em bases. Ictus cordis em 6º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior, com frêmito palpável. Ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, em 2 tempos, com sopro holossistólico plurifocal, mais audível em foco mitral, e sopro protodiastólico em foco aórtico. Diante desse caso, indique o exame de escolha para confirmação diagnóstica.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230120)

Enunciado: Mulher, 31 anos de idade, procura atendimento ambulatorial com queixa de dispneia aos subir escadas e ladeiras, além de tosse seca, há 6 meses, progredindo para dispneia aos pequenos esforços, há 2 semanas. Refere vários episódios de amigdalite na infância e adolescência. Ao exame físico, apresenta-se com FC: 102bpm, PA: 100X60mmHg. Ausculta com murmúrios vesiculares reduzidos e estertores crepitantes em bases. Ictus cordis em 6º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior, com frêmito palpável. Ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, em 2 tempos, com sopro holossistólico plurifocal, mais audível em foco mitral, e sopro protodiastólico em foco aórtico. Diante desse caso, indique a melhor conduta terapêutica, a longo prazo, considerando o diagnóstico etiológico mais provável.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176344)

Enunciado: Mulher, 40 anos de idade, recepcionista, vem para consulta com cardiologista por queixa de "pressão alta". Diz que há dois dias estava trabalhando quando sentiu cefaleia frontal em peso e atribuiu à pressão arterial, porque quando sente dor de cabeça "a pressão está sempre alta". Mediu a PA com o médico do trabalho e verificou niveis de 160X90mmHg. Em casa, após melhorar da cefaleia, voltou a medir a pressão arterial duas vezes, com intervalo de uma hora, verificando niveis de 124X70mmHg e 130X70mmHg. Nega comorbidades, tabagismo ou estilismo. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral e nutricional, corada. PA: 150x90mmHg em mais de uma medida, sem alterações significativas com a mudança de decúbito ou de membro. FC: 85bpm. Exame segmentar sem alterações. Diante do quadro descrito, indique a principal hipótese diagnóstica do quadro atual da paciente.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176285)

Enunciado: Mulher, 40 anos de idade, recepcionista, vem para consulta com cardiologista por queixa de "pressão alta". Diz que há dois dias estava trabalhando quando sentiu cefaleia frontal em peso e atribuiu à pressão arterial, porque quando sente dor de cabeça "a pressão está sempre alta". Mediu a PA com o médico do trabalho e verificou níveis de 160 x 90 mmHg. Em casa, após melhora da cefaleia, voltou a medir a pressão arterial duas vezes, com intervalo de uma hora, verificando níveis de 124 x 70 mmHg e 130 x 70 mmHg. Nega comorbidades, tabagismo ou etilismo. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral e nutricional, corada. PA = 150 x 90 mmHg em mais de uma medida, sem alterações significativas com a mudança de decúbito ou de membro. FC = 85 bpm. Exame segmentar sem alterações. Diante do quadro descrito, indique o método indicado para confirmação da sua hipótese principal.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

176295)

Enunciado: Mulher, 40 anos de idade, recepcionista, vem para consulta com cardiologista por queixa de "pressão alta". Diz que há dois dias estava trabalhando quando sentiu cefaleia frontal em peso e atribuiu à pressão arterial, porque quando sente dor de cabeça " a pressão está sempre alta". Mediu a PA com o médico do trabalho e verificou níveis de 160 x 90 mmHg. Em casa, após melhora da cefaleia, voltou a medir a pressão arterial duas vezes, com intervalo de uma hora, verificando níveis de 124 x 70 mmHg e 130 x 70 mmHg. Nega comorbidades, tabagismo ou etilismo. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral e nutricional, corada. PA = 150 x 90 mmHg em mais de uma medida, sem alterações significativas com a mudança de decúbito ou de membro. FC = 85 bpm. Exame segmentar sem alterações. Diante do quadro descrito, indique o tratamento medicamentoso ? classe de droga ? que deve ser instituído caso a paciente apresente novo episódio de pressão arterial elevada associada à cefaleia frontotemporal.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

84998)

Enunciado: Homem, 74 anos de idade, chega ao ponto-socorro com queixa, há 2 dias, de dispneia de moderada intensidade, associada à tosse, expectoração amarelada e chiado no peito. Nega febre. Refere várias crises semelhantes nos últimos 2 anos, necessitando de internação em algumas delas, a última foi há 4 meses. Apesar disto não realiza acompanhamento médico rotineiro. Antecedentes: Tabagista 65 anos-maço, atualmente 20 cigarros ao dia; Etilista de 2 doses de destilado ao dia, há 50 anos. Nega comorbidades ou uso crônico de medicações. Ao exame clínico: pessão arterial: 138x86 mmHg; frequência cardíaca: 110 batimentos/min, ritmico: frequência respiratória: 28 movimentos/min; Saturação minimamente invasiva de O2. 84% (ar ambiente) em repouso; bulhas rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos; murmúrios vesiculares presentes, diminuídos, com roncos e sibilos expiratórios difusos. Abdome plano, flácido, indolor a palpação: extremidades com cianose discreta. Instalada máscara de oxigênio 10 L/min. Após 10 minutos, o paciente evoluiu com rebaixamento do nível de consciência. Cite os diagnósticos do paciente na presente consulta, de acordo com a história clínica, os antecendentes e achados de exame físico.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49290)

Enunciado: Homem, 25 anos de idade, vem há um mês com cãibras e fadiga muscular, as quais atribui a início de atividade física. Relata níveis elevados de PA em exames anteriores. Tem história familiar de hipertensão e pai faleceu aos 42 anos de idade de AVC hemorrágico. No exame, apresenta IMC: 25, mucosas coradas, hidratado, PA: 160 x 100 mmHg, sem variação entre os membros. Ausculta cardíaca e respiratória sem alterações, abdome sem visceromegalias e extremidades sem edemas, sem sopros à ausculta. Traz exames: hemograma normal, creatinina: 0,9 mg/dl, ureia: 29 mg/dl. A melhor conduta inicial para esse paciente é dosar:

A) Cortisol sérico e urinário;

B) Potássio sérico e urinário;

C) Metanefrinas na urina;

D) Sódio em urina de 24 horas;

E) ACTH sérico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49296)

Enunciado: Homem, 57 anos de idade, em revisão no ambulatório, após internamento em emergência por edema agudo de pulmão há 15 dias, com dispneia aos esforços extra-habituais. Apresenta TA: 150 x 85 mmHg, pulso radial: 84 bpm, FR: 22 ipm. Mucosas coradas, sem estase de jugulares. Aparelho respiratório: pulmões limpos. Aparelho cardiovascular: ictus no 5º espaço intercostal, 2 cm fora da linha medioclavicular, impulsivo. Ausculta: bulhas rítmicas, B2 hiperfonese de B2 e presença de B4. Abdomên e extremidades sem alterações. Traz ecocardiograma: fração de ejeção de 55%, átrio esquerdo pouco aumentado, escape sistólico mitral com diâmetro valvular normal, hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo com alteração de relaxamento ventricular. A droga menos útil no caso é:

A) furosemida.

B) captopril.

C) digoxina.

D) amlodipina.

E) propranolol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

35013)

Enunciado: No tratamento do paciente com ICC crônica descompensada, é importante reconhecer em que perfil clínico-hemodinâmico ele se encontra , pois isso abre algoritmos de tratamento e facilita a abordagem terapêutica. Assim, o paciente no:

A) perfil A, traduz paciente congesto e bem perfundido, devendo ser priorizado diuréticos de alça.

B) perfil B, traduz paciente sem congestão sistêmica e bem perfundido, devendo ser priorizado vasodilatadores.

C) perfil C, traduz paciente congesto e mal perfundido, devendo ser priorizado o uso de digitálicos e diuréticos.

D) perfil D, traduz paciente em baixo débito cardíaco, devendo ser priorizado levosimedan para compensação mais rápida.

E) perfil L, traduz paciente mal perfundido e sem evidência de congestão sistêmica, sendo necessário inicialmente desafio volêmico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

34969)

Enunciado: Paciente portadora da Síndrome de Turner vem à consulta de rotina, quando é observada diminuição da amplitude dos pulsos arteriais nos membros inferiores, associada à presença de pulsos amplos e hipertensão arterial nos membros superiores, hiperfonese da 2ª bulha nas áreas aórtica e mitral; estalido protossistólico aórtico, principalmente na área mitral, sopro ocupando a mesotelessístole e avançando até a protomesodiástole na região do dorso esquerdo. A principal suspeita diagnóstica é de:

A) miocardite viral.

B) endocardite infecciosa.

C) estenose da pulmonar.

D) coarctação de aorta.

E) derrame pericárdico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27432)

Enunciado: A aferição da tensão arterial pode ser subestimada quando:

A) for realizada após ingesta de bebidas à base de cola.

B) forem realizadas duas auferições com menos de 2 minutos de intervalo.

C) tiver o manguito de borracha com largura de 60% da circunferência do braço.

D) for realizada imediatamente após atividade física.

E) a insuflação do manguito estiver acima de 50 mmHg da sistólica palpatória.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27444)

Enunciado: Homem, 22 anos de idade, apresenta-se com dor retroesternal e dispneia aos esforços habituais. Há 3 semanas iniciou febre com irritação em orofaringe, dores musculares e diarreia. Após 5 dias passou a febre, persistindo astenia. Há 1 semana iniciou dispneia ao deambular, com dor retroesternal e tosse seca. Surgiram dor abdominal à alimentação e distensão abdominal. Nega uso de drogas, tabagismo ou etilismo. Ao exame físico, TA: 120 x 70 mmHg, pulso radial: 122 bpm, arrítmico com ES. Temp: 37,5°C, mucosas coradas, orofaringe sem exsudatos. Estase de jugulares a 45°. Pulmões com crépitos em bases. Precórdio ativo, com impulsão paraesternal esquerda. Ictus no 6° espaço intercostal esquerdo linha hemiclavicular, duas polpas digitais. Bulhas arrítmicas à custa de extrassístoles sem pausa compensatória, presença de B3 e B4 sem sopros. Abdome doloroso à palpação em HD, com fígado percutível a 5 cm do RCD e 7 cm do AX. Espaço de Traube livre. Extremidades aquecidas e acianóticas com edema de MMII até terço médio das pernas. Eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal com extrassístoles supraventriculares e supradesnível de ST de 3 mm em DI, DII, AVL, e precordiais esquerdas. VHS 43 mm na primeira hora. Proteína C reativa: 6 mg/dl (VN até 8 mg/dl). Dos exames complementares, relacionados a seguir, o de maior valia no manejo desse paciente é:

A) antiestreptolisina O.

B) ecocardiograma.

C) teste ergométrico.

D) troponina I.

E) cineangiocoronariografia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27446)

Enunciado: Homem, 22 anos de idade, apresenta-se com dor retroesternal e dispneia aos esforços habituais. Há 3 semanas iniciou febre com irritação em orofaringe, dores musculares e diarreia. Após 5 dias passou a febre, persistindo astenia. Há 1 semana iniciou dispneia ao deambular, com dor retroesternal e tosse seca. Surgiram dor abdominal à alimentação e distensão abdominal. Nega uso de drogas, tabagismo ou etilismo. Ao exame físico, TA: 120 x 70 mmHg, pulso radial: 122 bpm, arrítmico com ES. Temp: 37,5°C, mucosas coradas, orofaringe sem exsudatos. Estase de jugulares a 45°. Pulmões com crépitos em bases. Precórdio ativo, com impulsão paraesternal esquerda. Ictus no 6° espaço intercostal esquerdo linha hemiclavicular, duas polpas digitais. Bulhas arrítmicas à custa de extrassístoles sem pausa compensatória, presença de B3 e B4 sem sopros. Abdome doloroso à palpação em HD, com fígado percutível a 5 cm do RCD e 7 cm do AX. Espaço de Traube livre. Extremidades aquecidas e acianóticas com edema de MMII até terço médio das pernas. Eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal com extrassístoles supraventriculares e supradesnível de ST de 3 mm em DI, DII, AVL, e precordiais esquerdas. VHS 43 mm na primeira hora. Proteína C reativa: 6 mg/dl (VN até 8 mg/dl). Quanto à etiologia do caso, é correto afirmar:

A) Vírus coxsackie é o agente mais comum.

B) Espasmo coronariano, sem lesão estrutural, é a maior possibilidade.

C) Homocisteinemia é o fator mais provável nessa faixa etária.

D) Tratamento com penicilina para estreptococos beta-hemolíticos está indicado.

E) Tuberculose é uma causa frequente do processo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27449)

Enunciado: Homem, 22 anos de idade, apresenta-se com dor retroesternal e dispneia aos esforços habituais. Há 3 semanas iniciou febre com irritação em orofaringe, dores musculares e diarreia. Após 5 dias passou a febre, persistindo astenia. Há 1 semana iniciou dispneia ao deambular, com dor retroesternal e tosse seca. Surgiram dor abdominal à alimentação e distensão abdominal. Nega uso de drogas, tabagismo ou etilismo. Ao exame físico, TA: 120 x 70 mmHg, pulso radial: 122 bpm, arrítmico com ES. Temp: 37,5°C, mucosas coradas, orofaringe sem exsudatos. Estase de jugulares a 45°. Pulmões com crépitos em bases. Precórdio ativo, com impulsão paraesternal esquerda. Ictus no 6° espaço intercostal esquerdo linha hemiclavicular, duas polpas digitais. Bulhas arrítmicas à custa de extrassístoles sem pausa compensatória, presença de B3 e B4 sem sopros. Abdome doloroso à palpação em HD, com fígado percutível a 5 cm do RCD e 7 cm do AX. Espaço de Traube livre. Extremidades aquecidas e acianóticas com edema de MMII até terço médio das pernas. Eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal com extrassístoles supraventriculares e supradesnível de ST de 3 mm em DI, DII, AVL, e precordiais esquerdas. VHS 43 mm na primeira hora. Proteína C reativa: 6 mg/dl (VN até 8 mg/dl). Entre os achados diagnósticos no ECG relativos às extrassístoles supraventriculares, nesse caso, não se encontra:

A) complexo QRS de duração normal.

B) vetor QRS com direção diferente dos batimentos normais.

C) ausência de onda P.

D) onda P de morfologia alterada.

E) ausência de pausa após uma extrassístole.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27452)

Enunciado: Homem, 22 anos de idade, apresenta-se com dor retroesternal e dispneia aos esforços habituais. Há 3 semanas iniciou febre com irritação em orofaringe, dores musculares e diarreia. Após 5 dias passou a febre, persistindo astenia. Há 1 semana iniciou dispneia ao deambular, com dor retroesternal e tosse seca. Surgiram dor abdominal à alimentação e distensão abdominal. Nega uso de drogas, tabagismo ou etilismo. Ao exame físico, TA: 120 x 70 mmHg, pulso radial: 122 bpm, arrítmico com ES. Temp: 37,5°C, mucosas coradas, orofaringe sem exsudatos. Estase de jugulares a 45°. Pulmões com crépitos em bases. Precórdio ativo, com impulsão paraestemal esquerda. Ictus no 6° espaço intercostal esquerdo linha hemiclavicular, duas polpas digitais. Bulhas arrítmicas à custa de extrassístoles sem pausa compensatória, presença de B3 e B4 sem sopros. Abdome doloroso à palpação em HD, com fígado percutível a 5 cm do RCD e 7 cm do AX. Espaço de Traube livre. Extremidades aquecidas e acianóticas com edema de MMII até terço médio das pernas. Eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal com extrassístoles supraventriculares e supradesnível de ST de 3 mm em DI, DII, AVL, e precordiais esquerdas. VHS 43 mm na primeira hora. Proteína C reativa: 6 mg/dl (VN até 8 mg/dl). A medida farmacológica mais importante no tratamento desse paciente é indicação de:

A) digitálico.

B) diurético de alça.

C) penicilina benzatina.

D) aspirina.

E) nitrato.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27482)

Enunciado: Paciente, 12 anos de idade, vem ao ambulatório pela primeira vez, com o propósito de realizar exame de rotina, pois sua mãe está preocupada com a proximidade da menarca. Ao exame, foi notada TA: 130 X 100 mmHg, sem qualquer outra anormalidade. A melhor conduta a ser adotada, nesse caso, é:

A) solicitar sumário de urina e provas de função renal.

B) marcar retorno, pelo menos, mais 2 vezes na mesma semana para confirmar a pressão arterial.

C) solicitar ultrassonografia renal e sumário de urina.

D) suspender o sal da dieta e usar diurético.

E) prescrever captopril em dose mínima e marcar retorno após uma semana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13292)

Enunciado: Paciente, 18 anos de idade, apresenta em avaliação médica de rotina TA: 160 x 110 mmHg. Tem história familiar de hipertensão arterial. Ritmo urinário sem alterações, com urina de aspecto normal. Ao exame, apresenta-se sem outras alterações à exceção de esmagamento nos cruzamentos arteriovenosos na retina e imagem em ?chama de vela? na oftalmoscopia. Não há diferença pressórica entre os membros. A medicação que deve ser usada com cautela, nesse paciente, é:

A) propranolol.

B) nifedipina.

C) losartana.

D) diurético tiazídico.

E) clonidina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13293)

Enunciado: Paciente, 18 anos de idade, apresenta em avaliação médica de rotina TA: 160 x 110mmHg. Tem história familiar de hipertensão arterial. Ritmo urinário sem alterações, com urina de aspecto normal. Ao exame, apresenta-se sem outras alterações à exceção de esmagamento nos cruzamentos artério-venosos na retina e imagem em ?chama de vela? na oftalmoscopia. Não há diferença pressórica entre os membros. Quanto ao tratamento desse paciente, a meta deve ser:

A) internação imediata e redução da TA em 25% nas primeiras 6 horas

B) retorno com uma semana para reavaliação da TA

C) indicação de mudanças alimentares e de estilo de visa, com reavaliação em 3 meses

D) internação para observação e estudo, redução da TA em 24 horas

E) redução da TA com medicação oral, com reavaliação em 1 semana

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11131)

Enunciado: Homem, 72 anos de idade, com tensão arterial mantida em níveis de 175 X 80 mmHg, sem outras alterações, procura atendimento médico. O tratamento mais recomendado é:

A) iniciar propanolol oral.

B) iniciar nifedipina oral.

C) iniciar captopril oral.

D) indicar controle dietético de sódio, apenas.

E) iniciar diurético tiazídico oral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

11132)

Enunciado: A aferição correta da tensão arterial, por técnica padronizada, vem sendo enfatizada como medida de qualidade de atenção médica. São recomendações que fazem parte da padronização do Ministério da Saúde, exceto:

A) uso de manguito com largura correspondente a 40% da circunferência do braço

B) intervalo mínimo de 1 minuto entre as duas aferições

C) registro habitual da tensão arterial diastólica no momento do desaparecimento dos sons (Korotkoff V)

D) arredondamento de no máximo 5 mmHg no registro dos valores da tensão arterial

E) tomada sistemática da tensão arterial sistólica palpatória antes da auscultatória

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

18040)

Enunciado: Homem, 52 anos de idade, mulato escuro, com dispneia progressiva, palpitações, edema de MMII ascendente há 5 meses. Encontra-se com dispneia aos mínimos esforços e ortopneia. Ao exame físico, TA: 110x70mmHg. PR: 108bpm, fino, rítmico e alternante, FR: 31ipm. Apresenta estase de jugulares a 45º até ângulo da mandíbula. Precórdio ativo, com ictus cordis 3 cm para fora da linha hemiclavicular, no 6 espaço intercostal. Ausculta mostra ritmo em 3 tempos com terceira bulha. Creptos em bases de ambos os hemitóraces. Abdome com fígado a 5 cm do RCD e 8 cm do AX. Edema de MMII até nível de joelhos e cianose de extremidades. Das drogas relacionadas a seguir, se usada no caso, a que menos interfere na sobrevida desse paciente é:

A) Captopril.

B) Losartan.

C) Digoxina.

D) Carvedilol.

E) Amilodipina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

15752)

Enunciado: Paciente, sexo masculino, 38 anos de idade, com altura de 1,70m e peso de 85kg, tabagista, assintomático. Realizou exame de rotina, que incluiu dosagem de glicemia de jejum de 110mg/dl e glicemia pós-prandial de duas horas de 145mg/dl, a avaliação posterior incluiu uma dosagem de HbA1C, cujo resultado foi de 6,0%. A dosagem de colesterol total foi de 239mg/dl, com HDL de 42mg/dl e triglicérides de 315mg/dl. A PA. foi de 130X80mmHg em três tomadas, em momentos diversos. A melhor conduta para esse paciente é:

A) iniciar metformina oral.

B) iniciar sibutramina oral.

C) indicar programa de redução de peso e exercícios físicos.

D) iniciar acarbose oral.

E) iniciar rosiglitazona oral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

15808)

Enunciado: Paciente, 20 anos de idade, G1P0A0, vem referindo gestação de 24 semanas, diz ser portadora de cardiopatia tipo CIV, com dispneia a esforços, como subir ladeiras ou escadas, limitação que não apresentava antes da gestação. Ao ecocardiograma, evidencia-se defeito septal ventricular sem inversão de fluxo e hipertensão pulmonar leve com fração de ejeção de 55%. Segundo a NYHA, a paciente se encontra em classe funcional:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

343336)

Enunciado: Os inibidores da proteína co-transportadora SGLT2 (ISGLT2) inaugurou uma nova era no tratamento da insuficiência cardíaca IC em pessoas com diabetes.

A) Além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular.

B) Além de não controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular.

C) Além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, aumentando de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular.

D) Além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a não a mortalidade cardiovascular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281849)

Enunciado: Na encefalopatia hipertensiva pode, posteriormente, surgir alterações adequadamente descritas no item:

A) Nunca do estado mental e sim campimétricas, fotopsia, visão turva, alucinações visuais, crises convulsivas generalizadas, hiperreflexia e sinais de hipertensão intracraniana.

B) Do estado mental e campimétricas, fotopsia, visão turva, alucinações visuais, crises convulsivas generalizadas, hiperreflexia e nunca sinais de hipertensão intracraniana.

C) Do estado mental e não campimétricas, fotopsia ou visão turva.

D) Do estado mental e campimétricas, fotopsia, visão turva, alucinações visuais, crises convulsivas generalizadas, hiperreflexia e sinais de hipertensão intracraniana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281852)

Enunciado: No contexto da Insuficiência Mitral Secundária, há uma sobrecarga adicional ao VE pela regurgitação mitral, culminando num pior prognóstico. As principais etiologias são: doença arterial coronária (IM isquêmica) e miocardiopatia dilatada (dilatação anular e/ou mau posicionamento). Sendo correto o item:

A) Por esses motivos, o tratamento ideal é controverso, uma vez que a correção valvar não é curativa.

B) Por esses motivos, o tratamento ideal não é controverso, uma vez que a correção valvar não é curativa.

C) Por esses motivos, o tratamento ideal é controverso, uma vez que a correção valvar é curativa.

D) Por esses motivos, o tratamento ideal nunca é controverso, uma vez que a correção valvar é curativa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281854)

Enunciado: No momento em que aparecem as manifestações neurológicas da encefalopatia hipertensiva, geralmente, a PAD encontra-se acima de 125 mmHg. Podemos indicar como correto:

A) A resolução do quadro, quer do ponto de vista clínico, mas não do ponto de vista de imagem, demora, em média, várias semanas após o controle da PA.

B) A resolução do quadro, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista de imagem, demora, em média, várias semanas após o controle da PA.

C) A resolução do quadro, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista de imagem, demora, em média, várias meses após o controle da PA.

D) A resolução do quadro, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista de imagem, demora, em média, várias semanas antes do controle da PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281859)

Enunciado: A Ressonância Magnética é o exame diagnóstico de maior valor para o diagnóstico da encefalopatia hipertensiva. Sendo correto o item:

A) Na sequência T2, evidenciam-se lesões hiperintensas na substância branca com comprometimento preferencial das regiões parieto-occipitais.

B) Na sequência T2, evidenciam-se lesões hipointensas na substância branca com comprometimento preferencial das regiões parieto-occipitais.

C) Na sequência T2, evidenciam-se lesões hiperintensas na substância branca sem o comprometimento preferencial das regiões parieto-occipitais.

D) Na sequência T2, não evidenciam-se lesões hiperintensas na substância branca com comprometimento preferencial das regiões parieto-occipitais.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

283855)

Enunciado: Paciente do sexo feminino, 52 anos de idade, em investigação de alterações cardíacas. Após ecocardiograma, notou-se pressão arterial < 140 x 90 mmHg em duas aferições em consultório realizadas pelo médico, em ambos os braços, mas com Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) com valores médios diurnos em torno de 146 x 92 mmHg. A alternativa que contém o diagnóstico CORRETO desse caso clínico é:

A) Crise hipertensiva.

B) Hipertensa controlada.

C) Normotensa verdadeira.

D) Hipertensão Arterial Sistêmica mascarada.

E) Hipertensão Arterial Sistêmica do avental branco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

281883)

Enunciado: Paciente de 52 anos, portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada compensada é submetida à correção de hérnia incisional após liberação do cardiologista e avaliação pré-anestesica. O tempo do procedimento cirúrgico foi de 2 horas, tempo total de anestesia geral balanceada de 2 horas e 30 minutos, com volume total infundido de 1.500 ml de cristaloides, sem necessidade de transfusão de hemoderivados, diurese quantificada em coletor de urina por sonda de demora de 600 ml. É extubada sem intercorrências, porém na sala de recuperação anestésica queixa-se de dispneia e palpitações. Nega dor torácica. Sem nenhum sintoma neurológico. Sinais vitais: pressão arterial: 180/70 mmHg, frequência cardíaca: 116 bpm, frequência respiratória: 18 irpm, saturação periférica de oxigênio em ar ambiente: 90%, temperatura axilar: 36.5ºC. Foi submetida ao eletrocardiograma e à radiografia de tórax abaixo. O provável motivo dos sintomas acima relatados são:

A) Taquicardia supraventricular e atelectasia.

B) Taquicardia supraventricular e pneumonia.

C) Fibrilação atrial e congestão pulmonar.

D) Fibrilação atrial e atelectasia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

249972)

Enunciado: Quando analisamos os prognósticos de pacientes com hipertensão arterial, qual dos itens abaixo pode ser determinado como adequado?

A) As aferições de PA pela monitorização residencial da pressão arterial MRPA na avaliação do prognóstico de eventos futuros, apresentam pior correlação com os eventos do que as medidas de consultório na maioria deles.

B) As aferições de PA pela monitorização residencial da pressão arterial MRPA na avaliação do prognóstico de eventos futuros, apresentam melhor correlação com os eventos do que as medidas de consultório na maioria deles.

C) As aferições de PA pela monitorização residencial da pressão arterial MRPA na avaliação do prognóstico de eventos futuros, não apresentam correlação com os eventos do que as medidas de consultório na maioria deles.

D) As aferições de PA pela monitorização residencial da pressão arterial MRPA na avaliação do prognóstico de eventos futuros, apresentam melhor correlação com as medidas do que com os eventos de consultório na minoria deles.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215572)

Enunciado: Não é incomum que pacientes com insuficiência cardíaca crônica em classe funcional II (NYHA ? New York Heart Association) se encontrem autolimitados, ou seja, tenham tal classe funcional subestimada, por não se submeterem a esforços no dia a dia. NÃO está correto apenas um item. Marque-o.

A) No momento da avaliação do paciente, um raciocínio individualizado, envolvendo fatores prognósticos, é fundamental.

B) Tal raciocínio deve ir além da estimativa de classe funcional, incluindo dados de história, etiologia, exame físico, exames complementares, avaliação hemodinâmica e tolerância às medicações com impacto em mortalidade.

C) A avaliação do desempenho físico, por meio do teste da caminhada de 6 minutos ou do teste cardiopulmonar, estabelece de forma menos objetiva a real situação funcional nestes cenários.

D) A correta avaliação prognóstica implica na seleção adequada de terapias adicionais por meio do encaminhamento a centros especializados em IC, bem como a indicação de estratégias mais avançadas de tratamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215578)

Enunciado: Pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) e disfunção ventricular sistólica, que têm bloqueio atrioventricular com indicação de marca- passo, a Terapia de ressincronização cardíaca e cardiodesfibrilador implantável TRC (estímulo biventricular). Indique o item ERRADO nesse contexto.

A) Pacientes com FA sintomática com indicação de ablação atrioventricular não parecem ter benefício sobre morbidade quando recebem estímulo biventricular.

B) Ocorre benefício com TRC (estímulo biventricular) demonstrado.

C) Este efeito ocorreu, prioritariamente, no desfecho clínico de visitas à emergência ou hospitalização por IC.

D) A eficácia da TRC com benefícios clínicos inquestionáveis relacionados à melhora de sintomas e da qualidade de vida, redução de admissões hospitalares e melhora da sobrevida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215589)

Enunciado: Nas indicações de marca-passo convencional e/ou cardiodesfibrilador implantável, os estudos preliminares não randomizados sugerem que está CORRETO um item. Indique-o:

A) Pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) e disfunção ventricular esquerda, que tenham marca-passo convencional ou estimulação persistente de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI), e apresentem piora clínica e/ou ecocardiográfica clara não podem ter benefício com upgrade para (TRC) Terapia de dessincronizarão cardíaca e cardiodesfibrilador implantável (TRC) (estímulo biventricular).

B) Pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) e disfunção ventricular esquerda, que tenham marca-passo convencional ou estimulação persistente de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI), e apresentem piora clínica e/ou ecocardiográfica clara podem ter benefício com upgrade para (TRC) Terapia de dessincronizarão cardíaca e cardiodesfibrilador implantável (TRC) (estímulo biventricular).

C) Pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) e disfunção ventricular esquerda, que tenham marca-passo convencional ou estimulação persistente de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI), e apresentem piora clínica e/ou ecocardiográfica leve podem ter benefício com upgrade para (TRC) Terapia de dessincronizarão cardíaca e cardiodesfibrilador implantável (TRC) (estímulo biventricular).

D) Pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) e disfunção ventricular esquerda, que tenham marca-passo convencional ou estimulação persistente de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI), e apresentem melhora ecocardiográfica clara pode ter benefício com upgrade para (TRC) Terapia de dessincronizarão cardíaca e cardiodesfibrilador implantável (TRC) (estímulo biventricular).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215595)

Enunciado: A MAPA pode dar informações clínicas valiosas em pacientes idosos, como nos casos de suspeita de hipotensão arterial ortostática, pós-prandial, medicamentosa e situacional. É CORRETO que, no idoso, o descenso da PA durante o sono:

A) Não é relacionado com a redução da resistência vascular periférica, enquanto no jovem esse fenômeno é relacionado com a redução do débito cardíaco.

B) É relacionado com ao aumento da resistência vascular periférica, enquanto no jovem esse fenômeno é relacionado com a redução do débito cardíaco.

C) É relacionado com a redução da resistência vascular periférica, enquanto no jovem esse fenômeno não é relacionado com a redução do débito cardíaco.

D) É relacionado com a redução da resistência vascular periférica, enquanto no jovem esse fenômeno é relacionado com a redução do débito cardíaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215608)

Enunciado: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome complexa, com alteração da função cardíaca, o que resulta em sintomas e sinais de baixo débito cardíaco e/ou congestão pulmonar ou sistêmica. É CORRETO que a etiologia da IC:

A) Não difere de acordo com as diferentes regiões ao redor do mundo, e buscar a causa para o desenvolvimento da IC tem particular importância, uma vez que o prognóstico também difere entre elas, podendo orientar tratamento específico.

B) Difere de acordo com as diferentes regiões ao redor do mundo, e buscar a causa para o desenvolvimento da IC tem particular importância, uma vez que o prognóstico também difere entre elas, podendo orientar tratamento específico.

C) Difere de acordo com as diferentes regiões ao redor do mundo, e buscar a causa para o desenvolvimento da IC não tem importância, uma vez que o prognóstico também não difere entre elas, podendo orientar tratamento específico.

D) Difere de acordo com as diferentes regiões ao redor do mundo, e buscar a causa para o desenvolvimento da IC tem particular importância, uma vez que o prognóstico também difere entre elas, não podendo orientar tratamento específico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215613)

Enunciado: A hipertensão matinal atraiu atenção por causa da estreita relação com risco cardiovascular como condições caracterizadas por valores elevados de PA, podem causar eventos em idosos e, por meio da MAPA, é possível identificá-los e definir a melhor forma de tratamento.

Está CORRETO que, em idosos, verificou-se que:

A) A elevação matinal precoce da PA acima de 75 mmHg estava vinculada à maior prevalência de acidente vascular encefálico isquêmico.

B) A redução matinal precoce da PA acima de 55 mmHg estava vinculada à maior prevalência de acidente vascular encefálico isquêmico.

C) A elevação matinal precoce da PA acima de 55 mmHg estava vinculada à menor prevalência de acidente vascular encefálico isquêmico.

D) A elevação matinal precoce da PA acima de 55 mmHg estava vinculada à maior prevalência de acidente vascular encefálico isquêmico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215615)

Enunciado: A MAPA pode dar informações clínicas valiosas em pacientes idosos, como nos casos de suspeita de hipotensão arterial ortostática, pós-prandial, medicamentosa e situacional, bem como na avaliação de disautonomia e síncopes. Indique a CORRETA.

A) Nos idosos, algumas limitações devem ser salientadas. O enrijecimento arterial próprio da idade tende a superestimar a PA medida pelo método oscilométrico e, consequentemente, na presença de pseudo-hipertensão, a MAPA está sujeita a erros.

B) A presença de hiato auscultatório, comum nos idosos, mas que sendo usado o método oscilométrico não resultará em limitações.

C) Não se aceitam para os idosos os mesmos valores de normalidade da MAPA adotados para os adultos não idosos.

D) A redução do descenso da PA durante o sono, a pressão de pulso aumentada e a elevação matinal precoce da PA, rara nos idosos, relacionam-se a aumento do risco cardiovascular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

218190)

Enunciado: Sobre a atenção à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e às doenças crônicas não transmissíveis, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. ( ) Os pacientes com pré-hipertensão arterial e comorbidades devem ser tratados. O grupo de medicamentos com mais evidências científicas e que deve ser o tratamento de escolha são os Betabloqueadores, cujo uso recomendado é, exclusivo inicialmente, até que o teste terapêutico mostre a necessidade de associação de mais algum medicamento, que pode ser qualquer um dentre os Tiazídicos. inibidores da ECA ou bloqueadores do canal de cálcio. ( ) Todos os adultos devem ter sua PA aferida como medida de rastreamento e uma PAS ? 130 mmHg e/ou PAD ? 80 mmHg caracteriza HAS. A decisão do início do tratamento farmacológico deve se basear no cálculo do risco cardiovascular pelo escore global de Framingham tendo como alvo terapêutico uma PA < 120/80 mmHg. É recomendado o início de terapia combinada (2 anti-hipertensivos), se HAS estágio 2, e/ou se a PA medida estiver acima da meta em mais de 20/10 mmHg (sistólica/diastólica). Os fármacos de primeira linha são os Tiazídicos; inibidores da ECA ou bloqueadores do canal de cálcio e Betabloqueadores. ( ) O manejo da pessoa com HAS exige a estratificação de seu risco e vulnerabilidade, sendo o escore de Framingham ou o QRisk2, e, também, a Pirâmide de Risco para analisar a capacidade de autocuidado, grau de confiança e o apoio que as pessoas têm para cuidar de si mesmas, etc, ferramentas importantíssimas para a tomada de decisão junto com o usuário. Não se recomenda o início do tratamento medicamentoso, antes de se tentar as intervenções não medicamentosas para pessoas com PAS em até 159 ou 99 (grau I) se não elas não tiverem risco cardiovascular maior que 20%, ou diabetes mellitus, ou lesão de órgão alvo ou, ainda, doença cardiovascular estabelecida. A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

A) V, F, V.

B) V, F, F.

C) F, V, F.

D) F, F, V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

E) F, V, V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181182)

Enunciado: Um grande número de pacientes procura serviços de Emergência devido à Hipertensão Arterial. Considerando os conceitos de Urgência Hipertensiva (UH), Emergência Hipertensiva (EH) e Crise Hipertensiva, qual item não se mostra adequado?

A) A sobrevida de até 5 anos é significantemente maior em indivíduos com UH do que com EH.

B) Ausência de descenso noturno associa-se a maior risco de Lesão Órgão Alvo e consequente disfunção endotelial, situação envolvida na elevação aguda da PA.

C) Pacientes com queixas de cefaleia, dor torácica atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e síndrome de pânico associados à PA elevada não caracterizam UH ou EH, mas, na realidade, uma pseudocrise hipertensiva,

D) O tratamento pseudocrise hipertensiva deve ser realizado com medicações endovenosas preferencialmente e conscientização da adesão ao tratamento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

181202)

Enunciado: O quadro de Hipertensão Arterial Resistente (HAR) é definido de maneira adequado por diversos fatores. Para o diagnóstico de HAR é necessária medida ambulatorial de PA e verificação sistemática de adesão, sendo INCORRETO apenas:

A) PA de consultório não controlada apesar do uso de três ou mais anti-hipertensivos em doses inadequadas, incluindo-se preferencialmente um DIU, ou em uso de quatro ou mais medicamentos com controle pressórico.

B) Quando não inclui a verificação sistemática da terapêutica e da adesão, essa situação é melhor definida como HAR aparente (pseudorresistência).

C) A identificação da HAR verdadeira é fundamental para estabelecer abordagens específicas.

D) Estudos populacionais estimam prevalência em 12% da população hipertensa.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

162511)

Enunciado: Josefina, 56 anos, vem para consulta do HIPERDIA, na Unidade de Saúde da Família e é atendida por um médico residente. Ela está preocupada e relata estar usando as medicações "direitinho" como foram prescritas, que faz uso das medicações neste dia da consulta e a alimentação está adequada. Está em uso de hidroclorotiazida 50mg/dia, enalapril 40 mg/dia e anlodipino 10mg/dia. Sua PA no momento está 168 x 90 mmHg e a média das medidas ambulatoriais estão maiores que 150 x 90 mmHg. Em relação a este caso, é correto afirmar que

A) é necessário aumentar a dose do enalapril para 80 mg/dia.

B) é necessário aumentar a dose do anlodipino para 20 mg/dia.

C) pode ser necessário encaminhar a paciente para o cardiologista.

D) a PA de Josefina está elevada, pois a medicação de escolha, em monoterapia, seria um betabloqueador.

E) a PA de Josefina está elevada, pois não há indicação de uso de enalapril associado à hidroclorotiazida ou ao anlodipino.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157634)

Enunciado: Assinale a alternativa que NÃO representa uma cardiopatia que cursa com necessidade de pressões altas de enchimento ventricular (PVC elevada).

A) Comunicação interventricular.

B) Tetralogia de Fallot.

C) Anastomose cavopulmonar.

D) Shunt sistêmico-pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157630)

Enunciado: A avaliação inicial de um paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeição e a identificação de causa secundária, além da avaliação do risco CV, sendo DESNECESSÁRIO certificar-se de que o paciente não:

A) Esteja com a bexiga cheia.

B) Tenha praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos.

C) Tenha ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos.

D) Tenha fumado nos 60 minutos anteriores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157629)

Enunciado: Hipertensão Arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por diversas alterações. Sobre isso, indique a alternativa CORRETA.

A) Raramente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM).

B) Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação eventual dos níveis pressóricos = 140 e/ou 90 mmHg.

C) Mantém associação dependente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE) e infarto agudo do miocárdio (IAM).

D) Mantém associação independente com eventos como insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157633)

Enunciado: Quando analisamos o quadro brasileiro de Hipertensão Arterial e doença cardiovascular, podemos considerar como ADEQUADO o que consta em uma das opções. Indique-a.

A) Hipertensão arterial atinge mais de 60% dos idosos.

B) Junto com DM, suas complicações (cardíacas, renais e AVE) têm impacto pequeno na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar.

C) Hipertensão arterial no Brasil atinge 15% (36 milhões) de indivíduos adultos.

D) Em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, 339.672 dos quais (9,8%) decorrentes de DCV, a principal causa de morte no país.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157577)

Enunciado: Dentro da necessidade de avaliação inicial de um paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) inclui a confirmação do diagnóstico, com correta metodologia de aferição da PA, INADEQUADAMENTE descrita em uma das alternativas a seguir. Assinale-a:

A) Posicionamento: o paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas e pés apoiados no chão.

B) O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para baixo e as roupas não devem garrotear o membro.

C) Medir a PA na posição de pé, após 3 minutos.

D) Posicionamento: o paciente deve estar sentado, dorso recostado na cadeira e relaxado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157581)

Enunciado: Dentre as etapas para a realização da medição, NÃO pode ser considerada correta uma delas. Indique-a.

A) Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olecrano.

B) Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço.

C) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 5 cm acima da fossa cubital.

D) Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157584)

Enunciado: Dentre as inter-relações entre Hipertensão Arterial e doença cardiovascular no Brasil, aponte a alternativa em que a afirmação esteja INCORRETA.

A) Em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, 339.672 dos quais (29,8%) decorrentes de DCV, a principal causa de morte no País.

B) As taxas de mortalidade decorrentes de DCV em geral têm apresentado redução ao longo dos anos, com exceção das doenças hipertensivas (DH), que aumentou entre 2002 e 2009 e mostrou tendência à redução desde 2010.

C) As taxas de mortalidade têm apresentado redução das doenças hipertensivas (DH), no período que compreendeu entre 2002 e 2009.

D) Dentro de nossa realidade houve redução da IC congestiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157587)

Enunciado: Dentro dos conceitos de Medicina Preventiva existe um importante conceito de Pré-hipertensão que NÃO está adequadamente relacionado a uma das alternativas apresentadas a seguir. Aponte-a.

A) Pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada por PA sistólica (PAS) entre 121 e 139 e/ou PA diastólica (PAD) entre 81 e 89 mmHg.

B) Cerca de um décimo dos eventos cardiovasculares (CV) atribuíveis à elevação de PA ocorrem em indivíduos com PH.

C) A PH associa-se a maior risco de desenvolvimento de Hipertensão.

D) A implicação clínica dessas evidências epidemiológicas é que a PA de indivíduos Pré-hipertensos deve ser monitorada mais de perto, pois uma significativa proporção deles irá desenvolver HA e suas complicações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157589)

Enunciado: Em relação ao estudo de prevalência de Hipertensão Arterial no Brasil, aponte a alternativa que está em DESACORDO com as últimas diretrizes científicas.

A) A prevalência de HA no Brasil varia de acordo com a população estudada e o método de avaliação.

B) No Norte, foram apresentadas as maiores taxas.

C) Estudos transversais e de coorte incluídos mostraram tendência à diminuição da prevalência nas últimas três décadas.

D) O Sudeste foi a região com maior prevalência de HA autorreferida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157594)

Enunciado: Dentre os fatores de risco para Hipertensão Arterial, diversos fatores relacionados a ela podem ser considerados como importantes. Desse modo, marque a opção INCORRETA.

A) Não ocorre uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de Hipertensão.

B) A prevalência de HA autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos.

C) Estudos realizados no Brasil, incluindo indivíduos idosos, mostraram 68% de prevalência de Hipertensão.

D) Estudos brasileiros que avaliaram o impacto de polimorfismos genéticos na população de quilombolas não conseguiram identificar um padrão mais prevalente.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157596)

Enunciado: Acerca das estratégias para a implementação de medidas de prevenção da Hipertensão Arterial, que englobam políticas públicas de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação, podemos considerar como NÃO efetivo o seguinte. Indique-o.

A) O objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR associados.

B) Promover modificação do estilo de vida (MEV) e/ou uso regular de medicamentos.

C) Consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a PA de forma consistente.

D) O impacto da dieta rica em sódio, estimada em pesquisas, indica que a maioria das pessoas entrevistadas reconhece conteúdo alto ou muito alto de sal nos alimentos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157599)

Enunciado: Para auxiliar o diagnóstico de hipertensão, pode ser proposta a medição da PA fora do consultório. A PA fora do consultório pode ser obtida através da Medição Residencial da Pressão Arterial (MRPA), ou da MAPA de 24 horas. As medições da PA fora do consultório devem ser estimuladas, podendo ser realizadas por equipamento semiautomático do próprio paciente ou dos serviços de saúde. As principais vantagens da medição da PA fora do consultório estão listadas a seguir, com a EXCEÇÃO de uma delas. Aponte-a:

A) Maior número de medidas obtidas.

B) Refletem as atividades usuais dos examinandos.

C) Menor engajamento dos pacientes com o diagnóstico e o seguimento.

D) Abolição ou sensível redução do efeito de avental branco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157602)

Enunciado: Paciente hipertenso, mal controlado por ser muito agitado e teimoso, procura seu consultório pela terceira vez a fim de tentar obter o controle de sua hipertensão. Então durante a consulta, diversas argumentações a esse respeito são feitas. Entre elas, uma está atualmente INCORRETA, e está contida em uma das opções seguintes. Indique-a.

A) O AVE é a manifestação mais comum da lesão vascular causada pela HA.

B) A escolha terapêutica deve ser baseada na eficácia do medicamento e na tolerabilidade ao mesmo.

C) A associação de Hipertensão e Diabetes aumenta em quatro o risco Cardiovascular, e tem aumentado a prevalência de HA.

D) Cronicamente, a terapia anti-hipertensiva eficaz, mantendo PA menor que 130/80 mmHg, tem tido um papel decisivo na prevenção secundária de todos os tipos de AVE e AIT.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157598)

Enunciado: O tratamento da Hipertensão tem, em última análise, a redução da morbimortalidade, sendo que os desfechos mostram benefícios do tratamento realizado com o uso de medicações, sendo, entretanto, de grande importância conhecer seus mecanismos de ação bem como efeitos colaterais descritos. Sobre isso, aponte a alternativa INCORRETA.

A) Os Betabloqueadores promovem diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, havendo readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas.

B) Bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II, assim os BRA antagonizam a ação da angiotensina II por meio do bloqueio específico dos receptores AT1, responsáveis pelas ações vasoconstritoras, proliferativas e estimuladoras da liberação de aldosterona, próprias da angiotensina II.

C) Alfa bloqueadores; os medicamentos dessa classe agem como antagonistas competitivos dos a1-receptores pós-sinápticos, levando à redução da RVP com grande diminuição no débito cardíaco.

D) Vasodilatadores diretos; os medicamentos que representam essa classe são hidralazina e minoxidil. Atuam, diretamente, relaxando a musculatura lisa arterial, levando à redução da RVP.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157603)

Enunciado: Recentemente um antigo paciente, que você acompanha no ambulatório de clínica médica, evolui mal e teve indicado o início de Hemodiálise devido à lesão causada pela hipertensão. Ele o procurou bastante arrependido de não ter se medicado adequadamente no passado, mas pediu novamente a sua orientação, apesar de já ter sido transferido de especialidade. Em consideração aos anos de convívio, você o orientou ADEQUADAMENTE, conforme o contido em uma das alternativas a seguir. Assinale-o.

A) A medição da PA desses pacientes deve ser feita preferencialmente fora das unidades de diálise, nos intervalos interdialíticos.

B) As decisões terapêuticas baseadas na medição de PA residencial associam-se a um pior controle pressórico interdialítico avaliado pela MAPA de 24h em comparação à medição de PA pré-diálise.

C) Quando utilizamos a mensuração dos níveis pressóricos pré-diálise, ocorre que a PA obtida dessa forma, além de apresentar grande variabilidade, está geralmente superestimada.

D) Quando utilizamos a mensuração dos níveis pressóricos, ela é subestimada quando obtida após a diálise.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157717)

Enunciado: Assinale a alternativa que NÃO representa uma alteração observada no ECG de uma criança com miocardite.

A) Taquicardia sinusal.

B) Variações no segmento ST.

C) Desvios do eixo de QRS.

D) Infiltrados pulmonares em porções basais ou inferiores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157610)

Enunciado: Paciente hipertenso e diabético (ambos mal controlados porque o paciente é rebelde ao tratamento) se recusa a se medicar diariamente, bem como não consegue mudar seu estilo de vida, que tem, como principais pontos, o tabagismo e a ingesta de grandes quantidades de sal nos churrascos. Durante última consulta, foi constatado alteração da creatinina bem como um USG, que demonstrava rins aparentemente com anatomia preservada. Acerca desse quadro, podemos considerar que:

A) Na doença renal crônica, a redução pressórica não constitui a medida mais eficaz para a redução do risco CV.

B) Após iniciada a doença renal crônica, o controle da HAS não promove mais a atenuação da progressão do dano renal, independentemente do anti-hipertensivo utilizado.

C) O achado de albuminúria elevada é determinante de evolução desfavorável da doença renal, mas não causa aumento do risco Cardiovascular.

D) Pacientes idosos com doença renovascular, DAC e com risco de hipotensão postural frequentemente requerem a individualização do tratamento anti-hipertensivo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157652)

Enunciado: Com relação ao quadro clínico da miocardite, julgue itens expostos a seguir. ; I. A apresentação clínica é muito variável, desde assintomática ou levemente sintomática, com anormalidades eletrocardiográficas transitórias, até um quadro de choque cardiogênico.; II. Uma das manifestações cardiovasculares é a taquicardia inapropriada ao estado febril. ; III. Morte súbita cardíaca pode ser a primeira manifestação da miocardite na criança. Estão CORRETOS os itens

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157617)

Enunciado: Recentemente ocorreu um óbito em seu plantão com um paciente relativamente jovem, 57 anos de idade, que apresentava intensa dor torácica e dorsal, fora pressão extremamente elevada. Assim, sua curiosidade levou a, novamente, a revisar os conceitos de hipertensão, descobrindo que o seguinte conceito estava INCORRETO. Assinale-o.

A) Crise hipertensiva, chamada de Emergência, é caracterizada por elevação aguda de PA associada à Lesão Órgão Alvo, que pode incluir acometimento neurológico, renal, ocular, hepático ou insuficiência miocárdica, manifesta como encefalopatia, convulsões, alterações visuais, achados anormais de eletrocardiograma ou ecocardiograma, insuficiência renal ou hepática.

B) A Urgência é descrita como elevação da PA superior ao percentil 99 mais 5 mmHg (estágio 2), associada a sintomas menos graves, em paciente sob risco de evolução para LOA progressiva, sem evidência de acometimento recente.

C) Na Urgência sugere-se manejo com medicamentos, por via oral, com redução de PA em 12 horas, sob monitorização.

D) A redução muito rápida de PA na Urgência é contraindicada, pois leva à hipotensão, falência de mecanismos autorreguladores e possibilidade de isquemia cerebral e visceral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157621)

Enunciado: Como seu avô é viúvo e participa ativamente de diversas atividades sociais da terceira idade, ele convidou você para ministrar uma palestra, em seu grupo de idosos, com orientações sobre a hipertensão, o que você prontamente atendeu. Sobre as suas orientações, aponte aquela que é considera a MAIS correta.

A) A prevalência da Hipertensão aumenta progressivamente com o envelhecimento, sendo considerado o principal Fator Risco Cardiovascular não modificável na população geriátrica.

B) São considerados idosos, sob o ponto de vista cronológico, indivíduos com 75 anos ou mais de idade, vivendo em países desenvolvidos, ou com 70 anos ou mais, em países em desenvolvimento.

C) Dentro desse grupo etário, são chamados de muito idosos aqueles que já alcançaram a sétima década de vida.

D) O envelhecimento vascular é o aspecto principal relacionado à elevação da PA nos idosos, caracterizado por alterações na microarquitetura da parede dos vasos, com consequente enrijecimento arterial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157626)

Enunciado: Dentro da abordagem de hipertensão na situação especial que é a do idoso, NÃO podemos concordar que:

A) Existem evidências robustas do benefício de reduzir a PA com o tratamento anti-hipertensivo em idosos com 80 anos ou mais. Essa vantagem está limitada a indivíduos com PAS = 160 mmHg, nos quais a PAS foi reduzida a valores < 150 mmHg.

B) Em indivíduos idosos com menos de 80 anos, o tratamento anti-hipertensivo pode ser considerado para aqueles com PAS > 140 mmHg, para uma meta de PAS < 140 mmHg, desde que os indivíduos apresentem uma boa condição clínica e o tratamento seja bem tolerado.

C) Os benefícios de diferentes regimes terapêuticos em pacientes com idade superior ou inferior a 65 anos confirmam que existem evidências de que diferentes classes possuam efetividades diferentes em pacientes mais jovens ou mais velhos.

D) Um aspecto que merece destaque é a possibilidade de HA secundária no idoso, cujas causas mais frequentes são estenose de artérias renal, síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS), alterações de função tireoidiana e uso de medicamentos que podem elevar a PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157712)

Enunciado: Em relação ao diagnóstico de miocardite, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Está indicada a pesquisa de sorologias virais de forma rotineira.

B) Para a avaliação histopatológica é utilizado o critério de Dallas.

C) A cintilografia com 67-Gálio apresenta sensibilidade de 50%.

D) A avaliação diagnóstica da miocardite se faz inicialmente por meio da suspeita clínica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157738)

Enunciado: Durante consulta ambulatorial de paciente cardiopata, os familiares do paciente questionaram o médico assistente a respeito do consumo de álcool dele. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a orientação INCORRETA a respeito desse questionamento.

A) Consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a PA de forma consistente.

B) Ocorre em mulheres efeito protetor com dose inferior a 40 g de álcool/dia.

C) Ocorre em mulheres risco de HA com consumo de 30-40 g de álcool/dia.

D) Em homens, o risco aumentado de HA tornou-se consistente a partir de 31 g de álcool/dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157748)

Enunciado: Durante reunião da equipe de saúde, você é convidado a opinar a respeito de uma campanha de aferição de pressão arterial, fora do ambiente médico. Assim, você fundamenta sua opinião, ADEQUADAMENTE, com o contido na seguinte opção. Assinale-a:

A) Uma das vantagens de medição da PA fora do consultório seria o maior engajamento dos pacientes com diagnóstico e seguimento.

B) Uma das desvantagens seria a de ter relação com as atividades usuais dos examinandos.

C) Maior chance de vezes de medida pela potencialização do efeito do avental branco.

D) Aumenta a chance de erro diagnóstico por menor número de medidas pelo médico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157749)

Enunciado: Quando da avaliação de Idosos Hipertensos, podemos considerar como característicos deles as seguintes alternativas, com EXCEÇÃO de uma delas. Assinale-a.

A) Ocorre uma maior frequência do hiato uscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente baixos para a PAD.

B) A grande variação da PA nos idosos ao longo das 24 horas torna a MAPA uma ferramenta muitas vezes útil.

C) A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico.

D) Presença de arritmias, como Fibrilação Atrial, pode dificultar a medição da PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157753)

Enunciado: O sucesso do tratamento da Hipertensão Arterial com medidas nutricionais depende da adoção de um plano alimentar saudável e sustentável, sendo que a proposta de utilização de dietas radicais resulta em abandono do tratamento. Podemos adequadamente orientar durante a consulta estes tópicos, com a EXCEÇÃO de um deles. Aponte-o.

A) Existem evidências de que a ingestão de laticínios, em especial os com baixo teor de gordura, reduz a PA, sendo que o leite contém vários componentes, como cálcio, potássio e peptídeos bioativos que podem diminuir a PA.

B) O café, apesar de rico em cafeína, é uma substância com efeito pressor agudo, e possui polifenóis que podem favorecer a redução da PA.

C) O consumo de café em doses habituais está associado à maior incidência de Hipertensão Arterial.

D) O aumento do consumo de sódio está relacionado ao aumento da PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157655)

Enunciado: Paciente hipertenso e diabético mal controlado, 59 anos de idade, evolui com edema em membros inferiores e dificuldade tanto de caminhada quanto de dormir. Quando inicialmente avaliado, seu RX torácico demonstra aumento de ventrículos, congestão pulmonar, e seu ECG demonstra sobrecarga esquerda. Nessa consulta inicial, você prescreve carvedilol, espironolactona, furosemida e captopril. Diante de tal caso, qual das condutas a seguir pode ser considerada INADEQUADA e por qual motivo?

A) Captopril, porque potencializa a lesão renal.

B) Furosemida, porque apresenta toxicidade aumentada associada à espironolactona.

C) Espironolactona, porque causa hipercalemia nesse caso.

D) Carvedilol, porque necessita que inicialmente o paciente esteja compensado e sem congestão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157705)

Enunciado: Idosa cardiopata mal controlada é internada com descompensação da insuficiência cardíaca, mas evolui mal, sendo então transferida para a unidade de tratamento intensivo, onde é proposto tratamento com dobutamina. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a esse caso:

A) Melhora do débito cardíaco.

B) Protetor para arritmias.

C) Vasodilatador visceral.

D) Aumenta consumo de O2 miocárdico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

157754)

Enunciado: As ditas crises hipertensivas representam grande desafio para a prática clínica da medicina de urgência, vez que se correlacionam diversos órgãos e sistemas que finalmente são lesados pela elevação descontrolada e lesiva da Pressão. Assinale a alternativa que NÃO está dentre essas lesões.

A) Edema Cerebral.

B) Sangramento Cerebral.

C) Edema de Papila de Nervo Óptico.

D) Cefaleia tipo Cluster.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134706)

Enunciado: Paciente masculino de 60 anos de idade deu entrada no hospital com quadro de dor torácica, dispneia e mal-estar progressivos há 8 horas. Seu ECG demonstrava tanto áreas de cicatriz, quanto áreas decorrentes de lesão. Pouco após sua admissão na sala de emergência, evoluiu com grande piora, agora com choque e dissociação eletromecânica, sendo, também, suspeitado de ruptura miocárdica. Aponte a afirmação que NÃO é compatível com esse quadro.

A) A ecocardiografia transtorácica pode, também, mostrar sinais: pouco líquido denso e achados clássicos de tamponamento cardíaco.

B) O ponto da ruptura, em geral, não é localizado pelo ecocardiograma.

C) São necessários grandes volumes de derrame pericárdico para o tamponamento.

D) A presença de líquido pericárdico, sem sinais de tamponamento cardíaco, não faz o diagnóstico de ruptura de parede ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134744)

Enunciado: O nitroprussiato de sódio, potente anti-hipertensivo, é frequentemente usado no dia a dia do tratamento de emergências cardiovasculares, NÃO sendo verdadeiro que:

A) Após metabolizado pelo fígado, perde a toxicidade.

B) A insuficiência renal facilita a intoxicação.

C) Atua de forma mista, em sistema arterial e venoso.

D) Com o uso, frequentemente a dose deve ser aumentada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134676)

Enunciado: Paciente com dispneia aos médios esforços, edema em membros inferiores, prostração e dificuldade de dormir. Refere ter problema no coração e utilizar medicação para "coração inchado". Qual dos aspectos abaixo seria compatível com intoxicação digitálica?

A) Paciente refere enxergar as coisas amareladas.

B) Aumento da frequência cardíaca.

C) Taquisfigmia.

D) Cialorreia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134691)

Enunciado: Paciente hipertenso mal controlado e cardiopata, com insuficiência cardíaca congestiva. Constantemente falta às consultas de ambulatório de cardiologia, procurando, a seguir, o Pronto-socorro para receber medicação "debaixo da língua". Deu entrada agora na emergência com PA 230x120mmHg, dispneico e com intensa estertoração pulmonar. A hipótese inicial é a de edema agudo hipertensivo, qual das opções abaixo apresenta efeito importante, tanto na pré-carga, quanto na pós-carga de Ventrículo Esquerdo na emergência?

A) Digitálico.

B) Nitroglicerina.

C) Nitroprussiato de sódio.

D) Furosemida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

139793)

Enunciado: Para a aferição da pressão arterial da criança, o manguito deve cobrir,

A) pelo menos, metade do comprimento do antebraço e 2/3 da sua circunferência.

B) pelo menos, 2/3 do comprimento do antebraço e 3/4 de sua circunferência.

C) no máximo, 2/3 do comprimento do antebraço e 3/4 de sua circunferência.

D) no máximo, metade do comprimento do antebraço e2/3 da sua circunferência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134778)

Enunciado: Qual patologia é característica da Tríade de Beck?

A) Tamponamento cardíaco.

B) Ruptura de aorta torácica.

C) Infarto agudo do miocárdio.

D) Pneumotórax hipertensivo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111831)

Enunciado: Dobutamina é uma importante ferramenta para o tratamento de pacientes cardiopatas, NÃO fazendo parte de suas interações o seguinte item:

A) vasodilatação.

B) cronotrópico.

C) inotrópico.

D) vasopressor.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111872)

Enunciado: A nifedipina de ação rápida apresenta algumas características que não são favoráveis ao seu uso nas complicações cardiovasculares. Podemos citar, entre elas, a:

A) falta de potência.

B) demora para ação.

C) taquicardia.

D) melhora da perfusão coronariana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111891)

Enunciado: Quando indicamos tratamento para Hipertensão Arterial Sistêmica Ambulatorial como um todo, analisamos as características individuais de cada paciente que recebe tratamento, sendo assim, indivíduo com cefaleia pode apresentar efeito profilático com qual das medicações?

A) Captopril.

B) Furosemida.

C) Propranolol.

D) Hidroclotiazida.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111906)

Enunciado: Paciente cardiopata, sequelado de Infarto que ocorreu há três anos, mostra-se rebelde ao controle nutricional, ainda ingerindo grandes quantidades de sódio na dieta. Este procura seu atendimento com grande dispneia decorrente de retenção hídrica. Qual das medicações abaixo utilizadas atua diminuindo pressão da pré-carga ventricular esquerda?

A) Nitroglicerina.

B) Furosemida.

C) Morfina.

D) Todas as alternativas anteriores atuam diminuindo pressão da pré-carga ventricular esquerda.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111838)

Enunciado: Paciente com Insuficiência Renal Crônica evoluiu com piora do quadro clínico, com edema, desorientação de descontrole da pressão arterial. Foi, então, realizada tomografia de crânio e exames sanguíneos. Qual é o achado que MELHOR caracteriza uma Encefalopatia Hipertensiva?

A) Edema Cerebral.

B) Sangramento Cerebral.

C) Uremia.

D) Acidose Metabólica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111870)

Enunciado: Paciente dá entrada no pronto-socorro queixando-se de intensa cefaleia e mal-estar de início súbito nesta manhã, quando iniciou suas atividades. Em avaliação inicial, mostrava-se lúcida, mas com fácies de dor e algo agitada. Sua pressão demonstrava valores elevados de 200 x 100 mmHg. Dessa forma, qual informação podemos considerar ADEQUADA?

A) Trata-se de emergência hipertensiva.

B) Trata-se de AVC Hemorrágico.

C) Está indicado Nitroprussiato de Sódio.

D) Inicialmente devemos medicar com analgésicos e ansiolíticos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

111901)

Enunciado: Qual das medicações abaixo listadas apresenta a necessidade de cuidados quanto à interferência de energia física, durante a sua infusão, e por isso de equipo com proteção?

A) Furosemida.

B) Emulsão Lipídeos.

C) Nitroprussiato de Sódio.

D) Glicose hipertônica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350864)

Enunciado: Paciente de 42 anos, atleta, com história recente de hipertensão de difícil controle, sem outras comorbidades. Faz uso de dois anti-hipertensivos (anlodipina e atenolol). O paciente apresentou episódio de astenia e paresia de membros inferiores tendo sido internado para investigação. Exame laboratorial evidenciou hipocalemia (1,9mmol/L), dosagem de catecolaminas urinárias normais. Qual achado de exame complementar é mais compatível com o diagnóstico?

A) Nódulo adrenal à tomografia com contraste.

B) Aneurisma de artéria renal à angiotomografia.

C) Hematúria e proteinúria no sumário de urina.

D) Nefropatia atrófica no ultrassom de vias urinárias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350877)

Enunciado: Paciente de 45 anos procura atendimento sem queixas objetivas. Relata perda de peso intencional - 15Kg ao longo dos últimos 12 meses - após mudança de estilo de vida (dieta e atividade física), motivada por diagnóstico de pré-diabetes. Persiste com o hábito de exercícios regulares (150min de atividade aeróbica semanal) além de dieta adequada. O exame físico está normal, exceto pela pressão arterial de 140x100mmHg e discreto edema de membros inferiores associado a aparente insuficiência venosa. Optou-se por uma rotina de aferições pressóricas ambulatoriais diárias (realizadas em um ambiente próximo ao seu domicílio), além de realização de exames complementares. Os resultados foram: hemograma, perfil lipídico e função renal normais. Hemoglobina glicada=5,5%, relação albumina/creatinina urinárias=450mg/g (VR < 30mg/g). A média das medidas pressóricas confirmou o valor aferido na consulta inicial. Ao ser informado da necessidade de tratamento, relata ser contrário ao uso de mais de uma droga, inicialmente. Com base nesses dados, qual dos itens abaixo representa a melhor escolha anti-hipertensiva?

A) Bloqueador de canal de cálcio.

B) Diurético tiazídico.

C) Inibidor de ECA.

D) Betabloqueador.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

350895)

Enunciado: Paciente de 60 anos, masculino, foi encaminhado da UBS para um hospital terciário para investigação de falta de ar de início há 4 meses, que piorava com esforços. Inicialmente, ainda conseguia trabalhar, porém, atualmente, não consegue tomar banho sozinho pelo cansaço. Relata que os sintomas são piores à noite, em especial, após deitar, chegando a acordar de madrugada várias vezes, além de ter buscado atendimento na UPA algumas vezes no período. Comparece à consulta em uso de enalapril, carvedilol e espironolactona. Histórico de hipertensão arterial, dislipidemia e tabagista 30 maços/ano. No momento da consulta, encontra-se acordado, consciente, conversando, eupneico em ar ambiente, PA 100x60 mmHg, FC 68 bpm, FR 18 irpm, SpO? 93% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com crepitações finas e esparsas, em ambas as bases. Abdome flácido. Edema +/4+ em membros inferiores com cacifo positivo. Trouxe ecocardiograma evidenciando fração de ejeção de 36%, com hipocinesia difusa, disfunção diastólica grave. Visando maior benefício de sobrevida nesse perfil de paciente, assinale a melhor medicação a ser associada.

A) Dapaglifozina.

B) Hidralazina.

C) Valsartana.

D) Digoxina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

321308)

Enunciado: Paciente masculino, 57 anos, diagnosticado com insuficiência cardíaca de etiologia hipertensiva há 3 anos. Portador de pré-diabetes. Evoluindo com dispneia progressiva, atualmente aos mínimos esforços, em atividades simples como escovar os dentes ou pentear os cabelos. Ex-tabagista há 15 anos. Apresenta boa aderência medicamentosa. Em uso de furosemida, losartana, carvedilol, espironolactona em doses otimizadas. Ao exame físico, apresenta-se com PA 130 x 70 mmHg; FC 65 bpm; FR 18 irpm; SpO? 98% em ar ambiente. Turgência jugular leve. Ausculta pulmonar com roncos em bases; edema de membros inferiores +/4+. Restante do exame físico sem achados. Exames complementares: Hb 12,4 g/dl (> 12 g/dl); leucócitos 6 mil (sem desvio); plaquetas 180.000 (VR 150.000?450.000); ureia 40 mg/dl (VR até 40 mg/dl); creatinina 1,2 mg/dl (VR até 1,3 mg/dl); sódio 133 mEq/L (VR 135?145 mEq/L); potássio 4 mEq/L (VR 3,5?5 mEq/L). Restante dos exames sem nada chamativo. Eletrocardiograma com sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, ritmo sinusal e sem sinais de arritmia. Ecocardiograma transtorácico, realizado há 15 dias, evidenciou fração de ejeção de 38%, às custas de hipocinesia difusa, sem sinais de lesão valvar. De acordo com o caso acima, qual a melhor conduta nesse momento?

A) Associação de ivabradina ao esquema de tratamento.

B) Suspensão de losartana e início de sacubitril/valsartana.

C) Suspensão de carvedilol e introdução de dapaglifozina.

D) Implante de CDI (cardiodesfibrilador implantável) de urgência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292809)

Enunciado: Homem, 70 anos, vem em consulta ambulatorial queixando-se de dispneia progressiva nos últimos 2 meses e, agora, em repouso. Relata também edema de membros inferiores e acorda com falta de ar durante a noite. É hipertenso e obeso. Fez um ECG, que revelou sinais de sobrecarga ventricular esquerda e um ecocardiograma, com FEVE = 65%, disfunção diastólica, pressão sistólica na artéria pulmonar de 40 mmHg e sinais de aumento de pressões no enchimento do VE (E/e' > 9). Está em uso de losartana 50 mg 2 vezes ao dia e hidroclorotiazida 25 mg cedo. Ao exame físico: PA = 150 x 90mmHg, FC = 80 bpm, crepitações pulmonares em terço inferior bilateralmente, ausência de sopros cardíacos, edema de membros inferiores de 2+/4+. LEGENDA: VE = Ventrículo Esquerdo; FEVE = Fração de Ejeção do VE. Qual é sua conduta inicial?

A) Associar betabloqueador e diurético de alça e manter o restante dos medicamentos.

B) Orientar perda de peso, associar hidralazina via oral e encaminhar ao pneumologista.

C) Introduzir antagonista da aldosterona e diurético de alça e manter os outros remédios.

D) Trocar tiazídico por diurético de alça e associar bloqueador de canal de cálcio à receita.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292811)

Enunciado: Homem de 70 anos, hipertenso de longa data, é admitido na emergência com dispneia aguda. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 220 x 120 mmHg e crepitações pulmonares bilaterais em dois terços inferiores. Considerando o diagnóstico mais provável, quais medicamentos dentre os listados abaixo, devem ser prescritos, prioritariamente.

A) Morfina e dobutamina.

B) Morfina e nitroglicerina.

C) Furosemida e dobutamina.

D) Furosemida e nitroglicerina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

292865)

Enunciado: Durante o exame físico de Edberto, você aferiu PA = 162 x 114mmHg, IMC = 38kg/m² , circunferência abdominal = 110 cm e glicemia capilar em jejum = 158 mg/dl. A ausculta cardíaca evidenciou frequência cardíaca de repouso de 120 bpm, ictus deslocado para o 6º espaço intercostal e com caráter propulsivo. Edberto ficou surpreso com o valor de sua pressão arterial, referindo que, apesar de não lembrar quando fora a última vez que teve a pressão arterial aferida, nunca havia chegado a esse nível pressórico. Ele, então, pergunta qual significado clínico desse valor. Assinale a alternativa com a conduta CORRETA.

A) Orientar que essa aferição isolada não implica diagnóstico de HAS, mas, em próximo atendimento, caso nível pressórico esteja maior que 140x90, será dado o diagnóstico de HAS.

B) Orientar que essa aferição isolada não implica diagnóstico de HAS. Solicitar diário pressórico (MRPA) para diagnóstico de HAS em próximo atendimento.

C) Diagnosticar e comunicar evento de Emergência hipertensiva e encaminhar a serviço de Urgência e Emergência para controle parenteral.

D) Informar que mesmo com somente essa aferição isolada, considerando dados clínicos, o paciente tem diagnóstico de HAS em medição única.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

259712)

Enunciado: Paciente masculino, 69 anos, em tratamento irregular para insuficiência cardíaca e hipertensão, procura a emergência com dispneia e edema de membros inferiores (MMII) que vem progredindo na última semana. Ao ser atendido, encontrava-se com frequência respiratória = 30 incursões/minuto, frequência cardíaca = 90 batimentos/minuto, pressão arterial = 190 x 110 mmHg , estava orientado, mas verbalizava com dificuldade, observava-se turgência jugular (3+/4+) a 45 graus e edema de MMII (4+/4+). Ausculta pulmonar com crepitações em 2/3 inferiores de tórax bilateralmente, ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular, em 2 tempos e sopro sistólico 3+/6+ no foco mitral. Pulsos palpáveis e simétricos. Negava dor precordial, eletrocardiograma mostrava ritmo sinusal e não apresentava sinais de isquemia. Exames laboratoriais séricos mostravam função renal normal e não evidenciavam sinais de injúria miocárdica. Saturação de oxigênio = 89% em ar ambiente. Radiografia de tórax está demonstrada abaixo. Qual a melhor conduta para o caso em questão?

A) Nitratos, diuréticos e betabloqueadores.

B) Dobutamina, diuréticos endovenosos, opioides e oxigênio.

C) Vasodilatadores, diuréticos e ventilação não invasiva com pressão positiva.

D) Ventilação não invasiva com pressão positiva, amiodarona e betabloqueadores.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234025)

Enunciado: Homem de 52 anos foi avaliado por queixa de cefaleia occipital frequente, fadiga e sonole?ncia diurna. Sedenta?rio, tambe?m referia dispneia aos esforc?os mais acentuados como correr ou subir escadas. Ao exame, apresentava IMC 32,5 kg/m², circunfere?ncia abdominal 102 cm; PA: 150 x 100 mmHg; pulso 95 bpm. Abdome: globoso por adiposidade e sem estrias. Exames bioqui?micos: glicemia 118 mg/dl; A1C: 5,5%, colesterol: 225 mg/dl; HDL: 32 mg/dl; triglicérides: 335 mg/dl; LDL: 126 mg/dl. Foi prescrito losartana e recomendado mudanc?as no estilo de vida. LEGENDA: IMC: Índice de Massa Corporal; PA: Pressa?o Arterial; bpm: Batimentos por Minuto; A1C: hemoglobina glicada. Qual conduta adicional seria a mais indicada?

A) Solicitar polissonografia para investigar apneia do sono.

B) Prescrever ácidos graxos de ômega 3 para promover elevação do HDL.

C) Indicar cirurgia bariátrica para tratar a obesidade e prevenir diabetes tipo 2.

D) Dosar microalbuminúria e proteína C-reativa para confirmar síndrome metabólica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

234027)

Enunciado: Paciente masculino, 76 anos, com histo?rico de dispneia aos esforc?os moderados, foi internado com quadro de dor tora?cica e si?ncope ao realizar esforc?o. Realizou cateterismo que demonstrou 3 pontes pe?rvias de cirurgia de revascularizac?a?o corona?ria realizada ha? 2 anos, sem leso?es significantes. E? diabe?tico mal controlado, em uso irregular de insulina 1,6 U/kg/dia e apresenta claudicac?a?o em membros inferiores, ao caminhar cerca de 150 metros. Ex-tabagista de 75 mac?os/ano, abandonou tabagismo ha? 2 anos e mante?m-se em tratamento para enfisema pulmonar moderado. Ao exame, tem IMC: 33,1 kg/m², PA: 124 x 104mmHg, Pulso regular de 96 bpm com ascensa?o lenta. Sopro sisto?lico ejetivo com pico telessito?lico mais audi?vel no 2o espac?o intercostal pro?ximo a? borda esternal direita. Creatinina se?rica de 2,3 mg/dL (VR: 0,8-1,3). Eletrocardiograma com hipertrofia ventricular esquerda e padra?o de sobrecarga. Ecocardiograma com frac?a?o de ejec?a?o de 48%, Pressa?o sisto?lica de arte?ria pulmonar estimada em 50 mmHg, a?rea valvar ao?rtica de 0,7 cm² e gradiente Ventri?culo esquerdo - Aorta de 55 mmHg. LEGENDA: VR: valor de refere?ncia; IMC: i?ndice de massa corporal; bpm: batimentos por minuto. Qual a terape?utica preferencial para o paciente nesse momento?

A) Cirurgia de troca valvar aórtica.

B) Plastia de valva aórtica com balão.

C) Implante de bioprótese aórtica transcateter.

D) Reabilitação cardiopulmonar exercícios físicos estruturados.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199784)

Enunciado: Um senhor de 74 anos, sem história de doenças prévias ou uso de medicações, fumante de cerca de 5 cigarros por dia, apresentou em consulta prévia registro de 2 aferições de PA com média de 136 x 86 mmHg. Trouxe ECG que apresenta padrão strain e evidencia derivação aVL com onda R de 13 mm e derivação V3 com onda S de 20 mm associado a componente negativo de onda P em derivação V1, de 2 mm. Ao realizar fundoscopia direta, observa-se o achado da foto abaixo. O médico insufla o cuff até 160 mmHg, deixando de perceber pulso radial entre 130 e 140 mmHg e não consegue palpar artéria radial em 160 mmHg. Após isso, faz 2 medidas de PA espaçadas com média de 136 x 82 mmHg. IMC = 29 kg/m². Restante do exame físico sem achados relevantes. LEGENDA: PA: Pressão Arterial; ECG: Eletrocardiograma; IMC: Índice de Massa Corpórea. O médico deve concluir tratar-se de qual condição?

A) Pré-hipertensão.

B) Pseudo-hipertensão.

C) Hipertensão mascarada.

D) Hiato auscultatório aumentado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

199737)

Enunciado: Paciente 45 anos, hipertenso, procura médico pneumologista com dispneia há 6 meses, atualmente aos grandes esforços. Nega tabagismo ou doenças pulmonares e cardíacas prévias. Exame físico é normal, exceto pela presença de segunda bulha hiperfonética à ausculta cardíaca e edema de membros inferiores (++/4+). Radiografia de tórax mostrava aumento de área cardíaca com parênquima normal. Foi solicitado ecocardiograma que demonstrou: aumento de câmaras direitas, Fração de ejeção = 56% (normal > 50%), com função diastólica de ventrículo esquerdo com leve redução e pressão sistólica de artéria pulmonar = 80 mmHg (normal). Qual das opções abaixo seria a medida mais adequada diante dessa situação?

A) Iniciar terapêutica com betabloqueadores, inibidores da ECA e diuréticos.

B) Solicitar sorologia para doença de chagas e coronariografia/ventriculografia.

C) Prescrever inibidores de fosfodiesterase (sildenafila, por exemplo) e anticoagulação.

D) Solicitar cateterização de artéria pulmonar e cintilografia de ventilação perfusão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

172954)

Enunciado: Homem de 55 anos se apresenta na sala de emergência por piora da dispneia. Vinha há cerca de 1 mês com dispneia de esforços, progressiva. Há 5 horas evoluiu com piora importante da dispneia que persistiu mesmo em repouso. Portador de hipertensão arterial sistêmica há 5 anos, porém sem adesão ao tratamento, e tabagista. Ao exame, observamos Pressão Arterial (PA) = 150 x 90 mmHg, Frequência Cardíaca (FC) = 90 batimentos por minuto e turgência jugular leve. Na ausculta, foi observado ritmo cardíaco irregular, terceira bulha e intensos sibilos expiratórios. Os exames de laboratório mostraram leucócitos de 13.500/mm³ (VR: 4.000?11.000/mm³), creatinina de 1,2 mg/dl (VR: 0,8?1,3 mg/dl) e pró-BNP elevado. Qual a primeira droga que deve ser administrada nesse caso, ainda na sala de emergência?

A) Amiodarona.

B) Furosemida.

C) Nitroprussiato.

D) Hidrocortisona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

150878)

Enunciado: Homem de 62 anos, com história de doença arterial coronariana, realizou revascularização miocárdica há 7 anos. Vem evoluindo ao longo dos dois últimos anos com piora da dispneia (atualmente, aos pequenos esforços), ortopneia, dispneia paroxística noturna e edema de membros inferiores. Nega queixas de dor torácica. Realizou há 2 meses coronariografia, que mostrou enxertos venosos coronários pérvios. Atualmente, em uso de AAS 100 mg/dia, sinvastatina 80 mg/dia, carvedilol 50 mg/dia e captopril 150 mg/dia. Ecocardiograma mostra hipocinesia difusa e fração de ejeção do ventrículo esquerdo = 32%. Ao exame, mostra-se com FC = 55 bpm; PA = 130 x 70 mmHg. Creatinina = 0,7 mg/dl. Qual o mecanismo de ação da medicação a ser necessariamente acrescida à prescrição, considerando o benefício na redução de mortalidade?

A) Antagonismo da aldosterona.

B) Inibição da bomba Na/K/ATPase.

C) Inibição da bomba Na/K/2Cl em alça de Henle.

D) Inibição da bomba Na/Cl em túbulo contorcido distal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126997)

Enunciado: Paciente de 53 anos, diabético, com hipertensão controlada com tiazídico, apresenta síndrome coronariana aguda sem alteração do segmento ST e com algum grau de disfunção de VE. Qual das seguintes drogas será a mais eficaz no tratamento do paciente acima?

A) Propranolol.

B) Anlodipino.

C) Captopril.

D) Nifedipino.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126941)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 55 anos, etilista, com dispneia progressiva aos esforços, procura ambulatório de clínica médica. Na ausculta cardíaca, observa-se ritmo totalmente irregular, presença de 3ª bulha e sopro sistólico (++/4) em foco mitral. ECG revela fibrilação atrial e complexos QRS de baixa voltagem em derivações periféricas. Qual dos achados abaixo se espera encontrar no ecodopplercardiograma?

A) No modo M, da valva mitral, aspecto de "pinheiro tombado".

B) No Doppler da valva mitral, a onda A maior que a onda E.

C) No Doppler da valva mitral, a onda E maior que a onda A.

D) No modo bidimensional, átrio esquerdo desproporcionalmente aumentado em relação ao ventrículo esquerdo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126947)

Enunciado: Paciente de 48 anos, motorista de ônibus, procurou unidade básica de saúde com queixas de fadiga, hipersonolência diurna relatando que a esposa se queixa do seu ronco à noite que não a deixa dormir. Ao exame físico: índice de massa corpórea de 32 kg/m2, circunferência do pescoço de 41cm, PA:145x95mmHg, Pulso:80 ppm, f:16 irpm. Auscultas cardíaca e pulmonar dentro da normalidade. Traz hemograma, glicemia e exames da função da tireoide dentro da normalidade. Qual exame deve ser solicitado para confirmação do provável diagnóstico?

A) Monitorização cardiorrespiratória de noite inteira.

B) Endoscopia nasal com manobra de Müller.

C) Polissonografia de noite inteira.

D) Polissonografia diurna (nap study).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

126993)

Enunciado: Dona Júlia, 50 anos, descobre em uma atividade preventiva realizada em seu Posto que sua pressão está alterada. Após três consultas com sua médica de família (MFC), com intervalo de 1 semana entre elas, Dona Júlia é informada que a média de seus valores de PA foi de 150 x 86 mmHg. A MFC solicita alguns exames para a paciente, que retorna em consulta subsequente com os seguintes resultados: glicemia de jejum = 88mg/dL; K+= 4 mEq/L; creatinina= 0,6 mg/dL; colesterol total = 180 mg/dL; HDL = 60 mg/dL; triglicerídeos = 145 mg/dL; sumário de urina, eletrocardiograma e fundo de olho sem alterações. A paciente nega tabagismo, etilismo, história prévia ou familiar de doença cardiovascular, tem IMC = 19,6 kg/m², peso = 55 Kg e pratica natação 4 vezes por semana. Relata à médica ter uma certa resistência a tomar medicamentos. Qual a conduta em relação à decisão de terapia medicamentosa para esse caso?

A) Iniciar terapia medicamentosa com um fármaco, uma vez que a paciente apresenta hipertensão estágio 1.

B) Iniciar terapia medicamentosa com um fármaco, uma vez que a paciente apresenta lesão em órgão-alvo.

C) Adiar por três a seis meses a decisão por terapia medicamentosa, uma vez que a paciente apresenta baixo risco cardiovascular.

D) Adiar por três a seis meses a decisão por terapia medicamentosa, uma vez que a paciente apresenta moderado risco cardiovascular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81254)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 49 anos, alcoolista, vem se queixando de dispneia a pequenos esforços. Na ausculta cardíaca, observa-se ritmo irregular por extrassístoles (1 por minuto), presença de terceira bulha e sopro sistólico (++/4) em foco mitral. Na ausculta pulmonar, ouvem-se crepitações na metade inferior do tórax. O fígado é palpável a 5 cm abaixo do rebordo costal direito e observa-se edema de MMII (++/4). O ECG mostra baixa voltagem do complexo QRS nas derivações periféricas e alteração difusa da repolarização ventricular. A radiografia do tórax mostra aumento da área cardíaca (++/4) e congestão pulmonar. Entre as drogas que podem ser prescritas para esse paciente, uma delas deverá reduzir a mortalidade em longo prazo. Essa droga é:

A) Digoxina.

B) Furosemida.

C) Carvedilol.

D) Amiodarona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81239)

Enunciado: Paciente do sexo masculino, 70 anos, hipertenso e portador de dislipidemia, vem se queixando de forte dor retroesternal com irradiação para o dorso. Pressão arterial medida de 180/120 mmHg. Observa-se assimetria de pulso braquial. O ECG é normal e a radiografia de tórax está abaixo (VER IMAGEM). Qual o exame mais indicado para confirmação diagnóstica, dentre as opções abaixo?

A) Cintilografia do miocárdio.

B) Ecocardiograma transtorácico.

C) Cateterismo cardíaco com aortografia.

D) Tomografia computadorizada do tórax.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81314)

Enunciado: Paciente de 65 anos, portador de insuficiência cardíaca congestiva, comparece ao acolhimento da unidade básica de saúde com queixa de dispneia em repouso. A última avaliação clínica ocorreu há 15 dias e o paciente não apresentava sinais e/ou sintomas. Ao exame, o médico observou crepitações bilaterais em 2/3 inferiores em ambos hemitórax e ritmo irregular, não auscultado em consultas anteriores. Diante dessa situação, qual deverá ser a conduta mais adequada para o médico da atenção primária?

A) Iniciar furosemida 40 mg/dia, enalapril 20 mg/dia e solicitar retorno em 48 horas.

B) Encaminhá-lo ao serviço de cardiologia ambulatorial para ajuste da medicação.

C) Encaminhá-lo ao serviço de cardiologia para realização de ecocardiografia.

D) Coordenar o cuidado do paciente e encaminhá-lo ao serviço de urgência.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81319)

Enunciado: Paciente de 82 anos, restrito ao leito, recebe visita domiciliar de seu médico da atenção primária. Paciente é hipertenso, portador de insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial crônica e apresenta sequela motora de acidente vascular cerebral. Estava em uso de enalapril: 20 mg/dia; carvedilol: 50 mg/dia; ácido acetilsalicílico: 100 mg/dia; hidroclorotiazida: 25 mg/dia; metildopa: 500 mg/dia e digoxina: 0,25 mg/dia. Como o médico deverá fazer o ajuste na medicação, considerando o melhor benefício para esse paciente e diminuição do risco de iatrogenias?

A) Reduzir os intervalos entre as doses dos medicamentos para diminuir a probabilidade de efeitos adversos.

B) Solicitar avaliação da função hepática desse paciente semestralmente, devido ao risco de intoxicação digitálica.

C) Reduzir a dose da digoxina para 0,125 mg e substituir diurético tiazídico, ante risco elevado de intoxicação digitálica.

D) Suspender a metildopa, visto que aumenta o número de receptores locais para medicações adrenérgicas, podendo causar hipotensão importante na associação dessas drogas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

81321)

Enunciado: João, 68 anos, vem à consulta de retorno para mostrar exames. Nega tabagismo, não pratica atividade física regularmente e não faz uso de medicamentos. Nega história familiar de doenças cardiovasculares. A pressão arterial aferida nos dois membros superiores é de 138/89 mmHg, sentado, em repouso e com a bexiga vazia. Nas duas últimas consultas, a pressão arterial estava com o mesmo valor. A estatura é 1,80 m, peso 72 Kg e perímetro braquial de 30 cm. Apresenta glicemia em jejum: 85 mg/dL, colesterol total: 150 mg/dL, HDL: 60 mg/dL, triglicerídeos: 100 mg/dL e creatinina plasmática: 1,2 mg/dL. Qual a conduta mais adequada para esse caso?

A) Tratamento não-medicamentoso associado ao tratamento medicamentoso com enalapril.

B) Tratamento não-medicamentoso associado ao tratamento medicamentoso com hidroclorotiazida.

C) Tratamento não-medicamentoso isolado por 6 meses. Se não atingir a meta, associar ao tratamento medicamentoso.

D) Tratamento não-medicamentoso isolado por 3 meses. Se não atingir a meta, associar ao tratamento medicamentoso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

65775)

Enunciado: Considere uma paciente de 30 anos, com queixa de dispneia progressiva aos esforços. Sua ausculta cardíaca revela B1 hiperfonética em foco mitral, B2 hiperfonética em foco pulmonar, estalido de abertura da valva mitral e sopro diastólico em ruflar (++/4+) em foco mitral. A radiografia do tórax mostra sinal do duplo contorno e surgimento do 4º arco na silhueta cardíaca esquerda. O ECG mostra onda P bífida em DII. O ecocardiograma mostra folhetos mitrais espessados, calcificados e com mobilidade reduzida, área valvar mitral de 0,9 cm^2 e escore de Block de 12. Qual a melhor conduta para esta paciente?

A) Tratamento clínico.

B) Comissurotomia mitral cirúrgica.

C) Troca de valva mitral por prótese metálica.

D) Dilatação da valva mitral por cateter balão.

E) Troca de valva mitral por prótese biológica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51197)

Enunciado: Paciente de 50 anos, previamente hipertenso, sem tratamento, apresentou infarto agudo do miocárdio há 30 dias. Procura atendimento com dispneia e tosse seca, que se iniciaram ainda no hospital, palpitações aos esforços, ortopneia e edema de MMII. A PA está normal. Apresenta crepitações em bases na ausculta pulmonar. O paciente está em uso de aspirina e enalapril 10 mg 2x/dia. Seu ecocardiograma apresenta fração de ejeção de VE reduzida. Qual a conduta seguinte?

A) Manter enalapril, associar furosemida e atenolol.

B) Substituir enalapril por losartana e associar furosemida.

C) Manter enalapril, associar carvedilol e diurético tiazídico.

D) Trocar enalapril por losartana, associar isossorbida e hidralazina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51246)

Enunciado: Qual a alternativa correta quanto à doença cardiovascular na hipertensão arterial sistêmica?

A) Diuréticos são eficazes no tratamento da hipertensão arterial, mas não têm eficácia na redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares.

B) A hipertensão sistólica isolada e a pressão de pulso são fatores de risco importantes para doença cardiovascular em pacientes de meia-idade e idosos.

C) Metas antropométricas a serem alcançadas são o IMC menor que 25 kg/m² e a circunferência abdominal "menor que" 108 cm para os homens e "menor que" 80 cm para as mulheres.

D) Há superioridade do bloqueador do receptor de angiotensina II em relação ao inibidor da enzima conversora da angiotensina na redução de eventos coronarianos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

51250)

Enunciado: Em um indivíduo adulto normal, sem comorbidades, com que idade e intervalo é recomendado solicitar perfil lipídico para avaliação de risco cardiovascular?

A) Desde os 20 anos e a cada 5 anos.

B) Desde os 30 anos e a cada 5 anos.

C) Desde os 30 anos e a cada 3 anos.

D) Desde os 40 anos e a cada ano.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37599)

Enunciado: Em relação aos valores de pressão arterial no consultório, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial de 24 horas (MAPA), Automedida da Pressão Arterial (AMPA) e Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) que caracterizam a normotensão ou hipertensão controla, a hipertensão, a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada, marque a opção incorreta:

A) Normotensão ou hipertensão controla: consultório <140/90; MAPA vigília = 130/85; AMPA = 130/85; MRPA = 130/85.

B) Hipertensão do avental branco: consultório = 140/90; MAPA vigília < 130/85; AMPA < 130/85; MRPA < 130/85.

C) Hipertensão: consultório = 140/90; MAPA vigília > 130/85; AMPA > 130/85; MRPA > 130/85.

D) Hipertensão mascarada: consultório = 140/90; MAPA vigília < 130/85; AMPA < 130/85; MRPA < 130/85.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37609)

Enunciado: Segundo a VI diretriz de Hipertensão Arterial, assinale a alternativa incorreta em relação aos fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica (HAS).

A) Em relação à cor, a HAS é duas vezes mais prevalente em indivíduos de cor não branca.

B) A influência do nível socioeconômico na ocorrência da HAS já está estabelecida, ela é mais frequente nos indivíduos de menor nível socioeconômico.

C) A contribuição de fatores genéticos para a gênese da HAS está bem estabelecida na população.

D) Atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo em indivíduos pré-hipertensos, bem como a mortalidade.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32528)

Enunciado: Num paciente com intoxicação aguda e grave por propranolol, qual das medicações abaixo é a mais adequada ao tratamento?

A) Atropina.

B) Glucagon.

C) Clonazepam.

D) Cloreto de cálcio.

E) Sulfato de Magnésio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37616)

Enunciado: Modificações no estilo de vida é recomendação apontada no último consenso (2010) de Hipertensão Arterial. Dentre as recomendações, qual a que tem mostrado maior impacto na redução da pressão arterial?

A) Controle de peso.

B) Restrição de sal a 5g dia (próprio dos alimentos e adicionado).

C) Moderação no consumo de álcool.

D) Ingestão de cálcio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37389)

Enunciado: Correlacione os quadros clínicos com as doenças: I. Manoel, 57 anos, etilista pesado, hipertenso e diabético, com queixa de dispneia aos esforços, dispneia paroxística noturna, ortopneia e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se ictérico (+/4), com ritmo cardíaco regular, em 3T (B3) e fígado palpável há 3 cm do RCD, edema MMII 2+/4. ECG com sobrecarga ventricular esquerda. Radiografia de tórax com cardiomegalia. II. Antônio, 71 anos, tabagista pesado, etilista e hipertenso, com queixa de dispneia aos esforços e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se com pletora facial, com ritmo cardíaco regular, em 2T, B2 hiperfonética, MV diminuído difusamente, edema MMII 2+/4. ECG com sobrecarga atrial direita. III. Francisca, 54 anos, tabagista e não etilista, com queixas de dispneia aos esforços, ortopneia e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se ictérica (++/4), com turgência jugular a 45º, com ritmo cardíaco regular, em 3T (B3) e fígado palpável há 4 cm do RCD, edema MMII 3+/4. ECG com bloqueio de ramo direito. Radiografia de tórax com cardiomegalia. IV. Raimunda, 70 anos, diabética, hipertensa, obesa, tabagista e etilista social, com queixas de dispneia aos esforços, ortopneia e edema de membros inferiores. Ao exame encontra-se com ritmo cardíaco regular, em 2T, crepitantes em bases pulmonares bilateralmente, edema MMII 2+/4. ECG com onda Q em parede anterior. 1. Miocardiopatia dilatada provavelmente de etiologia chagásica; 2. Miocardiopatia isquêmica; 3. Miocardiopatia dilatada provavelmente de etiologia alcoólica; 4. Cor pulmonale.

A) I-1; II-3; III-2; IV-4.

B) I-3; II-2; III-4; IV-1.

C) I-3; II-2; III-1; IV-4.

D) I-3; II-4; III-1; IV-2.

E) I-1; II-4; III-3; IV-2.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

30865)

Enunciado: Em qual condição clínica associada à insuficiência cardíaca congestiva está indicado o uso de digoxina no esquema terapêutico inicial?

A) Fibrilação atrial.

B) Taquicardia ventricular não sustentada.

C) Diabetes mellitus.

D) Insuficiência renal crônica.

E) Doença coronariana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

30871)

Enunciado: Paciente se apresenta no consultório com queixa de palpitações. No exame físico, você percebe um sopro diastólico mais intenso no ápice e uma primeira bulha hiperfonética. Ele traz um ECG que revela onda P entalhada com duração de 120ms em D2 e com inflexão negativa de 02 mm em V1. O eixo do QRS está em 120°. Qual das patologias abaixo é o diagnóstico mais provável?

A) Hipertireoidismo com taquicardiomiopatia.

B) Forame oval patente.

C) Insuficiência aórtica.

D) Defeito do septo ventricular.

E) Estenose mitral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

25284)

Enunciado: Uma jovem com 25 anos, auxiliar de farmácia, comparece ao ambulatório de cirurgia geral do HUWC/UFC para submeter-se a uma cirurgia plástica. No exame físico é detectado um sopro em ruflar diastólico atribuível à válvula mitral. A válvula mitral é melhor ouvida em que espaço intercostal?

A) Segundo espaço intercostal esquerdo, próximo ao esterno.

B) Quinto espaço intercostal direito, próximo ao esterno.

C) Quinto espaço intercostal esquerdo, na linha clavicular média.

D) Segundo espaço intercostal direito, próximo ao esterno.

E) terceiro espaço intercostal direito, próximo ao esterno.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29446)

Enunciado: São procedimentos da avaliação inicial de rotina para o paciente hipertenso, EXCETO:

A) análise de urina

B) ureia plasmática

C) potássio plasmático

D) acido úrico plasmático

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29450)

Enunciado: São indícios de hipertensão arterial secundária, EXCETO:

A) Início da hipertensão antes dos 30 anos ou após os 60 anos de idade.

B) Assimetria de pulsos femorais.

C) Exame de urina anormal (proteinúria ou hematúria).

D) Sintomas de apneia durante o sono.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

24340)

Enunciado: Homem de 52 anos, tabagista e alcoolista crônico, chega ao IJF com dispneia aos esforços, aumento do volume abdominal e edema MMII há 04 meses. Ao exame levemente dispneico, turgência jugular a 45º, RCI em 2T, abdome globoso com piparote positivo e fígado palpável 5 cm abaixo do rebordo costal direito. Presença de edema MMII com cacifo. Tem ECG evidenciando baixa voltagem do QRS, fibrilação atrial e inversão difusa das ondas T. A área cardíaca é normal ao RX de tórax. Qual a principal hipótese diagnóstica?

A) Cirrose hepática

B) Cor pulmonale

C) Pericardite constrictiva crônica

D) Miocardiopatia isquêmica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

24343)

Enunciado: Em relação ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS), é CORRETO afirmar:

A) Os betabloqueadores têm indicação na HAS pós-infarto agudo do miocárdio.

B) Os diureticos devem ser usados como tratamento inicial de homens sexualmente ativos.

C) HAS secundária à estenose bilateral da arteria renal deve ser tratada com antagonistas da angiotensina II.

D) Os antagonistas do cálcio são drogas preferenciais para jovens portadores de BAV do 2º grau.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27697)

Enunciado: Paciente de 66 anos, sexo masculino, portador de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão há 20 anos. Queixa-se de há seis meses apresentar intolerância aos exercícios moderados (dispneia ao caminhar três quarteirões), edema de membros inferiores durante o dia e alguns episódios de dispneia noturna. Exame físico mostrou leve taquicardia (105 bpm), pressão arterial de 110 X 70 mmHg, ausculta cardíaca com discreto sopro sistólico mitral e edema de MMII (++/4). Ecocardiograma evidenciou disfunção sistólica moderada (FE = 42%) e leve insuficiência mitral. Além do controle do diabetes e da hipertensão, como deve ser tratado farmacologicamente este paciente? (Assinale o item com melhor combinação para este estágio da doença).

A) Inibidor da ECA + Espironolactona.

B) Betabloqueador + digitálico.

C) Betabloqueador + Inibidor da ECA.

D) Espironolactona + digitálico.

E) Inibidor da ECA + digitálico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27699)

Enunciado: Assinale o item que contém a característica semiológica do sopro de estenose aórtica.

A) Crescendo com pico tardio

B) Crescendo-decrescendo

C) Ruflar grave com reforço pré-sistólico

D) Decrescendo

E) Em maquinaria

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27701)

Enunciado: Paciente de 49 anos, sexo masculino, diabético há 5 anos e em uso de metformina. Sem outras alterações relevantes. Após repetidas medições, foi constatada hipertensão arterial sistêmica com PA = 150 x 85 mmHg. Exames de sangue e urina foram normais. Dos itens abaixo, selecione o que contém a medicação mais apropriada para este caso.

A) Inibidor da ECA.

B) Antagonista de canal de cálcio.

C) Betabloqueador.

D) Diurético.

E) Antagonista do receptor da angiotensina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

25389)

Enunciado: Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, queixa-se de dispneia progressiva, atualmente a pequenos esforços. Na ausculta cardíaca, observa-se hiperfonese da 1ª bulha em foco mitral e da 2ª bulha em foco pulmonar. Qual a doença valvar que melhor corresponde a este tipo de ausculta?

A) Estenose aórtica.

B) Insuficiência aórtica

C) Estenose mitral

D) Insuficiência mitral

E) Estenose pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27710)

Enunciado: Um bebê de 5 meses do sexo masculino é trazido ao pediatra porque a mãe sente uma vibração estranha sobre o peito do filho que parece se relacionar com o seu batimento cardíaco. A criança tem síndrome de Down. No exame, um frêmito paraesternal é sentido. Atividade precordial é acentuada e se estende sobre as áreas paraesternal e apical direitas. Uma terceira bulha proeminente é audível no ápice. A característica que melhor descreve o sopro ouvido no exame é:

A) sopro sistólico em ejeção

B) sopro holossistólico

C) sopro diastólico precoce

D) sopro telediastólico tardio

E) sopro contínuo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27750)

Enunciado: Um garoto de 9 anos é visto pelo médico para seu exame anual de manutenção da saúde. Ele tem uma história de asma, que foi diagnosticada na idade de 7 anos. Atualmente, ele está passando por episódios de falta de ar e chiado a cada duas semanas. Estes episódios são rapidamente aliviados por salbutamol inalado. Seus pais negam qualquer uso prévio de corticosteroides orais e nunca foi internado por insuficiência respiratória. O exame físico é normal, exceto por uma pressão arterial de 145/95 mmHg. Duas medições seguintes, durante visitas separadas confirmam este valor. A causa mais provável para esta pressão arterial elevada é:

A) patologia cardiovascular.

B) patologia do sistema nervoso central.

C) o efeito de droga.

D) patologia endócrina.

E) patologia renal.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

25360)

Enunciado: Paciente de 55 anos é acompanhada por hipertensão arterial sistêmica (HAS) em uso de hidroclorotiazida há 5 anos. Nos últimos 6 meses, vem apresentado mau controle da pressão arterial e decide-se associar captopril após avaliação que não detectou sinais de HAS secundária. Após 1 mês de uso da combinação, paciente evolui com angioedema facial. Assinale o item abaixo que descreve a conduta adequada nesta paciente:

A) Deve-se suspender o captopril e reintroduzi-lo aos poucos após 4 a 6 semanas

B) Deve-se substituir o captopril por outra droga da mesma classe

C) Deve-se suspender permanentemente o uso de inibidores da ECA nesta paciente

D) Deve-se manter o esquema e administrar anti-histamínicos até resolução completa

E) Deve-se associar o captopril a outra droga que não a hidroclorotiazida

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13399)

Enunciado: Raimundo Pereira, paciente do ambulatório de cardiologia, tem a fração de ejeção do ventrículo igual a 25% (N>55%) e hipocinese difusa. Seu estilo de vida é sedentário. Alimenta-se regularmente com carne vermelha mais de 6 vezes por semana e bebe bebida alcoólica diariamente 4 vezes. Sua altura é 1.85cm, peso 86 kg, IMC 25kg/m2. Sua pressão é 90/60mmHg. Arteriografia coronariana normal. Qual das recomendações abaixo é a mais importante para este paciente?

A) Exercícios aeróbicos devem ser evitados.

B) Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

C)

Comer menos carne vermelha e aumentar a ingestão de carnes brancas, por ser rico em ômega 3, principalmente peixe.

D) Iniciar body pump.

E) Manter o peso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7276)

Enunciado: Quais as classes de drogas mais indicadas na terapia da disfunção assintomática do ventrículo esquerdo?

A) Betabloqueadores e inibidores da ECA.

B) Inibidores da ECA e digitálicos.

C) Diuréticos e antagonistas da aldosterona.

D) Diuréticos e inibidores da ECA.

E) Não se indica terapia medicamentosa para a disfunção ventricular assintomática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13438)

Enunciado: Paciente candidato à cirurgia eletiva, hipertenso controlado com betabloqueador e bloqueador de canal de cálcio. Qual a conduta apropriada no pré--operatório?

A) Suspender apenas o bloqueador do canal de cálcio 48 horas antes.

B) Suspender apenas o beta-bloqueador 48 horas antes.

C) Manter as medicações.

D) Suspender os dois fármacos 48 horas antes.

E) Associar diurético ao esquema em uso 48 horas antes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9125)

Enunciado: João, 18 anos, residente em Fortaleza, comparece à unidade de saúde após ?picada? de escorpião há cerca de 4 horas. Apresenta dor local. Considerando que ele tem microalbuminúria, não teve evento isquêmico coronariano e não tem insuficiência cardíaca ou renal, qual a classe de anti-hipertensivo de escolha?

A) Inibidores da enzima conversora da angiotensina/antagonista do receptor da angiotensina.

B) Beta-bloqueadores.

C) Diuréticos de alça.

D) Bloqueadores dos canais de cálcio.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9049)

Enunciado: Miguel tem 12 anos, estatura desproporcionalmente elevada, aracnodactilia e leve deslocamento do cristalino. Seu pai faleceu subitamente durante um exercício físico. Dra. Patrícia desconfiou de uma possível alteração genética no gene que codifica a fibrilina-1. Solicitou, então, um ecocardiograma que evidenciou uma dilatação da aorta ascendente com regurgitação aórtica. Em que patologia Dra. Patrícia deve ter pensado?

A) Síndrome de Marfan

B) Acondroplasia

C) Tetralogia de Fallot

D) Síndrome de Klinefelter

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9081)

Enunciado: Sr. Pedro, 82 anos, procurou seu médico de família com escoriações em mmii e hematoma em face após episódio de queda no banheiro de sua casa. Sr. Pedro vive com Dona Lourdes, 80 anos, 1 filha viúva de 56 anos e 2 netas. Veio à consulta acompanhado pela filha, ela relatou que Dona Lourdes também caíra 2 vezes no último mês. Todas as alternativas abaixo seriam contraindicações absolutas para Sr. Pedro iniciar de forma lenta e gradual um programa de atividade física, EXCETO:

A) Alteração da acuidade auditiva.

B) Angina instável.

C) Hipertensão não-controlada.

D) Bloqueio cardíaco de 3º grau.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9085)

Enunciado: Dona Glória, 62 anos, viúva, prendas do lar procurou seu médico com queixa de dispneia para caminhar no plano, edema de mmii, ?falta de ar que piora à noite, melhorando quando ela se levanta e vai para janela tomar ar?. Ao exame o médico verificou pressão arterial de 140/90 mmHg, frequência cardíaca = 105 bpm. Trouxe um RX de tórax realizado em serviço de urgência que revelava índice cardio-toráxico = 0,6 e edema pulmonar interticial. Segundo os critérios de Boston para o diagnóstico da insuficiência cardíaca, qual a classificação para Dona Glória?

A) Diagnóstico definido.

B) Diagnóstico possível.

C) Diagnóstico provável.

D) Os dados fornecidos pelo caso acima não permitem fazer a classificação diagnóstica segundo os critérios de Boston.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

9088)

Enunciado: Dona Glória, 62 anos, viúva, prendas do lar procurou seu médico com queixa de dispneia para caminhar no plano, edema de MMII, ?falta de ar que piora à noite, melhorando quando ela se levanta e vai para janela tomar ar?. Ao exame o médico verificou pressão arterial de 140/90mmHg, frequência cardíaca = 105bpm. Trouxe um RX de tórax realizado em serviço de urgência que revelava índice cardiotoráxico = 0,6 e edema pulmonar intersticial. Em relação aos exames complementares que o médico de família deverá solicitar, assinale a afirmativa INCORRETA:

A) O ECG auxilia na identificação ideológica e é um exame bastante acessível, devendo fazer parte da investigação de todos os pacientes.

B) A radiografia de tórax é empregada tanto no diagnóstico inicial como na identificação de descompensações clínicas.

C) A hiponatremia é achado frequente em insuficiência cardíaca e está associada à gravidade da doença.

D) A redução dos níveis de ureia e creatinina pode ser explicada pela ativação da enzima conversora da angiostensina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

6957)

Enunciado: Sobre a terceira bulha, é correto afirmar:

A) É um som de alta frequência.

B) É produzida nos átrios.

C) É melhor audível com o diafragma do estetoscópio.

D) É melhor audível com o paciente em decúbito lateral esquerdo.

E) Ocorre no período de enchimento ventricular lento.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

6962)

Enunciado: O cianeto (metabólito do nitroprussiato de sódio) é removido da corrente sanguínea através da sua ligação com:

A) A glutamina e o triptofano.

B) A albumina e o fosfato.

C) A meta-hemoglobina e o tiossulfato.

D) A tiroxina e o lactato.

E) A insulina e o cortisol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13443)

Enunciado: Considere a situação onde você seja um gestor de saúde e esteja planejando ações estratégicas de prevenção e promoção de saúde em sua comunidade. É necessário saber a prevalência dos principais fatores nocivos à saúde. Dentre os fatores nocivos a saúde abaixo, assinale o mais prevalente em grandes cidades do Brasil:

A) Tabagismo.

B) Sedentarismo.

C) Alcoolismo.

D) Diabetes.

E) Hipertensão.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

17809)

Enunciado: Paciente diabético tipo II, 55 anos, sexo masculino apresenta dor torácica aos médios esforços.Teste ergométrico foi sugestivo de isquemia miocárdica. Está em uso de AAS 81 mg/dia, metformina 1,7g/dia, sinvastatina 20mg/dia, hidroclorotiazida 40mg/dia e enalapril 20mg/dia. Fará cateterismo coronariano em 2 dias. Qual dos seguintes procedimentos é imprescindível?

A) Suspender AAS imediatamente

B) Suspender metformina imediatamente

C) Suspender sinvastatina imediatamente

D) Suspender anti-hipertensivos imediatamente

E) Suspender todos os medicamentos imediatamente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

17817)

Enunciado: Paciente de 55 anos, masculino, acompanhado por diabetes tipo II, procura o ambulatório de clínica médica para consulta rotineira. Não tem quaisquer queixas, seus exames laboratoriais não mostram alterações. Seus níveis glicêmicos são controlados com 1,7g de metformina por dia. Seu exame físico mostra um IMC = 23,4 kg/m² e PA = 160x90 / 155x85mmHg (2 medições com intervalo de 5 minutos). Ele refere níveis pressóricos semelhantes em aferições domiciliares. Não há outras alterações no exame físico. Com base neste caso, selecione o item que contiver a melhor opção terapêutica anti-hipertensiva.

A) Hidroclorotiazida 25mg/dia.

B) Captopril 25mg 2x/dia.

C) Captopril 25mg 2x/dia + Hidroclorotiazida 25mg/dia.

D) Captopril 25mg 2x/dia + Amlodipina 5mg/dia.

E) Amlodipina 5mg/dia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

15958)

Enunciado: Nos pacientes portadores de estenose mitral, é correto afirmar que:

A) dispneia é um sintoma de importância secundária.

B) disfagia e rouquidão não fazem parte do quadro clínico.

C) lúpus eritematoso e artrite reumatoide são as causas mais comuns.

D) o ecocardiograma é essencial na confirmação diagnóstica.

E) pacientes mesmo com fibrilação atrial dispensam o uso de anticoagulantes.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

365645)

Enunciado: Um paciente de 7 anos de idade com aumento dos valores séricos de triglicerídeos e colesterol LDL foi levado ao pronto-socorro com queixa de dor torácica tipo A e diagnosticado com infarto agudo do miocárdio extenso, apresentando choque cardiogênico e disfunção renal aguda. A correlação entre as doenças cardíaca e renal desse paciente é classificada como tipo

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

349717)

Enunciado: Um senhor de 62 anos, portador de HAS e tabagista, comparece à UBS para trazer os resultados de seus exames de rotina. Ele faz uso de losartana 50 mg BID e anlodipino 5mg MID e apresenta bom controle de pressão arterial. A seguir estão os resultados dos exames desse paciente: Hemoglobina: 14,3 mg/dl / Leucócitos: 7200/mm3 / Plaquetas: 230.000/mm3 / Potássio: 5,6 mEq/L / Sódio: 143 mEq/L / Ácido Úrico: 4,3 mg/dl / Glicose: 93 mg/dl / HbA1c - 5,4% / Creatinina: 0,8 mg/dl. Sangue oculto nas fezes (imunohistoquímica): positivo / Colesterol total: 122 / Col. HDL: 46 / Col. LDL: 68 / Relação albumina-creatinina: 3,2 mg/g. Diante desse quadro, qual é a conduta mais adequada?

A) O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a prescrição de diuréticos de alça para controle do potássio. Ele deve também ser referenciado para realização de colonoscopia para rastreio de câncer de cólon.

B) O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a prescrição de diuréticos de alça para controle do potássio. Ele deve também repetir o exame de sangue oculto nas fezes, uma vez que são necessárias 3 amostras positivas.

C) O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio - devendo ser substituída por atenolol, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da HAS. Ele deve também ser referenciado para realização de colonoscopia para rastreio de câncer de cólon.

D) O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio - devendo ser substituída por indapamida, que também é um medicamento de primeira linha para o tratamento da HAS. Ele deve também ser referenciado para realização de colonoscopia para rastreio de câncer de cólon.

E) O paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio - devendo ser substituída por indapamida, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da HAS. Ele deve também repetir o exame de sangue oculto nas fezes, uma vez que são necessárias 3 amostras positivas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322147)

Enunciado: Em relação à classificação da insuficiência cardíaca, segundo a American Heart Association (AHA), é correto afirmar que:

A) Um homem de 56 anos, com Fração de Ejeção (FE) de 36% no ecocardiograma, é considerado classe A.

B) Uma mulher caucasiana de 61 anos, com hipertensão arterial e sem alterações no ECG e/ou no ecocardiograma, é considerada classe C.

C) Uma mulher de 42 anos, portadora de miocardiopatia puerperal, com FE de 18% e quadro clinico refratário ao tratamento clínico otimizado, é considerada classe D.

D) A presença de alterações cardíacas estruturais, sem sintomas de insuficiência cardíaca, é considerada classe C.

E) A presença de dispneia aos pequenos esforços é considerada classe III.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322148)

Enunciado: Um homem de 75 anos, portador de estenose mitral grave, procura atendimento médico com queixa de dispneia e lipotimia. Sobre o exame físico desse paciente, é correto afirmar que

A) a presença de estalido de abertura precoce é frequente.

B) a hipofonese de B1 é comum.

C) sinais de insuficiência cardíaca esquerda são comuns.

D) o exame físico costuma ser normal.

E) a hipofonese de B2 é característica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322163)

Enunciado: Sobre o carvedilol, assinale a alternativa correta.

A) Sua dose máxima recomendada é 100 mg duas vezes ao dia.

B) É considerado uma medicação de primeira escolha nos casos de hipertensão arterial sistêmica.

C) Está contraindicado nos pacientes com bloqueio atrioventricular avançado.

D) Está indicado nos casos de insuficiência cardíaca descompensada, principalmente nos pacientes com perfil frio e úmido.

E) Pode ser associado ao propranolol nos pacientes portadores de fibrilação arterial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322207)

Enunciado: Dona Marli queixa-se de edema de membros inferiores após iniciar uso de medicamento para controlar sua pressão arterial e procura atendimento para realizar a troca do remédio, pois sente-se muito incomodada. O fármaco em questão deve ser

A) hidroclorotiazida.

B) losartana.

C) enalapril.

D) anlodipino.

E) atenolol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

322211)

Enunciado: Homem de 44 anos chega para consulta acompanhado da esposa, a qual reclama que ele ronca muito à noite. Ao final da avaliação, o médico explica que o diagnóstico provável é de apneia obstrutiva do sono. A orientação do profissional deve ser de que tal condição é fator de risco para

A) sinusopatia.

B) hipertensão arterial sistêmica.

C) pneumonia.

D) asma brônquica.

E) doença pulmonar obstrutiva crônica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

337594)

Enunciado: Roberto, um homem de 58 anos, é portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e hipotireoidismo. Há cerca de dois meses, ele sofreu um AVE isquêmico, apresentando diminuição de força em dimidio esquerdo, necessitando de auxílio para marcha. Desde que ocorreu o AVEi, Roberto não recuperou completamente a função cognitiva, apresentando dificuldade em compreender fala, acalculia e diminuição da memória de curto prazo. Considerando o caso descrito e seus conhecimentos, julgue o item a seguir. O tratamento adequado da hipertensão arterial com medicamentos de primeira linha (IECA, BRA, bloqueadores de canal de cálcio diidropiridínicos ou diuréticos tiazídicos) reduz o risco de eventos como um AVEi.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305289)

Enunciado: O uso da medicação sacubitril-valsartana está indicado em qual das seguintes doenças?

A) Hipertensão arterial refratária.

B) Miocardiopatia isquêmica.

C) Fibrilação atrial.

D) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida.

E) Hipertensão arterial sistêmica associada à diabetes mellitus.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

305301)

Enunciado: Uma mulher de 75 anos procura atendimento médico com queixa de falta de ar aos mínimos esforços. Possui histórico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ao exame, apresenta estertores crepitantes em bases pulmonares, Pressão Arterial (PA): 160 x 100 mmHg, perfusão distal adequada e edema de membros inferiores. Diante do exposto, assinale a alternativa CORRETA.

A) O uso de dobutamina diminui o risco de morte.

B) Apresenta perfil hemodinâmico quente e úmido.

C) Expansão volêmica com cristaloides está indicado nesse caso.

D) O uso de milrinone está indicado e impacta na sobrevida da paciente.

E) O uso de garrotes em membros, para diminuir a pós-carga, está indicado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298950)

Enunciado: Uma paciente de 65 anos de idade compareceu à consulta com queixa de polidipsia, polifagia, poliúria e perda ponderal de 5 kg nos últimos três meses. Queixa-se também de humor deprimido, anedonia e avolia. Tabagista, possui diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e depressão. Faz uso de amitriptilina 25 mg à noite, enalapril 10 mg, 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25 mg, 1 vez ao dia e salbutamol inalatório sob demanda. Ao exame físico, apresenta mancha hiperpigmentada em região de dobra cervical, aveludada à palpação. Observou-se PA = 160 mmHg x 110 mmHg em ambos os membros superiores. Foi realizada medida de HGT, com resultado de 320 mg/dL. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Pode-se associar um betabloqueador, como o propranolol, ao tratamento anti-hipertensivo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298951)

Enunciado: Uma paciente de 65 anos de idade compareceu à consulta com queixa de polidipsia, polifagia, poliúria e perda ponderal de 5 kg nos últimos três meses. Queixa-se também de humor deprimido, anedonia e avolia. Tabagista, possui diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e depressão. Faz uso de amitriptilina 25 mg à noite, enalapril 10 mg, 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25 mg, 1 vez ao dia e salbutamol inalatório sob demanda. Ao exame físico, apresenta mancha hiperpigmentada em região de dobra cervical, aveludada à palpação. Observou-se PA = 160 mmHg x 110 mmHg em ambos os membros superiores. Foi realizada medida de HGT, com resultado de 320 mg/dL. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Uma boa opção, como terceiro fármaco anti-hipertensivo, seria um bloqueador dos receptores de angiotensina ? (BRA), como a losartana, visto que diminuiria o risco cardiovascular, além de auxiliar na nefroproteção.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

298952)

Enunciado: Uma paciente de 65 anos de idade compareceu à consulta com queixa de polidipsia, polifagia, poliúria e perda ponderal de 5 kg nos últimos três meses. Queixa-se também de humor deprimido, anedonia e avolia. Tabagista, possui diagnósticos de hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e depressão. Faz uso de amitriptilina 25 mg à noite, enalapril 10 mg, 2 vezes ao dia, hidroclorotiazida 25 mg, 1 vez ao dia e salbutamol inalatório sob demanda. Ao exame físico, apresenta mancha hiperpigmentada em região de dobra cervical, aveludada à palpação. Observou-se PA = 160 mmHg x 110 mmHg em ambos os membros superiores. Foi realizada medida de HGT, com resultado de 320 mg/dL. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Fatores socioeconômicos podem acarretar risco significativo para hipertensão arterial, como, por exemplo, baixa renda familiar e menor escolaridade.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284283)

Enunciado: A hipertensão arterial atinge grande parte dos brasileiros e contribui para a morbimortalidade cardiovascular. Em 2016, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou a Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. De acordo com essa diretriz, julgue o item a seguir. Na medição de pressão arterial no consultório médico, não é mais recomendada a estimação da pressão sistólica pela palpação da artéria radial quando for utilizado o método auscultatório.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261216)

Enunciado: Um paciente de 45 anos de idade foi encaminhado para avaliação de disfagia há cerca de seis meses, com sensação de "parada da descida do alimento" no meio do tórax. O paciente relata histórico de dispneia com piora progressiva e passado de tratamento irregular para febre reumática. Ao exame, observaram-se ritmo cardíaco regular em dois tempos, com sopro diastólico audível em ápice; FC = 86 bpm; FR = 20 ipm; e SatO2 = 95%. O esofagograma atual mostra compressão extrínseca do esôfago. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Esse paciente apresenta estenose mitral com repercussão clínica.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284284)

Enunciado: A hipertensão arterial atinge grande parte dos brasileiros e contribui para a morbimortalidade cardiovascular. Em 2016, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou a Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. De acordo com essa diretriz, julgue o item a seguir. A hipotensão ortostática é definida como uma redução > 20 mmHg da pressão arterial sistólica ou 10 mmHg da pressão arterial diastólica em pacientes que estejam, há três minutos, na posição ortostática.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261217)

Enunciado: Um paciente de 45 anos de idade foi encaminhado para avaliação de disfagia há cerca de seis meses, com sensação de "parada da descida do alimento" no meio do tórax. O paciente relata histórico de dispneia com piora progressiva e passado de tratamento irregular para febre reumática. Ao exame, observaram-se ritmo cardíaco regular em dois tempos, com sopro diastólico audível em ápice; FC = 86 bpm; FR = 20 ipm; e SatO2 = 95%. O esofagograma atual mostra compressão extrínseca do esôfago. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O reparo cirúrgico da valva com próteses metálicas é preferível por reduzir o risco de hemólise e a necessidade de anticoagulação.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284285)

Enunciado: A hipertensão arterial atinge grande parte dos brasileiros e contribui para a morbimortalidade cardiovascular. Em 2016, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou a Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. De acordo com essa diretriz, julgue o item a seguir. Pacientes que apresentam pressão de 120 x 80 mmHG no consultório médico e de 150 x 100 mmHg na monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA) de 24 horas são definidos como portadores de hipertensão do avental branco.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

284286)

Enunciado: A hipertensão arterial atinge grande parte dos brasileiros e contribui para a morbimortalidade cardiovascular. Em 2016, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou a Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. De acordo com essa diretriz, julgue o item a seguir. A melhor combinação medicamentosa para pacientes com doença renal crônica em estágio IV é a de inibidores da ECA com bloqueadores do receptor de angiotensina.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261219)

Enunciado: Um paciente de 45 anos de idade foi encaminhado para avaliação de disfagia há cerca de seis meses, com sensação de "parada da descida do alimento" no meio do tórax. O paciente relata histórico de dispneia com piora progressiva e passado de tratamento irregular para febre reumática. Ao exame, observaram-se ritmo cardíaco regular em dois tempos, com sopro diastólico audível em ápice; FC = 86 bpm; FR = 20 ipm; e SatO2 = 95%. O esofagograma atual mostra compressão extrínseca do esôfago. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. A evolução da patologia descrita cursa com aumento pressórico do leito vascular pulmonar.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274364)

Enunciado: Paciente, masculino, 63 anos, obeso e sedentário, vai à consulta de avaliação de rotina pelo programa saúde da família. Durante a anamnese, o paciente se queixa de edema de membros inferiores, poliúria e crises de dor em hálux e tornozelos, com diagnóstico de artrite gotosa. Nega outras doenças ou uso de medicação contínua. Ao exame físico, apresenta-se corado, hidratado, com PA: 190/110, FC: 88, FR: 16, SO2: 98% em ar ambiente, com ausculta pulmonar sem alterações, hiperfonese de B2 em foco aórtico e edema de membros inferiores ++/4+. Referente a esse caso, qual é a conduta mais adequada?

A) Orientar sobre cuidados e hábitos de vida, diagnosticar hipertensão arterial sistêmica e iniciar diurético tiazídico.

B) Diagnosticar síndrome metabólica e iniciar hipoglicemiante biguanida.

C) Orientar sobre cuidados e hábitos de vida e solicitar monitorização ambulatorial da pressão arterial sistêmica.

D) Orientar sobre cuidados e hábitos de vida, diagnosticar hipertensão arterial sistêmica e iniciar inibidor de enzima conversora de angiotensina.

E) Orientar sobre cuidados e hábitos de vida e orientar retorno em 3 meses para reavaliação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261233)

Enunciado: Um paciente com história de dor torácica aos esforços comparece à consulta por estar mais cansado do que o normal. Refere que vem apresentando ortopneia e dispneia paroxística noturna. Foram realizados investigação laboratorial, Holter, ecocardiograma e cateterismo cardíaco. O ecocardiograma e o cateterismo estão representados a seguir. Tendo em vista esse caso clínico, as imagens apresentadas e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O ecocardiograma do paciente apresenta fração de ejeção reduzida, sendo necessária, o mais precocemente possível, a introdução de sacubitril com valsartana em relação à angioplastia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261234)

Enunciado: Um paciente com história de dor torácica aos esforços comparece à consulta por estar mais cansado do que o normal. Refere que vem apresentando ortopneia e dispneia paroxística noturna. Foram realizados investigação laboratorial, Holter, ecocardiograma e cateterismo cardíaco. O ecocardiograma e o cateterismo estão representados a seguir. Tendo em vista esse caso clínico, as imagens apresentadas e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O eletrocardiograma desse paciente pode apresentar alterações isquêmicas, como onda plus minus em derivações precordiais.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274370)

Enunciado: Paciente, 65 anos, masculino, previamente hipertenso, em uso regular da medicação, é admitido no setor de urgência com quadro de aumento pressórico de forma rápida, associado à cefaleia holocraniana, vômitos e confusão mental. Nega demais sintomas associados, como febre. Na admissão, está com PA: 210/130 mmHg, FC: 60bpm, FR: 14 ipm, SO2: 96% em ar ambiente. A respeito desse o quadro, é CORRETO afirmar que:

A) Deve-se considerar o diagnóstico de crise hipertensiva, com encefalopatia hipertensiva, e a meta é redução da PA média em 10 a 15% na primeira hora e até 25% no primeiro dia de tratamento.

B) O diagnóstico é crise de migrânea, sendo o tratamento a analgesia forte e hidratação.

C) O diagnóstico é hipertensão intracraniana e deve ser feita imediata punção de líquido cefalorraquidiano.

D) Devem ser feitos controle com medicação anti-hipertensiva via oral e solicitação de exames para análise de possível lesão de órgão-alvo.

E) Um dos diagnósticos diferenciais do quadro neurológico é hipertensão maligna e, nesse caso, deve ser feita ressonância para diferenciar etiologias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261237)

Enunciado: Um paciente de 35 anos de idade, com miocardiopatia isquêmica dilatada com fração de ejeção prévia de 30%, encaminha-se à emergência com dor torácica em aperto há sete horas, dispneia importante e sudorese. Foram solicitados exames laboratoriais que demonstram hemograma normal, função renal e eletrólitos normais. Seu peptídeo natriurético cerebral (BNP) era de 300 pg/mL (valor de referência até 150 pg/dL). Solicitou-se, então o eletrocardiograma representado na figura a seguir. Considerando esse caso clínico, a figura apresentada e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Miocardiopatia isquêmica dilatada é a forma mais rara das miocardiopatias dilatadas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

274392)

Enunciado: A miocardiopatia hipertrófica é a doença genética cardiovascular mais comum. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o tema.

A) É de grande importância por ser uma das principais causas de morte súbita nos jovens e, como o exercício físico é um dos principais desencadeantes da morte súbita, há contraindicação absoluta para participação em atividades esportivas competitivas.

B) Muitos indivíduos que carregam o defeito genético só vão expressar clinicamente a doença em idade mais avançada. Durante a aceleração do crescimento corporal na adolescência, ocorre um remodelamento do ventrículo esquerdo com aparecimento da hipertrofia, sendo que, em geral, o pico da expressão morfológica da doença instala-se entre 17 e 21 anos de idade.

C) A ecocardiografia detecta a hipertrofia ventricular esquerda na ausência de doenças sistêmicas ou de outras anomalias cardíacas. O eletrocardiograma é anormal na maioria dos pacientes, com padrão variável, mostrando fraca correlação com a intensidade da hipertrofia vista ao ecocardiograma.

D) Fortes fatores de risco para morte súbita incluem: história de parada cardíaca ou de taquicardia ventricular sustentada, história familiar de morte súbita, síncope, principalmente quando recorrente ou relacionada com exercício, hipotensão arterial em resposta ao exercício.

E) Para prevenção de morte súbita, o tratamento que tem se mostrado mais eficaz é o uso contínuo de antiarrítmicos. A ablação com álcool é uma alternativa boa para os pacientes pediátricos que não toleram a medicação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261305)

Enunciado: Determinado paciente de 58 anos de idade, tabagista, com histórico de IAM há cinco anos e DM2, em uso de metformina, comparece à consulta com os seguintes exames laboratoriais: glicemia = 136 mg/dl; colesterol HDL = 32 mg/dl; colesterol LDL = 192,3 mg/dl; e creatinina sérica = 1,32 mg/dl. Apresenta medida de PA = 165 mmHg x 102 mmHg. FC = 80 bpm, SatO2 = 92% com níveis tensionais confirmados em duas consultas com mais de quatro semanas entre elas.

Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir.

Trata-se de um caso de HAS estágio 2.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261306)

Enunciado: Determinado paciente de 58 anos de idade, tabagista, com histórico de IAM há cinco anos e DM2, em uso de metformina, comparece à consulta com os seguintes exames laboratoriais: glicemia = 136 mg/dl; colesterol HDL = 32 mg/dl; colesterol LDL = 192,3 mg/dl; e creatinina sérica = 1,32 mg/dl. Apresenta medida de PA = 165 mmHg x 102 mmHg. FC = 80 bpm, SatO2 = 92% com níveis tensionais confirmados em duas consultas com mais de quatro semanas entre elas.

Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. O tratamento indicado é a realização de medidas não farmacológicas (mudanças no estilo de vida) e reavaliação em três meses.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261308)

Enunciado: Determinado paciente de 58 anos de idade, tabagista, com histórico de IAM há cinco anos e DM2, em uso de metformina, comparece à consulta com os seguintes exames laboratoriais: glicemia = 136 mg/dL; colesterol HDL = 32 mg/dL; colesterol LDL = 192,3 mg/dL; e creatinina sérica = 1,32 mg/dL. Apresenta medida de PA = 165 mmHg x 102 mmHg. FC = 80 bpm, SatO2 = 92% com níveis tensionais confirmados em duas consultas com mais de quatro semanas entre elas. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Tendo em vista o histórico de IAM prévio e as demais comorbidades, além do controle pressórico, também é recomendado o controle dos fatores de risco, tais como controle glicêmico, cessar tabagismo, uso de AAS e estatinas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

261309)

Enunciado: Determinado paciente de 58 anos de idade, tabagista, com histórico de IAM há cinco anos e DM2, em uso de metformina, comparece à consulta com os seguintes exames laboratoriais: glicemia = 136 mg/dL; colesterol HDL = 32 mg/dL; colesterol LDL = 192,3 mg/dL; e creatinina sérica = 1,32 mg/dL. Apresenta medida de PA = 165 mmHg x 102 mmHg. FC = 80 bpm, SatO2 = 92% com níveis tensionais confirmados em duas consultas com mais de quatro semanas entre elas. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Entre as drogas de primeira linha para tratamento da hipertensão, encontram-se os diuréticos tiazídicos, IECA, betabloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

255786)

Enunciado: No que se refere aos conhecimentos relacionados a bioética, saúde mental, endocrinologia, dermatologia e cardiologia, julgue o item a seguir. Os digitálicos são medicamentos que reduzem a mortalidade por insuficiência cardíaca congestiva.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214484)

Enunciado: Um paciente de 58 anos de idade, negro, chega à emergência levado pela esposa por estar sonolento, queixando-se de cefaleia de forte intensidade, fadiga e episódios de náuseas seguidos de vômito de forte intensidade. A esposa relata que os sintomas se iniciaram no dia e vêm apresentando piora progressiva. Nega queixas de dor torácica e (ou) precordial, e também nega queixas álgicas abdominais. O paciente refere quadro prévio de hipertensão arterial e está em uso de anti-hipertensivos. A esposa relata que ele se queixa de episódios frequentes de cefaleia no último ano e que tem estado "muito estranho" nos últimos três meses, apresentando ações inconsequentes até nas pequenas decisões diárias. Ao exame, apresenta-se em estado geral regular, acordado e conversando, porém com aspecto sonolento, ventilando espontaneamente em ar ambiente. Apresenta ausculta cardíaca e pulmonar sem particularidades. Sinais vitais: FC = 58 bpm; FR = 22 irpm; PA = 190 mmHg x 125 mmHg; SatO? = 97%; e temperatura axilar (Tax) = 38,6 °C. Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Dado o quadro de crise hipertensiva, deve-se investigar a função renal, pois o paciente apresenta risco aumentado para nefroesclerose maligna em relação à média da população.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214520)

Enunciado: A paciente W. B. R., 52 anos de idade, faz acompanhamento no posto de saúde da respectiva comunidade em razão do diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ela levou à consulta o ECG apresentado. (Velocidade do papel = 25 mm/s; 1 cm = 1mv). Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. Nesse traçado eletrocardiográfico, observa-se a presença de bloqueio de ramo direito associado a bloqueio posteroinferior do ramo esquerdo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214505)

Enunciado: A paciente W. B. R., 52 anos de idade, faz acompanhamento no posto de saúde da respectiva comunidade em razão do diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ela levou à consulta o ECG apresentado. (Velocidade do papel = 25 mm/s; 1 cm = 1mv). Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. A pericardite constritiva deve ser considerada, em razão das alterações eletrocardiográficas.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214509)

Enunciado: A paciente W. B. R., 52 anos de idade, faz acompanhamento no posto de saúde da respectiva comunidade em razão do diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ela levou à consulta o ECG apresentado. (Velocidade do papel = 25 mm/s; 1 cm = 1mv). Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. O tratamento com corticoides, hidroxiureia e interferon está indicado.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

179174)

Enunciado: Com relação à abordagem terapêutica da hipertensão arterial em paciente com síndrome metabólica, é correto afirmar que

A) o controle da pressão arterial com apenas uma droga ocorra em cerca de 2/3 dos pacientes hipertensos.

B) seu objetivo seja a redução da pressão arterial para valores abaixo de 140 mmHg/ 90 mmHg, considerando-se o elevado risco cardiovascular associado.

C) a presença de nefropatia com proteinúria importante implique em redução da pressão arterial para valores abaixo de 130 mmHg/85 mmHg.

D) a pressão arterial deva ser reduzida para valores abaixo de 140 mmHg/ 90 mmHg em associação com diabetes tipo 2.

E) a associação de drogas seja indicada desde o início do tratamento anti-hipertensivo quando a pressão arterial for "maior ou igual"160 mmHg/ 100 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177611)

Enunciado: M.C.L., sexo feminino, de 76 anos de idade, é paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (40%), atualmente com classe funcional NYHA II. Como comorbidades, apresenta HAS, DM e fibrilação atrial fixa. Considerando o quadro dessa paciente e sua patologia, julgue o item a seguir. Níveis elevados de BNP poderiam embasar a prescrição de espironolactona para essa paciente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177615)

Enunciado: M.C.L., sexo feminino, de 76 anos de idade, é paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (40%), atualmente com classe funcional NYHA II. Como comorbidades, apresenta HAS, DM e fibrilação atrial fixa. Considerando o quadro dessa paciente e sua patologia, julgue o item a seguir. Com o objetivo de melhora da sobrevida, indica-se a prescrição de IECA, beta-bloqueadores e digitálicos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177552)

Enunciado: M.C.L., sexo feminino, de 76 anos de idade, é paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (40%), atualmente com classe funcional NYHA II. Como comorbidades, apresenta HAS, DM e fibrilação atrial fixa. Considerando o quadro dessa paciente e sua patologia, julgue o item a seguir. A prescrição de diuréticos de alça e o controle das doses utilizadas têm base em parâmetros clínicos de sobrecarga de volume.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177640)

Enunciado: No contexto da Atenção Primária à Saúde, eventualmente, encontram-se prontuários que relatam todo o curso de vida de certo paciente, desde o período gestacional até a idade adulta, incluindo-se o período reprodutivo. Suponha que o M.S.F., atualmente com 28 anos de idade, foi acompanhada, no posto de saúde, durante toda a sua vida, desde a própria gestação da qual foi fruto. Ao longo de sua vida, várias estratégias de prevenção e programas de rastreamento foram efetuados e, eventualmente, continuarão sendo utilizados ao longo de seu envelhecimento. A paciente é sexualmente ativa, solteira, negra, com dois filhos (2 e 4 anos de idade), secretária, não tabagista, não etilista, fisicamente ativa, com IMC = 22,5 e PA = 125 mmHg x 70 mmHg na última consulta. A respeito dessas estratégias e desses programas e considerando as recomendações dos Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, julgue o item a seguir. A medida da pressão arterial é indicada para a faixa etária da paciente, devendo-se realizar essa medida anualmente.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154361)

Enunciado: L. A. P., 42 anos de idade, bancário, comparece ao ambulatório de clínica médica para avaliação. Ele relata ao médico residente que passa por quadro de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna e rouquidão há três anos, com piora recente, inclusive com um episódio hemoptoico. Aponta ainda que apresentou dois episódios de síncope no trabalho, após intensa angústia, sudorese fria e tremores em extremidades superiores. Clinicamente, apresenta discreto edema em membros inferiores. O exame do aparelho respiratório encontra-se dentro dos parâmetros de normalidade. O aparelho cardiovascular apresenta ritmo irregular, percebendo-se ruflar diastólico após estalido de abertura e BI e PI hiperfonéticas. Com base nesse caso e nos exames complementares, assinale a alternativa que indica o quadro da paciente.

A) Estenose aórtica; eletrocardiograma esboça aumento atrial esquerdo e hipertrofia ventricular esquerda; ecocardiograma com hipertrofia ventricular esquerda concêntrica, separação reduzida das cúspides da valva aórtica e Doppler mostrando gradiente acentuado nos casos graves.

B) Insuficiência mitral; eletrocardiograma esboça aumento atrial esquerdo e hipertrofia ventricular esquerda; ecocardiograma com aumento de ventrículo esquerdo, hipertrofia ventricular esquerda e Doppler com grande jato regurgitante.

C) Estenose mitral; eletrocardiograma esboça aumento atrial esquerdo e hipertrofia ventricular direita; ecocardiograma com movimento restrito dos folhetos de valva mitral e Doppler tricúspide pode revelar hipertensão pulmonar.

D) Insuficiência aórtica; eletrocardiograma esboça aumento atrial esquerdo e hipertrofia ventricular esquerda; ecocardiograma mostra, para os casos crônicos, grande aumento de ventrículo esquerdo e, para os agudos, ventrículo esquerdo pequeno e pré-fechamento de válvula mitral.

E) Insuficiência pulmonar; eletrocardiograma esboça aumento atrial direito e hipertrofia ventricular direita; ecocardiograma mostra, para os casos crônicos, grande aumento de ventrículo direito e, para os agudos, ventrículo direito pequeno e pré-fechamento de válvula tricúspide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

152147)

Enunciado: Paciente, 40 anos de idade, foi ao pronto-socorro por anasarca, espuma na urina e hipertensão (160 x 100 mmHg). Apresenta exames de função renal sérica normais. Fez exame de urina que demonstrou proteína +++. Realizou proteinúria de 24 horas, que demonstrou 5 g de proteínas. Considerando essa situação, julgue o item a seguir. Casos dessa síndrome geralmente cursam com perda de função renal.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

131810)

Enunciado: Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, com relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e seus fatores de risco, assinale a alternativa CORRETA:

A) Inexiste relação entre a pressão arterial e a idade do indivíduo.

B) A prevalência global de HAS é mais elevada nas mulheres até os 50 anos de idade.

C) Embora a população brasileira apresente uma dieta rica em sódio, carboidratos e gorduras, a elevação da pressão arterial não se relaciona com o consumo elevado de sódio.

D) A ingesta de bebidas alcoólicas por um período de tempo prolongado pode aumentar os níveis de pressão arterial.

E) A atividade física reduz a incidência de HAS apenas em indivíduos previamente hígidos, não apresentando o mesmo efeito em indivíduos pré-hipertensos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135122)

Enunciado: Uma paciente de cinquenta e cinco anos de idade foi internada em uma enfermaria de clínica médica por apresentar, havia três meses, dispneia associada a tosse seca toda noite. Esse quadro tende a melhorar vinte minutos após a paciente assumir posição ortostática. A paciente não apresenta hemoptise, dor torácica, cianose, febre, sudorese ou calafrios e não há antecedentes mórbidos na história patológica pregressa. O exame físico mostrou PA de 180 x 100 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm e saturação de oxigênio, ao ar ambiente, de 89%. Foi identificado sopro sistólico em foco mitral com a presença de B3, diminuição do murmúrio vesicular e sibilos em ambas as regiões infraescapulares. As extremidades da paciente não apresentam edema. Identificou-se, na radiografia de tórax, derrame pleural bilateral e aumento da cavidade cardíaca. Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. Essa paciente deve ser submetida a toracocentese para se investigar a ocorrência de síndrome de derrame pleural.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135127)

Enunciado: Uma paciente de cinquenta e cinco anos de idade foi internada em uma enfermaria de clínica médica por apresentar, havia três meses, dispneia associada a tosse seca toda noite. Esse quadro tende a melhorar vinte minutos após a paciente assumir posição ortostática. A paciente não apresenta hemoptise, dor torácica, cianose, febre, sudorese ou calafrios e não há antecedentes mórbidos na história patológica pregressa. O exame físico mostrou PA de 180 x 100 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm e saturação de oxigênio, ao ar ambiente, de 89%. Foi identificado sopro sistólico em foco mitral com a presença de B3, diminuição do murmúrio vesicular e sibilos em ambas as regiões infraescapulares. As extremidades da paciente não apresentam edema. Identificou-se, na radiografia de tórax, derrame pleural bilateral e aumento da cavidade cardíaca. Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. A história clínica dessa paciente indica que ela apresenta dispneia paroxística noturna.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135132)

Enunciado: Uma paciente de cinquenta e cinco anos de idade foi internada em uma enfermaria de clínica médica por apresentar, havia três meses, dispneia associada a tosse seca toda noite. Esse quadro tende a melhorar vinte minutos após a paciente assumir posição ortostática. A paciente não apresenta hemoptise, dor torácica, cianose, febre, sudorese ou calafrios e não há antecedentes mórbidos na história patológica pregressa. O exame físico mostrou PA de 180 x 100 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm e saturação de oxigênio, ao ar ambiente, de 89%. Foi identificado sopro sistólico em foco mitral com a presença de B3, diminuição do murmúrio vesicular e sibilos em ambas as regiões infraescapulares. As extremidades da paciente não apresentam edema. Identificou-se, na radiografia de tórax, derrame pleural bilateral e aumento da cavidade cardíaca. Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. A ausculta cardíaca da paciente não caracteriza presença de ritmo de galope em três tempos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135119)

Enunciado: Uma paciente de cinquenta e cinco anos de idade foi internada em uma enfermaria de clínica médica por apresentar, havia três meses, dispneia associada a tosse seca toda noite. Esse quadro tende a melhorar vinte minutos após a paciente assumir posição ortostática. A paciente não apresenta hemoptise, dor torácica, cianose, febre, sudorese ou calafrios e não há antecedentes mórbidos na história patológica pregressa. O exame físico mostrou PA de 180 x 100 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm e saturação de oxigênio, ao ar ambiente, de 89%. Foi identificado sopro sistólico em foco mitral com a presença de B3, diminuição do murmúrio vesicular e sibilos em ambas as regiões infraescapulares. As extremidades da paciente não apresentam edema. Identificou-se, na radiografia de tórax, derrame pleural bilateral e aumento da cavidade cardíaca. Com relação a esse caso clínico, julgue o item a seguir. O nível de 89% para saturação de oxigênio ao ar ambiente indica que a PaO2 da paciente apresenta menos de 60 mmHg, bem como quadro de insuficiência respiratória.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135078)

Enunciado: Com relação aos tratamentos de doenças cardiovasculares, julgue o item seguinte.

Pacientes diabéticos cuja pressão arterial seja de 140 x 90 mmHg no momento do diagnóstico ou durante o seguimento, deve ser tratados com medicamentos associados a modificações no estilo de vida, como hábitos alimentares e exercícios fisicos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135095)

Enunciado: Com relação aos tratamentos de doenças cardiovasculares, julgue o item seguinte. Os diuréticos tiazídicos são a primeira das escolhas de tratamento contra a hipertensão arterial, e apresentam como efeitos adversos hipocalemia e hipouricemia.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

135109)

Enunciado: Com relação aos tratamentos de doenças cardiovasculares, julgue o item seguinte. O peso do paciente é um fator a ser considerado para definir se existe, ou não, a necessidade de ele realizar tratamento contra doenças cardiovasculares, e uma das medidas físicas utilizadas para avaliar a coerência desse procedimento é a circunferência da cintura. Considera-se, então, que medidas das circunferências abdominais acima de 88 cm em mulheres e acima de 100 cm em homens implicam indicação para o tratamento.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108126)

Enunciado: A hipertensão arterial, que se associa a alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos, é uma doença de causa multifatorial que acomete cerca de 15% a 20% da população brasileira adulta. Acerca dessa patologia, julgue o item subsecutivo. O exame de fundo de olho permite identificar lesões no sistema vascular de pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108127)

Enunciado: A hipertensão arterial, que se associa a alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos, é uma doença de causa multifatorial que acomete cerca de 15% a 20% da população brasileira adulta. Acerca dessa patologia, julgue o item subsecutivo. A maioria dos pacientes portadores de hipertensão arterial apresenta hipotrofia do ventrículo esquerdo.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

105537)

Enunciado: De acordo com o último relatório do Joint National Committee, o oitavo, (JNC VIII) publicado no início deste ano (2014), a recomendação para adultos maiores de sessenta anos de idade é que se introduza terapêutica anti-hipertensiva para valores de pressão, em mmHg:

A) > 120 x 80.

B) > 135 x 85.

C) > 139 x 85.

D) "Maior ou igual a" 140 x 90.

E) "Maior ou igual a" 150 x 90.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

108216)

Enunciado: Um paciente de setenta e dois anos de idade, com antecedente de hipertensão arterial há vários anos, compareceu ao ambulatório relatando dispneia decorrente de esforços maiores que os habituais, como subir escadas ou andar apressadamente. O paciente relatou, ainda, o uso irregular de um anti-hipertensivo prescrito (clortalidona). No exame físico, o idoso apresentou-se normocorado, com extremidades quentes, frequência cardíaca de 108 bpm, pressão arterial de 154 mmHg x 72 mmHg, turgência jugular a 30°, ausculta pulmonar normal, ictus cordis propulsivo no 6º espaço intercostal esquerdo da linha axilar anterior, ritmo cardíaco em galope (terceira bulha) e sem sopros. Adicionalmente, notou-se refluxo hepatojugular e edema perimaleolar bilateral. Os exames laboratoriais revelaram sódio de 144 mEq/L; potássio de 5,4 mEq/L; creatinina de 3,2 mg/dl; hemoglobina de 10,4 g/dL; e hematócrito de 31%. Os demais exames bioquímicos e a função tireoidiana estavam normais. O ecocardiograma revelou fração de ejeção de 36%. Com referência ao caso clínico acima apresentado, julgue o item que se segue. O captopril e a espironolactona devem ser acrescentados à terapêutica inicial visando melhora da qualidade de vida e aumento na sobrevida desse paciente.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88710)

Enunciado: Acerca de doenças crônicas, julgue o item subsequente. Pacientes com hipertensão arterial maligna apresentam frequentemente insuficiência renal progressiva e retinopatia com exsudatos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82113)

Enunciado: Uma paciente de vinte e cinco anos de idade procurou atendimento no ambulatório de clínica médica com relato de dispneia aos esforços, que evoluiu nas últimas quatro semanas para ortopneia e episódios de dispneia paroxística noturna. Informou também, nesses últimos dias, a presença de edema de membros inferiores, mais acentuado no período vespertino. O exame físico mostrou: pressão arterial de 115 mmHg x 70 mmHg, frequência cardíaca de 80 bpm, precórdio calmo, ritmo cardíaco regular em dois tempos, primeira bulha hiperfonética em foco mitral e segunda bulha hiperfonética em foco pulmonar, presença de estalido de abertura de sopro diastólico suave (grau 2 de Levine) e de reforço pré-sistólico mais bem audíveis em foco mitral e presença de sopro sistólico (grau 2 de Levine) mais bem audível em foco tricúspide, sem irradiação e intensificado com a manobra de Rivero-Carvallo. Havia discretos estertores inspiratórios em terços inferiores de ambos hemitórax. Abdome livre e sem visceromegalias. Edema de membros inferiores, com sinal de Godet positivo, +1/+4. O eletrocardiograma mostrou ritmo sinusal, eixo elétrico médio do QRS (SÂQRS) discretamente desviado para a direita e sinais de sobrecarga atrial esquerda. A radiografia de tórax mostrou área cardíaca normal, sinais de dilatação do átrio esquerdo, de congestão venocapilar pulmonar e de ingurgitamento venoso crônico. Com base nessas informações clínicas e nos exames complementares apresentados, julgue o item seguinte.

O principal diagnóstico para o paciente em questão é o de valvopatia mitral do tipo dupla lesão, com predomínio de regurgitação mitral.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82072)

Enunciado: Uma paciente de vinte e cinco anos de idade procurou atendimento no ambulatório de clínica médica com relato de dispneia aos esforços, que evoluiu nas últimas quatro semanas para ortopneia e episódios de dispneia paroxística noturna. Informou também, nesses últimos dias, a presença de edema de membros inferiores, mais acentuado no período vespertino. O exame físico mostrou: pressão arterial de 115 mmHg x 70 mmHg, frequência cardíaca de 80 bpm, pré-córdio calmo, ritmo cardíaco regular em dois tempos, primeira bulha hiperfonética em foco mitral e segunda bulha hiperfonética em foco pulmonar, presença de estalido de abertura, de sopro diastólico suave (grau 2 de Levine) e de reforço pré-sistólico mais bem audíveis em foco mitral e presença de sopro sistólico (grau 2 Levine) mais bem audível em foco tricúspide, sem irradiações e intensificado com a manobra de Rivero-Carvallo. Havia discretos estertores inspiratórios em terços inferiores de ambos hemitórax. Abdome livre e sem visceromegalias. Edema de membros inferiores, com sinal de Godet positivo, +1/+4. O eletrocardiograma mostrou ritmo sinusal, eixo elétrico médio do QRS (SÂQRS) discretamente desviado para a direita e sinais de sobrecarga atrial esquerda. A radiografia de tórax mostrou área cardíaca normal, sinais de dilatação do átrio esquerdo, de congestão venocapilar pulmonar e de ingurgitamento venoso crônico. Com base nessas informações clínicas e nos exames complementares apresentados, julgue o item seguinte.

O achado estetoacústico descrito no foco tricúspide, bem como sua modificação com a manobra semiológica de Rivero-Carvallo, são indícios da presença de insuficiência tricúspide.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88705)

Enunciado: Um paciente de cinquenta e um anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito, foi ao ambulatório com queixa de sonolência diurna excessiva e roncos noturnos, relatando ainda uso diário de clortalidona 50 mg. No exame físico, foram observados IMC = 31 kg/m², pressão arterial de 144 mmHg x 92 mmHg (média de três medidas), frequência cardíaca de 78 bpm e circunferência abdominal de 105 cm. Os resultados dos exames laboratoriais apresentaram triglicerídeos de 296 mg/dL, colesterol total de 264 mg/dL, HDL colesterol de 34 mg/dL, LDL colesterol de 160 mg/dL, hemoglobina glicada (A1C) de 7,4% e glicemia de jejum de 138 mg/dL. A dosagem de microalbuminúria em amostra isolada de urina revelou 108 µg/mg de creatinina. O eletrocardiograma e os demais exames laboratoriais solicitados foram normais. Considerando esse caso clínico, julgue o item a seguir. Outros estudos diagnósticos complementares são desnecessários para a investigação de causas secundárias de hipertensão arterial.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88701)

Enunciado: Um paciente de cinquenta e um anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito, foi ao ambulatório com queixa de sonolência diurna excessiva e roncos noturnos, relatando ainda uso diário de clortalidona 50 mg. No exame físico, foram observados IMC = 31 kg/m², pressão arterial de 144 mmHg x 92 mmHg (média de três medidas), frequência cardíaca de 78 bpm e circunferência abdominal de 105 cm. Os resultados dos exames laboratoriais apresentaram triglicerídeos de 296 mg/dL, colesterol total de 264 mg/dL, HDL colesterol de 34 mg/dL, LDL colesterol de 160 mg/dL, hemoglobina glicada (A1C) de 7,4% e glicemia de jejum de 138 mg/dL. A dosagem de microalbuminúria em amostra isolada de urina revelou 108 µg/mg de creatinina. O eletrocardiograma e os demais exames laboratoriais solicitados foram normais. Considerando esse caso clínico, julgue o item a seguir. Considerados o melhor controle metabólico e a redução de futuros eventos cardiovasculares, a melhor opção para o controle pressórico é a adição de atenolol ao esquema terapêutico.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

82121)

Enunciado: Acerca das doenças dos cuidados de saúde em pessoas idosas, julgue o item a seguir:

Durante a medida da pressão arterial em idosos, pode ocorrer maior frequência de hiato auscultatório, subestimando a verdadeira pressão sistólica ou superestimando a pressão diastólica, e a pseudo-hipertensão, que pode ser detectada por meio da manobra de Osler.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88646)

Enunciado: Acerca de doenças cardiovasculares e hipertensão, julgue o item a seguir. Para pacientes hipertensos que apresentam pressão arterial controlada, a prescrição de ácido acetilsalicílico em baixas doses diminuem a ocorrência de complicações cardiovasculares, desde que o uso deste medicamento não seja contraindicado ao paciente e gere mais benefícios que eventuais riscos a sua saúde.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

88651)

Enunciado: Acerca de doenças cardiovasculares e hipertensão, julgue o item a seguir. O uso de vasodilatadores arteriais diretos, como hidralazina e minoxidil é indicado como monoterapia a pacientes hipertensos.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64687)

Enunciado: Paciente portador de insuficiência cardíaca classe funcional IV da NYHA realizará um tratamento farmacológico que deverá incluir:

A) IECA + diurético de alça + espironolactona, apenas.

B) digital + bloqueador de canais de cálcio + espironolactona.

C) IECA + betabloqueador + espironolactona.

D) IECA + digital + diurético de alça.

E) IECA + betabloqueador + diurético de alça + espironolactona.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64307)

Enunciado: Uma paciente de vinte e quatro anos de idade, procurou atendimento médico ambulatorial, relatando, havia três meses, dispneia aos esforços, e recentemente, falta de ar durante o período noturno, necessitando ficar sentada na cama para conseguir conciliar o sono. Informou, ainda, desconforto no hipocôndrio direito e empachamento pós-prandial, presentes nas duas últimas semanas, além de edema de membros inferiores, mais acentuado no final do período vespertino. No exame clínico, a paciente apresentou-se consciente, com dispneia, principalmente ao assumir o decúbito dorsal, afebril, acianótica, com pressão arterial de 114 mmHg x 74 mmHg (no membro superior direito, sentada) e frequência cardíaca de 90 bpm. O exame cardiovascular evidenciou precórdio calmo, ictus cordis visível e palpável no 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemi clavicular esquerda, normoimpulsivo e impulsão sistólica discreta na região para esternal esquerda baixa. À ausculta, percebeu-se ritmo cardíaco regular duplo, hiperfonese da segunda bulha em área pulmonar, primeira bulha hiperfonética em áreas de ponta, presença de estalido de abertura da mitral, sopro diastólico (grau II de Levine) proto meso diastólico com reforço pré-sistólico mais bem audível em área mitral. A paciente apresentou, ainda, pulsos periféricos palpáveis e simétricos, presença de leve turgência jugular a direita (com cabeceira do leito a 30°) e refluxo hepato jugular. O exame respiratório não mostrou anormalidades. O exame do abdome mostrou dor à palpação do hipocôndrio direito, com fígado palpável a 2 cm abaixo da borda costal direita, liso, borda romba. Havia presença de edema nos membros inferiores, com sinal de Godet. O eletrocardiograma convencional mostrou ritmo sinusal, frequência ventricular média de 92 spm, SÂQRS igual a +120°, sobrecarga atrial esquerda, sem outras anormalidades. Acerca do quadro clínico acima apresentado, julgue o item a seguir. O principal diagnóstico para o caso clínico relatado é a dupla lesão mitral, com predomínio de estenose mitral.

A) Certo

B) Errado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45714)

Enunciado: Considere que um médico assistente tenha constatado, em um paciente de 22 anos de idade com diagnóstico de cardiopatia reumática, entre outros achados semiológicos, a presença de um sopro holossistólico, melhor audível na área tricúspide - com intensidade grau ll segundo a classificação de Levine -, intensificado pela realização da manobra de Müller. Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA.

A) A intensidade do sopro em análise sugere, com alta possibilidade de acerto, insuficiência mitral leve.

B) A intensificação do sopro em estudo, pela manobra realizada, indica a presença de regurgitação tricúspide.

C) A descrição do sopro permite inferir que há frêmito cardíaco associado.

D) A manobra realizada é utilizada para induzir incremento na pós-carga de trabalho do coração.

E) A manobra de handgrip (preensão manual) pode substituir a manobra de Müller realizada, pois esses procedimentos clínicos compartilham a mesma base fisiopatológica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45726)

Enunciado: Uma senhora de 32 anos de idade procurou atendimento médico com relato de que há seis meses passou a apresentar fadiga, dispneia aos grandes esforços, edema de membros inferiores, dor no hipocôndrio direito e a sensação de empachamento pós-prandial. Negou doenças anteriores, tabagismo, e etilismo. Seu exame físico mostrou: paciente emagrecida, frequência cardíaca de 90 bpm, pressão arterial de 100 x 80 mmHg, com evidência de pulso paradoxal, turgência jugular observada com cabeceira do leito elevada a 40°, aumento da pressão venosa jugular durante a inspiração profunda, presença de retração intercostal (simultânea com a sístole cardíaca) observada no décimo primeiro e décimo segundo espaços intercostais esquerdos, ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas hipofonéticas, com presença de knock após a segunda bulha cardíaca em área tricúspide. Aparelho respiratório sem anormalidades. Abdome: hepatomegalia dolorosa sem ascite. Extremidades: edema de membros inferiores, mole, frio e indolor. O eletrocardiograma apresentou: ritmo sinusal, frequência ventricular média de 92 spm, SÂQRS = + 120°, onda P entalhada em derivação D2, baixa voltagem do complexo QRS no plano frontal e alterações difusas e inespecíficas da repolarização ventricular. Com base nessa situação clínica hipotética, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

A) Pericardite constritiva.

B) Cor pulmonale.

C) Mixoma atrial.

D) Cardiomiopatia hipertrófica.

E) Miocardite viral.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

45729)

Enunciado: De acordo com a participação da ingestão de sal (NaCI) na etiologia da hipertensão arterial, os pacientes podem ser divididos em dois grupos: sal-sensíveis e sal-insensíveis. Os primeiros devem ter como terapia inicial um diurético e são detectados laboratorialmente por:

A) Sódio sérico elevado, independentemente da quantidade na dieta.

B) Sódio sérico elevado após dieta hipersódica.

C) Sódio urinário normal ou elevado após dieta hipersódica.

D) Sódio urinário normal ou baixo após dieta hipersódica.

E) Sódio urinário elevado independentemente do tipo da dieta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49138)

Enunciado: Um homem de quarenta e nove anos de idade foi atendido no pronto-socorro, queixando-se de cefaleia intensa, holocraniana e pulsátil, iniciada havia quatro horas, associada a náuseas, tonturas, borramento visual, bem como de sonolência excessiva e confusão mental havia duas horas. Negou febre. Relatou ter recebido diagnóstico de hipertensão arterial, tendo suspendido a medicação, por contra própria, havia três meses. O resultado do exame clínico evidenciou paciente sonolento, desorientado no tempo e no espaço, com pressão arterial de 220 x 150 mmHg, medida no membro superior direito (circunferência do braço direito = 30 cm), com a utilização de bolsa inflável padrão (com largura de 12 cm e comprimento de 23 cm); frequência cardíaca da 95 bpm; pulmões limpos; ritmo cardíaco regular em dois tempos, sem sopros; abdome livre, sem visceromegalias. Realizado exame neurológico, verificou-se ausência de sinais de localização focal ou de irritação meníngea. O exame de fundo de olho mostrou edema na papila óptica bilateral, retina com hemorragias lineares e exsudatos algodonosos extravasculares. Considerando o caso clínico acima apresentado, julgue o item que se segue. A principal hipótese diagnóstica é a de encefalopatia hipertensiva, devendo os níveis da pressão arterial (sistólica e diastólica) serem imediatos e rapidamente reduzidos para valores próximos de 160 x 110 mmHg, mediante uso de nitroprussiato de sódio, um doador de óxido nítrico, que induz potente dilatação arterial e venosa.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49136)

Enunciado: Um homem de quarenta e nove anos de idade foi atendido no pronto-socorro, queixando-se de cefaleia intensa, holocraniana e pulsátil, iniciada havia quatro horas, associada à náuseas, tonturas, borramento visual, bem como de sonolência excessiva e confusão mental havia duas horas. Negou febre. Relatou ter recebido diagnóstico de hipertensão arterial, tendo suspendido a medicação, por conta própria, havia três meses. O resultado do exame clínico evidenciou paciente sonolento, desorientado no tempo e no espaço, com pressão arterial de 220 x 150 mmHg, medida no membro superior direito (circunferência do braço direito = 30 cm), com a utilização de bolsa inflável padrão (com largura de 12 cm e comprimento de 23 cm); frequência cardíaca de 95 bpm; pulmões limpos; ritmo cardíaco regular em dois tempos, sem sopros; abdome livre, sem visceromegalias. Realizado exame neurológico, verificou-se ausência de sinais de localização focal ou de irritação meníngea. O exame de fundo de olho mostrou edema na papila óptica bilateral, retina com hemorragias lineares e exsudatos algodonosos extravasculares. Considerando o caso clínico acima apresentado, julgue o item que se segue. Constata-se que a medida da pressão arterial foi superestimada, observando-se inadequação entre a circunferência do braço e as dimensões da bolsa inflável.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

52637)

Enunciado: Julgue o item a seguir relativo a emergências cardiovasculares. "Dissecções agudas da aorta com envolvimento da aorta ascendente são consideradas emergências cirúrgicas devido ao elevado risco de ruptura aórtica, de tamponamento cardíaco, de insuficiência aórtica aguda e grave e de acidente vascular encefálico."

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32190)

Enunciado: Pedro, dezenove anos de idade, procurou atendimento médico e relatou que há uma semana tem apresentado febre e dor articular no cotovelo direito, no tornozelo direito e no punho esquerdo (não simétrica e migratória). Nos últimos três dias, passou a apresentar dispneia ao executar atividades físicas menos intensas que as habituais e ortopneia, e relata sentir há dois dias dor precordial leve e continua. Seu exame clínico mostrou palidez cutânea, aceitando mal o decúbito horizontal. O exame físico constatou temperatura axilar de 38,2ºC, pressão arterial de 120 mmHg x 72 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm. Ictus cordis localizado no sétimo espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média esquerda, com 5 cm de extensão, impulsivo, ritmo cardíaco regular e tríplice (por terceira bulha), bulhas hipofonéticas e taquicárdicas, presença de sopro holossistólico, mais bem audível no foco mitral, irradiado para região axilar, grau 3 (classificação de Levine), que não sofreu intensificação com a manobra de Mueller; na borda esternal esquerda baixa, foi auscultado atrito pericárdico. Havia estertores pulmonares em terços inferiores de ambos os hemitórax. Abdome livre e sem visceromegalias. Dor à palpação do cotovelo direito, sem sinais flogísticos. O Eletrocardiograma (ECG) mostrou taquicardia sinusal, frequência ventricular media de 115 spm, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, sobrecarga de câmaras esquerdas, extrassístoles ventriculares isoladas e alterações difusas e secundárias da repolarização ventricular. O resultado das hemoculturas colhidas foi negativo. O hemograma evidenciou discreta leucocitose, sem anemia. Observaram-se aceleração da Velocidade de Hemossedimentação (VHS), elevação dos níveis séricos de antiestreptolisina O e de proteína C reativa. No texto, foi mencionada a realização da manobra de Mueller durante a ausculta cardíaca do paciente. Acerca dessa manobra propedêutica, assinale a alternativa correta.

A) Consiste em colocar o paciente na posição chamada "prece maometana" e, assim, aproximar o coração da parede torácica.

B) Durante essa manobra, o paciente deve fazer uma expiração forçada com a glote fechada e, ao longo da fase de expiração, busca-se induzir o aumento da pressão intratorácica e a redução da pré-carga de trabalho do ventrículo direito.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

C) Nessa manobra, o paciente assume a posição de cócoras e com isso promove-se aumento da pós-carga de trabalho do ventrículo esquerdo.

D) Nesse procedimento, solicita-se ao paciente que realize uma inspiração profunda com a glote fechada; induzindo, assim, redução da pressão intratorácica e aumento da pré-carga de trabalho do ventrículo direito.

E) Para a realização dessa manobra, pede-se ao paciente que faça uma preensão manual (esforço isométrico), e dessa forma desencadeia-se uma elevação na pós-carga de trabalho do ventrículo esquerdo.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37938)

Enunciado: Um rapaz com 18 anos de idade, em atendimento médico ambulatorial de um centro de saúde, relatou inchaço no corpo, náuseas/vômitos matinais, anorexia, redução progressiva do volume urinário e urina avermelhada, com início há uma semana. Relatou ter apresentado, havia duas semanas, infecção das vias aéreas (completamente resolvida) e negou outras doenças. No exame físico, ele se apresentava: normolíneo, em regular estado geral, com mucosas hipocoradas (+2/+4), frequência cardíaca de 105 bpm e pressão arterial de 150 mmHg x 110 mmHg (deitado, medida no membro superior direito, usando-se bolsa inflável apropriada para a circunferência do braço). Pulmões sem alterações. O exame cardiovascular revelou ictus cordis no quinto espaço intercostal e na linha hemiclavicular esquerda, com 2 cm de extensão, normoimpulsivo, ritmo cardíaco regular em 3 tempos (à custa de terceira bulha), sopro sistólico (+2/+6), suave, audível em todos os focos, presença de ruído compatível com atrito pericárdico, mais bem audível na borda esternal esquerda baixa. Abdome sem alterações. Edema em membros inferiores (+2/+4) até os joelhos, frio, indolor, com sinal de Godet. Exames complementares evidenciaram: ureia = 130 mg/dl; creatinina = 7 mg/dl; sódio plasmático = 140 mEq/L; potássio plasmático = 6,8 mEq/L; hematócrito = 28%; hemoglobina = 9,2 g/dl; leucograma normal; plaquetas = 250.000/mm3; EAS com ausência de glicose e de proteína; hemoglobina (++); hemácias = 25 por campo; leucócitos = 2 por campo; cilindros hemáticos (+++). Com base nas informações do quadro clínico acima, julgue o item. O atrito pericárdico auscultado no paciente em tela pode apresentar, no máximo, dois componentes estetoacústicos (correspondentes às fases sistólicas atrial e ventricular), é caracteristicamente mais bem audível com o uso da campânula do estetoscópio levemente aplicada sobre a parede torácica e compartilha da mesma base fisiopatológica do sinal de Godet.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37940)

Enunciado: Um rapaz com 18 anos de idade, em atendimento médico ambulatorial de um centro de saúde, relatou inchaço no corpo, náuseas/vômitos matinais, anorexia, redução progressiva do volume urinário e urina avermelhada, com início há uma semana. Relatou ter apresentado, havia duas semanas, infecção das vias aéreas (completamente resolvida) e negou outras doenças. No exame físico, ele se apresentava: normolíneo, em regular estado geral, com mucosas hipocoradas (+2/+4), frequência cardíaca de 105 bpm e pressão arterial de 150 mmHg x 110 mmHg (deitado, medida no membro superior direito, usando-se bolsa inflável apropriada para a circunferência do braço). Pulmões sem alterações. O exame cardiovascular revelou ictus cordis no quinto espaço intercostal e na linha hemiclavicular esquerda, com 2 cm de extensão, normoimpulsivo, ritmo cardíaco regular em 3 tempos (à custa de terceira bulha), sopro sistólico (+2/+6), suave, audível em todos os

focos, presença de ruído compatível com atrito pericárdico, mais bem audível na borda esternal esquerda baixa. Abdome sem alterações. Edema em membros inferiores (+2/+4) até os joelhos, frio, indolor, com sinal de Godet. Exames complementares evidenciaram: ureia = 130 mg/dl; creatinina = 7 mg/dl; sódio plasmático = 140 mEq/L; potássio plasmático = 6,8 mEq/L; hematócrito = 28%; hemoglobina = 9,2 g/dl; leucograma normal; plaquetas = 250.000/mm³; EAS com ausência de glicose e de proteína; hemoglobina (++); hemácias = 25 por campo; leucócitos = 2 por campo; cilindros hemáticos (+++). Com base nas informações do quadro clínico acima, julgue o item. Nesse quadro clínico, durante a esfigmomanometria, como a relação entre as dimensões da bolsa inflável e a medida da circunferência do braço foi adequada, é correto inferir que o comprimento e a largura dessa bolsa inflável correspondiam a, respectivamente, 80% e 40% da medida da circunferência do membro em questão.

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

32162)

Enunciado: A hipertensão arterial primária (essencial) causa lesões intrínsecas das arteríolas renais (ateroesclerose hialina), que resultam em angionefroesclerose. A terapêutica deve controlar a pressão arterial para evitar danos cardiovasculares e preservar a taxa de filtração glomerular, com o objetivo de retardar o desenvolvimento de insuficiência renal crônica. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a prescrição medicamentosa adequada para essa situação.

A) Inibidores de angiotensina e diuréticos tiazídicos em baixas doses.

B) Betabloqueadores e diuréticos de alça dose plena.

C) Inibidores de canais de cálcio e diuréticos tiazídicos em altas doses.

D) Monoterapia com diuréticos de alça em dose plena.

E) Inibidores de canais de cálcio e inibidores de angiotensina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27558)

Enunciado: Quanto ao tratamento para hipertensão arterial sistêmica (HAS), considere as seguintes afirmações, selecionando a correta.

A) Os diuréticos tiazídicos são fármacos muito conhecidos e frequentemente utilizados no tratamento da HAS, devendo ser utilizados em baixas doses, dado a sua capacidade de redução da morbimortalidade em estudos de longo prazo.

B) A seleção de um determinado fármaco para o tratamento da HAS deve considerar a sua tolerabilidade através de doses crescentes para que se possa tratar o distúrbio fisiopatológico coexistente

C) Metanálises dos estudos clínicos vêm demonstrando a importância de estabelecer metas de pressão arterial mais baixa em pacientes idosos

D) Os inibidores da ECA são agentes de escolha em pacientes com disfunção renal e estenose bilateral da artéria renal

E) O estabelecimento de metas de pressão arterial mais baixa inclui grupos específicos de pacientes como: diabéticos, jovens e portadores de lesão em órgão-alvo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

27559)

Enunciado: A Insuficiência Cardíaca (IC) é um importante problema de saúde pública em nosso país e no mundo, responsável por relevante contingente de hospitalizações e mortes na população adulta. Tratando-se desta questão, é CORRETO afirmar:

A) A anemia grave pode interferir na função miocárdica ao acarretar anóxia miocárdica na presença de coronariopatia crônica subjacente.

B) A IC de alto e baixo débito nem sempre são facilmente distinguíveis. A IC de baixo débito decorre da redução da resistência vascular sistêmica e a de alto débito decorre da miocardiopatia dilatada, da cardiopatia isquêmica da valvopatia e da hipertensão.

C) Dentre as causas precipitantes encontram-se a doença isquêmica, as miocardiopatias, as cardiopatias congênitas, valvares e hipertensivas.

D) A fadiga e a fraqueza relacionam-se à redução da perfusão do músculo cardíaco.

E) Na IC grave recomenda-se repouso absoluto no leito, na perspectiva de redução da carga sobre o miocárdio e dos níveis da pressão arterial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

29754)

Enunciado: O início rápido ou a alteração clínica dos sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, com necessidade de tratamento urgente, caracteriza a insuficiência cardíaca aguda. Acerca desse tema, julgue o seguinte item. "Valores do peptídio natriurético do tipo B abaixo de 100 pg/ml permitem excluir quadro de insuficiência cardíaca em pacientes com dispneia aguda."

A) Certo.

B) Errado.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7548)

Enunciado: A doença de Chagas, enfermidade de caráter endêmico e com ampla distribuição no território nacional, volta a surpreender as autoridades sanitárias com a recente descoberta de casos agudos da doença. A respeito dessa doença, julgue os itens a seguir: I - A principal forma de transmissão da doença é através da corrente sanguínea, com a inoculação do parasita através da saliva do triatomíneo. II - Uma das apresentações da doença é o edema bipalpebral, conhecido como sinal de Romaña.

III - Resulta da infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi. IV - A forma aguda da doença de Chagas é mais frequentemente vista em adultos na quarta década de vida. V - Nos pacientes infectados, a reação de Machado Guerreiro é positiva. A quantidade de itens certos é igual a:

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

E) 5.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

7551)

Enunciado: Hipertensão arterial sistêmica é a principal causa de morte no mundo. Acerca dessa afecção, assinale a alternativa incorreta.

A) É fator de risco para acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva e dissecção da aorta.

B) Em sociedades menos industrializadas, nas quais o consumo de calorias e de sal é baixo, a pressão arterial dos indivíduos não aumenta com o avançar da idade.

C) Os níveis de pressão sistólica e diastólica de 120-139 e 80-89 mmHg, respectivamente, são considerados pré-hipertensão.

D) Os inibidores de enzima conversora da angiotensina (ECA) e os antagonistas dos receptores ATI da angiotensina II, apresentam perfil farmacológico adequado para diabéticos hipertensos, especialmente na vigência de nefropatia diabética.

E) As anormalidades tireoidianas (hiper e hipotireoidismo) são as principais causas de hipertensão secundária.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

8583)

Enunciado: Homem de 62 anos de idade, segue em acompanhamento de Insuficiência Cardíaca Congestiva classe funcional III (NYHA). Mantém-se sem descompensações há 1 ano. Do prontuário e informações colhidas junto ao paciente, nota-se o uso de algumas das medicações descritas nas alternativas. Assinale qual das seguintes drogas não altera a mortalidade dessa doença:

A) enalapril.

B) caverdilol.

C) espironolactona.

D) losartan.

E) digoxina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13856)

Enunciado: Em uma consulta ambulatorial de clínica médica verificou-se, durante o exame físico em um paciente com 22 anos de idade assintomático cardiovascular, a presença de discreto abaulamento e impulsão sistólica da região paraesternal esquerda baixa, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com hiperfonese e desdobramento amplo e fixo da segunda bulha cardíaca (que não varia com as manobras de Rivero-Carvallo e de Valsalva) no foco pulmonar, sopro sistólico ejetivo no segundo espaço intercostal esquerdo, sem irradiação, ausência de cliques e estalidos. O eletrocardiograma convencional e radiografia de tórax mostraram, respectivamente, ritmo sinusal, eixo do QRS desviado para a direita, leve sobrecarga do ventrículo direito e bloqueio completo pelo ramo direito do feixe de His; as imagens radiológicas evidenciaram vasos pulmonares periféricos e centrais dilatados, aumento moderado da área cardíaca à custa das câmaras direitas e botão aórtico pequeno. Nesse caso clínico, a principal hipótese diagnóstica é de:

A) hipertensão arterial pulmonar.

B) comunicação interatrial.

C) estenose na valva pulmonar, grave.

D) comunicação interventricular.

E) persistência do canal arterial.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

334876)

Enunciado: Um paciente de 60 anos de idade com diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva é submetido a exame ecocardiográfico que mostra diminuição da fração de ejeção sistólica do ventrículo esquerdo. Nesse caso, visando a reduzir o risco de mortalidade, a medicação mais apropriada a ser prescrita é

A) ácido acetilsalicílico.

B) digoxina.

C) diurético.

D) bloqueador de cálcio.

E) inibidor da enzima conversora de angiotensina.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301251)

Enunciado: Em pacientes hipertensos com doença renal crônica, existem particularidades que devem ser observadas ao se propor o tratamento adequado. Acerca do tratamento da hipertensão arterial sistêmica para esses indivíduos e conforme as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020, julgue o item a seguir. Os betabloqueadores estão indicados para pacientes com insuficiência cardíaca associada à doença renal crônica.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301252)

Enunciado: Em pacientes hipertensos com doença renal crônica, existem particularidades que devem ser observadas ao se propor o tratamento adequado. Acerca do tratamento da hipertensão arterial sistêmica para esses indivíduos e conforme as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020, julgue o item a seguir. Bloqueadores do canal de cálcio e bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II devem ser a primeira opção em pacientes transplantados renais por prevenirem a perda do enxerto.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301253)

Enunciado: Em pacientes hipertensos com doença renal crônica, existem particularidades que devem ser observadas ao se propor o tratamento adequado. Acerca do tratamento da hipertensão arterial sistêmica para esses indivíduos e conforme as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020, julgue o item a seguir. A associação entre bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II e inibidores da enzima conversora de angiotensina é útil nos casos que cursam com albuminúria importante.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301254)

Enunciado: Em pacientes hipertensos com doença renal crônica, existem particularidades que devem ser observadas ao se propor o tratamento adequado. Acerca do tratamento da hipertensão arterial sistêmica para esses indivíduos e conforme as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020, julgue o item a seguir. A meta de tratamento de pacientes desse grupo é a mesma para diabéticos e não diabéticos: pressão arterial <130 mmHg x 80 mmHg.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

301255)

Enunciado: Em pacientes hipertensos com doença renal crônica, existem particularidades que devem ser observadas ao se propor o tratamento adequado. Acerca do tratamento da hipertensão arterial sistêmica para esses indivíduos e conforme as recomendações das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020, julgue o item a seguir. Em pacientes hipertensos sob tratamento dialítico, as médias sistólicas obtidas por medidas domiciliares associam-se linearmente ao aumento do risco cardiovascular.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291471)

Enunciado: Uma mulher de 48 anos de idade é trazida por familiares à unidade de emergência de hospital de alta complexidade com quadro de confusão mental, cefaleia e amaurose bilateral. Segundo familiares, a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica há 2 anos, vindo em investigação diagnóstica por ser classificada como hipertensão arterial resistente. Nas últimas 2 semanas, a paciente passou a não tomar seus fármacos anti-hipertensivos, em razão de acreditar que o tratamento não estava mais funcionando. Na véspera, a paciente começou a se queixar de cefaleia holocraniana, pouco responsiva a fármacos, além de turvação visual. No dia de hoje, a paciente tornou-se um pouco confusa e começou a se queixar de que não estava conseguindo enxergar nada, razão por que foi trazida, às pressas, à unidade de emergência. Ao exame físico, a paciente mostra-se confusa, sonolenta, atendendo com dificuldade a algumas solicitações verbais. Sua Pressão Arterial (PA) encontra-se em 240 x 160 mmHg em ambos os membros superiores, enquanto a frequência cardíaca é de 96 bpm. Um sopro é auscultado no flanco direito de seu abdome. Iniciado tratamento anti-hipertensivo, intravenoso, a paciente é submetida a uma tomografia computadorizada de crânio em que foram detectadas áreas hipodensas em regiões occipitais. A paciente é, então, encaminhada para realização de uma ressonância magnética de encéfalo que, na imagem pesada em T2, revela a presença de hiperintensidade de sinal nos lobos, occipitais, sem limites muito bem definidos. Instituído o tratamento indicado, a paciente evolui com regressão completa dos déficits neurológicos previamente descritos. Acerca do tratamento da paciente em questão, pode-se afirmar que:

A) O alvo terapêutico no caso seria a normalização da pressão arterial em, no máximo, 2 horas.

B) Após compensação clínica, seria fundamental ressecar o tumor adrenal secretor presente à direita.

C) Nicardipina e labetalol por via intravenosa seriam excelentes escolhas farmacológicas para redução da PA da paciente.

D) Em razão da presença de trombose da artéria basilar, deveria ser adicionada anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263981)

Enunciado: Em reunião de equipe, foi solicitada uma visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde para uma paciente idosa devido às dificuldades físicas de locomoção e de ausência de meios de transporte próprios. Durante a visita, o médico de família conheceu a paciente de 75 anos e a filha. Ela informou que a mãe não consegue caminhar longas distâncias e que faz uso das seguintes medicações: hidroclorotiazida 25 mg/dia; losartana 50 mg de 12 em 12 horas; anlodipino 5 mg de 12 em 12 horas; enalapril 20 mg de 12 em 12 horas; clonidina 0,150 mg de 12 em 12 horas; metformina 850 mg 3 comprimidos/dia; insulina NPH 22 UI pela manhã e 22 UI à noite e sinvastatina 20 mg à noite. A paciente referiu estar se sentindo triste, sem disposição e com esquecimentos há cerca de 2 meses. A filha relatou compartilhar diazepam 5 mg e amitriptilina 25 mg, de uso próprio, com a mãe, para melhora do desânimo e da insônia. O médico também constatou que a paciente faz uso frequente de diclofenaco 50 mg para dores no joelho e de flunarizina 10 mg para tontura que a acomete principalmente pela manhã. Ao exame físico, constatou-se que a paciente estava em bom estado geral, corada, hidratada, FC = 82 bpm, FR = 18 irpm, SpO? = 95%, PA = 140 x 80 mmHg e ausência de alterações à ausculta cardíaca e pulmonar e ao exame de abdome. Foi realizada glicemia capilar com resultado de 66 mg/dl (valor de referência: 60 a 100 mg/dl). Em relação ao caso clínico, responda à questão a seguir. Qual é a associação de anti-hipertensivos em uso pela paciente que deve ser evitada?

A) Resposta:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

268899)

Enunciado: Um paciente de 57 anos de idade compareceu ao atendimento ambulatorial para ajuste de medicamento anti-hipertensivo; faz uso de amlodipina 10 mg ao dia. Não apresentou queixas. Ao exame, observam-se FC= 80 bpm, FR = 20 irpm, SatO2 = 97% e PA = 160 mmHg x100 mmHg. De acordo com uma possível comorbidade apresentada pelo paciente, assinale a alternativa que corresponde a uma adequada indicação de anti-hipertensivo.

A) Diabetes mellitus - Hidroclorotiazida.

B) Gota - Losartana.

C) Disfunção erétil - Clonidina.

D) Insuficiência coronariana - Hidralazina.

E) Asma - Propranolol.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263362)

Enunciado: Uma mulher com 69 anos de idade, hipertensa, em uso de enalapril 40 mg/dia e de hidroclorotiazida 25 mg/dia, tem palpitações, tremores de membros superiores e dispneia que começaram há cerca de 30 minutos, logo após ter sido assaltada. Está orientada, corada, sem déficits motores focais, FC = 110 bpm, PA = 200 x 120 mmHg em membros superiores. Ausculta cardíaca: bulhas normofonéticas, ritmo regular em 2 tempos, sem sopros. Pulsos radiais e femorais amplos, bilateralmente, FR = 24 irpm, sem esforço respiratório. Ausculta pulmonar normal. Oximetria de pulso de 99 % (em ar ambiente). O eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal e sinais de sobrecarga ventricular esquerda. A abordagem inicial adequada para essa paciente é administrar

A) nifedipina de liberação rápida por via oral ou sublingual, repetindo a medicação se PA permanecer acima de 180 x 100 mmHg após 60 minutos.

B) ansiolítico por via oral, mantendo-a em observação em local tranquilo e reavaliando os níveis pressóricos num intervalo de 30 a 60 minutos.

C) nitroglicerina por via endovenosa contínua, ajustando a dose a cada 5 minutos até alcançar níveis pressóricos inferiores a 160 x 90 mmHg.

D) metoprolol em bolus por via endovenosa, repetindo a medicação se PA permanecer acima de 180 x 100 mmHg após 10 minutos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273342)

Enunciado: Paciente do sexo feminino, 67 anos, hipertensa, obesa, dislipidêmica, apresenta em consultas sucessivas níveis pressóricos médios de 156x104 e IMC 30,5; está em uso de losartana 100mg/dia e atenolol 50mg/dia. Perfil laboratorial: Cr 0,7, LDL 162, HDL 33, TGL 270, Glic 110. Considere RCV: risco cardiovascular e LOA: lesão de órgão alvo. Nesse caso, o RCV é:

A) intermediário; a avaliação de LOA não á mandatória; a meta pressórica é < 135x85; o tratamento é inadequado e deverá ser reformulado

B) muito alto; deverá ser avaliada a presença de LOA; a meta pressórica é < 130x80; ao tratamento atual deverá ser associado inicialmente um diurético tiazídico

C) intermediário; deverá ser avaliada a presença de LOA; a meta pressórica é < 140x90; ao tratamento atual deve ser associado um bloqueadores de canais de cálcio

D) alto; deverá ser avaliada a presença de LOA; a meta pressórica é < 130x80; o tratamento é inadequado e deverá ser reformulado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

273343)

Enunciado: Um homem, de 78 anos, há 2 meses queixa-se de falta de ar, com piora progressiva. Aos grandes esforços, sente queimação retroesternal e, em uma dessas ocasiões, sentiu tonturas, escurecimento visual e quase desmaiou, melhorando ao se deitar. Para conseguir dormir, eleva a cabeceira da cama e, mesmo assim, acorda com ?canseira? todas as noites, melhorando quando se senta. Refere, ainda, ?inchaço? nas pernas. Exame físico: PA = 128x88mmHg, FC = 108bpm, em bom estado geral, com extremidades quentes, jugulares túrgidas a 45ª e pulsos carotídeos diminuídos. Pulmões: murmúrio vesicular presente com estertores crepitantes nas bases. Coração: bulhas arrítmicas normofonéticas, com desdobramento da 2ª bulha na expiração, B4 audível em mesocárdio e foco mitral e sopro sistólico paraesternal à direita, com irradiação para as carótidas. A ausculta cardíaca refere-se a:

A) ausência de fibrilação atrial e estenose aórtica.

B) presença de fibrilação atrial e insuficiência tricúspide.

C) sobrecarga de volume e insuficiência mitral.

D) presença de fibrilação atrial e estenose aórtica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

291537)

Enunciado: Uma mulher de 38 anos de idade é admitida na enfermaria de cardiologia de hospital de alta complexidade, em função de quadro de dispneia progressiva, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Segundo a paciente informa, seus sintomas anteriores iniciaram-se há cerca de 1 ano, tendo progredido ao longo do período. Procurou assistência médica em algumas ocasiões, sendo finalmente internada para realização de exames complementares e definição diagnóstica. Em sua história patológica pregressa, há relato de dois episódios de febre reumática na adolescência, num dos quais foi detectado um "sopro no coração". Fez uso de penicilina benzatina de forma mensal, mas irregular, até os 18 anos de idade. Nega outros dados relevantes de anamnese. Ao exame físico, paciente está em bom estado geral, em atitude ortopneica. Não há febre. PA = 120 x 70 mmHg; FC = 87 bpm. Ritmo cardíaco é irregular, em 2 tempos, com 1.° bulha hiperfonética e presença de sopro diastólico (2+/6+) em ponta, melhor audível em semi-decúbito lateral esquerdo; um ruído protodiastólico curto, de alta frequência, é também auscultado no foco mitral, mas não se observa reforço do ruflar diastólico. Há anicardiosfigmia. Não é detectada turgência jugular a 45°. Estertores crepitantes finos são auscultados em bases. Não há congestão hepática, nem edema de MMII. Exames complementares iniciais (incluindo VHS) revelam-se normais, sendo a pesquisa de ASLO e swab de orofaringe negativos para infecção por streptococcus pyogenes. Eletrocardiograma revela ritmo de fibrilação atrial, com QT normal. Diante dos dados relatados, a melhor explicação para o quadro da paciente é

A) insuficiência valvar aórtica.

B) estenose mitral reumática.

C) cardite reumática aguda

D) endocardite infecciosa de septo interventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

263438)

Enunciado: Um homem com 50 anos de idade é internado em hospital terciário para investigação diagnóstica e tratamento de quadro caracterizado por dispneia aos moderados esforços. Há relato, ainda, de precordialgia em aperto, com duração de cerca de 5 minutos, precipitada por esforços e aliviada com o repouso, além da ocorrência de 2 episódios de síncope nos últimos 12 meses. Ao realizar exame físico, constatou-se que o paciente se encontra em regular estado geral, corado, acianótico, eupneico, com a cabeceira do leito elevada a 30 graus. Seu ritmo cardíaco é regular, em 3 tempos, com a presença de 4.ª bulha e a existência de um sopro mesossistólico 3+/6+ mais audível no 2.º espaço intercostal direito, na borda esternal; os pulsos arteriais são do tipo parvus et tardus. A ausculta pulmonar apresenta discretos estertores crepitantes em bases. Não há edema de membros inferiores. A radiografia de tórax (PA e perfil) mostra leve dilatação da raiz da aorta, área cardíaca normal e presença de calcificações mitro-aórticas. É solicitado, então, um ecocardiograma transtorácico que revela área valvar aórtica de 0,9 cm^2 (normal: 3 a 4 cm^2), sendo o gradiente ventrículo esquerdo (VE) - aorta de 55 mmHg e velocidade máxima de fluxo transvalvar de 4,5 metros/segundo (normal = inferior a 2m/seg); fração de ejeção do VE é de 52 %. Frente ao processo de avaliação diagnóstica e ao estabelecimento de plano terapêutico neste momento, qual é a conduta médica indicada para o paciente e sua justificativa?

A) Indicar início de tratamento farmacológico com diurético de alça, inibidor de enzima conversora de angiotensina e nitrato, dada a presença de insuficiência cardíaca provocada pelo aneurisma da aorta torácica ascendente.

B) Solicitar a complementação do ecocardiograma com infusão endovenosa de dobutamina, em razão da necessidade de melhor definir o comprometimento da função diastólica causado pela regurgitação valvar aórtica.

C) Proceder cateterismo cardíaco diagnóstico e possivelmente terapêutico, dada a inegável existência de doença arterial coronariana como causa da angina pectoris estável e disfunção sistólica do VE.

D) Solicitar avaliação do risco cirúrgico visando à realização de troca valvar aórtica, em razão da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

existência de estenose aórtica grave sintomática, com indicação de substituição da valva afetada.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

230543)

Enunciado: Ocorrem diversas circunstâncias que podem alterar a medida das velocidades do fluxo e a avaliação anatômica, sendo que a avaliação das velocidades pode estar comprometida em algumas condições que afetam as medidas da análise espectral. Podemos APENAS aceitar o item:

A) Dentre as condições proximais à bifurcação ressaltamos as valvopatias aórticas (estenose ou insuficiência), estenoses de origem aterosclerótica ou arterites com envolvimento do arco aórtico, ramos e carótida comum.

B) Dentre as condições distais à bifurcação ressaltamos as valvopatias aórticas (estenose), estenoses de origem aterosclerótica ou arterites com envolvimento do arco aórtico, ramos e carótida comum.

C) Dentre as condições proximais à bifurcação excluímos as valvopatias aórticas (estenose ou insuficiência).

D) Dentre as condições proximais à bifurcação ressaltamos as valvopatias aórticas (estenose ou insuficiência), estenoses de origem aterosclerótica ou arterites com envolvimento do arco aórtico, mas não dos ramos e carótida comum.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206171)

Enunciado: A Insuficiência Mitral (IM) primária crônica é uma das valvopatias mais prevalentes mundialmente. A etiologia reumática ainda é predominante no Brasil, embora o prolapso da valva mitral tenha aumentado em frequência. Algumas das características de insuficiência mitral primária, importantes ao exame físico, são listadas abaixo, indique a fora de contexto:

A) Ictus cordis desviado para a esquerda e para baixo.

B) Primeira bulha hiperfonética.

C) Segunda bulha hiperfonética.

D) Sopro sistólico regurgitativo ? +++/6+.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206174)

Enunciado: Em razão do aumento da expectativa de vida e do consequente envelhecimento da população, a estenose aórtica (EAo) apresenta prevalência crescente na atualidade, o diagnóstico de estenose aórtica é importante e apresenta diversas características. Quanto a isso, determine o item que NÃO faz parte de uma dessas características:

A) Pulso Parvus et Tardus.

B) Sopro sistólico ejetivo com pico protosistólico.

C) Hipofonese de B2.

D) Hipofonese de B1.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206177)

Enunciado: Sinais de Musset, sinal de Becker, dança das artérias, sinal de Muller, sinal de Quincke, sinal de Rosenbach, sinal de Gerhard, sinal de Traube, sinal de Duroziez, sinal de Mayne e sinal de Hill. Podem ser entendidos ADEQUADAMENTE como:

A) Sinais clínicos de aumento de pressão de pulso.

B) Sinais clínicos de diminuição de pressão de pulso.

C) Sinais clínicos de redução de pressão de pulso.

D) Sinais clínicos de fluxo de pressão de pulso.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212131)

Enunciado: Com relação a doenças respiratórias, julgue o item a seguir. A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) aumenta, de forma significativa, o risco de doença coronariana; insuficiência cardíaca (com ou sem redução da fração de ejeção); ocorrência de arritmias atriais e ventriculares; aterosclerose; doença coronariana; acidente vascular encefálico e diabetes melito.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212094)

Enunciado: Procurou assistência médica uma paciente de 25 anos de idade, que apresentava dispneia aos médios esforços e edema nos membros inferiores, o qual ficava mais acentuado no final da tarde. Ela tinha histórico de amigdalites de repetição. No exame físico, constatou-se pressão arterial de 110 mmHg x 70 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm, saturação de oxigênio = 93% (ar ambiente) e presença de estertores inspiratórios em terço inferior de ambos os hemotórax, à ausculta pulmonar. O exame cardiovascular evidenciou precórdio calmo, ictus cordis visível e palpável no 5° espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular esquerda, e discreta impulsão no terço inferior da região esternal (no sentido craniocaudal). A ausculta cardíaca mostrou ritmo cardíaco regular em 2 tempos, hiperfonese da primeira bulha em área mitral, na qual, também, foi constatada a presença de sopro diastólico (tipo ruflar) ? grau 3 de Levine ? seguido de esforço pré-sistólico e de ruído de abertura da mitral, e discreta hiperfonese da segunda bulha em área pulmonar. O abdome apresentava-se livre e sem visceromegalias. O edema era mole, frio, indolor, com sinal de Godet presente, e observado nos dois terços inferiores de ambas as pernas. Foi realizado Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações. Considerando esse caso clínico, julgue o item subsecutivo. O principal diagnóstico dessa paciente é estenose mitral pura.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

212136)

Enunciado: Procurou assistência médica uma paciente de 25 anos de idade, que apresentava dispneia aos médios esforços e edema nos membros inferiores, o qual ficava mais acentuado no final da tarde. Ela tinha histórico de amigdalites de repetição. No exame físico, constatou-se pressão arterial de 110 mmHg x 70 mmHg, frequência cardíaca de 92 bpm, saturação de oxigênio = 93% (ar ambiente) e presença de estertores inspiratórios em terço inferior de ambos os hemotórax, à ausculta pulmonar. O exame cardiovascular evidenciou precórdio calmo, ictus cordis visível e palpável no 5° espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular esquerda, e discreta impulsão no terço inferior da região esternal (no sentido craniocaudal). A ausculta cardíaca mostrou ritmo cardíaco regular em 2 tempos, hiperfonese da primeira bulha em área mitral, na qual, também, foi constatada a presença de sopro diastólico (tipo ruflar) - grau 3 de Levine - seguido de esforço pré-sistólico e de ruído de abertura da mitral, e discreta hiperfonese da segunda bulha em área pulmonar. O abdome apresentava-se livre e sem visceromegalias. O edema era mole, frio, indolor, com sinal de Godet presente, e observado nos dois terços inferiores de ambas as pernas. Foi realizado Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações. Considerando esse caso clínico, julgue o item subsecutivo. Com base nas manifestações clínicas observadas, ao pedir o ECG, o médico já deverá inferir que devem estar presentes as seguintes alterações eletrocardiográficas: eixo elétrico do complexo QRS desviado para a esquerda (acima de -30°); onda P na derivação D2, com duração normal apiculada, com aumento de sua amplitude que indique sobrecarga atrial esquerda; complexo QRS com aumento de tempo de ativação (deflexão intrinsecoide); e aumento de amplitude (>30 mm) nas derivações do plano horizontal, o que indica sobrecarga ventricular esquerda.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206133)

Enunciado: Alterações próprias do envelhecimento determinam aspectos diferenciais na PA dessa população, sendo INADEQUADO se considerar que,

A) o envelhecimento vascular é o aspecto principal relacionado à elevação da PA nos idosos, caracterizado por alterações na microarquitetura da parede dos vasos, com consequente enrijecimento arterial.

B) grandes vasos, como a aorta, perdem sua distensibilidade e, apesar de os mecanismos precisos não estarem claros, envolvem

primariamente mudanças estruturais na camada média dos vasos, como fratura por fadiga da elastina, depósito de colágeno e calcificação.

C) alterações próprias do envelhecimento determinam aspectos diferenciais na PA dessa população, como maior frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD.

D) apesar de os indivíduos nessa faixa etária serem menos conscientes de sua condição e estarem mais frequentemente sob tratamento do que os hipertensos de meia-idade, as taxas de controle da PA nos idosos são inferiores, em especial após os 60 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206142)

Enunciado: O diagnóstico e a avaliação do grau de envolvimento com LOA são fundamentais para a escolha do tratamento, sendo INADEQUADO que

A) a hipertensão renovascular (HARV) não pode ser secundária à estenose parcial, uni ou bilateral da artéria renal (EAR), desencadeada e mantida por isquemia do tecido renal.

B) a hipertensão renovascular (HARV) tem prevalência de 5% dos pacientes hipertensos.

C) a principal causa é a aterosclerose (90%), seguida por displasia fibromuscular, sendo a arterite de Takayasu a menos frequente.

D) independentemente do fator causal, é importante determinante de morbimortalidade CV.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206148)

Enunciado: Para indicação da opção terapêutica, deve-se considerar a etiologia e as condições clínicas associadas à Hipertensão Arterial. Sendo INCORRETO se considerar que,

A) em pacientes com HARV por displasia fibromuscular há 82- 100% de controle da PA e re-estenose em 10%.

B) evidências de benefício no tratamento mecânico percutâneo ou cirúrgico não estão restritas a situações como perda progressiva da função renal, EAP e dificuldade de controle da PA, que promove Lesão de órgão-alvo LOA irreversível.

C) na Hipertensão renovascular HARV aterosclerótica sem complicações, o implante de stent comparado ao tratamento clínico otimizado não mostrou benefícios no controle da PA, na progressão da doença renal, ou na ocorrência de eventos clínicos e mortalidade.

D) para pacientes com EAR aterosclerótica e PA controlada por tratamento clínico, sem complicações cardíacas e função renal estável ao longo de 6-12 meses, a intervenção mecânica não é recomendada, sendo o tratamento clínico a primeira opção.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

206084)

Enunciado: Para detecção de adenoma unilateral produtor de Aldo APA ou hiperplasia, é indicada TC de adrenais com cortes finos ou RNM. Sendo CORRETA a seguinte conduta:

A) o cateterismo de veias adrenais é indicado quando, à TC, as adrenais são normais, têm anormalidades bilaterais (espessamento

ou micronódulos) ou lesão unilateral em pacientes > 60 anos.

B) o teste de supressão com dexametasona é indicado para investigar HAP supressível por glicocorticoide em pacientes com hiperaldosteronismoprimário HAP e início de HA antes dos 40 anos.

C) o cateterismo de veias adrenais é contraindicado quando, à TC, as adrenais são normais, têm anormalidades bilaterais (espessamento ou micronódulos) ou lesão unilateral em pacientes > 40 anos.

D) o teste de supressão com dexametasona não é indicado para investigar HAP supressível por glicocorticoide em pacientes com hiperaldosteronismo primário HAP e início de HA antes dos 40 anos.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175082)

Enunciado: Dentro das evoluções de diversas doenças relacionadas a dano ao miocárdio, podemos apenas considerar como INCORRETA a alternativa, que demonstra inadequado conceito de evolução ou fisiopatologia:

A) A sarcoidose é uma doença multissistêmica de etiologia desconhecida, caracterizada pelo acúmulo de linfócitos T, fagócitos mononucleares e granulomas não caseosos nos tecidos envolvidos. Os pulmões são afetados em aproximadamente 90% dos pacientes, e a presença de doença pulmonar contribui de forma independente para a morbimortalidade associada a essa doença.

B) A miocardite de células gigantes é uma forma autoimune de agressão miocárdica e caracteriza-se histologicamente por um infiltrado de células gigantes multinucleadas, além de infiltrado inflamatório de células T, eosinófilos e histiócitos.

C) A grande liberação de citocinas inflamatórias e mediadores do estresse oxidativo, leva a uma intensa agressão às células miocíticas. O que leva a perda de miócitos, além de uma reposição por neo formação de miócitos. Essa intensa agressão, promove uma evolução acelerada . Ocorre assim perda rápida da função ventricular e evolução clínica desfavorável.

D) A Síndrome Hipereosinofílica pode ocorrer em associação a diversas doenças com manifestação sistêmica, como Síndrome de Churg-Strauss, câncer, infecções parasitárias e helmínticas, ou estar relacionada a vacinações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175083)

Enunciado: A importância do conhecimento do eletrocardiograma do atleta é muito importante atualmente, devido à inclusão do ECG de repouso na avaliação pré-participação esportiva, faz-se necessário o entendimento do ?ECG de atleta?, sendo essas alterações eletrocardiográficas decorrentes do treinamento de alta performance, sem, necessariamente, alterações anatômicas e/ou estruturais, considerados como parte do ?coração de atleta?. Das descrições abaixo, uma se mostra INCORRETA nesse contexto, assinale-a:

A) Redução do intervalo PR.

B) Bradicardia sinusal.

C) Arritmia sinusal fásica ou respiratória.

D) Aumento da voltagem de ondas R ou S entre 30 a 35 mm.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175093)

Enunciado: Na miocardite induzida por drogas existem diversos aspectos em usa gênese e fisiopatologia que devem ser adequadamente conhecidos. Dentre os aspectos apresentados nas alternativas abaixo, assinale o INCORRETO:

A) Na miocardite induzida por drogas parte da justificativa da hipersensibilidade se dá em resposta a componentes quimicamente reativos que se ligam a proteínas promovendo modificações estruturais. Essas partículas são fagocitadas pelas células de defesa, por vezes macrófagos, os quais as apresentam na superfície dessas células aos linfócitos T.

B) Na miocardite induzida por drogas, uma resposta de hipersensibilidade retardada, são liberadas citocinas como interleucina 5, estimulante de eosinófilos.

C) Na miocardite induzida por drogas o acúmulo de interleucina 5 promove um grande infiltrado eosinofílico com aumento da resposta de hipersensibilidade e maior lesão miocárdica.

D) Na miocardite induzida por drogas a predisposição genética não parece favorecer esse padrão de resposta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175095)

Enunciado: Dentro da análise de um importante exame de imagem, o Ecocardiograma, podemos apenas considerar como INCORRETO o seguinte achado relacionado com Miocardites:

A) Os achados ecocardiográficos na miocardite são inespecíficos.

B) As alterações ecocardiográficas espelham a agressão inflamatória miocárdica e as consequências desta sobre a função e

remodelagem ventricular, podendo ser encontrados trombos intraventriculares ou atriais.

C) As alterações na contração ventricular podem ser difusas ou segmentares, completamente diferentes das alterações isquêmicas.

D) Na miocardite fulminante, usualmente encontramos importante disfunção sistólica com diâmetros cavitárias normais, por vezes associada a aumento da espessura da parede septal, indicando edema miocárdico.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175097)

Enunciado: Quando analisamos a importância da Biópsia Cardíaca para o correto diagnóstico, devemos também analisar as complicações relacionadas a ela. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA:

A) As complicações da biópsia endomiocárdica felizmente são raras.

B) A utilização do ecocardiograma associado à fluoroscopia reduz, de forma significativa, a possibilidade de punção inadvertida que
possa ocasionar perfuração miocárdica ou lesão de coronária.

C) Entretanto, o pneumotórax e a perfuração do septo interventricular não são descritas como complicação.

D) Perfuração de parede livre de VD pode ser considerada uma potencial complicação.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175099)

Enunciado: Os exames de medicina nuclear têm sido aplicados há várias décadas na avaliação de pacientes com suspeita de miocardite, somente não podemos considerar como CORRETA alternativa:

A) Suas principais aplicações estão relacionadas à avaliação da função ventricular esquerda, avaliação da presença de inflamação cardíaca, identificação de subtipos de miocardites e monitoração da resposta terapêutica.

B) Em alguns determinados tipos de miocardite como na sarcoidose, proporciona menor acurácia.

C) A mais estudada na literatura é a cintilografia com 67-Gálio, que apresenta sensibilidade de 50% no diagnóstico da miocardite.

D) A cintilografia com 67-Gálio têm sua melhor utilização diagnóstica se nos primeiros três meses de apresentação clínica da miocardite.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175100)

Enunciado: A Biópsia Endomiocárdica (BEM), apesar de ser método invasivo, quando bem indicada, apresenta grande importância para o paciente, todas as alternativas abaixo se apresentam de forma correta, com EXCEÇÃO de:

A) A Biópsia Endomiocárdica (BEM) é o método ?padrão-ouro? para o diagnóstico da miocardite.

B) A Biópsia Endomiocárdica (BEM) é o método ?padrão-ouro? para a pesquisa de persistência viral cardíaca, assim como de outras doenças cardiovasculares não inflamatórias.

C) A BEM tem como objetivos estabelecer o diagnóstico de inflamação miocárdica com ou sem persistência viral, mas não consegue definir a necessidade e o tipo de terapêutica a ser adotada.

D) Nas situações clínicas onde há insuficiência cardíaca de início recente (menos de 2 semanas), com instabilidade hemodinâmica, sem resposta ao tratamento usual e/ou presença de arritmias ventriculares ou bloqueios cardíacos de alto grau, a BEM desempenha importante papel na investigação do fator causal, com impacto na terapêutica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175141)

Enunciado: Dentro da abordagem de Jovens com Hipertensão Sistólica Isolada (HSI), podemos considerar como INCORRETO:

A) A HSI é rara em jovens saudáveis do sexo masculino com menos de 30 anos e pode estar associada à pressão central normal.

B) A HSI em jovens saudáveis do sexo masculino com menos de 30 anos é associada à pressão central normal, o tratamento não teria benefícios significativos.

C) A HSI em jovens saudáveis do sexo masculino, com pressão central normal, é recomendada a adoção de medidas não medicamentosas, com monitorização de LOA.

D) O tratamento da HSI deve ter início imediato de terapia farmacológica caso seu risco CV seja alto.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175170)

Enunciado: Quando analisamos os aspectos relacionados aos cuidados de Hipertensão relacionados na população idosa, apenas podemos considerar como correta a seguinte alternativa:

A) Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD.

B) A grande variação da PA nos idosos ao longo das 24 horas torna a MAPA uma ferramenta poucas vezes útil.

C) A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, sendo que a manobra de Osler não tem capacidade de diagnosticá-la, pois a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial.

D) Maior ocorrência de hipertensão pós-prandial e, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, podem impossibilitar a medição da PA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183923)

Enunciado: A respeito da hipertensão arterial sistêmica (HAS), considerada o principal fator de risco para ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) e de infarto agudo do miocardio (IAM), julgue o item a seguir. A avaliação do paciente hipertenso deverá incluir a realização de exame físico e de exames laboratoriais, entre eles o exame de urina para avaliação de proteinúria.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183936)

Enunciado: A respeito da hipertensão arterial sistêmica (HAS), considerada o principal fator de risco para ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) e de infarto agudo do miocárdio (IAM), julgue o item a seguir. Apesar de o tabagismo ser uma prática social mundialmente relacionada a doenças pulmonares, não existe relação comprovada entre o uso do cigarro e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio entre fumantes, independentemente da faixa etária.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175179)

Enunciado: Hoje, em seu ambulatório, um antigo paciente em seguimento para Doença Chagásica solicitou que lhe fosse explicado quais as interações que seus exames mais recentes tinham demonstrado a respeito de seu prognóstico, então você o orientou adequadamente com diversos dados epidemiológicos e clínicos, sendo apenas um dos abaixo inadequado, indique-o:

A) Nos pacientes com etiologia chagásica, a presença de taquicardia ventricular sustentada é preditor de prognóstico reservado.

B) Nos pacientes com etiologia chagásica, a presença de taquicardia ventricular não sustentada é preditor de prognóstico reservado.

C) A Fração de Ejeção de Ventrículo Esquerdo (FEVE) < 40% é o único preditor independente de mortalidade.

D) Pacientes chagásicos em lista de espera para transplante cardíaco também apresentam melhor prognóstico em relação a outras etiologias.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

183954)

Enunciado: A respeito da hipertensão arterial sistêmica (HAS), considerada o principal fator de risco para ocorrência de acidente vascular cerebrla (AVC) e de infarto agudo do miocardio (IAM), julgue o item a seguir. As medidas para o tratamento da HAS demandam elevado custo financeiro, consistindo grande desafio em todo mundo.

A) CERTO

B) ERRADO

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

168539)

Enunciado: Um homem com 43 anos de idade comparece ao ambulatório de cardiologia para iniciar seguimento por apresentar hipertensão arterial sistêmica. Ele relata que, há uma semana, havia realizado medida indireta, eventual de seus níveis pressóricos e observado pressão arterial = 240 x 120 mmHg. Naquele momento, não procurou assistência médica de urgência, mantendo-se assintomático desde então. O paciente informa ser ex-tabagista de 20 maços/ano tendo interrompido o hábito há 2 anos. Nega etilismo ou outros vícios; nega uso rotineiro de qualquer medicação. Ao exame físico, observa-se paciente em bom estado geral, obeso, com indice de massa corporal (IMC) de 40 Kg/m² (peso= 130 Kg; altura = 180 m) e circunferência abdominal de 120 cm, apresentando ausculta respiratória e cardíaca sem alterações. O exame do abdome não evidencia massas ou visceronegatias, observando-se edema discreto e simétrico em ambos os membros inferiores. Apresenta frequência cardíaca = 92 bpm. pressão arterial = 220 x 130 mmHg em ambos os braços, utilizando-se esfigmomanômetro apropriado para circunferência braquial. Foram solicitados exames laboratoriais que evidênciam sódio sérico = 142 mEq/L(valor de referência 135 a 145 mEq/L); potássio sérico = 4 ,1 mE/L (valor de referência: 3,5 a 4,5 mEq/L); creatinina sérica = 1,3 mg/dL (valor de referência: 0,6 a 1,2 mg/dL); uréia sérica = 38 mg/dL (valor de referência: 30 a 60 mg/dL), glicemia de jejum (dias diferentes) = 130 mg/dL (primeira amostra) e 134 mg/dL (segunda amostra), (valor de referência: 70 a 99 mg/dL); colesterol total = 214 mg/dL (valor de referência limitrofe: 200 a 239 m/dL); colesterol LDL = 141 mg/dL (valor de referência limitrofe 130 a 159 mg/dL); colesterol HDL = 45 mg/dL (valor desejável: superior a 60 mg/dL); colesterol VLDL = 28 mg/dL (valor de referência até 30 mg/dL); triglicerides = 138 mg/dL (valor de referência limitrofe: 150 a 199 mg/dL); excreção urinária de albumina = 260 mg/dia (0,18 pg/min). O eletrocardiograma e o raio-X do tórax estavam normais. Com base na história clínica e nos achados do exame físico do paciente, faça o que se pede no item a seguir. Descreva as condutas imediatas a serem tomadas.

Resposta descritiva:

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154510)

Enunciado: Paciente do sexo masculino com história de etilismo importante, cessado há dois anos após o diagnóstico de miocardiopatia dilatada de etiologia provavelmente alcoólica, com fração de ejeção ventricular esquerda estimada em 34%. Comparece à consulta ambulatorial de rotina, em uso de Enalapril 10 mg 12/12h, Espironolactona 25 mg/dia e Furosemida 40 mg/dia, apresentando-se com dispneia apenas aos grandes esforços (consegue caminhar mais de 200 m em região plana, com leve limitação das atividades físicas). Ao exame físico: Pressão arterial = 100 x 60 mmHg; Frequência de pulso = 100 bpm; ritmo regular; Ausculta pulmonar; murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios. Ausculta cardíaco regular, em 2 tempos, sem sopros; Sem outras alterações dignas de nota. Segundo a classificação da New York Heart Association (NYHA) para Insuficiência Cardíaca, qual seria a classe funcional (CF) deste paciente?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

154514)

Enunciado: Paciente do sexo masculino com história de etilismo importante cessado há dois anos após o diagnóstico de miocardiopatia dilatada de etiologia provavelmente alcoólica, com fração de ejeção ventricular esquerda estimada em 34%. Comparece à consulta ambulatorial de rotina, em uso de enalapril 10 mg 12/12h, espironolactona 25 mg/dia e furosemida 40 mg/dia, apresentando-se com dispneia apenas aos grandes esforços (consegue caminhar mais de 200 m em região plana, com leve limitação das atividades físicas). Ao exame físico: pressão arterial = 100 x 60 mmHg; frequência de pulso = 100 bpm, ritmo regular; ausculta pulmonar; murmúrio vesicular fisiológico, sem ruídos adventícios; ausculta cardíaca regular, em 2 tempos, sem sopros; sem outras alterações dignas de nota. Na consulta, inicia-se terapia betabloqueadora com carvedilol 3,125 mg de 12/12h e, após uma semana, o paciente retorna. Refere piora da dispneia, agravada ao deitar-se (relata que precisa dormir com a cabeceira mais elevada), e surgindo aos mínimos e moderados esforços, gerando limitação das atividades cotidianas. Ao exame físico neste momento: pressão arterial = 98 x 60 mmHg; frequência de pulso = 84 bpm, ritmo regular; ausculta pulmonar com estertores bibasais, estase jugular a 45º; edema de membros inferiores +2/+4; sem outras alterações. Neste momento, qual é a conduta médica mais adequada?

A) Suspender o carvedilol.

B) Trocar o carvedilol por ivabradina.

C) Reduzir dose do carvedilol pela metade e associar diurético tiazídico.

D) Manter carvedilol em mesma dose, e aumentar dose de furosemida.

E) Aumentar a dose do carvedilol e trocar enalapril por losartana.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158066)

Enunciado: Paciente de 13 anos de idade, obeso, mas sem outras comorbidades conhecidas, apresenta-se à consulta acompanhado da mãe a fim de solicitar atestado para liberação para atividade física, exigido para participação das aulas de educação física na respectiva escola. Ao exame físico, apresenta: PA MSD = 200 mmHg x 120 mmHg; PA MSE = 120 mmHg x 80 mmHg; AC = BNF; RR; 2T, presença de sopro sistólico 2+/6+ em todo o precórdio; AP = normal; ABD = normal; Ext = pulsos pediosos presentes, mas de baixa amplitude. O ECG foi realizado com presteza pela equipe de ambulatório, revelando sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Em relação ao caso apresentado, quanto ao provável diagnóstico do paciente e considerando as Diretrizes de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assinale a alternativa CORRETA.

A) As formas mais severas dessa patologia costumam causar insuficiência cardíaca entre o final da adolescência e o início da idade adulta.

B) Caso haja condições clínicas de postergação do tratamento cirúrgico, realizá-lo após os 14 anos de idade diminui a recorrência.

C) O quadro clínico é compatível com coarctação de aorta na topografia de aorta torácica descendente.

D) O tratamento é sempre intervencionista.

E) Essa patologia representa a segunda maior causa de hipertensão secundária na população brasileira.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159586)

Enunciado: Um paciente de quarenta e oito anos de idade procurou atendimento médico queixando-se de sonolência diurna excessiva, ronco alto, pausas respiratórias testemunhadas, engasgos e sono agitado. O exame físico revelou pressão arterial de 150 mmHg x 100 mmHg; frequência cardíaca de 85 bpm; 1,70 m de altura; peso corporal de 118 kg; e palato ogival, sem outras alterações. O exame de polissonografia mostrou índice de apneia-hipopneia por hora (IAH) igual a 25 eventos/hora. Tendo como referência esse caso clínico, julgue o item que se segue. No caso em apreço, a pressão arterial elevada decorre da inibição absoluta da atividade do sistema nervoso parassimpático (vagal) do paciente.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159590)

Enunciado: Um paciente de quarenta e oito anos de idade procurou atendimento médico queixando-se de sonolência diurna excessiva, ronco alto, pausas respiratórias testemunhadas, engasgos e sono agitado. O exame físico revelou pressão arterial de 150 mmHg x 100 mmHg; frequência cardíaca de 85 bpm; 1,70 m de altura; peso corporal de 118 kg; e palato ogival, sem outras alterações. O exame de polissonografia mostrou Índice de Apneia-hipopneia por Hora (IAH) igual a 25 eventos/hora. Tendo como referência esse caso clínico, julgue o item que se segue. No caso em consideração, recomenda-se, como principal tratamento, a realização de pressão positiva contínua nas vias respiratórias.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159594)

Enunciado: Um paciente de quarenta e oito anos de idade procurou atendimento médico queixando-se de sonolência diurna excessiva, ronco alto, pausas respiratórias testemunhadas, engasgos e sono agitado. O exame físico revelou pressão arterial de 150 mmHg x 100 mmHg; frequência cardíaca de 85 bpm; 1,70 m de altura; peso corporal de 118 kg; e palato ogival, sem outras alterações. O exame de polissonografia mostrou índice de apneia-hipopneia por hora (IAH) igual a 25 eventos/hora. Tendo como referência esse caso clínico, julgue o item que se segue. O principal diagnóstico para o paciente em questão é síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS).

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159539)

Enunciado: Uma professora do ensino fundamental, de vinte e oito anos de idade, procurou atendimento médico por apresentar dispneia aos médios esforços. O exame físico cardiovascular revelou ictus cordis visível e palpável no 5º espaço intercostal na linha medioclavicular esquerda; presença de hiperfonese; e desdobramento fisiológico da segunda bulha em foco pulmonar. Na ausculta do foco mitral, observaram-se hiperfonese da primeira bulha, estalido de abertura da mitral e sopro protomesodiastólico ? grau III de Levine ? associado a reforço pré-sistólico. No exame clínico, não foram observadas outras alterações significativas. Após avaliação clínica e laboratorial, o médico estabeleceu o diagnóstico de cardiopatia reumática crônica, tipo estenose mitral, de moderada intensidade. Com referência a esse caso clínico, julgue o seguinte item: no caso em consideração, o reforço pré-sistólico indica a presença de moderada regurgitação no nível da valva mitral.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159566)

Enunciado: José, de cinquenta e cinco anos de idade, foi levado pelo SAMU ao pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal por apresentar sangramento nasal decorrente de um acidente de carro. Segundo um transeunte que testemunhou o fato, José dirigia o veículo a aproximadamente 40 km/h quando colidiu com um hidrante na descida de uma entrequadra do Plano Piloto. No hospital, o paciente não se lembrava de nada. Com base no caso clínico apresentado, julgue o seguinte item. Após a primeira avaliação e a contenção do sangramento, a hipótese diagnóstica a ser levantada pelo médico é a de que o paciente seja portador de síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS), convulsão e depressão.

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

159573)

Enunciado: Julgue o próximo item, relativo à síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS). As variáveis com maior valor preditivo positivo para diagnóstico de SAOS são circunferência de pescoço, roncos e índice de massa corporal (IMC).

A) CERTO.

B) ERRADO.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133927)

Enunciado: De acordo com o documento VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, a aferição da pressão arterial dever ser feita a partir de

A) Dois minutos de repouso em ambiente calmo.

B) Doze horas de abstinência sexual.

C) Deflação do manguito na velocidade de 10 mmHg por segundo.

D) Sessenta minutos sem atividade física.

E) Duas horas sem uso de tabaco.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133935)

Enunciado: Paciente feminina de 36 anos de idade, sedentária e obesa, agenda uma consulta por estar preocupada com a pressão arterial em razão de recente óbito familiar. Mostra-se ansiosa para fazer "todos os exames de pressão", mas se queixa de dificuldade financeira e pede somente os exames com maior nível de evidência. Considerando essa situação hipotética, é CORRETO afirmar que a paciente foi adequadamente orientada, caso tenha sido informada de que, entre os exames iniciais, os que têm nível de evidência B, de acordo com VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, são os seguintes:

A) De ureia e de potássio.

B) Ecocardiograma e de glicemia de jejum.

C) De glicemia pós-prandial e de creatinina.

D) De curva glicêmica e de colesterol total.

E) De creatinina e de eletrocardiograma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133942)

Enunciado: Preocupado com o recente diagnóstico de insuficiência cardíaca, um nutricionista de 58 anos de idade indaga acerca das adequações dietéticas com maior nível de evidência, dizendo-se disposto a seguir qualquer terapêutica com recomendação Classe 1 da III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica. Considerando essa situação hipotética, a referida recomendação é restrição

A) Hídrica de 1.000-1.500 mL em pacientes sintimáticos com risco de hipervolemia.

B) Do consumo de sódio a 2-3 gramas por dia, desde que não comprometa a ingesta calórica e na ausência de hiponatremia.

C) Do consumo de sódio a menos de 10 gramas por dia, desde que não comprometa a ingesta calórica e na ausência de hiponatremia.

D) Hídrica menor que 1.000 mL em pacientes sintomáticos com risco de hipervolemia.

E) Do consumo de sódio a menos de 2 gramas por dia, desde que não comprometa a ingesta calórica e na ausência de hiponatremia.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

104742)

Enunciado: Para a avaliação da pressão arterial em consulta ambulatorial ser adequada, deve ser feita em:

A) duas medidas espaçadas em cinco minutos.

B) duas medidas seguidas.

C) uma medida, em decúbito dorsal, seguida de outra em posição ortostática.

D) uma medida no braço direito e, cinco minutos após, na perna direita,

E) três medidas seguidas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

104749)

Enunciado: No tratamento da hipertensão arterial em diabéticos, o objetivo é manter a PA < 130/80 mmHg para:

A) proteger o rim, retardando o desenvolvimento da glomerulopatia diabética, que ocorre somente no diabetes tipo 1.

B) diminuir a microalbuminúria, quando existente, melhorando o prognóstico da doença.

C) evitar o acidente vascular hemorrágico, que ocorre, em alta prevalência, em diabetes tipo 2.

D) manter o sistema nervoso central íntegro.

E) evitar embolia pulmonar.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80694)

Enunciado: Insuficiência cardíaca é uma situação clínica comum no Brasil e tem etiologias diversas. Algumas condições gerais devem ser identificadas precocemente pelo clínico assistente como fatores causais. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta um desses fatores.

A) Contratilidade miocárdica prejudicada, levando à função sistólica reduzida, geralmente com aumento da fração de ejeção.

B) Função diastólica alterada, com função sistólica mantida, causando geralmente diminuição da fração de ejeção.

C) Shunts arteriovenosos na circulação esplâncnica.

D) Insuficiência valvular.

E) Arritmias quando são do tipo em salvas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80723)

Enunciado: Em relação a pericardites é correto afirmar que a:

A) Dor pré-cordial está presente em todos os pacientes independentemente da etiologia.

B) Dor é típica e aumenta à expiração.

C) Dor é aliviada na posição deitada (supino).

D) Dor é muito diferente da que ocorre no infarto agudo do miocárdio e não entra em seu diagnóstico diferencial.

E) Pericardite que acontece na artrite reumatoide geralmente é assintomática.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97795)

Enunciado: Uma paciente com 19 anos de idade, primípara, na 24ª semana de gestação, vem à consulta pré-natal com queixa de dispneia progressiva há duas semanas, inicialmente aos grandes esforços e, atualmente, aos médios esforços. Ao exame físico, apresenta altura uterina compatível com a idade gestacional, edema de membros inferiores ++/4+, estertores crepitantes em bases pulmonares. Frequência respiratória = 24 irpm; frequência cardíaca = 106 bpm; ausculta com ritmo cardíaco regular e sopro diastólico (++/4) mais audível no ápice, acompanhado de hiperfonese de B1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a hipótese diagnóstica e a etiologia:

A) Estenose mitral, provavelmente de origem reumática.

B) Insuficiência mitral, provavelmente de origem reumática.

C) Prolapso da válvula mitral, como parte de síndrome de Marfan.

D) Sopro funcional, como parte do estado hipercinético da gravidez.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97810)

Enunciado: Um paciente com 50 anos de idade, com diagnóstico de hipertensão pulmonar idiopática, com antecedente de internação prévia há um ano, devido à dispneia aos esforços e anasarca, deu entrada no pronto-socorro por ter apresentado episódio de síncope durante a relação sexual. Refere fazer uso de diltiazem regularmente e informa que nos últimos dois meses houve evolução da dispneia para pequenos esforços e surgimento de letargia. Nas últimas duas semanas, vem evoluindo com dor abdominal em hipocôndrio direito e edema de membros inferiores e apresentou ainda três episódios de dor precordial em aperto, sem irradiação, desencadeados por grandes esforços. Ao exame físico, mostra-se com estado geral regular, eupneico em repouso, orientado, sem déficits neurológicos. A ausculta cardíaca revela ritmo regular, com hiperfonese de B2 , sem sopros, frequência cardíaca = 92 bpm, pressão arterial = 100 x 65 mmHg. Observa-se turgência jugular a 45° e ausculta pulmonar é normal. A palpação da borda hepática, a cerca de 5 cm do rebordo costal direito, é levemente dolorosa. Há edema de membros inferiores, atingindo até a coxa e parede abdominal, +++/4+, frio e indolor. Foram realizados radiografia de tórax (incidência posteroanterior) e Eletrocardiograma (ECG), mostrados a seguir (VER ANEXO).

A) Radiografia do tórax: abaulamento do tronco da artéria pulmonar e redução da trama vascular periférica pulmonar; ECG: bloqueio de ramo direito, desvio do eixo cardíaco para a direita e padrão de repolarização ventricular do tipo strain.

B) Radiografia do tórax: abaulamento do tronco da artéria pulmonar e redistribuição da trama vascular para os ápices pulmonares; ECG: bloqueio de ramo esquerdo, desvio de eixo cardíaco para a direita e padrão de repolarização ventricular do tipo strain.

C) Radiografia do tórax: aumento de ambos os ventrículos cardíacos e redução da trama vascular periférica pulmonar; ECG: bloqueio de ramo esquerdo, desvio do eixo cardíaco para a direita e alterações inespecíficas da repolarização ventricular.

D) Radiografia do tórax: aumento de ambos os ventrículos cardíacos e redistribuição da trama vascular para os ápices pulmonares; ECG: bloqueio de ramo direito, desvio do eixo cardíaco para a direita e alterações inespecíficas da repolarização ventricular.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

80744)

Enunciado: O alcoolismo é um grave problema de saúde pública. Além de estar relacionado diretamente a mortes violentas, pode gerar importantes agravos orgânicos de saúde, sendo um deles a miocardiopatia alcoólica. Com base nessa informação, assinale a alternativa em que a bebida apresenta, além do álcool, um componente que age sinergicamente na gênese daquela patologia.

A) Aguardente, apresenta chumbo em sua composição.

B) Vodka, apresenta mercúrio em sua composição.

C) Conhaque, apresenta manganês em sua composição.

D) Uísque, apresenta metais pesados em sua composição.

E) Cerveja, apresenta cobalto em sua espuma.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

97839)

Enunciado: Um homem, com 45 anos de idade, professor do ensino médio, é atendido em ambulatório para tratamento de hipertensão arterial diagnosticada há três anos como de natureza essencial (primária). Refere que nos últimos meses, mesmo fazendo uso regular de inibidores da enzima conversora de angiotensina, de bloqueador de canal de cálcio e de diurético, os seus níveis pressóricos mantêm-se elevados. Tem história familiar de hipertensão arterial. Não refere antecedentes patológicos. Não é submetido a acompanhamento dietético ou à prática de exercícios físicos regulares. Não utiliza outros medicamentos. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, com índice de massa corporal = 30,6 kg/m², frequência respiratória = 22 irpm, frequência cardíaca = 112 bpm e pressão arterial = 160 x 110 mmHg; ausculta pulmonar normal; ritmo cardíaco regular em 2T, bulhas normofonéticas, sem sopros ou arritmias; exame abdominal e de membros sem alterações. Exame de fundo de olho: tortuosidade e espessamento de arteríolas, presença de alguns cruzamentos patológicos. Eletrocardiograma com sinais de sobrecarga ventricular esquerda e alterações difusas de repolarização. Radiografia de tórax com aumento da área cardíaca por aumento do ventrículo esquerdo. Bioquímica sérica: glisose = 116 mg/dl (Valor de referência = 75-99 mg/dl), ureia = 70 mg/dl (Valor de referência = 20-35 mg/dl), creatinina = 1,8 mg/dl (Valor de referência = 0,7-1,2 mg/dl). O quadro apresentado é demonstrativo de:

A) hipertensão maligna instalada.

B) insuficiência renal decorrente do uso de agentes hipertensivos.

C) evolução natural da hipertensão essencial ligada à história familiar.

D) comprometimento dos órgãos-alvos na hipertensão arterial sistêmica.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

64443)

Enunciado: Em relação ao uso de betabloqueadores na Insuficiência Cardíaca (IC) é correto afirmar:

A) Metoprolol e carvedilol comprovadamente reduzem a mortalidade na IC crônica.

B) A meta para a dose de carvedilol é atingir dose diária de 12,5 mg/dia.

C) Doses devem ser reajustadas a cada dois dias até se chegar aos níveis desejados.

D) Não devem ser empregados em associação com diuréticos.

E) Há contraindicação absoluta para o seu uso em diabéticos.

Gabarito

345435.

Comentário: A síndrome de insuficiência cardíaca pode ser classificada quanto aos seus estágios evolutivos e, nos sintomáticos, quanto a sua classe funcional. A última é determinada pelo grau de comprometimento às atividades cotidianas, relacionando-se com o prognóstico desta entidade. Vamos relembrar a categorização em classes funcionais proposta pelo New York Heart Association (NYHA) e globalmente utilizada abaixo Classe I Paciente sem limitação às atividades cotidianas. Atinge mais de 6 METs no teste ergométrico. Classe II Paciente com limitação leve. Sintomas nas atividades cotidianas ou médios esforços. Atinge 4-6 METs no teste ergométrico. Classe III Paciente com limitação moderada. Sintomas com atividades menos intensas do que as ordinárias ou pequenos esforços. Atinge 2-4 METs no teste ergométrico. Classe IV Paciente com importante limitação física. Sintomas em repouso ou aos mínimos esforços. N o é capaz de tolerar o teste ergométrico. Posta a classificação do NYHA, vamos correlacioná-las com as alternativas Letra A incorreta. NYHA I. Letra B incorreta. NYHA III. Letra C incorreta. NYHA IV. Letra D correta. NYHA II. Resposta letra D.

345449.

Comentário: Temos uma idosa com dispneia aos esforços, edema de membros inferiores e turgência jugular patológica, indicando uma síndrome de insuficiência cardíaca (IC). A radiografia de tórax demonstra congestão venocapilar pulmonar, corroborando esta possibilidade. Dado que

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

seu ritmo cardíaco é irregular, lidamos com a possibilidade de fibrilação atrial concomitante, estando a frequência cardíaca de repouso dentro do alvo esperado para esta arritmia. O ecocardiograma transtorácico foi adequadamente indicado, documentando aspecto de cardiopatia hipertensiva e fração de ejeção normal. Sobre a paciente em questão, vamos avaliar as alternativas e desenvolver o estudo sobre o tema Letra A incorreta. A descompensação da IC exige ajuste medicamentoso, a fim de permitir o controle dos sintomas. O aumento da dose de diuréticos constitui a medida inicial nos pacientes congestos, uma vez que reduzem a pré-carga e o volume circulante, implicando em melhora da dispneia e do edema. Letra B correta. A associação de manifestações congestivas com demonstração de fração de ejeção igual ou maior que 50% designam a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP). A terapia diverge do tratamento dos pacientes com FE reduzida, sendo focado em alívio de sintomas e controle de comorbidades. Em nosso caso, além de melhora da dispneia e do edema, a otimização dos anti-hipertensivos e a manutenção da anticoagulação para a fibrilação atrial estão indicados. Letra C incorreta. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é caracterizada pela presença da síndrome clínica com função sistólica deprimida, sendo a FE igual ou menor que 40%. Letra D incorreta. Em nosso contexto, a fração de ejeção de 65% estabelece ICFEP. Os inotrópicos seriam indicados somente nos indivíduos com FE reduzida e sinais de baixa perfusão tecidual, devendo os pacientes congestos e quentes serem abordados com aumento do diurético e vasodilatador. Resposta letra B.

345454.

Comentário: A questão traz paciente de 52 anos, com pressão arterial elevada apesar do uso de um IECA (captopril) em dose regular. Os valores pressóricos permanecem elevados durante a medicação feita no domicílio, portanto podemos afastar, a princípio, um quadro de hipertensão do jaleco branco que justificasse a necessidade de MAPA (LETRA D CORRETA). Tampouco podemos classificar o paciente como uma HAS resistente, que é aquela PA de consultório que permanece com valores 140 90 mmHg, com o uso de três ou mais classes de fármacos anti-hipertensivos com ações sinérgicas, em doses máximas preconizadas ou toleradas, sendo um deles

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

preferencialmente um diurético tiazídico (LETRA C INCORRETA). A melhor opção aqui é associar uma segunda droga ao esquema anti-hipertensivo, sendo as melhores opções um diurético tiazídico ou bloqueador de canal de cálcio, que são drogas de primeira linha (LETRA C CORRETA). Associar um BRA não é uma boa opção, pois o paciente já faz uso de um IECA, que possui mecanismo de ação semelhante (LETRA A INCORRETA). Resposta letra B.

345471.

Comentário: Tratamos de um homem com múltiplas comorbidades, incluindo um passado de infarto agudo do miocárdio (IAM) submetido a revascularização percutânea, que apresenta-se na emergência com piora, de início agudo, da dispneia habitual. Ao exame foram observados elevação pressórica e estertores bolhosos, associados à queda na saturação de oxigênio. Após manejo inicial ocorreu melhora clínica significativa. Considerando o caso clínico, vamos avaliar as hipóteses e condutas dispostas Letra A incorreta. Apesar dos inúmeros fatores de risco que poderiam favorecer a ocorrência de novo IAM, a ausência de precordialgia denota um achado negativo para este evento. Embora a síndrome coronária possa transcorrer sem dor, não tratamos de um paciente típico para esta manifestação, estando claro em nosso cenário uma descompensação da insuficiência cardíaca (IC). Ainda, nas situações que cursam com edema agudo de pulmão, como a nossa, os nitratos orais são geralmente insuficientes, havendo necessidade de uso de drogas intravenosas. Letra B incorreta. O tromboembolismo pulmonar expressa-se principalmente por dispneia de início súbito. No entanto, neste evento a ausculta do aparelho respiratório dissocia-se dos sintomas, sendo pouco expressiva e sem estertores bolhosos. Adicionalmente, a resposta a anticoagulação não ocorre prontamente, estando atrelada à atuação do sistema fibrinolítico do paciente. Letra C incorreta. Em um indivíduo com substrato cardiológico estrutural prévio e dispneia, exprimindo sinais de congestão pulmonar ao exame físico, está determinada descompensação da IC. Todavia, apesar de benefícios bem estabelecidos para o tratamento da IC crônica, os betabloqueadores devem ser evitados nos quadros agudos, visto que sua ação inocronotrópica negativa pode piorar os sintomas congestivos e favorecer a migração de um perfil quente para um perfil úmido . Letra D correta. A terapia do edema agudo de pulmão hipertensivo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

consiste em oxigenação e redução da pressão de enchimento ventricular. A última é obtida por diminuição da pré-carga, através da prescrição de diuréticos e vasodilatadores venosos, notadamente a nitroglicerina. Uma vez que a doença arterial coronariana representa globalmente a principal etiologia da IC, o antecedente de IAM extenso indica fortemente a possibilidade de cardiopatia isquêmica. Resposta letra D.

345496.

Comentário: Temos um menino com roncos noturnos, sono agitado e pausas respiratórias, associados à sintomas diurnos de sonolência e desatenção. Veja que a má qualidade do sono noturno impacta no comportamento e rendimento escolar da criança, sendo o quadro altamente sugestivo de síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS). Este distúrbio respiratório do sono pode ocorrer em até 5% da população infantil, tendo como morbidades associadas inatenção, hiperatividade e déficit cognitivo, tais como em nosso caso. Estas tratam-se de efeitos das alterações das trocas gasosas e despertares noturnos, não relacionando-se ao diagnóstico primário de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como apontado na letra A. Apesar do refluxo gastroesofágico poder cursar com episódios breves de pausas respiratórias em escolares, outros achados, como laringoespasmo e vômitos seriam esperados, estando a letra B inadequada. O diagnóstico definitivo da SAOS é feito pela associação de sintomas com polissonografia compatível, o que torna a letra C correta. A hipertrofia de adenoides, citada na letra D, constitui fator de risco para a SAOS na faixa pediátrica, já que pode acarretar estreitamento de vias aéreas, contudo, isoladamente não justifica as manifestações clínicas do paciente. Resposta letra C.

343842.

Comentário: Temos uma paciente apresentando hiponatremia assintomática, em uso de losartana e hidroclorotiazida. Com as informações disponíveis no enunciado, a única etiologia possível para o distúrbio eletrolítico é o uso de hidroclorotiazida Os diuréticos tiazídicos diminuem a capacidade de diluição renal e aumentam a excreção de sódio. Depois que ocorre depleção de volume, a liberação não osmótica da vasopressina (ADH) causa retenção de água e agrava a hiponatremia. E como devemos tratar a hiponatremia Depende da causa Se fosse uma hipovolêmica, faríamos hidratação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com SF 0,9%. Porém, vimos que os principais mecanismos envolvidos são (1) redução na capacidade de diluição renal e natriurese (2) síndrome de secreção inapropriada de ADH (SIADH). O primeiro componente pode ser tratado com a suspensão da droga, enquanto o tratamento da SIADH consiste em restrição hídrica furosemida - vaptan. Tudo isso pode ser feito ambulatorialmente, assim como o controle dos níveis de sódio. A reposição de sódio propriamente dita deve ser feita para pacientes com hiponatremia aguda (48h) e sintomática Certamente, não é o que estamos vendo no caso em tela. Resposta letra C.

343851.

Comentário: A paciente da letra A apresenta um pico hipertensivo claramente associado a um fator desencadeante transitório, de caráter emocional. Como não há sinais ou sintomas de lesão aguda de órgão-alvo, a princípio vamos considerar que se trata de uma pseudocrise hipertensiva ,. A conduta é tratar a ansiedade e reavaliar. Se persitir hipertensa, aí sim poderemos considerar o uso de anti-hipertensivo (letra A errada)... O paciente da letra B apresenta sinais e sintomas de glomerulonefrite pós-estreptocócica. A hipertensão arterial faz parte do quadro, e pode ser grave. Contudo, apesar de o paciente estar bastante hipertenso, não há sinais ou sintomas de lesão de órgão-alvo, logo, não se trata de emergência hipertensiva (letra B errada)... A paciente da letra D apresenta sinais e sintomas sugestivos de labirintite aguda (vertigem rotatória vômitos). A pressão arterial pode aumentar em resposta ao desconforto físico associado a esta condição, ou seja, a hipertensão, neste caso, provavelmente é consequência das queixas apresentadas, e não sua causa Vamos tratar a vertigem e os vômitos, e reavaliar, sem usar anti-hipertensivos a princípio (letra D errada)... Agora, o paciente da letra C tem uma emergência hipertensiva clássica... Trata-se de um paciente com PA muito elevada, dor retroesternal aguda e assimetria de pulsos entre membros superiores e inferiores (inclusive com pulsos não palpáveis nos membros inferiores). Este é o quadro clínico da dissecção aórtica aguda, condição que deve ser abordada inicialmente com anti-hipertensivos parenterais de ação rápida, pois a persistência de PA elevada coloca a vida do paciente em risco. Resposta letra C.

283286.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Em relação aos efeitos colaterais dos anti-hipertensivos, o edema de membros inferiores (maleolar) é o principal efeito colateral dos antagonistas de canais de cálcio di-hidropiridínicos, como o anlodipino. O mecanismo é uma resposta vasodilatadora exagerada na circulação dos membros inferiores, gerando hiperfluxo e maior transudação de líquido ao nível da circulação capilar nesta região. Já a hiperuricemia e a gota são complicações mais associadas ao uso de diuréticos, no caso, a hidroclorotiazida. Vale lembrar que os diuréticos, ao promoverem certo grau de hipovolemia, fazem aumentar a reabsorção de sódio e água no túbulo contorcido proximal. A consequência será uma maior concentração e reabsorção de ácido úrico neste segmento do néfron, o que reduz a sua excreção renal e com isso favorece o surgimento de hiperuricemia gota. Por fim, só mais um detalhe, a losartana, na verdade, costuma ser uma boa opção em pacientes com gota, pois apresenta um efeito uricosúrico (reduz a reabsorção de ácido úrico). Resposta letra C.

251858.

Comentário: Um dos efeitos adversos mais comuns com o uso dos inibidores da ECA (IECA) é a tosse (5-20% dos pacientes), decorrente do acúmulo de bradicininas e substância P, que ocorre pelo bloqueio da ação da enzima conversora da angiotensina. A tosse costuma iniciar-se uma a duas semanas após o tratamento, mas pode aparecer até seis meses após. As mulheres são mais afetadas que os homens. Após descontinuação do tratamento, a tosse cessa dentro de quatro dias, mas pode demorar até quatro semanas. O uso de AINEs como o AAS ou a indometacina reduz a incidência de tosse, embora os AINEs não sejam recomendados para esse fim, uma vez que reduzem o efeito dos IECA e aumentam o risco de outros efeitos adversos, como a hipercalemia. Resposta C.

247145.

Comentário: A hipertensão venosa sistêmica com aumento da pressão venosa central (PVC) pode causar elevação da pressão renal intersticial, por transmissão retrógrada da pressão atrial direita às veias renais, que leva a um estado de hipóxia no parênquima renal, que vai ter como conseq ência redução da excreção de sódio, o que contribui a piora da função renal nos pacientes com IC

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

descompensada. Além disso, o incremento na PVC esta associado com atenuação dos reflexos vasculares que causa alteração na capacidade de resposta arterial prejudicando o fluxo renal sanguíneo efetivo. Resposta letra A.

247147.

Comentário: A hipertensão arterial é considerada um dos principais fatores de risco para desenvolvimento e progressão da aterosclerose e seus desfechos clínicos como o acidente vascular cerebral (AVC), infarto do miocárdio (IM) e a obstrução arterial periférica (OAP). É também uma importante causa da insuficiência renal crônica (IRC) e o mais importante fator de risco para a progressão da lesão renal. A nefroesclerose hipertensiva é a principal causa de doença renal crônica no Brasil e a sua fisiopatologia envolve a isquemia glomerular crônica. Portanto, o nosso gabarito é a letra C.

247166.

Comentário: Esta questão foi anulada pela banca devido a erro de digitação no valor da pressão arterial... Pelo que conseguimos perceber ao ler as alternativas, esse senhor de 50 anos, coronariopata, tinha pressão agudamente aumentada, mas sem lesão de órgão alvo apesar da cefaleia, não havia alteração do exame neurológico. Ora, em coronariopatas, o aumento agudo e grave da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo define urgência hipertensiva, em que há RISCO de LOA (A e D erradas). Nas urgências hipertensivas, o tratamento é feito com anti-hipertensivos orais (B e C erradas). O analgésico seria fundamental para atenuar a cefaleia, provável responsável pelo aumento da pressão arterial desse senhor. Gabarito MEDGRUPO E.

247184.

Comentário: Estamos diante de um caso típico de síndrome de veia cava superior ou síndrome do mediastino superior. Este evento é decorrente da invasão do mediastino superior por tumores, levando à compressão da veia cava superior aí localizada. Nesta faixa etária, uma vez que o carcinoma broncogênico é bastante raro, os principais tumores malignos associados a este quadro são os linfomas não Hodgkin, linfomas Hodgkin, LLA tipo T, teratomas malignos, timomas e neuroblastoma. O quadro também pode ser causado por algumas doenças infecciosas, como

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tuberculose, histoplasmose, ou ainda, por doenças vasculares, como trombose secundária à cirurgia cardíaca, podem também provocar este quadro. Os sinais e sintomas característicos da síndrome incluem turgência jugular, pletora, edema da cabeça e pescoço, cianose, proptose e síndrome de Horner. As manifestações clínicas são intensificadas com a manobra de Valsalva, pelo aumento do retorno venoso. Como em crianças a traqueia e o brônquio, fonte principal, são estruturas fibrocartilaginosas mais finas e complacentes, os processos tumorais adjacentes a essas estruturas podem acarretar em queixas relacionadas à compressão das vias respiratórias, incluindo tosse, dispneia, chiado, estridor ou cianose. Em relação às outras opções diagnósticas listadas, embora o diagnóstico de hipertensão intracraniana seja considerado nos casos de cefaleia e desmaio, esperaríamos encontrar hipertensão arterial, bradicardia e vômitos, além do quadro não cursar com pletora e estase venosa. No ataque de pânico, pode haver cefaleia, desmaio, recusa a deitar e até dispneia, mas não há substrato para estase venosa na cabeça e pescoço. Na crise de asma os achados cardinais são a tosse seca, sibilância, com alterações na ausculta pulmonar. Finalmente, a síndrome de lise tumoral possui um quadro clínico totalmente diferente a destruição das células tumorais leva à liberação de seu conteúdo para a corrente sanguínea, principalmente fosfato, potássio e ácidos nucleicos, sendo a clínica secundária a tais alterações laboratoriais. Resposta letra B.

217656.

Comentário: Questão direta sobre medicamentos anti-hipertensivos. Vamos analisar e buscar a correta. A - INCORRETA. Os alfabloqueadores estão indicados nesses casos. B - INCORRETA. O alisquireno, inibidor direto da renina, é um medicamento ótimo e já há evidências para garanti-lo como medicação eficaz em reduzir a pressão arterial, mas ainda é cedo para conhecer seus efeitos em longo prazo. C - INCORRETA. Os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II, conhecidos como BRA, também reduzem proteinúria. D - CORRETA. Deve-se evitar verapamil e diltiazem em pacientes com disfunção sistólica grave, mas são uma boa opção para arritmias cardíacas. Resposta correta letra D.

182602.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial classifica os indivíduos nos seguintes estágios (PAS pressão arterial sistólica PAD pressão arterial diastólica valores expressos em mmHg) PA normal PAS menor ou igual a 120 PAD menor ou igual a 80 Pré-hipertensão PAS 121-139 PAD 81-89 Hipertensão estágio 1 PAS 140-159 PAD 90-99 Hipertensão estágio 2 PAS 160-179 PAD 100-109 Hipertensão estágio 3 PAS maior ou igual a 180 PAD maior ou igual a 110 Quando a PAS e a PAD situam-se em categorias diferentes, o maior valor deve ser utilizado para a classificação. Chegamos à conclusão de que trata-se de uma hipertensão estágio 1 , não é O gabarito inicial da Banca havia sido a opção (C). Após a formulação de um recurso, o gabarito oficial foi modificado para a alternativa (B).

182624.

Comentário: De acordo com a classificação da NYHA para insuficiência cardíaca, temos que - Classe I sem limitação física. As atividades ordinárias (do cotidiano) não causam sintomas dispneia só aos grandes esforços (ex. empurrar um carro). - Classe II as atividades ordinárias causam sintomas, ou seja, dispneia aos médios esforços (ex. varrer a casa). - Classe III as atividades mais brandas que as ordinárias causam sintomas, ou seja, dispneia aos pequenos esforços (ex. andas devagar no plano, vestir-se). - Classe IV sintomas em repouso ou aos mínimos esforços (ex. pentear o cabelo). Como o paciente possui sintomas com as atividades ORDINÁRIAS (do cotidiano), ele é classificado com NYHA classe II. Resposta B.

183198.

Comentário: No paciente com cardiopatia hipertrófica com fração de ejeção preservada, ocorre um déficit de relaxamento e aumento das pressões de enchimento. O nosso objetivo é controlar o duplo produto, principalmente com controle de frequência cardíaca, visando a diminuição dos sintomas anginosos pelo consumo de O2 pelo miocárdio. Este efeito é alcançado através das drogas inotrópicas negativas como os betabloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, por serem mais cardiosseletivos. Das opções listadas, o verapamil é um bloqueador de canal de cálcio que possui excelente efeito inotrópico negativo. Resposta C.

159089.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Essa questão versa sobre os efeitos colaterais dos anti-hipertensivos. Vamos fazer um breve resumo do tema e associar as colunas para gabaritar a questão Diuréticos (como a hidroclorotiazida) hipopotassemia (ou hipocalemia), hipomagnesemia (que pode induzir arritmias ventriculares) e h iperuricemia . Betabloqueadores (como o propranolol) broncoespasmo , bradicardia excessiva (inferior a 50 bpm), distúrbios da condução atrioventricular, depressão miocárdica, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção sexual. Também podem acarretar intolerância à glicose, hipertrigliceridemia e redução do HDL-colesterol. Antagonistas do canal de cálcio (como o anlodipino) cefaleia , tontura, rubor facial e edema periférico . Inibidores da enzima conversora da angiotensina (como o captopril) tosse seca , alteração do paladar e reações de hipersensibilidade (erupção cutânea, edema angioneurótico). Em indivíduos com insuficiência renal crônica, podem induzir hiperpotassemia (hipercalemia). Em pacientes com hipertensão renovascular bilateral ou com rim único, podem promover redução da filtração glomerular com aumento dos níveis séricos de ureia e creatinina. Ao associarmos as colunas, temos a seguinte ordem 4 - 2 - 1 - 3. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Perceba que a questão parece difícil. Contudo, se o aluno não se desesperar e apenas lembrar que os betabloqueadores causam broncoespasmo, a questão fica fácil e o aluno é capaz de chegar rapidamente ao gabarito.

159119.

Comentário: A clortalidona possui como mecanismo de ação o aumento da excreção do sódio urinário e (como consequência), do potássio (A incorreta). Os diuréticos poupadores de potássio (ex. amilorida, espironolactona) tendem a aumentar a concentração sérica de magnésio a explicação é que, ao inibirem a reabsorção de sódio pelas células do túbulo coletor, o magnésio (que também é uma carga positiva), passa a ser reabsorvido em seu lugar (C incorreta). Por fim, a hidroclorotiazida tende a ser hiperglicemiante, sendo essa uma desvantagem do seu uso em pacientes diabéticos (D incorreta). Resposta B.

159122.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas I) Incorreta a principal causa de morte em pacientes

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hipertensos é o acidente vascular encefálico. O IAM é a segunda causa. II) Incorreta os agentes parenterais mais indicados nas emergências hipertensivas são a nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio intravenosos. III) Correta em pacientes com AVE isquêmico não candidatos à trombólise, a hipertensão arterial é benéfica até certo ponto, pois permite a perfusão adequada das zonas de penumbra isquêmica . Portanto, apenas a afirmativa III está correta. Resposta C.

159125.

Comentário: Vamos analisar as assertivas. A Incorreta. As emergências hipertensivas não devem ser tratadas ambulatorialmente, e quase sempre requerem drogas intravenosas. B Incorreta. Os nitratos devem ser utilizados com cautela nas síndromes coronarianas agudas (especialmente naquelas com isquemia do ventrículo direito), pelo risco de hipotensão severa e choque cardiogênico. C - Incorreta. O fármaco de escolha para controle pressórico na eclâmpsia é a hidralazina, pois não é maléfica ao feto. D Correta. A droga de primeira escolha na dissecção aórtica é o betabloqueador intravenoso, objetivando uma frequência cardíaca abaixo de 60 bpm. Caso a PA continue elevada após uso dessa droga, adiciona-se um vasodilatador, habitualmente o nitroprussiato de sódio, objetivando a PA próxima de 100-120 mmHg. É importante lembrar que o nitroprussiato não deve ser iniciado antes do controle da frequência cardíaca, pois seu efeito vasodilatador leva à taquicardia reflexa via simpática, aumentando o débito cardíaco e promovendo maior estresse na parede aórtica. Portanto, resposta letra D.

108798.

Comentário: Os indivíduos portadores de insuficiência cardíaca ou com fatores de risco para essa condição podem ser classificados nos grupos A (fatores de risco), B (doença estrutural assintomática), C (doença estrutural sintomática) e D (doença estrutural sintomática refratária ao tratamento). A partir do grupo B, já estão indicadas medicações redutoras da mortalidade, especialmente os inibidores da ECA (IECA) ou bloqueadores do receptores de angiotensina II (BRA) além dos betabloqueadores. Como as alternativas A e B estavam ambas corretas, já que contemplavam tais medicações, a questão foi anulada.

108801.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Já se foi o tempo dos BETABLOQUEADORES como medicação de primeira linha para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica nos hipertensos em geral (eles continuam sendo medicação de primeira linha somente na presença de ICFER ou doença coronariana). As medicações de primeira linha para o tratamento de hipertensos em geral são diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensina II e bloqueadores dos canais de cálcio (A errada). Recomenda-se avaliações semestrais nesses pacientes (B errada). O uso de ácido acetilsalicílico está formalmente indicado em pacientes com doença aterosclerótica sintomática (AVE ou IAM, por exemplo), como prevenção secundária. Como prevenção primária só está indicado num contexto específico, e não de forma generalizada para todos os hipertensos. A indicação atual é pacientes de ambos os sexos, com idade entre 50-69 anos e risco cardiovascular estimado 10% em 10 anos, na ausência de contraindicações ao AAS ou fatores de alto risco para sangramento, desde que o paciente se comprometa a manter a terapia por pelo menos 10 anos (C errada). A mudança do estilo de vida pode ser empregada como única medida para pacientes hipertensos de baixo e médio risco, inicialmente. Resposta D.

84507.

Comentário: Sempre que você atender, PELA PRIMEIRA VEZ, um paciente no seu consultório e o diagnosticar como portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, é mandatório solicitar um kit de exames básicos. Não é algo como um checkup , mas um conjunto de exames que têm - cada um deles - utilidades bem definidas nesse grupo de pacientes. Devemos lançar mão de exames que verifiquem a lesão de órgão-alvo (urina parcial, que mostraria proteinúria, ECG de repouso que mostraria sinais de cardiopatia hipertensiva e creatinina mostrando disfunção renal), exames para aferir o risco cardiovascular global do doente (glicemia em jejum colesterol total e frações) e potássio para termos uma base na hora de escolher drogas que modifiquem os níveis séricos de potássio (como os inibidores da enzima conversora da angiotensina). Resposta certa Letra D.

84549.

Comentário: Os antagonistas da aldosterona estão indicados nos pacientes com IC sintomática (estágio C), FE reduzida (30-35%) e classe funcional II a IV da NYHA. Os pacientes da classe II

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

devem ter histórico de internação prévia por motivo cardiovascular ou níveis elevados de BNP. Estas drogas também estão indicadas após IAM agudo em pacientes com FE 40%, sintomas de IC ou diabetes. Esta indicação é baseada principalmente em um grande estudo (RALES), publicado em 1999, com a espironolactona em baixa dose em pacientes com CF III ou IV houve redução de 35% nas hospitalizações e 30% no risco de morte por IC nos 2 primeiros anos de uso da droga. Mais recentemente, o estudo EMPHASIS-HF , comparou a eplerenona (25 mg dia) ao placebo para pacientes pouco sintomáticos (classe funcional II), porém, com disfunção sistólica importante (FE menor ou igual a 30%). Os resultados evidenciaram redução de 24% na mortalidade geral e 37% de redução nos eventos combinados, óbito cardiovascular e hospitalizações por IC. Como se pode observar, esses dados foram próximos aos obtidos com a espironolactona nos pacientes CF III-IV do clássico estudo RALES. Cumpre ressaltar que a espironolactona pode levar à retenção renal de K , logo, pacientes avaliados para seu uso devem ter K sérico 5 mEq L. Face ao exposto, apenas a assertiva E não corresponde a uma indicação da espironolactona em pacientes com IC.

84493.

Comentário: Vamos classificar os níveis pressóricos desse paciente De acordo com o VII Joint, ele pode ser classificado como pré-hipertenso e, de acordo com as antigas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, ele tem pressão arterial limítrofe (PAS entre 130 e 139 mmHg). De todo modo, seja qual for a classificação, sabemos que o seguimento é o mesmo medidas conservadoras como mudanças nos hábitos de vida, perda de peso (já que ele tem um sobrepeso e isto eleva a pressão arterial) e realização de atividade física, tudo isso com o objetivo de reduzir o risco cardiovascular global do nosso paciente. Resposta certa Letra C.

84505.

Comentário: Lembre-se do bordão aprendido no Medeletro a onda T acompanha o potássio . Se a onda T encontra-se achatada, principalmente quando há exacerbação da onda U, o diagnóstico hidroeletrolítico mais provável é a HIPOcalemia. Este paciente está sob risco imediato de morte súbita (por arritmias ventriculares malignas) e deve repor potássio intravenoso sem demora. Resposta certa C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

66967.

Comentário: A questão quer saber quais seriam, dessa lista, os efeitos adversos atribuíveis aos tiazídicos e betabloqueadores. A hipocalemia é comum aos diuréticos (de alça e tiazídicos), enquanto a hipovolemia é mais comum aos diuréticos de alça. A hiperuricemia é efeito adverso dos tiazídicos. Hipercalemia é mais comum no uso de IECA e BRA e, por fim, a tosse é um efeito possível do uso de IECA. Única resposta possível letra C.

50109.

Comentário: Hipertensão arterial gravíssima numa mulher jovem é um achado atípico que deve chamar a atenção do médico, ainda mais diante da presença de evidências clínicas de lesão em órgãos-alvo (ex. retinopatia hipertensiva). Quando o quadro de HAS é atípico - como é o caso das hipertensões exuberantes em pacientes jovens, com 30 anos - a probabilidade pré-teste de HAS secundária aumenta sobremaneira, sendo mandatório investigar causas identificáveis (e potencialmente curáveis e tratáveis) para a hipertensão. Nestes pacientes a história familiar de HAS não costuma ser importante, e não muda em nada a conduta diagnóstica. Sabemos que a principal causa de HAS secundária é a chamada HAS parenquimatosa renal, por doenças crônicas do parênquima dos rins. No entanto, a presença de 5-6 leucócitos por campo não configura uma piúria exuberante, como seria esperado nas nefrites intersticiais crônicas. Os anticoncepcionais orais aumentam o risco de HAS, mas, dificilmente por si mesmos, produziriam uma HAS tão grave quanto à desta paciente. Em mulheres jovens é imprescindível auscultar com cuidado a região dos flancos e abdome, à procura de sopros sistodiastólicos em topografia de artéria renal. Neste subgrupo, uma das causas mais frequentes de HAS secundária é a HAS renovascular por estenose de artéria renal decorrente da condição conhecida como displasia fibromuscular da média , que acomete preferencialmente os segmentos mais distais das artérias renais. Resposta certa D.

50118.

Comentário: No próprio enunciado da questão, o autor menciona que o paciente é hipertenso, dislipidêmico e portador de esteatose hepática, porém como tais diagnósticos estão presentes nas cinco alternativas, não nos ajudou em nada. O mesmo paciente apresenta um IMC de 37 kg m², o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

que o classifica como um obeso tipo II (IMC entre 35 e 39,9 kg m²). Quando analisamos os dados laboratoriais do paciente nos deparamos com uma glicemia de jejum de 128 mg dl e uma hemoglobina glicada de 7,6%, o que o torna portador de diabetes. Mas você pode se perguntar Não é necessário repetir o teste para determinar o diagnóstico de diabetes . Se apenas um teste tivesse sido solicitado, realmente deveríamos repeti-lo contudo, quando dois testes diferentes são solicitados ao mesmo tempo, e ambos são concordantes para o diagnóstico, nenhum exame adicional é necessário. E para finalizar um paciente obeso, hipertenso, com um triglicerídeo 150 mg dl, com um HDL-c 50 mg dl e com uma glicemia de jejum ou igual a 100 mg dl, pode ser considerado como portador de síndrome metabólica. Alternativa C correta.

50120.

Comentário: De acordo com o estudo UKPDS, a única droga que reduziu o risco de eventos cardiovasculares ateroscleróticos em diabéticos obesos foi a metformina (pertencente ao grupo das biguanidas). Sua ação ocorre através de 3 mecanismos principais 1) inibição da gliconeogênese hepática, principal responsável pela hiperglicemia de jejum 2) melhora da sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina 3) redução do turnover de glicose a nível esplâncnico. O aumento da secreção de insulina ocorre com uso de fármacos como as sulfonilureias e as gliptinas, enquanto que a acarbose leva à redução da absorção intestinal de glicose. Já a redução da secreção pancreática de glucagon é observada com uso dos análogos do GLP-1 e dos inibidores da dipeptil peptidase IV. Resposta certa A.

50123.

Comentário: Relembre a classificação evolutiva da insuficiência cardíaca conforme proposto pela American Heart Association (AHA). Resposta certa B.

50100.

Comentário: Toda criança ou adolescente com níveis pressóricos acima do percentil 90 (para a faixa etária, sexo e altura) deve receber tratamento não medicamentoso. No caso em tela, seriam importantes algumas mudanças no estilo de vida , como dieta atividades físicas, a fim de reduzir o sobrepeso. Se a PA continuar elevada, devemos iniciar uma investigação para causas secundárias

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(lembrando que a principal etiologia da HAS secundária é renal) e considerar o pronto início de tratamento farmacológico anti-hipertensivo. Não há estudos suficientes a respeito do uso de anti-hipertensivos na infância adolescência, e a escolha dessas drogas segue os mesmos preceitos dos adultos. Contudo, é interessante citar uma exceção à regra adolescentes do sexo feminino possuem contraindicação relativa aos IECA e BRA, devido à possibilidade de gravidez indesejada e os consideráveis riscos dessas drogas para o feto. Perceba, então, que não há uma resposta adequada aqui (nenhuma fala das MEV). O gabarito da banca foi a letra D.

50094.

Comentário: Segundo o Nelson (Tratado de Pediatria), a insuficiência cardíaca em crianças sempre cursa com algum grau de hepatomegalia (não raro com esplenomegalia associada). Taquicardia e taquipneia são sinais bastante frequentes tanto no adulto quanto na criança. Oligúria, hipotensão arterial e enchimento capilar lentificado são sinais, na verdade, de choque cardiogênico, um estágio mais grave e avançado da IC. A cardiomegalia, por outro lado, é extremamente comum na IC sistólica, sendo encontrada com grande frequência nas crianças portadoras desta condição. Resposta certa C.

37073.

Comentário: As emergências hipertensivas se caracterizam por elevações súbitas e acentuadas da pressão arterial, levando a lesões de órgãos-alvo que ameaçam a vida do paciente. Dentre as opções fornecidas, apenas a opção C se encaixa, já que se trata de um provável quadro de dissecção de aorta com dor torácica e diminuição de pulso nos membros, evidenciando dissecção até ramos mais periféricos como subclávia e ilíacas. A opção é uma pseudocrise motivada por estresse emocional a B um caso de GNPE a D e E possivelmente hipertensão não controlada adequadamente. Resposta C.

37087.

Comentário: A hipertensão acelerada maligna constitui uma emergência hipertensiva caracterizada pela associação de lesão renal aguda associada a graves alterações no fundo de olho como o papiledema (retinopatia grau IV). Resposta D.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37105.

Comentário: Definimos sopro inocente como o sopro cardíaco percebido durante o exame físico, porém, não associado a qualquer anormalidade anatômica ou funcional cardíaca. O sopro inocente é extremamente comum na criança, em geral desaparecendo com o avançar da idade. Na maioria dos casos pediátricos ele é atribuído ao turbilhonamento do sangue quando da passagem pelo trato de saída do VD. As principais características do sopro inocente da criança são (1) ter baixa intensidade (1 ou 2) (2) ser mesossistólico (3) não estar acompanhado de outras alterações semiológicas e (4) reduzir ou desaparecer com manobras que reduzem o retorno venoso ao coração (ex. Valsalva, passar da posição supina para a posição ortostática). A classificação de Levine é a mais utilizada na prática para estimar a intensidade do sopro vai de grau I (mínimo) a grau VI (intenso). A partir do grau III o sopro é acompanhado de frêmito (sensação tátil do turbilhonamento sanguíneo) e, de um modo geral, tal achado basicamente descarta a possibilidade de sopro inocente (merecendo investigação cardiológica complementar ao exame físico). Assim, resposta certa E.

37106.

Comentário: Em crianças, sobretudo nos lactentes, é mais difícil realizar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Os sintomas podem até se apresentar da forma clássica, mas as manifestações mais comuns são a taquipneia com sibilância, taquicardia, dificuldade no aleitamento, déficit no crescimento, irritabilidade, choro fraco, retrações subcostais e batimentos de asa de nariz. Manifestações congestivas como edema, turgência jugular patológica e hepatomegalia são menos comuns, mais quando encontradas são bem específicas para o diagnóstico. Os exames que mais frequentemente auxiliam o diagnóstico são a radiografia de tórax e o ecocardiograma. O ECG pode mostrar alterações, mas nenhuma se mostra de forma específica nessa idade. Assim, podemos concluir que a letra B constitui a melhor opção, sendo o gabarito divulgado pelo concurso.

37107.

Comentário: Assim como nos adultos a IC da criança é caracterizada por hipoperfusão tissular e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pode ser classificada de diversas maneiras, inclusive em alto e baixo débito. Em lactentes, as manifestações mais comuns costumam ser a irritabilidade, a taquipneia com sibilância, a taquicardia e o déficit de crescimento, sendo as manifestações congestivas, como edema, menos comuns. O principal exame que auxilia o diagnóstico é a radiografia de tórax, que frequentemente revela a cardiomegalia. O ecocardiograma pode elucidar tanto o diagnóstico quanto as possíveis malformações associadas, além de fornecer dados prognósticos. Dessa forma, podemos notar que a alternativa B está errada, configurando a resposta da questão.

29354.

Comentário: Vamos analisar as alternativas... A CORRETA A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é a condição na qual o coração é incapaz de garantir o débito cardíaco adequado para as necessidades metabólicas do organismo, ou quando o só o faz à custa do aumento de suas pressões de enchimento. B CORRETA Os principais sinais e sintomas de ICC na infância são aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca e aumento do fígado. Lactentes pequenos raramente desenvolvem edema periférico, pois ficam a maior parte do tempo deitados, e por isso, o pediatra deve sempre verificar edema em dorso e edema peripalpebral. A alternativa C também está CORRETA e é autoexplicativa... Portanto, ficamos com a alternativa D (todas as anteriores corretas) como resposta.

29340.

Comentário: A HAS de início fora da faixa etária típica (isto é, antes dos 30 anos ou após 55 anos) é um critério bem estabelecido para a suspeita de HAS secundária Outros dados que sugerem hipertensão arterial secundária são hipertensão grave em brancos hipertensão refratária hipertensão acelerada maligna sopro abdominal (sugere estenose de artéria renal) hipocalemia hipertensão lábil com episódios de taquicardia, tremores e sudorese (sugere feocromocitoma) sinais de endocrinopatia (estigmas de cushing, sinais de hipertireoidismo, etc) insuficiência renal piora da função renal com IECA (sugere estenose da artéria renal bilateral) proteinúria persistente inexplicada e redução ou ausência de pulso femoral (sugere coarctação da aorta). A Síndrome Metabólica se associa com a hipertensão primária ou essencial... Resposta Letra E.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

369529.

Comentário: Considerando o diagnóstico de insuficiência aórtica , sabemos que quando a lesão é grave e acompanhada de repercussões sobre a função cardíaca (disfunção sistólica do ventrículo esquerdo), o tratamento de escolha é cirúrgico, devendo ser feito com substituição da valva doente. O reparo valvar não é padrão, e não deve ser indicado diante de franca insuficiência cardíaca... O tipo de prótese preferencial para pacientes jovens (55 anos) é a valva metálica , devido a sua maior durabilidade. Resposta substituição valvar aórtica por prótese mecânica .

343162.

Comentário: De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes a respeito do Tratamento da hiperglicemia em pacientes com DM2 e insuficiência cardíaca, o advento dos inibidores da proteína co-transportadora SGLT2 (ISGLT2) inaugurou uma nova era no tratamento da IC em pessoas com diabetes. Estudos como o EMPAREG OUTCOME, DECLARE e CANVAS mostraram que, além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular . Resposta letra A.

343163.

Comentário: De acordo com o Posicionamento Brasileiro sobre Hipertensão Arterial Resistente (2020), O comprometimento cerebrovascular na hipertensão arterial resistente (HAR) ocorre de maneira sutil e insidiosa. Lesões microscópicas da substância branca têm início precoce e podem evoluir de modo irreversível, promovendo déficit cognitivo e progressão para demência vascular. Pacientes com HAR têm maior risco de infarto cerebral e isquemia cerebral transitória, fato apontado pelos estudos que mostram um aumento de risco de 17 e 14%, respectivamente. Aterosclerose carotídea e dos pequenos vasos cerebrais são responsáveis por fenômenos isquêmicos e tromboembólicos. A oclusão de artéria retiniana é um marcador de lesão de pequenos vasos e tem sido associada a maior risco de evento cerebral . Resposta letra B.

313427.

Comentário: De acordo com a Diretriz Brasileira de HAS (2020) Os IECA e outros bloqueadores do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sistema reninaangiotensina-aldosterona (SRAA) podem provocar hiperpotassemia em pacientes com insuficiência renal, sobretudo nos diabéticos, e o uso e contraindicado na gravidez, pelo risco de complicações fetais. Por isso, seu emprego deve ser cauteloso e frequentemente monitorado em adolescentes e mulheres em idade fértil. A resposta é, portanto, a opção D.

313429.

Comentário: Questão baseada em um trecho da diretriz brasileira de hipertensão arterial. Vamos a ele Os BRA antagonizam a ação da angiotensina II pelo bloqueio específico dos receptores AT1, responsáveis pelas ações próprias da angiotensina II (vasoconstrição, estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona). No tratamento da hipertensão arterial, especialmente em populações de alto risco cardiovascular ou com comorbidades, proporcionam a redução da morbidade e da mortalidade . Resposta letra B.

313431.

Comentário: O mecanismo de edema provocado por bloqueadores de canal de cálcio envolve redistribuição de fluido do espaço intravascular para o interstício. Em teoria, a vasodilatação mediada por bloqueadores do canal de cálcio (principalmente os di-hidropiridínicos) aumenta a permeabilidade capilar e, por conseguinte, a formação de edema (o fenômeno ocorre principalmente no território arterial). Tal efeito aparenta ser dose-dependente (2-3 vezes maior quando empregamos altas doses). Curiosamente, o edema pode motivar a prescrição de diuréticos, o que não resolve o quadro e pode ser até nocivo para um paciente sem sinais de hipervolemia. Por outro lado, inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona podem reduzir a incidência e a gravidade deste edema por um mecanismo mediado por venodilatação. Resposta letra A.

313434.

Comentário: Dentre os efeitos adversos causados pelos bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão, o edema maleolar costuma ser o mais registrado e resulta da própria ação vasodilatadora (mais arterial que venosa), promovendo a transudação capilar. A cefaleia latejante e as tonturas são comuns. O rubor facial é mais comum com os BCC di-hidropiridínicos de ação rápida. A hipercromia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hipertrofia gengival são efeitos adversos ocasionais. Os efeitos adversos costumam ser dose-dependentes, podem causar intolerância aos BCC di-hidropiridínicos e, às vezes, resultam em resistência ao tratamento. Nesses casos, pode ser testada a utilização de BCC lipofílicos (manidipino, lercanidipino, lacidipino) ou o levanlodipino em baixas doses. A verapamila e o diltiazem podem agravar a IC, além de causar bradicardia e bloqueio atrioventricular. Observa-se a obstipação intestinal com a verapamila. Resposta letra C.

314209.

Comentário: Emergência hipertensiva é uma situação em que o aumento da pressão arterial ameaça de imediato a vida do paciente, cursando com lesões de órgão-alvo agudas e progressivas. A PA deve ser reduzida em minutos ou poucas horas com drogas parenterais, tais como nitroprussiato de sódio (vasodilatador arterial e venoso), nitroglicerina (vasodilatador arterial e venoso), hidralazina (vasodilatador de ação direta), metoprolol (bloqueador beta-adrenérgico seletivo), esmolol (bloqueador beta-adrenérgico seletivo de ação ultrarrápida), furosemida (diurético de alça) e fentolamina (bloqueador alfa-adrenérgico). Das medicações listadas, o nitroprussiato de sódio é a mais emblemática da emergência hipertensiva Isso porque ele possui meia-vida curta, com início de ação imediato. Melhor resposta letra B.

278073.

Comentário: Questão baseada, integralmente, no Posicionamento Brasileiro sobre Hipertensão Arterial Resistente 2020. Vamos, então, revisar o trecho que respondia questão Deve ser observada a possibilidade de ocorrer efeito do avental branco, fenômeno que envolve duas situações. A primeira é a hipertensão do avental branco, quando a PA está elevada em medidas isoladas no consultório e normais no MAPA (monitoramento ambulatorial da pressão arterial) ou no MRPA. A segunda situação é o efeito do avental branco, caracterizado por PA de consultório elevada em relação à média de pressão de vigília no MAPA ou à média semanal do MRPA (monitoramento residencial da pressão arterial), sem haver alteração do diagnóstico, seja de hipertensão ou normotensão. Essas duas situações podem levar ao falso diagnóstico de HAR, acarretando a realização de exames e o uso de medicação de modo desnecessário. É possível

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

referir-se à hipertensão do avental branco como uma causa de hipertensão arterial pseudorresistente . Resposta letra A.

280393.

Comentário: Questão baseada, integralmente, no Posicionamento Brasileiro sobre Hipertensão Arterial Resistente 2020. Vamos, então, revisar o trecho que respondia questão Uma vez afastada a pseudorresistência, confirma-se a existência da HAR (hipertensão arterial resistente) e inicia-se uma investigação diagnóstica com exames específicos, conforme a orientação das Diretrizes de Hipertensão em relação ao comprometimento de lesões em órgãos-alvo e hipertensão secundária. A ocorrência de comorbidades associadas deve ser detectada com exames especializados de acordo com a suspeita clínica. Resposta letra C.

275968.

Comentário: Vamos avaliar as alternativas (A) Incorreta. A HAS é definida por valores de PA 140 x 90 mmHg. Anexamos ao comentário o estadiamento da HAS, segundo a diretriz. (B) Correta. A estenose de artéria renal é causa clássica de HAS secundária (a mais comum é a doença renal parenquimatosa) Com a redução do lúmen do vaso, menos sangue chega ao glomérulo, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembre-se que a angiotensina II é uma substância que promove vasoconstrição, aumentando a PA. (C) Incorreta. A PA sistólica é compatível com PA normal e a diastólica, com pré-HAS (85-89 mmHg). De 80 a 84 mmHg, o paciente é considerado portador de PA normal. Portanto, pelo intervalo apresentado, não dá para dizer que é pré-HAS. (D) Incorreta. As medidas não farmacológicas devem ser iniciadas já na pré-HAS e são fundamentais para o controle pressórico do paciente. Resposta (B).

280394.

Comentário: Questão baseada, integralmente, na Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias 2020. Vamos, então, revisar o trecho que respondia questão O acompanhamento clínico do paciente, enquanto apresentar valvopatia anatomicamente não importante é realizado com consultas e reavaliações ecocardiográficas periódicas (anexo) . No paciente com EM (estenose mitral) não importante, reavaliações podem ser realizadas a cada 1 ano. Não é esperado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

rotineiramente que pacientes com área valvar 1,5 cm² desenvolvam sintomas ou complicadores. No caso de surgimento destas alterações, antes que o paciente desenvolva valvopatia anatomicamente importante, é imperativo considerar a possibilidade de que outros diagnósticos diferenciais sejam responsáveis pelas mesmas. O paciente com EM importante, por sua vez, deverá ser reavaliado em intervalos menores de tempo, habitualmente a cada 6 a 12 meses. Resposta letra A.

278075.

Comentário: Questão baseada, integralmente, no Posicionamento Brasileiro sobre Hipertensão Arterial Resistente 2020. Vamos, então, revisar o trecho que respondia questão A hipertensão arterial resistente (HAR) é definida quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três anti-hipertensivos de diferentes classes , incluindo um bloqueador do sistema renina-angiotensina (IECA ou BRA), um bloqueador dos canais de cálcio (BCC) de ação prolongada e um diurético tiazídico (DT) de longa ação em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão. Resposta letra B.

280396.

Comentário: Questão baseada, integralmente, na Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias 2020. Vamos, então, revisar o trecho que respondia questão Avaliação de Risco Operatório A indicação da intervenção nos pacientes valvares deve ser sempre baseada na comparação do benefício e do provável risco do procedimento proposto. Para tal fim, alguns escores online são utilizados, dentre eles o EuroSCORE II (http www.euroscore.org calc.html) e o STS (Society of Thoracic Surgeons, http riskcalc.sts.org stswebriskcalc calculate), validados em diferentes populações, com capacidade preditiva de mortalidade em 30 dias. Pacientes com STS 4% são convencionalmente considerados de baixo risco cirúrgico, enquanto aqueles com escore entre 4-8% têm risco intermediário e aqueles com escore 8% tem alto risco. Em relação ao EuroSCORE II, quando menor que 4% o paciente é considerado de baixo risco e, se escore 4%, risco aumentado. Caso ocorra discrepância entre os escores, devemos utilizar aquele cujo risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

estimado foi maior.3 8 Importante ressaltar que ambos os escores não incluem alguns fatores relacionados a desfechos prognósticos, como fragilidade e contraindicações específicas aos procedimentos, como, por exemplo, aorta em porcelana. Além disso, a avaliação do risco não substitui a impressão da avaliação clínica individual e a decisão da intervenção deve ser sempre compartilhada com paciente e familiares . Resposta letra B.

280398.

Comentário: Questão baseada, integralmente, na Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias 2020. Vamos, então, revisar o trecho que respondia questão A ecocardiografia é o principal exame complementar para a avaliação anatômica da valva mitral, sendo fundamental para a definição da gravidade da valvopatia, das repercussões hemodinâmicas e dos parâmetros que estão relacionados à chance de sucesso das intervenções, com avaliação individualizada de cada componente da valva (anel valvar, cúspides valvares, aparato subvalvar) . Resposta letra D.

278610.

Comentário: Questão sem muita criatividade, integralmente, retirada do Posicionamento Luso-Brasileiro de Emergências Hipertensivas 2020. Vamos, então, revisar um trecho do documento que respondia a questão Avaliação Clínica e Laboratorial Durante a abordagem da EH, o profissional deverá realizar a diferenciação entre emergência e urgência, fazendo o diagnóstico correto das diversas situações de EH, a fim de selecionar a terapia mais adequada para cada LOA (lesão de órgão-alvo). Isso é muito importante, pois o diagnóstico e o tratamento corretos podem evitar agravamento do quadro clínico decorrente da situação crítica . Resposta letra A.

278611.

Comentário: Questão sem criatividade extraída do Posicionamento Brasileiro sobre Hipertensão Arterial Resistente (2020) . De fato, a proteína C reativa (PCR) elevada é considerada preditora independente de doença coronariana e cerebrovascular, sendo um biomarcador mais importante para hipertensos resistentes mais JOVENS, obesos, com MAPA não controlado e padrão NÃO dipper , ou seja, sem descenso noturno. Resposta D.

278613.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Segundo o Posicionamento Luso-Brasileiro de Emergências Hipertensivas, publicado em 2020, o fármaco anti-hipertensivo ideal para uso parenteral deve apresentar as seguintes características capacidade de reverter alterações fisiopatológicas envolvidas, rápido início de ação, curva dose-resposta previsível, mínimo ajuste de dosagem, alta seletividade, não promover elevação da PIC, pronta reversibilidade, baixo risco de promover hipotensão arterial, fácil substituição por fármacos para uso oral e satisfatória relação custo-benefício. Resposta letra C.

280403.

Comentário: Essa questão foi retirada da Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias de 2020. Veja só o trecho presente no tópico sobre insuficiência mitral primária crônica Os pacientes com IM anatomicamente discreta ou moderada deverão ser mantidos em acompanhamento clínico e ecocardiográfico periódicos, sem indicação de intervenção (medicamentosa ou cirúrgica) para interrupção da história natural da doença valvar. Por outro lado, pacientes com IM importante devem prosseguir no fluxograma de avaliação específica, buscando-se sintomas secundários à valvopatia e ou presença de complicadores. Resposta letra D.

278086.

Comentário: Questão baseada, integralmente, no Posicionamento Brasileiro sobre Hipertensão Arterial Resistente 2020. Vamos, então, revisar o trecho que respondia questão Assim, HAR-NC (hipertensão arterial resistente não controlada) é definida como uma PA que permanece acima do nível desejado (140 90 mmHg), apesar do uso concomitante de quatro ou mais agentes anti-hipertensivos de diferentes classes e um quarto fármaco, que geralmente é um antagonista do receptor mineralocorticoide ou um bloqueador simpático central . Resposta letra C.

279037.

Comentário: Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Chagas, no tópico tratamento etiológico da doença de Chagar na fase crônica Para pessoas com cardiopatia chagásica em fase inicial, por exemplo, que apresentam somente alterações no eletrocardiograma (ECG), com fração de ejeção (FE) normal, ausência de insuficiência cardíaca (IC) e ausência de arritmias graves, tanto o tratamento quanto não tratar com benznidazol são alternativas válidas. A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

decisão deve ser compartilhada, ou seja, é necessário envolver a pessoa afetada no processo de tomada de decisão, apresentando os potenciais benefícios e riscos, assim como as incertezas a respeito da efetividade do tratamento. Resposta letra C.

278634.

Comentário: Esta é uma questão que em uma primeira leitura parece difícil, entretanto, é questionado qual o principal fator de risco associado a síndrome de apneia obstrutiva do sono em crianças com doenças neuromusculares ou neurológicas. Todas as alternativas apresentam fatores que podem estar relacionados a apneia obstrutiva do sono em crianças, entretanto, as doenças neurológicas e neuromusculares acabam levando ao desenvolvimento da síndrome quando causam hipotonia da musculatura da faringe e laringe levando muitas vezes a desabamento posterior da base da língua e oclusão da entrada da via aérea ou até mesmo com parada do drive respiratório por alterações centrais relacionadas ao ciclo ventilatório causadas pela doença de base. Alterações anatômicas, inclusive de partes moles como as tonsilas palatinas, faríngeas (adenoide) ou mesmo as amígdalas também podem levar a apneia obstrutiva do sono em crianças mas não tem correlação direta com doenças neurovasculares ou neurológicas. Gabarito D

280464.

Comentário: Questão retirada diretamente da Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular, publicada em 2020 Segundo o texto, as principais atuações do Médico-Líder na equipe de reabilitação são -Executar a avaliação pré-participação, com inclusão de testes de exercício, de modo a subsidiar a programação inicial das sessões de treinamento da RCV -Treinar a equipe para identificar situações de risco e realizar o atendimento apropriado em situações emergenciais -Estabelecer restrições e limites para a prescrição dos exercícios físicos -Liderar e interagir com os demais membros da equipe, com o objetivo de otimizar a qualidade e a segurança da prescrição dos exercícios físicos -Programar reavaliações subsequentes, sempre interagindo com o médico assistente. A questão utilizou apenas o texto do primeiro item, na íntegra, mantendo inalterada apenas a alternativa A. Resposta letra A

249381.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão que foi anulada por um erro de digitação do enunciado. O correto era não podemos apenas indicar como ADEQUADO que . Entretanto, vamos fingir que não houve esse erro. Essa questão foi retirada da 6ª DIRETRIZES DE MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL E 4ª DIRETRIZES DE MONITORIZAÇÃO RESIDENCIAL DA PRESSÃO ARTERIAL. Nesse documento há um trecho que diz o seguinte As variações dia a dia da PA podem ser avaliadas, (letra A - CORRETA) permitindo estabelecer separadamente as medidas do período matinal e do entardecer anoitecer, (letra B - CORRETA) porém a importância dessa diferenciação ainda não é clara. A associação de dano em órgão-alvo com a PA durante o entardecer anoitecer da MRPA pode ser equivalente à PA durante o sono da MAPA. (letra D - CORRETA) A PA matinal pode estar associada a dano em órgão-alvo como AVE . (letra C - INCORRETA) Resposta seria a letra C, mas por causa do erro do enunciado a questão foi anulada.

249285.

Comentário: Aproveitar a questão para fazer uma revisão sobre a a hipotensão ortostática que corresponde a um dos achados clínicos na neuropatia autonômica do diabetes. Os sintomas associados com hipotensão ortostática incluem sensação de cabeça muito leve, fraqueza, desmaio, vertigem, alterações visuais, e em casos mais graves, síncope ao ficar em posição ortostática. Estes sintomas podem ser agravados por muitos medicamentos que são prescritos para pacientes com diabetes tais como vasodilatadores, diuréticos, insulina (através de vasodilatação endotélio-dependente) e anti-depressivos tricíclicos, uma classe de drogas comumente usada para o alívio sintomático da dor associada com a neuropatia diabética dolorosa. A hipotensão ortostática é definida como uma redução da PA sistólica de pelo menos 20 mmHg ou PA diastólica de pelo menos 10 mmHg em 1 a 3 min após assumir a posição ortostática. No diabetes, hipotensão ortostática ocorre frequentemente como consequência de desnervação simpática vasomotora eferente, causando redução da vasoconstrição do leito vascular esplâncnico e periférico. Resposta letra C.

249290.

Comentário: Nas crianças, a Síndrome da Apneia Obstrutiva do SONO (SAOS) é caracterizada por

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

episódios recorrentes de obstrução parcial ou completa das vias aéreas superiores durante o sono. Caracteriza-se por um continuum que vai desde o ronco primário, que pode levar a alterações neurocognitivas em alguns casos, passando por resistência aumentada das vias aéreas, hipoventilação obstrutiva e, finalmente, SAOS. A prevalência de ronco é elevada e, dependendo da forma como ele é definido, varia entre 1,5% e 15%. O diagnóstico da SAOS, combinando questionários de relatos dos pais e exames complementares, apresenta uma prevalência de 1-4%. A SAOS é mais frequente nos meninos, nas crianças com sobrepeso, de ascendência africana, com história de atopia e prematuridade. Ronco alto e frequente, apneias observadas pelos familiares e sono agitado são os sintomas mais frequentes. O exame físico deve identificar a situação ponderostatural do paciente, avaliar evidências de obstrução crônica das vias aéreas superiores e ainda verificar a presença de alterações craniofaciais. A polissonografia de noite inteira é o exame padrão tanto para o diagnóstico, como para a definição da pressão necessária em equipamentos de pressão positiva e também para a avaliação do tratamento cirúrgico. A hipóxia intermitente e os múltiplos despertares resultantes dos eventos obstrutivos contribuem para as consequências cardiovasculares, neurocognitivas e comportamentais bem descritos nesses pacientes. Melhor resposta letra B.

249210.

Comentário: Sabemos que as adenotonsilectomias geralmente são feitas de forma ambulatorial, exceto em crianças menores de 2 a 3 anos e crianças que possuem comorbidades. Não há contraindicação do procedimento em menores de 2 anos e obesos. Ela possui indicações específicas e não deve ser sempre indicada. Na síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) a cirurgia está indicada quando a criança apresenta retardo no crescimento, rendimento escolar insuficiente, enurese ou outras alterações no comportamento. Estudos observacionais demonstram que a adenotonsilectomia nas crianças com hiperplasia adenotonsilar e polissonografia anormal melhora a qualidade de vida, o padrão de sono, a transição noite e dia e previne ou melhora comorbidades como atraso no crescimento e rendimento escolar pobre. No entanto, a recorrência da obstrução pode ocorrer e a criança pode não apresentar melhora da apneia. Resposta letra C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215470.

Comentário: Questão sem nenhuma criatividade Afinal, foi retirada, na íntegra, das 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Vamos, então, relembrar o trecho que respondia a questão Elevação matinal precoce da PA - calculada pela diferença entre a PAS matinal (média das pressões nas primeiras duas horas após o despertar) e a menor PAS durante o sono (média da pressão mais baixa e das pressões imediatamente antes e após a mais baixa) - tem sido associada a desfechos cardiovasculares. A dificuldade da padronização do cálculo desse parâmetro e a sua baixa reprodutibilidade indicam que ele não deve ser usado na prática clínica . Resposta letra B.

215485.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, das 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Vamos, então, relembrar o trecho que respondia a questão A variabilidade extraída a partir das diferenças de cada medida é denominada variabilidade de curto período. Metanálise com 11 estudos identificou uma associação positiva entre mortalidade e variabilidade sistólica diurna de curto período. Diante de tais resultados, a redução da variabilidade da PA poderia ter implicações terapêuticas independentemente da redução das médias de PA. No entanto, a falta de padronização dos diferentes índices descritos para essa avaliação de curto período, seu real significado incremental na estratificação de risco e a ausência de pontos de corte para normalidade não permitem que esse parâmetro seja, no momento, utilizado na interpretação da MAPA . Resposta letra B.

215494.

Comentário: Questão da prática diária no manejo da Insuficiência cardíaca e uso de Ventilação mecânica. Ótima para revisarmos, pois a banca pede a alternativa incorreta. Vamos às alternativas A- INCORRETA. A ventilação INVASIVA no IAM Killip III com Edema agudo pulmonar não reduz MORTALIDADE e sim melhora a SINTOMATOLOGIA. As outras alternativas estão corretas e vale a revisão. Gabarito LETRA A.

215230.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: No cenário da IC avançada, a classificação clínica dos pacientes pela NYHA , de fato não mais possibilita adequada seleção dos pacientes que se beneficiarão de terapias medicamentosas, cardiodesfibriladores implantáveis, ressincronizadores ventriculares, transplante cardíaco ou dispositivos de assistência circulatória mecânica (DACM). Na verdade, os pacientes que permanecem sintomáticos, apesar de toda terapia otimizada disponível, devem ser classificados de modo diferenciado idealmente pelos perfis propostos pelo Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support (INTERMACS) I Choque cardiogênico grave (intervenção em horas) II Declínio progressivo apesar do inotrópico (intervenção em dias) III Estável às custas de inotrópico (intervenção em semanas a meses) IV Internações frequentes (intervenção em semanas a meses) V Em casa, intolerante aos esforços (intervenção de urgência variável, dependente do estado nutricional e do grau de disfunção orgânica) VI Limitação aos esforços (intervenção de urgência variável, dependente do estado nutricional e do grau de disfunção orgânica) VII NIHA III (sem indicação de intervenção) Resposta certa LETRA D.

215503.

Comentário: Questão de farmacologia no R1. A banca quer saber quais são os efeitos colaterais principais do opioide usado no Edema Agudo Pulmonar, no caso, a morfina principalmente. Vamos relembrar alguns deles Depressão respiratória mediada pelos receptores MOP localizados no centro respiratório do tronco cerebral Nauseas e Vômitos devido ativação de receptores opióides localizados na zona quimiorreceptora de gatilho do vômito Bradicardia bradicardia pela redução do tônus simpático e efeito direto sobre o nó sinoatrial Hipotensão pela vasodilatação venosa e redução da pré-carga causada pela liberação de histamina e redução do tônus simpático Prurido devido liberação de histamina. Por isso a resposta é a LETRA C.

215510.

Comentário: Questão retirada, na íntegra, das 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e 4ª Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Vamos, então, relembrar o trecho que respondia a questão As cargas de pressões (na MAPA) expressam a percentagem de medidas acima dos valores de normalidade para as 24 horas, vigília e sono.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Avaliação prospectiva em estudo populacional não indica que esse parâmetro possa modificar a estratificação de risco fornecida pelas médias de PA . Apenas um detalhe A questão merecia recurso, pois não deixa claro se é para marcar correta ou a incorreta. Resposta letra D.

215517.

Comentário: Questão maldosa sobre INSUFICIÊNCIA CARDÍACA(IC) e Edema agudo pulmonar(EAP), pois a banca pede para marcar a INCORRETA. Percebam que na alternativa C, tudo está correto, exceto pela palavra não . Pacientes com IC crônica agudizada, em geral podem apresentar função global e tendência hipotensão, com quadros de EAP de baixo débito. As demais alternativas estão corretas e valem a revisão. Resposta LETRA C.

216305.

Comentário: O autor da questão pegou um trecho da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca e reproduziu em todas as opções, mudando algum detalhe. No paciente séptico, pode haver flutuações de PA que levam ao prejuízo na avaliação de parâmetros ecocardiográficos. Por exemplo, os exames speckle tracking com strain longitudinal ventricular são mais sensíveis em detectar disfunção miocárdica subclínica do que as medidas da função sistólica global, uma vez que avaliam o grau de deformidade miocárdica. Questão bastante difícil e específica. Resposta C.

215242.

Comentário: Diante de um caso de insuficiência cardíaca crônica, a solicitação de alguns exames complementares é fundamental. Em primeiro lugar, devemos ter um ecocardiograma de base (até mesmo para poder diagnosticar a condição). Além disso, também são importantes ECG (exame barato e não-invasivo), radiografia de tórax, função renal, lipidograma, eletrólitos, hemograma, glicemia, entre outros. Eles servem para avaliar o paciente como um todo (não devemos focar nossa atenção apenas no coração - outras comorbidades podem prejudicar de forma significativa o prognóstico da doença) - opção (A) incorreta e opções (B) e (C) corretas. Além disso, alguns deles, especialmente os eletrólitos e a função renal, são importantes para o monitoramento de efeitos colaterais de certas drogas (diuréticos, inibidores da ECA, entre outros) - opção (D) correta. Resposta a ser marcada LETRA A.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

215525.

Comentário: Questão com um enunciado um pouco confuso, mas que simplesmente fala sobre o manejo clínico da insuficiência cardíaca com congestão pulmonar. Analisando as opções No edema agudo pulmonar, o objetivo principal é, de fato, desencharcar o pulmão, redistribuindo o líquido para a circulação periférica (A correta). Vasodilatadores para facilitar a migração do líquido para circulação periférica, diuréticos para espoliar volume em excesso e suporte ventilatório não invasivo com pressão positiva, são as principais medidas empregadas no manejo deste quadro (B e C corretas). A presença de hipotensão, sabidamente, é uma contraindicação relativa à realização de CPAP, pois o aumento da pressão positiva, reduz o retorno venoso, débito cardíaco e consequentemente, a pressão arterial (D incorreta). Resposta D.

215532.

Comentário: Questão sobre INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÔNICA interessante. A banca pede para marcar a alternativa INCORRETA, vamos analisar A- INCORRETA. NA IC crônica devemos lembrar que o sistema já se acostumou com hipervolemia, de forma que o sistema linfática pulmonar encontra-se vasodilatado e consegue drenar boa parte da congestão pulmonar. Isso explica o porquê de alguns casos de IC crônica agudizada não se apresentarem com EDEMA AGUDO DE PULMÃO, mas sim com congestão sistêmica. As demais alternativas estão corretas e vale a pena a revisão. Resposta certa LETRA A.

215249.

Comentário: Questão extraída na íntegra da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (2018). Vamos ler o trecho de referência A realização de Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações é recomendada na avaliação inicial de todos os pacientes com IC, para avaliar sinais de cardiopatia estrutural como hipertrofia ventricular esquerda, isquemia miocárdica, áreas de fibrose (letra B correta), distúrbios da condução atrioventricular, bradicardia ou taquiarritmias, que podem demandar cuidados e tratamentos específicos (letra D correta). Vários destes aspectos são marcadores prognósticos em muitas cardiopatias, como na chagásica crônica (letra A correta). A detecção de Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE), com alargamento pronunciado da duração do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

complexo QRS, auxilia na indicação da Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) letra C incorreta . Portanto, a única assertiva incorreta e gabarito da questão é a letra C.

215255.

Comentário: Mais uma questão deste concurso extraída da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (2018). Vejam o trecho no qual a banca se baseou A radiografia simples do tórax, por sua simplicidade, rapidez de obtenção e ampla disponibilidade, é recomendada na avaliação inicial dos pacientes com sinais e sintomas de IC, para avaliação de cardiomegalia e congestão pulmonar (letra A correta). Porém, vale ressaltar que a sensibilidade do método é bastante limitada e, ainda, que a disfunção sistólica cardíaca significativa pode ocorrer sem cardiomegalia na radiografia de tórax (letra B incorreta). O método tem maior valor no contexto da IC aguda, em que as alterações de congestão pulmonar são mais intensas (letra C correta). A radiografia de tórax também é útil por sua capacidade de identificar causas pulmonares de dispneia, como doença pulmonar intersticial, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), neoplasia pulmonar e pneumonia (letra D correta) . Portanto, a única assertiva incorreta e gabarito da questão é a letra B.

215263.

Comentário: Segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (2018), o ecocardiograma transtorácico convencional (bidimensional com doppler Eco-2D-Doppler) é um método abrangente, que pode identificar acuradamente a presença de alterações estruturais cardíacas (A incorreta), incluindo anormalidade do miocárdio, das válvulas cardíacas e do pericárdio, além de avaliar aspectos hemodinâmicos (B incorreta). O ecocardiograma permite a avaliação simultânea de múltiplas variáveis relevantes, do ponto de vista clínico, úteis para a compreensão das manifestações clínicas, auxiliando no planejamento terapêutico e na estratificação prognóstica dos pacientes com IC (C correta, D incorreta). Resposta C.

215284.

Comentário: A insuficiência cardíaca é uma doença de alta prevalência, caracterizada por insuficiência do coração fornecer o débito cardíaco adequado para a perfusão tecidual sistêmica ou

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pela sua capacidade de fazê-lo às custas de elevação das pressões intracavitárias. No entanto, esta doença apresenta-se de diferentes formas, o que pode alterar o entendimento da doença e o seu tratamento. O ecocardiograma transtorácico, que consiste na avaliação ultrassonográfica do coração, é o método de escolha para o estudo cardíaco desses pacientes. No entanto, não é necessário o uso rotineiro de softwares sofisticados, como para avaliação da deformidade da parede cardíaca. Gabarito Alternativa C.

215290.

Comentário: A insuficiência cardíaca é uma manifestação frequente em pacientes com doença de Chagas, razão pela qual a mesma deve ser descartada em pacientes que apresentam disfunção cardíaca de etiologia não definida. No contexto de transplante de órgãos, qualquer sinal de reativação da doença, mesmo na ausência de insuficiência cardíaca, deve levantar a suspeita e indicar exames para que a doença seja investigada. Gabarito Alternativa B.

215294.

Comentário: Quanto mais alto forem os valores dos peptídeos natriuréticos, mais eles falam a favor de IC. Assim, esse diagnóstico é considerado muito provável sobretudo quando BNP 400 pg ml e NT-pró-BNP 450 pg ml para menores de 50 anos, 900 pg ml para aqueles entre 50-75 anos e 1.800 pg ml para maiores de 75 anos. Em contrapartida, a IC é improvável com BNP 100 pg ml e e NT-pró-BNP 300 pg ml em qualquer faixa etária. Diz-se que a IC é possível com valores intermediários a este citados. Resposta a ser marcada LETRA D.

215300.

Comentário: O sacubitril é um inibidor de neprilisina, enzima que degrada peptídeos natriuréticos, bradicina e adrenomedulina. A inibição da neprilisina, portanto, levaria ao aumento na concentração dessas substâncias. Em pacientes em uso do medicamento sacubitril-valsartana, a inibição da neprilisina pelo sacubritil promove elevação nos níveis séricos do BNP, mas não do NT proBNP, interferindo na acurácia diagnóstica do BNP. Nestes pacientes, devemos utilizar o NT-proBNP. Resposta certa LETRA C.

215555.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Questão que traz um raciocínio bastante lógico na máxima que adotamos em relação à transplante se o paciente está mais grave, ele ganha mais pontos e consequentemente, sobe na fila de prioridade do transplante. Portanto, a opção D que coloca que pacientes que estão deteriorando não devem ser candidatos à trasnplante, está incorreta. Resposta D.

215283.

Comentário: A redação do enunciado parece estar incompleta, mas, pelo contexto, especialmente das alternativas, percebe-se que a abordagem se refere à insuficiência cardíaca aguda. Nessa situação, a presença de um ECG normal é incomum, próximo de 13%, e praticamente exclui doença miocárdica crônica alternativa A incorreta. As demais opções são conceituais. Resposta a ser marcada LETRA A.

212220.

Comentário: Questão direta sobre INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DIASTÓLICA ou IC com Fração de Ejeção Normal (ICFEN ICFEP). A banca pede para marcar uma causa, vamos relembrar Hipertensão arterial Diabetes Obesidade Cardiopatia isquêmica crônica Doença de depósito Hipertrofia ventricular esquerda Cardiopatia hipertensiva Estenose aórtica. Portanto, a resposta certa é a LETRA C.

215478.

Comentário: Os agonistas 2-adrenérgicos estimulam os receptores alfa 2 agonistas levando a redução do estímulo simpático. (Letra B - CORRETA) Constituem uma classe de drogas com propriedades potencialmente úteis em anestesia e terapia intensiva, que incluem efeito anti-hipertensivo, analgesia, sedação, diminuição da concentração alveolar mínima (CAM) dos anestésicos inalatórios e redução de tremores pós-operatórios. Letra A A associação de agonistas alfa-2 aos opióides, quando administrados pela via sistêmica (e não via oral), é considerada uma técnica bastante eficaz no que concerne aos efeitos analgésicos. CORRETA Letra C Exato. Há um melhor efeito analgésico via epidural, pois atinge maiores concentrações. CORRETA Letra D INCORRETA Resposta letra D.

182726.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A ecocardiografia transtorácica é exame importante de avaliação de pacientes com cardiopatia estrutural, tais como a insuficiência cardíaca, sendo um exame barato e pouco invasivo (alternativa A correta). Métodos de análise refinada, como o strain e a ecocardiografia tridimensional permitem avaliar com maior precisão os volumes ventriculares, fração de ejeção, débito cardíaco e grau de comprometimento hemodinâmico (alternativa B incorreta). A realização de ecocardiografia pré operatória de rotina aumenta o tempo de permanência hospitalar, sem apresentar aumento de sobrevida para os pacientes (alternativas C e D corretas). Gabarito Alternativa B.

183563.

Comentário: A fisiopatolologia da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida resulta da perda de miócitos (isquemia, infecção, autoimune, tóxico-metabólica) culminando em disfunção sistólica. De forma a compensar este efeito, o miocárdio tenta contrair com mais força e mais vezes, mas as fibras danificadas vão tornando-se mais delgadas e o coração dilata (remodelamento excêntrico). Este coração dilatado não consegue impulsionar o sangue adiante e começa a ocorrer refluxo mitral com hipertensão pulmonar em estágios mais avançados. Já na de fração de ejeção preservada, observamos um aumento da espessura do miocárdio (hipertrofia concêntrica) e diminuição da cavidade ventricular. Ocorre uma desorganização das fibras hipertróficas e dificuldade no relaxamento miocárdico (D incorreta). Ao longo do processo, a liberação de radicais livres, citocinas, interleucinas e endotelinas resultantes da cascata inflamatória corroboram para o estado de caquexia em que estes pacientes se encontram nas fases finais da doença (A correta). Nesta fase observamos também elevação dos níveis de noradrenalina, peptídeo natriurético cerebral e a hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona que perpetuam a lesão no miocárdio (B correta). Drogas que visam bloquear estes mecanismos como betabloqueadores, iECAs, inibidores da aldosterona são utilizadas para melhora do prognóstico da doença. Diuréticos e digitálicos também são utilizados com o objetivo de aliviar os sintomas (D correta). Resposta D

183597.

Comentário: O tratamento da miocardite abrange medidas gerais, utlizadas em qualquer portador

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de miocardiopatia assim como medidas mais específicas. O uso de imunoglobulina intravenosa (IGIV) tem efeito antiviral e imunomodulador o que teoricamente, traria benefícios nos quadros de miocardite viral. Entretanto, algumas revisões sistemáticas vem questionando esta indicação, haja vista que não existem grandes estudos avaliando o efeito da IGIV nas miocardites. A infusão de interferon beta demonstrou benefício nos portadores de miocardiopatia dilatada (A correta) e vem se tornando um importante objeto de estudo como ferramenta terapêutica (D correta). O uso do interferon beta diminuiu a carga viral, com eliminação viral nos casos do adenovírus e enterovírus, embora tenha ocorrido persistência viral do parvovírus B19 em alguns pacientes. Entretanto, observou-se melhora da classe funcional em avaliações posteriores (B incorreta, C correta). Resposta B.

183608.

Comentário: Na avaliação do paciente com insuficiência cardíaca, o primeiro passo é avaliar o perfil hemodinâmico apresentado, pois cada perfil implica numa abordagem terapêutica específica. Dessa forma, podemos entender o paciente como úmido , ou seja, com sinais evidentes de congestão pulmonar e ou sistêmica ou seco , sendo frequentemente o perfil do paciente que encontra-se equilibrado clinicamente. Mas e quanto a perfusão O nível de consciência alterado, hipotensão, perfusão capilar lentificada ou débito urinário reduzido caracterizam um paciente frio (mal perfundido) e a ausência dessas alterações é encontrada em pacientes quentes . Gabarito Alternativa A.

183055.

Comentário: Vamos analisar as assertivas a respeito da cardiomiopatia hipertrófica (CMH) A. Correta. As evidências apontam para uma causa genética, autossômica dominante. Cerca de 50% dos pacientes têm história familiar positiva, já existindo diversas mutações descritas, as quais codificam proteínas contráteis dos sarcômeros. B. Correta. A CMH é doença primária do miocárdio, geneticamente determinada por mutações nas proteínas contráteis dos sarcômeros. C. Correta. A CMH uma doença cardíaca complexa, com características fisiopatológicas específicas e uma grande diversidade de apresentações clínicas, morfológicas e funcionais. A forma de apresentação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

mais comum é a hipertrofia septal assimétrica, mas existem outras, como a hipertrofia simétrica hipertrofia apical assimétrica (forma de Yamagushi) e outras hipertrofias segmentares mais raras. D. Incorreta. Embora a maior parte dos pacientes seja assintomática, existem diversos padrões de localização e extensão da hipertrofia. Portanto, a alternativa incorreta e resposta da questão é a LETRA D.

183616.

Comentário: O uso da imunoglobulina intravenosa (IGIV) tem efeito antiviral e imunomodulador o que teoricamente, traria benefícios nos quadros de miocardite viral. Entretanto, algumas revisões sistemáticas vem questionando esta indicação, haja vista que não existem grandes estudos avaliando o efeito da IGIV nas miocardites. (A,B e C corretas). O uso do interferon beta diminuiu a carga viral, com eliminação viral nos casos do adenovírus e enterovírus, embora tenha ocorrido persistência viral do parvovírus B19 em alguns pacientes. Entretanto, observou-se melhora da classe funcional em avaliações posteriores (D incorreta).

183065.

Comentário: O prognóstico da cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é extremamente variável, com a maior parte dos pacientes permanecendo assintomática durante toda a vida. De acordo com Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os critérios clínicos estabelecidos de pior prognóstico na CMH são - Septo interventricular com espessura 30 mm - Morte súbita prematura na família - História de síncope sem etiologia definida - Taquicardia Ventricular Não Sustentada (TVNS) ao Holter - Resposta anormal da pressão arterial ao teste de esforço em indivíduos com menos de 40 anos. Resposta D.

183073.

Comentário: A miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, com mutações identificadas em cerca de 70% dos casos nos genes do sarcômero, que codificam componentes do aparelho contrátil miocárdico. Caracteriza-se por hipertrofia ventricular exacerbada, de várias morfologias, resultando em áreas de fibrose (identificadas por ressonância magnética), que ocasionam alterações hemodinâmicas por alteração estrutural e aumento importante do risco de arritmias

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

malignas. Gabarito Alternativa A.

183630.

Comentário: Os diuréticos de alça, como a furosemida, consistem em uma importante medida terapêutica nos casos de congestão pulmonar, causados por uma insuficiência cardíaca aguda, por exemplo. Embora não haja estudos que demonstrem redução da mortalidade, seu uso já é quase universal pelos médicos nessas situações. A dose inicial é variável na literatura. Contudo, o valor apresentado na opção (D) (1 mg kg) pode ser encontrada em algumas diretrizes brasileiras. Em outras referências, é recomendada uma dose fixa de 40-80 mg. É importante ressaltar que a furosemida possui dois efeitos principais além de aumentar a diurese, provoca venodilatação (efeito semelhante ao da morfina). Dessa forma, reduz a pré-carga ventricular e diminui a congestão pulmonar Agora, um dado importantíssimo o efeito venodilatador ANTECEDE o efeito diurético Sendo assim, a única alternativa incorreta é a opção (B).

183079.

Comentário: A miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, com mutações identificadas em cerca de 70% dos casos nos genes do sarcômero, que codificam componentes do aparelho contrátil miocárdico. Caracteriza-se por hipertrofia ventricular exacerbada, de várias morfologias, resultando em áreas de fibrose (identificadas por ressonância magnética), que ocasionam alterações hemodinâmicas por alteração estrutural e aumento importante do risco de arritmias malignas. O exame de escolha para identificação das áreas de fibrose miocárdica é a ressonância magnética, capaz de diferenciar a hipertrofia miocárdica do atleta, em que não há fibrose associada, da miocardiopatia hipertrófica, com padrão multifocal e confluente de fibrose. Gabarito Alternativa B.

183635.

Comentário: Questão retirada em sua integridade da I Diretriz Brasileira de Pericardites e Miocardites, publicada em 2013 pela Sociedade brasileira de cardiologia. O tema diz respeito ao uso de imunoadsorção como terapia para a cardiomiopatia inflamatória. Se os autoanticorpos cardíacos contribuem para disfunção miocárdica, faz sentido que sua remoção possa melhorar a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hemodinâmica ventricular esquerda e portanto a sobrevida dos pacientes. Estudos com pentoxifilina também sugerem melhora da função ventricular, permanecendo como indicação de nível IIb segundo a diretriz. Segue o texto original O processo de imunomodulação tem como objetivo reduzir a agressão inflamatória e autoimune através da remoção e modulação de possíveis agentes agressores envolvidos na patogênese da miocardite. A terapia de imunoadsorção através de plasmaférese seletiva visa a retirada de autoanticorpos específicos associada à terapia com IG-IV para imunomodulação inflamatória das citocinas e da produção dos autoanticorpos. (ALTERNATIVA A CORRETA). A utilização da imunoadsorção em pacientes com cardiomiopatia inflamatória crônica com níveis séricos elevados de autoanticorpos contra 1 neurorreceptor miocárdico associado à reposição de IG-IV, demonstrou redução da atividade inflamatória miocárdica e melhora clínica da classe funcional e da função ventricular e maior sobrevida ao fim de cinco anos. (ALTERNATIVA C INCORRETA). Embora esses resultados sugiram um possível benefício desta terapêutica nos pacientes com miocardite autoreativa, o número de pacientes avaliados é muito reduzido para que possamos estabelecer essa estratégia terapêutica como definitiva. A pentoxifilina apresenta como propriedades anti-inflamatórias o bloqueio da transcriptase do TNF- e a redução dos níveis de interleucinas 2 e 6, com consequente redução dos efeitos de cardioagressão dessas citocinas. (ALTERNATIVA B CORRETA). Na cardiomiopatia dilatada com IC crônica e na cardiomiopatia periparto, a utilização de pentoxifilina na posologia de 1200mg a 2400mg dia, pelo período de seis meses, ocasionou melhora clínica da classe funcional e da função ventricular (ALTERNATIVA D CORRETA). Esses resultados sugerem um papel benéfico da pentoxifilina como terapêutica coadjuvante nas cardiomiopatias inflamatórias crônicas, sendo ainda necessário ainda comprovar este benefício nas cardiomiopatias de início recente ou miocardites agudas. Resposta letra C

183032.

Comentário: O coração do atleta de alta performance é diferente do coração de indivíduos não atletas e tais alterações configuram a síndrome do coração do atleta, caracterizada por aumento da massa cardíaca, do volume diastólico e do diâmetro diastólico final, relacionado aos exercícios

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

predominantemente de resistência, e aumento da massa e hipertrofia concêntrica, nos casos de exercícios isométricos. Dessa forma, é fundamental diferenciar condições patológicas que possam produzir uma morfologia cardíaca similar, o que pode ser realizado através do ecocardiograma, engoespirometria ou ressonância magnética, sendo esse último o método com melhor acurácia, por ser possível a avaliação de fibrose, edema miocárdico e infiltração gordurosa. A presença de fibrose NÃO costuma ocorrer no coração de atleta, a despeito de alguns resultados evidenciando áreas de realce tardio em corações de maratonistas e triatletas.

183062.

Comentário: O edema agudo de pulmão ocorre frequentemente em pacientes coronariopatas, hipertensos e diabéticos, caracterizando-se por uma elevação ABRUPTA da pressão capilar pulmonar (alternativa A incorreta), o que ocasiona uma translocação do líquido intravascular para o espaço intersticial e alveolar pulmonar (alternativa B correta), levando ao quadro típico de taquidispneia SÚBITA e intensa em repouso (alternativa C correta), com quadro congestivo comprovado pela radiografia de tórax (alternativa D correta). Gabarito Alternativa A.

183070.

Comentário: As causas mais comuns de insuficiência cardíaca são a miocardiopatia isquêmica (mais frequente), chagásica, relacionada a doença hipertensiva ou idiopática (alternativa B correta). O conhecimento da fisiopatologia para abordagem terapêutica adequada é essencial para redução da morbiletalidade pela doença (alternativa A correta). Na fase inicial da insuficiência cardíaca há déficit do relaxamento ventricular, o que reduz o seu volume de enchimento e, consequentemente, o débito cardíaco. Dessa forma, são estabelecidos mecanismos adaptativos, como ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, na tentativa de reestabelecer o débito cardíaco através do aumento do volume plasmático circulante (alternativa D correta). Outras condições associadas a descompensação do quadro são aquelas em que há sobrecarga hemodinâmica de PRESSÃO ou de VOLUME, o que ocasiona desequilíbrio nos mecanismos de compensação, levando a redução do débito cardíaco (alternativa C incorreta). Gabarito Alternativa C.

183646.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Essa questão é autoexplicativa. Segundo diretrizes brasileiras de diabetes, o uso de insulina em pacientes com insuficiência cardíaca não proporcionou um aumento da sobrevida. Pelo contrário foi demonstrado até aumento da mortalidade Contudo, acredita-se que esse efeito seja apenas uma variável confundidora. Como sabemos, a insulina representa uma medida terapêutica reservada para os casos de DM mais graves, geralmente. Portanto, os indivíduos que usam essa droga já possuem um risco mais elevado de desfechos negativos (entre eles, o óbito) Além disso, nenhum estudo foi desenvolvido para avaliar de forma objetiva o impacto do tratamento com e sem insulina. Resposta (B).

183122.

Comentário: O edema agudo de pulmão ocorre frequentemente em pacientes coronariopatas, hipertensos e diabéticos, caracterizando-se por uma elevação abrupta da pressão capilar pulmonar, o que ocasiona uma translocação do líquido intravascular para o espaço intersticial e alveolar pulmonar, levando ao quadro típico de taquidispneia súbita e intensa em repouso, com quadro congestivo comprovado pela radiografia de tórax e ao exame físico, com queda da saturação de O2 e estertores bolhosos em bases e terço médio pulmonar bilateralmente. Tal quadro justifica-se pela incapacidade do ventrículo esquerdo de estabelecer um débito cardíaco adequado, resultando em mecanismos compensatórios que ocasionam o aumento da resistência vascular. Gabarito Alternativa A.

183645.

Comentário: Questão sobre hipertensão que apresenta alguns conceitos sobre tratamento medicamentoso. Vamos analisar cada opção Pacientes com risco cardiovascular elevado (7.5% em 10 anos segundo o cálculo do ASCVD) hipertensos classe I ou que sejam hipertensos grau II ou III devem são elegíveis para uso de esquema antihipertensivo combinado (A correta). Alguns estudos tem demonstrado excelentes resultados em termos de controle pressórico ao combinar duas, três ou até mesmo quatro drogas antihipertensivas, em doses reduzidas (B correta). Os diuréticos de alça podem ser associados no tratamento da hipertensão, principalmente em pacientes com síndrome edemigênica (IC, cirrose, síndrome nefrótica) e não ficam restritos a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pacientes com clearance de creatinina menor que 10 ml min 1.73m2 (C incorreta). A associação de drogas com o mesmo mecanismo de ação, dantes muito utilizada, tendo como exemplo a associação de iECAs com BRAs, mostrou-se deletéria e deve ser evitada (D correta). Resposta C.

183038.

Comentário: O edema agudo de pulmão ocorre frequentemente em pacientes coronariopatas, hipertensos e diabéticos, caracterizando-se por uma elevação ABRUPTA da pressão capilar pulmonar, o que ocasiona uma translocação do líquido intravascular para o espaço intersticial e alveolar pulmonar, levando ao quadro típico de taquidispneia SÚBITA e intensa em repouso, com quadro congestivo comprovado pela radiografia de tórax. No entanto, não há consenso sobre os valores de saturação necessários para caracterizar o quadro, motivo pelo qual foi solicitado recurso para a questão. Porém, a banca manteve a alternativa A como gabarito oficial.

183592.

Comentário: As drogas de primeira linha para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica são os diuréticos tiazídicos, os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC), os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e os bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA). Todas reduzem a morbimortalidade cardiovascular. Por outro lado, a presença de alguma comorbidade na qual o uso dos betabloqueadores é necessário (profilaxia da enxaqueca, doença coronariana, insuficiência cardíaca) permite o uso desses fármacos em monoterapia. Outras classes farmacológicas também podem ganhar destaque , de acordo com as condições associadas (ex metildopa na gestação). Dessa forma, concluímos que a única alternativa incorreta é a opção (A).

183089.

Comentário: Pacientes que realizam uso crônico de betabloqueadores, especialmente os que possuem insuficiência cardíaca, possuem alta dependência dessa droga para manter o equilíbrio hemodinâmico. Portanto, a suspensão dessa classe de drogas pode aumentar a morbimortalidade desses pacientes. O ajuste de drogas ou descontinuação do uso de betabloqueadores somente devem ser realizados em contextos nos quais a sua utilização pode ser potencialmente prejudicial,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

como nos bloqueios atrioventriculares avançados, casos de instabilidade hemodinâmica ou de efeitos colaterais graves relacionados ao medicamento. Gabarito Alternativa B.

181325.

Comentário: Questão conceitual de fisiologia cardíaca. O débito cardíaco representa o volume de sangue que o coração é capaz de impulsionar pela unidade de tempo, ou seja, trata-se de um fluxo cuja unidade usual é (L min). É o resultado do produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Resposta B.

181338.

Comentário: Paciente diabético que vem mantendo pressão acima de 140 x 90 mmHg, o que, de acordo com as diretrizes brasileiras, o define como hipertenso. Nos diabéticos hipertensos, a terapêutica da hipertensão deve sempre ser medicamentosa e com meta de pressão abaixo de 130 x 80 mmHg. Resposta C.

183564.

Comentário: Com relação ao manejo da hipertensão arterial pulmonar (HAP) na faixa etária pediátrica, vamos avaliar as alternativas A) ERRADA O uso de anticoagulantes orais é uma medida essencialmente paliativa e seu impacto no aumento da sobrevida dos pacientes com HAP não está definido. B) CORRETA O oxigênio a 100% tem ação vasodilatadora pulmonar no manejo inicial das crianças com HAP. C) CORRETA O tratamento convencional da HAP consiste também no controle da disfunção ventricular direita, sendo que a digoxina é a droga mais utilizada para este fim. D) CORRETA Diuréticos como furosemida e espironolactona ajudam a controlar a congestão sistêmica, tendo-se o cuidado de não diminuir excessivamente a pré-carga ventricular direita e conseqüente piora do débito cardíaco. Resposta letra A.

183575.

Comentário: O sildenafil é um inibidor seletivo da fosfodiesterase tipo 5, que assim como o óxido nítrico, provoca vasodilatação. Logo, o mais esperado é que o paciente evolua com HIPOtensão, diferentemente do apontado pela alternativa B. Resposta letra B.

182741.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos analisar um trecho da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Capítulo 2 - Diagnóstico e Classificação A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial. Maior ocorrência de EAB, hipotensão ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença de arritmias, como fibrilação atrial, podem dificultar a medição da PA. Perceba que a banca simplesmente retirou esse trecho da diretriz, colou na assertiva A (nosso gabarito) e fez pequenas alterações no texto para formar as letras B,C e D. Tanto assunto importante e de forma diferente para se cobrar e temos que nos deparar com uma questão igual a essa. Infelizmente, não temos o que fazer. Portanto, o nosso gabarito é a letra A.

182760.

Comentário: As bancas de residência médica estão cada vez mais sem criatividade. A nova moda é retirar trechos na íntegra de artigos, jornais ou consensos de sociedades específicas e substituir uma palavra ou outra e pedir que o aluno encontre qual assertiva está correta ou incorreta. Nesse caso, vamos retirar um trecho da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Capítulo 2 - Diagnóstico e Classificação Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD. A grande variação da PA nos idosos ao longo das 24 horas torna a MAPA uma ferramenta muitas vezes útil. Perceba que ao analisarmos as assertivas a banca muda um palavra ou outra que acaba por invalidar as letras A,B e D e portanto, o nosso gabairto é a letra C. A banca poderia cobrar esse conceito de diversas outras maneiras porém preferiu dessa forma.

182792.

Comentário: A hipertensão arterial é um fator de risco isolado de alta relevância para eventos cardiovasculares, sendo o emprego de fármacos e medidas não medicamentosas, como perda ponderal, dieta, exercícios e cessação do tabagismo, a base do tratamento, com eficácia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

comprovada para redução de mortalidade cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca (alternativas A e D corretas e C incorreta). Há indicação imediata de tratamento para indivíduos com pressão arterial aferida maior ou igual a 160x100 mmHg e ou portadores de risco cardiovascular, ainda que hipertensos em estágio 1 (alternativa B correta). Gabarito Alternativa C.

182802.

Comentário: A hipertensão arterial é um fator de risco isolado de alta relevância para eventos cardiovasculares, sendo o emprego de fármacos e medidas não medicamentosas, como perda ponderal, dieta, exercícios e cessação do tabagismo, a base do tratamento, com eficácia comprovada para redução de mortalidade cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Há indicação imediata de tratamento para indivíduos com pressão arterial aferida maior ou igual a 160x100 mmHg e ou portadores de alto risco cardiovascular, ainda que hipertensos em estágio 1. Nos casos de hipertensão em estágio 1 em pacientes com baixo a moderado risco vascular, pode-se tentar a terapia não farmacológica por 3 a 6 meses, devendo ser iniciada terapia farmacológica em caso de piora dos níveis pressóricos ou se for identificada falha de adesão às medidas não farmacológicas. Gabarito Alternativa A.

158800.

Comentário: Betabloqueadores e diuréticos tiazídicos estão associados à piora do controle glicêmico, sendo uma associação a ser evitada em diabéticos. Considerando que todo esquema anti-hipertensivo de diabético deve idealmente conter um IECA ou um BRA, também poderíamos chegar à resposta facilmente por exclusão... Resposta A.

158795.

Comentário: Paciente com diagnóstico prévio de hipertensão arterial com pressão de 170 x 100 mmHg, ou seja, com a sistólica entre 160-179 mmHg, classificando-a em estágio 2 (E errada), o que já indica tratamento farmacológico imediato (A errada). Por ter risco cardiovascular alto, nesta doente definida como estágio 2 com 1 ou mais fatores de risco, sua meta terapêutica é PA 130 x 80 mmHg (B errada). Estágio 2 já deve começar com 2 drogas em combinação, cada uma em dose

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

baixa (D errada). Resposta letra C.

161356.

Comentário: O achado de lâmina hiperdensa na tomografia de crânio (LETRA C) é compatível com sangramento intracraniano (hemorragia subaracnoidea). Todos os demais achados citados são compatíveis com o diagnóstico radiográfico de encefalopatia hipertensiva. Gabarito letra C.

158754.

Comentário: O sujeito escreve um enunciado enorme para fazer uma pergunta conceitual, que, para ser respondida, independe do enunciado. Enfim... A cardite reumática é a manifestação da fase aguda da febre reumática, mais comum em crianças, que causa com maior frequência a insuficiência mitral. Já a cardiopatia reumática ou cardite crônica é uma sequela da cardite reumática, que costuma se manifestar 10 a 20 anos após o episódio agudo de febre reumática. A principal lesão orovalvar é a estenose mitral. Resposta A.

161302.

Comentário: A alternativa B é a única incorreta os betabloqueadores atuam promovendo REDUÇÃO inicial do débito cardíaco (efeito inocronotrópico negativo) e da produção renal de renina, readaptação de barorreceptores e QUEDA dos níveis de catecolaminas nas sinapses nervosas. Adicionalmente, carvedilol e nevibolol possuem atividade vasodilatadora.

161392.

Comentário: Paciente com insuficiência renal evoluindo com hipervolemia grave (hipertensão arterial grave, edema agudo de pulmão) com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica devido a insuficiência respiratória. O tratamento que vai de fato resolver o problema é a hemodiálise. O uso do nitroprussiato como vasodilatador é adequado, entretanto devemos ter em mente que o risco de intoxicação pelo tiocianato, um metabólito do nitroprussiato, é maior nos pacientes com disfunção renal. Dessa forma, o uso deve ser pelo menor tempo possível. Resposta D.

161226.

Comentário: Questão tranquila O alisquireno atua por inibição direta da renina, com consequente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

redução da síntese de angiotensina II. A droga possui comprovada ação anti-hipertensiva, podendo ser utilizada em monoterapia. Gabarito Letra C.

161197.

Comentário: Por ser um exame de baixíssimo custo e de fácil operação, o eletrocardiograma (ECG) costuma ser utilizado para o rastreio de algumas doenças cardiovasculares, como a hipertrofia ventricular esquerda (HVE). Caso haja alguma evidência de HVE ao ECG, um ecocardiograma (ECO) deve ser solicitado, já que é um método bem mais sensível para o diagnóstico dessa condição - opção (A) incorreta. Por meio dele, é possível visualizar o aspecto da hipertrofia, além de mensurar o tamanho atrial e as funções sistólica e diastólica (motivo pelo qual também deve ser solicitado na suspeita clínica de insuficiência cardíaca) - opções (B), (C) e (D) corretas. Resposta (A).

161203.

Comentário: Há indicação imediata de tratamento para indivíduos com pressão arterial aferida maior ou igual a 160x100 mmHg e ou portadores de risco cardiovascular, ainda que hipertensos em estágio 1 (alternativa A incorreta). A redução dos níveis pressóricos é fator importante para redução de risco cardiovascular em pacientes hipertensos, principalmente com níveis pressóricos mais elevados (alternativa B correta e alternativa D incorreta). Apesar de ter um papel essencial no controle das comorbidades que elevam o risco cardiovascular e adjuvante no controle pressórico, a terapia não farmacológica não é considerada suficiente para controle dos níveis pressóricos. Gabarito Alternativa B.

161270.

Comentário: O feocromocitoma é uma neoplasia rara, originada nas células cromafins. Para determinar as frequências aproximadas relacionadas a esta entidade podemos utilizar a regra dos 10 do feocromocitoma 10% dos tumores são -Bilaterais -Extra-adrenais -Malignos -Cursam SEM hipertensão arterial -Ocorrem antes dos 20 anos de idade -Apresentam-se como incidentalomas adrenais -Recidivam após ressecção cirúrgica. Com essa regrinha podemos concluir que a alternativa A está incorreta.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

161414.

Comentário: Como sabemos, as doenças cardiovasculares são importante causa de morbimortalidade em todo o mundo. Por isso, ênfase tem sido dada a programas de reabilitação cardiovascular (RCV) e de prevenção secundária. Os seus grandes pilares incluem mudanças no estilo de vida com foco na atividade física programada, interrupção do uso de drogas e do tabagismo, alimentação saudável e estratégias para modular o estresse. Um programa de RCV deve ter como meta melhorar o estado fisiológico e psicológico do paciente, através de uma abordagem multidisciplinar. Dessa forma, a única alternativa incorreta é a opção (C).

161359.

Comentário: Hipertensão Arterial (HA) condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos 140 e ou 90 mmHg (A CORRETA). Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM) (B e C CORRETAS). Mantém associação independente com eventos como morte súbita, Acidente Vascular Encefálico (AVE), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Insuficiência Cardíaca (IC), Doença Arterial Periférica (DAP) e Doença Renal Crônica (DRC), fatal e não fatal (D INCORRETA). Resposta D.

161366.

Comentário: Questão conceitual. Vejamos as alternativas A - Consumo crônico e elevado de bebidas alcoólicas aumenta a PA de forma consistente. Meta-análise de 2012, incluindo 16 estudos com 33.904 homens e 19.372 mulheres comparou a intensidade de consumo entre abstêmios e bebedores. Em mulheres, houve efeito protetor com dose inferior a 10 g de álcool dia e risco de HA com consumo de 30-40 g de álcool dia. Em homens, o risco aumentado de HA tornou-se consistente a partir de 31 g de álcool dia. INCORRETA. B - Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA, relacionada ao i) aumento da expectativa de vida da população brasileira, atualmente 74,9 anos ii) aumento na população de idosos 60 anos na última década (2000 a 2010), de 6,7% para 10,8%. INCORRETA. C - Estudos brasileiros que avaliaram o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

impacto de polimorfismos genéticos na população de quilombolas não conseguiram identificar um padrão mais prevalente. Mostraram forte impacto da miscigenação, dificultando ainda mais a identificação de um padrão genético para a elevação dos níveis pressóricos. CORRETA. D - Na pesquisa nacional de saúde de 2013 a prevalência de hipertensão autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos, sendo o sexo feminino mais prevalente. INCORRETA. Resposta C.

161380.

Comentário: Questão sem problemas, todas as alternativas estão corretas e são conceituais, exceto a letra B, pois o objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, e tratar quando necessário, não só com medicamentos, mas também com mudança dos hábitos de vida (dieta, atividade física...). Portanto, resposta letra B.

161383.

Comentário: O estudo a que se refere o enunciado foi um estudo de base populacional em Cuiabá, MT, (n 1.298 adultos 18 anos) que revelou prevalência geral de sedentarismo de 75,8% (33,6% no lazer 19,9% no trabalho 22,3% em ambos). Observou-se associação significativa entre HA e idade, sexo masculino, sobrepeso, adiposidade central, sedentarismo nos momentos de folga e durante o trabalho , escolaridade inferior a oito anos e renda per capita 3 salários mínimos. Perceba que a associação é com escolaridade inferior a 8 anos e renda per capita 3 salários mínimos e não 5 salários mínimos como citado no enunciado. Dessa forma, o nosso gabarito é a letra D.

161389.

Comentário: À luz do exposto na VI Diretriz Brasileira de Hipertensão, esse quesito tem duas respostas possíveis. Veja, de acordo com o documento em questão, é necessário tomar alguns cuidados antes e durante a aferição da pressão arterial, tanto para não alarmar o paciente, quanto para não falsear essa etapa do exame físico. Dentre esses cuidados (1) garantir que o paciente esteja em repouso há pelo menos 5 minutos (A errada) (2) que se mantenha calado durante a aferição (3) que não esteja com a bexiga cheia (4) que não tenha praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos e (5) que não tenha fumado nos 30 minutos anteriores (D errada). Assim, embora a banca tenha aceito somente a alternativa D, consideramos que a alternativa A também

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

seria resposta adequada.

161393.

Comentário: De acordo com a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial sistêmica, a medida da pressão arterial deve obedecer aos seguintes princípios 1. Explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medição. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento. 2. Certificar-se de que o paciente NÃO - Está com a bexiga cheia - Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos - Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos - Fumou nos 30 minutos anteriores. 3. Posicionamento - O paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado - O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotear o membro. 4. Medir a PA na posição de pé, após 3 minutos, nos diabéticos, idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada. Resposta B.

161282.

Comentário: Questão muito difícil A miocardite se caracteriza pela presença de uma resposta inflamatória do miocárdio, frequentemente acarretada por uma agressão infecciosa primária em outro sítio. Na avaliação dos pacientes com miocardite, a Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) permite identificar tanto a injúria miocárdica inflamatória das fases aguda e subaguda quanto as lesões cicatriciais frequentemente presentes na fase crônica da doença. A RMC deve ser realizada o mais precocemente a partir da suspeita clínica. Exames subsequentes de reavaliação devem ser feitos com 4 e 12 semanas após o episódio agudo, com o objetivo de avaliar a evolução do processo inflamatório, quando positivo o exame, e a função de remodelagem. Devido a questões logísticas inerentes ao método, a RMC não está indicada na avaliação dos pacientes portadores de miocardite fulminante com instabilidade hemodinâmica. Resposta D.

161289.

Comentário: Os quadros de miocardite progressiva e refratária têm no transplante cardíaco de emergência sua única chance de sobrevida (A correta). Sempre que for necessário instituir suporte

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inotrópico com drogas vasoativas, o ideal é que esse tratamento seja titulado para a menor dose possível, pelo menor tempo possível (B correta). As complicações da miocardite citadas na alternativa D constituem indicações independentes de anticoagulação plena, logo, tal indicação continua válida a despeito da existência de endocardite (D correta). A VNI não é um bom método terapêutico em crianças pequenas pelo fato de necessitar de cooperação do paciente, o que nem sempre é possível neste grupo, principalmente no estrato de menor faixa etária... Resposta certa C.

134824.

Comentário: Paciente com história de IAM há 4 anos, evoluindo com ICFER (insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida). Podemos fazer essa afirmativa (fração de ejeção reduzida) em função da presença de sinais de má-perfusão tecidual... Pois bem, o que está correto acerca do uso de DOBUTAMINA neste doente Em primeiro lugar, lembre-se que dobutamina é um agonista beta-1 adrenérgico. Logo, exerce ação inotrópica e cronotrópica positiva, aumentando o consumo miocárdico de oxigênio. Num paciente com cardiopatia isquêmica (ICFER por doença coronariana), o uso de dobutamina pode ser perigoso, na medida em que pode induzir complicações isquêmicas, como arritmias ou mesmo um novo infarto A dose inicial é de 0.5 a 1.0 micrograma kg min, podendo chegar a 20 mcg kg min. Ao aumentar o débito cardíaco, ela aumenta o fluxo sanguíneo para os diversos órgãos e tecidos do corpo... Logo, resposta certa B.

134112.

Comentário: A queixa descrita é compatível com uma dor originada no pericárdio (dor torácica anterior que melhora com a posição de cócoras e com a posição genupeitoral). Os sinais encontrados são compatíveis com tamponamento cardíaco (tríade de Beck hipotensão, TJP e bulhas abafadas). A ausência de atrito pericárdico não é estranha nesse contexto quando um grande volume de líquido se acumula no espaço pericárdico, o afastamento dos folhetos pericárdicos impede a ocorrência de atrito. Enfim, o que se espera no ecocardiograma de um derrame pericárdico importante Devido ao isolamento elétrico promovido pelo líquido em torno do coração, o principal sinal é uma amplitude variável e geralmente baixa do QRS numa mesma derivação unipolar (precordiais, que são as que observam mais diretamente o coração). Uma

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

supradesnível de ST pode ser observado, mas tal achado costuma estar presente em derivações precordiais E periféricas. Resposta certa C.

134314.

Comentário: Betabloqueadores são CONTRAINDICADOS na intoxicação por cocaína O motivo é o seguinte a cocaína é um poderoso agonista alfa e beta-adrenérgico. Quando o paciente intoxicado é exposto a um BETAbloqueador, os receptores beta-2, localizados na parede vascular, são inibidos. Tais receptores exercem ação VASODILATADORA, e, quando inibidos pela medicação, ocorre um desequilíbrio criado por ação da cocaína, que assim fica livre para exercer sua ação sobre os receptores alfa-1, também localizados na parede vascular, cuja ação é VASOCONSTRITORA. Dito de outro modo, o que acontece é o seguinte há um súbito predomínio de forças vasoconstritoras, gerando espasmo coronariano, o que, no contexto de aumento do consumo miocárdico de oxigênio (estímulo aos receptores beta-1 adrenérgicos induzido pela própria cocaína), tem grande chance de levar a um quadro de isquemia miocárdica. Resposta certa B.

134114.

Comentário: O que o autor deseja saber é qual dos fatores não interfere na decisão manter os níveis de pressão arterial ou reduzí-los no contexto do AVE isquêmico. Neste grupo recomenda-se não reduzir os níveis pressóricos, exceto quando estes ultrapassam valores de 220 x 120 mmHg, nas primeiras 24 horas (logo, as alternativas B e D devem ser consideradas). Cabe a ressalva que pacientes em protocolo de trombólise representam exceção a este valor, pois devem ter PA 185 x 110 para administração de trombolíticos. Não podemos esquecer que o AVE isquêmico pode se tratar de uma emergência hipertensiva, e muitas vezes associa-se a outras situações que denotam emergência (tais como IAM, dissecção aórtica, edema agudo de pulmão). Desta forma, a presença de outras complicações relacionadas a hipertensão arterial interferem na decisão de abordar os níveis tensionais. A tomografia computadorizada de crânio normal ou com lesão isquêmica não é levada em consideração para definição da abordagem da HAS, visto que em fases iniciais de um AVE isquêmico instalado a TC pode não mostrar alterações.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

134277.

Comentário: As emergências hipertensivas são situações em que ocorre aumento da pressão arterial com consequente ameaça imediata a vida do paciente, cursando com lesões de órgão-alvo. A pressão arterial deve ser reduzida em minutos a poucas horas com drogas parenterais. O nitropussiato de sódio é uma destas drogas. Trata-se de um nitrato com potente efeito vasodilatador direto de artérias e veias. Deve ser evitado em portadores de isquemia miocárdica devido a possibilidade de roubo coronariano associado a sua potente ação vasodilatadora sistêmica. Possui meia vida curta, com início e término de ações rápidas em doses de 0,25-10 mcg kg min. A droga é metabolizada pelas hemáceas em cianeto, o qual é convertido em tiocianato pelo fígado. A intoxicação por cianeto pode gerar acidose metabólica e alterações na curva de dissociação da oxihemoglobina, implicando em distúrbios respiratórios. Alternativa C é a única correta.

134311.

Comentário: Na encefalopatia hipertensiva o aumento súbito e significativo da pressão arterial ultrapassam o limite da auto-regulação cerebral, gerando hiperfluxo vascular, com consequente extravasamento de líquido para o espaço intersticial e edema cerebral. Esta entidade usualmente ocorre com níveis muito altos de PA (240 X 130 mmHg). A alternativa D está adequada. Vamos além O quadro clínico se desenvolve ao longo de dias, com cefaleia, náuseas e vômitos, podendo ocorrer ainda rebaixamento do nível de consciência e crises convulsivas. Há necessidade de instalação imediata de terapia anti-hipertensiva, preferencialmente com droga intravenosa de meia-vida curta para melhor titulação. Este é o caso do nitroprussiato de sódio, nicardipina e labetalol. Devemos reduzir a PAM em cerca de 25% do valor prévio nas primeiras 3 horas.

134858.

Comentário: Paciente hipertensa crônica resolveu parar de tomar as medicações anti-hipertensivas e evoluiu com uma importante emergência hipertensiva insuficiência ventricular esquerda aguda, complicada com congestão pulmonar grave (edema agudo de pulmão) Diversas medicações devem ser prescritas neste momento (1) morfina, que além de aliviar a dispneia exerce algum efeito

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

venodilatador sistêmico, reduzindo o retorno venoso ao coração direito e, consequentemente, a pré-carga cardíaca (2) diuréticos de alça, que agudamente também exercem alguma ação venodilatadora sistêmica, reduzindo a pré-carga, e no médio-longo prazo promovem eliminação renal de sódio e água, reduzindo a volemia e a congestão pulmonar (3) anti-hipertensivo parenteral potente e de ação rápida, sendo a droga de escolha o nitroprussiato de sódio, que exerce poderosa ação vasodilatadora tanto venosa (redução da pré-carga) quanto arterial (redução da pós-carga), controlando ao mesmo tempo a congestão pulmonar e os níveis pressóricos... Passada a fase aguda, sendo a paciente devidamente estabilizada do ponto de vista hemodinâmico, os anti-hipertensivos orais devem ser retomados. Vale lembrar que nifedipina é uma droga oral de ação rápida, sendo atualmente contraindicada nas emergências hipertensivas pelo fato de promover intensa taquicardia reflexa e consequente risco de isquemia miocárdica, com documentação de aumento da morbimortalidade por causa disso em estudos clínicos... Resposta certa A.

134320.

Comentário: Os principais órgãos-alvo da hipertensão arterial (tanto aguda quanto crônica) são (1) coração, (2) rim, (3) cérebro, (4) retina, (5) os próprios vasos arteriais, como a aorta. A córnea sequer possui vascularização própria (a nutrição de suas células é feita por difusão de nutrientes a partir do humor aquoso). Logo, a hipertensão não afeta a córnea... Resposta certa D.

134848.

Comentário: Lendo este caso você pode se imaginar dentro de uma sala de atendimento de emergência, pois este cenário é bastante comum na vida real. Tal como na prova, na vida real você pode sistematizar o seu pensamento para não errar. Vamos juntos A elevação de Pressão Arterial (PA) pode ou não se associar a lesões à órgãos-alvo. Quando as lesões orgânicas ocorrem estaremos diante de crises hipertensivas. As crises hipertensivas podem configurar emergências (ameaça imediata a vida do paciente) ou urgências (ameaça incipiente - em horas a dias - a vida do paciente). Nos pacientes sem lesão orgânica a VI Diretriz Brasileira de HAS considera ainda como urgência hipertensiva a pressão arterial diastólica ou 120 mmHg. Ora vejamos, nosso paciente não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

apresenta nenhuma destas condições. Temos então a chamada pseudocrise hipertensiva elevação de PA assintomática ou com sintomas não relacionados ao níveis de PA, diante de situações de estresse. Nestes casos a conduta correta é a orientação quanto ao controle regular da pressão arterial e a administração de medicamentos sintomáticos. Se nosso paciente apresenta-se com cefaleia e ansiedade considera-se adequado medicá-lo com analgésicos e ansiolíticos, conforme descrito na letra C.

134329.

Comentário: O efeito rebote é um sério problema em usuários de certos agentes anti-hipertensivos quando a medicação não é utilizada de forma regular e correta... O grupo mais associado a este fenômeno é o dos AGONISTAS ALFA-2 ADRENÉRGICOS CENTRAIS, como o metildopa e a clonidina. Resposta certa C.

134334.

Comentário: Na encefalopatia hipertensiva, o que se espera é EDEMA CEREBRAL difuso. Outra lesão aguda cerebral relacionada à hipertensão é o AVE hemorrágico, que cursa com presença de sangue extravascular no encéfalo (no parênquima e ou no espaço subaracnoide) - A errada... O hemograma pode mostrar anemia, e o EAS pode mostrar proteinúria, num quadro de HAS acelerada-maligna, porém, individualmente tais achados não possuem ESPECIFICIDADE para uma emergência hipertensiva . O dado que, na presença de anemia e proteinúria, confere especificidade para o diagnóstico de emergência hipertensiva é o achado de esquizócitos (células-elmo) no esfregaço de sangue periférico... Lembre-se numa hipertensão muito grave e aguda, pode haver lesão endotelial difusa na microcirculação, com necrose fibrinoide da camada íntima dos vasos. Os microtrombos formados levam à ruptura mecânica das hemácias circulantes, justificando uma anemia hemolítica microangiopática . No rim, tal processo justifica a instalação de uma glomerulopatia isquêmica aguda, o que promove azotemia, oligúria, proteinúria e hematúria... Assim, a melhor resposta aqui é a letra C.

134274.

Comentário: O edema pulmonar se forma quando a pressão capilar pulmonar excede a pressão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

coloidosmótica. Como o enunciado afirma que essa esta normal, ou seja, entre 15 e 18 mmHg, conclui-se que devemos manter a Pcap em torno desse valor. Gabarito opção C.

131372.

Comentário: Os sinais e sintomas descritos são clássicos de uma dissecção aórtica aguda (aneurisma dissecante). As condutas prioritárias são o alívio da dor (morfina ou derivados) e o controle da FC e da PA sistólica para níveis em torno de 60 bpm e 100-120 mmHg, respectivamente. A droga de primeira escolha, que deve ser feita antes dos demais anti-hipertensivos, tem que ser um betabloqueador intravenoso (ex. esmolol, labetalol). Esta etapa inicial de betabloqueio é imprescindível , pois a cada batimento sistólico uma cabeça de dissecção aumenta a separação entre as camadas íntima e média da aorta, agravando o quadro. Atingido o betabloqueio (se a PA ainda persistir acima do alvo citado) iniciamos um agente vasodilatador intravenoso como o nitroprussiato de sódio (como opção poderíamos utilizar um IECA intravenoso, como o enalaprilato, ou antagonistas de canais de cálcio, como nicardipina, diltiazem ou verapamil). Seja como for, é importante ter em mente que o vasodilatador não deve ser iniciado ANTES de se atingir o betabloqueio, pois a diminuição da resistência vascular periférica, conquanto seja benéfica no sentido de baixar a PA, será maléfica neste contexto porque vai acelerar o fluxo do jato sistólico, agravando também a dissecção na parede aórtica (os fatores que influem na progressão da dissecção aórtica são (1) frequência cardíaca (2) pressão arterial (3) velocidade do jato sistólico). Logo, existe mais de uma resposta possível aqui A, D e E. Questão extremamente malfeita, que teve como gabarito oficial da banca a letra D.

134036.

Comentário: Com PA na faixa entre 140-159 mmHg, para a sistólica, e 90-99 mmHg, para a diastólica, nosso paciente é considerado hipertensão ESTÁGIO 1, de acordo com a VI Diretriz Brasileira de HAS. Se este paciente apresentar 3 ou mais fatores de risco cardiovascular e ou diabetes mellitus (ou síndrome metabólica) e ou lesão de órgão-alvo (como hipertrofia ventricular esquerda), o risco cardiovascular adicional atribuído aquele estágio de HAS passa a ser considerado alto . Se não houvesse DM, LOA e nenhum outro fator de risco além da HAS, o risco

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

adicional seria baixo . Com 1 ou 2 fatores de risco cardiovascular além da HAS o risco seria moderado . E se houvesse alguma complicação da HAS plenamente instalada (ex. nefropatia, ICC), o risco seria muito alto . Logo, resposta certa C.

109718.

Comentário: As medidas não farmacológicas são de suma importância no tratamento da hipertensão arterial. Elas estão indicadas em todos aqueles que têm pressão arterial limítrofe ou HAS diagnosticada. Os pacientes estágio I de baixo ou médio risco cardiovascular podem tentar esta terapia de forma exclusiva por até seis e três meses, respectivamente. As principais recomendações são controle de peso, adoção da dieta DASH, redução do consumo de sal, moderação no consumo de álcool e prática habitual de exercícios físicos. Quanto ao café, a Diretriz Brasileira de HAS diz Os polifenóis contidos no café e em alguns tipos de chás têm potenciais propriedades vasoprotetoras. Os riscos de elevação da PA causados pela cafeína, em doses habituais, são irrelevantes. . Por esta razão, limitar a ingestão de café não se inclui entre as medidas modificadoras do estilo de vida para o controle da PA. Resposta C.

109986.

Comentário: Para acertar a questão, precisamos antes relembrar os estágios de evolução da insuficiência cardíaca - Estágio A paciente de risco para IC (HAS, coronariopatia, etc), porém ainda sem alteração cardíaca estrutural - Estágio B paciente já portador de alteração estrutural cardíaca, como Hipertrofia Ventricular Esquerda (HVE), disfunção sistólica ou diastólica ao ECO, doença valvar significativa ou áreas de infarto miocárdico - porém ainda sem sinais ou sintomas de IC - Estágio C IC sintomática - Estágio D IC refratária (fase terminal). Dessa forma, o estágio C corresponde, grosso modo , a qualquer paciente sintomático (dispneia, ortopneia) que não esteja em fase terminal da doença (sintomas graves e refratários ao tratamento). Resposta D.

110007.

Comentário: Existem diversas situações clínicas nas quais o débito cardíaco está normal ou até acima do esperado e, mesmo assim, o indivíduo apresenta quadro clínico compatível com insuficiência cardíaca, já que o débito encontra-se abaixo do necessário para suprir sua demanda

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

metabólica. Tal condição geralmente ocorre em estados hipercinéticos tireotoxicose, beribéri (por deficiência de tiamina), fístulas arteriovenosas, anemia, doença de Paget. Não se encaixa aí o tamponamento, que seria uma causa de insuficiência cardíaca de BAIXO débito (junto com a maioria das causas de IC, como cardiopatia isquêmica, hipertensiva, etc). Gabarito correto.

110063.

Comentário: Portadores de insuficiência do ventrículo esquerdo são beneficiados pelo uso de IECA, pois tal classe de medicamentos diminui o remodelamento ventricular, atrasando a evolução natural da doença e, desse modo, comprovadamente prolongando a sobrevida do paciente (A errada). A doença renal crônica avançada realmente pode impossibilitar o uso de IECA, uma vez que tal medicamento diminui a taxa de filtração glomerular, podendo desencadear síndrome urêmica aguda. Todavia, tal evento tende a ser mais provável somente quando a DRC já se encontra num estágio muito avançado, geralmente, com creatinina acima de 3,0 mg dl e não, 1,5 mg dl. Cumpre ressaltar, inclusive, que graus mais precoces de DRC também se beneficiam com o uso de IECA, pois tais fármacos conferem nefroproteção ao diminuir o surgimento de GESF secundária (sobrecarga dos néfrons remanescentes) e, assim, atrasar a evolução da própria DRC (C errada). Em relação ao limite inferior de segurança para a PA, assume-se o valor de 90 mmHg e não, 100 mmHg (D errada). Enfim, outra contraindicação clássica aos IECA é a presença de nefropatia isquêmica, isto é, estenose de artéria renal bilateral ou unilateral em rim único ao bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se encontra hiperestimulado de forma adaptativa nesses doentes, os IECA podem desencadear síndrome urêmica aguda neste contexto. Resposta certa B.

109766.

Comentário: Existem QUATRO classes de medicação de primeira linha para o tratamento de hipertensos diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensina II e bloqueadores dos canais de cálcio. Cada um deles pode ser usado, salvo contraindicação, em qualquer grupo de doentes, mas existem indicações específicas para certos fármacos, de acordo com características do pacientes, por exemplo iECA - hipertensos

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

que também são diabéticos. Bloqueadores dos receptores de angiotensina - indivíduos com indicação de uso de iECA, mas com efeitos colaterais (tosse crônica, por exemplo). Diuréticos tiazídicos - idosos. Resposta A.

109971.

Comentário: A dobutamina é um agonista beta-1 adrenérgico que exerce efeito prioritariamente inotrópico positivo (aumento do débito cardíaco pelo aumento da contratilidade miocárdica). A frequência cardíaca também pode aumentar (efeito cronotrópico positivo), e a resistência vascular periférica tende a cair com o aumento do débito cardíaco, o que é uma resposta fisiológica... Ora, se o débito cardíaco aumenta e a resistência vascular periférica cai, o que você acha que acontece com o fluxo esplâncnico (perfusão das vísceras intra-abdominais). É claro que este fluxo (que estava diminuido na situação de baixo débito) tende a melhorar bastante... Resposta certa C.

109741.

Comentário: As variáveis que interferem na oferta de oxigênio (DO2) podem ser vistas na fórmula abaixo DO2 DC (Hb x 1,34) SaO2 0,003 Pao2 Destes, os que podem sofrer maior interferência por medidas terapêuticas médicas s o dosagem de hemoglobina e débito cardíaco, o qual é determinado pela contratilidade miocádica e volume sistólico. É por isso que quando estamos diante de um choque séptico, por exemplo, tentamos melhorar o estado de choque com transfusão de concentrado de hemáceas objetivando hemoglobina 10 g dl ou infundimos inotrópicos, como dobutamina. A pressão venosa central é uma media de pressão das grandes veias de retorno ao átrio direito, refletindo a pressão de enchimento das cavidades direitas cardíacas ou pré-carga do VD. Assim, estima a volemia e função cardíaca, sem qualquer interferência em oferta de oxigênio.

110010.

Comentário: N o tem discuss o O quadro clínico descrito pelo autor é absolutamente típico de pericardite aguda. Então vamos revisar e complementar Os pacientes com pericardite aguda desenvolvem dor torácica precordial ou retroesternal contínua, tipo pleurítica, que piora com decúbito dorsal e é aliviada na posição sentada com o tronco inclinado para frente (posição de prece maometana ou genupeitoral) ou abraçado ao travesseiro (posição de Blechman). Pode haver

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

taquicardia e dispneia por hipoventilaç o associada a dor. Sucede ou concorre frequentemente com sintomatologia viral inespecífica, incluindo febre e astenia. O atrito pericárdico está presente em até 85% dos casos, caracterizando-se por um som áspero e evanescente. O ECG evolui em quatro fases, sendo clássico o estágio 1, em que há difuso supradesnível de ST com concavidade pra cima e infradesnível de intervalo PR. Pode complicar em até 15% dos casos com tamponamento cardíaco.

110608.

Comentário: O conceito mais aceito para a definição de Síndrome metabólica é proposto pelo National Cholesterol Education Program - ATP III. De acordo com este, na presença de três dos cinco critérios o paciente é classificado como portador de síndrome metabólica. S o eles Circunferência abdominal -Mulheres 88 cm -Homens 102 cm Pressão arterial sistólica 130 ou diastólica 85 mmHg Triglicerídeos 150 mg dl HDL-Colesterol -Mulheres 50 mg dl -Homens 40 mg dl Glicemia de jejum 100 mg dl Nenhuma resposta está perfeita. Mas a que melhor se encaixa no conceito é a letra A.

86639.

Comentário: Repare que o enunciado não fornece dados básicos do exame físico, como o nível tensional do paciente. No entanto, as opções de resposta não dão margem para dúvida este paciente apresenta alguma síndrome hipertensiva aguda. Ora, se ele tem taquidispneia e cefaleia holocraniana de início há 3 horas, com piora progressiva, seguramente se trata de uma emergência hipertensiva , o que significa que há lesão aguda de órgãos-alvo com ameaça iminente à vida do paciente (edema agudo de pulmão e encefalopatia hipertensiva, respectivamente). Logo, o tratamento deve consistir em controle pressórico imediato, lançando mão de poderosos anti-hipertensivos parenterais, como o nitroprussiato, por exemplo. Resposta certa C.

86864.

Comentário: Vamos lembrar o que acontece na insuficiência ventricular esquerda. A incapacidade da câmara esquerda de suprir às necessidades teciduais traduz-se por retenção de fluido nos pulmões. O que acontece de fato é que o sangue não é passado para a frente no sistema arterial e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

acaba havendo estase de sangue no interior do ventrículo esquerdo. Isto inicia um processo de aumento das pressões de enchimento ventricular esquerdo e atrial esquerdo. A pressão elevada no átrio esquerdo exerce influência direta na circulação pulmonar, causando hipertensão nessa circulação, o que causa a transudação de líquido e pode culminar com edema pulmonar. Essa alteração da dinâmica circulatória é que causa do que representa o principal sintoma da insuficiência cardíaca dispneia e seus correlatos, dispneia paroxística noturna e ortopneia. Resposta certa letra D.

86803.

Comentário: Para variar um pouco, o examinador não pediu os dois mais célebres efeitos colaterais dos IECA angioedema e tosse seca Vamos aproveitar e atribuir cada um dos efeitos colaterias a uma classe de drogas Hipersensiblidade cutânea -- IECA Rubor facial -- Bloqueadores dos canais de cálcio Bloqueio atrioventricular -- Betabloqueadores Alteração do paladar -- IECA. Resposta certa Letra D.

86637.

Comentário: Temos aqui uma hipertensa de cor parda, sedentária e tabagista, que apresenta PA fora do alvo preconizado, que para pessoas com 60 anos seria PA 140 x 90 mmHg de acordo com as novas diretrizes norteamericanas - o equivalente ao VIII Joint.. . Pois bem, alguma medida deve ser tomada visando a redução do risco cardiovascular, que neste caso é alto (20% em 10 anos de acordo com a escala de Framingham)... Segundo a já citada diretriz de hipertensão, as drogas de escolha para o paciente negro são justamente os tiazídicos e os antagonistas de cálcio diidropiridínicos (ex. anlodipino), exceto quando existe doença renal crônica (situação em que as drogas de escolha, mesmo em negros, passam a ser os IECA ou BRA). Não dá pra aumentar a dose do tiazídico, que já é máxima (25 mg dia), mas dá pra aumentar a dose de anlodipino (que pode chegar a 10 mg dia). Como a recomendação para a adoção de mudanças terapêuticas no estilo de vida (ex. abstinência do tabaco e prática de atividades físicas regulares) é importante para todos os hipertensos (em qualquer guideline), a melhor resposta para essa questão é sem dúvida a letra B. O gabarito oficial da banca, no entanto, foi a letra D...

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

158414.

Comentário: Questão tranquila. O paciente possui hipertensão arterial resistente, cuja definição é dada pelo não controle pressórico com uso de três drogas anti-hipertensivas em doses otimizadas, sendo pelo menos uma delas um diurético. Nesses casos, sempre devemos investigar uma causa de hipertensão arterial secundária... Em um paciente obeso, pletórico, com sonolência diurna, a melhor hipótese diagnóstica recai sobre a síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono. Resposta letra C.

158398.

Comentário: Vejamos os pontos-chave deste caso a paciente apresenta pico hipertensivo, associado a história de ortopneia e documentação de congestão pulmonar em radiografia de tórax. Estamos tratando de uma emergência hipertensiva o edema agudo de pulmão. Nesta entidade a conduta terapêutica consiste em redução de pré e pós-carga, além de controle de sobrecarga volêmica. Com esta finalidade podemos lançar mão de drogas vasodilatadoras arteriais, venodilatadores e diuréticos de ação rápida. É importante ressaltar que a furosemida possui como ação mais precoce a venodilatação, seguida somente então por seu efeito diurético. A ventilação não invasiva também exerce função dupla, visto que gera aporte de oxigênio e reduz o retorno venoso através da aplicação de pressão positiva na via aérea inferior (o aumento da pressão intratorácica promovido pela ventilação com pressão positiva comprime a veia cava inferior e reduz o retorno venoso). A intubação orotraqueal reserva-se aos casos de insuficiência respiratória aguda refratária às medidas não invasivas. Resposta letra C.

108575.

Comentário: Vejamos temos um senhor idoso e portador de hipertens o arterial sistêmica mal controlada, isto é, um paciente altamente susceptível ao desenvolvimento de lesões orgânicas decorrentes da HAS. O coração é um dos órg os-alvo desta doença e entre as manifestações possíveis temos a cardiopatia hipertensiva. Em fases avançadas, esta complicação pode levar a cardiomiopatia dilatada. Pela história e exame físico podemos concluir que nosso paciente justamente desenvolveu insuficiência cardíaca. O tratamento medicamentoso da disfunção

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ventricular esquerda inclui medicamentos que unicamente melhoram os sintomas e os que alteram a história natural da doença. Isto ocorre porque na patologia da doença ocorre um processo de remodelamento do coração desencadeado por sobrecarga ventricular e ação de mediadores neuro-humorais e citocinas. Os antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, atuam no remodelamento reverso, estando indicados nos pacientes com classe funcional NYHA III-IV ou casos selecionados em classe funcional II. A furosemida é uma grande arma no arsenal terapêutico da IC, principalmente no alívio de sintomas, porém, sem impacto na sobrevida. Os diuréticos tiazídicos podem ser utilizados neste grupo de pacientes, porém, também não interferem na história natural da doença. Portanto, o gabarito da questão é a letra B.

108576.

Comentário: A cardiomegalia pode estar presente em outras condições que não a Insuficiência Cardíaca (IC), inclusive em situações que evoluem para IC (hipertrofia ventricular esquerda em certas valvulopatias ou na hipertensão arterial - A errada). Por conta da dilatação do coração como um todo, pode haver também aumento da área do anel valvar, determinando insuficiência de valva cardíaca. Quando as valvas mitral e tricúspide estão insuficientes, auscultamos sopro sistólico (B errada). Por conta de congestão intestinal na IC, pode haver anorexia e, inclusive, muitas vezes evitamos medicações ORAIS nos pacientes descompensados do ponto de vista cardíaco, já que tal congestão também impede a absorção intestinal. Resposta D.

327229.

Comentário: Como o próprio enunciado destacou, a maioria das doenças que causam insuficiência cardíaca (IC) se caracterizam pela redução do débito cardíaco. Isso acontece, por exemplo, quando há isquemia e morte de células miocárdicas em um paciente com insuficiência coronariana em pacientes que evoluem com miocardiopatia dilatada pela doença de Chagas e, de forma ainda mais aguda, nos casos de miocardite viral - pela inflamação do miocárdio. Contudo, existem situações nas quais o débito cardíaco está normal ou até acima do esperado e, mesmo assim, o indivíduo apresenta quadro clínico compatível com insuficiência cardíaca, já que o débito encontra-se abaixo do necessário para suprir sua demanda metabólica. Tal condição geralmente ocorre em estados

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hipercinéticos tireotoxicose, beribéri, fístulas arteriovenosas, anemia, doença de Paget. Existe ainda associação entre obesidade grave e IC de alto débito, embora o mecanismo não seja bem compreendido. Na IC de alto débito, o indivíduo, apesar de cansado, dispneico e por vezes congesto, apresenta-se vasodilatado, com extremidades quentes, taquicárdico, com pressão de pulso normal ou elevada. Resposta letra C.

327230.

Comentário: A hipertensão mascarada ocorre quando a pressão arterial (PA) é normal no consultório, mas é elevada fora dele. Pode ser detectada em cerca de 7 a 8% dos indivíduos no consultório, atingindo aproximadamente 15% dos pacientes normotensos. Vários fatores estariam envolvidos, como idade avançada, sexo masculino, tabagismo, consumo de álcool, atividade física, hipertensão induzida pelo exercício, ansiedade, estresse, obesidade, diabetes, doença renal crônica e história familiar de hipertensão arterial. Ela está associada à dislipidemia, à disglicemia, à lesão de órgão alvo, à pré-hipertensão e à atividade adrenérgica e aumenta o risco de desenvolver diabetes e hipertensão sustentada. A incidência de eventos CV é cerca de duas vezes maior na hipertensão mascarada do que em normotensos, sendo comparável à dos hipertensos de fato. Cuidado para não confundir com a hipertensão do jaleco branco Neste caso, a PA é elevada no consultório, mas é normal fora dele. Resposta letra B.

298202.

Comentário: Vamos analisar as assertivas sobre a insuficiência cardíaca (IC) A) INCORRETA. Anemia e gravidez são causas de IC de alto débito. B) INCORRETA. IC crônica são aqueles pacientes com diagnóstico estabelecido de IC ou ocorrência dos sintomas de forma gradual . C) CORRETA. A IC crônica é subdividida em dois grupos (1) IC com fração de ejeção normal do ventrículo esquerdo (FE 50%), a ICFEN (2) IC com fração de ejeção reduzida do ventrículo esquerdo (FE 40% algumas referências citam 40%), a ICFER. Os termos ICFEN e ICFER substituíram os antigos termos insuficiência cardíaca diastólica e sistólica , respectivamente. Pacientes com fração de ejeção entre 40-49% possuem FE borderline ou limítrofe intermediária, e muitos autores os enquadram no conceito de FE normal ou preservada (ICFEN). D) INCORRETA.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Os termos ICFEN e ICFER substituíram os antigos termos insuficiência cardíaca diastólica e sistólica , respectivamente. Resposta letra C.

298204.

Comentário: De acordo com as Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020, em pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador que possuam hipertensão arterial, diabéticos ou não, a meta de PA é 130 80 mmHg . Metas mais estritas podem ser almejadas em casos selecionados, sob estrita vigilância e após compartilhamento de riscos com o paciente (LETRA A CORRETA). Com relação ao tratamento medicamentoso, os IECA ou os BRA estão indicados em hipertensos com ou sem albuminúria, sendo contraindicada sua associação. Os diuréticos tiazídicos ou de alça, estes últimos no caso de DRC estágios G4-G5, e os bloqueadores de canal de cálcio são eficazes, principalmente em associação a IECA ou BRA. Os betabloqueadores estão indicados na doença arterial coronariana e na insuficiência cardíaca. Antagonistas dos receptores mineralocorticoides são medicamentos que diminuem a proteinúria, porém podem causar hipercalemia. Resposta letra A.

286703.

Comentário: Pensando nos critérios de Framingham, os mais clássicos para diagnóstico de insuficiência cardíaca, temos como critérios maiores (mais específicos) (1) dispneia paroxística noturna, (2) turgência jugular patológica, (3) estertores pulmonares, (4) cardiomegalia no Rx de tórax, (5) edema agudo de pulmão, (6) B3, (7) PVC 16 cm H2O, (8) refluxo abdominojugular, (9) perda de peso 4,5 kg em cinco dias de tratamento diurético. A melhor resposta seria a letra D, porém, a banca havia dado como letra C e depois resolveu anular a questão sabe-se lá porquê...

252212.

Comentário: Insuficiência ou regurgitação mitral é a incapacidade de fechamento da valva mitral durante a sístole cardíaca, permitindo o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. O sopro holossistólico em ponta (foco mitral) é o sopro característico da insuficiência mitral. Resposta C.

256579.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Relembrando os PERFIS clínico-hemodinâmicos da insuficiência cardíaca descompensada, temos Perfil A (quente e seco) COM Perfusão periférica adequada e SEM evidência de congestão Perfil B (quente e úmido) mais comum COM Perfusão periférica adequada e COM evidência de congestão Perfil C (frio e úmido SEM Perfusão periférica adequada e COM evidência de congestão Perfil D ou L (frio e seco) SEM Perfusão periférica adequada e SEM evidência de congestão No caso da questão, há a descrição de BOA PERFUSÃO CAPILAR periférica portanto, podemos concluir que não se trata do perfil C ou L (LETRAS A e C INCORRETAS). Em relação ao grau de congestão pulmonar, é nítida a presença de sinais de sobrecarga volêmica retrógrada, levando à crepitação nas bases pulmonares, hipertensão pulmonar (P2 A2) e edema de membros inferiores (LETRA A INCORRETA). Resposta letra B.

208359.

Comentário: Questão sobre INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC) interessante. A banca cobra os conceitos fisiopatológicos e nomenclatura. Devemos marcar a correta, vamos analisar. A CORRETA. Perfeito Na IC crônica agudizada, o paciente pode evoluir também com disfunção diastólica devido à gravidade do componente sistólico, a disfunção global. B INCORRETA. Isso ocorre na IC aguda e não crônica. C INCORRETA. Edema agudo ocorre com altas pressões de enchimento nas câmaras esquerdas. D INCORRETA. A IC direita pode ocorrer com débito cardíaco e pressão normal, pois o ventrículo esquerdo, principal responsável pelo débito, encontra-se normal. Resposta letra A.

176014.

Comentário: Carey Coombs é um sopro diastólico auscultado no foco mitral. Ele é explicado pela restrição funcional à abertura dos folhetos mitrais devido à presença de intenso edema nestes folhetos (valvulite), tal qual acontece nos quadros de cardite reumática aguda. Logo, tal sopro é simplesmente clássico desta condição Resposta certa B.

176035.

Comentário: O paciente apresenta insuficiência cardíaca com congestão pulmonar e sistêmica, porém, com boa perfusão periférica (PA limítrofe, extremidades normotérmicas com enchimento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

capilar normal). Trata-se do perfil quente e úmido da IC descompensada, ou perfil B, justamente o perfil mais frequentemente encontrado na prática. Resposta certa B.

176074.

Comentário: Com apenas uma medida de PA elevada, não podemos afirmar que o paciente é definitivamente hipertenso Na realidade, isso até poderia ser feito se fosse um paciente de alto risco cardiovascular ou se os níveis pressóricos estivessem absurdamente altos (180 x 110 mmHg). Para um caso como o do paciente em tela, a conduta consiste em repetir a aferição da PA, tanto numa próxima visita ambulatorial quanto pelas estratégias de Monitorização Residencial da PA (MRPA) ou Monitorização Ambulatorial da PA (MAPA), sendo ideal utilizar pelo menos uma dessas duas últimas. De acordo com a VII Diretriz Brasileira de HAS , a estratégia de MRPA é descrita da seguinte forma (1) obter a média de três medidas antes do café da manhã e três medidas antes do jantar, durante cinco dias ou (2) obter a média de duas medidas antes do café da manhã e duas medidas antes do jantar, durante sete dias . Logo, nenhuma alternativa corresponde ao que preconiza a referência nacional. A banca deu como gabarito a letra D, mas, formalmente, a letra D também está errada. Questão sem resposta certa, que merecia ter sido anulada

151883.

Comentário: Sopro diastólico é SEMPRE patológico Um sopro diastólico em foco mitral, associado à hiperfonese de B1, é achado característico da estenose mitral , que tem como principal etiologia em jovens as sequelas de uma cardite reumática prévia . A hiperfonese de P2 (P2 A2) reflete nesse contexto a existência de algum grau de hipertensão pulmonar, complicação natural da estenose mitral. A queixa de dispneia progressiva aos esforços também é típica desta condição Logo, só poderíamos marcar a letra B. O tratamento medicamentoso é voltado para o controle dos sintomas, sendo fundamentado, no que tange à congestão pulmonar, no uso de diuréticos de alça (ex. furosemida). Os betabloqueadores podem até ser usados, mas não é o principal medicamento para o controle da dispneia. Lembre-se de que os BB são úteis para controle da frequência cardíaca, e que quanto maior a frequência cardíaca, menor é o tempo de enchimento diastólico, sendo maior, consequentemente, a sobra de sangue no interior do átrio esquerdo, o que faz aumentar a pressão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hidrostática desta câmara (a qual se reflete, dada a ausência de válvulas nas veias pulmonares, sobre a circulação venocapilar pulmonar, causando congestão). Assim, os BB podem ser adjuvantes da diureticoterapia de alça em pacientes com sintomas crônicos de congestão pulmonar, bem como em pacientes que se apresentam em franco edema agudo de pulmão e naqueles com fibrilação atrial. O método de escolha para confirmar o diagnóstico de estenose mitral e estratificar sua gravidade é o ecocardiograma, preferencialmente transesofágico. Seja como for, a melhor resposta ainda é a letra B.

151899.

Comentário: A classificação clínica e hemodinâmica de Stevenson é tradicionalmente empregada na avaliação de pacientes que se apresentam com insuficiência cardíaca aguda (ou crônica descompensada). Ela se baseia numa análise combinada do grau de adequação da perfusão periférica e do grau de congestão pulmonar. Desse modo, 4 perfis clínico hemodinâmicos são descritos (1) perfil A quente e seco (perfusão periférica adequada, ausência de congestão pulmonar - isto é, paciente SEM DESCOMPENSAÇÃO CARDÍACA AGUDA). (2) perfil B quente e úmido (perfusão periférica adequada, congestão pulmonar). (3) perfil L frio e seco (perfusão periférica reduzida, ausência de congestão pulmonar). (4) perfil C frio e úmido (perfusão periférica reduzida, congestão pulmonar). Resposta certa D.

139123.

Comentário: Quando não podemos utilizar os betabloqueadores Pelo seu efeito inotrópico e cronotrópico negativo, os betabloqueadores são formalmente contraindicados em caso de bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, bradicardia 50 bpm, e hipotensão arterial com pressão sistólica 80 mmHg ou choque hemodinâmico. (C INCORRETA) Paralelamente, devido ao seu efeito bloqueador de receptores beta2 pulmonares e do músculo liso de vasos periféricos, os betabloqueadores levam ao maior risco de episódios de broncoespasmo e vasoespasmo periférico, sendo também contraindicação relativa seu uso na asma DPOC e na doença vascular periférica grave. (A e B INCORRETAS) A insuficiência cardíaca da miocardiopatia dilatada não é uma contraindicação e sim uma poderosa indicação para o uso de betabloqueadores, preferencialmente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardioseletivos, permitindo inclusive prolongamento da sobrevida desses pacientes. Resposta letra D

103791.

Comentário: O edema pulmonar nada mais é do que uma transudação de líquido do intra para o extravascular no interior do parênquima alveolar. Essa transudação - tal qual outras formas de edema - ocorre por um desequilíbrio nas forças de Frank-Starling da microcirculação, isto é o somatório da pressão oncótica do tecido com a pressão hidrostática intravascular supera o somatório da pressão oncótica intravascular com a pressão hidrostática do tecido. Ora, se algum fator aumentar a pressão oncótica do plasma (intravascular), teremos uma força que se contrapõe à formação de edema Todas as demais opções são causas clássicas de edema pulmonar. Resposta certa B.

103798.

Comentário: O feocromocitoma é uma neoplasia rara das células cromafins, hipersecretante de catecolaminas. Causa hipertens o arterial lábil com picos significativos ou crônica de difícil controle, associada à tríade clássica cefaleia, sudorese e palpitações. Pode também haver hipotensão. Com certa frequência as questões cobram a regra dos 10 10% dos tumores s o malignos 10% dos tumores são bilaterais 10% (10-15%) dos tumores são extra-adrenais (paragangliomas) 10% dos tumores são pediátricos 10% dos tumores são familiares. A letra C é a única falsa

81986.

Comentário: Haverá desigualdade entre os pulsos arteriais dos membros superiores toda vez que houver obstrução vascular após a emergência do tronco braquiocefálico direito (o primeiro grande ramo do arco aórtico). Assim, na dissecção aórtica que se origina após o referido vaso, bem como na doença de Takayasu (uma vasculite da aorta e seus ramos que quase sempre se inicia pelo acometimento seletivo da artéria subclávia esquerda), é esperada uma assimetria entre os pulsos arteriais dos membros superiores (sendo o direito maior que o esquerdo). O termo estenose aórtica supravalvar significa o seguinte existe obstrução da aorta em algum ponto acima da valva aórtica. Ora, isso abre um amplo leque de possibilidades, por exemplo, uma coarctação congênita da aorta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

localizada após a emergência do tronco braquiocefálico direito (a maior parte das coarctações congênitas de aorta apresenta essa característica). A letra E dispensa comentários. Enfim, uma estenose aórtica SUBVALVAR, como pode acontecer na cardiomiopatia hipertrófica septal (o septo assimetricamente hipertrofiado encosta no folheto anterior da valva aórtica, promovendo uma obstrução ao trato de saída do ventrículo esquerdo), reduz a onda de pulso simetricamente em ambos os lados. Resposta certa C.

80961.

Comentário: Na dissecção aguda de aorta existe um rasgo na camada íntima da parede deste grande vaso arterial permitindo a entrada de sangue pulsátil sob pressão. Por força da pressão sistólica máxima (aquela observada no lúmen aórtico durante a sístole ventricular), dá-se uma separação entre as camadas íntima e média, isto é, a dissecção propriamente dita. Em casos extremos o sangue pode achar o caminho até a camada adventícia, quando então existe risco de ruptura espontânea da aorta (o que, evidentemente, costuma provocar morte súbita). A abordagem inicial de todas as formas de dissecção aórtica aguda, por conseguinte, consiste num controle imediato e certeiro da pressão sistólica, o que é feito com o mais potente anti-hipertensivo parenteral que existe, o nitroprussiato de sódio (Nipride). Como o efeito mecânico da dissecção também é influenciado pelo pico sistólico, isto é, pela variação entre a menor e a maior pressão dentro da aorta, é preciso lançar mão de alguma droga que reduza a frequência dessa variação, ou seja, que reduza a frequência cardíaca. Assim, está indicado associar um betabloqueador intravenoso. Vale lembrar que nas dissecções aórticas agudas que acometem a croça aórtica, o tratamento definitivo deve ser cirúrgico (colocação de um tubo aórtico). Já nos casos de dissecção aguda da porção descendente da aorta torácica ou abdominal o tratamento pode ser conservador. Resposta certa B.

81956.

Comentário: Analisando as alternativas A) FALSA. A sepse cursa com diminuição da Resistência Vascular Periférica (RVP) e aumento da pulmonar, diminuindo o aporte sanguíneo ao Ventrículo Esquerdo (VE). Portanto, diminui a pré-carga. B) VERDADEIRA. A regurgitação mitral gera uma

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dilatação secundária do átrio esquerdo, gerando um maior aporte sanguíneo ao VE, que por sua vez AUMENTA A PRÉ-CARGA ventricular. Nosso gabarito. C) FALSA. A falência do ventrículo direito reduz o aporte sanguíneo para a circulação pulmonar, consequentemente reduzindo o aporte ao VE. Diminui a pré-carga. D) FALSA. Desidratação reduz o volume sanguíneo total, reduzindo tanto a pré quanto a pós-carga ventricular, já que o aporte sanguíneo está reduzido generalizadamente. E) FALSA. A embolia pulmonar aumenta a resistência vascular pulmonar, diminuindo a chegada de sangue ao VE, causando redução da pré-carga. Gabarito letra B.

81968.

Comentário: Temos um paciente de 58 anos, obeso, que se apresenta com níveis tensionais elevados e preenche critério para o diagnóstico de diabetes mellitus (duas glicemias de jejum ou igual a 126 mg dl). Logo, além de orientarmos o início de medidas comportamentais (como dieta e atividade física, objetivando a perda de peso), temos que iniciar o rastreio de complicações vasculares do diabetes (nefropatia, retinopatia) e também iniciar tratamento farmacológico para HAS e DM. A solicitação do TOTG é completamente desnecessária, visto que o paciente já possui critérios diagnósticos para o diabetes. Alternativa A.

80930.

Comentário: Não basta decorar Devemos sempre usar a lógica para respondermos questões sobre fatores de risco e ou proteção. O tema da vez é DCV e DM. Apesar de estarem presentes ao mesmo tempo em grande parte dos casos, é importante ressaltar que na maioria deles a diabetes acaba sendo o desencadeador da doença cardiovascular, e na outra parte estão juntas por outras razões. Ou seja, a diabetes mellitus pode ser vista como fator de risco para a doença cardiovascular, mas o contrário não ocorre. Vamos raciocinar sobre os fatores citados A) Falsa. Genética, tudo bem. Mas o consumo excessivo de sal não é risco para desenvolver DM, e sim para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e, consequentemente, DCV. B) Falsa. Ocupações estressantes podem ser, mais uma vez, associadas a HAS e DCV, mas nunca a DM. Baixa escolaridade, apesar de pouco citada, é vista como risco para ambas as condições, segundo alguns estudos, mas não devemos valorizá-la durante uma prova de concurso, a não ser que não

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

exista outra alternativa melhor. C) Falsa. Ocupações menos qualificadas também não têm qualquer relação com ambas as condições. D) Falsa. Hipercolesterolemia não tem relação com DM. E) Perfeito. Sedentarismo e obesidade, componentes da síndrome metabólica, são vistos como importantes fatores de risco para ambas as condições. Sem decoreba, gabarito letra E.

60829.

Comentário: Lesões de Janeway são características da endocardite infecciosa pulso parvo e tardo é uma alteração encontrada na ESTENOSE aórtica aracnodactilia é um achado constitucional da síndrome de Marfan e xantelasmas são depósitos cutâneos de gordura vistos nas síndromes de hiperlipidemia. Ora, o famoso sinal de Musset (balanço da cabeça a cada batimento cardíaco) é clássico da insuficiência aórtica grave, impulsionado pelo hiperfluxo de sangue nas artérias cervicais. Resposta certa letra C.

60838.

Comentário: A presença de turgência jugular patológica (verificada com o tórax do paciente a uma inclinação de 45), aliada ao clássico sinal de Kussmaul (aumento ou não colabamento da jugular interna durante inspiração profunda) são sinais do exame físico que revelam uma importante restrição diastólica do ventrículo direito (restrição ao enchimento dessa câmara). Quando combinados ao encontro de um knock pericárdico (um estalo grosseiro auscultado no precórdio logo no início da diástole), tais achados permitem o diagnóstico clínico de PERICARDITE CONSTRITIVA, uma condição que ainda pode cursar com hepatomegalia congestiva, ascite e edema de membros inferiores, bem como combinações variadas de todas essas queixas (ex. ascite sem edema de membros inferiores). A pericardite constritiva (formação de uma carapaça fibrosa em torno do coração) pode ser uma consequência tardia de qualquer forma de pericardite aguda (incluindo pericardite aguda viral e pericardite pós-cirurgia cardíaca). Seu tratamento definitivo deve ser a pericardiectomia. Resposta certa letra B.

61535.

Comentário: As VI diretrizes de Hipertensão Arterial da SBC estabelecem como meta pressórica para hipertensos estágios 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio o valor habitual para os

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

hipertensos, isto é, uma PA 140 x 90 mmHg. Para os demais pacientes (hipertensos e comportamento limítrofe com risco cardiovascular alto e muito alto, ou com 3 ou mais fatores de risco, DM, síndrome metabólica ou lesões em órgãos-alvo, ou ainda portadores de insuficiência renal com proteinúria 1,0 g l) o alvo é PA 130 x 80 mmHg. Resposta A.

60837.

Comentário: Apesar da maioria dos hipertensos necessitar de terapia medicamentosa, sabemos que o tratamento não é baseado APENAS nessa estratégia. Na realidade, todo paciente que recebe fármacos anti-hipertensivos deve também aderir às modificações no estilo de vida, que exercem efeitos comprovadamente sinergísticos com as medicações. Além do mais, existem situações onde somente as medidas conservadoras estão indicadas (ex. pré-hipertensão) (A errada). De todos os agentes anti-hipertensivos considerados de primeira linha, um dos que promove as reduções mais pronunciadas na morbimortalidade cardiovascular (particularmente em relação à ocorrência de eventos cerebrovasculares) são os diuréticos tiazídicos . Logo, idealmente tal classe deveria sempre ser prescrita a todos os hipertensos de qualquer estágio, na ausência de contraindicações (C e D erradas). Dentre as modificações de estilo de vida com eficácia comprovada, podemos citar a moderação no consumo de álcool etílico , o abandono do tabagismo e perda de peso com controle da obesidade central . Atente para este último detalhe, pois o acúmulo periférico de gordura (citado pela alternativa E) acarreta risco cardiovascular significativamente inferior ao acarretado pela obesidade mais centrípeta. Resposta certa B.

46731.

Comentário: A síndrome de Eisenmenger , em termos bem simples, é a hipertensão pulmonar grave que se desenvolve em decorrência da existência de um shunt esquerda-direita crônico (ex. defeito de septo atrial ou ventricular) Quando ela se instala, a direção do shunt se inverte (isto é, por conta da hipertensão pulmonar acentuada, o fluxo de sangue pelo shunt passa a ser da direita para a esquerda, e o paciente desenvolve cianose). Pois bem, só com esta explicação vemos que a letra A está errada (há sinais de hipertensão pulmonar, bem pode haver sopro cardíaco e cianose sistêmica). A letra B fala em resistência vascular pulmonar reduzida (errado, é aumentada). A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

chamada pressão de pulso nada mais é que a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. Um aumento da pressão de pulso reflete a existência de um débito sistólico alto, o que se associa a um aumento do débito cardíaco (DC DS x FC). A letra E não fala nada com nada. Sobrou a letra C na vigência de hipertensão pulmonar ocorre sobrecarga pressórica do ventrículo direito. Um VD sobrecarregado e dilatado costuma ser palpável no precórdio, como um impulso paraesternal ou subcostal (sinal erroneamente chamado por alguns de ictus de VD) Resposta certa C.

46725.

Comentário: Os únicos betabloqueadores que comprovadamente mostraram reduzir a morbimortalidade da IC com Fração de Ejeção de VE (FEVE) reduzida em estudos clínicos prospectivos foram o bisoprolol , o carvedilol e o metoprolol . O grande benefício dos betabloqueadores vem do fato de que essas drogas conseguem bloquear o efeito miocardiotóxico de um excesso sustentado de liberação de catecolaminas sobre o coração. Na IC com baixa FEVE, o sistema nervoso simpático (adrenérgico) encontra-se constantemente hiperativado na tentativa de compensar a queda no débito cardíaco. O mesmo princípio se aplica às drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, como os IECAs e BRAs, que reduzem os efeitos miocardiotóxicos da angiotensina II sobre o coração. A digoxina é útil na IC com FEVE reduzida fibrilação atrial, pois ao mesmo tempo em que melhora a contratilidade miocárdica também bloqueia o nódulo AV, reduzindo a resposta ventricular a esta taquiarritmia. Além dos betabloqueadores, dos IECAs e dos BRAs, outras classes farmacológicas também mostraram reduzir a morbimortalidade em pacientes refratários ou com contraindicação a essas drogas (particularmente negros) estamos falando da combinação de HIDRALAZINA NITRATO (no caso, dinitrato de isossorbida, que tem meia-vida mais longa), que é igualmente comprovada Logo, resposta certa E.

46718.

Comentário: A estenose aórtica é uma das lesões valvares mais frequentes dos pacientes idosos. Sabemos que na maioria das vezes esta lesão é assintomática e, quando os sintomas aparecem (EA sintomática), chegou a hora de indicar a cirurgia de troca valvar, pois, a partir do surgimento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

do primeiro sintoma - geralmente a síncope -, a sobrevida do paciente passa a ser mensuravelmente muito curta síncope, dor torácica, dispneia. O exame físico da EA é característico (1) na palpação do precórdio, temos um ictus cordis tipicamente sustentado (2) na palpação de pulsos arteriais centrais, podemos ter um pulso parvo e tardo (fraco e tardio em relação à primeira bulha) (3) na ausculta cardíaca, temos um sopro sistólico melhor audível nos focos aórtico e aórtico acessório, que tipicamente se irradia para a base do coração e pode se associar ao fenômeno de Gallavardin (sopro audível nos focos da base, com intervalo auscultatório na borda esternal esquerda baixa e ressurgimento do sopro no foco mitral - com um timbre diferente - , podendo dar a falsa impressão da existência de um sopro de insuficiência mitral). Resposta certa E.

34115.

Comentário: Os fármacos associados à redução de mortalidade na IC sistólica são IECA, BRA, betabloqueador e espironolactona. Estudos recentes também apontam o benefício da associação hidralazina nitrato, particularmente em negros que não toleram IECA ou BRA. O Harrison , em sua última edição, ainda indica a associação hidralazina nitrato a todos os pacientes negros com IC sistólica classe funcional II a IV da NYHA, mesmo aqueles já em uso de IECA ou BRA, conforme o recomendado pela HFSA (Heart Failure Society of America). Na ausência de opção completa, contendo BRA, ficaremos com a letra C.

34116.

Comentário: A insuficiência cardíaca consiste em uma síndrome clínica na qual o coração se torna incapaz de garantir um débito cardíaco adequado à demanda tecidual ou só o faz à custa do aumento de suas pressões de enchimento. Buscando um maior entendimento desta síndrome, podemos classificá-la de diferentes formas. Uma delas, de acordo com o tipo de função predominantemente acometida, isto é, se disfunção sistólica ou diastólica. Dentre as causas de insuficiência cardíaca diastólica (em que a função sistólica está preservada), temos hipertensão arterial, doença coronariana, cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatias restritivas (sarcoidose, amiloidose, endomiocardiofibrose) e pericardite constrictiva. A cardiomiopatia periparto não se encaixa neste grupo, pois se caracteriza por dilatação ventricular, constituindo uma causa de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

insuficiência sistólica (ou com fração de ejeção reduzida). Resposta C.

34119.

Comentário: Dentre as opções fornecidas todas com exceção da letra D podem levar à disfunção cardíaca e consequentemente ao choque cardiogênico. Isso porque o hemotórax levaria a outro tipo de choque o hipovolêmico. Resposta D.

34176.

Comentário: Veja bem todas as condições citadas pelas alternativas da questão são etiologias possíveis de insuficiência cardíaca em pacientes pediátricos Entretanto, aquelas mais provavelmente observadas em indivíduos na faixa etária adolescente são a febre reumática e a anemia falciforme. A doença de Kawasaki (através da ocorrência de vasculite coronariana e infarto agudo do miocárdio) e as malformações cardíacas congênitas são encontradas com maior probabilidade na faixa etária pré-adolescente. Resposta certa C.

34300.

Comentário: Temos aqui um paciente tabagista com sobrepeso e hipertensão que realiza primeira consulta na unidade de saúde. Pela classificação do VII Joint, seria estágio II (pela VI Diretrizes Brasileiras estágio III) - A correta, mas questionável. De qualquer forma, sendo classe II ou III deve-se iniciar prontamente terapia farmacológica - B correta. Alterações no estilo de vida como cessação do tabagismo também estão indicadas - C correta. A princípio, seu acompanhamento segue na própria unidade de saúde, mas caso ela seja de difícil controle, caracterizando-o como portador de HAS resistente, o acompanhamento com especialista é recomendável E correta. Por último, descartamos a opção D, pois eletroencefalograma e hipertensão não fazem parte dos exames iniciais a serem solicitados no hipertenso. Lembrando mais uma vez, seria potássio, creatinina, EQU, ECG, glicemia de jejum, colesterol total e HDL, triglicerídeos e ácido úrico. Resposta D.

26441.

Comentário: Questão tranquila. As drogas utilizadas no tratamento da Insuficiência Cardíaca (IC) com FE reduzida que alteram a mortalidade (melhoram a sobrevida) são (1) Inibidores da ECA (2)

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Betabloqueadores (3) Antagonistas da aldosterona (4) Antagonistas dos receptores da angiotensina e (5) Hidralazina Nitrato. Os digitálicos, como a digoxina, não demonstraram em nenhum estudo redução da mortalidade, devendo ser utilizados com objetivo de melhora sintomática em pacientes classe III-IV da NYHA que não compensam com uso de IECA, betabloqueador e diurético. Outra indicação da digoxina no tratamento da IC é nos casos de fibrilação atrial de alta resposta ventricular que não são controlados pelos betabloqueadores. Resposta Letra C.

26442.

Comentário: A medida da pressão arterial (PA) deve ser feita com o paciente em repouso, em ambiente calmo, como o menor estresse possível e sem efeito de nenhuma substância pressórica circulante (nicotina, café, descongestionantes, etc). O método de escolha para a aferição da PA no consultório ou domicílio é a esfigmomanometria. Neste método, o tamanho do manguito deve circundar pelo menos 80% da circunferência do braço, pois quando o manguito é menor (num paciente obeso) a PA será superestimada (D CORRETA). O cuff deve ser insuflado até 20mmHg acima da PA sistólica (estimada pelo desaparecimento do pulso radial) e então desinsuflado numa velocidade aproximada de 3mmHg seg, para auscultar os sons de Korotkoff com o estetoscópio. A PA sistólica corresponde à fase I (aparecimento do som), enquanto a PA diastólica é a fase V (desaparecimento do som). O hiato auscultatório é o desaparecimento dos sons durante a última parte da fase I e a fase II. Este hiato pode cobrir uma faixa de 30 a 40 mmHg, podendo deste modo ser causa de subestimação da PA. Para evitá-lo, realizamos o método palpatório antes do auscultatório (B CORRETA). Sabemos que os sons de Korotkoff são originados pelas vibrações de abrir e fechar das artérias e que em alguns pacientes (como os idosos) as paredes das artérias são muito endurecidas (pela arteriosclerose e calcificação), o que faz com que estas artérias não se colabem mesmo com pressões acima da PA diastólica, e mantêm-se abrindo e fechando mesmo com pressões acima da PA sistólica. Ao aferir a PA nestes pacientes constataremos, portanto, um falso aumento da PA, que chamamos de Pseudo-hipertensão arterial. Um dado que pode ajudar no diagnóstico desta condição é a manobra de Osler, que consiste na palpação da artéria endurecida (sem pulso), mesmo após insuflação do manguito a níveis superiores à PA sistólica aferida (A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

CORRETA). Um grande número de pacientes apresenta PA elevada apenas quando um médico ou profissional da saúde afere sua pressão. Quando a PA é aferida em casa por parentes ou amigos, ou quando seus valores são obtidos pela MAPA, quase todas as medidas são normais. Esta situação é denominada de Hipertensão do Jaleco Branco (C CORRETA). O hiato auscultatório e a pseudo-hipertensão são situações frequentes de erro da PA em pacientes idosos, e não em gestantes (E ERRADA). Resposta Letra E.

26481.

Comentário: O quadro clássico do tamponamento cardíaco é descrito nos termos da famosa tríade de Beck turgência jugular, hipotensão arterial e hipofonese das bulhas cardíacas. Essas três manifestações se justificam da seguinte forma (1) o acúmulo de líquido no espaço pericárdico comprime externamente o coração, que fica, portanto, com o retorno venoso dificultado aumenta a pressão venosa central , que é a pressão no átrio direito, transmitindo-se retrogradamente às veias jugulares (turgência) (2) da mesma forma que o retorno venoso do VD é prejudicado, o do VE também não será o mesmo Ocorre redução na pré-carga do VE e, por conseguinte, redução no débito cardíaco (queda na pressão arterial) (3) a camada de líquido em torno do coração bloqueia a propagação do som das bulhas (hipofonese). Vale lembrar que a maioria dos doentes com tamponamento não se apresenta com a tríade completa. Agora, apesar de muitos autores classificarem o choque decorrente de tamponamento cardíaco como choque obstrutivo (semelhante ao TEP), outros enfatizam mais o aspecto cardiogênico desse tipo de choque como é preciso que ocorra diástole para haver sístole, no tamponamento o miocárdio ventricular não consegue exercer sua funcionalidade (literalmente, encher para esvaziar) A disfunção ventricular tem termos conceituais, pode ser primariamente sistólica ou diastólica, e no tamponamento cardíaco o principal problema está na insuficiência diastólica que eleva as pressões de enchimento e responde pela queda no débito cardíaco. Além disso, ocorre também certo grau de obstrução ao fluxo aórtico, devido à compressão exercida pelo derrame ao nível da emergência deste grande vaso. Logo, sobrou a alternativa B que é a resposta da questão não ocorre desvio de mediastino, uma vez que o sangue se acumula uniformemente ao redor do coração... Resposta certa letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

26685.

Comentário: Os três principais sintomas causados pela estenose aórtica (em fases avançadas) são angina, síncope e dispnéia Todo portador de EA grave deve possuir hipertrofia ventricular esquerda (HVE), uma vez que a restrição crônica e progressiva ao fluxo aórtico gera um mecanismo adaptativo no miocárdio de modo que sua contratilidade aumenta à custa de importante hipertrofia concêntrica Com o tempo, contudo, ocorre degeneração dos cardiomiócitos, e o ventrículo hipertrofiado acaba entrando numa fase de grande dilatação As consequências hemodinâmicas da EA podem ser facilmente identificadas no exame físico através da percepção de um pulso arterial parvus et tardus , isto é, um pulso fraco (baixa amplitude) e retardado em relação à sístole do VE... Conforme dissemos, todo portador de EA grave deve ter HVE concêntrica. O ictus cordis da HVE concêntrica é tipicamente propulsivo e sustentado (hiperativo), porém, estamos falando de um ictus eutópico (5º espaço intercostal esquerdo, linha hemiclavicular) O deslocamento do ictus reflete a dilatação da câmara ventricular, que faz com que a ponta do coração fique mais à esquerda e para baixo Ora, então não esperamos um ictus ao mesmo tempo propulsivo e desviado Cada uma dessas características reflete uma fase específica da lesão miocárdica na EA Na fase compensada (HVE concêntrica) temos ictus propulsivo e eutópico. Mas na fase descompensada (HVE excêntrica) temos ictus fraco, difuso e deslocado Resposta certa letra B.

7483.

Comentário: Foi no final do século XIX que um cientista finlandês chamado Robert Tigerstedt descobriu, junto com seu jovem discípulo Per Bergmann (que na época tinha apenas 24 anos), que os rins eram capazes de secretar uma substância com grande potencial para aumentar a pressão arterial Tal substância vasopressora foi então batizada como Renina Apesar de o trabalho original que descreveu os efeitos da renina ser atualmente considerado um dos clássicos da medicina moderna (por constituir um excelente exemplo de aplicação do método científico), mais de 40 anos se passaram até que a importância de tal descoberta fosse devidamente valorizada e desse origem a toda uma linha de pesquisa em hipertensão arterial Inicialmente extraiu-se a renina a partir da homogenização de tecido renal de coelho, e a injeção desse homogenizado em coelhos saudáveis

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

causava aumentos extremos na pressão arterial, mesmo quando em pequenas quantidades (por exemplo frações de mililitro do extrato de tecido aumentavam em até 50% o valor da PA de cobaias) Mais tarde se descobriu que a renina era na verdade uma proteína secretada pelo parênquima sempre que o rim ficava isquêmico, o que foi demonstrado pelo não menos clássico estudo de Goldblatt, em 1934, no qual a artéria renal principal de cães era clampeada artificialmente, resultado num quadro de hipertensão arterial grave semelhante ao observado em humanos Aos poucos foi sendo comprovado o importantíssimo papel dos rins no controle fisiológico e patológico da pressão arterial Assim, de todas as substâncias secretadas pelos rins que têm participação no processo hipertensivo, sem dúvidas a renina é a mais clássica e a que tem um papel notavelmente central O cininogênio cuja hidrólise origina a bradicinina, um importante vasodilatador que promove redução na pressão arterial é secretado pelo fígado (cininogênio de alto peso molecular) ou produzido localmente nos tecidos inflamados (cininogênio de baixo peso molecular) O fator de ativação plaquetária também é produzido e secretado em tecidos inflamados, e sua principal fonte são os leucócitos polimorfonucleares. Essa molécula participa do processo inflamatório (funcionando como uma citocina pró-inflamatória) bem como do processo hemostático (ativando diretamente as plaquetas) Já a eritropoetina é um hormônio produzido e secretado pelo parênquima renal (células do túbulo proximal) cuja função primordial é estimular a produção de hemácias pela medula óssea Apesar de a eritropoetina recombinante exógena (utilizada no tratamento da anemia relacionada à insuficiência renal crônica) ter como principal efeito colateral o aumento dos níveis pressóricos, numa situação normal essa substância não participa ativamente da regulação da pressão arterial Prostaglandinas são moléculas vasodilatadoras produzidas por diversos tecidos em diversas situações De uma forma geral elas têm meia-vida muito curta, o que faz com que sua ação se limite às células próximas ao local onde foi secretada (efeito parácrino). Assim, ainda que participem do controle da hemodinâmica renal (promovendo vasodilatação da arteríola aferente), no que tange ao controle da pressão arterial sistêmica as prostaglandinas tem um papel direto muito menos significativo do que a renina

7467.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Mais uma questão direta a estenose valvar aórtica é a lesão orovalvar mais comum nos EUA, sendo que em idosos a etiologia mais comum é a DEGENERAÇÃO CALCÍFICA. Nestes casos, a valva aórtica é tricúspide, sem nenhuma alteração congênita. A etiologia exata é desconhecida (provável predisposição genética individual), mas a HIPERCOLESTEROLEMIA e o DIABETES MELLITUS são fatores de risco Estima-se que cerca de 25% dos pacientes acima de 65 anos, e até 35% com idade superior a 70 anos, exibam evidências ecocardiográficas de estenose valvar aórtica degenerativa (esclerose aórtica), sendo que apenas 2 a 3% apresentam alterações hemodinâmicas consequentes à estenose. RESPOSTA CORRETA B.

10045.

Comentário: Fácil O critério idade para pensarmos em hipertensão secundária é (1) aparecimento súbito da HAS antes dos 30 anos ou (2) após os 55 anos Marcelo teve HAS diagnosticada aos 40 anos, logo, está dentro da faixa etária HABITUAL do surgimento de HAS As demais alternativas estão corretas níveis pressóricos elevados neste momento, apesar de medicação controlada, indicam a possibilidade de efeito jaleco branco , o qual deverá ser investigado. Faz parte da rotina de acompanhamento regular dos hipertensos a solicitação dos exames expostos na letra C, além do fundo-de-olho anual por um oftalmologista e a pesquisa de microalbuminária (caso o EAS seja negativo), que não foram citados na opção. As recomendações higieno-dietéticas se aplicam a todos os hipertensos Resposta certa letra B.

7514.

Comentário: Muito fácil. Os inibidores da ECA são as drogas de primeira escolha no tratamento da HAS em pacientes diabéticos, pois reduzem a hipertensão glomerular (vasodilatação da arteríola eferente) atrasando assim a evolução do processo de glomeruloesclerose diabética. Este benefício é chamado de nefroproteção dos IECA , e deve sempre ser buscado (A correta) Já no paciente coronariopata, quem tem efeito de cardioproteção são os beta-bloqueadores (B correta) Ao manterem a frequência cardíaca controlada impedindo o surgimento de episódios de taquicardia essas drogas protegem o indivíduo do desenvolvimento súbito de isquemia miocárdica, que pode ser tanto sintomática (angina pectoris) quanto assintomática (isquemia silenciosa , responsável por

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

muitos episódios de morte súbita por fibrilação ventricular) O efeito inotrópico negativo também reduz o consumo miocárdico de oxigênio (contribuindo para o efeito antianginoso), além de promover reduções na pressão arterial (efeito anti-hipertensivo) Beta-bloqueadores não-seletivos como o propranolol (que atravessam a barreira hematoencefálica e também atuam no SNC) são drogas muito úteis na profilaxia da enxaqueca recorrente (D correta) Agora, a letra E está incorreta, pois existe sim uma combinação que deve ser evitada dá uma olhada na letra C Os bloqueadores dos canais de cálcio são contra-indicados em pacientes com insuficiência cardíaca sistólica avançada o efeito inotrópico negativo das drogas não-diidropiridínicas (diltiazem e, principalmente, verapamil) pode levar a uma importante piora da função ventricular esquerda Resposta certa letra C.

10003.

Comentário: Antigamente, a tuberculose era a causa mais comum de pericardite crônica nos Estados Unidos, mas atualmente ela é responsável por apenas 2% dos casos naquele país, ficando o primeiro lugar com os derrames pericárdicos pós-virais Todavia, em países como Brasil, África e Índia, a tuberculose sem dúvidas ainda é a causa mais comum de pericardite subaguda crônica As outras etiologias frequentes são doenças neoplásicas (principalmente pulmão e mama), mixedema, uremia, radioterapia e colagenoses, além do derrame pericárdico crônico idiopático Resposta certa letra B

10005.

Comentário: O pulso paradoxal é um sinal clássico das doenças pericárdicas que promovem restrição ao enchimento diastólico do coração, como a síndrome de tamponamento cardíaco (por qualquer causa) e a pericardite constrictiva (onde pode ser visto em até 1 3 dos pacientes) Entretanto, temos que lembrar que outras doenças também podem se acompanhar da presença de pulso paradoxal (que em termos simples quer dizer pulso que desaparece à inspiração) Os mecanismos que promovem o pulso paradoxal nestes casos NÃO SÃO OS MESMOS que justificam seu aparecimento nas doenças pericárdicas, sendo, na verdade, mais variados e complexos (e por isso não vamos nos deter aqui em sua explicação biofísica detalhada). Apenas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

memorize as demais condições que podem cursar com pulso paradoxal (1) DPOC tipo enfisematoso, (2) asma brônquica, (3) obstrução aguda das vias aéreas, (4) tromboembolismo pulmonar e (5) alguns casos de choque hipovolêmico De fato, as doenças orovalvares aórticas não tem qualquer relação com a presença de pulso paradoxal na estenose aórtica o pulso clássico é o PARVO E TARDO, e na insuficiência aórtica o pulso clássico é o PULSO EM MARTELO D ÁGUA (pulso de Corrigan) Resposta certa letra E

284568.

Comentário: Mulher de 60 anos, hipertensa e diabética não insulinodependente, sobre a qual pergunta-se sobre a classificação pressórica na primeira consulta (PA 182 x 100 mmHg). Pela pressão arterial sistólica, a paciente seria HAS estágio III (PA 180 mmHg), enquanto que a pressão diastólica (100 109 mmHg) classificaria a paciente como estágio II. Na presença de discordância, prevalece o valor mais grave , ou seja, pela Diretriz Brasileira seria uma hipertensa estágio III. A Diretriz Americana não contempla o estágio III, então, essa paciente seria um estágio II. Pelo gabarito divulgado pela banca, a referência utilizada foi a Diretriz Brasileira. Resposta letra D.

284569.

Comentário: Paciente hipertensa e diabética em uso de duas drogas de primeira linha (Bloqueador de Receptor de Angiotensina (BRA) e bloqueador de canal de cálcio) para tratamento de hipertensão, não atingiu os níveis pressóricos alvejados. Pergunta-se qual deverá ser a conduta subsequente. A adição de um diurético tiazídico é uma excelente conduta, pois é uma droga de 1ª linha no tratamento da hipertensão (letra A correta). O captopril, por ser da classe dos IECAs, também está entre as drogas de 1ª linha no tratamento da hipertensão. Contudo, associar um IECA com um BRA resulta apenas em efeitos colaterais (disfunção renal, hipercalemia), sendo uma contraindicação formal (letra B incorreta). A hidralazina é um vasodilatador direito e não é uma droga de 1ª linha, portanto, trocar a losartana, que é de 1ª linha, por hidralazina, não seria benéfico neste caso (letra C incorreta). A losartana está na dose máxima (50 mg de 12 12h), assim como o anlodipino (5 mg de 12 12h), então não há por que aumentar as doses (letra D incorreta). Aproveitando o gancho da questão, vamos relembrar que os IECAs, BRAs, diuréticos tiazídicos e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

bloqueadores de canais de cálcio são as classes consideradas como drogas de 1ª linha no tratamento da hipertensão. Os betabloqueadores não fazem mais parte deste grupo. Resposta letra A.

284570.

Comentário: Temos uma paciente hipertensa e com diabetes mellitus tipo 2. Manter a pressão arterial controlada no indivíduo diabético é essencial para a proteção renal, o que reduz a albuminúria, além de ser importante para diminuir o risco de AVE e de hipertrofia ventricular esquerda. Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2020), citadas pelo enunciado, a meta pressórica no hipertenso diabético é 130 80 mmHg (grau de recomendação IIa, nível de evidência B). O mesmo alvo é encontrado nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2019 2020). Resposta letra B.

230118.

Comentário: Dispneia progressiva aos esforços, associado a tosse seca, diminuição da ausculta em bases pulmonares com presença de estertores crepitantes são sinais e sintomas que sugerem congestão pulmonar. A presença de soprologia complexa, com deslocamento do ictus cordis , não deixa dúvida quanto à etiologia cardíaca do quadro, logo, estamos diante de uma síndrome de insuficiência ventricular esquerda crônica (insuficiência cardíaca) Ora, numa mulher jovem, ainda mais com histórico de múltiplos episódios de amigdalite na infância adolescência, não há como não pensar em cardiopatia reumática como sendo a principal explicação causal para o quadro.

230119.

Comentário: Considerando a enorme probabilidade pré-teste de cardiopatia reumática, frente aos sinais e sintomas e os fatores de risco apresentados, o exame que pode confirmar e estratificar a gravidade das lesões valvares reumáticas é o ecocardiograma, inicialmente transtorácico (o transesofágico pode vir a ser necessário para uma melhor avaliação do quadro, mas jamais indicaríamos tal exame sem antes ter feito um transtorácico que justifique sua solicitação).

230120.

Comentário: Frente a uma doença orovalvar acompanhada de insuficiência cardíaca,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

especialmente quando o mais provável é que se trate de valvopatia complexa (mitro-aórtica), não há opção terapêutica melhor do que o tratamento cirúrgico das lesões, o que, nestes casos, costuma envolver troca valvar.

176344.

Comentário: Repare que toda vez que essa mulher tem sua pressão aferida por profissional médico, apresenta hipertensão. Quando a pressão é aferida em casa, no entanto, os níveis tensionais são normais. A partir dessas observações, podemos traçar para ela o diagnóstico de hipertensão do jaleco branco ou hipertensão do avental branco. O exame diagnóstico pode ser tanto a monitorização ambulatorial da pressão arterial (com aparelho automatizado portado pelo paciente) quanto a monitorização residencial desta (MRPA). Para realizar a MRPA, afere-se a pressão durante 7 dias consecutivos, 3 vezes antes do desjejum, 3 vezes antes do jantar. São consideradas anormais as médias de PA 130 80 mmHg.

176285.

Comentário: Repare que toda vez que essa mulher tem sua pressão aferida por profissional médico apresenta hipertensão. Quando a pressão é aferida em casa, no entanto, os níveis tensionais são normais. A partir dessas observações, podemos traçar para ela o diagnóstico de hipertensão do jaleco branco ou hipertensão do avental branco. O exame diagnóstico pode ser tanto a monitorização ambulatorial da pressão arterial (com aparelho automatizado portado pelo paciente) quanto a monitorização residencial desta (MRPA).

176295.

Comentário: Certamente a cefaleia que essa mulher tem é primária. Não vemos qualquer tipo de sinal de alarme para causas secundárias. Ademais, parece tratar-se de cefaleia tensional, cefaleia frontal em peso . Assim, a melhor conduta em relação à dor é utilizar fármacos com ação analgésica. São opções analgésicos comuns (ex. dipirona) e anti-inflamatórios não esteroidais (cetorolaco).

84998.

Comentário: Num idoso grande tabagista (carga tabágica 20 maços-ano), principalmente quando o

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

paciente ainda fuma, é muito provável que queixas respiratórias como dispneia e tosse crônica sejam devidas a um quadro de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) - o grande diagnóstico de base deste caso. O atual quadro, por conseguinte, representa uma DPOC descompensada. Considerando a história do paciente, em que sobressai a queixa de tosse crônica, trata-se de um padrão de bronquite crônica , e portanto uma bronquite crônica infectada agora... O tabagismo também deve fazer parte da lista de problemas do paciente, uma vez que o mesmo ainda fuma (a cessação do tabagismo efetivamente prolonga a sobrevida do portador de DPOC, além de melhorar sua qualidade de vida ao reduzir o número de descompensações). Hoje já dispomos de medicamentos e outras estratégias para auxiliar o paciente na difícil tarefa de parar de fumar, logo, há mais um objetivo bem definido para o médico do ambulatório responsável por este caso. A banca deu gabarito ainda hipertensão arterial sistêmica , mas não temos elementos no enunciado para aventar tal hipótese...

49290.

Comentário: Hipertensão arterial em idade jovem, particularmente com história familiar positiva (complicação de HAS grave em parente relativamente jovem), deve nos fazer pensar em HAS secundária. Na investigação inicial, a seleção dos exames complementares a serem solicitados deve se pautar, sempre que viável, nas pistas clínicas disponíveis. Qual seria a grande pista clínica que este paciente apresenta Repare que ele se queixa de cãibras e fraqueza muscular, alterações compatíveis com a hipótese de hipocalemia. Que forma (grave) de HAS secundária cursa com hipocalemia (e alcalose metabólica) É claro que é o hiperaldosteronismo primário , geralmente associado à presença de um aldosteronoma (Síndrome de Conn). Portanto, o exame mais adequado em face do contexto clínico está representado, sem dúvida, na letra B.

49296.

Comentário: Temos aqui uma IC com fração de ejeção normal (50%), isto é, uma insuficiência cardíaca diastólica . Ao contrário do que acontece na IC sistólica, não há nenhuma droga específica que seja comprovadamente eficaz em modificar a história natural desta doença de maneira independente, isto é, não há nenhuma droga que deve ser usada de maneira obrigatória,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

independente de qualquer outra condição. A seleção do tratamento medicamentoso, portanto, deve se pautar nos comemorativos que o paciente apresenta (ex. anti-hipertensivos para tratar a hipertensão arterial). Sendo assim, excetuando-se a letra C, todos os fármacos citados podem (e devem) ser empregados no controle da hipertensão (ou da congestão, no caso da furosemida). A digoxina, por outro lado, não tem qualquer papel num doente com fração de ejeção preservada. Resposta certa C.

35013.

Comentário: Os dois principais determinantes hemodinâmicos para a insuficiência cardíaca aguda são a elevação da pressão de enchimento do VE e a diminuição do débito cardíaco (com consequente aumento da resistência vascular periférica, devido à ativação neuro-hormonal). Como essas alterações hemodinâmicas podem ocorrer de forma isolada ou em conjunto, pacientes em vigência de insuficiência cardíaca crônica agudizada (ou descompensada) são divididos em quatro perfis clínico-hemodinâmicos, e baseado nestes, condutas terapêuticas mais adequadas são traçadas. Perfil A pressão de enchimento de VE normal com perfusão normal (Quente e seco) Perfil B elevação da pressão de enchimento do VE com perfusão normal (Quente e úmido) Perfil C elevação da pressão de enchimento do VE com diminuição da perfusão (Frio e úmido) Perfil L pressão de enchimento do VE normal ou baixa com diminuição da perfusão tecidual (Frio e seco). O tratamento tem como objetivo restaurar o perfil hemodinâmico normal (perfil A). Assim, pacientes que se encontram no perfil B (Quente e úmido), devem ser tratados com diuréticos e vasodilatadores, tendo em vista a redução da pressão de enchimento do VE. Pacientes frios e úmidos tem no uso de inotrópicos positivos com ação vasodilatadora (dobutamina, dopamina em doses baixas, milrinona, levosimendan), sua melhor medida intervencionista. Os pacientes que se apresentam com perfil L (Frio e seco) devem ser investigados cuidadosamente por meio de cateterismo de câmaras direitas. A presença de uma pressão de enchimento baixa, deverá ser corrigida cautelosamente com a reposição de líquidos. Logo, a alternativa E encontra-se correta.

34969.

Comentário: Essa questão é tão fácil, que você nem precisava ter perdido o seu tempo soletrando

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vagarosamente as complicadas expressões que o enunciado utiliza para descrever as características soprológicas observadas no caso. Num paciente pediátrico com diferença entre os pulsos dos membros superiores e inferiores, sendo que nos superiores existe hipertensão arterial, o primeiro diagnóstico que nos vêm à mente é de coarctação de aorta, a quarta cardiopatia congênita mais comum da prática e uma das principais etiologias de HAS secundária na faixa etária pediátrica. Se o paciente é portador de Síndrome de Turner, então, tal hipótese se encaixa perfeitamente (lembre-se de que esta síndrome é um importante fator de risco para coarctação de aorta). As demais características semiológicas descritas no caso são achados possíveis na coarctação de aorta (estreitamento, em geral, após o ligamento arterial na crossa aórtica).

Resposta certa D.

27432.

Comentário: Vamos analisar as alternativas... A ERRADA A ingestão de bebidas contendo cafeína, como café e Coca-Cola, podem elevar transitoriamente a PA (ou seja, ela é superestimada). B ERRADA Aferições sequenciais, principalmente no mesmo membro, podem elevar transitoriamente a PA, superestimando-a. C CORRETA Segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço, e seu comprimento, a pelo menos 80%. Um manguito com largura maior que a preconizada (60%), dificulta mais ainda a passagem do sangue durante sua insuflação (mais do que um manguito com largura de 40%), levando à leitura de uma PA mais baixa que a real. Seria como aferir a PA de uma criança usando um manguito de adulto... a PA é mais baixa que a real, ou seja, subestimada. D ERRADA A atividade física pode elevar transitoriamente a PA, superestimando-a. E ERRADA O manguito deve ser inflado até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica. Insuflação até pressões maiores pode causar incômodo ao paciente, aumentando transitoriamente a PA, que assim será superestimada... Outra causa de subestimação da PA, não descrita na questão, é o hiato auscultatório... O hiato auscultatório é o desaparecimento dos sons durante a última parte da fase I e a fase II. Este hiato pode cobrir uma faixa de 30 a 40 mmHg, podendo deste modo ser causa de subestimação da PA. Para evitá-lo, realizamos o método palpatório antes do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

auscultatório. Resposta Letra C.

27444.

Comentário: Temos um paciente jovem e previamente hígido que se apresenta com relato de quadro gripal inespecífico e, uma semana após, já com remissão quase completa dos sintomas, inicia um quadro de dispneia ao esforço, com exame clínico compatível para insuficiência cardíaca congestiva de padrão biventricular (congestão pulmonar congestão sistêmica desvio do ictus cordis). Esta é a evolução clássica da miocardite viral, que se manifesta através de dilatação biventricular e insuficiência cardíaca sistólica. Supra de ST em várias derivações, bem como elevação das troponinas (em até 30-50% dos casos) geralmente estão presentes VHS elevado também é comum. Neste momento, o exame mais útil para corroborar do diagnóstico e permitir o acompanhamento evolutivo é o ecocardiograma. Lembre-se que o diagnóstico é feito pela conjunção de dados clinicoepidemiológicos, laboratoriais, eletrocardiográficos, ecocardiográficos e histopatológicos. A biópsia endomiocárdica normalmente é indicada, apesar de ter acurácia limitada (sensibilidade 80% e especificidade 65%). Resposta certa letra B.

27446.

Comentário: A causa mais comum de miocardite aguda na prática é a infecção viral , principalmente por enterovírus, destacando-se o Coxsackie B (o mesmo da pericardite aguda viral). As demais opções são incorretas o espasmo coronariano é característico da angina de Prinzmetal , hiper-homocisteinemia é fator de risco para doença coronariana e não miocardite, penicilina é tratamento para cardite reumática e não para toda miocardite (neste caso, a história é típica de miocardite viral). A tuberculose está bem mais associada à pericardite do que à miocardite. Resposta certa letra A.

27449.

Comentário: O que é uma extrassístole É um batimento cardíaco prematuro (ou seja, que vem antes do tempo) substituindo um batimento sinusal. Pode ter origem numa descarga elétrica ventricular (ES ventricular) ou não (ES supraventricular) - o que importa é que ele não é gerado pelo nódulo sinusal O assunto da questão são as extrassístoles supraventriculares, e o autor quer

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

saber a opção errada, ou seja, qual característica não encontramos, de jeito nenhum, nesse tipo de extrassístole. Vamos analisar A) Uma ES supraventricular despolariza o ventrículo da mesma forma que um batimento sinusal, isto é, através do nódulo AV e sistema de His-Purkinje. O que é o QRS É a representação da despolarização ventricular. Se a despolarização ventricular é igual, o QRS da ES supraventricular tem a mesma duração do QRS sinusal (estreito). Afirmativa correta. B) Como acabamos de ver, uma ES supraventricular despolariza o ventrículo da mesma forma que um batimento sinusal, ou seja, o eixo do QRS mantém a mesma direção de um batimento com origem sinusal. Opção incorreta (gabarito). D) (trocamos a ordem) A onda P representa a despolarização atrial. Por definição, a ES supraventricular NÃO tem origem no nódulo sinusal, logo, os átrios são despolarizados de forma diferente quando comparados a um batimento sinusal, originando alterações da onda P. Afirmativa correta. C) Se a origem da ES supraventricular for numa porção do átrio mais próxima ao NAV, além da onda P de morfologia diferente da P sinusal, observaremos, provavelmente, um intervalo PR mais curto. E se a origem da extrassístole for a junção AV Aí depende. O impulso elétrico sinusal vai se propagar para os átrios e para os ventrículos, se ele se propagar para os átrios em maior velocidade, poderemos ter uma onda P negativa (já que o átrio está sendo ativado de baixo para cima) antes do QRS. Se essa condução para os átrios for mais lenta, a onda P pode se inserir após o QRS ou mesmo durante o QRS, o que faz com ela não seja percebida no traçado Assim, não necessariamente teremos onda P numa extrassístole supraventricular de origem juncional Baseado nisso, não podemos escolher a opção C como resposta, já que a questão pergunta o que não se encontra nas ES supraventriculares , e neste caso a ausência de P pode ocorrer sim, em alguns casos. E) As extrassístoles ventriculares quase sempre produzem pausas compensatórias, o que não ocorre nas ES supraventriculares. Afirmativa correta. Assim, resposta certa letra B.

27452.

Comentário: A medida inicial mais importante para o alívio sintomático de um paciente com ICC descompensada é sem dúvidas a diureticoterapia , de preferência com diuréticos de alça como a furosemida. O digital é medida válida para associação ao tratamento padrão em pacientes com

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sintomas refratários, e portanto não encontra indicação, neste momento, em nosso caso. Penicilina e AAS fazem parte do tratamento da cardite reumática, e já vimos que a doença deste paciente muito provavelmente é a miocardite viral aguda. Nitratos são úteis na síndrome coronariana e nas emergências hipertensivas (ex. EAP hipertensivo, que não é o caso). Logo, resposta certa letra B.

27482.

Comentário: Uma menina de 12 anos de idade com PA 130 x 100 mmHg apresenta-se bem acima do percentil 95 da curva de pressão para sexo e idade. Mesmo sem o gráfico, você já infere que uma pressão acima de 140 x 90 mmHg (considerada o limite da normalidade em adultos) já deve significar anormalidade e possibilidade de hipertensão. Na grande maioria dos casos, a hipertensão iniciada na adolescência é idiopática, primária ou essencial, ou seja, não está associada a nenhuma doença adrenal, renal ou tumoral. Por isso, não são necessários exames complementares como função renal ou EAS ou USG abdominal Para que se possa estabelecer o diagnóstico de HAS, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, são necessárias 3 medidas da PA sucessivas, obtidas pelo mesmo examinador, em consultas diferentes com equipamento e técnica adequadas. Resposta letra B.

13292.

Comentário: Veja bem paciente jovem (25-30 anos de idade) com PA elevada deve ser investigado para hipertensão secundária. A causa mais comum é a hipertensão secundária a uma doença parenquimatosa renal (2-3% dos casos), e em segundo lugar vem a doença renovascular (1-2%), que nesta faixa etária é mais frequentemente causada por displasia fibromuscular da camada média arterial... Ora, os IECA ou bloqueadores dos receptores da angiotensina (como o losartan) são contraindicados na presença de estenose bilateral de artéria renal ou unilateral em rim único, pois podem precipitar deterioração da função renal. Assim, até termos mais certeza de qual é o verdadeiro problema de base desse doente devemos tomar cuidado e não prescrever tais drogas antes de nos certificarmos da ausência dessas comorbidades... Feocromocitoma, neste caso, é menos provável que hipertensão renovascular, devido à ausência de suas outras manifestações típicas (cefaleia, palpitações...).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

13293.

Comentário: Segundo a classificação de Keith-Wegener-Barker (KWB) para retinopatia hipertensiva, o encontro de hemorragia (que classicamente é descrita como em chama de vela) e ou exsudatos é classificado como retinopatia grau III, sendo considerado indicativo de hipertensão acelerada... A retinopatia seria grau IV - hipertensão maligna - se houvesse papiledema O encontro de altos níveis pressóricos associados à lesão de órgão-alvo característica de hipertensão acelerada maligna caracteriza uma emergência hipertensiva, havendo indicação de controle da PA nas próximas 24-48 horas, segundo diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

11131.

Comentário: Diversos estudos comprovaram que a hipertensão sistólica isolada do idoso (apenas a PA sistólica está aumentada, geralmente por perda da elasticidade aórtica secundária ao processo de envelhecimento arterioesclerose) aumenta enormemente o risco cardiovascular (especialmente a ocorrência de AVC, que é a principal causa de morte em nosso meio). Tais estudos também demonstraram os importantes benefícios dos tiazídicos na melhoria do prognóstico dessa doença (na verdade os tiazídicos são a PRIMEIRA ESCOLHA para o controle da HAS sistólica isolada, cabendo o segundo lugar aos bloqueadores dos canais de cálcio) Trata-se de uma medicação extremamente barata, eficaz e disponível, de fácil adesão por parte do paciente (apenas uma tomada diária) e com poucos efeitos colaterais quando utilizada numa dose máxima de até 25 mg dia (doses maiores se associam à hiperglicemia, hiperuricemia e hiperlipemia) Os tiazídicos também são anti-hipertensivos de primeira linha para todos os tipos de hipertenso (negro, branco, jovem, idoso, obeso, magro), exceto gestantes (que devem evitar o uso de diuréticos). Além disso devem sempre ser considerados quando o paciente necessita de mais de uma droga anti-hipertensiva (a adição de um diurético potencializa o esquema terapêutico) Como a questão não cita nenhuma outra condição capaz de influenciar na escolha do anti-hipertensivo (ex beta-bloqueador para o coronariopata, IECA ou BRA para o diabético e para o nefropata), ficaremos com a opção do tiazídico

11132.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: A técnica de ESFIGMOMANOMETRIA deve ser executada com perfeição para ser fidedigna (esfigmo pulso manometria medir a pressão)... O primeiro passo é a escolha de um manguito adequado às dimensões do membro superior do paciente sabemos que a LARGURA da bolsa inflável deve ser 40% da circunferência do membro, ao passo que o COMPRIMENTO da bolsa deve ser 80% dessa mesma circunferência (A correta)... O centro do manguito deve ser colocado sobre a artéria braquial a 2-3 cm acima da fossa antecubital. A insuflação do manguito deve ser acompanhada de palpação da artéria radial ipsilateral, e quando o pulso radial desaparecer, num determinado valor de pressão, deveremos inflar cerca de 20 mmHg adicionais, para só depois aplicar o estetoscópio no ponto de ausculta (método palpatório opção E correta)... Antes de aferirmos a PA o paciente deve estar relaxado há pelo menos 5 minutos. Recomenda-se então que a PA seja medida no mínimo 2 vezes, com pelo menos 1 minuto de intervalo entre cada aferição (B correta)... Existem 5 fases de Korotkoff. O aparecimento do som (fase 1) identifica o valor da PA sistólica, enquanto seu desaparecimento (fase 5) marca o valor da PA diastólica (C correta)... Entretanto, é preciso lembrar que existe uma exceção a essa regra a fase 4 (abafamento do som) determina a PA diastólica nos portadores de INSUFICIÊNCIA AÓRTICA, pois em tal caso pode não ocorrer a fase 5... Assim, sobrou a opção D, que realmente está incorreta não devemos arredondar o valor da PA

18040.

Comentário: Questão muito mal formulada Ora, primeiramente é necessário fazer o diagnóstico do caso temos um paciente com inúmeros sinais e sintomas que apontam para uma insuficiência cardíaca de início há 5 meses. Veja quantos critérios maiores e menores ele apresenta na tabela abaixo São 3 maiores (turgência jugular patológica, terceira bulha, estertores pulmonares) e 3 menores (dispneia aos esforços, edema em membro inferior bilateral, hepatomegalia). Lembre-se de que bastariam 2 maiores ou 1 maior e 2 menores para fechar o diagnóstico clínico de ICC... Mas a questão pergunta qual das medicações tem um menor impacto sobre a sobrevida do paciente. Podemos descartar imediatamente o captopril, losartan e carvedilol, que pertencem às classes de medicamentos associadas às maiores taxas de redução de mortalidade na insuficiência cardíaca,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

principalmente os inibidores da ECA e betabloqueadores. Restam a digoxina e amlodipina, sendo que ambos sabidamente não modificam a história natural da doença. Já está comprovado que a digoxina (inotrópico positivo) promove uma melhora sintomática e reduz a taxa de internação por descompensação da insuficiência cardíaca, apesar de estar associada a um aumento das mortes por arritmia, mantendo um efeito neutro sobre a mortalidade global. Os bloqueadores de canais de cálcio são medicações que classicamente devem ser evitadas na insuficiência cardíaca por estarem relacionados a maiores taxas de descompensação, principalmente os mais cardiosseletivos, como o verapamil e diltiazem. Entre os diidropiridínicos, a anlodipina parece ser segura para ser utilizada com antianginoso ou anti-hipertensivo, sem modificar as taxas de hospitalização ou mortalidade. Portanto, tanto a digoxina quanto a amlodipina não modificam a sobrevida dos pacientes com ICC Questão sem resposta. O gabarito oficial foi alternativa E.

15752.

Comentário: Este paciente deve ser considerado como um pré-hipertenso pelo 7º Joint ou Limítrofe pela Diretriz Brasileira. O ideal para este paciente é indicar mudanças no estilo de vida como cessar o tabagismo, iniciar dieta para redução de peso e programa de exercícios físicos. Gabarito Letra C.

15808.

Comentário: Observe a tabela em anexo e relembre a classificação funcional da insuficiência cardíaca de acordo com a New York Heart Association (NYHA). Perceba que a nossa paciente se encaixa na classe II de ICC... Vale dizer que sua piora durante a gestação provavelmente é secundária a certas alterações fisiológicas do organismo materno, particularmente o aumento da volemia que deve estar aumentando as pressões de enchimento de suas câmaras cardíacas, resultando em congestão. Resposta certa B.

343336.

Comentário: Toda a questão que tiver alternativas muito parecidas é por que foi copiada, ipsis litteris , de algum documento. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nesses casos, a possibilidade de conhecermos o documento é remota. Portanto, em muitas vezes, basta uma leitura atenta para que possamos acertar por eliminação Voltando a questão, note que a mesma foi retirada das

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes documento intitulado Tratamento da hiperglicemia em pacientes com DM2 e insuficiência cardíaca. Segundo o mesmo, o advento dos inibidores da proteína co-transportadora SGLT2 (ISGLT2) inaugurou uma nova era no tratamento da IC em pessoas com diabetes. Estudos como o EMPA-REG OUTCOME, DECLARE e CANVAS mostraram que, além de controlar efetivamente a glicemia, esses fármacos apresentam efeito importante na fisiopatologia da IC, reduzindo de forma expressiva as internações por insuficiência cardíaca e a mortalidade cardiovascular. Resposta letra A.

281849.

Comentário: Segundo o Posicionamento Luso-Brasileiro de Emergências Hipertensivas, de 2020 A encefalopatia hipertensiva pode se apresentar com início insidioso, evoluindo com cefaleia holocraniana, náuseas ou vômitos. Posteriormente, podem surgir alterações do estado mental e campimétricas, fotopsia, visão turva, alucinações visuais, crises convulsivas generalizadas, hiperreflexia e sinais de hipertensão intracraniana. No momento em que aparecem as manifestações neurológicas, geralmente, a PAD encontra-se acima de 125 mmHg. A resolução do quadro, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista de imagem, demora, em média, várias semanas após o controle da PA. A persistência de um déficit é sinal de existência de lesão neurológica focal. Resposta letra D.

281852.

Comentário: A questão foi retirada da Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias de 2020. Observe o seguinte trecho deste documento A insuficiência mitral (IM) secundária decorre de alterações ventriculares (disfunção e ou dilatação), enquanto que os folhetos valvares mitrais e as cordoalhas são normais. Nesse contexto, há uma sobrecarga adicional ao VE pela regurgitação mitral, culminando num pior prognóstico. As principais etiologias são doença arterial coronária (IM isquêmica) e miocardiopatia dilatada (dilatação anular e ou mau posicionamento). Por esses motivos, o tratamento ideal é controverso, uma vez que a correção valvar não é curativa. De maneira geral, está indicada intervenção em pacientes que se mantêm sintomáticos, a despeito de tratamento medicamentoso otimizado. Mesmo assim, a decisão terapêutica deve ser individualizada

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

e, sempre que possível, compartilhada com o Heart Team . Resposta letra A.

281854.

Comentário: O Posicionamento Luso-Brasileiro de Emergências Hipertensivas, de 2020, aborda essa tema no seguinte trecho A encefalopatia hipertensiva pode se apresentar com início insidioso, evoluindo com cefaleia holocraniana, náuseas ou vômitos. Posteriormente, podem surgir alterações do estado mental e campimétricas, fotopsia, visão turva, alucinações visuais, crises convulsivas generalizadas, hiperreflexia e sinais de hipertensão intracraniana. No momento em que aparecem as manifestações neurológicas, geralmente, a PAD encontra-se acima de 125 mmHg. A resolução do quadro, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista de imagem, demora, em média, várias semanas após o controle da PA. A persistência de um déficit é sinal de existência de lesão neurológica focal. Resposta letra B.

281859.

Comentário: No trecho que abrange o diagnóstico da encefalopatia hipertensiva, o Posicionamento Luso-Brasileiro de Emergências Hipertensivas de 2020, diz que A ressonância magnética é o exame diagnóstico de maior valor. Na sequência T2, evidenciam-se lesões hiperintensas na substância branca com comprometimento preferencial das regiões parieto-occipitais. O território irrigado pelo sistema vertebrobasilar pode ser atingido em casos mais graves. A presença de hipersinal ao coeficiente de difusão aparente sugere a ocorrência de edema vasogênico. Laboratorialmente, podem-se encontrar trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, proteinúria, aumento dos valores da creatinina plasmática e das enzimas hepáticas. Na tomografia computadorizada, são habituais hipodensidades focais ou difusas na substância branca e no córtex, com sinais de edema. O eletroencefalograma mostra lentificação difusa com perda do ritmo alfa, ou atividade epileptiforme, se existirem crises convulsivas. Resposta letra A.

283855.

Comentário: Essa paciente tem, provavelmente, hipertrofia ventricular esquerda no ecocardiograma ora, se resolveram investigar a possibilidade de hipertensão arterial sistêmica (HAS) com base no eco, esse é o achado mais óbvio a se pensar... No consultório, porém, foram constatados níveis

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pressóricos normais... Será que esse paciente não é mesmo hipertenso Em outras palavras, será que aferindo a pressão arterial normal no consultório já permite afastar, por completo, o diagnóstico de HAS Na verdade, não. Tanto é assim que, atualmente, se recomenda a aferição da pressão arterial (PA) também fora do consultório, seja através da MAPA (monitorização ambulatorial da PA), seja através da MRPA (monitorização residencial da PA). No caso apresentado, o resultado da MAPA revelou média dos valores em vigília 135 x 85 mmHg, o que traduz HAS (letras B e C incorretas). Agora, como classificar o fenômeno descrito, em que a paciente tem níveis pressóricos normais no consultório e elevados fora dele Trata-se da hipertensão mascarada Essa condição deve ser pesquisada em indivíduos com PA normal ou limítrofe e mesmo nos hipertensos controlados, que desenvolvem sinais de lesão de órgão alvo. Aproveitando o ensejo, vamos lembrar mais duas definições - Hipertensão do Jaleco Branco um grande número de pessoas apresenta PA 140 x 90 mmHg apenas quando um médico ou profissional de saúde afere a sua pressão. Quando a PA é aferida em casa, por parentes ou amigos, ou quando os valores da PA são determinados pela MAPA, quase todas as medidas encontram-se abaixo de 140 x 90 mmHg (letra E incorreta). - Crise hipertensiva elevação aguda dos níveis pressóricos 180 x 120 mmHg com ou sem lesões de órgão-alvo (letra A incorreta). Resposta letra D.

281883.

Comentário: Vamos começar analisando o eletrocardiograma. Perceba que os intervalos R-R são irregulares e não há ondas P (o que você vê entre os complexos QRS nada mais são do que ondas T). Está dado o diagnóstico de fibrilação atrial Na taqui supra, esperamos encontrar intervalos R-R regulares. Já a radiografia de tórax revela trama vascular mais pronunciada, sugerindo congestão. Não há qualquer evidência de atelectasia ou de condensação pulmonar, que seria representada por área hipotransparente localizada. Resposta letra C.

249972.

Comentário: De acordo com as diretrizes brasileiras, a aferição da PA através do MAPA e da MRPA apresenta melhor correlação com o prognóstico de eventos cardiovasculares futuros do que a medida de consultório. Lembre-se que a grande vantagem desses métodos, principalmente da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

MAPA, é a avaliação dos níveis tensionais durante um período maior, ao longo de um dia, e não de um só momento.

215572.

Comentário: Obviamente, um raciocínio clínico individualizado é fundamental para que as melhores condutas sejam tomadas para aquele indivíduo (cada caso é um caso diferente) opções (A) e (D) corretas. De preferência, a avaliação deve ser ampla dados da história, da etiologia e do exame físico, por exemplo, devem ser levados em conta opção (B) correta. De fato, a única alternativa incorreta é a (C). Além da avaliação subjetiva, perguntando se o paciente consegue realizar alguns tipos de exercícios, é possível definir a classe funcional através de parâmetros MAIS objetivos, como o teste ergométrico e o teste da caminhada de 6 minutos. Resposta (C).

215578.

Comentário: Pessoal todas as assertivas foram copiadas ipsis litteris da última Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. A única incorreta é a letra A Pacientes com FA sintomática com indicação de ablação atrioventricular também parecem ter benefício sobre morbidade quando recebem estímulo biventricular. Resposta A.

215589.

Comentário: A prova pegou um trecho da diretriz brasileira de IC e mudou uma palavra em cada opção. Mas vamos pelo bom senso se o paciente com IC piora a clínica e ecocardiograma e possui um CDI ou MP, o upgrade que pode favorecer esse paciente é a terapia de ressincronização cardíaca (estímulo biventricular). Isso é especialmente benéfico nos pacientes com FEVE menor ou igual a 35% (indicação das diretrizes estrangeiras). Resposta B.

215595.

Comentário: Como sabemos, uma das principais vantagens da MAPA em relação à aferição comum e à MRPA é o fato de poder acompanhar a PA do paciente durante o sono (lembre-se que a hipertensão arterial noturna é um importante fator de risco cardiovascular). Normalmente, os níveis tensionais se reduzem durante o sono. O famoso descenso noturno é considerado normal quando ocorre redução da PA durante o sono entre 10-20% em relação à vigília. Mas o que explica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

isso Em jovens, esse fenômeno parece estar relacionado a uma redução transitória do débito cardíaco. Por outro lado, o fator principal do descenso em idosos é uma queda mais pronunciada da resistência vascular periférica. Aproveitando a questão, veja a classificação do comportamento da PA entre os períodos de vigília e sono proposta pela Sociedade Brasileira de Cardiologia Descenso acentuado 20% Descenso normal 10-20% Descenso atenuado 0 e 10% Descenso ausente 0 ou 0. Resposta (D).

215608.

Comentário: A alternativa que apresenta o conceito correto é a opção (B). De fato, as etiologias de insuficiência cardíaca variam ao redor do mundo. Obviamente, aquelas principais (HAS e doença coronariana) são encontradas em qualquer região, mas outras menos frequentes, como a doença de Chagas, só são identificadas em certos países. Cabe ressaltar que o prognóstico pode variar dependendo da etiologia na maioria dos casos, um paciente com área extensa de infarto miocárdico possui um prognóstico menos favorável do que outro que desenvolve algum grau de disfunção miocárdica por conta de uma miocardite transitória, por exemplo.

215613.

Comentário: Questão baseada nas diretrizes brasileiras de MAPA e MRPA. Segundo o documento, apenas a alternativa (D) está correta a elevação matinal da PA acima de 55 mmHg está associada à maior prevalência de AVE isquêmico. Esse dado, inclusive, fez com que guidelines buscassem alvos de PA mais baixos para os idosos do que aqueles outrora preconizados para essa faixa etária, desde que sejam bem tolerados pelo paciente. Resposta (D).

215615.

Comentário: Temos aqui uma questão copiada, na íntegra, das Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial e da Diretriz de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Vamos, então, ao trecho que serviu de base para a elaboração da mesma A MAPA pode dar informações clínicas valiosas em pacientes idosos, como nos casos de suspeita de hipotensão arterial ortostática, pós-prandial, medicamentosa e situacional, bem como na avaliação de disautonomia e síncopes. Nos idosos, algumas limitações devem ser salientadas. O enrijecimento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

arterial próprio da idade tende a subestimar a PA medida pelo método oscilométrico e, consequentemente, na presença de pseudo-hipertensão, a MAPA está sujeita a erros (Letra A INCORRETA). A presença de hiato auscultatório, comum nos idosos, mas que sendo usado o método oscilométrico não resultará em limitações (Letra B CORRETA). Aceitam-se para os idosos os mesmos valores de normalidade da MAPA adotados para os adultos não idosos (Letra C INCORRETA). A redução do descenso da PA durante o sono, a pressão de pulso aumentada e a elevação matinal precoce da PA, comuns nos idosos, relacionam-se a aumento do risco cardiovascular (Letra D INCORRETA). Resposta letra B.

218190.

Comentário: Vejamos cada uma das assertivas acerca da hipertensão arterial sistêmica e das doenças crônicas não transmissíveis I - Falsa. As drogas de primeira linha para tratamento de indivíduos hipertensos são os IECA BRA e os diuréticos tiazídicos. II - Falsa. Apesar da definição para o diagnóstico de hipertensão estar correto, as drogas de primeira linha são as já citadas anteriormente e o alvo do tratamento, na maioria dos casos, é uma PA 130 x 80 mmHg. III - Verdadeira. O risco cardiovascular global apresentado pelo paciente é essencial ao seu manejo, devendo as mudanças de estilo de vida serem priorizadas nos indivíduos com hipertensão leve. Gabarito Alternativa D.

181182.

Comentário: Questão boa para sedimentarmos os conceitos de urgência, emergência e pseudocrise hipertensiva. A emergência hipertensiva é caracterizada pela elevação abrupta da PA, com níveis geralmente maiores ou iguais a 180x120 mmHg podendo chegar a 220x140mmHg, associada à lesão de órgãos alvo. São exemplos disso encefalopatia hipertensiva, AVE, síndrome coronariana aguda, dissecção aórtica, edema agudo de pulmão e eclâmpsia. Devem ser manejadas prontamente com antihipertensivos parenterais, seguida de manutenção com drogas orais enquanto ocorre o desmame das drogas parenterais (D incorreta). As urgências hipertensivas não cursam com lesão de órgão alvo e costumam apresentar níveis tensionais de PA diastólica 120mmHg. São situações na qual os níveis pressóricos podem provocar prejuízo nos próximos dias

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ou horas. São exemplos de urgência hipertensiva PA elevada em pacientes com doença coronariana estável, aneurisma de aorta não dissecante, queimaduras extensas, epistaxes graves (não é orgão alvo), estados de hipercoagulabilidade, pré-operatório, hipertensão da gestação e crises adrenérgicas leves. Por serem eventos menos graves, carregam menor potencial de morbimortalidade a longo prazo (A correta). Devemos reduzir a PA nesses casos com drogas orais. A pseudocrise hipertensiva é o evento em que um paciente hipertenso, geralmente de longa data, ansioso ou estressado, com má adesão ao tratamento medicamentoso, apresenta elevação dos níveis pressóricos. A elevação da PA pode ser assintomática ou vir associada a sintomas que não possuem relação com o aumento pressórico (cefaleia leve, parestesias, dor torácica inespecífica, mal estar). Estes paciente devem ser orientados a procurar atendimento ambulatorial para hipertensão e podem se beneficiar de um ansiolítico para ansiedade e analgésico para cefaleia na consulta da emergência. (C correta, D incorreta). Resposta D

181202.

Comentário: A Hipertensão Arterial Resistente é uma situação encontrada em pacientes ADERENTES ao tratamento e que não respondem à terapia OTIMIZADA (doses adequadas) com três drogas, incluindo entre elas um diurético (letra A incorreta). Vamos relembrar que antes de definir uma hipertensão como resistente, é necessário descartar algumas condições (pseudorresistência) (1) medida inadequada da PA (2) HAS agravada pelo efeito do jaleco branco (3) tratamento inadequado (4) inerentes ao paciente (falta de aderência ao tratamento, dieta rica em sal, ingestão excessiva de álcool) (5) HAS secundária.

162511.

Comentário: Nesse caso, temos que pensar na hipótese de hipertensão arterial resistente , que é definida como pacientes aderentes ao tratamento e que não respondem à terapia otimizada com três drogas, incluindo um diurético. É justamente o caso da nossa paciente, que procura a unidade básica de saúde já em uso de três anti-hipertensivos em dose máxima, sendo um deles a hidroclorotiazida (diurético tiazídico), e com médias de pressão acima do recomendado no caso da paciente, pelo VIII Joint, teríamos uma meta de pressão arterial 140 x 90 mmHg. Pois bem,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

garantindo que a paciente possui uma boa adesão terapêutica, é importante descartar também outras condições causadoras de pseudorresistência medida inadequada da pressão arterial HAS agravada pelo efeito do jaleco branco (solicitando uma MAPA) e causas secundárias de hipertensão arterial (ex. hiperaldosteronismo, estenose de artéria renal, apneia obstrutiva do sono, etc. Se essas condições forem descartadas, uma quarta medicação deve ser adicionada a espironolactona (25-50 mg dia) é a droga de escolha, como bloqueador de receptor mineralocorticoide, pelo possível hiperaldosteronismo associado. Dessa forma, analisando as opções não há indicação de aumentar a dose de enalapril ou anlodipino (as doses máximas habituais são de 40 e 10 mg dia, respectivamente) A e B incorretas. Os betabloqueadores não são considerados medicação antihipertensiva de primeira linha, exceto se houver uma outra indicação para o seu uso (ex. insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana) D incorreta. A associação de IECA tiazídico bloqueador de canal de cálcio está perfeita essas são drogas de primeira linha no tratamento da hipertensão arterial E incorreta. Por fim, ficamos com a letra C para melhor investigação da hipertensão resistente da nossa paciente, a melhor conduta é encaminhamento para um cardiologista, que irá dispor de mais ferramentas, usualmente não disponíveis na atenção primária. Resposta letra C.

157634.

Comentário: A comunicação interventricular é a cardiopatia congênita mais comum, que cursa com shunt esquerda-direita, cuja magnitude depende do tamanho do defeito e da relação entre a resistência pulmonar e sistêmica. Quando pequena, a CIV é restritiva, com pressão no VD normal. Resposta letra A.

157630.

Comentário: De acordo com a 7 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial , antes de realizar a técnica correta de aferição da PA deve-se certificar de que o paciente NÃO - Está com a bexiga cheia (A correta) - Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos (B correta) - Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos (C correta) - Fumou nos 30 minutos anteriores (D incorreta). Portanto, o tempo mínimo sem fumar cigarro é de 30 minutos, e não 60 minutos Resposta LETRA

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

D.

157629.

Comentário: De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos maior ou igual que 140 e ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito. Mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal crônica, fatal e não fatal. Resposta letra D.

157633.

Comentário: Questão bobinha que baseia-se em números trazidos pela VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Vamos conhecer esta epidemiologia No Brasil a hipertensão arterial afeta 32,5% dos indivíduos adultos, cerca de 36 milhões de pessoas. Destes, mais de 60% dos idosos são atingidos. Em associação ao diabetes mellitus, a HAS contribui para mais de 50% das mortes cardiovasculares, tendo importante impacto em perda da produtividade do trabalho e da renda familiar (ou seja, além de gerar mortalidade, gera morbidade). Em 2013 nosso país documentou 1.138.670 óbitos, dos quais 339.672 (29,8%) decorreram de doenças cardiovasculares (DCV). As grandes informações que a questão nos dá é sobre a elevada prevalência da HAS na população idosa e o impacto das DCV em morbimortalidade no Brasil. Estes são os dados que valem a pena serem memorizados. Resposta letra A.

157577.

Comentário: De acordo com a 7 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial , as recomendações para a medição correta da pressão arterial incluem explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medição. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento. Deve-se certificar de que o paciente não está com a bexiga cheia não praticou exercícios físicos há pelo

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

menos 60 minutos não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não fumou nos 30 minutos anteriores. Em relação ao posicionamento, o paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado (letras A e D corretas) . O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e as roupas não devem garrotear o membro (letra B incorreta) . Existe a recomendação de medir a PA na posição de pé, após 3 minutos, nos diabéticos, idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada (letra C correta) . Portanto, resposta incorreta e gabarito da questão letra B.

157581.

Comentário: Outra questão do concurso que utilizou a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial , que dá recomendações específicas quanto às etapas para realização da medição da pressão arterial. Vejamos essas etapas 1. Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano 2. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço 3. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital 4. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial 5. Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial 6. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva 7. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS obtido pela palpação 8. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo) 9. Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação 10. Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff) 11. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa 12. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS PAD zero 13. Realizar pelo menos duas medições, com intervalo em torno de um minuto. Medições adicionais deverão ser realizadas se as duas primeiras forem muito diferentes. Caso julgue adequado, considere a média das medidas 14. Medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço onde foi obtida a maior pressão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

como referência 15. Informar o valor de PA obtido para o paciente 16. Anotar os valores exatos sem arredondamentos e o braço em que a PA foi medida. Portanto, a alternativa incorreta e gabarito da questão é a LETRA C, pois o manguito deve ser colocado 2 a 3 cm acima da fossa cubital, e não 5 cm como descrito.

157584.

Comentário: No Brasil, a hipertensão arterial (HA) atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença cardiovascular (DCV). Junto com o diabetes mellitus, suas complicações (cardíacas, renais e AVE) têm impacto elevado na perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, estimada em US 4,18 bilhões entre 2006 e 2015. Em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, 339.672 dos quais (29,8%) decorrentes de DCV, a principal causa de morte no país (A correta) . As taxas de mortalidade por doenças hipertensivas têm aumentado no período entre 2002 de 2009 (B correta, C incorreta) , mostrando tendência a redução desde 2010. Também houve redução da taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca congestiva (ICC), que variou de 47,7 100.000 habitantes (2000) para 24,3 100.000 habitantes em 2013 (D correta) . Portanto, alternativa incorreta e gabarito da questão LETRA C

157587.

Comentário: A pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada pela PA sistólica entre 121 e 139 e ou PA diastólica entre 81 e 89 mmHg (A correta). A prevalência mundial é de aproximadamente 21% a 37,7%. A PH associa-se a maior risco de desenvolvimento de hipertensão arterial e anormalidades cardíacas (C correta). Cerca de um terço dos eventos cardiovasculares atribuíveis à elevação de PA ocorrem em indivíduos com PH (B incorreta). Estudos da incidência de doenças cardiovasculares, doenças isquêmicas do coração e AVE em indivíduos pré-hipertensos mostrou que o risco foi maior naqueles com níveis entre 130 e 139 ou 85 e 89 mmHg do que naqueles com níveis entre 120 e 129 ou 80 e 84 mmHg. A implicação clínica dessas evidências epidemiológicas é que a PA de indivíduos pré-hipertensos deve ser monitorada mais de perto, pois uma significativa proporção deles irá desenvolver hipertensão arterial e suas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

complicações (D correta). Portanto, resposta incorreta e gabarito LETRA B.

157589.

Comentário: A questão explora alguns conceitos sobre a epidemiologia da hipertensão arterial e quer saber qual a afirmativa incorreta. Vamos analisar as assertivas A) Correta. Naturalmente, a prevalência de hipertensão arterial irá depender do método do estudo em questão e da população estudada (ex. depende do desenho do estudo, do método de aferição da PA, da idade dos pacientes, etc.) B) Incorreta. Dados do sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL - 2006 a 2014) indicam que a prevalência de HA autorreferida na região sudeste foi a maior (23,3%), seguida pelo Sul (22,9%) e Centro-Oeste (21,2%). Nordeste e Norte apresentaram as menores taxas, 19,4% e 14,5%, respectivamente. C) Correta. Em estudos de meta-análise recente, os estudos transversais e de coorte incluídos mostraram tendência à diminuição da prevalência nas últimas três décadas, de 36,1% para 31,0%. D) Correta, como explicado na alternativa B. Portanto, gabarito letra B.

157594.

Comentário: A questão aborda fatores de risco relacionados à hipertensão arterial (HA), presentes na 7 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial . Vamos analisar as assertivas A) Incorreta. Há sim uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA, relacionada ao aumento da expectativa de vida da população brasileira, atualmente 74,9 anos, e ao aumento na população de idosos 60 anos na última década (2000 a 2010). B) Correta. A prevalência de HA autorreferida foi estatisticamente diferente entre os sexos, sendo maior entre mulheres. C) Correta. Uma meta-análise de estudos realizados no Brasil incluindo 13.978 indivíduos idosos mostrou 68% de prevalência de HA. D) Correta. De fato não houve identificação de um padrão de polimorfismo genético mais relacionado à hipertensão arterial nessa população. Tais estudos mostraram forte impacto da miscigenação, dificultando ainda mais a identificação de um padrão genético para a elevação dos níveis pressóricos. Portanto, a resposta incorreta e nosso gabarito é a letra A.

157596.

Comentário: Embora a dieta hipossódica (até 2g sal dia) seja recomendada como prevenção e no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tratamento não-farmacológico da hipertensão arterial (HA), dados do sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL) demonstraram que apenas 15,5% das pessoas entrevistadas reconhecem conteúdo alto ou muito alto de sal nos alimentos letra D incorreta. As alternativas A e B estão corretas e são conceituais. Em relação ao consumo crônico de álcool, esse leva ao aumento da pressão arterial de forma consistente. Uma meta-análise de 2012, incluindo 16 estudos com 33.904 homens e 19.372 mulheres comparou a intensidade de consumo entre abstêmios e bebedores. Em mulheres, houve efeito protetor com dose inferior a 10g de álcool dia e risco de HA com consumo de 30-40g de álcool dia. Em homens, o risco aumentado de HA tornou-se consistente a partir de 31g de álcool dia letra C correta. Portanto, podemos concluir que apenas uma minoria da população consegue identificar e aplicar a dieta hipossódica como medida de prevenção para hipertensão arterial. Gabarito D.

157599.

Comentário: A MAPA e a MRPA são os métodos habitualmente utilizados para realizar as medições fora do consultório. Ambas fornecem informações semelhantes da PA, porém só a MAPA avalia a PA durante o sono. Ambas, entretanto, estimam o risco cardiovascular, devendo ser consideradas aplicáveis para a avaliação da PA fora do consultório, respeitando-se as suas indicações e limitações. As principais vantagens da medição da PA fora do consultório são (1) Maior número de medidas obtidas. (2) Refletem as atividades usuais dos examinandos. (3) Abolição ou sensível redução do efeito de avental branco (EAB). (4) Maior engajamento dos pacientes com o diagnóstico e o seguimento. Portanto, a alternativa incorreta é a LETRA C Os pacientes que fazem medidas fora do consultório sentem-se MAIS estimulados a dar seguimento ao acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial, sendo essa uma das vantagens desses métodos.

157602.

Comentário: Vamos analisar as assertivas sobre alguns conceitos da hipertensão arterial (HA) A) Correta. O acidente vascular encefálico (AVE) é também a principal causa de mortalidade na população brasileira. B) Correta. A eficácia e a tolerabilidade de um fármaco devem ser levados em consideração no tratamento de qualquer doença, principalmente de uma doença tão prevalente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

com a HA. C) Incorreta. A associação de HA e DM dobra o risco cardiovascular e tem aumentado a prevalência de HA, fato ligado à elevação nas taxas de sobrepeso e obesidade, bem como ao aumento da população de idosos em nosso meio. D) Correta. Embora existam divergências na literatura em relação ao alvo pressórico, a 7 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial considera que em pacientes com alto risco cardiovascular (ex. AVE AIT prévio), a meta é PA 130 80 mmHg. Portanto, alternativa incorreta e resposta LETRA C.

157598.

Comentário: Os alfabloqueadores são medicamentos que agem como antagonistas competitivos dos 1 -receptores pós-sinápticos, levando à redução da resistência vascular periférica sem maiores mudanças no débito cardíaco (letra C incorreta). São representantes dessa classe a doxazosina, prazosina e terazosina. O efeito hipotensor é discreto como monoterapia, sendo a preferência pelo uso associado. Apresentam contribuição favorável e discreta no metabolismo lipídico e glicídico, e em especial na melhora da sintomatologia relacionada à hipertrofia prostática benigna. As demais assertivas estão corretas e são conceituais. Resposta letra C.

157603.

Comentário: Temos problemas com essa questão Retirada da 7 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, o autor conseguiu se confundir nas alternativas. Vamos entender o porquê... Pacientes com doença renal crônica em terapia renal substitutiva e hipertensos devem preferencialmente aferir sua pressão arterial (PA) longe do momento em que fazem a diálise, pois no momento pré-diálise ela está geralmente superestimada, assim como é subestimada quando obtida após a diálise, além de apresentar grande variabilidade (letras C e D corretas). Por esse motivo, a medição da PA desses pacientes deve ser feita preferencialmente fora das unidades de diálise, nos intervalos interdialíticos (letra A correta). Uma boa forma de verificar a PA desses pacientes é com medidas de PA residencial. As medidas de PA residencial apresentam boa associação com a MAPA, bem como com o prognóstico cardiovascular em pacientes dialíticos. Além disso, um estudo randomizado mostrou que decisões terapêuticas baseadas na medição de PA residencial associam-se a melhor controle pressórico interdialítico avaliado pela MAPA de 24h em comparação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

à medição de PA pré-diálise (letra B incorreta). Portanto, podemos verificar que a questão possui três alternativas corretas letras A, C e D . A mesma deveria ter sido anulada, mas o gabarito liberado pelo concurso foi letra A.

157717.

Comentário: Ao eletrocardiograma, podemos evidenciar supradesnivelamento do segmento ST ou alterações de repolarização ventricular, taquicardia sinusal (geralmente desproporcional à febre se houver), arritmias variadas, evidência de aumento ventricular, ainda podendo ser normal ou demonstrando alterações pouco específicas. Dessas apresentadas, não se descreve devio de eixo do QRS. Um adendo infiltrado pulmonar não é observado pelo ECG, mas de toda forma, gabarito letra C

157610.

Comentário: Vamos analisar as assertivas acerca do quadro descrito. A) Incorreta, pois o controle da hipertensão arterial é a medida mais eficaz para redução do risco cardiovascular. B) Incorreta, pois o tratamento da hipertensão arterial é fundamental para evitar a progressão de um estágio precoce de doença renal crônica para um estágio mais avançado. C) Incorreta, pois a albuminúria é um marcador prognóstico desfavorável tanto de doença renal, como de doença cardiovascular (ex. infarto, AVE, morte). A explicação é que esse é um marcador de dano de lesão em órgão-alvo relacionado a mau controle de doenças de base (principalmente diabetes). D) Correta. A estratégia mais utilizada atualmente nos casos de doença renovascular em idosos (estenose renal por aterosclerose) é a terapia farmacológica, cujo fundamento é o uso racional de anti-hipertensivos, de preferência aqueles que bloqueiam a síntese ou a ação da angiotensina II (IECA ou BRA). Faz-se necessária prevenção secundária de doença arterial coronariana AAS, betabloqueadores, estatina, controle da glicemia, do tabagismo, do sedentarismo. Além disso, as doses devem ser tituladas com cautela devido à presença de hipotensão postural. Portanto, resposta certa letra D.

157652.

Comentário: As manifestações clínicas da miocardite são bastante variáveis, podendo abranger formas subclínicas, como dilatação e disfunção ventricular assintomática, ou mesmo manifestações

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

clínicas agudas de insuficiência cardíaca descompensada, fulminante com quadro de choque cardiogênico, dor precordial, mimetizando doença coronariana, palpitações, síncope, ou lipotimia, e morte súbita (em crianças ou adultos). Além disso, podem ocorrer alterações eletrocardiográficas transitórias. Na fase aguda, as alterações mais comuns são os distúrbios de repolarização e bloqueios atrioventriculares, assim como padrão sugestivo de isquemia coronariana com infra ou supradesnível do segmento ST de região cardíaca específica ou difusa, sendo que a presença de onda Q indica pior prognóstico. A presença de arritmias supraventriculares ou ventriculares é frequente. Nas fases subaguda ou crônica , predominam os sinais eletrocardiográficos de remodelamento de câmaras, como sobrecarga ventricular e presença de bloqueio de ramo esquerdo, ambos relacionados a pior prognóstico. Nos quadros de acometimento do pericárdio em associação ao miocárdio (perimiocardite), é comum o padrão clássico eletrocardiográfico de pericardite com supradesnível do segmento ST difuso e infra do segmento PR é comum I e III corretas. Pode ocorrer a chamada taquicardia sinusal inapropriada como uma resposta fisiológica (ex. febre), em que a frequência cardíaca fica acima de 100 bpm na tentativa de aumentar o débito cardíaco devido à agressão miocárdica em voga II correta. Portanto, todas as assertivas estão corretas. Resposta letra D.

157617.

Comentário: A emergência hipertensiva é caracterizada pela elevação abrupta da PA, com níveis geralmente maiores ou iguais a 180x120 mmHg podendo chegar a 220x140mmHg, associada à lesão de órgãos alvo. São exemplos disso encefalopatia hipertensiva, AVE, síndrome coronariana aguda, dissecção aórtica, edema agudo de pulmão e eclâmpsia (A correta). As urgências hipertensivas não cursam com lesão de órgão alvo e costumam apresentar níveis tensionais de PA diastólica 120mmHg. São situações na qual os níveis pressóricos podem provocar prejuízo nos próximos dias ou horas. São exemplos de urgência hipertensiva PA elevada em pacientes com doença coronariana estável, aneurisma de aorta não dissecante, queimaduras extensas, epistaxes graves (não é orgão alvo), estados de hipercoagulabilidade, pré-operatório, hipertensão da gestação e crises adrenérgicas leves. (B correta). Devemos reduzir a PA nesses casos com drogas

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

orais, lentamente, ao longo de 24-48 horas (C incorreta), visando evitar hipotensão e isquemia cerebral e visceral (D correta). Resposta C

157621.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas a respeito da hipertensão arterial sistêmica (HAS) no idoso. A. Incorreta, pois a HAS é o principal fator de risco cardiovascular modificável , uma vez que há meios de controla-la através de tratamento. B. Incorreta. De acordo com a 7 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, são considerados idosos indivíduos com 65 anos ou mais de idade, vivendo em países desenvolvidos, ou com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento. C. Incorreta. São chamados de muito idosos aqueles que já alcançaram a oitava década de vida. D. Correta. Essa rigidez em microvasos e artérias se expressa como hipertensão sistólica isolada, condição com alta prevalência na população geriátrica e considerada um fator de risco independente para aumento da morbimortalidade cardiovascular. Gabarito letra D.

157626.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas acerca da hipertensão arterial no idoso. A. Segundo a 7 a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, em pacientes acima de 80 anos, devemos considerar o tratamento anti-hipertensivo apenas para pacientes com PAS maior ou igual que 160 mmHg, objetivando um alvo de PAS 150 mmHg. Correta. B. Já nos idosos com menos de 80 anos, os alvos são parecidos com a população geral iniciar o tratamento quando a PAS está maior ou igual que 140 mmHg, objetivando PAS 140 mmHg. Correta. C. Uma metanálise prospectiva comparou os benefícios de diferentes regimes terapêuticos em pacientes com idade superior ou inferior a 65 anos, confirmando que não existem evidências de que diferentes classes possuam efetividades diferentes em pacientes mais jovens ou mais velhos. Incorreta. D. Devemos sempre lembrar de pesquisar causas secundárias de hipertensão arterial, como as citadas, nos extremos de faixa etária (pacientes muito jovens e idosos). Correta. Portanto, a única assertiva incorreta e resposta da questão é a letra C.

157712.

Comentário: Vamos analisar as assertivas a respeito das miocardites. A. Incorreta. A pesquisa do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fator causal da miocardite através de exames complementares deverá ser guiada de acordo com a suspeição clínica.Todos os pacientes devem ser investigados para doenças sistêmicas inflamatórias autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, sarcoidose, Churg-Strauss e doença celíaca. Por outro lado, a pesquisa de sorologias virais possui baixa sensibilidade e especificidade, apresentando uma correlação de somente 4% da sorologia com a infecção viral miocárdica. Esse dado demonstra que a sorologia viral não deve ser utilizada de forma rotineira para a investigação diagnóstica da miocardite. No Brasil, a doença de Chagas, em razão de sua alta prevalência, deve ser investigada de forma rotineira em todos os pacientes de áreas endêmicas. B. Correta. O clássico critério de Dallas para miocardite requer células inflamatórias e necrose de miócitos à biópsia endomiocárdica, sendo a ausência de necrose caracterizada como miocardite borderline . Esse critério é bastante criticado pela falta de correlação com a evolução clínica, a presença de vírus e a variabilidade entre patologistas. C. Correta. Os exames de medicina nuclear têm sido aplicados há várias décadas na avaliação de pacientes com suspeita de miocardite. Suas principais aplicações estão relacionadas à avaliação da função ventricular esquerda, avaliação da presença de inflamação cardíaca, identificação de subtipos de miocardites e monitoração da resposta terapêutica. Na avaliação da presença de inflamação cardíaca, a presença de inflamação miocárdica pode ser detectada por diversas técnicas radionuclídicas. A mais estudada na literatura é a cintilografia com 67-Gálio, que apresenta sensibilidade de 50% no diagnóstico da miocardite, sendo que sua melhor utilização diagnóstica se dá nos primeiros três meses de apresentação clínica. D. Correta. A avaliação diagnóstica da miocardite se faz inicialmente através da suspeita clínica, juntamente com métodos diagnósticos não invasivos. A confirmação diagnóstica só é possível através da análise histológica obtida pela biópsia endomiocárdica do ventrículo direito. Na prática clínica a maioria dos diagnósticos de miocardite são de suspeição diagnóstica, pois somente a minoria dos pacientes com suspeita de miocardite são submetidos a investigação por biópsia endomiocárdica para confirmação da agressão inflamatória. Portanto, a assertiva incorreta e resposta da questão é a letra A.

157738.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Vamos nos lembrar que a moderação ao consumo de álcool representa uma das medidas não farmacológicas indicadas para o controle da hipertensão arterial sistêmica (HAS). Provavelmente por estimulação adrenérgica central o abuso de bebidas alcoólicas eleva a pressão arterial de forma consistente. O risco se torna aumentado com consumo de 30-40g de álcool por dia em mulheres e a partir de 31g diários em homens. De forma oposta, o consumo de dose inferior a 10g de álcool por dia apresenta efeito protetor ao desenvolvimento de HAS no sexo feminino, fato possivelmente relacionado ao aumento do HDL-colesterol. A alternativa B é a incorreta.

157748.

Comentário: A medida da pressão arterial fora do consultório está bem estabelecida como método para diagnóstico e seguimento da hipertensão arterial sistêmica. As documentações podem ser feitas através de Medição Residencial de Pressão Arterial (MRPA) ou Medida Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas. A MRPA deve ser encorajada por meio de aparelho do próprio paciente ou em serviços de saúde. Possui inúmeras vantagens, entre as quais Propicia um número maior de medidas, sendo capaz de refletir as atividades habituais do pacientes e aumentar a chance de acerto diagnóstico Permite participação ativa do paciente em diagnóstico e acompanhamento, gerando maior engajamento Reduz o efeito do avental branco, ao eliminar a repercussão do médico sobre o paciente. A alternativa A é a única correta.

157749.

Comentário: A FA dificulta a medição da PA pelo método auscultatório, pois tanto o ritmo cardíaco quanto o volume sistólico ficam totalmente irregulares (D correta). A chamada pseudo-hipertensão está associada ao processo de arterioesclerose (enrijecimento da parede vascular) do envelhecimento. Evidencia-se sua presença através da manobra de Osler, isto é, a artéria radial continua sendo palpada após insuflação do manguito do esfigmomanômetro a um valor acima da PA sistólica (C correta). Idosos apresentam controle autonômico lábil, o que explica grandes variações da PA ao longo de um dia, tanto para mais quanto para menos. Assim, a MAPA é uma ferramenta especialmente útil na avaliação destes pacientes (B correta). Enfim, o hiato auscultatório é realmente mais comum no idoso, e está corretamente descrito na alternativa A. Porém, seus

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

principais riscos são subestimar a PA sistólica ou SUPERESTIMAR a PA diastólica, isto é, sistólica falsamente baixa ou diastólica falsamente ALTA... Resposta certa A.

157753.

Comentário: Todas as assertivas foram retiradas na íntegra da VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, estando, portanto, corretas. A exceção é a letra C estudos recentes sugerem que o consumo de café em doses habituais não está associado com maior incidência de HA nem com elevação da PA. Resposta C.

157655.

Comentário: Os sinais e sintomas descritos permitem um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva . Perante este diagnóstico, é preciso instituir tratamento com drogas que evitem o remodelamento cardíaco e prolonguem a sobrevida betabloqueadores, IECA ou BRA e antagonistas de aldosterona. É preciso também instituir tratamento sintomático, isto é, drogas que aliviam os sintomas, sem prolongar a sobrevida diurético de alça, digital (em casos selecionados). Pois bem, vejamos então as alternativas. As letras A e C estão erradas porque os problemas que elas citam só acontecem quando o paciente já possui insuficiência renal avançada Não podemos concluir que nosso paciente seja um nefropata, com base nas informações fornecidas pelo enunciado. A letra B está errada porque não há interação tóxica documentada entre furosemida e espironolactona. Ora, a resposta aqui é a letra D apesar de necessário e indicado, o betabloqueador só deve ser iniciado após compensação inicial do quadro de congestão pulmonar, o que é feito com restrição salina na dieta e diureticoterapia de alça. Iniciar o betabloqueador antes de se obter isso levará a uma piora paradoxal dos sintomas congestivos, uma vez que tais drogas exercem ação inotrópica negativa. Resposta certa D.

157705.

Comentário: A dobutamina é um inotrópico potente de utilização por via intravenosa e aplicação em casos de descompensação de insuficiência cardíaca relacionados à hipoperfusão e congestão pulmonar. Atua essencialmente por efeito ativador dos receptores beta-1 adrenérgicos miocárdicos, melhorando o débito cardíaco em consequência da atividade ino cronotrópica. Em função do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

aumento da contratilidade miocárdica, tende a aumentar o consumo de oxigênio pelo coração. Em escala menor, estimula os receptores beta-2 adrenérgicos, gerando efeito vasodilatador e potencial para o desenvolvimento de arritmias. Resposta letra B.

157754.

Comentário: As crises hipertensivas constituem-se de elevações abruptas e importantes nos níveis de pressão arterial, as quais podem ser divididas em -Emergências hipertensivas O aumento da PA resulta em ameaça IMEDIATA a vida do paciente, cursando com lesão de órgão-alvo. -Urgências hipertensivas O aumento da PA resulta em ameaça POTENCIAL a vida do paciente, com possibilidade de desenvolvimento de lesão de órgão-alvo nas horas ou dias seguintes. O edema cerebral, sangramento cerebral e edema de papila representam substratos que ocorrem na encefalopatia hipertensiva, acidente vascular encefálico hemorrágico e hipertensão acelerada maligna, modalidades de emergência hipertensiva. A cefaleia em cluster ou em salvas denota uma cefaleia trigêmino-autonômica, com possível mecanismo causado por ativação de vias nociceptivas trigeminovasculares e ativação autonômica craniana reflexa. Habitualmente ocorrem em caráter exacerbações-remissões, não designando formas de crise hipertensiva. Os níveis tencionais podem se elevar de forma SECUNDÁRIA a dor, podendo marcar pseudocrise hipertensiva. Gabarito letra D.

134706.

Comentário: Em uma ruptura de parede livre do VE o paciente evolui com hemopericárdio e tamponamento cardíaco. Nesta situação hiperaguda , uma pequena quantidade de líquido no saco pericárdico (pouco líquido denso) já é suficiente para elevar a pressão intracavitária e tamponar o funcionamento da bomba cardíaca - A certa e C errada. O mero encontro de líquido, sem o correspondente comprometimento hemodinâmico grave, não indica ruptura de parede livre aquele líquido, sem dúvida, não possui pressão aumentada, logo, não exerce efeito compressivo externo sobre o coração - D certa. O diagnóstico das rupturas cardíacas pós-IAM tem que ser dado de forma rápida pela clínica aliada ao ecocardiograma (para que o paciente possa ir logo para o centro cirúrgico), não sendo necessária a demonstração do exato ponto de ruptura miocárdica basta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

demonstrar a existência de hemopericárdio (ruptura de parede livre), jato regurgitante entre VE e VD (ruptura de septo) e ou jato regurgitante entre VE e AE (ruptura de cordoalha mitral ou músculo papilar). O eco, aliás, não tem boa acurácia para encontrar o exato ponto de ruptura (B certa). Resposta certa C.

134744.

Comentário: O nitroprussiato de sódio é um poderoso anti-hipertensivo que dilata tanto artérias quanto veias (C correta), sendo metabolizado inicialmente pelas hemácias, que o transformam em cianeto (altamente tóxico). Este é rapidamente convertido no fígado a tiocianato , que também é tóxico, apesar de menos tóxico que o cianeto (A incorreta). O tiocianato possui eliminação renal, logo, na insuficiência renal o risco de toxicidade aumenta (B correta). Uma das consequências da exposição prolongada ao nitroprussiato é o fenômeno de taquifilaxia, isto é, doses progressivamente maiores passam a ser necessárias a fim de manter o mesmo efeito terapêutico (D correta). Resposta certa A.

134676.

Comentário: A intoxicação por digitálicos (digoxina, deslanosídeo) pode produzir diversos tipos de arritmias cardíacas, tanto bradiarritmias como taquiarritmias. O aumento de frequência cardíaca ou taquisfigmia podem até estar relacionadas com o uso de digitais, porém no contexto de um paciente com insuficiência cardíaca descompensada (que habitualmente cursa com taquicardia compensatória), não são os melhores preditores da intoxicação digitálica (B e C incorretas). Outros sintomas da intoxicação por digitais são os gastrointestinais (anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal), psiquiátricos (delirium , fadiga, confusão, tonteira) e visuais (borramento, diplopia e alterações na percepção da cor, essa última chamada de cromatopsia). A cromatopsia, especificamente a xantopsia (visão amarelada) é uma alteração classicamente associada à intoxicação digitálica e deve nos fazer apontar para esse diagnóstico. Resposta letra A.

134691.

Comentário: As opções contêm duas drogas vasodilatadoras nitroglicerina e nitroprussiato de sódio. A primeira é predominantemente um vasodilatador venoso (redução da pré-carga), dilatando

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

também o leito coronariano. A segunda é vasodilatador muito mais potente, que além de dilatar veias e leito coronário, dilata também as artérias musculares da periferia (redução da pós-carga). Logo, resposta certa C.

139793.

Comentário: No adulto, são requisitos gerais para uma adequada mensuração lugar confortável, braço apoiado a nível equivalente ao coração paciente em repouso por 5 min, manômetro calibrado e de fácil visualização manguito que cubra 40% do perímetro da circunferência do braço, inflar rapidamente até 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso arterial distal e desinflá-lo a uma velocidade de 2-4 mmHg s, considerar o aparecimento dos sons para identificação da pressão sistólica (PAS) e o desaparecimento (fase V de Korotkoff) para identificação da pressão diastólica (PAD),desinflar totalmente o manguito após a aferição e aguardar pelo menos 1-2 min para nova medida. A aferição da PA é influenciada pelas seguintes situações exercício, refeição, estresse, distensão vesical, dor, fumo, frio e calor excessivo. No caso da aferição da PA na criança, os requisitos são quase todos os mesmos, com exceção do manguito, que nesse caso deve cobrir 2 3 do comprimento do antebraço e 3 4 de sua circunferência. Manguitos maiores levam a valores menores que o real e manguitos menores levam a valores maiores que o real.

134778.

Comentário: A tríade de Beck é o achado semiológico clássico do tamponamento cardíaco e consiste em hipotensão arterial, turgência jugular e hipofonese de bulhas. Apesar de ser um achado clássico, está presente na minoria dos casos dessa condição. Resposta correta A

111831.

Comentário: A dobutamina é um agonista beta-1 adrenérgico que promove basicamente um efeito de inotropismo positivo sobre o coração, isto é, aumenta a contratilidade miocárdica, aumentando o débito cardíaco. Algum efeito cronotrópico (taquicardizante) também acaba sendo observado... Por conta do aumento do débito cardíaco, há um reflexo vascular de diminuição da resistência vascular periférica, ou seja, vasodilatação. A dobuta, ao contrário do que algumas pessoas erroneamente pensam, NÃO É um agente vasopressor primário... Se quisermos aumentar a pressão arterial do

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

paciente o mais correto é lançar mão de um vasoconstrictor periférico, como a noradrenalina ou a vasopressina Resposta certa D.

111872.

Comentário: A nifedipina é um bloqueador dos canais de cálcio diidropiridínico que exerce seu efeito por vasodilataç o periférica. As diidropiridinas de curta ação provocam uma rápida vasaodilataç o arterial que desencadeia uma taquicardia e aumento da contratilidade cardíaca por ativação reflexa do sistema nervoso simpático. Por esta razão, estas drogas não devem ser utilizadas em pacientes com isquemia miocárdica. Existem formulações de liberação lenta que não possuem este efeito.

111891.

Comentário: A escolha de um anti-hipertensivo deve levar em consideração o contexto clínico do paciente. O propranolol é uma das drogas de primeira linha na profilaxia da enxaqueca. Metoprolol e timolol também são betabloqueadores considerados bem estabelecidos como profilaxia eficaz para enxaqueca. Atenolol e nadolol são provavelmente eficazes, mas menos estabelecidos.

111906.

Comentário: As três drogas podem ser empregadas no tratamento do edema agudo de pilm o. Os efeitos esperados dos nitratos, como a nitroglicerina, são vasodilatação coronariana e venosa. Desta forma esta medicação reduz o retorno venoso sistêmico (pré-carga) para o VD e consequentemente para o VE. A furosemida e a morfina possuem como efeito primário ação diurética e analgésica, mas possuem de forma concomitante efeito secundário venodilatador. Desta forma, também atuam reduzindo o retorno venoso. Ainda, no contexto do EAP a morfina exerce efeito ansiolítico, reduzindo a sensaç o de dispneia. Todas as opções reduzem a pré-carga ventricular esuqerda.

111838.

Comentário: A encefalopatia hipertensiva se caracteriza por aumento súbito e significativo da pressão arterial, que ultrapassa o limite da auto-regulaç o cerebral, gerando hiperfluxo vascular e consequente extravasamento de liquido para o espaço intersticial com edema cerebral. Esta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

entidade usualmente ocorre com níveis muito altos de PA (240 X 130 mmHg). O quadro clínico caracteriza-se por cefaleia, náuseas e vômitos, podendo haver rebaixamento do nível de consciência e crises convulsivas. Sinais focais não s o encontrados.

111870.

Comentário: A PA desta paciente encontra-se em níveis perigosamente altos em curto prazo Resposta claro que sim, pois a sistólica está acima de 180 mmHg (a diastólica, por outro lado, está abaixo de 120 mmHg). Como classificar, então, o atual evento hipertensivo Trata-se de uma emergência, uma urgência ou uma pseudocrise hipertensiva Resposta ainda não podemos ter certeza neste momento. Veja bem com uma sistólica acima de 180 mmHg e uma queixa de forte cefaléia presente logo após acordar, a primeira preocupação que nos vem à mente é a possibilidade de encefalopatia hipertensiva . De um modo geral, os valores de PA que ocasionam este quadro são bem mais altos do que a PA apresentada pela paciente (240 x 120 mmHg), porém, um indivíduo previamente normotenso pode muito bem fazer uma encefalopatia hipertensiva até mesmo com a sistólica abaixo de 180 mmHg (o enunciado não informa se a paciente é hipertensa prévia ou não). Na encefalopatia hipertensiva esperamos outras alterações neurológicas difusas além da forte cefaleia secundária à hipertensão intracraniana e ao edema cerebral o paciente também costuma apresentar alterações visuais, delirium , estupor, coma, crise convulsiva, etc, no entanto, nada impede que a paciente esteja apenas abrindo o quadro de encefalopatia hipertensiva e, por isso, neste exato momento, possui apenas cefaleia... O diagnóstico de uma EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA como a encefalopatia requer a identificação de níveis extremamente altos de PA em conjunto com sinais e sintomas de lesão AGUDA de um órgão-alvo. Na realidade, a queixa apresentada pela paciente (cefaleia isolada), pode ou não representar uma lesão aguda de órgão-alvo em sua fase inicial. O fato é que outra explicação igualmente possível para o caso seria a seguinte a paciente tem cefaleia por qualquer outro motivo (ex. enxaqueca, cefaleia tensional) e esta está CAUSANDO DIRETAMENTE UM AUMENTO REACIONAL DA PRESSÃO ARTERIAL Entenda bem o dilema clínico que temos a nossa frente não estamos dizendo que o diagnóstico de emergência hipertensiva pode ser descartado neste

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

momento... O que estamos colocando em discussão é que o atual quadro da paciente poderia ser igualmente explicado por um problema bem mais simples que uma emergência hipertensiva (a cefaleia é a causa do aumento na PA, e não sua consequência, ou seja, ainda pode se tratar de uma PSEUDOCRISE HIPERTENSIVA). Tais considerações são da maior importância prática, pois o tratamento de cada uma dessas condições é absolutamente diferente Na emergência, internaremos a doente no CTI e iniciaremos poderosos anti-hipertensivos parenterais (como o nitroprussiato de sódio), enquanto que, na pseudocrise, provavelmente resolveremos a história toda em questão de minutos ou poucas horas, liberando a paciente para casa o problema é que indicar o tratamento errado, por ter feito um diagnóstico errado, poderá ser extremamente prejudicial. Então pense conosco ainda não existem indícios convincentes de lesão aguda de órgão-alvo, correto De todos os sinais e sintomas de uma encefalopatia hipertensiva esta paciente possui apenas a cefaleia que, como vimos, também poderia ser explicada por outros motivos, logo, consideramos que é seguro e prudente não iniciar logo de cara um anti-hipertensivo parenteral, a despeito da PA bastante elevada, devendo-se primeiro tratar os problemas já identificados, isto é faremos analgésicos para a cefaleia, junto com ansiolíticos (pois a paciente está claramente ansiosa) vamos esperar de 30 minutos a 1 hora (tempo suficiente para as drogas ministradas fazerem um bom efeito), mantendo a paciente sob vigilância. Findo este prazo, reavaliaremos o quadro se houver melhora (sintomas e PA), o diagnóstico de pseudocrise poderá ser definitivamente estabelecido Se não houver melhora (ou se houver piora), aí sim, bancaremos os riscos inerentes ao tratamento anti-hipertensivo parenteral. A literatura já deixou bem claro que iniciar um anti-hipertensivo parenteral numa pseudocrise hipertensiva é comprovadamente MALÉFICO, acarretando sérias consequências adversas Logo, em vista da dúvida diagnóstica (pela inconsistência de um diagnóstico definitivo de emergência hipertensiva), o teste terapêutico de escolha deverá ser baseado na hipótese mais simples, isto é, de pseudocrise hipertensiva. Melhor resposta D.

111901.

Comentário: O nitroprussiato de sódio é uma substância fotossensível, isto é, a luz solar pode

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

promover sua decomposição, levando a uma perda de efeito clínico. A infusão de nitroprussiato deve ser feita com o equipo do soro protegido da luz (revestido com papel). Resposta certa C.

350864.

Comentário: Paciente jovem, previamente hígido (atleta), apresentando hipertensão arterial (HA) de difícil controle, com início recente, evoluindo com hipocalemia grave, sintomática e inexplicada... Hipertensão arterial grave de início recente em indivíduo previamente hígido é um dado que sugere hipertensão arterial secundária Sabemos que todo paciente suspeito para HA secundária deve ser cuidadosamente investigado para a presença de manifestações peculiares que possam sugerir um diagnóstico etiológico específico, de modo a orientar a realização de exames complementares direcionados, o que torna esta investigação muito mais custo-eficaz. No caso em tela, temos uma manifestação peculiar bastante evidente hipocalemia grave inexplicada (ex. o paciente não utiliza diuréticos, o que poderia a princípio justificar a queda do potássio sérico)... Ora, temos que procurar então por causas de HA secundária associadas à hipocalemia, e a principal é o hiperaldosteronismo primário , uma vez que a aldosterona estimula a reabsorção de sódio no túbulo coletor renal, em troca da secreção de potássio (caliurese)... O hiperaldosteronismo primário pode ser causado por um aldosteronoma (tumor adrenal secretor de aldosterona) ou por hiperplasia cortical adrenal. Letra A correta. Os tumores adrenais costumam ser localizados por meio de imagem tomográfica do abdome, logo, tal achado seria útil no caso apresentado. Letra B incorreta. Outra causa de HA secundária que poderia justificar hipocalemia (neste caso, por hiperaldosteronismo secundário) seria a estenose de artéria renal, que cursaria com estenose vascular, e não com aneurisma de artéria renal... Letra C incorreta. Hematúria e proteinúria são indícios de glomerulopatia, ou seja, HA secundária a uma doença parenquimatosa renal. Na maioria das vezes a doença renal cursa com hipercalemia. Letra D incorreta. Atrofia renal na ultrassonografia também é sugestiva de doença parenquimatosa renal e, como dissemos, a HA secundária neste caso cursaria com hipercalemia. Resposta certa letra A.

350877.

Comentário: O enunciado descreve uma paciente de 45 anos que realizou mudanças no estilo de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

vida após ter sido diagnosticada com pré-diabetes, o que resultou na perda de 15 kg e no retorno da HbA1c para níveis normais. Porém, ainda assim, ela apresenta níveis pressóricos elevados, configurando hipertensão arterial sistêmica. Inclusive, pela classificação da diretriz brasileira, trata-se de uma hipertensão estágio 2, uma vez que a PA diastólica é ou 100 mmHg. Nestes casos, a recomendação é iniciar tratamento com duas medicações anti-hipertensivas - embora, no caso da questão, a paciente tenha se mostrado contrária ao uso de mais de uma droga. Seja como for, o grande ponto dessa questão é qual anti-hipertensivo devemos prescrever neste caso Dispomos hoje de quatro classes de medicamentos consideradas de primeira linha e a escolha entre elas deve ser baseada nas características e comorbidades do paciente. São elas diuréticos tiazídicos, inibidores da ECA (IECA), antagonistas da angiotensina (BRA) e antagonistas do cálcio (BCC). No caso da questão, existe um dado que coloca os IECA BRA como a melhor opção para esta paciente a presença de albuminúria severamente aumentada (ou 300 mg g) Tais medicações auxiliam na redução da pressão intragumerular, diminuindo a albuminúria e, consequentemente, melhorando desfecho renal. Uma dúvida que poderia surgir é com relação a causa da nefropatia Classicamente, sabemos que a albuminúria está associada a doença renal do diabetes, entretanto, também pode se encontrada na nefropatia hipertensiva. Provavelmente, é o que estamos vendo aqui Com relação as outras opções Letra A incorreta. A paciente apresenta edema de membros inferiores, o que pode ser agravado com o uso de BCC. Letra B incorreta. Até poderíamos prescrever um diurético tiazídico para esta paciente, mas não teríamos nenhum benefício adicional do ponto de vista renal. Por isso, não é a melhor escolha Letra D incorreta. Além de também não ter efeito benéfico na albuminúria, de forma geral, os betabloqueadores não são considerados anti-hipertensivos de primeira linha. Resposta letra C.

350895.

Comentário: Resumindo, temos um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (FE 40%). Nesse sentido, sabemos que algumas drogas trazem benefício de sobrevida, enquanto outras apenas promovem melhora sintomática. Com isso em mente, vamos às opções Letra A correta. Classe mais conhecida para o tratamento do diabetes mellitus e que mostrou,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

recentemente, benefícios como redução do risco de morte e hospitalização por IC, independentemente da presença de diabetes. O dados iniciais vieram do estudo DAPA-HF, com uso da dapagliflozina (se ClCr 30 ml min), naqueles com IC de classes funcionais II IV e, posteriormente, também observados com a empagliflozina pelo estudo EMPEROR- Reduced (se ClCr 20 ml min). A ideia é adicionar a classe ao esquema padrão (betabloqueador, antagonista do sistema renina-angiotensina e antagonista da aldosterona), compondo um esquema quádruplo , desde que a função renal permita. Letra B incorreta. A combinação hidralazina e nitrato até traz benefício em termos de sobrevida, mas o uso isolado de hidralazina não. Letra C incorreta. Muito cuidado aqui A valsartana é um bloqueador de receptor de angiotensina (BRA) e agrega benefício de sobrevida sim. O problema é que não pode ser associada ao esquema do paciente, já que ele faz uso de enalapril. Lembre-se de que não podemos associar IECA e BRA Letra D incorreta. Atualmente, digitálicos podem ser indicados nos pacientes com IC que persistem sintomáticos, apesar do uso da terapia medicamentosa otimizada e diuréticos (se necessário para o controle de fluidos). Tal como os diuréticos, não trazem benefício comprovado na sobrevida dos pacientes. Resposta letra A.

321308.

Comentário: A questão descreve paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (40%) e que apresenta importante limitação de sintomas aos mínimos esforços como pentear os cabelos e escovar os dentes (NYHA IV) já em uso de losartana, carvedilol, espironolactona e furosemida, em doses otimizadas. Apesar de a losartana (um bloqueador do receptor da angiotensina II) historicamente ter sido utilizada como droga de primeira linha no tratamento da ICFEr, atualmente, há maior evidência de benefícios e redução da mortalidade com uma outra droga que também atua por meio do bloqueio do sistema renina-angiotensina, que é a combinação de sacubitril valsartana. Essa troca medicamentosa está indicada sempre que o paciente tiver pressão arterial 100 mmHg e não tiver história de angioedema, como no caso clínico em tela (letra B correta). A associação da ivabradina é recomendada à terapêutica padrão em pacientes em ritmo sinusal com FC 70 bpm e classes funcionais II III da NYHA com disfunção sistólica em uso de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

terapia otimizada (letra A incorreta). A dapaglifozina, um inibidor do SGLT2, seria uma boa opção de droga adicional caso o paciente mantenha-se sintomático após a substituição da losartana e a função renal permita (se ClCr 30) No entanto, o carvedilol não deve ser suspenso (letra C incorreta). O cardiodesfibrilador implantável (CDI) reduz significativamente a mortalidade de pacientes com cardiopatia não isquêmica ou isquêmica após 40 dias de IAM, com FE 35% e classe funcional NYHA II ou III (após compensação com tratamento clínico otimizado). Tal estratégia serve como profilaxia primária da morte súbita neste grupo de alto risco para fibrilação ventricular. A indicação para colocação de CDI também se impõe para profilaxia secundária em pacientes com episódios de arritmia ventricular com instabilidade hemodinâmica, além daqueles que já apresentaram um episódio de PCR e ainda possuem expectativa de vida acima de um ano (letra D incorreta). Resposta letra B.

292809.

Comentário: O diagnóstico deste paciente é de insuficiência cardíaca congestiva (IVE IVD) por disfunção diastólica de VE (ou seja, uma ICFEP IC com FE preservada). Uma vez que o paciente está congesto, é indicada diureticoterapia na IC, a classe de escolha são os diuréticos de alça, não os tiazídicos, sendo indicada a troca. A dose deve ser cuidadosa, pelo risco de redução demasiada da pré-carga e hipotensão arterial. Tampouco está indicada associação de tiazídico com diurético de alça (excluímos as letras A e C). O paciente encontra-se hipertenso, sendo necessária uma droga para associação com a losartana. O verapamil é uma droga bem tolerada nesses pacientes, sendo geralmente indicada para associação (letra D correta). Por fim, a opção B é absurda, uma vez que associa hidralazina (droga que não está entre as nossas principais opções) e encaminha o paciente cardiopata para o pneumologista. Por exclusão, a única resposta possível é a letra D.

292811.

Comentário: Este paciente de 70 anos procura atendimento na emergência com dispneia, grave hipertensão arterial e estertores crepitantes nos terços inferiores de ambos os pulmões. Qual é o seu diagnóstico Ora, trata-se de provável edema agudo de pulmão hipertensivo. Lembra da fisiopatologia A excessiva pressão arterial faz com que o Ventrículo Esquerdo (VE) torne-se

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

agudamente incapaz de relaxar-se disfunção diastólica o que impede que o sangue proveniente da circulação pulmonar desague no VE. O resultado hipertensão pulmonar aguda, levando à transudação de líquido para dentro dos alvéolos pulmonares, prejuízo à troca gasosa e intensa dispneia. O tratamento farmacológico do edema agudo de pulmão hipertensivo consiste em reduzir o retorno venoso ao coração (pré-carga) e a resistência à saída do sangue do interior do ventrículo esquerdo (pós-carga). Os fármacos incluem nitroglicerina, que atua como vasodilatador arterial e venoso furosemida que, além de ser diurético, também é venodilatadora a morfina foi utilizada por muito tempo para pacientes com edema agudo de pulmão. O problema é que, embora reduza a sensação de dispneia e a pré-carga (venodilatação), foi associada ao aumento de mortalidade em diversos trabalhos (letra B incorreta). Por fim, atente-se não há insuficiência cardíaca diastólica em que se use dobutamina. Essa medicação é útil para casos de edema agudo cardiogênico, já que aumenta a força contrátil do miocárdio (letras A e C incorretas). Resposta letra D.

292865.

Comentário: Questão interessante e do dia a dia do(a) médico(a) generalista. Considerando a aferição pressórica no consultório, o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) pode ser firmado com base na média entre duas medidas da pressão arterial, em pelo menos duas consultas, com níveis maiores ou iguais a 140 x 90 mmHg ou em uma consulta nos pacientes de alto risco cardiovascular, com lesões de órgão-alvo, ou com níveis pressóricos extremamente elevados, isto é, a partir de 180 x 110 mmHg. Assim, pode-se afirmar que o paciente ilustrado é hipertenso, isso com base nos valores pressóricos muito elevados ou na possível cardiopatia hipertensiva o desvio do ictus traduz cardiomegalia (letras A e B incorretas). Por fim, emergência hipertensiva é definida pela elevação grave da pressão arterial associada a lesões agudas de órgão-alvo lembre-se de que a cardiopatia hipertensiva é lesão crônica (letra C incorreta). Resposta letra D.

259712.

Comentário: Sempre que estivermos diante de um caso de IC descompensada, devemos avaliar o perfil hemodinâmico do paciente neste caso, trata-se de perfil quente e úmido . O perfil B de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

descompensação, como o observado neste caso, é o mais comum, caracterizando um paciente congesto que mantém perfusão periférica adequada. Os pacientes com edema agudo pulmonar estão incluídos neste grupo. O tratamento deve ser feito basicamente com diurético e vasodilatadores, como a nitroglicerina, o nitroprussiato e a nesiritida, visando a redução da pré e da pós-carga, a fim de melhorar o desempenho do VE. A VNI pode ser necessária. Resposta C.

234025.

Comentário: Um homem obeso que apresenta fadiga, sonolência diurna e hipertensão deve ser obrigatoriamente investigado para síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono Os fatores predisponentes são obesidade, principalmente central sexo masculino anormalidades craniofaciais, como hipoplasia maxilomandibular aumento do tecido mole e do tecido linfoide da faringe obstrução nasal anormalidades endócrinas, como hipotireoidismo acromegalia e história familiar. Os fatores associados são Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), hipertensão pulmonar, arritmias cardíacas relacionadas ao sono, angina noturna, refluxo gastroesofágico, prejuízo na cognição e na qualidade de vida e insônia. Nesse caso, o exame indicado é a polissonografia. Resposta A.

234027.

Comentário: Pessoal temos um paciente com estenose aórtica grave, identificada por jato transaórtico 4.0 m s ou gradiente transvalvar 40 mmHg esses pacientes também apresentam geralmente área valvar 1.0 cm2, embora este não seja um critério diagnóstico. Pessoal, EA grave sintomática é igual a troca valvar, sendo opções o implante de prótese transcateter ou a cirurgia convencional de troca valvar. O que estabelece o tipo de abordagem é o estado geral do paciente e a necessidade ou não de revascularização miocárdica. Este paciente não apresenta indicação de RVM pelo CATE, porém tem um risco cirúrgico quase proibitivo para uma cirurgia convencional (idade, enfisema, DRC, DM mal controlado), o que favorece a escolha pelo implante de bioprótese transcateter. Resposta C.

199784.

Comentário: O ECG revela a presença de sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo, e o fundo de olho mostra duas alterações arterioscleróticas da retinopatia hipertensiva (1) cruzamento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

arteriovenoso patológico (2) mudança do reflexo arteriolar. Vamos lembrar que, com a progressão das lesões retinianas por efeito da pressão arterial elevada, surgem alterações patológicas nos pontos de cruzamento arteriovenoso, como o ocultamento do segmento da vênula sob a arteríola (círculo). Além disso, o reflexo arteriolar pode se encontrar alterado devido às mudanças estruturais do vaso (estreitamento de suas paredes e diminuição do lúmen), dando um aspecto dourado a ele, como se fosse um fio de cobre , ou, com a progressão da doença, um aspecto mais esbranquiçado, como um fio de prata (seta). Ora, o paciente tem indícios de lesão de órgão-alvo da hipertensão arterial sistêmica, porém, este diagnóstico não pode ser confirmado ambulatorialmente. Que hipótese diagnóstica se impõe Temos que considerar que se trata de um quadro de HIPERTENSÃO MASCARADA, isto é, o paciente é normotenso na frente do médico, mas fica hipertenso a maior parte do tempo no dia a dia. A principal explicação é que algumas pessoas, paradoxalmente, relaxam quando vão na consulta, diminuindo o tônus adrenérgico e promovendo, assim, uma resposta pressórica redutora transitoriamente. A MAPA (Monitorização Ambulatorial da PA) está indicada para esclarecer essa possibilidade, e a resposta a ser marcada aqui é, sem dúvida, a letra C.

199737.

Comentário: Pacientes com hipertensão pulmonar apresentam uma clínica relativamente inespecífica marcada, dentre outros achados, por dispneia aos esforços, dor torácica (que pode ser por distensão da artéria pulmonar ou por isquemia cardíaca) e falência de ventriculo direito com congestão sistêmica. Ao exame físico, podemos encontrar hiperfonese de P2, ictus de VD palpável e B4 de VD. Em casos avançados, há B3 de VD e sopro de insuficiência tricúspide. A radiografia de tórax mostra abaulamento do segundo arco à esquerda, redução da vascularização pulmonar e aumento do átrio e ventriculo direitos. O ECG pode evidenciar sinais de sobrecarga de câmaras direitas enquanto o ecocardiograma ajuda a elucidar a etiologia e estimar a pressão da artéria pulmonar. A causa primária ou idiopática é mais rara. Geralmente, a hipertensão pulmonar faz parte do constructo clínico de alguma outra doença e, como nosso paciente não tem diagnóstico etiológico estabelecido, é necessário prosseguir com a investigação antes de tratá-lo. Isso pode até

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ser feito de forma não invasiva com prova de função respiratória, TC de tórax (em caso de suspeita de doença intersticial) e cintilografia pulmonar (ou mesmo angiotomografia de artérias pulmonares), mas o melhor exame é o cateterismo direito. O ecocardiograma ajuda por ser capaz de estimar a PSAP e muitas vezes até esclarece a provável etiologia, mas o Harrison é claro em dizer que o ecocardiograma é um exame de triagem, enquanto o monitoramento hemodinâmico invasivo é o padrão-ouro para diagnóstico e avaliação da gravidade da doença . Seria até possível também a realização de um teste de esforço antes da monitorização invasiva, mas nosso paciente já tem relato de dispneia aos esforços, o que aumenta muito a chance do teste ser positivo e não alterar a conduta. A melhor resposta seria, de fato, a letra D. Acontece que o enunciado tem um erro grosseiro ao afirmar que a PSAP de 80 mmHg é normal já que valores 25 mmHg são considerados anormais. Por essa razão, a questão acabou sendo anulada...

172954.

Comentário: O pulo do gato aqui era atentar para o fato de que um pró-BNP elevado confirma a existência de um componente cardiogênico para a dispneia Muita gente pode ter desconsiderado a hipótese de congestão pulmonar devido à ausência de estertores na ausculta pulmonar, porém, não podemos esquecer que os sibilos eventualmente significam congestão, caracterizando a chamada asma cardíaca (obstrução do lúmen da via aérea por edema da mucosa brônquica). Teríamos mesmo que pensar nesta possibilidade haja vista que todo o restante do contexto clínico aponta para um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva (paciente hipertenso mal controlado com história de dispneia progressiva aos esforços, apresentando turgência jugular e terceira bulha cardíaca). O fato é que após história e exame físico realmente ficamos em dúvida quanto à causa da dispneia, porém, o pró-BNP bem indicado serviu como divisor de águas para mostrar a origem do problema. Assim, para tratar o edema pulmonar cardiogênico, a droga de escolha é o diurético de alça, como a furosemida . Resposta certa B.

150878.

Comentário: Temos um paciente com doença isquêmica do miocárdio que evoluiu com insuficiência ventricular e vem piorando sua classe funcional (atualmente NYHA III). Sabemos que não há

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

artérias ou enxertos a serem abordados, pois o paciente tem uma coronariografia recente sem obstruções significativas. Precisamos, portanto, otimizar a terapia clínica do paciente com o objetivo de melhorar sua classe funcional e aumentar sua sobrevida. O paciente já está em uso de betabloqueador, IECA, AAS e estatina, no entanto, há mais um medicamento indicado que não está sendo usado o antagonista de aldosterona (ex. espironolactona). Essa classe de medicamentos está indicada em paciente com IC sintomática (estágio C), FE 35% e classe funcional NYHA II a IV. Estima-se que essa intervenção reduza a chance de internações em 35% e o risco de morte por IC em cerca de 30% nessa população. Resposta A.

126997.

Comentário: Se o paciente está evoluindo com disfunção ventricular, isto é, apresentando indícios de uma Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida (ICFER), pode-se mudar a história natural da doença, promovendo um aumento de sobrevida (evitando-se o remodelamento cardíaco) com o uso das três principais abordagens farmacológicas (1) betabloqueadores específicos (carvedilol, bisoprolol ou metoprolol) (2) IECA ou BRA (3) antagonistas do receptor de aldosterona. O propranolol não pertence ao subgrupo dos BB que mostrou benefício especial no tratamento da ICFER, apesar de poder ser usado com sucesso no paciente coronariopata sem ICFER. A anlodipina é um di-hidropiridínico de longa ação que funciona como anti-hipertensivo e antianginoso, mas não mostrou efeito especial de aumento de sobrevida na ICFER. A nifedipina é um di-hidropiridínico também, porém possui ação rápida. Logo, só devemos empregá-lo se este for de liberação lenta (ex. nifedipino retard), pois, caso o contrário, ocorre AUMENTO no risco de morte, já que se trata de poderoso vasodilatador que induz intensa taquicardia reflexa. Resposta letra C.

126941.

Comentário: Trata-se de uma questão específica e conceitual, talvez mais apropriada para uma prova para especialista em ecocardiograma ou no máximo para um candidato a R3 em Cardiologia... Mas vamos lá temos um paciente de 55 anos, masculino, com indícios de insuficiência ventricular esquerda (dispneia progressiva B3 à ausculta cardíaca), portador de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

fibrilação atrial, com achados semióticos compatíveis com insuficiência mitral (Sopro sistólico 2 6 , com epicentro no foco mitral). Ao ECO, o módulo M nos traduz a rampa ef, que é a fase inicial da diástole, sendo sucedida pela contração atrial. Com o aumento da pressão diastólica final do VE, como ocorre na cardiopatia dilatada, a rampa ef fica lenta em sua descida , sobrevindo uma segunda onda para vencer a restrição distólica (Como a restriçao diastólica atrapalha o esvaziamento atrial, surge uma segunda onda para vencer tal impedimento hidrostático). No modulo M, se faz um corte transverso da valva mitral, no qual se constata, com a valva normofuncionante, uma imagem triangular , correspondente à sua abertura e fechamento. Sendo assim, como na IM o sangue reflui na sístole, ocorre o surgimento de um novo triângulo , achado que assemelha a um pinheiro tombado . Portanto, a resposta correta é a opção A.

126947.

Comentário: Sabemos que além de o principal fator de risco para a síndrome de apneia obstrutiva do sono ser a obesidade, homens são acometidos cerca de 3 vezes mais do que mulheres. Em relação ao quadro clínico, roncos e fadiga e sonolência matinais são os sintomas preponderantes Neste contexto, é mandatória a realização de uma polissonografia, que ao mostrar 5 ou mais eventos respiratórios predominantemente obstrutivos (apneias mistas ou obstrutivas, hipopneias ou despertares relacionados a esforço respiratório), fecha o diagnóstico. Alternativa C correta.

126993.

Comentário: Vamos devagar, pois a questão é polêmica. Estamos diante de uma paciente com Hipertensão Arterial Estágio 1, correto O que fazer Avaliar o seu risco cardiovascular. Trata-se de uma mulher, com idade abaixo de 65 anos, que não é tabagista, com triglicerídeos abaixo de 150, HDL acima de 40, sem diabetes e sem história familiar. Logo, possui BAIXO RISCO CARDIOVASCULAR. Agora que vem a pergunta. O que fazer para um paciente com HAS estágio 1 e baixo risco cardiovascular Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial indica-se, inicialmente (por um período máximo de 6 meses), terapia não medicamentosa, como medidas de modificação do estilo de vida. Mas a paciente não tem o que mudar você pensa. Não podemos afirmar com tanta certeza. Sua alimentação pode ser desregrada, sua ingestão de sódio diária pode

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ser elevada, sua ingesta de estimulantes também. Sendo assim, deve-se adiar por 3-6 meses a decisão por uma terapia medicamentosa. E reavaliar a paciente após esse período. Resposta letra C.

81254.

Comentário: Diante de um paciente com dispneia aos esforços, com sinais de congestão pulmonar, edema de membros inferiores, terceira bulha, hepatomegalia e aumento da área cardíaca no raio X de tórax, temos que pensar em insuficiência cardíaca congestiva como a principal hipótese diagnóstica (4 critérios maiores terceira bulha, estertores pulmonares, raio X com cardiomegalia e congestão pulmonar e 2 critérios menores hepatomegalia e dispneia aos esforços de Framingham). Além disso, ele apresenta um fator de risco para miocardiopatia dilatada, que seria o alcoolismo. Neste contexto, o autor quer saber quais são as drogas utilizadas no tratamento da ICC associadas à redução de mortalidade em longo prazo. Vamos listá-las a seguir inibidores da ECA antagonistas dos receptores de angiotensina antagonistas da aldosterona betabloqueadores associação de nitrato com hidralazina. Alternativa C CORRETA.

81239.

Comentário: Quando avaliamos um doente com queixa de dor torácica, a primeira coisa que devemos fazer é BUSCAR SINAIS DE INSUFICIÊNCIA CORONARIANA AGUDA. Não dá para você admitir um doente na sala de emergência com dor torácica e DEIXAR DE PEDIR um Eletrocardiograma (ECG) nos primeiros dez minutos do atendimento ao paciente. E o autor fez questão de seguir esse protocolo, tendo o eletrocardiograma desse paciente sido normal. Mesmo com um eletrocardiograma normal, nosso paciente poderia ter insuficiência coronária aguda SIM Ele poderia ter IAM sem supra de ST ou angina instável. Mas o que você tinha que perceber para resolver esta questão de prova era que o doente tem ALARGAMENTO DO MEDIASTINO e ASSIMETRIA DE PULSOS BRAQUIAIS Agora, é só fazermos as contas Dor torácica com irradiação para dorso assimetria de pulsos braquiais alargamento do mediastino Dissecção aguda de aorta. De posse dessas informações, agora sim podemos responder a pergunta. Qual é o exame mais adequado Como se trata muito provavelmente de uma dissecção da aorta ascendente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

arco da aorta pois não há sintomas abdominais, por exemplo, isto associado ao alargamento do mediastino o exame de escolha é um ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO. É deste modo que, nesta questão, podemos praticamente afastar insuficiência coronariana aguda, pois ele nos dá uma hipótese diagnóstica muito mais plausível pelos dados apresentados. Cintilografia do miocárdio é um exame que avalia o fluxo coronariano. Portanto, letra A INCORRETA. Letra B INCORRETA. A sensibilidade do ecocardiograma transtorácico neste caso é inadequada. O exame correto seria o TRANSESOFÁGICO. A aortografia nestes doentes é um exame usado pelo cirurgião para melhor planejar a cirurgia e observar a lesão íntima característica desta condição. Deste modo, seu uso não é o mais indicado para CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA. Observando tudo isso, a alternativa que nos resta é a Tomografia Computadorizada Helicoidal de Tórax, que tem sensibilidade 85 a 95% para o diagnóstico da condição em discussão. Resposta correta letra D. Vale ressaltar que o doente do caso está sendo acometido por uma EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA, pois há pressão arterial de 180 x 120 mmHg e LESÃO EM ÓRGÃO-ALVO Deveríamos, pois, tratá-lo com drogas anti-hipertensivas parenterais, como é o caso do nitroprussiato de sódio. Além disso, precisamos reduzir a força de contração do miocárdio neste caso, utilizando drogas inotrópicas negativas, como é o caso do propranolol, também por via endovenosa.

81314.

Comentário: Nesta questão, estamos vendo conceitos clínicos e da Medicina Preventiva num só quesito. E, viva a transdisciplinaridade De qualquer modo, ao examinarmos este doente com insuficiência cardíaca vemos que este se apresenta com estertores em 2 3 inferiores do tórax, acompanhados de ritmo irregular (que antes não existia). O que nos parece estar acontecendo com este doente Parece que ele está cursando com uma arritmia (muito provavelmente a fibrilação atrial, pela arritmia achada na ausculta cardíaca) que está descompensando sua cardiopatia de base De todo modo, o paciente - se ainda não está - tem grande risco de vir a apresentar, em pouco tempo, um edema pulmonar agudo (estertores em dois terços do torax), que em vigência de arritmia configura um SINAL DE INSTABILIDADE. Não conseguiremos manejar adequadamente

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

este doente numa unidade BÁSICA de saúde, pois existe a possiblidade de necessitarmos de CARDIOVERSÃO ELÉTRICA (caso se confirme taquiarritmia com instabilidade) e NÃO HÁ DÚVIDA de que precisamos fazer um eletrocardiograma do doente, além de monitorizá-lo. Letra A incorreta. Não vamos dar alta a este paciente para retorno em 48h na vigência de uma descompensação aguda como esta. Letra B incorreta. Mais uma vez, nada de dar alta a este paciente no momento. Letra C Incorreta. Não temos tempo de mandar este doente ao serviço de cardiologia para fazer ecocardiograma, pois ele está FRANCAMENTE INSTÁVEL no momento. Letra D Um dos atributos da Atenção Primária à Saúde é justamente a coordenação do cuidado é de responsabilidade da equide de saúde ORGANIZAR AS INFORMAÇÕES e o CUIDADO a respeito do doente. Entendam a equipe de saúde deve continuar o acompanhamento do doente, mesmo que ele vá ser atendido em outra unidade. E, é justamente isso o que queremos fazer com o nosso amigo encaminhá-lo para uma unidade de saúde com maior suporte à demanda dele neste momento. Resposta certa letra D.

81319.

Comentário: Olhando a prescrição deste paciente, o primeiro item que nos salta aos olhos considerando que se trata de um IDOSO é a dose elevada de digoxina que ele está usando. Sabemos que a digoxina é uma das drogas com menor índice terapêutico da prática médica (lembre-se índice terapêutico diferença entre a dose terapêutica e a dose tóxica). Inclusive, referências em geriatria e atenção primária sugerem que a digoxina nunca seja utilizada em doses superiores a 0,125 mg dia nesses pacientes, pois diversos estudos evidenciaram que acima dessa dose a digoxina representa uma das principais causas de iatrogenia farmacológica em idosos. Como ele necessita utilizar digoxina, seria interessante também retirar a hidroclorotiazida. Sabemos que um dos principais fatores de risco para intoxicação digitálica é a hipocalemia, já que a digoxina atua na bomba de sódio e potássio competindo pelo sítio de ligação do potássio. Na vigência de hipocalemia, por conseguinte, o efeito digitálico é exacerbado, o que em idosos se acompanha de grande probabilidade de provocar intoxicação. Como o paciente é portador de ICC, o ideal, inclusive, é que ele esteja em uso de furosemida (diurético de alça). Lembre-se de que a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

furosemida também pode causar hipocalemia, no entanto, o risco é bastante inferior quando comparada à hidroclorotiazida. Resposta certa C.

81321.

Comentário: Vamos analisar essa polêmica questão com calma. Para começar, o que podemos dizer do Seu João Trata-se de um senhor, com poucos fatores de risco, sem síndrome metabólica, sem diabetes e com diagnóstico de Pressão arterial limítrofe (ou pré-hipertensão). O que fazer nesses casos Iniciar imediatamente o tratamento não farmacológico, como mudanças no estilo de vida. Ok Contudo, olhamos mais embaixo e vemos que ele apresenta 1,2 mg dL de creatinina... Será que isso é uma lesão de órgão-alvo ou será que o paciente já apresenta uma doença renal crônica A resposta é não há como saber, mas, a princípio, não, pois faltaram dados para fecharmos esse diagnóstico. Concluindo e resumindo, a melhor resposta era a letra C, devido ao paciente ter pouquíssimos fatores de risco e não apresentar indicação de tratamento medicamentoso inicial (a saber diabéticos ou com SM ou cardiopata ou com lesão de órgão alvo ou com 3 fatores de risco adicionais). No entanto, a banca considerou o paciente, erradamente, com doença renal crônica, provavelmente pelo clearence de creatinina (60) e, tendo isso em vista, recomendou o início do tratamento medicamentoso. Logo, o gabarito divulgado e mantido foi a letra A.

65775.

Comentário: A síndrome clínica descrita permite o diagnóstico de estenose mitral sintomática, o que foi confirmado pelo ecocardiograma e estratificado como grave (área valvar 1 cm^2). Ora, a paciente tem indicação, em tal contexto (EM grave sintomática), de abordagem intervencionista da valvopatia. O escore de Block avalia o grau de distorção anatômica do aparelho valvar e dos tecidos subvalvares, sendo útil para auxiliar na definição da melhor abordagem terapêutica. Classicamente, um Block 8 indica que a valva mitral e, principalmente, o aparelho subvalvar, encontram-se relativamente íntegros e pouco calcificados, sendo esperado um resultado satisfatório com a realização de valvoplastia percutânea com balão ou comissurotomia mitral cirúrgica. Quando o Block é 11 a estrutura valvar encontra-se severamente comprometida e calcificada, sendo enorme o risco de surgir insuficiência mitral importante no pós-operatório de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

valvoplastia ou comissurotomia, já que folhetos muito rígidos e calcificados têm baixa probabilidade de se coaptarem de forma adequada após serem descolados uns dos outros. Nestes pacientes, é preferível realizar a troca valvar cirúrgica Existem duas opções de valva protética metálica ou biológica. Num paciente jovem com longa expectativa de vida - como no caso em tela - o ideal, sempre que possível, é implantar uma valva metálica, pois esta é bem mais duradoura que a biológica, particularmente em se tratando da posição mitral (isto é, no lado esquerdo do coração, onde as pressões e o estresse mecânico são maiores). O grande problema das valvas metálicas é que elas obrigam o paciente a ser anticoagulado plenamente para o resto da vida, o que pode ser uma tarefa difícil de cumprir para muitos pacientes. A banca deu como gabarito a letra B, mas, a nosso ver, uma melhor resposta seria a letra C.

51197.

Comentário: Estamos frente a um paciente que evolui com disfunção sistólica de VE após um IAM. Observe que o autor da questão menciona que a tosse do paciente iniciou-se com ele ainda hospitalizado Então, com isso o autor quer atribuir o surgimento da tosse a algum fato que já existia com o paciente ainda internado Dessa forma, poderíamos até vincular a tosse do paciente ao início do IECA, o qual deveria ser substituído por um BRA (Losartan). No entanto, a dispneia do paciente (iniciada juntamente com a tosse) não é justificada pelo uso do IECA, já que os pacientes que desenvolvem tosse com o uso desta medicação geralmente não cursam com obstrução do fluxo aéreo. Assim, não conseguimos, com o caso apresentado, relacionar a tosse apenas com o uso do IECA, o que já torna esta questão passível de recurso, uma vez que o gabarito divulgado foi a opção B. Já em relação às outras medicações, com o aparecimento de sinais de congestão sistêmica e pulmonar, a introdução de diuréticos de alça também está plenamente indicada. Um outro ponto seria o uso dos betabloqueadores, os quais SEMPRE estão indicados (salvo algumas contraindicações) em pacientes com IC sistólica e doença isquêmica do coração. No entanto, neste momento, com o paciente agudamente descompensado, a introdução desta classe de drogas deve ser postergada, apesar do fato de que o paciente já deveria ter ido de alta com esta droga em sua prescrição após o IAM. O ideal, então, seria manter o IECA, introduzir um diurético de alça

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

(furosemida), compensando o paciente para posteriormente iniciar um betabloqueador e avaliar se a tosse é ou não efeito adverso do enalapril. O gabarito, contudo, foi mantido como a opção B, mesmo após os pedidos de recurso.

51246.

Comentário: Vamos ver cada opção LETRA A ERRADA No momento em que os tiazídicos conseguem controlar a pressão arterial em um grupo de pacientes, eles demonstram sua eficácia em reduzir as complicações cardiovasculares LETRA B CERTA Afirmativa conceitual... São características que comprovadamente aumentam o risco de complicação cardiovascular. LETRA C ERRADA O que busca são medidas antropométricas que fujam dos valores definidores inclusive de síndrome metabólica. Assim, deseja-se uma circunferência abdominal 102 cm para os homens e 88 com para as mulheres. Além disso, busca-se um IMC normal, ou seja, entre 17 e 24,9 Kg m 2 . LETRA D ERRADA Essa superioridade não existe são drogas com eficácia semelhante...

51250.

Comentário: Questão conceitual as recomendações brasileiras e a principal diretriz americana para dislipidemia (NCEP-ATPIII) recomendam a avaliação de perfil lipídico a partir dos 20 anos de idade, repetindo-os a cada 5 anos. Existe ainda uma organização americana (USPSTF) que recomenda o início de rastreio para dislipidemia somente aos 35 anos para homens e 45 anos para mulheres, podendo antecipar para os 20 anos em casos de fatores de risco para doença coronariana. De qualquer maneira, essa variação não invalida a questão. Resposta certa letra A.

37599.

Comentário: O diagnóstico de HAS pode ser feito pela medida casual do ambulatório, residencial (MRPA) e ambulatorial nas 24h (MAPA). No ambulatório, estão elevados valores de PA maiores ou iguais a 140 X 90 mmHg. São consideradas anormais na MAPA as médias de pressão arterial de 24 horas, vigília e sono acima de 125 75, 130 85 e 110 70 mmHg, respectivamente. Na AMPA, valores acima de 130 X 85 mmHg estão alterados. (A e C corretas) Contudo, não só a HAS pode ser diagnosticada, como outras situações também 1) HAS do jaleco ou do avental branco aferições do consultório mostrando hipertensão e outras extra-ambulatoriais mostrando normotensão. (B

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

correta) 2) Efeito do jaleco branco paciente apresenta PAs 20 mmHg e ou PAd 10 mmHg maiores no consultório que fora dele. 3) HAS mascarada aferições de consultório mostrando normotensão e outras aferições extra-ambulatoriais demonstrando PA elevada (D errada).

37609.

Comentário: Vamos analisar as opções A correta Para completarmos, estudos brasileiros com abordagem simultânea de gênero e cor demonstraram predomínio de mulheres negras com excesso de HAS de até 130% em relação às brancas. Não se conhece, com exatidão, o impacto da miscigenação sobre a HAS no Brasil. B incorreta A influência do nível socioeconômico na ocorrência da HAS é complexa e difícil de ser estabelecida. No Brasil, a HAS foi mais prevalente entre indivíduos com menor escolaridade. C correta Porém, não existem, até o momento, variantes genéticas que possam ser utilizadas para predizer o risco individual de desenvolver HAS. D correta Correta e exatamente como consta nas Diretrizes.

32528.

Comentário: O antídoto de primeira linha para tratar a intoxicação por betabloqueadores é o glucagon (que deve ser ministrado em bolus IV de 5 mg durante 1 minuto, seguido de infusão contínua a 2-5 mg h, objetivando manter a PAM em torno de 60 mmHg) O glucagon consegue estimular a adenilato-ciclase intracelular a despeito do bloqueio desta enzima pelo excesso de betabloqueadores. A adenilato-ciclase é responsável pela formação do AMP cíclico intracelular, um importante segundo mensageiro que estimula, entre outros eventos, a liberação de cálcio no citoplasma das células musculares lisas durante o ciclo de despolarização contração. Os sais de cálcio (gluconato ou cloreto) também podem ser usados para tratar a intoxicação por BB, porém, são considerados agentes de segunda linha, reservados aos casos de não resposta ao glucagon (quando então são associados a este último). Resposta certa B.

37616.

Comentário: Observem a tabela extraída das Diretrizes para responder a essa questão (VER IMAGEM) Como podemos perceber, o controle de peso foi o que mostrou maior redução da PA, chegando até 20 mmHg.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

37389.

Comentário: Apesar de trabalhosa, a questão não apresenta grandes dificuldades. Cada pequeno caso clínico apresenta pistas que indicam as respectivas causas de miocardiopatia. No caso I, a dica é o etilismo pesado associado à ICC franca. Não resta dúvida cardiopatia dilatada secundária ao álcool. No caso II, a dica está na descrição ao exame físico do paciente (pletora facial, hipertensão pulmonar - B2 hiperfonética, MV diminuído difusamente, sobrecarga atrial direta no ECG) que indica um DPOC (lembre-se do blue bloater) com ICC. Estamos de frente a uma Cor pulmonale . No caso III, a principal dica é a presença de BRD que junto ao HBAE é uma das manifestações mais comuns da cardiopatia chagásica. No caso IV, a dica está nos fatores de risco para doença arterial coronariana, associados com a presença de onda Q de necrose miocárdica prévia no ECG, sugerindo cardiopatia isquêmica. Assim, a melhor correlação está explícita na letra D .

30865.

Comentário: Os digitálicos não são considerados drogas de primeira linha na IC sistólica. Atualmente, são indicados nos pacientes com IC sistólica sintomática, apesar do uso de diuréticos e vasodilatadores em doses otimizadas. Tal como os diuréticos, não trazem benefício comprovado na sobrevida do paciente apenas agem no alívio sintomático. Devem ser evitados na IC diastólica. Outra indicação do uso de digital é o controle da resposta ventricular (inibição do nódulo AV) em pacientes com IC e fibrilação atrial. Segundo os guidelines da AHA, os betabloqueadores são as drogas mais eficazes, tanto para modular a resposta ventricular à FA em repouso e no exercício, quanto no que tange à mortalidade. A digoxina controla bem a resposta ventricular em repouso, mas não durante exercício. O texto deixa claro que a associação digital betabloqueador é preferível, sendo mais eficaz que o uso de betabloqueador isolado. As demais opções apresentadas não são indicações de uso de digitálico na insuficiência cardíaca (a insuficiência renal pode, ainda, predispor à intoxicação digitálica).

30871.

Comentário: Um ruflar diastólico representa o sinal mais clássico da estenose mitral. Trata-se de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

um sopro meso ou holodiastólico, localizado no ápice (foco mitral), de baixa frequência (melhor audível com a campânula do estetoscópio e em decúbito lateral esquerdo), sem irradiação. O sopro se exacerba ao esforço físico e se reduz ao handgrip , manobra de Valsalva e inspiração profunda. A concomitância de hiperfonese de B1 corrobora o diagnóstico, sendo decorrente do súbito tensionamento dos folhetos valvares durante a sístole, uma vez que esses folhetos estão sendo empurrados contra um átrio esquerdo hipertenso e sobrecarregado . A onda P de duração prolongada (isto é, entalhada na derivação D2, como se houvesse uma onda P para cada átrio direito e esquerdo) e o famoso sinal de Morris (onda P bifásica em V1, com o componente negativo 1 quadradinho) são evidências eletrocardiográficas típicas de sobrecarga do átrio esquerdo, achado esperado na estenose mitral. Por fim, a queixa de palpitação também é condizente com o quadro, uma vez que a sobrecarga atrial induzida pela estenose mitral com frequência produz instabilidade elétrica do miocárdio naquela região e posterior degeneração para fibrilação atrial (que pode ser intermitente ou permanente em particular quando o átrio está aumentado, com mais de 4 cm de diâmetro). Resposta certa E.

25284.

Comentário: O foco mitral está localizado no 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. Tal localização é coincidente com a topografia do ápice cardíaco. O sopro em ruflar diastólico sugere estenose mitral, que numa mulher jovem assintomática, em nosso meio, representa (na imensa maioria das vezes) uma sequela de cardite reumática. Resposta certa letra C.

29446.

Comentário: Segundo a V diretriz Brasileira de Hipertensão arterial (2006), a avaliação inicial de rotina de um paciente com Hipertensão inclui (1) Análise da urina EAS (2) Potássio plasmático (3) Creatinina plasmática (4) Glicemia de jejum (5) Colesterol total, HDL e triglicérides (6) Ácido úrico plasmático e (7) Eletrocardiograma convencional... A TFG deve ser estimada pela fórmula de Cockroft-Gault TFG (ml min) 140 - idade x peso (kg) creatinina plasmática (mg dl) x 72 para homens para mulheres, multiplicar o resultado por 0,85... O LDL-colesterol é calculado pela fórmula

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

LDL-c colesterol total HDL-c triglicérides 5 (quando a dosagem de triglicérides for abaixo de 400 mg dl). A dosagem da ureia plasmática não faz parte desta rotina... Resposta Letra B.

29450.

Comentário: Os dados que sugerem hipertensão arterial secundária são hipertensão de início fora da faixa etária típica (isto é, antes dos 30 anos ou após 55-50 anos) hipertensão grave em brancos hipertensão refratária hipertensão acelerada maligna sopro abdominal (sugere estenose de artéria renal) hipocalemia hipertensão lábil com episódios de taquicardia, tremores e sudorese (sugere feocromocitoma) sinais de endocrinopatia (estigmas de cushing, sinais de hipertireoidismo, etc) insuficiência renal piora da função renal com IECA (sugere estenose da artéria renal bilateral) proteinúria persistente inexplicada e redução ou ausência de pulso femoral (sugere coarctação da aorta). A letra A é a resposta desta questão, simplesmente pelo simples detalhe na V diretriz Brasileira de Hipertensão arterial (2006) o valor utilizado é após 50 anos, e não após 60 anos... Resposta Letra A.

24340.

Comentário: Aumento abdominal caracterizando ascite importante (piparote positivo), num paciente etilista crônico, é sempre igual à cirrose hepática com hipertensão porta, certo Errado... Veja que este paciente, além de ascite, apresenta fígado aumentado, o que não condiz com o diagnóstico de cirrose apesar de não ter sido feita uma verdadeira hepatimetria no exame físico (medida da submacicez hepática na linha hemiclavicular direita, através da percussão), um fígado palpável a 5 cm do RCD muito provavelmente está aumentado Além disso, o mais importante observamos sinais de insuficiência do VD, como turgência jugular patológica (a 45º)... Raramente a hipertensão porta isolada justifica o achado de TJP (seria possível na coexistência de uma síndrome de hipertensão portopulmonar , por exemplo). Logo, estamos mais provavelmente diante de uma síndrome de congestão venosa sistêmica com hepatomegalia congestiva... Agora, o ECG com baixa voltagem e achatamento difuso de onda T (por vezes inversão) traz à tona a hipótese diagnóstica de pericardite constritiva . Tal condição, em nosso meio, com frequência é secundária à pericardite tuberculosa , e cursa caracteristicamente com restrição ao enchimento das 4 câmaras cardíacas,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

gerando, nas fases iniciais, um quadro de congestão sistêmica e ascite cardiogênica. Os sinais e sintomas de IVE (síndrome de congestão pulmonar e baixo débito cardíaco) costumam aparecer mais tarde... O RX de tórax evidencia calcificação em 50% dos casos, com o coração apresentando tamanho normal (ou seja, um RX de tórax normal não descarta esta entidade). O tratamento, nos casos de tuberculose confirmada (causa mais comum), é feito com esquema RIP e pericardiectomia ... De qualquer forma será necessária a realização de biópsia pericárdica para esclarecer o diagnóstico antes do tratamento. Resposta certa letra C.

24343.

Comentário: Vamos analisar as alternativas... A CORRETA os betabloqueadores são indicados não só no tratamento da doença coronariana (reduzindo a demanda miocárdica de oxigênio) como também em todos os pacientes com disfunção cardíaca sistólica assintomática e sintomática (insuficiência cardíaca), agindo, neste caso, através da inibição ao remodelamento cardíaco, o que reduz a progressão da disfunção e aumenta a sobrevida desses pacientes. Os betabloqueadores mais estudados neste contexto (insuficiência cardíaca) são o carvedilol, o metoprolol e o bisoprolol. B ERRADA vários anti-hipertensivos estão associados ao desenvolvimento de disfunção erétil, entretanto, merecem destaque as seguintes medicações diuréticos tiazídicos, espironolactona, clonidina e metildopa. Entre estas medicações, os tiazídicos são os principais, conforme resultado do estudo Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) , que demonstrou uma incidência de disfunção erétil de 17,1% nos pacientes tratados com estes diuréticos. Os betabloqueadores já foram muito incriminados no passado como causa de disfunção erétil, entretanto, estudos recentes não confirmaram um aumento importante de disfunção sexual com estas medicações. C ERRADA a estenose bilateral de artérias renais (ou unilateral em rim único) é contraindicação clássica ao uso de IECA - a droga pode causar insuficiência renal aguda nesses pacientes. D ERRADA os antagonistas de canais de cálcio não-diidropiridínicos, como diltiazem e verapamil, além dos betabloqueadores, devem ser evitados em pacientes com BAV de segundo e terceiro graus, pois, ao inibirem a condução elétrica pelo NAV, podem agravar o bloqueio. Resposta Letra A.

27697.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Em todos os estágios da insuficiência cardíaca com FE reduzida estão indicadas as principais drogas modificadoras de doença, isto é, drogas que reduzem o remodelamento cardíaco por inibirem os efeitos da hiperativação neuro-hormonal decorrente da disfunção sistólica. Já foi mais do que demonstrado que esse tratamento melhorou e muito a sobrevida dos cardiopatas graves. As principais drogas são (1) betabloqueadores (como o carvedilol, que na verdade é um bloqueador misto , alfa e beta-adrenérgico, o metoprolol e o bisoprolol) e (2) inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona (particularmente os IECA, como o captopril, que foram os mais estudados até o momento). O uso de antagonistas diretos de aldosterona (ex. espironolactona) só encontra respaldo científico para o paciente com IC avançada, classes III e IV de NYHA. Os digitálicos, como a digoxina, não demonstraram em nenhum estudo redução da mortalidade, devendo ser utilizados com objetivo de melhora sintomática em pacientes que não compensam com uso de IECA, betabloqueador e diurético. Outra indicação da digoxina no tratamento da IC é nos casos de fibrilação atrial de alta resposta ventricular que não são controlados pelos betabloqueadores. Como o paciente desta questão apresenta uma IC classe II (dispneia aos grandes moderados esforços), o tratamento inicial deve ser feito com IECA Betabloqueador. Resposta Letra C.

27699.

Comentário: O formato em diamante ou crescendo-decrescendo reflete o próprio processo de contração ventricular contra um ofício estenosado. Num primeiro momento, o sangue progressivamente ganha velocidade (aumentando seu turbilhonamento, e, portanto, a intensidade do sopro), para depois reduzi-la na mesma medida (fase descendente do fenômeno auscultatório). Questão sem dificuldades Resposta certa letra B.

27701.

Comentário: Questão mal formulada... Qualquer medicamento anti-hipertensivos de primeira-linha (IECA, BRA, diuréticos tiazídicos, betabloqueadores ou antagonistas do canal de cálcio) podem ser utilizado para o controle da pressão arterial em monoterapia inicial, especialmente para pacientes com hipertensão arterial em estágio 1. Especificamente com relação ao tratamento da hipertensão

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

em pacientes diabéticos, várias medicações já demonstraram ser efetivas e com impacto na mortalidade os IECA e os BRA, que podem retardar a nefropatia diabética os diuréticos tiazídicos (estudo ALLHAT demonstrou redução de Insuficiência cardíaca em pacientes tratados com clortalidona) betabloqueadores (o UKPDS demonstrou que o atenolol é tão efetivo como o captopril para controle da PA e complicações microvasculares) e os antagonistas do canal de cálcio (estudo ACCOMPLISH demonstrou proteção cardiovascular com uso da anlodipina associada ao IECA). O gabarito oficial da questão foi a letra D, apesar de acharmos que a questão deveria ter sido anulada por conter mais de uma resposta.

25389.

Comentário: Por incrível que pareça, a banca manteve como gabarito oficial a letra E , mesmo após a interposição de recursos bem embasados pela equipe acadêmica do MEDGRUPO... É claro que as alterações descritas na questão são clássicas da estenose mitral (EM), e não da estenose pulmonar (EP) Nas fases iniciais da EM a primeira bulha cardíaca estará acentuada, enquanto ainda existir algum grau de flexibilidade nos folhetos valvares (atribui-se este fenômeno ao rápido aumento de pressão no ventrículo esquerdo durante a sístole ventricular, que faz com que os folhetos mitrais adquiram grande velocidade de fechamento, sendo o choque entre eles o responsável pelo som exacerbado). Quando os folhetos já se encontram muito espessos e calcificados, o som de B1 tende a ser progressivamente atenuado, até desaparecer (imobilidade dos folhetos)... Por outro lado, devido ao surgimento de hipertensão arterial pulmonar (consequente à hipertensão venocapilar pulmonar), espera-se que o portador de EM evolua também com aumento do componente P2 da segunda bulha Logo, a melhor resposta aqui seria a letra C... Aprenda mais ... A estenose pulmonar é uma lesão cardíaca incomum, na maioria das vezes de origem congênita. As principais entidades envolvidas são Tetralogia de Fallot, Síndrome da Rubéola Congênita, Síndrome de Noonan, Estenose Pulmonar Isolada e a Síndrome Carcinóide (forma adquirida). O exame físico costuma apresentar alterações sutis, sendo raramente proeminentes dentro do quadro síndrômico que o paciente típico possui... Dentre os achados clássicos, citamos (1) proeminência da onda a no pulso venoso jugular, (2) impulso sistólico de VD

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

no precórdio, (3) sopro sistólico ejetivo na borda esternal esquerda alta (foco pulmonar), (4) click sistólico no foco pulmonar, (5) desdobramento de B2, (6) presença de B4 de VD...

27710.

Comentário: A cardiopatia congênita mais comum na síndrome de Down é o defeito do septo atrioventricular total, uma condição na qual existem defeitos de fechamento nos septos interatrial e interventricular, com shunt esquerda-direita... Na história natural dessa lesão observa-se o desenvolvimento de ICC biventricular, geralmente acompanhada de insuficiência mitral importante (onde se destaca um sopro holossistólico audível no ápice cardíaco) e insuficiência tricúspide (ambos por dilatação dos anéis valvares). Quando surge hipertensão pulmonar (síndrome de Eisenmenger), a falência do VD se torna proeminente, justificando a impulsão precordial de VD palpável e visível na região paraesternal (aumento da atividade precordial). Resposta certa letra B.

27750.

Comentário: Uma PA acima do percentil 95 para idade e sexo, aferida em 3 ocasiões diferentes e com a técnica adequada é diagnóstica de hipertensão arterial. Neste caso, a PA do percentil 95 equivale a no máximo 129 x 89 mmHg. Portanto, neste sentido, não há dúvidas quanto ao diagnóstico de HAS... As causas de hipertensão arterial em crianças adolescentes também são divididas em (1) Essencial e (2) Secundárias... A hipertensão essencial só é a causa mais comum de hipertensão em crianças mais velhas (adolescentes), sendo um diagnóstico de exclusão (é preciso afastar as causas de hipertensão secundária antes de fechar o diagnóstico)... No geral, as causas secundárias são responsáveis pela maior parte dos casos de hipertensão em crianças... São várias as causas, sendo as mais comuns a doença parenquimatosa renal, a doença renovascular (displasia fibromuscular) e a hipertensão de origem endócrina (feocromocitoma, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primário, etc). Entre as causas parenquimatosas renais, vale destacar as glomerulonefrites, a cicatriz renal (sequela de Pielonefrite), a doença renal policística e a doença renal crônica de qualquer etiologia. Resposta Letra E.

25360.

Comentário: O angioedema ocorre em até 0,7% dos pacientes tratados com IECA, sendo esta a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

causa mais frequente de angioedema isolado em pacientes que procuram um atendimento de emergência. O angioedema relacionado aos IECA envolve tipicamente a língua, os lábios, a faringe, a laringe, a boca e tecidos subglóticos. Metade dos casos ocorre até 1 semana após o início do tratamento (como a paciente em questão), enquanto o restante dos casos pode ocorrer até anos após o início da droga... O desenvolvimento de angioedema com IECA é uma contraindicação formal ao uso de qualquer IECA Resposta Letra C.

13399.

Comentário: Essa questão é muito fácil Paciente alcoólatra, com disfunção sistólica de VE, coronariografia normal e sem história de hipertensão arterial provavelmente é portador de cardiopatia alcoólica, e nesta situação é imprescindível que o mesmo pare de beber

7276.

Comentário: Diuréticos e digitálicos são úteis apenas para o alívio sintomático da insuficiência cardíaca, sem alterar a mortalidade a longo prazo. Nos pacientes com disfunção sistólica do VE, mesmo se assintomáticos (classe I da NYHA), estão indicados os inibidores da ECA (ou antagonistas do receptor de ATII nos pacientes que não toleram IECA) e os betabloqueadores, drogas essas que devem ser feitas na maior dose possível O motivo desta recomendação é bem simples hoje em dia sabemos que a disfunção sistólica, mesmo se leve, se acompanha de ativação de mecanismos neuro-humorais de compensação cardíaca (catecolaminas e sistema renina-angiotensina-aldosterona). Tais mecanismos resultam em piora progressiva de disfunção sistólica a longo prazo, pois seus mediadores acabam exercendo efeitos tóxico-degenerativos sobre as células miocárdicas (o chamado remodelamento cardíaco). Resposta certa letra A.

13438.

Comentário: Ora... Se a pressão do paciente está controlada com o uso dessas medicações, o desejável é mantê-las do jeito como estão Só suspenderíamos uma delas se houvesse indicação formal de fazê-lo no pré-op, mas nem os BB ou os ACC precisam ser suspensos antes de uma cirurgia... Os betabloqueadores ainda têm um benefício adicional no perioperatório que é a redução da mortalidade cirúrgica em coronariopatas adequadamente betabloqueados (evita-se a taquicardia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

que tão frequentemente aparece nesse período e pode induzir isquemia miocárdica no paciente predisposto). Os anti-hipertensivos que devem ser suspensos no pré-op são os diuréticos, pois a manutenção de seu uso pode piorar a hipovolemia que comumente aparece no pós-op. Resposta certa letra C.

9125.

Comentário: Diante de um paciente com microalbuminúria (excreção diária de albumina na urina entre 30-300 mg) devemos fazer de tudo para que a lesão renal se estabilize e não progrida Sabemos que a microalbuminúria representa o início de uma lesão renal progressiva (nefropatia diabética ou hipertensiva), mas a boa notícia é que nesta fase precoce podemos intervir de maneira muito favorável. Além do controle rigoroso de todos os fatores de risco, devemos introduzir drogas que atuem sobre a hemodinâmica glomerular, reduzindo a hipertensão do tufo capilar e, consequentemente, eliminando o principal fator lesivo dessa estrutura. As drogas que fazem isso são (1) inibidores da ECA e (2) antagonistas do receptor de angiotensina. Elas promovem relaxamente da arteríola eferente, e reduzem a hipertensão intraglomerular e a hiperfiltração. Resposta certa letra A.

9049.

Comentário: Opção A correta. A síndrome de Marfan é uma doença de herança autossômica dominante, com ampla variação de expressão e alguns casos esporádicos. Acontece por mutação no gen da fibrilina (FBN1) localizado no cromossoma 15q15-21.3. A fibrilina é uma glicoproteína componente das microfibrilas extracelulares, que estão presentes nas fibras elásticas da epiderme, derme e zônulas oculares. As principais manifestações clínicas são 1) Crescimento alta estatura, membros longos, escassez de tecido subcutâneo e hipotonia muscular 2) Esqueléticas pectus excavatum, pectus carinatum, diminuição da relação entre segmento superior e inferior, escoliose 20º, redução da extensão de cotovelo (170º) e pés planos 3) Ocular subluxação de cristalino, miopia e deslocamento de retina 4) Cardiovascular dilatação da aorta ascendente com ou sem regurgitação aórtica, dissecção da aorta ascendente, prolapso da valva mitral, dilatação da artéria pulmonar. Opção B incorreta. A acondroplasia é uma causa de baixa estatura grave

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

desproporcional, ou seja, com a relação SS SI elevada geralmente por encurtamento grave dos membros. Opção C incorreta. A tetralogia de Fallot é uma cardiopatia grave cianótica, e que não cursa com alta estatura. Opção D incorreta. A síndrome de Klinefelter é a causa mais frequente de hipogonadismo no sexo masculino, afetando 1 entre cada 500-1000 homens. O cariótipo mais comum é o 46 XXY, mas podem ocorrer 48 XXXY e mosaicos 46 XY, 47 XXY. Quanto maior o número de cromossomas X, mais grave serão as alterações fenotípicas gonadais e extragonadais. O genótipo 46, XXY resulta da não disjunção dos cromossomas sexuais de um dos pais durante a meiose, enquanto o mosaicismo decorre da não disjunção cromossômica após a concepção, durante as divisões mitóticas. Há uma disgenesia de túbulos seminíferos e por isso, a espermatogênese está ausente. As células de Leydig, produtoras de testosterona, produzem o hormônio em quantidades subnormais. Clinicamente há hábito eunucoide (relação segmento superior inferior 1) por aumento desproporcional do comprimento dos membros inferiores, ginecomastia, micropênis, testículos pequenos e endurecidos. Há uma maior predisposição de doenças pulmonares crônicas (bronquites, enfisema), cânceres (tumores de mediastino, tumores de mama, linfoma não Hodgkin) e diabetes mellitus, em taxas maiores que na população em geral.

9081.

Comentário: Questão simples. Não vamos recomendar exercício físico para ninguém com angina instável, HAS não controlada ou bloqueio de alto grau. Assim, a alternativa que nos resta é a letra A mesmo que o paciente seja completamente surdo não existe nenhuma contra-indicação à prática regular de atividade física

9085.

Comentário: Essa questão bem que tentou nos pegar desprevenidos, mas como você aprendeu desde cedo que a CLÍNICA É SOBERANA, não foi difícil marcar a resposta certa (opção A) Repare como estamos diante de um quadro clássico de ICC dispnéia aos esforços, dispneia paroxística noturna, edema de MMII... O fato é que os critérios de Boston estão em desuso já faz um tempinho Contudo, vamos aproveitar a questão para conhecê-los... Trata-se de uma soma de pontos. O diagnóstico é DEFINIDO com escore de 8 a 12 pontos, PROVÁVEL com 5 a 7 pontos, e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

IMPROVÁVEL quando 4 pontos. Categoria I história nº de pontos Dispnéia de repouso---------- 4 Ortopnéia---------- 4 Dispnéia paroxística noturna---------- 3 Dispnéia ao andar no plano---------- 2 Dispnéia ao subir escada---------- 1 Categoria II exame físico Taquicardia 91-110bpm---------- 1 110bpm---------- 2 Elevação da pressão venosa---------- 2 Elevação da pressão venosa edema de MMII--- 3 Creptação pulmonar Base---------- 1 Acima das bases----------2 3ª bulha---------- 3 sibilos---------- 3 Categoria III raio X de tórax Edema alveolar---------- 4 Edema intersticial---------- 3 Derrame pleural bilateral---------- 3 Somatória para cada categoria admite-se no máximo 4 pontos. História paciente leva pontuação máxima (4) DPN e dispnéia ao andar no plano. Exame 1 ponto (FC) RX 3 pontos (edema intersticial) Total 8 pontos diagnóstico de IC. Logo, resposta certa letra A

9088.

Comentário: A opção claramente incorreta é a letra D, que na verdade é absurda e não merece maiores comentários O ECG é um exame simples, barato e amplamente disponível, que deve ser solicitado para TODOS os pacientes cardiopatas Apesar das características que acabamos de citar, não raro fornece informações extremamente úteis, ainda mais na investigação etiológica da insuficiência cardíaca (ex BRD HBAE sugere cardiopatia chagásica, amputação de onda R onda Q patológica sugerem infarto prévio do miocárdio, etc)... A radiografia de tórax não é um exame obrigatório para a confirmação diagnóstica de ICC, porém geralmente é solicitada (inclusive o encontro de cardiomegalia índice cardiotorácico 0,5 é um critério Major de Framingham). Quando o paciente se apresenta francamente descompensado a radiografia de tórax assume uma importância ainda mais especial permite o diagnóstico diferencial com patologias pulmonares, por exemplo identifica uma pneumonia... A hiponatremia é frequente na ICC, e tem significado prognóstico. Veja bem quanto menor a fração de ejeção, mais intensa é a resposta neuro-humoral

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

compensatória (secreção de ADH, hiperatividade adrenérgica e ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona). Ora, quanto maior a secreção de ADH (por ativação dos barorreceptores no arco aórtico e no bulbo carotídeo) maior a incapacidade renal de excretar água livre, isto é, maior a retenção de água e mais intensa a hiponatremia...

6957.

Comentário: Molezinha A terceira bulha cardíaca (B3) é produzida pela vibração do sangue nas paredes do ventrículo esquerdo disfuncionante quando da fase de enchimento rápido dessa cavidade (fase protodiastólica). É um som de baixa freqüência (grave) melhor audível com a campânula do estetoscópio quando o paciente assume o decúbito lateral esquerdo (e o ictus cordis se aproxima mais da parede torácica). Resposta certa letra D.

6962.

Comentário: O nitroprussiato de sódio (Nipride) é um nitrato com potente efeito vasodilatador direto, tanto arterial quanto venoso. É o anti-hipertensivo parenteral mais utilizado em nosso meio para tratar as emergências hipertensivas, pois além de ser bastante eficaz possui meia-vida extremamente curta (1-2 minutos), o que permite a rápida titulação de suas doses e o controle quase que imediato da pressão arterial É feito em infusão contínua na dose de 0,25-10 micrograma kg min, lembrando que o equipo do soro deve ser protegido contra a luz (fotossensível). Deve ser evitado na isquemia miocárdica (induz roubo coronariano e aumenta a área de isquemia) e na eclâmpsia antes do parto (intoxica o bebê), a não ser que a HAS seja refratária a todas as outras drogas disponíveis É metabolizado em CIANETO pela hemácias, sendo este posteriormente convertido em TIOCIANATO pelo fígado, o qual, por sua vez, será totalmente eliminado pelos rins... O efeito adverso mais comum é a intoxicação pelo tiocianato, que acontece na terapia prolongada (4 dias de infusão contínua) com altas doses Manifesta-se por agitação psicomotora, confusão mental, fadiga, vômitos e coma. O risco é maior na presença de insuficiência renal Já os pacientes hepatopatas tendem a desenvolver intoxicação pelo cianeto, uma complicação extremamente grave e caracterizada por acidose metabólica, arreflexia, midríase, convulsões, pele rosada e um hálito com odor típico de amêndoas amargas A intoxicação por nitroprussiato é geralmente tratada com a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

suspensão do medicamento, mas pode ser necessário administrar antídotos específicos, especialmente na suspeita de intoxicação pelo CIANETO Os antídotos mais utilizados são o NITRITO DE SÓDIO a 3% (4 a 6 mg IV) seguido pela infusão de 50 mL de uma solução de TIOSSULFATO DE SÓDIO a 25%... O nitrito induz a formação de METEMOGLOBINA, uma hemoglobina com ferro no estado oxidado, o qual, portanto, é incapaz de se ligar ao oxigênio. Este ferro oxidado, por outro lado, tem afinidade pelo cianeto, e funciona como um quelante dessa substância O tiossulfato converte diretamente o cianeto em tiocianato, um composto com menor toxicidade que pode ser excretado pelos rins Se for necessário podemos lançar mão da hemodiálise, já que tal procedimento remove o tiocianato da circulação (mantendo seus níveis abaixo do limiar tóxico, que gira em torno de 10-12 mg dL). Resposta certa letra C.

13443.

Comentário: Olha só a maldade que fizeram com os candidatos desse concurso essa questão quase esteve à frente de seu tempo (a prova foi no final de 2008) Segundo dados divulgados em novembro de 2008 pelo ministério da saúde, o principal fator de risco associado à mortalidade cardiovascular no Brasil seria o sedentarismo, levando a 32% dos óbitos por IAM e AVE em ambos os sexos Só quem conseguiu ler artigos recém-publicados na véspera da prova é que pôde acertar essa questão, ou seja, não deve ter sido muita gente

17809.

Comentário: Vamos resumir o enunciado Paciente com quadro de dor torácica aos médios esforços e teste ergométrico sugestivo de isquemia miocárdica vai ser submetido à coronariografia em 2 dias. Quais as precauções que devemos ter com esse paciente Em primeiro lugar devemos orientar quanto aos riscos e beneficíios do procedimento e explicar como é realizado o exames. Solicita-se um jejum de 6 horas para o paciente. Além disso, o paciente deve suspender duas medicações, caso faça uso metformina e anticoagulantes. Como o exame pode levar à uma nefropatia por contraste com piora da função renal, pode-se desenvolver uma acidose lática devido ao uso da metformina. Os anticoagulantes são suspensos pelo risco de sangramento. Portanto, o nosso gabarito é a letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

17817.

Comentário: Questão simples segundo o último consenso americano de hipertensão arterial publicado em 2003 (sétimo joint), o alvo pressórico de pacientes com diabetes e ou insuficiência renal crônica deverá ser menor do que 130x80mmHg, sendo que a maioria destes pacientes necessitará de no mínimo 2 anti-hipertensivos para atingir estes níveis. Na ausência de indicações específicas, como doença coronariana, insuficiência cardíaca, nefropatia ou doença cerebrovascular, a associação deverá preferencialmente conter um diurético tiazídico, com a segunda droga podendo ser um inibidor da ECA, inibidor AT1, bloqueador de canais de cálcio ou betabloqueador. Como o paciente é diabético, um inibidor da ECA ou do receptor AT1 são opções atraentes mesmo na ausência de nefropatia (proteinúria), pois estes agentes não influenciam o perfil lipídico ou glicídico.

15958.

Comentário: Vamos analisar cada uma das alternativas letra A errada, pois a dispneia é um sintoma importante no quadro de estenose mitral já que a sua presença indica a presença de congestão pulmonar (veja o texto da sua apostila e repare o que escrevemos é um sintoma cardinal). A letra B também está errada em caso de grandes aumentos atriais na estenose mitral, pode haver compressão do nervo laríngeo recorrente levando à rouquidão e compressão esofágica levando à disfagia. A causa mais comum de estenose mitral é a cardiopatia reumática crônica, e não lúpus e atrite reumatoide, por isso a alternativa C também é incorreta. A letra E está errada, já que a anticoagulação está indicada em fibrilação atrial recorrente, persistente ou permanente. Sobrou a alternativa D, que está correta o ecocardiograma é essencial porque não só mostra a disfunção da válvula como também indica o Escore de Block (fundamental para terapia) e confirma a etiologia reumática quando encontra o folheto posterior da valva mitral imóvel e espessado.

365645.

Comentário: De forma resumida, o enunciado descreve um paciente com infarto agudo do miocárdio extenso, evoluindo com choque cardiogênico e disfunção renal aguda. Ou seja, estamos diante de uma síndrome cardiorrenal A grande verdade é que o rim e o coração, embora não sejam

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

próximos anatomicamente, estão muito ligados em termos fisiopatológicos. Desta maneira, a disfunção (aguda ou crônica) de um destes órgãos pode acabar afetando o outro. Daí surgiu o conceito de síndrome cardiorrenal, que pode ser classificada da seguinte forma Tipo 1 (aguda) insuficiência cardíaca (IC) aguda resulta em lesão renal aguda Tipo 2 disfunção cardíaca crônica gerando doença renal crônica (DRC) progressiva Tipo 3 piora abrupta e primária da função renal (ex a isquemia renal ou glomerulonefrite) causando disfunção cardíaca aguda Tipo 4 DRC primária contribuindo para disfunção cardíaca (doença coronariana, IC ou arritmia) Tipo 5 (secundário) distúrbios sistêmicos ou crônicos (ex sepse, DM) que podem causar disfunção renal e cardíaca. No caso da questão, temos uma disfunção cardíaca aguda gerando lesão renal aguda, o que é compatível com uma síndrome cardiorrenal tipo 1. É estranho um quadro desses em uma criança de 7 anos, né Mas isso não muda o raciocínio da questão Resposta letra A.

349717.

Comentário: A questão nos traz paciente de 62 anos, hipertenso bem controlado e tabagista, em consulta de rotina, com dois problemas clínicos a serem analisados (1) Hipercalemia (potássio 5,5 mEq L) observem que o aumento do potássio é muito leve 5,6 mEq L e o paciente não apresenta qualquer sintoma relacionado a esse distúrbio eletrolítico. A provável etiologia é o uso da losartana, um anti-hipertensivo da classe do bloqueador do receptor da angiotensina II (BRA) que possui como efeito adverso a retenção de potássio. Nos causaria preocupação maior se o paciente tivesse sintomas (ex. fraqueza muscular cãimbras) ou se os valores de potássio estivessem 6,5 mEq L. (2) Sangue oculto nas fezes positivo esse é um exame utilizado para rastreamento de câncer colorretal. Sua positividade deve nos fazer solicitar uma colonoscopia para confirmar o achado da neoplasia colorretal. Sendo assim, qual é a melhor conduta Letras A e B incorretas. A hipercalemia do paciente é muito leve e assintomática. Não é necessário nenhuma conduta terapêutica específica para controle do potássio nesse caso, como prescrição de diurético de alça. A própria suspensão do agente causador , a losartana, irá normalizar o aumento do potássio Para não descontrolar a pressão do paciente, deveremos trocar a losartana por outro anti-hipertensivo de primeira linha que não seja associado à hipercalemia como efeito adverso, como por exemplo um

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tiazídico. Letra C incorreta. O atenolol (betabloqueador) não é um anti-hipertensivo de primeira linha, portanto, não é a conduta mais adequada no contexto da subtistuição do BRA. Letra D correta. Justamente o que discutimos acima Devido à hipercalemia, a losartana deve ser trocada por outro anti-hipertensivo que não seja um BRA ou IECA. O paciente já faz uso de anlodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio. Sobrou o tiazídico, como a hidroclorotiazida ou indapamida (que é um t iazídico-like). Além disso, ele deve ser referenciado para detecção de um possível câncer colorretal, através da colonoscopia. Letra E incorreta. Basta uma amostra positiva de sangue oculto fecal para considerar o teste positivo, portanto, não é necessário repetir o exame. O próximo passo é a colonoscopia. Resposta letra D.

322147.

Comentário: De acordo com a AHA, a insuficiência cardíaca pode ser dividia basicamente em quatro estágios. Estágio A (risco para IC) - Existe risco para IC, mas sem sintomas, doença cardíaca estrutural ou biomarcadores cardía cos de estira mento ou lesão (ex. pacientes com hipertensão, doença cardiovascular ateros clerótica, diabetes, sín drome metabólica e obesidade, exposição a agentes cardiotóxicos, variante genética para cardiomiopatia ou história familiar positiva de cardiomiopatia). Estágio B (pré-IC) - Sem sintomas ou sinais de IC e evidência de pelo menos um dos seguintes diagnósticos (1) doença cardíaca estrutural (função sistólica reduzida, hipertrofia ventricular, aumento de câmaras cardíacas, anormalidades na contratilidade, doença valvar) (2) evidência de aumento das pressões de enchimento (seja por medidas hemodinâmicas invasivas ou por exames de imagem não invasivos) ou (3) pacientes com fatores de risco e níveis elevados de BNPs ou troponina cardíaca persistentemente elevada. Estágio C (IC sintomática) - Doença cardíaca estru tural com sintomas atuais ou anteriores de IC. Estágio D (IC avançada) - Sintomas acentuados de IC que interferem na vida diária e com hospitalizações recorrentes apesar das tentativas de terapia medicamentosa otimizada. Dito isso, vamos analisar os casos descritos nas alternativas. Letra A incorreta. Ainda que esteja assintomático, por apresentar disfunção sistólica, esse paciente deveria ser classificado como estágio B. Letra B incorreta. Pela descrição, temos apenas fatores de risco para IC, ou seja, seria um estágio A. Letra C correta Trata-se de uma

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

paciente com IC grave, sintomática e refratária ao tratamento clínico otimizado. Letra D incorreta. A descrição da alternativa é compatível com o estágio B. Letra E incorreta. A sintomatologia da IC (estágios C e D) pode ser semiquantificada através da classe funcional da New York Heart Association (NYHA). Nesse caso, NYHA III corresponde à dispneia aos pequenos esforços, enquanto NYHA IV seria dispneia aos mínimos esforços. Perceba, portanto, que o grande problema desta alternativa é que ela não traz a classificação pela AHA, e sim a classificação de NYHA. Resposta letra C.

322148.

Comentário: Questão difícil O primeiro ponto importante é lembrar que a principal etiologia da estenose mitral, no Brasil, é a sequela de febre reumática. Nas fases iniciais da doença, a valva mitral não está calcificada e, portanto, o seu tecido ainda possui elasticidade suficiente para produzir hiperfonese de B1 e estalido de abertura. À medida que a EM progride e a pressão atrial esquerda aumenta, o estalido de abertura ocorre cada vez mais cedo, justificando a letra A como gabarito. Nos casos em que a doença avança a ponto da valva ficar calcificada e perder sua mobilidade, o estalido de abertura pode até desaparecer. E as outras opções - Letra B incorreta. Se a etiologia for reumática, o mais comum é o paciente apresentar hiperfonese de B1 nas fases mais precoces da doença e, com passar dos anos, pela calcificação valvar, evoluir para normofonese. Pode haver hipofonese de B1 Até pode, mas não é algo tão comum. - Letra C Polêmica Muito cuidado aqui Esse paciente NÃO apresenta insuficiência de VE, mas pode evoluir com sinais de insuficiência cardíaca esquerda. Entenda como a dificuldade do sangue é sair do átrio esquerdo em direção ao ventrículo esquerdo, esta última câmara não sofre repercussão deste tipo de lesão valvar funciona como se o VE não enxergasse a lesão estenótica mitral. Assim, as consequências clínicas serão percebidas no átrio esquerdo (aumento de tamanho) e na circulação pulmonar de maneira retrógrada. Portanto, o paciente pode ter SINAIS de IC esquerda (relacionados com a congestão pulmonar), sem ter acometimento do VE. Provavelmente, o objetivo da banca era escrever que não há insuficiência VENTRICULAR esquerda, mas acabou se confundindo e abrindo margem para dupla interpretação. - Letra D incorreta. Como vimos, existem diversas alterações no

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

exame físico do nosso paciente. - Letra E incorreta. Não há hipofonese de B2 Na verdade, muitos casos crônicos evoluem com insuficiência pulmonar e hipertensão arterial pulmonar, apresentando hiperfonese de P2, P2 A2 e sopro sistólico. Portanto, apesar do gabarito inicial ter sido a letra A, entendemos que essa questão deveria ser ANULADA por apresentar duas respostas possíveis.

322163.

Comentário: Vamos para as alternativas Letra A INCORRETA - A dose plena (máxima) do carvedilol é de 25 mg 2x dia, sendo permitido o uso de 50 mg 2x dia em indivíduos 85 kg. Letra B INCORRETA - Betabloqueadores não são mais considerados anti-hipertensivos de primeira linha por não produzirem reduções significativas da morbimortalidade cardiovascular na população hipertensa em geral. Podem entrar, no entanto, para pacientes com algum ganho secundário com a droga, como é o caso de pacientes com ICFER, doença coronariana ou taquiarritmias. Letra C CORRETA - De fato, dentre as contraindicações ao uso do carvedilol, estão os bloqueios atrioventriculares avançados (de segundo e terceiro grau). Isso pela capacidade da droga em inibir o nódulo AV. Letra D INCORRETA - Na verdade, não se deve iniciar o uso de um betabloqueador em pacientes com IC francamente descompensada. Isso é ainda mais verdadeiro para o perfil frio e úmido , que encontra-se congesto e hipoperfundido. Os betabloqueadores reduzem o cronotropismo e o inotropismo, podendo assim reduzir ainda mais o débito cardíaco do paciente e, consequentemente, agravar o quadro de congestão e hipoperfusão. Para os pacientes que já faziam uso prévio do BB, a sua manutenção pode ser considerada somente caso não haja hipotensão arterial sintomática ou evidências de baixo débito. Letra E INCORRETA - A associação de dois betabloqueadores não está indicada, sob o risco de aumento dos efeitos adversos. Para portadores de fibrilação atrial, pode-se considerar a associação de algum outro inibidor do nódulo AV de outra classe (digoxina, por exemplo , para um adequado controle de FC, caso necessário. Resposta letra C.

322207.

Comentário: Temos aqui uma paciente com queixa de edema de membros inferiores No entanto, atenção máxima agora, note que a queixa começou após ela fazer iniciar um medicamento para a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pressão arterial Qual remédio é esse Com certeza um bloqueador de canal de cálcio (exemplo anlodipina). Lembre-se que estas são drogas com um bom perfil de segurança e não costumam apresentar efeitos adversos graves quando bem indicadas. O efeito colateral MAIS COMUM é exatamente o edema de membros inferiores. Este edema não costuma melhorar com a associação de diuréticos, mas sim com os IECA. No entanto, na maioria dos casos o edema responde apenas a suspensão da droga, embora a redução da dose também seja uma opção. A redução da ingestão de sal pode ajudar. Resposta letra D.

322211.

Comentário: A SAHOS (síndrome da apneia obstrutiva do sono) é uma condição crônica, de obstrução cíclica das vias aéreas superiores (VAS) ao dormir, associada a sinais ou sintomas de distúrbios do sono, o mais comum sendo sonolência diurna excessiva. A prevalência de SAHOS aumenta com a idade, especialmente em pessoas maiores de 60 anos. É mais frequente entre homens obesos e que apresentam roncos, em geral, em fases de sono profundo. Além da obesidade, aumento das tonsilas, macroglossia, flacidez do palato mole e dos tecidos faríngeos podem contribuir para a apneia. A idade da população e o crescimento dos índices de obesidade contribuem para o aumento das taxas de SAHOS. Distúrbios do sistema nervoso central (SNC) (p. ex., acidente vascular cerebral AVC , tumores, trauma), álcool e sedativos podem agravar quadros de apneia obstrutiva. As manifestações da apneia obstrutiva são cansaço diurno, sonolência, sensação de descanso inadequado, dificuldade de concentração, ronco pesado e crônico, noctúria, cefaleia ao acordar e apneia observada por terceiro. O médico de família e comunidade, conhecendo a síndrome, pode garantir diagnóstico e manejo adequados, com impacto positivo na saúde geral dos seus pacientes. Agora, voltando a questão A APS é fator de risco para quais condições Hipertensão arterial sistêmica (principal), hipertensão pulmonar, arritmias cardíacas, isquemia miocárdica e cerebral e depressão. Resposta letra B.

337594.

Comentário: Segundo o Harrison, a hipertensão arterial é o fator de risco mais importante para eventos cerebrovasculares A incidência desta complicação aumenta progressivamente com a

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

elevação dos níveis pressóricos, particularmente a PA sistólica em pacientes com 65 anos. Por isso, o tratamento da hipertensão é capaz de reduzir tanto AVE isquêmico, quanto hemorrágico. Atualmente, dispomos de quatro classes de medicamentos consideradas de primeira linha para o tratamento da hipertensão arterial diuréticos tiazídicos, inibidores da ECA, antagonistas da angiotensina e antagonistas do cálcio. Resposta letra A.

305289.

Comentário: A partir dos resultados do estudo PARADIGM-HF, recomenda-se a troca de IECA BRA para o sacubitril-valsartana nos pacientes com IC com FE reduzida que persistem sintomáticos mesmo após o emprego de doses otimizadas dos bloqueadores neuro-hormonais. Não existe nenhuma outra indicação para esta medicação. Logo, a resposta é a opção D.

305301.

Comentário: Vamos relembrar os perfis hemodinâmicos na insuficiência cardíaca aguda O perfil A (quente e seco) representa o paciente sem hipervolemia e com boa perfusão tecidual. É o objetivo do nosso tratamento de manutenção, concorda O perfil B (quente e úmido) é o mais comum, caracterizando um paciente congesto que mantém perfusão periférica adequada. É justamente o caso aqui O tratamento deve ser feito com diuréticos (furosemida) e vasodilatadores, como a nitroglicerina ou o nitroprussiato. O perfil C (frio e úmido) caracteriza os pacientes congestos com DC reduzido, vasoconstrição periférica e má perfusão tecidual. Nesses casos, o tratamento deve ser feito usando inotrópicos com ação vasodilatadora, como a dobutamina, a dopamina em baixas doses e a milrinona. Nossa paciente não está nesse perfil, o que significa que tais drogas não estão indicadas. Cabe lembrar ainda que, embora sejam drogas necessárias para alguns pacientes com IC aguda, o impacto na mortalidade com o uso de inotrópicos é questionável. O perfil D ou L (frio e seco) geralmente demanda hidratação venosa cautelosa, com solução cristaloide e, preferencialmente, sob monitorização hemodinâmica. Também não é o caso aqui. Por fim, a letra E traz uma conduta que não deve ser recomendada, lembrando que a intenção do tratamento é reduzir o trabalho cardíaco através da redução da pré-carga e da pós-carga. Resposta letra B.

298950.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Um betabloqueador não deve ser a próxima droga a ser acrescida ao esquema Além de não ser de primeira linha, o fato de o paciente ter DPOC (e usar uma droga beta-2 agonista para alívio dos sintomas) faz com que essa classe farmacológica não seja muito adequada, já que pode piorar os sintomas respiratórios por promover broncoespasmo. As medicações beta-1 seletivas, como o atenolol, até podem ser consideradas, já que os receptores beta das vias aéreas são, majoritariamente, do tipo beta-2. Porém, as drogas não seletivas, como o propranolol devem ser evitadas. Nesse caso, o próximo fármaco a ser acrescentado ao esquema é um bloqueador de canal de cálcio, classe de primeira linha no manejo anti-hipertensivo. Resposta letra B.

298951.

Comentário: Perceba que, apesar do uso de dois anti-hipertensivos, a paciente mantém níveis tensionais elevados. Bom, a próxima medicação a ser acrescentada ao esquema também deve ser de primeira linha, assim como o tiazídico e o inibidor da ECA. Embora a losartana, um bloqueador do receptor de angiotensina II, também faça parte desse seleto grupo de drogas, lembre-se que não devemos associar esta classe aos IECA os mecanismos de ação são praticamente os mesmos, não havendo grandes benefícios em associá-los, além de aumentarem o risco de eventos adversos quando usados simultaneamente. Diante disso, podemos dizer que o fármaco mais adequado seria um bloqueador de canal de cálcio, como a anlodipina. Resposta letra B.

298952.

Comentário: Realmente, fatores socioeconômicos são listados pela Diretriz Brasileira de HAS como fatores de risco da doença. Dentre esses, podemos destacar menor escolaridade, condições de habitação inadequadas e baixa renda familiar. Para ganharmos bagagem com a questão e aprender mais alguns fatores de risco diferentes da HAS consumo de 6 doses de álcool dia e uso de algumas drogas, como eritropoietina, glicocorticoides, descongestionantes nasais, entre outros. Resposta letra A.

284283.

Comentário: Segundo a Sétima Diretriz Brasileira de HAS, as etapas para aferição de pressão arterial são as seguintes 1. Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

olécrano 2. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço 3. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital 4. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial 5. Estimar o nível da pressão arterial sistólica (PAS) pela palpação do pulso radial (utilizando técnica auscultatória) 6. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva 7. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS obtido pela palpação 8. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo) 9. Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação 10. Determinar a pressão arterial diastólica (PAD) no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff) 11. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa 12. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS PAD zero 13. Realizar pelo menos duas medições, com intervalo em torno de um minuto. Medições adicionais deverão ser realizadas se as duas primeiras forem muito diferentes. Caso julgue adequado, considere a média das medidas 14. Medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço onde foi obtida a maior pressão como referência 15. Informar o valor de PA obtido para o paciente e 16. Anotar os valores exatos sem arredondamentos e o braço em que a PA foi medida. Portanto, a técnica de palpação é indicada pela Sétima Diretriz Brasileira. Só por curiosidade, essa recomendação também é mantida na Oitava Diretriz (2020). Item incorreto.

261216.

Comentário: Assertiva certa. Vamos por partes A febre reumática causa lesões orovalvares agudas e crônicas... A lesão orovalvar crônica mais comum é a estenose mitral (EM). Ora, tal valvopatia gera, à ausculta cardíaca, sopro diastólico no ápice do coração (foco mitral) justamente o achado auscultatório apresentado pelo paciente. Do ponto de vista fisiopatológico, a EM impõe sobrecarga atrial esquerda, que acaba se transmitindo retrogradamente ao leito venocapilar pulmonar e gerando congestão local. Assim, clinicamente, o principal sintoma da EM é a dispneia progressiva...

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Conclusão o paciente apresentado já tem repercussão clínica da EM. Resposta letra A.

284284.

Comentário: De acordo com a Sétima Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (e também a Oitava - de 2020) a hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pacientes idosos, diabéticos, disautonômicos e naqueles em uso de medicação anti-hipertensiva. Assim, particularmente nessas condições, deve-se medir a PA com o paciente de pé, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como a redução da PAS maior ou igual que 20 mmHg ou da PAD maior ou igual que 10 mmHg. Portanto, a afirmativa está correta Resposta letra A.

261217.

Comentário: Assertiva errada. A febre reumática causa lesões orovalvares agudas e crônicas... A lesão orovalvar crônica mais comum é a estenose mitral (EM). Ora, tal valvopatia gera, à ausculta cardíaca, sopro diastólico no ápice do coração (foco mitral), justamente o achado auscultatório apresentado pelo paciente. Para a EM, a troca valvar é uma das propostas terapêuticas. A prótese a ser utilizada pode ser biológica ou metálica com o uso de prótese metálica, a anticoagulação é mandatória, já que a superfície protética é um prato cheio para a formação de trombos. Além disso, a prótese metálica pode traumatizar as hemácias, causando hemólise. Resposta letra B.

284285.

Comentário: O conceito é exatamente o inverso A hipertensão do jaleco branco tem uma prevalência global estimada em 13% e configura a situação em que aferições do consultório mostram valores anormais da PA e extra-ambulatoriais (ou seja, no MAPA ou na MRPA), normotensão. Acredita-se que esta forma de hipertensão apresente risco nulo ou minimamente elevado. Apesar de não existirem evidências de benefício da intervenção medicamentosa nesse grupo, tais pessoas devem permanecer em seguimento clínico de perto. A principal situação para a pesquisa de HAS do jaleco branco seria em pacientes jovens ou idosos, do sexo feminino, com relato de medidas normais da PA em casa e hipertensão estágio I no consultório, sem lesão de órgão-alvo. Portanto, a afirmativa está incorreta. Resposta letra B.

284286.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Incorreta A combinação de IECA com BRA ou de um inibidor de renina com IECA ou BRA resultou em maior ocorrência de lesão renal aguda e de hiperpotassemia sem um aumento proporcional dos seus benefícios (inclusive com pouca relevância nos níveis pressóricos em si). Tal fato levou a proscrição dessa estratégia da prática nefrológica. Resposta letra B.

261219.

Comentário: Assertiva certa. A febre reumática causa lesões orovalvares agudas e crônicas... A lesão orovalvar crônica mais comum é a estenose mitral (EM). Ora, tal valvopatia gera, à ausculta cardíaca, sopro diastólico no ápice do coração (foco mitral), justamente o achado auscultatório apresentado pelo paciente. Do ponto de vista fisiopatológico, a EM impõe sobrecarga atrial esquerda, que acaba se transmitindo retrogradamente ao leito venocapilar pulmonar e gerando congestão local. Clinicamente, o grande sintoma da EM é a dispneia progressiva. Resposta letra A.

274364.

Comentário: Já podemos dizer que esse paciente é hipertenso Níveis de PA maiores ou iguais a 180 x 110 mmHg já permitem firmar o diagnóstico mesmo com apenas uma aferição. Trata-se de uma hipertensão estágio 3, o que já indica elevado risco cardiovascular. Nesses casos, é preciso iniciar a terapia medicamentosa e não medicamentosa imediatamente Segundo a Diretriz Brasileira de 2020, deveríamos iniciar o tratamento com duas drogas (indivíduos muito idosos e ou frágeis devem começar com monoterapia, mas não parece ser o caso). Lembre-se que os tiazídicos não devem ser usados no caso, já que há história sugestiva de gota (contraindicação clássica a essa classe farmacológica). A princípio, a metformina só deveria ser iniciada caso o paciente fosse diagnosticado com diabetes, o que ainda não é possível, já que não há qualquer exame laboratorial disponível. Analisando as alternativas, percebemos que a melhor opção realmente é a letra D, embora não indique terapia anti-hipertensiva combinada.

261233.

Comentário: Vamos com calma... Temos um indivíduo coronariopata (angina pectoris coronariografia mostrando falha de enchimento em descendente anterior) e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER clínica ECOTT compatíveis). Sempre que estivermos diante

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de um quadro como esse, é preciso se questionar o seguinte será que essa IC não foi causada ou, pelo menos, agravada pela doença coronariana (lembre-se que esta é uma etiologia clássica de IC) É bem possível que sim, ainda mais se tratando de uma lesão grave A diretriz brasileira de IC recomenda (grau IA) a coronariografia em pacientes com IC e sintomas de angina de peito ou equivalente anginoso. Há outra indicação interessante (grau IIA-C) cineangiocoronariografia em pacientes com IC FEVE menor ou igual a 35%, sem angina, porém de alto risco para DAC . Resumindo não há dúvida que devemos submeter esse paciente ao procedimento. Considerando que ele já foi submetido ao exame e há lesão significativa, passível de correção, devemos realizar a angioplastia. Provavelmente, isso levará a um aumento da fração de ejeção. Em relação à terapia farmacológica A associação sacubutril valsartana só costuma ser indicada quando o paciente se mantém sintomático a despeito de terapia otimizada para a IC. Perceba que não há relato de tratamento no enunciado Dessa forma, quando comparamos angioplastia X sacubutril valsartana, a prioridade nesse momento é, sem dúvida, pela primeira. Resposta (B).

261234.

Comentário: Temos um indivíduo coronariopata (angina pectoris coronariografia mostrando falha de enchimento em descendente anterior) e insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER clínica ECOTT compatíveis). Bom, a onda T plus minus nada mais é do que uma onda T que possui parte de seu traçado positivo e parte negativo. Ela está relacionada à síndrome de Wellens, condição marcada por uma série de achados eletrocardiográficos que se associam à lesão de artéria descendente anterior - justamente o vaso acometido no caso. Veja seus critérios diagnósticos 1) ondas T bifásicas ou profundamente invertidas em V2 e V3 ou, ocasionalmente, nas outras derivações precordiais 2) enzimas cardíacas normais ou minimamente elevadas 3) segmento ST normal ou minimamente elevado (1 mm) 4) sem perda da progressão de ondas R em derivações precordiais 5) ausência de ondas Q patológicas e 6) dor torácica anginosa. Há dois tipos clássicos de Wellens Tipo 1 (20-25% dos casos) caracterizado pelo achado da onda T plus minus nas derivações precordiais V2 e V3. Tipo 2 (75-80% dos casos) caracterizado por uma onda T profunda e simétrica, principalmente em V2 e V3, mas que pode ser encontrada em qualquer

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

derivação precordial. Sendo assim, podemos concluir que esse paciente realmente pode apresentar-se com esse tipo de achado no eletrocardiograma, levando em consideração sua clínica e sua coronariografia. Resposta (A).

274370.

Comentário: Um paciente com hipertensão muito importante, associada à cefaleia, vômitos e confusão mental é o desenho de uma crise hipertensiva com lesão de órgão-alvo, que nesse caso é o cérebro. Que tipo de lesão uma pressão arterial muito elevada pode causar As maiores possibilidades são hemorragia subaracnóidea e encefalopatia hipertensiva, que podem ser diferenciadas através de uma tomografia do crânio. Não há como afirmar que o diagnóstico tem outra causa primária somente com essas informações, portanto não podemos dizer que definitivamente há migrânea ou hipertensão intracraniana (B e C INCORRETAS). A ressonância magnética não é um exame indicado para situações de emergência, pois é demorado e não é útil para diferenciar a hipertensão maligna, que tem como manifestação principal a disfunção renal (E INCORRETA). E quanto ao tratamento É sempre importante frisar que o tratamento das emergências hipertensivas deve ser feito com medicações endovenosas, e não orais. Elas permitem redução gradual da PA, com rápida ação e fácil titulação, evitando lesões decorrentes da redução muito rápida da PA (D INCORRETA). O ritmo de redução, embora possa variar de acordo com a referência, está compatível com o descrito na alternativa A, com redução de 10-15% na primeira hora e 25% no primeiro dia (A CORRETA). Resposta letra A.

261237.

Comentário: A cardiomiopatia dilatada é caracterizada pela dilatação e contração prejudicada de um ou ambos os ventrículos. Os pacientes afetados têm função sistólica prejudicada e podem ou não desenvolver manifestação clínicas. A principal causa da cardiomiopatia dilatada é idiopática (50% dos casos) e outras etiologias incluem miocardite (9%), doenças infiltrativas (5%), cardiomiopatia periparto (5%), hipertensão (4%), HIV (4%), colagenoses (3%) e quimioterápicos (1%). Embora haja controversa na literatura a respeito se a doença coronariana é, de fato, uma causa de cardiomiopatia dilatada (alguns advogam que a classificação seria apenas de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

cardiomiopatia isquêmica), de qualquer forma a isquemia não é considerada a etiologia mais comum de dilatação cardíaca (9% dos casos). Resposta B.

274392.

Comentário: Vamos revisar alguns conceitos sobre a Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH). Sabemos que ela é uma doença primária do miocárdio, geneticamente determinada por mutações nos diversos genes que codificam proteínas contráteis dos sarcômeros, caracterizada por uma inapropriada hipertrofia ventricular concêntrica, geralmente restrita ao VE, associada a uma função sistólica hiperdinâmica. As evidências apontam para uma causa genética, autossômica dominante. Ocorre em aproximadamente 1 a cada 500 indivíduos na população geral. Cerca de 50% dos pacientes têm história familiar positiva, já existindo diversas mutações descritas. Os pacientes sintomáticos geralmente se apresentam com dispneia aos esforços (pela IC com FE preservada) angina pectoris (pela isquemia miocárdica) sinais de baixo débito (síncope pré-síncope), geralmente durante esforço físico (pode ser causada pela estenose subaórtica dinâmica, pela IC diastólica levando à redução do enchimento ventricular e pela ocorrência de arritmias). Ao exame físico, comumente encontramos ictus de VE tópico, porém propulsivo e sustentado. A presença de B4 é comum, podendo se manifestar à palpação do ictus como um movimento pré-sistólico que antecede B1. O desdobramento paradoxal de B2 pode ocorrer devido ao prolongamento da sístole ventricular esquerda em relação à direita (lembre-se de que a hipertrofia predomina à esquerda). A presença de sopro sistólico pode ter dois significados nesses pacientes apenas a hipercontratilidade de VE (aumentando o fluxo intracavitário sistólico) ou a CMH obstrutiva. Em relação ao sopro auscultado na CMH obstrutiva não podemos esquecer, principalmente, de duas condições semiológicas importantíssimas aumenta de intensidade com a manobra de Valsalva em posição ortostática e diminui de intensidade com o handgrip e a posição de cócoras. A CMH é a principal causa de morte súbita em atletas e pode evoluir com arritmias malignas e morte súbita também em pacientes não atletas. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de arritmias malignas com evolução para morte súbita são história pessoal de morte súbita abortada ou arritmia ventricular sustentada história pessoal de síncope de provável origem arritmogênica,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

especialmente com ocorrência nos últimos 6 meses história familiar de morte súbita possivelmente atribuída à CMH espessura do ventrículo esquerdo 30 mm (em qualquer segmento) disfunção sistólica do ventrículo esquerdo (FE 50%) aneurisma apical de VE (independente do tamanho). As alternativas A, B, C e D são conceituais e estão CORRETAS. Para prevenção de morte súbita na CMH, o tratamento que tem se mostrado mais eficaz é o implante de um cardiodesfibrilador implantável (CDI) e não o uso de antiarrítmicos, como sugerido na alternativa E, que está INCORRETA. Além disso, a ablação com álcool é muito questionável para pacientes pediátricos pois ocorre morte do miocárdio. Provocamos, deliberadamente, um IAM na criança sendo, portanto, um tratamento muito discutível.

261305.

Comentário: Assertiva certa. O paciente descrito tem Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), tendo em vista que, conceitualmente, hipertenso é aquele paciente que tem a média das aferições da pressão arterial, em duas ou mais consultas, acima dos valores considerados adequados. O estadiamento atual da HAS, segundo as diretrizes brasileiras, está reproduzido na tabela a seguir (VER IMAGEM). Resposta letra A.

261306.

Comentário: Assertiva errada. O paciente descrito tem Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) no estágio 2 (VER IMAGEM). Assim, sua terapia farmacológica deve ser iniciada imediatamente com dois fármacos em doses baixas. Naturalmente, as medidas não farmacológicas estão indicadas, mas cuidado essas não devem ser exclusivas, como sugerido pela assertiva da banca. Os pacientes candidatos à estratégia proposta pela assertiva, isto é, iniciar apenas medidas não farmacológicas, são os hipertensos estágio 1 com baixo risco cardiovascular. Nosso paciente, perceba, além de hipertenso, é tabagista, coronariopata e diabético tipo 2 seu risco cardiovascular é, definitivamente, alto. Resposta letra B.

261308.

Comentário: Em qualquer paciente com doença coronariana, o controle dos fatores de risco faz parte da abordagem terapêutica. Nesse indivíduo em específico, é preciso controlar os níveis

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tensionais, a glicemia (melhor avaliada através da HbA1C) e a dislipidemia (com estatinas de alta potência, devido à doença aterosclerótica já instalada), além, é claro, da cessação do tabagismo. O AAS também deve ser prescrito, pois se trata de uma droga fundamental no tratamento da doença coronariana. Resposta letra A.

261309.

Comentário: Questão que gerou discussão na época da prova Como sabemos, há quatro classes farmacológicas mais eficazes para o controle da HAS tiazídicos, bloqueadores dos canais de cálcio, IECA e BRA. Os betabloqueadores também são citados em algumas diretrizes, embora pareçam ser menos eficazes, principalmente na redução do risco de eventos neurovasculares (AVE). O grande problema é que os betabloqueadores são drogas fundamentais para pacientes que sofreram IAM. Nesse contexto, eles podem ser encarados como drogas de primeira linha também Perceba o que a banca escreve logo antes da assertiva final do enunciado Considerando esse caso clínico . Ora, esse indivíduo com história de infarto merece um betabloqueador Por causa disso, a Banca mudou o gabarito oficial após solicitação de recursos pelos alunos de ERRADO para CERTO . Uma última observação devemos evitar o uso de betabloqueadores em diabéticos, já que eles podem mascarar sinais e sintomas de uma eventual hipoglicemia, mas, nesses casos, é preciso pesar os riscos x benefícios da terapia. No caso em tela, a tendência é que os benefícios sejam maiores, já que não história alguma de hipoglicemia. Assertiva certa.

255786.

Comentário: Afirmativa ERRADA. Os digitálicos possuem efeito inotrópico leve, reduzem a atividade do barorreceptor do seio carotídeo e são inibidores do sistema simpático. Tais efeitos são capazes de reduzir os níveis de norepinefrina, os níveis plasmáticos de renina e talvez também os de aldosterona, o que seria benéfico no paciente com Insuficiência Cardíaca (IC). O estudo da Digitalis Investigation Group até mostrou redução nas hospitalizações por IC no grupo tratado, mas nenhuma redução na mortalidade nem melhora na qualidade de vida. Doses baixas são suficientes para obtermos um potencial benefício no seu uso, enquanto doses mais altas comprometem a segurança terapêutica. Resumo da ópera em geral, a digoxina fica reservada para o tratamento de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pacientes que seguem muito sintomáticos a despeito de bloqueio neuro-hormonal ideal com controle do volume adequado. É muito mais para controle de sintomas, não por reduzir mortalidade. Gabarito B.

214484.

Comentário: O paciente apresenta febre, rebaixamento do nível de consciência, náuseas, vômitos, cefaleia de forte intensidade e hipertensão. Assim, a hipótese de meningite como entidade etiológica para o quadro é a mais provável, dada a presença de febre. Ainda que não houvesse processo infeccioso, níveis pressóricos que ocasionem alteração do estado mental devem ser compreendidos como encefalopatia hipertensiva, uma emergência hipertensiva que relaciona-se ao acometimento de outros órgãos, podendo haver nefroesclerose maligna, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, entre outros. Questão CERTA.

214520.

Comentário: Olhando o ECG e nos baseando na clínica e epidemiologia do paciente temos que pensar em miocardiopatia chagásica aqui. Ou seja, a insuficiência cardíaca aqui muito provavelmente é secundária a uma doença de Chagas. Mas vamos a análise do ECG mais a fundo. O que salta aos olhos aqui Bloqueio de ramo direito Perceba como há uma padrão rSR em V1 e uma onda S alargada em V6. Hemibloqueio anterior esquerdo Perceba agora que há um padrão rS em paredes inferiores (bem visto em aVF, DII e DIII) e Qr em DI e aVL. Por isso, afirmativa ERRADA. Resposta letra B.

214505.

Comentário: Olhando o ECG e nos baseando na clínica e epidemiologia do paciente temos que pensar em miocardiopatia chagásica aqui. Ou seja, a insuficiência cardíaca aqui muito provavelmente é secundária a uma doença de Chagas. Mas vamos a análise do ECG mais a fundo. O que salta aos olhos aqui Bloqueio de ramo direito Perceba como há uma padrão rSR em V1 e uma onda S alargada em V6. Hemibloqueio anterior esquerdo Perceba agora que há um padrão rS em paredes inferiores (bem visto em aVF, DII e DIII) e Qr em DI e aVL. Por isso, afirmativa ERRADA. Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

214509.

Comentário: Temos uma paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, com eletrocardiograma com padrão de bloqueio do ramo direito e bloqueio divisional ântero superior, sendo esses achados sugestivos de acometimento pela doença de Chagas. No entanto, ainda que haja confirmação do diagnóstico por sorologia, na fase crônica da doença não há indicação de tratamento rotineiro, devendo ser tratada apenas a insuficiência cardíaca. Afirmativa ERRADA.

179174.

Comentário: Vejamos as alternativas A - errada. Monoterapia controla um terço dos casos de hipertensão. B - errada. O alvo em portadores de síndrome metabólica é menor que 130 x 80 mmHg. C - errada. Albuminúria acima de 30mg por dia traz o alvo para abaixo de 130 x 80 mmHg. D - errada. Mais uma vez, alvo menor que 130 x 80 mmHg em hipertensos diabéticos. E - certa. No estágio 2, devemos associar duas drogas para o tratamento da hipertensão. Resposta E.

177611.

Comentário: A prescrição de espironolactona na insuficiência cardíaca em pacientes com classe funcional entre II a IV e fração de ejeção menor ou igual a 35%. Pré-requistos para utilizar a medicação em pacientes com classe funcional II são internação prévia por motivo cardiovascular ou BNP elevado. Assertiva correta. Resposta A.

177615.

Comentário: As drogas que aumentam a sobrevida dos pacientes com insuficiência cardíaca são os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), os bloqueadores do receptor de angiotensina II (usados como alternativa aos IECA), os betabloqueadores (succinato de metoprolol, carvedilol e bisoprolol), a espironolactona (em casos de CF II-IV) e a combinação de hidralazina com nitrato (principalmente em pacientes negros). Reparem que os digitálicos não fazem parte dessa seleta lista De fato, essas medicações podem ser usadas em pacientes com IC, especialmente naqueles que se mantém sintomáticos (refratários à terapia padrão) e para controle da frequência cardíaca quando há fibrilação atrial associada, mas eles não aumentam a sobrevida Portanto, a afirmativa é ERRADA (B).

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

177552.

Comentário: Vamos relembrar a estratégia farmacológica na insuficiência cardíaca Nos pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, sempre devem ser prescritas drogas que aumentam sobrevida IECA (ou BRA) betabloqueador. Quando há limitação leve (NYHA II), podemos acrescentar espironolactona se a fração de ejeção for menor ou igual 35%. O uso de diurético (furosemida) e de digital fica direcionado para pacientes sintomático, isto é, com retenção de volume. Sendo assim, a afirmativa está CERTA (A).

177640.

Comentário: Segundo o Caderno de Atenção Básica Está recomendado o rastreamento da hipertensão arterial nos adultos (acima de 18 anos) sem o conhecimento de que sejam hipertensos. Grau de recomendação A. Intervalo de rastreamento Não se tem evidência para se recomendar um ótimo intervalo para rastrear a hipertensão nos adultos . O 7 JNC (The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure) recomenda o rastreamento a cada dois anos nas pessoas com pressão arterial menor que 120 80 e rastreamento anual se a pressão sistólica estiver entre 120 e 139 mmHg ou a diastólica entre 80 e 90 mmHg. Assim, resposta letra B, pois o Caderno expôs apenas uma recomendação feita por outra fonte. Mas o próprio Caderno diz que não há evidência quanto ao tempo de se repetir o rastreamento, como mostra o trecho sublinhado.

154361.

Comentário: O ruflar diastólico é o sopro característico da estenose mitral, embora possa acontecer em outras condições como a febre reumática aguda (sopro de Carey Coombs), a insuficiência mitral grave (hiperfluxo pela valva mitral) e a insuficiência aórtica grave (sopro de Austin Flint). A confirmação é feita pela hiperfonese de B1 e pelo estalido de abertura, ambos presentes no paciente, e que só acontecem na estenose mitral. O átrio esquerdo aumenta de tamanho progressivamente, devido ao aumento da pressão intracavitária, o que predispõe à ocorrência de fibrilação atrial (ritmo irregular) e à presença de hipertensão pulmonar secundária achados que justificam a hipertrofia ventricular direita e a hiperfonese de P2. Tudo isso justifica o quadro clínico

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

do paciente. Resposta C.

152147.

Comentário: Anasarca e proteinúria nefrótica (3,5 g dia em adultos). Que diagnóstico sindrômico nos vem à mente neste momento Apesar de não ter sido descrita em sua forma completa (que inclui ainda hipoalbuminemia e hipercolesterolemia), não há como não pensar em síndrome nefrótica, condição que tem na proteinúria maciça , ou nefrótica, o elemento chave para o seu diagnóstico. Considerando que este paciente não possui outros sinais e sintomas sugestivos de uma doença sistêmica, a princípio consideraremos que se trata de síndrome nefrótica primária (isto é, uma glomerulopatia idiopática). Em pacientes adultos, a forma mais comum de síndrome nefrótica primária é a GEFS (glomeruloesclerose focal e segmentar). Tendo isso em mente, fica mais fácil interpretar o quadro clínico, pois não podemos esquecer que uma das peculiaridades da GEFS em adultos é que ela PODE CURSAR COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E ATÉ MESMO HEMATÚRIA EM UMA PARCELA DOS DOENTES. Beleza, então a princípio tudo se encaixa na hipótese de GEFSi, que deverá ser confirmada por meio de uma biópsia renal (exame obrigatório na investigação de síndrome nefrótica em pessoas com 8 anos de idade). O problema aqui é que o gabarito da banca foi errado , isto é, eles discordam da afirmativa de que a maioria dos portadores de GEFSi evolui com perda da função renal. Sabemos que, sem tratamento, a GEFSi leva à falência renal em 50% dos pacientes num período de 6-8 anos, em média. Logo, a assertiva está CORRETA.

131810.

Comentário: Vamos analisar as afirmativas sobre os fatores de riscos para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doença de elevada prevalência e morbimortalidade na população mundial. A Incorreta. Existe relação direta e linear da pressão arterial com a idade, sendo a prevalência de HAS superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos. B Incorreta. A prevalência global de HAS entre homens e mulheres é semelhante, embora seja mais elevada nos homens até os 50 anos, invertendo-se a partir da 5ª década. C Incorreta. Ingestão excessiva de sódio tem sido correlacionada com elevação da pressão arterial. Por outro lado, o efeito hipotensor da restrição de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sódio tem sido demonstrado. D Correta. A ingestão de álcool por períodos prolongados de tempo pode aumentar a pressão arterial e a mortalidade cardiovascular em geral. Em populações brasileiras, o consumo excessivo de etanol se associa com a ocorrência de HAS de forma independente das características demográficas. E Incorreta. Atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo em indivíduos pré-hipertensos, bem como a mortalidade e o risco de doença cardiovascular. Portanto, a única assertiva correta e resposta da questão é a letra D.

135122.

Comentário: Essa paciente apresenta um quadro de insuficiência cardíaca descompensada cursando com congestão pulmonar e derrame pleural bilateral. Os derrames pleurais por congestão pulmonar ocorrem principalmente à direita e geralmente não necessitam de tratamento específico, sendo indicado o tratamento para a congestão pulmonar com consequente resolução do derrame indiretamente. O tratamento para congestão pulmonar inclui restrição hídrica, nitroglicerina venosa, suporte com oxigênio, através de macronebulização ou ventilação não invasiva e diuréticos de alça como furosemida, podendo ser associados a tiazídicos em casos de evolução mais crônica. Em alguns casos utiliza-se morfina visando à redução da pré-carga por venodilatação e à redução da sensação desconfortável de dispneia. Gabarito letra B.

135127.

Comentário: A afirmativa está CORRETA. A Dispneia Paroxística Noturna (DPN) é o nome dado à situação na qual o paciente tem seu sono interrompido por uma dramática sensação de falta de ar, levando-o a sentar-se no leito, ou mesmo levantar-se e procurar uma área da casa mais ventilada, visando obter alívio da súbita sensação de sufocação . A dispneia piora ao decúbito e é aliviada com a ortostase. Pode estar presente ainda sudorese profusa. DPN é uma condição comum em pacientes portadores de insuficiência cardíaca esquerda. Nesses casos, admite-se que, durante o sono, a reabsorção do edema periférico leve à hipervolemia sistêmica e pulmonar, com consequente agravamento da congestão pulmonar. As sobrecargas hemodinâmicas, que ocorrem em uma fase particular do sono chamada de fase dos movimentos rápidos dos olhos (REM), podem contribuir para o agravamento da congestão pulmonar e facilitar o surgimento desse tipo de

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dispneia. No sono REM, documenta-se grande estimulação dos nervos simpáticos sobre o sistema cardiovascular.

135132.

Comentário: A afirmativa está ERRADA, pois ela nega a existência de ritmo de galope em 3 tempos na paciente que apresenta B3. A ausculta cardíaca normal é em 2 tempos, pois é composta por 2 bulhas. Chamamos de ritmo de galope quando além das 2 bulhas fisiológicas, existe uma bulha acessória, que pode ser B3, B4 ou ambas. A B3 marca disfunção ventricular, enquanto B4 marca baixa complacência ao enchimento rápido ventricular protagonizado pela contração atrial no final da diástole. É válido lembrar, portanto, que não existe B4 em pacientes portadores de fibrilação atrial. Ambas as bulhas acessórias são ruídos diastólicos, mas a B3 marca hipertrofia excêntrica, um ventrículo dilatado, enquanto a B4 marca hipertrofia concêntrica.

135119.

Comentário: A afirmativa está CORRETA, pois uma saturação de 89% indica hipóxia, ou seja, Pa02 60. A saturação de oxigênio normal é acima de 94%. A paciente do caso relatado apresenta uma insuficiência cardíaca esquerda cursando com dispneia paroxística noturna e ortopneia. A causa da dispneia dela não é pulmonar e sim cardiogênica. Nesse caso, encontraríamos um BNP aumentado, marcador que ajuda a diferenciar entre dispneia pulmonar ou cardiogênica, por congestão.

135078.

Comentário: De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial, para o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica e o início do tratamento são necessárias três aferições com a PA 140 x 90 mmHg. No entanto, o diagnóstico de HAS pode ser feito já na segunda aferição, caso a mesma indique pressão acima de 180 x 110 mmHg. Uma aferição isolada da pressão arterial não indica o início de anti-hipertensivos isoladamente. O diagnóstico de HAS também é feito quando o MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial) apresentar média na vigília 130 x 85 mmHg ou o MRPA (Medida Residencial de Pressão Arterial) apresentar média 130 x 85 mmHg.

135095.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Os diuréticos tiazídicos são drogas de primeira escolha para o tratamento de hipertensão arterial crônica, mas eles podem causar hiponatremia, hipocalemia, hipocalciúria, hipovolemia e hiperuricemia, não hipouricemia. Eles são contraindicados em pacientes com gota ou hiperuricemia. Eles também são indicados para pacientes com hipercalciúria cursando com nefrolitíase. Sendo assim, a afirmativa está ERRADA.

135109.

Comentário: O tamanho da circunferência abdominal não indica o tratamento de doenças cardiovasculares, mas sim demonstra aumento do risco cardiovascular quando é maior que 80 cm em mulheres e 94 cm em homens e indica aumento substancial do risco quando maior que 88 cm em mulheres e 102 cm em homens. Afirmativa ERRADA, gabarito letra B.

108126.

Comentário: A hipertensão arterial sistêmica tem, como órgãos-alvo das suas lesões, os vasos sanguíneos de forma geral, inclusive aqueles presentes no rim e na retina. Ao examinarmos a retina do paciente, através da fundoscopia indireta (pelo fundo de olho), podemos identificar quatro graus de retinopatia hipertensiva I - estreitamento arteriolar II - cruzamento arteriovenoso patológico III - hemorragias ou exsudatos IV - edema de papila. Assertiva correta.

108127.

Comentário: Questões de CERTO ou ERRADO muitas vezes deixam margem a dúvidas, mas não foi o caso desta. A hipertensão arterial sistêmica pode cursar com uma série de lesões orgânicas quando n o controlada. Entre os alvos da doença temos o coração. A hipertrofia do ventrículo esquerdo é a repercussão mais comum da HAS, em decorrência da sobrecarga pressórica ao miocárdio. Esta pode estar presente em até 50% dos hipertensos não tratados em análise por ecocardiografia. A hipotrofia do ventrículo esquerdo n o é achado decorrente da HAS.

105537.

Comentário: O VIII Joint norte-americano atualiza as recomendações para o tratamento da hipertensão arterial com um intervalo de 10 anos em relação ao VII Joint . Ele restabelece alguns alvos para tratamento de HAS. Os pacientes 60 anos sem diabetes mellitus ou doença renal

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

crônica devem ser tratados com valores de PA 150 x 90 mmHg, devendo este ser o novo alvo para este grupo. Nessa população idosa (60 anos), se o tratamento farmacológico resulta em níveis pressóricos menores (por exemplo, PAS 140 mmHg) e é bem tolerado (sem efeitos adversos), a terapia não necessita ser ajustada. Resposta E.

108216.

Comentário: Sabemos que, dentre os medicamentos capazes de AUMENTAR a SOBREVIDA dos portadores de insuficiência cardíaca, destacam-se os inibidores da enzima conversora de angiotensina (caso do captopril), os bloqueadores de receptores de angiotensina II (BRA II), os betabloqueadores, a associação hidralazina-dinitrado e a espironolactona. Os iECA devem ser evitados em pacientes com Cr acima de 3mg dL e a espironolactona está contraindicada em doentes com K 5,0mEq L (pelo risco de hipercalemia, já que inibe as funções da aldosterona). Assertiva errada (resposta B).

88710.

Comentário: O que caracteriza a síndrome de hipertensão acelerada-maligna é o descontrole relativamente rápido dos níveis pressóricos (elevação progressiva ao longo de dias semanas) associado ao surgimento de lesões em órgãos-alvo como rins (nefroesclerose maligna) e retina (retinopatia hipertensiva grau III IV). Assertiva correta.

82113.

Comentário: Errada. Este paciente apresenta-se em franca síndrome de insuficiência cardíaca congestiva, associada à duas lesões orovalvares estenose mitral (sopro diastólico suave em foco mitral, B1 hiperfonética, estalido de abertura) e insuficiência tricúspide (hiperfonese de B2 e sopro sistólico em foco tricúspide, que aumenta de intensidade com a inspiração profunda - manobra de Rivero-Carvalho positiva). Considerando que se trata de paciente jovem, o mais provável é que estejamos diante de uma paciente com sequela de febre reumática (cardiopatia reumática) acometendo a valva mitral e a insuficiência tricúspide seja secundária à sobrecarga do VD por hipertensão arterial pulmonar consequente à EM.

82072.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Correta. Este paciente apresenta-se em franca síndrome de insuficiência cardíaca congestiva (IVE IVD), associada à duas lesões orovalvares estenose mitral (sopro diastólico suave em foco mitral, B1 hiperfonética, estalido de abertura) e insuficiência tricúspede (hiperfonese de B2 e sopro sistólico em foco tricúspede, que aumenta de intensidade com a inspiração profunda - manobra de Rivero-Carvalho positiva). Considerando que se trata de paciente jovem, o mais provável é que estejamos diante de uma paciente com sequela de febre reumática (cardiopatia reumática) acometendo a valva mitral e a insuficiência tricúspide seja secundária à sobrecarga do VD por hipertensão arterial pulmonar consequente à EM.

88705.

Comentário: Observe que este paciente apresenta diversos diagnósticos que corroboram para o diagnóstico de síndrome metabólica hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e dislipidemia. Além disso, o exame de urina evidencia microalbuminúria e o relato de sonolência diurna excessiva e roncos noturnos sugere o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, condição associada à obesidade e que também contribui para o aumento do risco cardiovascular. Embora exista uma alta chance de que se trate de mais um caso de hipertensão primária, a apneia obstrutiva do sono é uma causa cada vez mais reconhecida de hipertensão secundária, sendo necessário o seu diagnóstico através do exame de polissonografia. O diagnóstico é fechado com o encontro de pelo menos 5 episódios de obstrução respiratória - hipopneia ou apneia - superiores a 10 segundos cada, por hora de sono.

88701.

Comentário:

82121.

Comentário: Este é um item importante sobre a semiologia da pressão arterial os cuidados na aferição da PA em idosos. Para recordarmos, existem dois aspectos muito importantes Maior frequência de hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito, geralmente entre o final da fase I e o início da fase II dos sons de Korotkoff. Tal achado pode subestimar a verdadeira pressão sistólica ou superestimar a pressão diastólica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Pseudo-hipertensão, caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado em decorrência do enrijecimento da parede da artéria. Pode ser detectada por meio da manobra de Osler, que consiste na inflação do manguito no braço até o desaparecimento do pulso radial. Se a artéria for palpável após esse procedimento, sugerindo enrijecimento, o paciente é considerado Osler positivo. AFIRMATIVA CORRETA.

88646.

Comentário: Segundo as recomendações da USPSTF (United States Prevention Services Task Force), de 2009, o uso de aspirina pode ser considerado na prevenção primária de eventos cardiovasculares (antes que o evento aconteça) em homens com idade entre 45-79 anos em que a redução no risco de IAM suplante o risco de hemorragia digestiva. Em mulheres com idade entre 55-79 anos, a aspirina também pode ser usada desde que a redução no risco de AVC suplante o risco de hemorragia digestiva. Vale ressaltar que hoje em dia a decisão acerca do início de aspirina regular como forma de prevenção primária deve levar em conta ainda o benefício em relação à diminuição do risco de câncer colorretal. Logo, assertiva correta.

88651.

Comentário: Como monoterapia no tratamento da HAS, devemos utilizar apenas drogas consideradas de primeira linha, o que não inclui hidralazina nem minoxidil. Tradicionalmente, cinco classes de drogas sempre foram consideradas de primeira linha para o tratamento da hipertensão arterial crônica primária - Diuréticos tiazídicos - Inibidores da ECA (prils) - Antagonistas da angiotensina (sartans) - Antagonistas do cálcio - Betabloqueadores Ultimamente, tem sido contestada a posição dos beta-bloqueadores na lista, assim como tem sido discutida a inclusão dos inibidores da renina (alisquireno). Mas, em nenhum momento, foi cogitada a inclusão da hidralazina e do minoxidil nesta lista - são drogas de segunda linha, que devem ser usadas apenas na terapia combinada.

64687.

Comentário: Naturalmente, o paciente deverá fazer uso de drogas que comprovadamente alteram mortalidade em seu estágio IECA, beta-bloqueador e espironolactona. Essa combinação está

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

presente nas alternativas C e E, sendo que esta última fornecida como gabarito acrescenta ainda um diurético de alça. Esse acréscimo é absolutamente discutível, pois tais diuréticos são usados para controle sintomático e, no enunciado, não é citado o estado clínico atual ou pregresso do paciente. Deste modo, fazemos essa ressalva em relação ao gabarito fornecido pela banca (opção E).

64307.

Comentário: No caso descrito, temos uma paciente com quadro clínico de insuficiência cardíaca dispneia, ortopneia, hepatomegalia, edema periférico com sinal do cacifo, turgência jugular etc, sem sinais ao exame físico de insuficiência ventricular esquerda (pulsos preservados, exame do precórdio normal). No entanto, são claros os sinais de hipertensão arterial pulmonar (hiperfonese de B2), com aumento atrial esquerdo. Semiologicamente o sopro descrito é de estenose mitral. Em momento algum do texto existe referência do ponto de vista semiológico a insuficiência mitral que sugira a presença desta lesão. Desta forma, a afirmativa é errada uma vez que o principal diagnóstico para o caso clínico relatado é a estenose mitral.

45714.

Comentário: A manobra de Müller é o contrário da manobra de Valsalva. Se no Valsalva o paciente faz uma EXPIRAÇÃO forçada contra uma glote fechada, no Müller ele faz uma INSPIRAÇÃO forçada com o nariz e a boca fechados. Sabemos que a manobra de Valsalva aumenta a pressão intratorácica, reduzindo o retorno venoso. Já a manobra de Müller, por sua vez, reduz a pressão intratorácica, aumentando o retorno venoso. Ora, se o paciente tinha um sopro sistólico mais intenso no foco tricúspide, a principal hipótese é de regurgitação tricúspide. Espera-se que tal sopro se intensifique se houver aumento da PRÉ-CARGA (enchimento) do VD. Na manobra de Müller, portanto, o sopro de regurgitação tricúspide aumenta, pois aumenta o retorno venoso e, consequentemente, a pré-carga do ventrículo direito. Segundo a classificação de Levine, o sopro passa a ser acompanhado de frêmito catáreo quando sua intensidade for 3 . A manobra de preensão manual promove aumento da resistência vascular periférica, o que não tem qualquer relação com o retorno venoso ao coração direito e não modifica o sopro da regurgitação tricúspide.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Resposta certa B.

45726.

Comentário: De todas as opções diagnósticas listadas, qual é aquela que MAIS FREQUENTEMENTE se associa ao achado de PULSO PARADOXAL no exame físico Resposta nenhuma delas. No entanto, é importante reconhecer que a pericardite constritiva RARAMENTE pode cursar com pulso paradoxal. Por outro lado, o achado de knock pericárdico (no início da diástole, quando do enchimento ventricular) é altamente sugestivo desta forma crônica de pericardiopatia. Os demais achados semiológicos citados pela questão são compatíveis com um quadro de derrame pericárdico volumoso (ex. sinal de Kussmaul, ou aumento da distensão jugular à manobra de inspiração profunda), e a baixa voltagem dos complexos QRS no ECG em plano frontal é igualmente compatível com tal hipótese diagnóstica. A presença de pulmões limpos (sem crepitação em bases, indício de congestão) fala contra as letras C, D e E. No cor pulmonale esperaríamos uma história de pneumopatia avançada ou tromboembolismo pulmonar de repetição, além de QRS desviado para a direita no ECG. Logo, resposta certa A.

45729.

Comentário: A variação na pressão arterial de acordo com a ingestão de sal é conhecida como sensibilidade ao sal. Os mecanismos de hipertensão associados com esta característica, classicamente são atribuídos à retenção de sódio e água pelo organismo, provocando então o aumento da pressão. Como a retenção de sódio vem acompanhada da retenção de líquidos, com o aumento do volume vascular, a natremia não apresenta grandes variações. Por outro lado, conseguimos detectar a baixa excreção relativa de sódio pela urina. Desta forma, o sódio urinário é normal ou baixo após ofertarmos uma sobrecarga de sal.

49138.

Comentário: Paciente hipertenso, que cursa com pico hipertensivo associado a sintomas neurológicos sugestivos de comprometimento DIFUSO do SNC (cefaleia, tonteira, alterações visuais e rebaixamento do nível de consciência), na ausência de sinais focais e rigidez de nuca, deve ter como principal hipótese diagnóstica a encefalopatia hipertensiva.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

49136.

Comentário: De acordo com VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, o tamanho ideal da bolsa de borracha do esfigmomanômetro para se realizar uma aferição fidedigna da pressão arterial em um paciente adulto com circunferência do membro superior entre 27-34 cm (manguito adulto) deve ser de 23 cm de comprimento e 12 cm de largura. Tal cálculo é feito baseado no fato de que a largura da bolsa deve corresponder a 40% da circunferência do braço, e o seu comprimento a aproximadamente 80%. Logo, as dimensões do manguito utilizado estão corretas.

52637.

Comentário: Dissecções aórticas Stanford A (acometendo a aorta ascendente) representam 75% dos casos de dissecção aórtica aguda e devem necessariamente ser tratadas com uma abordagem cirúrgica, devido ao elevadíssimo risco de complicações e óbito com o tratamento clínico isolado. Afirmativa CORRETA

32190.

Comentário: E aí, conhecia essa Podemos dizer que a Manobra de Mueller é o inverso da Manobra de Valsalva. Se no Valsalva o paciente faz uma EXPIRAÇÃO forçada com a glote fechada, no Mueller ele faz uma INSPIRAÇÃO forçada com a boca e o nariz fechados (equivalente à glote fechada). Tal conduta produz uma pressão intratorácica muito negativa (subatmosférica), de modo que 2 eventos básicos podem ser notados (1) colapso da faringe e ou traqueia, em certos indivíduos com a síndrome de apneia obstrutiva do sono (2) aumento do retorno venoso (aumento da pré-carga do ventrículo direito). Logo, resposta certa D.

37938.

Comentário: O atrito pericárdico não coincide exatamente com nenhuma das fases do ciclo cardíaco, podendo ser ouvido tanto na sístole quanto na diástole, não mantendo relação fixa com as bulhas. Habitualmente é contínuo, com reforço sistólico, podendo em algumas situações restringir-se à sístole. Em relação ao caso descrito, a presença do atrito pericárdico ocorre na chamada pericardite urêmica, a qual ocorre em pacientes com insuficiência renal, devido a presença de toxinas urêmicas que não são depuradas pelos rins, o que acaba causando

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

inflamação dos folhetos pericárdicos (parietal e visceral). Já o sinal de Godet (também chamado de sinal do cacifo), está relacionado à diminuição da filtração glomerular, com consequente retenção volêmica, o que leva a formação de edema. Portanto, os mecanismos fisiopatogenicos do sinal de Godet e do atrito pericárdico são diferentes, sendo este relacionado a toxinas urêmicas e aquele à retenção volêmica. Afirmativa incorreta.

37940.

Comentário: Questão direta e conceitual. Segundo as principais diretrizes que norteiam o manejo na hipertensão arterial, a aferição da pressão arterial possui uma técnica padronizada a ser seguida, a qual começa pela seleção de um manguito adequado para o tamanho do braço do paciente. Após a determinação da circunferência do braço do indivíduo, a escolha do aparelho deve levar em conta que a largura da bolsa de borracha do manguito tem que corresponder a 40% da circunferência do braço, e seu comprimento a, pelo menos, 80%. Logo, a afirmativa está correta.

32162.

Comentário: Atenção diuréticos de alça (ex. furosemida) não são drogas de primeira linha para tratar a hipertensão Os diuréticos de alça só são bem empregados no tratamento da hipertensão de indivíduos com insuficiência renal crônica avançada (os quais são tipicamente refratários aos tiazídicos). Em todos os demais hipertensos, os diuréticos de primeira linha são os tiazídicos em baixas doses (ex. hidroclorotiazida 6,25 a 25 mg dia). Com este conceito em mente, descartamos as alternativas B, C e D. A maioria dos pacientes hipertensos (2 3), particularmente aqueles que já possuem lesão de órgão-alvo como a nefroangioesclerose benigna, necessita de dois ou mais agentes anti-hipertensivos para um adequado controle da pressão arterial. Segundo as últimas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (VI Diretrizes, 2010), as drogas de primeira escolha para pacientes com lesão renal hipertensiva sem insuficiência renal avançada são os diuréticos tiazídicos em baixas doses. Caso seja necessário associar outro fármaco, a associação de primeira escolha deve ser um inibidor da ECA ou BRA (que além de reduzirem a PA reduzindo o risco cardiovascular global conferem o benefício de uma nefroproteção adicional, especialmente nos indivíduos que apresentam franca proteinúria ou microalbuminúria). A associação proposta na letra

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

E (IECA Antagonista de Cálcio) também é válida para controlar a pressão, PORÉM, não é o esquema de primeira linha recomendado pelas diretrizes no tratamento da nefroesclerose hipertensiva benigna (nestes casos, os Ant de cálcio só podem ser usados se houver associação de um IECA ou BRA, para contrabalançar os efeitos de vasodilatação da arteríola aferente promovidos pelo Ant de cálcio). Assim, a melhor resposta, sem dúvida A.

27558.

Comentário: Vamos analisar as alternativas... A CORRETA Não há dúvidas que o tratamento da hipertensão arterial, quando realizado adequadamente, seja com diuréticos ou qualquer anti-hipertensivo, reduz a morbidade e a mortalidade relacionadas à doença. É importante não confundir o tratamento de hipertensão com insuficiência cardíaca sistólica o uso de betabloqueadores, IECA, BRA e espironolactona aumenta a sobrevida na IC sistólica, enquanto os diuréticos não aumentam a sobrevida na IC sistólica (apenas diminuem os sintomas). Isso não ocorre na HAS, doença na qual qualquer fármaco que controle adequadamente a PA sem efeitos adversos significativos diminui morbimortalidade e aumenta sobrevida. B ERRADA O erro aqui está na tolerabilidade através de doses crescentes . O que guiará o uso dos anti-hipertensivos é a resposta pressórica do paciente. Por exemplo, nos casos dos tiazídicos, frequentemente já os iniciamos em dose máxima (hidroclorotiazida 25 mg dia), assim não são necessárias doses crescentes para obter efeito anti-hipertensivo, já que o organismo não desenvolve tolerância aos seus efeitos. C e E ERRADAS Os grupos que se beneficiam de controle mais estrito da PA são os diabéticos e portadores de algumas lesões em órgãos-alvo (nefropatas, portadores de insuficiência cardíaca). Não existe benefício comprovado de metas mais baixas para jovens e idosos. D ERRADA Os IECA são absolutamente contraindicados em portadores de estenose bilateral de artéria renal ou estenose unilateral em rim único, pois podem precipitar insuficiência renal nesses pacientes. Resposta Letra A.

27559.

Comentário: Vamos lá. A CORRETA os coronariopatas, que já apresentam perfusão miocárdica comprometida em situações normais, podem apresentar angina pectoris e descompensação da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

função cardíaca (redução da contratilidade miocárdica) em caso de anemia grave, devido à hipóxia e anóxia celular, particularmente se a instalação for rápida. B ERRADA a maioria dos pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) apresenta um baixo débito cardíaco com aumento da resistência vascular sistêmica (IC sistólica) ou uma restrição ao enchimento ventricular (IC diastólica), entretanto, em raros casos, encontramos um débito cardíaco elevado e uma resistência vascular sistêmica muito baixa. Estes casos são chamados de IC de alto débito. Esta forma de IC ocorre em situações clínicas como a tireotoxicose, beribéri, fístulas arteriovenosas, anemia e doença de Paget, onde o déficit é metabólico e o coração é incapaz de manter um débito suficientemente elevado para impedir o surgimento de sintomas de insuficiência cardíaca. C ERRADA esta alternativa é maldosa . Observe que o enunciado da questão faz referência à população ADULTA. As cardiopatias congênitas que cursam com insuficiência cardíaca são responsáveis por uma parcela ínfima dos casos de insuficiência cardíaca em adultos, já que, quando essas crianças chegam a desenvolver insuficiência cardíaca e não têm a cardiopatia corrigida, dificilmente atingirão a idade adulta. D ERRADA fadiga e fraqueza na IC decorrem de redução da perfusão da musculatura esquelética, e não cardíaca. E ERRADA não existe recomendação de repouso absoluto na IC, já que neste caso estaremos aumentando, por exemplo, o risco de TVP e desenvolvimento de úlceras de pressão (escaras), sem benefício claro ao paciente. A atividade física deve ser limitada pelo sintoma do paciente e não pelo resultado do ecocardiograma. Resposta letra A.

29754.

Comentário: O BNP (peptídeo natriurético cerebral ou do tipo B), apesar do nome, é um peptídeo produzido pelo miocárdio dos ventrículos sempre que ocorre um estiramento do miocárdio (como na insuficiência cardíaca). Portanto, nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca, encontraremos valores elevados do BNP, e nas pneumopatias não encontramos esse aumento. Este achado pode ser bastante útil nos pacientes que se apresentam com dispneia aguda e não sabemos se o quadro é secundário a uma pneumopatia ou a uma cardiopatia. Estudos evidenciaram que valores do BNP 100 pg ml apresentam alta sensibilidade (90%) e razoável

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

especificidade (76%) para o diagnóstico de ICC. Apesar de sabermos que mesmo um exame com excelente acurácia para o diagnóstico não é capaz de excluir completamente o diagnóstico de uma doença, o tratado de medicina interna do Harrison (referência bibliográfica do concurso), em sua última edição é categórico Uma concentração normal do BNF em pacientes não tratados é extremamente útil para excluir o diagnóstico da insuficiência cardíaca . Resposta item certo (letra A).

7548.

Comentário: Afirmativa I errada o parasito está presente nas FEZES do barbeiro (Triatoma infestans), e não em sua saliva... Afirmativa II correta o sinal de Romaña é clássico (também é chamado de chagoma). Ressalte-se que ele é bipalpebral (ambas as pálpebras de um mesmo olho), isto é, trata-se de lesão unilateral... Atenção para não confundir bipalpebral com bilateral Afirmativa III óbvia não merece comentário... Afirmativa IV errada a doença de Chagas aguda é mais freqüente em crianças que adultos... Afirmativa V correta eis aqui o item polêmico da questão A afirmativa foi considerada correta pela banca. O teste da fixação do complemento (Machado-Guerreiro) é um dos muitos exames para se diagnosticar doença de Chagas. O problema é a construção da frase, veja só nos pacientes infectados, a reação de Machado Guerreiro é positiva . Ora, não podemos dizer que isso está errado... Se o autor dissesse nos pacientes infectados, a reação de Machado Guerreiro é SEMPRE positiva , aí sim a frase sem dúvidas estaria incorreta Logo, resposta certa letra C.

7551.

Comentário: Questão conceitual sem dificuldades... Sabemos que as principais etiologias da hipertensão arterial secundária são 1. Doenças parenquimatosas renais 2-3% 2. Estenose de artéria renal 1-2% 3. Uso de anticoncepcionais orais 0,5-1% 4. Hiperaldosteronismo primário 0,3% 5. Outros (incluindo hiper ou hipotireoidismo) 0,1% Logo, é evidente que as disfunções tireoideanas, apesar de serem patologias comuns, respondem pela minoria dos casos de HAS secundária As demais alternativas estão corretas e não merecem maiores comentários. Na verdade, gostaríamos apenas de deixar registrada uma observação o que está escrito na letra B foi

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

simplesmente copiado na íntegra de um trecho do Cecil (referência em clínica médica). Resposta certa letra E

8583.

Comentário: Questão simples. As drogas que comprovadamente aumentam a sobrevida na insuficiência cardíaca (por inibirem a hiperativação neuro-humoral e consequentemente evitarem o remodelamento cardíaco) são os IECA (ou BRA), como enalapril e losartan, os beta-bloqueadores, como o carvedilol, e os antagonistas da aldasterona, como a espironolactona, este último sendo indicado somente para os pacientes com classe funcional III ou IV Digitálicos e diuréticos não aumentam sobrevida, mas são úteis para reduzir os sintomas...

13856.

Comentário: Muita gente, após a leitura deste enunciado, já sai procurando por uma tal de hipertensão arterial pulmonar entre as alternativas... Como de fato existe essa opção, ela acabou sendo marcada de maneira imediata, e o candidato imediatamente marcou a resposta errada Gente, os sinais de sobrecarga do coração direito observados no ECG e no raio-x desse caso clínico são compatíveis com os achados iniciais ao exame físico impulsão sistólica de VD palpável na borda esternal esquerda baixa (chamada erroneamente por alguns de ictus de VD este termo não é válido quando se trata do ventrículo direito) e hiperfonese de B2 à custa do componente pulmonar (P2) O desdobramento de B2 representa um atraso na ejeção ventricular direita, comumente observado nos casos de bloqueio de ramo direito, disfunção ventricular direita, estenose pulmonar e CIA (neste último por sobrecarga de volume) O que deve nos fazer pensar em CIA nessa questão é uma característica extremamente peculiar do desdobramento de B2 repare em como ele é nitidamente FIXO Manobras que deveriam alteração a duração da ejeção ventricular direita (por modificarem o retorno venoso) não surtem qualquer efeito sobre o desdobramento (isto é, não fazem o componente P2 ser mais precoce ou mais tardio) Estamos falando das manobras de Rivero-Carvalho (inspiração profunda promove aumento do RV) e Valsalva (expiração forçada contra a glote fechada promove diminuição do RV) O desdobramento fixo de B2 é PATOGNOMÔNICO DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL A explicação é a seguinte se eu aumento

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

o RV (por exemplo, inspirando profundamente) eu diminuo o jato interatrial e o volume diastólico final do meu ventrículo direito permanece inalterado Por outro lado, se eu faço a manobra de Valsalva (e com isso diminuo o RV), o jato interatrial aumenta, mantendo constante, novamente, o volume diastólico final do VD Assim, alterações do RV se acompanham de alterações proporcionalmente antagônicas do jato interatrial, e o volume do ventrículo não se altera, fazendo com o que o atraso na ejeção do VD seja constante, e, de fato, exista sobrecarga de volume no lado direito do coração (justificando os demais sinais clínicos, eletrocardiográficos e radiográficos citados) Logo, resposta certa letra B Só um lembrete a estenose pulmonar grave é acompanhada de uma 4ª bulha, ondas a proeminentes no pulso venoso jugular e, às vezes, pulsações pré-sistólicas no fígado, provocadas pelas contrações atriais vigorosas

334876.

Comentário: A questão quer saber qual das drogas está associada à redução do risco de mortalidade no tratamento de uma paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (ICFEr). As classes farmacológicas que trazem esse benefício são (1) Betabloqueadores devem ser administrados para todos os pacientes com IC COMPENSADA, com nenhuma ou pouca retenção de volume. (2) Inibidores da ECA devem ser administrados em TODOS os pacientes com IC. Podem ser substituídos pelos Bloqueadores do Receptor da Angiotensina (BRA). (3) Associação valsartan sacubitril (INRA) combinação aprovada que pode substituir IECA ou BRA, com benefícios na sobrevida ou mesmo ser utilizada como primeira linha. (4) Antagonistas da aldosterona (espironolactona) utilizar nos pacientes das classes funcionais NYHA II, III e IV. Os pacientes da classe II devem ter histórico de internação prévia por motivo cardiovascular ou níveis elevados de BNP. Estas drogas também estão indicadas após IAM agudo em pacientes com FE 40%, sintomas de IC ou diabetes. (5) Inibidores de SGLT2 (empaglifiozina, dapagliflozina) reduzem mortalidade e número de internações por IC, independentemente da presença de diabetes. (6) Associação hidralazina nitrato substituem os IECA e BRA nos pacientes que não toleram essas drogas devido a hipercalemia ou insuficiência renal. Além disso, é indicada em pacientes que se mantêm sintomáticos mesmo com terapêutica otimizada. Pode aumentar a sobrevida,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

principalmente em negros. (7) Ivabradina inibidor específico e seletivo da corrente If do nó sinoatrial. Fica recomendada para pacientes com ritmo sinusal, FC 70 bpm e classes funcionais II-III da NYHA com disfunção sistólica em uso de terapia otimizada. Alguns trabalhos a relacionam com aumento da sobrevida também. Vale lembrar que os diuréticos e a digoxina são utilizados como drogas sintomáticas, essa última atualmente relegada para casos refratários. Portanto, dentre as classes citadas, a única associada com redução de mortalidade é o inibidor da enzima conversora da angiotensina. Resposta letra E.

301251.

Comentário: Afirmativa CERTA. A diretriz brasileira de hipertensão arterial organiza da seguinte forma o tratamento anti-hipertensivo de pacientes com doença renal crônica os IECA ou os BRA estão indicados em hipertensos com ou sem albuminúria, sendo proscrita sua associação. Os diuréticos tiazídicos ou de alça (estes últimos no caso de doença renal crônica estágios G4-G5) e os bloqueadores de canal de cálcio são eficazes, principalmente em associação a IECA ou BRA. Betabloqueadores estão indicados se houver doença arterial coronariana ou insuficiência cardíaca associada pelo benefício secundário nestas condições. Antagonistas dos receptores mineralocortocoides são medicamentos que diminuem a proteinúria, porém podem causar hiperpotassemia (ensaios clínicos com novos antagonistas dessa classe são aguardados).

301252.

Comentário: Afirmativa correta, de acordo com a fonte citada pelo autor, sobre o tratamento de pacientes em terapia renal substitutiva O tratamento deve ser iniciado por medidas que visem à obtenção do peso-seco , como restrição hidrossalina e ultrafiltração na hemodiálise. Não obstante, cerca de 60% dos pacientes sob tratamento dialítico necessitam de três ou mais anti-hipertensivos, em diversas combinações, para o controle da hipertensão arterial. Nessa população, a hiperatividade do sistema nervoso simpático (SNS) tem papel importante na gênese da hipertensão arterial e na doença cardiovascular. Em consonância, o bloqueio beta-adrenérgico foi superior à inibição da ECA na prevenção da morbidade cardiovascular e no controle da PA em pacientes com hipertrofia ventricular esquerda sob tratamento hemodialítico. Em indivíduos transplantados renais,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

os bloqueadores de canal de cálcio os bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II consistem na primeira opção, pois há evidências de que previnam a perda do enxerto Resposta letra A.

301253.

Comentário: Afirmativa INCORRETA. De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, publicadas em 2020, sobre o tratamento de pacientes com doença renal crônica Com relação ao tratamento medicamentoso, os IECA ou os BRA estão indicados em hipertensos com ou sem albuminúria, sendo proscrita sua associação . Sabemos que a associação de IECA e BRA até reduz a proteinúria, mas sem melhora nos desfechos renais, no risco cardiovascular ou mortalidade Além disso, há maior risco de hipotensão, hipercalemia e maior incidência de rins terminais. Os riscos não justificam um potencial benefício em relação à proteinúria. Resposta letra B.

301254.

Comentário: De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial - 2020, sobre o tratamento de pacientes com doença renal crônica A presente diretriz recomenda em adultos com hipertensão arterial e doença renal crônica, diabéticos ou não, meta de PA 130x 80 mmHg. Metas mais estritas podem ser almejadas em casos selecionados, sob estrita vigilância e após compartilhamento de riscos com o paciente . Resposta letra A.

301255.

Comentário: Questão copiada e colada da Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, publicada em 2020, sobre o tratamento de pacientes com doença renal crônica e terapia renal substitutiva. De acordo com essa fonte, as medidas residenciais de pressão arterial são mais reprodutíveis, fornecem informações relevantes para decisões terapêuticas e associam-se a melhor controle da pressão arterial. Inclusive, é citado neste documento que as médias sistólicas obtidas por medidas domiciliares associam-se linearmente ao aumento do risco cardiovascular nesses pacientes com doença renal crônica em terapia dialítica. Na prática, é comum fazermos esse acompanhamento através de medidas domiciliares, que muito ajudam no manejo terapêutico e na estratificação de risco. Resposta letra A.

291471.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Estamos diante de um quadro compatível com encefalopatia hipertensiva Um aumento súbito e significativo da PA pode ultrapassar o limite da autorregulação do fluxo cerebral, levando ao hiperfluxo e extravasamento de líquido para o interstício, isto é, um edema cerebral (edema cerebral que justifica o achado de hipodensidade na TC, ou seja, não se trata de um AVEi, como colocado na letra D). Em hipertensos crônicos prévios, a síndrome geralmente só ocorre com níveis muito altos de PA (240 x 120). Ora, e por que essa paciente fez uma emergência hipertensiva Aliás, por que ela tem hipertensão resistente O sopro em flanco direito é compatível com uma possível estenose de artéria renal unilateral, o que explicaria o quadro Cuidado, não estamos diante de um feocromocitoma, que cursaria com uma franca síndrome adrenérgica (B incorreta). O primeiro sintoma é a cefaleia, geralmente frontoccipital ou holocraniana. A síndrome de hipertensão intracraniana e edema cerebral instala-se de forma insidiosa nos próximos dias, com náuseas e vômitos, queda do nível de consciência (sonolência, torpor e coma) e crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas. O principal diagnóstico diferencial é com o AVE, motivo pelo qual um exame de neuroimagem pode ajudar. A ressonância magnética de crânio pode indicar edema da substância branca da região occiptoparietal, condição conhecida como síndrome de leucoencefalopatia posterior ou PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) trata-se de um edema potencialmente reversível, ou seja, quando os níveis pressóricos forem reduzidos e o paciente melhorar dos sintomas, esse edema desaparece. Em relação ao tratamento o paciente deve ser imediatamente internado e a terapia anti-hipertensiva prontamente iniciada. A preferência é por uma droga venosa de meia-vida curta (pode-se utilizar o nitroprussiato de sódio, a nicardipina ou o labetalol). A meta é baixar a PAM em, no máximo, 25% na primeira hora de tratamento, o que já costuma produzir uma melhora dramática dos sintomas. Feito isso, mantemos a PA em torno de 160 x 110 100 mmHg nas próximas 2 a 6h. Deve-se evitar reduções mais intensas da PAM no primeiro dia, pois, devido à perda da autorregulação do fluxo cerebral, uma queda muito acentuada pode resultar em isquemia cerebral e AVC. Posteriormente, com o paciente estabilizado, o esquema de anti-hipertensivos orais é iniciado retomado, desmamando-se progressivamente a medicação venosa. O objetivo é atingir uma PA em torno de 135 x 85 mmHg nas 24 48h

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

subsequentes. Resposta letra C.

263981.

Comentário: Estamos diante de uma paciente que usa quatro drogas anti-hipertensivas hidroclorotiazida, enalapril, losartana e clonidina, sendo esta última a única de segunda linha. Como sabemos, a combinação entre IECA e BRA deve ser evitada. Por terem mecanismos de ação semelhantes, a associação não promove grandes benefícios de redução da PA e potencializam os efeitos colaterais, como hipercalemia e disfunção renal. Portanto, o uso das medicações em conjunto deve ser evitado. Uma das duas deveria ser substituída por outro anti-hipertensivo, como a espironolactona.

268899.

Comentário: A questão aborda o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, sendo solicitado a melhor escolha de anti-hipertensivo conforme a comorbidade apresentada. Vamos analisar cada uma das alternativas (A) INCORRETA. Na verdade, o diabetes mellitus, por si só, não é indicativo de nenhuma classe específica de anti-hipertensivo. No entanto, caso o paciente apresente microalbuminúria, as drogas de escolha serão os IECA ou BRA (apresentam efeito nefroprotetor). Repare ainda que os tiazídicos tem como possível efeito colateral a ocorrência de hiperglicemia (pelo bloqueio na liberação de insulina diretamente induzido por essas drogas), e dessa forma talvez não sejam as drogas mais apropriadas nesta circunstância. (B) CORRETA. Sabe-se que a losartana apresenta efeito uricosúrico, podendo auxiliar no tratamento da hiperuricemia. Repare ainda que este é um efeito específico da losartana e não um efeito da classe dos BRA. (C) INCORRETA. A clonidina tem como efeito colateral a ocorrência de disfunção erétil. (D) INCORRETA. A hidralazina pode provocar taquicardia reflexa, a qual pode precipitar ou agravar a isquemia miocárdica. (E) INCORRETA. Os betabloqueadores podem precipitar broncoespasmo devido o bloqueio dos receptores ß2 da musculatura lisa dos brônquios, especialmente um betabloqueador não seletivo como o propranolol. Resposta letra B.

263362.

Comentário: Estamos diante de uma paciente previamente hipertensa que desenvolve elevação

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

dos níveis tensionais, tremores e dispneia após ser assaltada. Um eletrocardiograma foi realizado para excluir de forma mais segura a possibilidade de síndrome coronariana aguda. Apesar da PA diastólica ser compatível com urgência hipertensiva, o melhor diagnóstico para essa mulher é de pseudocrise hipertensiva, desencadeada pelo estresse decorrente do assalto a presença de um fator desencadeante nítido geralmente aponta para esta hipótese. A melhor conduta em situações como essa é atacar a origem do problema, que, nesse caso, é a agitação psicomotora. Isso pode ser feito com a prescrição de algum ansiolítico (ex benzodiazepínico), e não um anti-hipertensivo. É de bom tom manter a paciente em observação e reavaliar os níveis tensionais após a medicação. Com essa estratégia, os níveis tensionais certamente se reduzirão... Resposta letra B.

273342.

Comentário: Segundo a diretriz brasileira de HAS de 2020, a presença de um dos seguintes fatores define o paciente como de alto risco cardiovascular (o risco muito alto não é citado pelo documento) lesão de órgão-alvo, doença renal crônica (a partir do estágio 3), diabetes, doença cardiovascular estabelecida, HAS estágio 3, HAS estágio 2 com um fator de risco cardiovascular e HAS estágio 1 com 3 fatores de risco. Vamos analisar essa paciente... Ela possui níveis compatíveis com HAS estágio 2 (a diastólica está entre 100-109 mmHg) e apresenta alguns fatores de risco, como obesidade e dislipidemia. Dessa forma, podemos afirmar que ela tem risco cardiovascular elevado Sua meta pressórica é entre 120-129 x 70-79 mmHg. Como está fora do alvo, o tratamento deve ser reavaliado. Analisando as alternativas, a melhor resposta é, de fato, a letra D.

273343.

Comentário: Estamos diante de um caso clássico de estenose aórtica A redução do lúmen da valva aórtica faz com que o sangue engarrafe nas próprias câmaras cardíacas, no pulmão e na circulação venosa sistêmica, levando a um verdadeiro quadro de insuficiência cardíaca congestiva (esquerda direita). Como não consegue ejetar grande quantidade de sangue para a aorta, os miócitos cardíacos podem acabar sendo hipoperfundidos, resultando em angina. O quadro anginoso também pode ser justificado por outro fenômeno o aumento da demanda para vencer a resistência imposta pela estenose, os miócitos se hipertrofiam E a ausculta Bom, o sopro da estenose aórtica é

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

tipicamente sistólico, em padrão crescente-decrescente (em diamante), melhor audível no foco aórtico. A B4 é clássica e é originada do choque do sangue contra a parede ventricular endurecida (hipertrofiada) a partir da contração atrial, etapa importante do enchimento ventricular normal (na FA, não há contração atrial e, consequentemente, B4). E o tal do desdobramento na expiração Ele é conhecido como desdobramento paradoxal. Na inspiração, há aumento do retorno venoso e, consequentemente, atraso no fechamento da valva pulmonar esse é o desdobramento fisiológico. Na expiração, os componentes pulmonar e aórtico coincidem. Agora, com a estenose aórtica, o VE demora mais a se esvaziar e, naturalmente, a valva aórtica leva mais tempo para se fechar. Na inspiração, os componentes aórtico e pulmonar se equilibram (na ins, a pulmonar demora mais, lembra). Já na expiração, o componente pulmonar volta ao normal e o aórtico segue atrasado, resultando no desdobramento. Resposta letra A.

291537.

Comentário: A questão traz uma paciente adulta, com clínica de insuficiência cardíaca descompensada dispneia progressiva, ortopneia, dispneia paroxística noturna, estertores pulmonares e presença de fibrilação atrial confirmada no eletrocardiograma e no exame físico ritmo irregular anisocardiosfigmia (ausculta de batimento cardíaco sem palpação de pulso periférico). A IC desta paciente pode ser concluída pela ausculta cardíaca , que traz dados sugestivos de ESTENOSE MITRAL presença de hiperfonese da primeira bulha (que corresponde ao fechamento das valvas atrioventriculares) e ruflar diastólico mais audível no foco mitral. Por conta da dificuldade de esvaziamento do átrio esquerdo, pacientes com estenose mitral tipicamente cursam com dilatação desta câmara cardíaca, o que predispõe à fibrilação atrial e ao surgimento de sintomas de congestão pulmonar. Em relação à ETIOLOGIA da estenose mitral, a principal causa no Brasil é a sequela da febre reumática adquirida na infância, problema que é descrito com detalhes no enunciado há história de dois episódios na adolescência e profilaxia secundária inadequada posteriormente (LETRA B CORRETA). A cardite reumática aguda é a apresentação da infância da febre reumática, cursa tipicamente com INSUFICÊNCIA MITRAL, e neste contexto veríamos a positividade dos marcadores infecciosos do estreptococo do grupo B (LETRA C INCORRETA). A

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

insuficiência valvar cursa com sopro diastólico aspirativo mais audível no foco aórtico ou aórtico acessório, além de pulsos periféricos amplos (LETRA A INCORRETA). O quadro não é sugestivo de endocardite infecciosa, uma vez que os sintomas começaram há um ano e não há sintomas como febre ou elevação de marcadores inflamatórios (LETRA D INCORRETA). Resposta letra B.

263438.

Comentário: Temos um paciente apresentando a famosa tríade clínica angina síncope dispneia aos esforços. Ao exame físico foi evidenciado sopro mesossistólico em foco aórtico (sopro ejetivo) e pulso parvus-tardus. Qual condição justificaria tais achados clínicos A estenose aórtica (EA) Repare que o ecocardiograma corrobora tal diagnóstico, demonstrando uma área valvar aórtica bastante reduzida (0,9 cm2). Podemos perceber ainda que a presença de sintomas, área valvar aórtica MENOR OU IGUAL A 1,0 cm2 e gradiente VE-aorta MAIOR OU IGUAL A 40 mmHg indicam a presença de EA grave (estágio D). Sendo assim, a grande proposta terapêutica será a realização de troca valvar, que pode ser cirúrgica ou através de hemodinâmica (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation) para os casos de alto risco cirúrgico (D CORRETA). De toda forma, vamos analisar cada uma das alternativas (A) INCORRETA. A insuficiência cardíaca foi provocada pela presença de estenose aórtica e não por um aneurisma de aorta torácica ascendente. Além disso, por se tratar de IC com FE preservada (FE MAIOR OU IGUAL A 50%), tais medicações até poderiam ser administradas na tentativa de melhora sintomática, no entanto, os diuréticos devem ser usados com cautela (pelo risco de maior redução do DC) e os nitratos, nesse contexto, não costumam ter boa resposta. Lembre-se que nos casos de ICFEP nenhuma destas drogas (ex IECA) tem benefício comprovado na mortalidade. Dessa forma, a prioridade aqui será a troca valvar aórtica. (B) INCORRETA. A regurgitação aórtica ocorreria em caso de insuficiência aórtica e não de estenose aórtica (EA). Na verdade, a disfunção diastólica se desenvolveu devido a EA. (C) INCORRETA. Na verdade, temos uma IC com FE preservada, ou seja, FE MAIOR OU IGUAL A 50% (disfunção diastólica). Além disso, apesar da forte associação de EA com doença coronariana, a angina pode ser provocada somente pela hipertrofia do VE, que aumenta a demanda de oxigênio e pode comprimir as artérias coronarianas em seu trajeto intramiocárdico. No

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

caso de um esforço físico, a demanda aumenta mais ainda, porém a menor área aórtica impede a compensação através de um maior débito cardíaco (o DC é fixo nestes casos). (D) CORRETA. Como descrito acima, o paciente apresenta EA grave sintomática (estágio D), necessitando de troca valvar aórtica. O risco cirúrgico deve ser realizado para definição da melhor proposta terapêutica (cirurgia x TAVI). Resposta letra D.

230543.

Comentário: Questão extraída do Posicionamento de Ultrassonografia Vascular do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. Vamos, então, revisar um trecho que respondia a questão Circunstâncias que Podem Alterar a Medida das Velocidades do Fluxo e A Avaliação Anatômica A avaliação das velocidades pode estar comprometida em algumas condições que afetam as medidas da análise espectral. Elas podem estar localizadas na bifurcação carotídea, distal ou proximal à mesma ou, ainda, na carótida contralateral. Dentre as condições proximais à bifurcação ressaltamos as valvopatias aórticas (estenose ou insuficiência), estenoses de origem aterosclerótica ou arterites com envolvimento do arco aórtico, ramos e carótida comum . Resposta letra A.

206171.

Comentário: Questão direta sobre INSUFICIÊNCIA MITRAL(IM). A banca quer saber qual dos achados NÃO corresponde a esse diagnóstico. Então vamos relembrar os achados da IM no exame físico Ictus cordis desviado para a esquerda e para baixo Primeira bulha hipofonética Segunda bulha hiperfonética Sopro sistólico regurgitativo 6 Sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita Como podem ver, a banca copiou e colou os critérios da diretriz. Por isso a resposta certa é LETRA B.

206174.

Comentário: Questão sobre ESTENOSE AÓRTICA (EA)cobrando as características do sopro. Uma ótima ocasião para revisar pois a questão pede a incorreta. As alternativas A,C e D estão corretas e fazem parte do quadro clínico e características do sopro na EA. Mas a alternativa B está errada. A EA tem sopro sistólico , tipo Holossistólico, mas como aumento de intensidade no meio, chamado

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

sopro em diamante . Resposta LETRA B.

206177.

Comentário: A insuficiência aórtica apresenta-se clinicamente por diversos sinais, são eles - Pulso em martelo d água - Ascensão rápida e colapso abrupto (melhor sentido na artéria radial) - Pulso Bisferiens - Pulso com 2 picos de ascenção - Sinal de Quincke - Pulsação do leito capilar sub-ungueal - Sinal de Musset - movimento pendular da cabeça - Sinal de Muller - movimento da úvula - Sinal de Traube (pistol shot) - Ruido sisto-diastólico na arteria femoral - Sinal de Duroziez - sopro sisto-diastólico ao comprimir a femoral em sua porção distal. Tais achados ocorrem por uma pressão elevada na sístole, com rápido descenso, visto que parte do fluxo sanguíneo retorna ao VE pela insuficiência valvar. Dessa forma, há aumento da pressão de pulso, ou seja diferença entre as pressões sistólica e diastólica. Gabarito Alternativa A.

212131.

Comentário: Observem esse trecho retirado do Harrison A SAOS é um importante fator contribuinte para distúrbios cardíacos, cerebrovasculares e metabólicos, bem como para morte prematura...pode aumentar a pressão arterial para níveis de pré-hipertensão e hipertensão, aumentar a prevalência de um padrão sem descenso noturno da pressão arterial e aumentar o risco de hipertensão resistente... Evidências epidemiológicas fortes indicam que a SAOS aumenta de forma significativa o risco de doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca com ou sem redução da fração de ejeção, arritmias atriais e ventriculares, aterosclerose e doença arterial coronariana, AVE e diabetes . Foi demonstrado que o tratamento da SAOS reduz vários marcadores de risco cardiovascular, melhora a resistência à insulina, diminui a taxa de recorrência de fibrilação atrial e melhora vários desfechos clínicos em pacientes com doença cardiovascular ativa A afirmativa só pode estar correta já que ela foi copiada e colada do próprio Harrison. Gabarito letra A.

212094.

Comentário: Os sinais e sintomas descritos são absolutamente clássicos de estenose mitral ictus cordis normal, hiperfonese da primeira bulha em foco mitral acompanhada de estalido de abertura,

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

ruflar diastólico e reforço pré-sistólico (aumento da intensidade do sopro diastólico mitral devido à contração do átrio esquerdo). Trata-se de paciente jovem do sexo feminino com passado de amigdalites de repetição. Qual a principal hipótese diagnóstica Sequela de cardite reumática, representada em sua forma mais frequente pela ESTENOSE MITRAL. Em relação ao diagnóstico da lesão valvar, perceba que não há dados que sugiram outra lesão associada (em outras valvas ou mesmo na própria valva mitral, na forma de uma dupla lesão mitral , isto é, estenose insuficiência). Assim, sob esta ótica está correto afirmar que existe uma estenose mitral pura . Todavia, olhando para o caso como um todo, o clínico não pode se satisfazer APENAS com este diagnóstico, uma vez que existem sinais e sintomas de outras alterações. Repare na existência de sinais e sintomas de HIPERTENSÃO PULMONAR e COR PULMONALE , complicações classicamente associadas à evolução da estenose mitral não tratada. A sobrecarga crônica do átrio esquerdo se reflete retrogradamente sobre o leito venocapilar pulmonar, causando congestão. Com o tempo, há uma resposta adaptativa da árvore arterial pulmonar, inicialmente com vasoespasmo dos ramos da artéria pulmonar (ainda reversível) e, numa fase mais tardia, remodelamento vascular, com fibrose e hiperplasia muscular da média, gerando hipertensão arterial pulmonar (irreversível). Esta hipertensão pulmonar, quando grave, sobrecarrega o lado direito do coração, levando à falência do ventrículo direito. Quando o VD falha (edema de membros inferiores, impulsão do terço inferior da região esternal, hiperfonese do componente P2 da segunda bulha) devido a um problema pulmonar, chamamos o quadro de cor pulmonale . Agora, sob este novo ponto de vista, podemos discordar do gabarito da banca (assertiva correta), pois o problema da paciente não é APENAS uma estenose mitral pura... Assim, ao nosso ver, a melhor resposta seria assertiva errada . Contudo, a banca deu como gabarito assertiva certa .

212136.

Comentário: Paciente com história de faringoamigdalites de repetição - dado que não foi colocado aí à toa - tem exame cardiovascular bem chamativo, com sopro em ruflar no foco mitral, além de esforço pré-sistólico e ruído de abertura da valva mitral, todos sinais característicos de estenose dessa valva. Certamente, você lembra que estenose mitral é a grande complicação valvular crônica

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

da febre reumática... Como consequência dessa alteração valvar, pode surgir sobrecarga atrial esquerda, manifesta pelo aumento da duração da onda P em D2 e índice de Morris em V1 (área da fase negativa da onda P em V1 acima de 1 milímetro quadrado). Não se espera sobrecarga ventricular esquerda - aliás, na estenose mitral o ventrículo esquerdo é poupado Assertiva errada. Resposta B.

206133.

Comentário: Questão extraída da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Capítulo 11 - Hipertensão Arterial no Idoso. Assim, percebam que as letras A, B e C foram retiradas, integralmente, do documento Entretanto, a letra D não. Vamos consertar a alternativa então e aprender juntos Estima-se que 69% dos idosos com antecedente de IAM, 77% com antecedente de AVE e 74% com histórico de IC tenham diagnóstico prévio de HA. Apesar de os indivíduos nessa faixa etária serem mais conscientes de sua condição e estarem mais frequentemente sob tratamento do que os hipertensos de meia-idade, as taxas de controle da PA nos idosos são inferiores, em especial após os 80 anos. . Resposta letra D.

206142.

Comentário: Questão extraída do 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Capítulo 12 - Hipertensão Arterial Secundária . Assim, percebam que as letras B, C e D foram retiradas, integralmente, do documento Entretanto, a letra A não. Vamos então consertar a alternativa e aprender juntos A hipertensão renovascular (HARV) é secundária a estenose parcial ou total, uni ou bilateral da artéria renal (EAR) ou de um de seus ramos, desencadeada e mantida por isquemia do tecido renal. Sua prevalência é 5% dos pacientes hipertensos. A principal causa é a aterosclerose (90%), seguida por displasia fibromuscular sendo a arterite de Takayasu a menos frequente.9 Independentemente do fator causal, é importante determinante de morbimortalidade CV. Resposta letra A.

206148.

Comentário: Questão sem criatividade e retirada, integralmente, da Sétima Diretriz de Hipertensão Arterial na parte de Hipertensão renovascular. Segue o trecho que respondia Para indicação da

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

opção terapêutica, deve-se considerar a etiologia e as condições clínicas associadas à Estenose de Artéria Renal (EAR), isto é, Hipertensão Arterial, nefropatia isquêmica e DCV acelerada. Evidências de benefício no tratamento mecânico percutâneo ou cirúrgico estão restritas a situações como perda progressiva da função renal, EAP e dificuldade de controle da PA, que promove LOA irreversível (letra B INCORRETA). Em pacientes com hipertensão renovascular (HARV) por displasia fibromuscular há 82-100% de controle da PA e reestenose em 10% (letra A CORRETA). Na HARV aterosclerótica sem complicações, em 3 estudos randomizados, o implante de stent comparado ao tratamento clínico otimizado não mostrou benefícios no controle da PA, na progressão da doença renal, ou na ocorrência de eventos clínicos e mortalidade (letra C CORRETA). Pacientes com EAR aterosclerótica e PA controlada por tratamento clínico, sem complicações cardíacas e função renal estável ao longo de 6-12 meses, a intervenção mecânica não é recomendada, sendo o tratamento clinico a primeira opção . (letra D CORRETA) Resposta letra B.

206084.

Comentário: Questão retirada da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Capítulo 12 - Hipertensão Arterial Secundária. Vamos, então, ao trecho que respondia a questão O hiperaldosteronismo primário (HAP) é uma condição clínica determinada por produção excessiva, inadequada e autônoma de aldosterona (Aldo), causada por hiperplasia bilateral das adrenais ou por adenoma unilateral produtor de Aldo (APA) e, mais raramente, por hiperplasia adrenal unilateral, carcinoma adrenal ou de origem genética (monogênicas ou quimera cromossômica). A prevalência do HAP em hipertensos é de 3-22%, sendo mais alta em hipertensos em estágio 3 e ou resistentes. Para detecção de APA ou hiperplasia, é indicada TC de adrenais com cortes finos ou RNM. O cateterismo de veias adrenais é indicado quando, à TC, as adrenais são normais, têm anormalidades bilaterais (espessamento ou micronódulos) ou lesão unilateral em pacientes 40 anos. (letras A e C - INCORRETAS) O teste de supressão com dexametasona é indicado para investigar HAP supressível por glicocorticoide em pacientes com HAP e início de HA antes dos 40 anos . (letra B - CORRETA e letra D - INCORRETA) Resposta letra B.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175082.

Comentário: A sarcoidose é uma doença multissistêmica de etiologia desconhecida, caracterizada pela presença de granulomas não caseosos em diversos órgãos. Afeta tipicamente adultos jovens, geralmente manifestando-se através de adenopatia hilar bilateral, opacidades pulmonares reticulares ou lesões de pele, oculares e articulares, sendo os pulmões acometidos em 90% dos casos. Os sintomas mais comumente apresentados são tosse, dor torácica, dispneia, fadiga e perda ponderal, sendo habitualmente realizados múltiplos exames laboratoriais e de imagem para descartar outras condições clínicas. A prova de função pulmonar tem papel importante tanto para avaliação da severidade do acometimento respiratório da doença, quanto no acompanhamento da sua progressão. (Alternativa A correta). A miocardite de células gigantes tem caráter autoimune, caracterizando-se por infiltrado inflamatório no tecido miocárdico, podendo acometer também outros órgãos, com predomínio de células gigantes multinucleadas, células T, eosinófilos e histiócitos (alternativa B correta). A etiologia desta doença é desconhecida e geralmente a evolução é rapidamente progressiva, devido a substituição de miócitos por fibrose, resultante do estresse oxidativo, levando a insuficiência cardíaca e óbito (alternativa C incorreta). A síndrome hipereosinofílica caracteriza-se por eosinofilia em sangue periférico com acometimento de órgãos sistêmicos, podendo ser primária ou associada a outras condições, como câncer, Churg-Strauss, infecções parasitárias e helmínticas e vacinações. O tratamento inclui uso de corticóides e imunossupressoes (alternativa D correta). Gabarito Alternativa C.

175083.

Comentário: O atleta, devido aos treinos de alta performance, desencadeia uma série de alterações orgânicas, dentre elas, mudanças estruturais cardíacas. Tais alterações podem ser vistas à ressonância nuclear magnética ou identificadas através do eletrocardiograma (ECG). O coração de atleta caracteriza-se por hipertrofia do VE (sem fibrose associada), o que é percebido ao ECG pelo aumento da voltagem das ondas R ou S, predominantemente nas derivações precordiais. A hipertrofia promove um maior débito cardíaco, o que permite uma redução da frequência cardíaca (bradicardia sinusal) e pode promover arritmia identificada em concomitância com a respiração. No

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

entanto, não identifica-se alteração da condução átrio-ventricular (intervalo PR). Gabarito Alternativa A.

175093.

Comentário: A miocardite pode ser causada por diversas etiologias. A maioria delas é provocada por processos infecciosos. Contudo, o autor dessa questão nos pergunta sobre a miocardite induzida por drogas Hidroxicloroquina, ciclofosfamida e cisplatina são exemplos de medicações que podem levar a essa condição. Na miocardite induzida por drogas, a resposta de sensibilidade. induzida pelos fármacos se dá de horas a meses (por isso, as manifestações podem não acontecer imediatamente após o início do uso). Parte da justificativa da hipersensibilidade se dá em resposta a componentes que se ligam a proteínas promovendo modificações estruturais. Essas partículas são fagocitadas pelas células de defesa, por vezes macrófagos, os quais as apresentam na superfície dessas células aos linfócitos T - opção (A) correta. O diagnóstico deve ser suspeitado quando há eosinofilia ou infiltrado eosinofílico no miocárdio. Citocinas, como a IL-5, estimulam a produção dessas células e estão aumentadas nessa condição - opção (B) correta. Esse acúmulo de IL-5 promove um grande infiltrado eosinofílico com aumento da resposta de hipersensibilidade e maior lesão miocárdica - opção (C) correta. Esse tipo de resposta parece ser favorecido por uma predisposição genética desses indivíduos - opção (D) incorreta. Dessa forma, a única alternativa incorreta é a (D).

175095.

Comentário: O ecocardiograma é um exame complementar importante na avaliação dos pacientes com suspeita de miocardite, principalmente para estabelecer a extensão do acometimento da doença, que reflete o grau de agressão inflamatória e remodelagem ventricular (alternativa B correta). No entanto, os achados são inespecíficos (alternativa A correta) e, por vezes, indistinguíveis das alterações isquêmicas, devido a possibilidade de acometimento segmentar ou difuso (alternativa C incorreta). Nos quadros fulminantes, há importante edema miocárdico, resultando em importante disfunção sistólica, porém, com diâmetros cavitários normais (alternativa D correta). Gabarito Alternativa C.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

175097.

Comentário: A realização de biópsia endomiocárdica pode estar indicada nos quadros de miocardite para correta identificação do agente causador do quadro. Para tal, deve ser realizada avaliação eco e eletrocardiográficas, além de cineangiocoronariografia para exclusão de causas isquêmicas que possam justificar a alteração cardíaca apresentada. As complicações desse procedimento são raras (alternativa A correta), girando em torno de 1%, especialmente se utilizado ecocardiograma associado a fluoroscopia, o que reduz ainda mais essa incidência (alternativa B correta). As complicações descritas são reação vaso-vagal, bloqueios átrio ventriculares de graus variados, perfuração de parede livre de ventrículo direito (alternativa D correta), pneumotórax (alternativa C incorreta), perfuração do septo interventricular, hematoma de sítio de punção, fístulas intracardíacas, hematoma retroperitoneal (acesso femoral), derrame pericárdico, deslocamento de trombos, tamponamento cardíaco, ruptura de cordoalhas tricúspides, arritmias ventriculares. Gabarito Alternativa C.

175099.

Comentário: Na avaliação de pacientes com miocardite, a utilização de exames de medicina nuclear permite avaliar a função ventricular esquerda, a inflamação cardíaca e identificar tipos de acometimento miocárdico e monitorar resposta ao tratamento instituído (alternativa A correta). A cintilografia com 67-Gálio apresenta sensibilidade de 50% para o diagnóstico de miocardite (alternativa C correta), com melhores resultados na fase aguda da doença, nos primeiros três meses de sintomas (alternativa D correta) e com maior acurácia na sarcoidose (alternativa B incorreta), em que há acúmulo de linfócitos T, fagócitos mononucleares e granulomas não caseosos nos tecidos envolvidos. Gabarito Alternativa B.

175100.

Comentário: A Biópsia Endomiocárdica é um procedimento raramente indicado, pois o que se encontra no histopatológico, na grande maioria das vezes, é fibrose, sem miocardite ou com miocardite, não modificando a conduta. Entretanto, algumas doenças tratáveis podem ser diagnosticadas pelo histopatológico, como a hemocromatose, a sarcoidose, algumas miocardites

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

agudas infecciosas. A importância deste exame é exatamente a possibilidade de diagnosticar algumas etiologias específicas que devem receber tratamentos também específicos, como doenças bacterianas, miocardite chagásica, fúngica, febre reumática, toxoplasmose, sarcoidose... O exame está indicado na suspeita dessas doenças, caso não haja outro meio de diagnosticá-las. Resposta certa C

175141.

Comentário: Questão sobre hipertensão sistólica isolada. Repare que esta foi retirada, na íntegra, do documento intitulado 7ª DIRETRIZ BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL . Vamos, então, relembrar o trecho que respondia a questão e pontuar o conteúdo A HSI é frequente em jovens saudáveis do sexo masculino com menos de 30 anos e pode estar associada à pressão central normal. (letra A - INCORRETA) Nesses casos, o tratamento não teria benefícios significativos, sendo recomendada a adoção de medidas não medicamentosas, com monitorização de lesões de órgão-alvo. (letras B e C - CORRETAS) O tratamento da HSI deve ter início imediato de terapia farmacológica caso seu risco CV seja alto. (letra D - CORRETA) No caso de elevação da PAD, adotam-se os mesmos critérios de tratamento da população em geral . Resposta letra A.

175170.

Comentário: Questão retirada na íntegra da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial Capítulo 2 - Diagnóstico e Classificação . Vamos analisar o trecho ao qual se referem as assertivas e chegar à única assertiva correta Aspectos especiais na medição da PA na população idosa decorrem de alterações próprias do envelhecimento, como a maior frequência do hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons durante a deflação do manguito, resultando em valores falsamente baixos para a PAS ou falsamente altos para a PAD (A CORRETA). A grande variação da PA nos idosos ao longo das 24 horas torna a MAPA uma ferramenta muitas vezes útil (B incorreta). A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela manobra de Osler, ou seja, a artéria radial permanece ainda palpável após a insuflação do manguito pelo menos 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso radial (C incorreta). Maior ocorrência de EAB, hipotensão ortostática e pós-prandial e, finalmente, a presença

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

de arritmias, como fibrilação atrial, podem dificultar a medição da PA (D incorreta). Perceba que somente a letra A encontra-se correta e portanto, é o nosso gabarito.

183923.

Comentário: Um dos sinais mais precoces da nefropatia hipertensiva é a excreção patológica de albumina. Lembre que, por dia, rins saudáveis excretam menos que 30mg de albumina. A partir desse valor, a albuminúria passa a ser patológica e detectada amostras urinárias. Assim, é de fundametal importância a realização periódica de exame EAS (elementos anormais e sedimentoscopia) em hipertensos. Assertiva correta. Resposta A.

183936.

Comentário: Assertiva errada. O tabagismo, juntamente à obesidade e ao sedentarismo, configura fator de risco modificável para doenças cardiovasculares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, configura a principal causa de morte evitável em todo o planeta. Resposta B.

175179.

Comentário: Questão bastante específica sobre o prognóstico de pacientes com cardiopatia chagásica, mas podemos aproveitar para revisar os principais pontos sobre essa condição. A doença de Chagas crônica sintomática torna-se evidente alguns anos ou mesmo décadas após a infecção inicial. Os sintomas são causados por alterações do ritmo, miocardiopatia segmentar ou dilatada e tromboembolismo. O bloqueio de ramo direito é uma anormalidade eletrocardiográfica comum, mas outros tipos de bloqueio intraventricular e atrioventricular, extrassístoles ventriculares, bem como taquiarritmias e bradiarritmias, ocorrem frequentemente. A miocardiopatia resulta muitas vezes em insuficiência cardíaca biventricular com predominância de insuficiência do lado direito em estágios avançados. Pode haver embolização de trombos murais para o cérebro ou outras áreas. A morte súbita é a principal causa de morte na cardiopatia de Chagas a insuficiência cardíaca congestiva e o choque são as causas seguintes mais comuns. Nos pacientes com etiologia chagásica, a presença de taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada é preditor de prognóstico reservado (alternativas A e B corretas), embora a FEVE 40% seja o único preditor independente de mortalidade (C correta). Pacientes chagásicos em lista de espera para

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

transplante cardíaco também apresentam pior prognóstico em relação a outras etiologias (D incorreta). Resposta D.

183954.

Comentário: Muito cuidado com a interpretação aqui O tratamento da HAS é, basicamente, pautado em mudanças no hábito de vida (alimentação e atividade física) e o uso correto das medicações. Isso demanda elevado custo Certamente não Diferente, por exemplo, do tratamento de neoplasias Como sabemos existem quimioterápicos que custam mais de 10 mil dólares Além disso, o tratamento da HAS não é um desafio no mundo todo. Pelo contrário Casos de tratamento desafiante e difícil em HAS é o mais raro. Resposta letra B.

168539.

Comentário: Como o paciente está com PA 160 x 100 mmHg, ele deve iniciar o tratamento anti-hipertensivo imediatamente, devendo, inclusive, iniciar já com terapia combinada, isto é, dois anti-hipertensivos diferentes em associação. Podemos escolher quaisquer drogas dentro do grupo de primeira linha (aquelas que além de reduzir a PA comprovadamente reduzem também a mortalidade cardiovascular - IECA, BRA, tiazídicos e ACC), lembrando que não se deve associar IECA com BRA, pois isso aumenta a mortalidade... Vale ressaltar que um IECA ou um BRA são mandatórios neste paciente, pois além do fato de ser diabético (duas glicemias de jejum, coletadas em momentos distintos, com valor 126 mg dl), este paciente já apresenta microalbuminúria (excreção urinária de albumina entre 30-300 mg dia), o que por si só já seria indicação de uma dessas drogas, independentemente da presença de HAS... Além do controle pressórico, está indicado iniciar o tratamento do diabetes mellitus, que neste caso é do tipo 2, sendo a droga de escolha a metformina. Medidas não farmacológicas que servem a ambos os propósitos, isto é, auxiliam no controle da HAS e do DM, também devem ser implementadas, como dieta hipocalórica e hipossódica. Com relação à prática de atividades físicas, vamos esperar o paciente obter um melhor controle da PA, pois não se deve estimular a prática de exercícios para pacientes com níveis de PA acima de 180 120 mmHg... Dado o alto risco cardiovascular do paciente (lembrando que se trata de diabético), está indicado iniciar estatina, de preferência uma estatina de alta

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

potência em dose plena (atorvastatina ou rosuvastatina).

154510.

Comentário: Estamos diante de um paciente com cardiomiopatia dilatada de origem alcoólica cujos sintomas são relatados como causadores de limitação física leve , o que é correspondente à classe funcional NYHA II letra B correta. Na classe NYHA I, não há limitação física e a dispneia só ocorre em esforços muito grandes (ex. empurrar um carro). Na classe III, há limitação moderada e dispneia em atividades do cotidiano, ou seja, dispneia aos pequenos esforços. Na classe IV, ocorre limitação física grave, com sintomas em repouso ou aos mínimos esforços. Resposta - letra B.

154514.

Comentário: Vamos começar classificando o nosso paciente temos um portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em classe funcional NYHA II. Neste grupo está bem estabelecido um grupo de drogas que atua no remodelamento ventricular, aumentando a sobrevida. Ele é composto por betabloqueadores, IECA ou BRA e antagonistas da aldosterona, sendo ainda possível a associação de hidralazina com nitrato. Assim, concluímos que a introdução de carvedilol à prescrição do paciente foi adequada. No entanto, devemos saber que, na fase inicial de sua instituição, essa classe medicamentosa pode piorar os sintomas de IC, visto que ela inibe o efeito adrenérgico compensatório sobre o miocárdio, reduzindo sua contratilidade. Este efeito tende a ser colateral sobrepujado pela melhora do remodelamento com a manutenção dos betabloqueadores. Desta forma, a menos que o paciente se torne francamente descompensado, devemos insistir na manutenção da droga, aumentando a dose dos diuréticos de alça para o alcance do alívio sintomático. Gabarito letra D.

158066.

Comentário: Paciente com coarctação de aorta... Os pacientes não submetidos à correção cirúrgica têm maior incidência de eventos CV. O tratamento é sempre intervencionista, por procedimento endovascular (indivíduos mais jovens ou crianças) ou cirurgia (hipoplasia do arco aórtico e ou necessidade de ressecção da coarctação). A resposta da PA ao tratamento intervencionista depende da duração da HA antes da cirurgia e da idade do paciente. Logo, opção D correta. Opção

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

A incorreta, pois nos casos mais graves, os sintomas aparecem precocemente, na infância. Opção B incorreta quanto antes for feita a correção maiores as chances de obtermos sucesso no controle pressórico desses pacientes e de menores alterações de desenvolvimento a longo prazo. Opção C incorreta. O caso da questão sugere estenose entre a emergência das subclávias no arco aórtico. Opção E incorreta, essa é causa rara de hipertensão secundária na população geral, responsável por cerca de apenas 2% dos casos.

159586.

Comentário: Estamos diante de um paciente hipertenso e obeso com queixa de sonolência diurna excessiva e pausas respiratórias presenciadas tem como diagnóstico mais importante a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O diagnóstico é confirmado através da polissonografia, que mostra cinco ou mais episódios de apneia ou hipopneia por hora de sono. Nesses pacientes, é uma hiperativação simpática que causa a elevação da pressão arterial. Assertiva errada. Resposta B.

159590.

Comentário: Estamos diante de um paciente hipertenso e obeso com queixa de sonolência diurna excessiva e pausas respiratórias presenciadas tem como diagnóstico mais importante a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O diagnóstico é confirmado através da polissonografia, que mostra cinco ou mais episódios de apneia ou hipopneia por hora de sono. Nesses pacientes, é uma hiperativação simpática que causa a elevação da pressão arterial. Assertiva correta. O palato ogival é frequente em respiradores bucais, em que permanece alto e fundo. Para esses doentes, o melhor tratamento é aplicar pressão positiva nas vias aéreas (CPAP). Resposta A.

159594.

Comentário: Paciente com queixas compatíveis com o diagnóstico de apneia do sono (SAOS) faz uma polissonografia que mostra 25 episódios hipo-apneicos. O diagnóstico da doença em questão - SAOS - está confirmado, visto que, para tanto, deve haver 5 ou mais episódios de hipo-apneia em uma hora de sono. Assertiva certa. Resposta A.

159539.

Comentário: O sopro da estenose mitral é denominado ruflar diastólico, um ruído grave com reforço

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

pré-sistólico, melhor audível com a campânula do estetoscópio no foco mitral em decúbito semilateral esquerdo. A acentuação pré-sistólica decorre da contração atrial, que aumenta o gradiente através da valva estenosada. Sua duração, e não sua intensidade, relaciona-se à maior gravidade da estenose mitral . A afirmativa está errada.

159566.

Comentário: Essa questão foi anulada após recurso feito para equipe MEDGRUPO. Vamos entender o motivo Da maneira como a assertiva está colocada, sugere-se que a PRINCIPAL HIPÓTESE diagnóstica a ser aventada pelo médico são as TRÊS DOENÇAS acima, sendo que, apenas a ocorrência de uma crise convulsiva enquanto o paciente estava dirigindo, já seria suficiente para provocar o acidente e o paciente não se lembraria de nada. Da mesma forma, APENAS o diagnóstico de SAOS, como este está associado à hipersonolência diurna (Balbani Formigoni, 1999), já poderia ser um fator que provocou o sono do paciente enquanto estava dirigindo, provocando o acidente. O transtorno depressivo, ou a depressão, também poderia levar à perda da memória recente. No entanto, o que torna o enunciado mais confuso ainda é que a assertiva, da maneira como está escrita, sugere que a principal hipótese diagnóstica para o caso clínico apresentado, é de que o paciente seja portador das três condições, isto é, da SAOS, da convulsão e da depressão, o que seria muita falta de sorte as três condições juntas. Se o enunciado se referisse AS PRINCIPAIS HIPÓTESES DIAGNÓSTICA , até poderíamos aceitar o gabarito como correto. Portanto, pelo fato de a interpretação do enunciado estar confusa e induzindo o candidato ao erro, uma vez que não é factível assumir que o paciente possua os três diagnósticos, a banca alterou o gabarito da questão.

159573.

Comentário: A Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é definida como episódios repetidos de apneia e hipopneia que ocorrem durante o sono, levando à hipersonolência diurna e a alterações cardiorespiratórias. Entre os fatores associados a esta síndrome, citam-se história familiar, OBESIDADE, AUMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA CERVICAL, aumento da relação cintura-quadril, hipotireoidismo, diabetes, acromegalia, insuficiência renal crônica, gravidez e

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

RONCOS, entre outros. O valor preditivo positivo é a capacidade de um teste pegar os verdadeiros positivos dentre todos aqueles que tiveram seu teste positivo. Como todos os itens descritos no enunciado (circunferência de pescoço, roncos e IMC), são fatores associados à SAOS, podemos dizer que a afirmativa está correta, já que eles estando presentes, a chance do paciente ter SAOS é grande. Portanto, o nosso gabarito é a letra A.

133927.

Comentário: De acordo com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, devemos seguir algumas regras durante a pressão arterial. Devemos explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo (A incorreta). Ele deve ser instruído a não conversar durante a medida. O paciente não deve estar de bexiga cheia, não deve ter praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos (D correta), não deve ter ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos recentemente, nem fumado nos 30 minutos anteriores (E incorreta). Não há recomendação específica quanto à necessidade de abstinência sexual (B incorreta). O paciente deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou do 4º espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. Deve-se obter a circunferência aproximadamente no meio do braço e selecionar o manguito de tamanho adequado, colocando-o sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, centralizando o meio da parte compressiva sobre a artéria braquial. Em seguida, proceder às seguintes etapas estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial (o seu reaparecimento corresponderá à PA sistólica) palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo C incorreta) determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), que é em geral fraco seguido de batidas regulares, e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação determinar a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff) auscultar cerca de 20 a 30 mmHg

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa - se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da sistólica diastólica zero. Sugere-se esperar em torno de um minuto para nova medida, embora esse aspecto seja controverso. Portanto, a única recomendação dentre as citadas é que o paciente não realize atividade física nos últimos 60 minutos. Resposta correta letra D.

133935.

Comentário: A avaliação inicial de um paciente com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) deve incluir história clínica completa, com especial atenção aos dados relevantes referentes ao tempo e tratamento prévio de hipertensão, fatores de risco, indícios de hipertensão secundária e de lesões de órgãos-alvo, aspectos socioeconômicos e características do estilo de vida do paciente e ao consumo pregresso ou atual de medicamentos ou drogas que podem interferir em seu tratamento (anti-inflamatórios, anorexígenos, descongestionantes nasais etc.). Além da medida da PA, a frequência cardíaca deve ser cuidadosamente medida, pois sua elevação está relacionada a maior risco cardiovascular. O exame físico deve ser minucioso, buscando sinais sugestivos de lesões de órgãos-alvo e de hipertensão secundária. O exame de fundo de olho deve ser sempre feito ou solicitado na primeira avaliação, em especial em pacientes com HAS estágio 3, que apresentam diabetes ou lesão em órgãos-alvo. Com relação aos exames complementares, devemos ter uma avaliação básica de todos os pacientes, os quais, segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, incluem análise de urina (EAS urina tipo 1) potássio plasmático creatinina plasmática glicemia de jejum colesterol total, HDL e triglicerídeos plasmáticos ácido úrico plasmático e eletrocardiograma convencional. Apesar de a pergunta ser sobre quais exames possuem níveis de evidência B (apenas a creatinina e ECG têm tal nível os demais são nível C LETRA E correta) , tal informação não é necessária para acertar a questão, pois as LETRAS A, B, C e D trazem exames que não fazem parte do laboratório básico de investigação do paciente hipertenso. Exames adicionais como o ecocardiograma podem ser solicitados dependendo do paciente em questão. Portanto, resposta E.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

133942.

Comentário: Restrição hídrica só é indicada na vigência de HIPONATREMIA (A e D erradas). O consumo de sódio deve ser reduzido, porém, a exata medida é controversa. Referências nacionais e internacionais citam uma restrição genérica de 2-3 gramas de sódio por dia, desde que não comprometa a ingesta de calorias e desde que não haja hiponatremia (B correta, C e E erradas). Resposta certa B.

104742.

Comentário: Buscando a realização de uma aferição da pressão arterial mais adequada recomenda-se que, com o paciente sentado (C errada) e o membro superior na altura do coração, as medidas sejam obtidas em ambos os braços (D errada) e, em caso de diferença, que se utilize como referência sempre o braço com o maior valor. As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial sugerem ainda que, em cada consulta, deverão ser realizadas pelo menos três medidas e a média das duas últimas deve ser considerada a PA real. Nesta diretriz, o intervalo recomendado entre as aferições é de um minuto, contudo esse não é um consenso, podendo ser de até 5 minutos de acordo com a referência semiológica. O que se tem como uniforme é que elas não devem ser sequenciais (B e E erradas). Melhor resposta letra A.

104749.

Comentário: O alvo para os níveis tensionais da população em geral é 140 x 90 mmHg. Algumas populações com determinadas comorbidades exigem alvos específicos. Atualmente há divergências nas diversas fontes, mas classicamente os pacientes com diabetes mellitus devem possuir como alvo PA 130 x 80 mmHg (é o que encontramos na Diretriz Brasileira de HAS e na maioria dos livros texto). A ADA, Sociedade Europeia de Cardiologia e o VIII Joint consideram o alvo 140 x 90 mmHg atualmente. O principal objetivo do controle pressórico nos pacientes diabéticos (tipo 1 e tipo 2) seria a redução da microalbuminúria, interferindo diretamente no prognóstico da doença. Por esta razão, nesta população específica, os IECA são os anti-hipertensivos de escolha para a terapia medicamentosa.

80694.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

Comentário: Pessoal, esta questão quis brincar com algumas informações sobre insuficiência cardíaca e suas causas. Vamos analisar as alternativas e perceber algumas pegadinhas da banca para aprendermos vários conceitos valiosos Letra A Geralmente, quando a contratilidade cardíaca está reduzida, o coração não é capaz de realizar um DÉBITO SISTÓLICO (montante de sangue expulso pelo ventrículo esquerdo durante sua contração) adequado. Sabendo que a fração de ejeção é o quociente entre o débito sistólico e o volume diastólico final, perceba que se o meu débito sistólico estiver reduzido, a fração de ejeção tenderá a estar reduzida também (Alternativa incorreta). Letra B Quando a função DIASTÓLICA está alterada, temos um déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo, ou seja, o nosso VE não consegue relaxar para receber sangue. Nesta situação, caso a função sistólica - a de expulsar o sangue - esteja normal, teremos uma fração de ejeção normal ou alta (Alternativa incorreta) Letra C Comunicações arteriovenosas sistêmicas são causas de insuficiência cardíaca de alto débito, mas os shunts arteriovenosos esplâncnicos definitivamente não são condições a serem reconhecidas PRECOCEMENTE sempre que pensarmos em ICC (Alternativa incorreta). Letra D Antes de começarmos o tratamento medicamentoso para um paciente com insuficiência cardíaca, devemos excluir condições de tratamento cirúgico, como as valvulopatias Não adianta prescrever drogas para um doente cuja função cardíaca só irá melhorar após correção cirúrgica destas (Alternativa correta). Letra E Arritmias em salva - ou paroxísticas - são aquelas que aparecem de modo intermitente (de vez em quando). Uma taquiarritmia mais sustentada - como uma fibrilação atrial - pode até causar ICC. Veja o que acontece caso o coração fique numa frequência de batimentos alta por muito tempo, o miocárdio pode tornar-se meio cansadão, marcando o conceito de taquicardiomiopatia é caracterizada por disfunção ventricular sistólica e insuficiência cardíaca congestiva, causadas por taquiarritmias persistentes ou repetitivas com frequência cardíaca elevada. (Alternativa incorreta).

80723.

Comentário: Como o próprio nome diz, pericardite corresponde à inflamação dos folhetos pericárdicos, o que pode ocorrer por diferentes etiologias, como viral (causa mais comum), bacteriana, urêmica, reumatológica (febre reumática, artrite reumatoide, lúpus), pós-infarto, entre

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

outras. A dor torácica costuma acompanhar o quadro, mas pode estar ausente em algumas situações, como na secundária à artrite reumatoide (LETRA A ERRADA e LETRA E CERTA). A dor da pericardite costuma ser precordial (o que sempre vai implicar que ela entre como diagnóstico diferencial da síndrome coronariana - LETRA D ERRADA) do tipo pleurítica (piora junto com a inspiração - LETRA B ERRADA) e aliviada quando o paciente fica sentado com o tronco inclinado para a frente - a chamada posição de prece maometana (LETRA C ERRADA). Resposta certa letra E.

97795.

Comentário: Hiperfonese de B1 sopro diastólico em foco mitral (ápice cardíaco) são achados diagnósticos da estenose mitral . Em um paciente jovem, em nosso meio, a explicação mais provável para esta lesão valvar ainda é a cardiopatia reumática crônica (sequela de surto (s) prévio (s) de febre reumática). Lembre-se de que a estenose mitral reumática pode seguir assintomática durante muitos anos, aparecendo, por exemplo, por causa das modificações fisiológicas do organismo materno (ex. aumento do volume plasmático circulante, o que ocasiona sobrecarga pressórica do átrio esquerdo e congestão pulmonar progressiva durante a gestação). Resposta certa A.

97810.

Comentário: No lado esquerdo da silhueta cardíaca, a primeira curvatura que aparece é o arco aórtico, que está normal neste paciente (convexo). Abaixo dele, a segunda estrutura esperada é o tronco da artéria pulmonar, que normalmente não é proeminente (quer dizer, em geral sua curvatura é côncava). Neste paciente o tronco da artéria pulmonar está nitidamente abaulado, o que não causa nenhuma surpresa uma vez que o mesmo é portador de hipertensão arterial pulmonar grave (condição onde a artéria pulmonar aumenta de calibre). Outra alteração radiográfica típica da HAP grave pode ser observada aqui escassez da trama vascular na periferia dos campos pulmonares (devido à obliteração arteriolar pulmonar que acontece na HAP). No ECG, observa-se logo de cara um bloqueio do ramo direito (QRS positivo em V1 e V2) e um desvio do eixo para a direita (QRS isodifásico em a VR e positivo em D3 eixo elétrico do QRS a 120º). Além

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

disso, é evidente ainda o padrão de strain na repolarização ventricular, revelando a sobrecarga pressórica. Sabemos que se trata de strain de VD, pois esta alteração se faz notar principalmente nas derivações V1 e V2 (strain ST convexo para cima, com ou sem desnível, e onda T negativa). Resposta certa A.

80744.

Comentário: A etiopatogenia da miocardiopatia alcoólica é multifatorial, sendo considerados significativos e com ação sinergística os seguintes fatores (1) indução direta de apoptose dos cardiomiócitos pelo álcool etílico (2) alterações metabólicas intracelulares mediadas por subprodutos da degradação do álcool como o acetaldeído (3) ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (4) deficiências nutricionais, como a hipovitaminose B1 (deficiência de tiamina) (5) efeito tóxico do COBALTO utilizado como aditivo da fabricação de cerveja (efeito específico nos bebedores de cerveja). Questão bastante difícil e ultraespecífica, resposta certa E.

97839.

Comentário: Em primeiro lugar, não resta dúvida que este paciente já possui pelo menos um tipo de lesão de órgão-alvo da hipertensão arterial sistêmica (retinopatia hipertensiva grau I). A nefropatia apresentada pode ser secundária à HAS ou pode ser primária - não há dados suficientes no enunciado que permitam uma diferenciação segura entre essas duas possibilidades (ex. cor do paciente, EAS, dosagem de proteinúria, biópsia renal)... De qualquer modo, já podemos afirmar que a letra D está certa Justamente por este último motivo, isto é, por não ser possível descartar um componente de nefropatia primária que agregaria um componente de HAS secundária ao quadro inicial de HAS primária desse paciente, não poderíamos marcar a letra C. O paciente tem disfunção renal significativa e HAS resistente (refratária ao tratamento com 3 drogas em doses otimizadas, sendo uma delas um diurético), fatores que apontam para a possibilidade de HAS secundária. Também não vamos marcar as letras B ou A a disfunção renal pelo uso de IECA é esperada em pacientes mais idosos que já tenham aterosclerose aortorenal importante, e a HAS maligna-acelerada é uma complicação evolutiva da HAS primária não tratada da forma correta (não parece ser o caso aqui)... Além do mais, a lesão ocular da HAS maligna-acelerada é a retinopatia

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina

grau III-IV... Resposta certa D.

64443.

Comentário: Os betabloqueadores com benefício comprovado na IC sistólica sintomática são apenas três Carvedilol, Succinato de Metoprolol e Bisoprolol memorize O Carvedilol é um bloqueador dos receptores alfa-1, beta-1 e beta-2, enquanto o Metoprolol e o Bisoprolol são bloqueadores beta-1 seletivos. Assertiva A correta. As demais são absurdas.

Medicina livre, venda proibida. Twitter @livremedicina